

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО · ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Не просто накормить

Как организовать безопасное, достойное и вариативное
питание людей с психическими нарушениями в домах
социального обслуживания



Евгений Владимирович Чистяков

директор СПб ГАСУСО «Дом социального обслуживания „Серафимовский“»

По материалам межрегионального семинара-совещания «Пространство Новых Идей 2.0»,
Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года

Методическое руководство. Вторая редакция, дополненная и переработанная (октябрь 2026 года). Первая редакция подготовлена к межрегиональному методическому семинару-совещанию «Пространство Новых Идей 2.0».

Автор: Чистяков Евгений Владимирович, директор Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом социального обслуживания „Серафимовский“».

Со-модератор дискуссии 26.08.2026: Нурбаев Тимур Аликович, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом социального обслуживания „Тесовый берег“».

Тема семинара: «Права, свободы, интересы жителей и персонала социальных стационаров».

Дискуссионная сессия 26 августа 2026 года, 14:00–15:30, «Организация питания: опыт реализации проектов» (площадка № 2). Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года.

Организаторы семинара: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.

Адресат: руководители стационарных организаций социального обслуживания — психоневрологических интернатов и домов социального обслуживания. На семинаре были представлены 51 субъект Российской Федерации.

Это справочник для внедрения, а не конспект девяностоминутной сессии. Документ не является нормативным правовым актом, клиническим руководством или индивидуальной юридической консультацией. Все локальные формы в приложениях — проекты, которые требуют адаптации к конкретному дому. Во второй редакции текст переписан литературным языком, дополнен справками по специальным терминам и новыми исследованиями; найденные при проверке неточности первой редакции исправлены, а их перечень приведён в разделе 41. Заявление о достоверности — там же.

Содержание

2. Обращение к читателю
3. Аннотация
4. Резюме для руководителя
5. Собирательная ситуация: «Один обед — пять конфликтов»
6. Кто находится за столом
7. Что значит «накормить»
8. От мономеню к вариативности: лестница моделей
9. Пищевое поведение при психических расстройствах
10. Дисфагия и аспирационный риск: невидимая угроза за общим столом
11. Лекарства и еда: пять правил, которые обязана знать кухня
12. Отказ от еды: от первого пропуска до врачебного решения
13. Переедание, гиперфагия и ночное едение
14. Пикацизм, заглатывание и другие поведенческие риски за столом
15. Невербальный выбор: как услышать того, кто не говорит
16. Дееспособность, опека и выбор еды: карта решений
17. Право Российской Федерации: что разрешено, что требуется, что опасно
18. Санитария и пищевая безопасность при вариативности
19. Два варианта блюда: технология без второй кухни
20. Точка раздачи: дизайн линии, очередь и помощь
21. Когда выбор изменился: журнал, пересчёт и «фиктивная вариативность»
22. Как проверить реальность питания: аудит и замеры
23. Кто участвует: география семинара и система ПНИ-2026
24. Как устроены нормы в регионах
25. Российские практики: публичные кейсы, региональный опыт и его границы
26. Международный опыт: проверяемые нормы зарубежных систем
27. Что говорят исследования: доказательные вмешательства и их границы
28. Люди за линией: персонал стола
29. Финансовые модели: сколько стоит питание и сколько стоит выбор
30. Закупки продуктов: 44-ФЗ без кошмаров
31. Документальный комплект: как практика становится системой
32. Как отвечать проверяющему: сценарий диалога без страха
33. Ответственность директора: честная карта рисков без запугивания
34. Права жителей и совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню
35. Пилот на 90 дней: минимальный безопасный старт
36. Дорожная карта на 12 месяцев: от пилота к системе
37. Четырнадцать возражений и честные ответы на них
38. Десять вопросов учредителю: повестка для разговора наверх
39. Предложения отрасли: что должно измениться выше уровня учреждения
40. Организационные предложения семинару
41. Заявление о достоверности: что в этом докладе на чём стоит
42. Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности
43. Заключение: что остаётся после последней страницы
- Учебные кейсы 1–4
- Учебные кейсы 5–8
- Учебные кейсы 9–12
- Учебные кейсы 13–16
- Учебные кейсы 17–20
- Учебные кейсы 21–22
- Приложения 1–6
- Приложения 7–12
- Приложения 13–18
- Приложения 19–24
- Приложения 25–30
- Приложения 31–36
- Приложения 37–38
- Приложения 39–42
- Приложения 43–44
- Приложение 45. План Б: питание при закрытии столовой
44. Список литературы

ЧАСТЬ 1

Вступление и резюме

разделы 1–4

2

Обращение к читателю

Коллеги, начну не с витрины, а с обычного обеда.

Один обед в доме социального обслуживания собирает за одним столом пять конфликтов. Очередь на раздаче спорит с помощью тем, кто не может есть сам. Отказ от еды проходит незамеченным, потому что его негде записать. Чашка кофе становится лекарственным риском для жителя на клозапине. «Добавка», выданная из жалости, расходится с назначением врача. А журналы заполняются не для жизни, а «к комиссии». Голодный житель и оплаченное сырьё, которое уходит в бак, — это не две разные проблемы, а одна система. Национальной доли пищевых отходов в наших домах не существует, и получить её можно только одним способом: семидневным замером в пилоте, а не лозунгом. Скрытые риски стола тоже велики. Расстройства глотания в изученных клинических группах встречаются у 21,9–69,5 % пациентов, получающих антипсихотики[1], и хотя переносить этот диапазон на все российские дома нельзя, сама его величина требует внимания (раздел 10).

Кто в вашем доме сегодня решает, что лежит на тарелке: сам житель, сиделка, врач, кухня, контракт или региональная норма? Чаще всего отвечают «кухня» и «норма», реже всего — «он сам». Между тем для человека, который живёт в интернате, еда — три-четыре события в день, и нередко это главные события дня. Семинар, к которому готовилась первая редакция этого руководства, был посвящён правам жителей. За столом эти права либо доходят до тарелки, либо остаются строкой в законе.

Что унести, если закрыть этот том после двух страниц. Ответом проверке служит не формула «запрета нет», а комплект документов. Закон не требует шведского стола и не запрещает замену блюда. Проверяющему нужна папка: положение о питании, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем, а там, где это уместно, — пищевые предпочтения, записанные в индивидуальную программу предоставления социальных услуг (442-ФЗ). Без такого комплекта та же самая практика выглядит как самовольное отступление от раскладки. Шаблоны собраны в приложениях, порядок сборки описан в разделах 31–32. Опорная норма о гуманном отношении — часть 2 статьи 5 Закона № 3185-1 (раздел 17).

Клинику кухня не назначает. Таблица «лекарство × еда», текстуры, «диабетический стол», реакция на отказ от еды — всё это решается только с врачом. Иначе осторожный директор правильно услышит в предложении о вариативности другое: «мне предлагают медицинскую реформу руками повара». Где проходит граница, сказано в разделах 4.0 и 4.3.

Практика уже есть. О выборе блюд публично сообщали два дома Новосибирской области, Усть-Илимский дом социального обслуживания, ДСО «Серафимовский» и несколько учреждений Иркутской области, причём каждое из иркутских работает по своей модели[2, 3, 4, 5, 6]. Это сообщения самих учреждений, а не независимый аудит, и подробный разбор того, что о них известно и чего мы не знаем, приведён в разделе 25.

О трёх четвертях. По данным за 2022 год, обработанным проектом «Если быть точным», порядка трёх из четырёх жителей ПНИ признаны судом недееспособными[7]. В вашем доме цифра может быть иной, но логика от этого не меняется. Повседневное пищевое предпочтение, как правило, не является сделкой, а опекун обязан учитывать мнение подопечного (пункт 3 статьи 36 ГК РФ). Подробно об этом — разделы 16 и 17.

Последнее слово этого текста — не «внедряйте», а «измеряйте». Семь дней замера отделяют убеждение от знания. Когда в Успенском ПНИ пишут, что жители «с лёгкостью освоили новую систему»[3], это говорит о методике, а не о чуде.

Как пользоваться руководством. Семинар прошёл 25–27 августа 2026 года; на сессии 26 августа показывалась презентация и раздавалась памятка на две страницы. Этот текст — не стенограмма, а справочник. Во второй редакции он переписан связным языком, дополнен справками по специальным терминам и новыми исследованиями, а ключевые формулировки зарубежных источников переведены на русский. Читать его подряд не нужно. Пятнадцать минут — раздел 4. Вечер — маршруты раздела 4.6. Неделя внедрения — разделы 31 и 35. Разговор с учредителем — разделы 31, 32, 33 и 37. Насколько можно доверять каждому утверждению — раздел 41, полный перечень источников — раздел 44.

3

Аннотация

Методическое руководство посвящено организации питания в стационарных организациях социального обслуживания, где живут люди с психическими расстройствами, — в психоневрологических интернатах и домах социального обслуживания. Первая редакция подготовлена к семинару «Пространство Новых Идей 2.0» (Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года); вторая, дополненная, выпущена в октябре 2026 года. Автор — Е. В. Чистяков, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“». Адресат — руководители таких организаций.

Руководство отвечает на три вопроса.

Клинический. Чем кормление людей с психическими расстройствами отличается от «обычного» стационарного питания? Какие риски стол обязан учитывать — лекарственно-пищевые взаимодействия, метаболические эффекты антипсихотиков, дисфагию, аспирацию и удушье, расстройства пищевого поведения — и почему учитывать их нужно через врача, а не через самостоятельность кухни?

Правовой. Что российское законодательство разрешает и чего не требует в части выбора блюд? Как оформить вариативное питание документами, которые можно положить на стол проверяющему?

Управленческий. Как провести пилот на девяносто дней, заменить лозунг замером и выстроить разговор с учредителем?

Доказательная база второй редакции включает реестр первой (российские правовые и практические источники, клинические публикации, международные стандарты) и новые источники, найденные при подготовке второй редакции: систематические обзоры, рандомизированные исследования, официальные документы ведомств и тексты российских нормативных актов. Ключевые формулировки зарубежных источников переведены на русский язык. Полный перечень и классы источников — в разделе 44, ограничения — в разделе 41. Публичные описания российских практик найдены в Новосибирской и Иркутской областях и в Санкт-Петербурге, самые ранние — с 2013 и 2023 годов; в Иркутской области четыре учреждения работают по разным моделям, единой региональной нормы нет (раздел 25).

Объём: 44 раздела, 22 учебных кейса, 45 шаблонов локальных документов. Это справочник для внедрения, а не текст для чтения подряд.

Ограничения: руководство не заменяет клинических рекомендаций, нормативных актов и индивидуальных юридических заключений; шаблоны — проекты локальных форм; редакции актов указаны по датам проверки (июль–октябрь 2026 года). Зарубежные данные получены в иных системах ухода, и их перенос на российские дома каждый раз оговаривается.

4

Резюме для руководителя

Этот раздел рассчитан на пятнадцать минут чтения. Если времени ещё меньше, начните с боли стола (один обед — пять конфликтов, раздел 5), затем прочитайте границу раздела 4.0, выводы 2, 5, 7 и 10 и минимальную модель раздела 4.4. Не начинайте разговор с коллегами с витрины «как хорошо у нас получилось». Сначала — несъеденное и голод, затем — документальная защита и пилот на одном отделении.

Руководство не предназначено для чтения подряд. Оно задумано как справочник, к которому возвращаются по мере внедрения; маршруты чтения предложены в разделе 4.6.

4.0. Сначала граница: что кухня не назначает

Эту границу нужно произнести раньше любого списка взаимодействий, иначе предложение о вариативном питании будет услышано как медицинская реформа руками повара.

Только с врачом: любые ограничения рациона (включая «диабетический стол»); изменение текстур (протёртое, загущённое); правила при дисфагии и протокол свободной воды; действия при длительном отказе от еды; режим питания при седации; решения об энтеральном и зондовом питании и о комфортном кормлении в конце жизни; сдвиг времени еды у жителей на инсулине; слабительные и реакция на запор; назначение анализов и добавок микронутриентов; интерпретация скрининга MUST и витаминизация при острых респираторных инфекциях.

Только с учредителем: изменение финансирования продуктовой строки; изменение штатного расписания, в том числе нормы помощи за столом; аутсорсинг питания; официальный статус пилота и его публичность.

Только после правовой проверки: формулировки о «согласии недееспособного» в локальных актах; обработка пищевых карт как персональных данных (сведения о здоровье относятся к специальной категории, и для их обработки нужно основание из части 2 статьи 10 закона № 152-ФЗ, раздел 17.6); ответы на запросы прокуратуры; любые конструкции, в которых учреждение одновременно выступает опекуном жителя.

Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача. Кухня исполняет назначение, а не ставит диагноз.

Врач

решает клинику

- ограничения рациона, в том числе «диабетический стол»
- текстуры, правила при дисфагии, протокол свободной воды
- действия при длительном отказе от еды
- питание при седации; время еды на инсулине
- зонд и комфортное кормление в конце жизни
- анализы, добавки, скрининг MUST
- подписывает таблицу «лекарство × еда»

Кухня и администрация

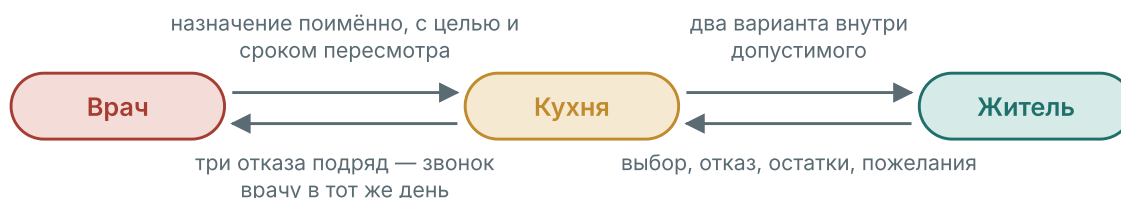
исполняют и организуют

- исполняют назначение и таблицу врача, не ставят диагноз
- два варианта блюда внутри допустимого
- журналы проб, бракеража, отказов, заказа — в ритме смены
- замер отходов и ночного интервала
- еда не подаётся, пока помощь не готова

Житель

выбирает

- блюдо из того, что допустимо по назначению врача
- повседневное пищевое предпочтение, как правило, не сделка: недееспособность не отменяет выбора
- говорит словом, жестом, отказом, остатками на тарелке



Только с учредителем: финансирование продуктовой строки, штаты и норма помощи за столом, аутсорсинг питания, статус пилота

Только после правовой проверки: «согласие недееспособного» в локальных актах, пищевые карты как персональные данные, ответы прокуратуре

Рисунок 1. Граница раздела 4.0: врач задаёт множество допустимых блюд, кухня исполняет и организует, житель выбирает внутри этого множества. Клинику кухня не назначает.

4.0а. Методология за один экран: как читать цифры

Утверждения доклада делятся на четыре класса, и класс никогда не повышается при пересказе (подробно — раздел 41).

Справка. Классы утверждений. Норма — цитата закона или подзаконного акта с реквизитами, первоисточником и датой проверки; ею спорят с юристом и проверяющим. **Толкование** — системное прочтение нормы применительно к ситуации, которую сама норма прямо не регулирует.

Рекомендация — опыт конкретного учреждения или вывод исследования: «делайте так, потому что так сделали там-то и получили то-то», но не императив. **Проект локальной практики** — шаблон приказа, положения или журнала; каждый требует локальной правовой проверки и несёт пометку «проект локальной формы, не норматив».

Цифры, акты и цитаты сопровождаются маркерами источников: российские правовые и практические, клинические и международные. Полный перечень — в разделе 44. Слово «проверено» без даты и адреса ничего не стоит. «Общий опыт» — это анекдот. «Как известно» — либо тривиальность, либо неправда. Утверждение без маркера — ошибка автора, а не недоразумение читателя.

Источники первой редакции проверены 23.07.2026, правовая сверка проведена 19–21.08.2026. Вторая редакция (октябрь 2026 года) перепроверила значительную часть ссылок и добавила новые; найденные расхождения исправлены и перечислены в разделе 41.6. С 1 сентября 2026 года действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26, который заменил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 без переходного периода; журналы августа по старым правилам не переписываются (раздел 18.10).

4.1. Одиннадцать главных выводов

Вывод 1. Ошибки за столом проверяют как юридически значимые. На проживающих в психоневрологических интернатах распространяются права, перечисленные в частях 2 и 4 статьи 37 Закона № 3185-1 (статья 43 этого закона). Гуманное отношение и уважение достоинства гарантирует часть 2 статьи 5[8]. Кратность питания нормирована санитарными правилами: не менее трёх приёмов пищи в день, диетическое питание по показаниям; до 1 сентября 2026 года это требование содержал СанПиН 3590-20, с 1 сентября — пункт 56 подпункт 11 СанПиН 4282-26[9]. Дела по статье 6.6 КоАП касаются качества и достаточности питания, а не «двух вторых»[10]. Подробно — разделы 17, 32, 33.

Вывод 2. Ответ проверяющему — комплект документов, а не формула «запрета нет». Федеральное право не запрещает вариативность и не обязывает давать выбор каждого блюда. Таблицы замены в региональных раскладках — законный механизм, хотя есть они не во всех актах (раздел 24)[11, 12]. Директору этого мало: нужна бумага, которая разрешает выбор именно в его доме. Минимальный комплект — положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем. Без него та же практика выглядит как отступление от раскладки. Разделы 31, 32.

Практика уже существует. О выборе блюд публично сообщали два ПНИ Новосибирской области, Усть-Илимский дом социального обслуживания, ДСО «Серафимовский» и несколько учреждений Иркутской области, каждое со своей моделью; самые ранние найденные описания относятся к 2013 и 2023 годам[2, 3, 4, 5, 6]. Это сообщения самих учреждений, а не независимый аудит. Разделы 8, 23, 25.

Вывод 3. Главные риски стола — клинические, и они измеримы. Антипсихотики различаются по прибавке веса в разы: по метаанализу ста рандомизированных исследований — от –0,23 до +3,01 кг за шесть недель[13]. Распространённость дисфагии в отдельных изученных группах пациентов на антипсихотиках составляет 21,9–69,5 %[1], среди проживающих зарубежных домов ухода — около 47 %[14]; переносить эти диапазоны на российские дома без оговорки нельзя. Смертность от пневмонии при тяжёлых психических расстройствах в семь раз выше популяционной[15], а смертность от удушья пищей при шизофрении — в двадцать раз[16]. Организация стола входит в профилактику преждевременной смертности. Разделы 9–14.

Вывод 4. Четыре лекарственно-пищевых правила кухня исполняет по таблице врача. Клозапин и кофеин, литий с солью и водой, ингибиторы МАО и тирамин, карбамазепин и грейпфрут[17, 18, 19, 20]. На посту — одна подписанная врачом таблица. Кухня не «убирает кофе сама». Раздел 11 и граница 4.0.

Вывод 5. Около трёх четвертей жителей ПНИ признаны недееспособными, и это не отменяет их выбора. По данным за 2022 год, обработанным проектом «Если быть точным» (публикация 09.04.2026), порядка 74 % жителей ПНИ признаны судом недееспособными; это вторичная аналитика, а не текущая статистическая отчётность, и в вашем доме цифра будет другой[7]. Сделки за недееспособного совершает опекун (статья 29 ГК РФ), но повседневное пищевое предпочтение, как правило, сделкой не является. Опекун обязан выяснять и учитывать мнение подопечного (пункт 3 статьи 36 ГК РФ). Закон № 442-ФЗ определяет права получателя услуг и индивидуальную программу. С тем, кто не говорит, работают показ двух порций, наблюдение и пищевая биография. Разделы 15, 16.

Вывод 6. «Диабетический стол» и другие жёсткие ограничения — зона врача, а не шаблона. Лечебное питание назначается поимённо, с целью и сроком пересмотра. Приказы Минздрава о лечебном питании, в том числе приказ от 05.08.2003 № 330, адресованы медицинским организациям и на организации социального обслуживания автоматически не распространяются[21, 22]. Разделы 17, 19.

Вывод 7. Вариативность без журналов — имитация для проверяющего. Без журнала фактического выбора нельзя доказать, что выбор существует, и нельзя пересчитать объёмы варки. Комплект — в выводе 2. Разделы 21, 31, 32.

Вывод 8. Честная финансовая модель начинается с замера. Мы не утверждаем, что вариативность «почти бесплатна»: источники расходятся, и обе позиции изложены в разделе 29.1. Семидневный замер отходов и трудозатрат до старта — первый шаг; иллюстративные расчёты в докладе помечены как иллюстрации. Опасен и «средний житель»: одного перекормили, другого недокормили, а среднее по отделению выглядит нормой (раздел 6.5). Разделы 29, 35.

Вывод 9. Директор отвечает за систему контроля. Ответственность наступает не за каждое отдельное событие, а за неработающий контроль[10, 23]. Письмо учредителю о дефиците ресурсов не освобождает от ответственности, но доказывает своевременное реагирование. Раздел 33.

Вывод 10. Пилот за девяносто дней реалистичен на одном отделении без новой сметы. Месяц измерений, месяц документов и обучения, месяц работы: в минимальной конфигурации — два варианта второго блюда на обед (раздел 35.3); новосибирские дома предлагают выбор и на завтраке[2, 3]. «Без новой сметы» не значит «без затрат»: полный переход дома может потребовать оборудования и ставок[5]. Пилот проверяет исполнимость, а не эффект: это не рандомизированное исследование (раздел 35.4а). Раздел 35.

Вывод 11. Лечебное питание и вариативное меню совместимы. Диета, назначенная врачом, задаёт множество допустимых блюд, а не одно блюдо; внутри этого множества выбор возможен (разделы 10.10, 17.12, 19). Шесть вопросов дискуссии 26 августа, которую вели Е. В. Чистяков и Т. А. Нурбаев, сохраняют силу и после семинара: они собраны в разделах 17.12–17.13 и 40. Различие закупочных контуров двух домов-модераторов (Серафимовский работает по 223-ФЗ, «Тесовый берег» — по 44-ФЗ) разобрано в разделе 30.

4.2. Что сказать повару в понедельник

1. Семь дней считаем отходы и смотрим, что реально остаётся на тарелках (приложение 25).
2. Замеряем интервал от ужина до завтрака — одной строкой в журнале.
3. На пост — таблица врача «лекарство × еда», а не самостоятельность кухни (приложение 21).
4. Три отказа подряд — звонок врачу в тот же день (приложение 9).
5. Если кухня чужая, открываем спецификацию контракта и ищем строку выбора (разделы 42 и 35.9).

Опрос жителей, письмо учредителю, рабочая группа, поднос для лежащих — всё это после этих пяти шагов. Чек-листы — приложения 18–20.

4.3. Чего нельзя делать без врача, учредителя или правовой проверки

Перечень дан в разделе 4.0. Этот раздел оставлен как указатель для тех, кто листает выводы и сразу ищет, «что можно».

4.4. Минимальная безопасная модель

Два варианта блюда, журнал и карта — без второй кухни. Модель состоит из шести элементов.

1. **Документы.** Положение об организации питания и журналы (пробы, бракераж, отказы, заказ) ведутся в ритме смены, а не «к комиссии».
2. **Клиника.** На посту — таблица врача; у сиделки — список дисфагического риска; три отказа подряд — врач в тот же день.
3. **Люди.** У каждого, кого кормят, есть конкретный помощник, и еда не подаётся, пока помощь не готова. Ориентиры штатной численности дают рекомендуемые нормативы приказа Минтруда № 305н, действующего с 1 сентября 2025 года (раздел 28).
4. **Голос жителя.** Остатки на тарелках разбирают; есть хотя бы один канал пожеланий.
5. **Замер.** Ночной интервал и объём отходов известны числом.
6. **Ночной интервал.** Операционная цель дома — не больше 13 часов. Это рабочий ориентир авторов внутри международного диапазона 11–14 часов, а не нормативное требование; 14 часов — верхняя граница американских правил CMS, а не целевой показатель российского чек-листа. Если интервал больше 13 часов, сдвигают расписание (ужин позже или завтрак раньше) либо по согласованию с врачом вводят вечерний перекус (раздел 13.9).

Если хотя бы один из шести элементов не выполняется, начинать нужно с него.

Главная просьба. Не меняйте всё меню сразу. Один обед, одно отделение, одна неделя замера — и только затем пилот на девяносто дней с двумя безопасными вариантами и журналом фактического выбора.

4.5. Что сделать в понедельник до обеда

Пять действий. Новая смета не нужна, меню не трогают. Врач входит в рабочую группу, чтобы ставить границу, а не «назначать диету руками кухни».

- 1. Посчитать сырьевую строку (1 час).** Расходы на продукты за последний полный месяц разделить на число жителей и на число дней. Если за пять минут это число никто не может назвать, это первая находка аудита. Методика — раздел 29.3, приложение 25.
- 2. Запустить семидневный замер отходов и времени раздачи (10 минут на запуск).** Ответственный — заведующий производством или старшая смены. Замеряются тарелочные остатки по трём основным приёмам (граммы на порцию), кухонные остатки и время от начала раздачи до последней тарелки. Журнал — приложение 25. Без замера через девять дней будет не с чем сравнивать.
- 3. Издать приказ о рабочей группе (30 минут).** Директор или заместитель по хозяйственной части, врач или фельдшер, диетическая сестра или заведующий производством, старшая медицинская сестра одного отделения и, если получится, представитель учредителя. Поручение: «в срок до [дата + 30 дней] подготовить предложение по пилоту на одном отделении на 90 дней».
- 4. Направить письмо-уведомление учредителю (30 минут).** Одна страница: обоснование со ссылкой на опубликованные российские практики (раздел 25), ссылка на санитарные правила (СанПиН 4282-26, п. 56 подп. 11), сроки, просьба о согласовании или уведомительный порядок. Шаблоны — приложение 33 (сообщение о ресурсах) и приложение 44 (письмо о пилоте); разделы 31, 38. Уведомление впоследствии снимает претензию о «самоуправстве».
- 5. Выбрать точку пилота (1 час с заведующим отделением).** Одно отделение на 20–35 жителей, лучше «сложное» (группа помощи, неговорящие жители), а не самое удобное; одна смена; один приём пищи — обед. Решение заносится в протокол рабочей группы. Почему «сложное» — раздел 35.7.

Чего не делать в первый понедельник. Не выбирать модель М1–М5 — это решение группы после замера. Не менять меню. Не выпускать пресс-релиз. Совет жителей подключается на этапе подбора пар эквивалентов.

Что будет на руках через семь дней: сырьевая строка, запущенный замер отходов, приказ с пятью фамилиями, письмо учредителю, выбранное отделение.

4.6. Маршруты чтения

Маршрут директора (два часа): разделы 4, 5, 8, 22, 35, 37, 42.

Маршрут внедрения (неделя): разделы 6–8, 17–19, 31, 35–36 и приложения.

Маршрут спорщика (вечер): разделы 23–27, 37, 39–40.

Клинический маршрут (для врача и старшей медицинской сестры): разделы 9–14, затем 15 и 20.

Раздел 41 не стоит пропускать никому. По клинике и международным нормам доказательная база плотная, а по эффекту вариативного меню в психиатрии — почти пустая. Поэтому последнее слово этого руководства — «измеряйте».

ЧАСТЬ 2

Сцена, терминология, лестница моделей

разделы 5–8

5

Собирательная ситуация: «Один обед — пять конфликтов»

Учебный кейс, составленный для анализа. Все персонажи и совпадения вымышлены; ситуация собрана из типичных элементов, описанных в проверенных источниках и практиках учреждений.

Прежде чем говорить о вариативном меню, нужно увидеть обычный обед таким, каков он есть, без витрины и без отчёта. Эта глава — одна сцена, разобранная по швам. Она не описывает конкретный дом и не обвиняет конкретных людей. Её задача в другом: показать, что привычные «мелкие неурядицы» столовой складываются в систему, и что у этой системы есть устройство, которое можно изменить. Пять конфликтов, о которых пойдёт речь, разбираются подробно в следующих главах; здесь они собраны вместе, потому что в жизни они случаются одновременно, за один и тот же час.

5.1. Обед, как он есть

Средний российский психоневрологический интернат рассчитан на 289 мест[7]. Оговоримся сразу: это расчёт аналитического проекта «Если быть точным», а не официальная статистика ведомства; по тем же данным, в 2024 году в России работали 466 взрослых ПНИ, в которых жили 139 тысяч человек[7]. Для нашей сцены важно не точное число, а порядок величины: это учреждение, где за один обед нужно накормить больше сотни людей.

Обеденный зал рассчитан на 120 мест, раздача поточная, в три захода[24]. На линии по одному варианту каждого блюда: борщ, гречка с котлетой, компот. В первом заходе двенадцать жителей едят только с чужой помощью. На смене четыре сиделки, и одна из них в это время разносит лекарства. До конца смены остаётся пять часов.

Первый конфликт: очередь против помощи. Тех, кто ест самостоятельно, обслужили первыми, потому что так быстрее, и они уже сидят перед остывающими тарелками. Двенадцать человек, которых нужно кормить, приходится на четырёх сиделок, а фактически на трёх. Значит, понадобится не меньше трёх циклов по 15–20 минут, и последних будут кормить холодным.

Эти минуты не взяты с потолка, и в действительности их, скорее всего, не хватает. В американском контролируемом исследовании, проведённом в четырёх домах сестринского ухода, помощь в еде, организованная по протоколу, требовала в среднем **42 минуты на одного человека за один приём пищи**, тогда как при обычной практике на человека приходилось около **5 минут** помощи. Именно протокольная помощь повышала потребление пищи и удерживала массу тела у жителей с риском непреднамеренного похудения, а в контрольных условиях люди продолжали худеть[25]. Это американские дома ухода с другим контингентом и

другим штатом, и переносить их минуты на российский ПНИ как норматив нельзя. Но порядок расхождения поучителен: между «покормили» и «помогли поесть» лежит разница во времени в несколько раз, и эту разницу персонал покрывает скоростью.

Скорость же и есть главный механизм вреда. Интегративный обзор пятидесяти двух исследований удушья пищей показал, что факторы риска не сводятся к самому человеку: они лежат также в обстановке трапезы, в качестве помощи за столом, в уходе за полостью рта и в наблюдении за общим здоровьем, зубами и лекарствами[26]. Иначе говоря, аспирация «на скорость» — это не несчастный случай, а следствие того, как устроен обед.

Международная норма, которую мы подробно разбираем в разделе 26, допускает не более двух полностью кормимых жителей на одного работника и требует подавать еду только тогда, когда помощь готова[27]. В России такой нормы нет, и нарушением её отсутствие не считается (разделы 20 и 28). Тем не менее сама помощь в приёме пищи у нас не пустое место: примерный перечень социальных услуг, утверждённый Правительством, называет «помощь в приеме пищи (кормление)» социально-бытовой услугой во всех формах обслуживания, а для стационарной формы отдельно — «обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами»[28]. Услуга, таким образом, закреплена; не закреплены её время, темп и соотношение «работник — кормимые». Именно в этом зазоре рождаются недоедание и аспирация.

Справка. Кормление как социальная услуга. Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 утверждает *примерный* перечень социальных услуг по видам. В разделе социально-бытовых услуг оно различает «обеспечение питанием» (стационарная и полустационарная формы) и «помощь в приеме пищи (кормление)» (все формы)[28]. Это разные услуги: первая отвечает за то, что еда есть, вторая — за то, что она дошла до человека. Перечень примерный: конкретный состав услуг утверждают субъекты РФ. Нормы времени и соотношения персонала постановление не устанавливает.

Второй конфликт: «он опять не ест кашу». Житель С. третий день подряд отодвигает тарелку. Журнала отказов нет: в лучшем случае запись появится в тетради, в худшем её не будет вовсе, и врач узнает о происходящем только в четверг. За отказом может стоять депрессивный эпизод, а может начинающаяся дисфагия, но проверить это некому: логопеда в штате нет. Покашливание за столом и «влажный» голос после еды никто не связывает с отказами[29]. Назовут ли происходящее «капризом» или «симптомом», зависит от того, кто сегодня дежурит. Маршрут отказа и правило «трёх отказов» изложены в разделе 12, признаки дисфагии — в разделе 10.4.

Третий конфликт: лекарства и кофе. Житель К. принимает клоzapин и с утра выпил две большие кружки крепкого кофе, который принесли родственники. Ни семью, ни самого К. не предупредили, что кофеин взаимодействует с клоzapином: резкий рост потребления кофеина повышает концентрацию препарата в крови до клинически значимых величин[17, 30]. Вечером седация оказывается сильнее обычного, и дежурная объясняет это «плохим днём». Механизм взаимодействия и таблица врача «лекарство × еда» разобраны в разделе 11.

Четвёртый конфликт: добавка. Житель П. принимает оланзапин и за год прибавил 14 килограммов. По данным метаанализов, у этого препарата один из самых выраженных профилей набора веса среди антипсихотиков[13]. П. просит вторую котлету. Сиделка отвечает: «Вам нельзя, вы полнеете», руководствуясь собственным представлением о пользе, а не врачебным

назначением. Вечером П. забирает хлеб у соседа. Разбирают этот эпизод как нарушение дисциплины, а не как самовольное ограничение рациона, с которого всё началось. Метаболика антипсихотиков изложена в разделе 13, отбирание еды — в разделе 14.

Пятый конфликт: проверка на следующей неделе. В четверг приходит комиссия учредителя. Завхоз распоряжается привести журналы «в порядок», и суточные пробы за двое прошедших суток подпишут сегодня задним числом. Из пяти конфликтов этот самый опасный, потому что он подменяет контроль его документальной имитацией. Прокурорские проверки показывают типовой состав дел против социальных учреждений по ст. 6.6 КоАП: отсутствие суточных проб и недоброкачественные продукты[10]. Эти дела касаются качества и достаточности питания, а не вариативности; санитарный контур подробно описан в разделе 18, ответственность — в разделе 33.



Рисунок 2. Один обед — пять точек отказа одной системы; шестой конфликт, «кто выбирает блюдо», появляется вместе с вариативным меню (раздел 5.2). Параметры зала — по [24].

5.2. Почему все пять конфликтов — одна система

У каждого конфликта есть свой очевидный «виноватый»: медлительная сиделка, капризный С., неосведомлённая семья К., несдержанный П., нерадивый завхоз. Если остановиться на этом, каждый эпизод закончится выговором, и через неделю всё повторится. На деле перед нами не пять проступков, а пять точек отказа одной системы.

Справка. Системный подход к ошибкам. В науке о безопасности (медицинской, авиационной, промышленной) различают *индивидуальный* и *системный* взгляд на ошибку. Первый ищет виновного; второй спрашивает, какие условия сделали ошибку вероятной и почему её ничто не остановило. Повторяющийся сбой в одном и том же месте почти всегда указывает на устройство процесса, а не на характер исполнителя. Для столовой это значит: если последних кормят холодным каждый день, проблема не в сиделке, а в порядке подачи и в численности смены.

Конфликт	Отказ системы	Где в докладе решение
Очередь против помощи	Нет нормы помощи за столом и порядка подачи; услуга «кормление» закреплена, её время — нет	Разделы 20, 28
«Не ест кашу»	Нет журнала отказов, триггеров и маршрута дисфагии	Разделы 10, 12
Лекарства и кофе	Нет лекарственно-пищевой таблицы и информирования семьи	Раздел 11, приложение 32
Добавка	Ограничение рациона принято не врачом и не зафиксировано	Разделы 13, 17, 19
Журналы «в порядок»	Контроль имитируется	Разделы 31, 33

Для начала ни один из пяти конфликтов не требует денег: нужны решение директора и документы. Три из пяти упираются в кадровую нагрузку, и здесь честнее сразу назвать дефицит, чем делать вид, что его закроет приказ (раздел 28). Вариативное питание добавит шестой конфликт — «кто выбирает блюдо». Если пять базовых конфликтов не закрыты, шестой добьёт систему: выбор, который накладывается на хаос, только умножает хаос. Поэтому дорожная карта (разделы 35–36) начинается не с витрины, а с измерения и фундамента.

5.3. Сцена спустя год

Та же столовая, тот же час, но позади год работы по этому докладу. Женщина, которой нужна тишина, ест за тихим столом у окна. Мужчина на клозапине пьёт кофе в количестве, согласованном с врачом, и семья знает почему. Житель с дисфагией получает свою текстуру, и тарелка у него не выглядит «детской». Неговорящий житель показал на карточку и получил то, на что показал. Кормимых обслуживают тогда, когда рядом есть кому помочь, а не в порядке очереди. Смена работает по журналам, и журналы пишутся в тот день, о котором в них сказано.

Пять конфликтов не исчезли: люди по-прежнему отказываются от еды, просят добавки, пьют кофе и иногда давятся. Но каждый конфликт получил процедуру, и поэтому перестал быть делом настроения дежурной. В этом и состоит различие между столовой, где «так получилось», и столовой, где знают, что делать.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-a/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S040	Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг»
M-feedassist_simmons	Simmons S.F. et al. Prevention of unintentional weight loss in nursing home residents: a controlled trial of feeding assistance // J Am Geriatr Soc. 2008;56(8):1466–1473
M-choke_hemsley_review	Hemsley B. et al. Dying for a meal: an integrative review of characteristics of choking incidents... // Am J Speech Lang Pathol. 2019;28(3):1283–1297

6

Кто находится за столом

Глава 5 показала один обед. Эта глава спрашивает, для кого он готовится. Ответ кажется очевидным — для жителей, — но именно здесь совершается первая и самая дорогая ошибка: мысленно подменить живых людей «средним жителем». Ниже мы разбираем, из каких различий складывается контингент дома, как превратить эти различия в рабочую карту для кухни и смены и почему без такой карты любое меню, сколь угодно вариативное, промахивается.

6.1. Неоднородность как единственная норма

«Среднего жителя ПНИ» не существует. Это видно уже по агрегированным данным. По оценке проекта «Если быть точным», почти две трети (65 %) жителей российских ПНИ старше 45 лет, три четверти (74 %) признаны недееспособными, а каждый десятый (11 %) находится на постоянном постельном режиме[7]. Первые две доли относятся к 2022 году. Уточним формулировку прежней редакции: источник говорит именно о постоянном постельном режиме; отдельной доли маломобильных жителей в нём нет, и маломобильных в доме, разумеется, больше, чем лежачих.

За этими процентами стоит столовая, где одновременно сидят очень разные люди. Пожилой человек с шизофренией и возрастной дисфагией. Молодой мужчина с расстройством аутистического спектра, который не переносит определённых текстур. Женщина средних лет с аффективным расстройством и выраженным набором веса на препаратах. Человек с умеренной умственной отсталостью, который не читает меню. Житель в стойкой ремиссии, который готовится к переводу в сопровождаемое проживание, и ему навык «своего стола» нужнее, чем кому-либо.

Поэтому задача дома формулируется не как «накормить контингент», а как построение для каждой группы маршрута к еде, которая достаточна, безопасна и выбрана самим человеком. Разделы 9–14 разбирают этот маршрут по клиническим механизмам; здесь мы составляем карту, на которую эти механизмы ложатся.

6.2. Пять измерений неоднородности

Жители различаются не по одному признаку, а сразу по нескольким, и каждый признак по-своему меняет то, как человек ест и как он может выбирать.

Психическое состояние. Депрессия делает человека безразличным к еде. Мания и возбуждение не оставляют времени на то, чтобы сесть за стол. Психоз добавляет страх, что еда «отравлена». Тревога превращает шумную очередь в место, которого человек избегает. Важно, что состояние меняется волнами: один и тот же житель в разные недели нуждается в разной организации питания. Поэтому «особые состояния» — это штатный режим работы, а не авария (раздел 9.6; про отказ от еды — раздел 12).

Когнитивные функции. Диапазон здесь простирается от сохранного интеллекта до глубокой умственной отсталости и деменции. Для стола важна не юридическая «компетентность», а *способ*, которым человек выбирает: словом по меню, указанием на порцию, жестом или устойчивым рисунком того, что он ест и оставляет (раздел 15). Когнитивный статус определяет инструмент выбора, но не решает вопрос о том, есть ли у человека выбор вообще.

Коммуникация. Неговорящие и малоговорящие жители составляют значимую долю контингента. Вопрос «Что будете?» для них худший из возможных инструментов, и их выбор приходится фиксировать иначе. Международное право в лице Замечания общего порядка № 1 Комитета ООН по правам инвалидов к ст. 12 Конвенции о правах инвалидов требует опираться на *поддерживаемое*, а не *замещающее* принятие решений[31]. Что это означает в правовом смысле для российского дома, разобрано в разделах 16–17; для стола это означает, что персонал помогает человеку выразить выбор, а не выбирает за него.

Справка. Поддерживаемое и замещающее принятие решений. При *замещающей* модели решение за человека принимает другое лицо (опекун, учреждение), руководствуясь собственным представлением о его «наилучших интересах». При *поддерживаемой* модели решение остаётся за самим человеком, а окружающие помогают ему понять варианты и выразить волю доступным способом. Замечание общего порядка № 1 (2014) настаивает на переходе ко второй модели[31]. Это международный ориентир, а не норма российского права о питании; правовой режим дееспособности и опеки изложен в разделе 16.

Соматическое состояние. Сюда относятся дисфагия (раздел 10), диабет и метаболический синдром (разделы 11 и 13), сердечно-сосудистые болезни, которые в шведском регистре оказались ведущей причиной избыточной смертности при шизофрении[32], а также запоры. Последние заслуживают отдельного слова: у людей, принимающих клозапин, запор встречается часто и может быть опасен для жизни — тяжёлая гипомотильность кишечника способна привести к непроходимости и перфорации[33]. Ведение запора — дело врача, а не кухни (раздел 4.0), но пищевой и питьевой режим, который замечает и фиксирует смена, — часть наблюдения. Наконец, эпилепсия добавляет риск аспирации при приступе за столом. Соматическая карта жителя очерчивает рамку, внутри которой возможен выбор.

Жизненный опыт и культура. «Всю жизнь ужинал в девять», религиозные правила, блюда детства и праздников — всё это якоря идентичности, и у человека, утратившего многое, они особенно прочны. Немецкий стандарт качества питания для учреждений, где живут пожилые люди, предусматривает сбор «пищевой биографии» при поступлении[34]; при утрате речи позднее она может оказаться единственным доступом к воле человека. Тот же круг немецких стандартов требует, чтобы перекусы были доступны в любое время[35]. Форма пищевой биографии — приложение 3; религиозные ограничения разобраны в разделе 15.

Справка. Пищевая биография. Так называют записанные при поступлении (со слов человека, родственников, по прежним документам) сведения о его пищевых привычках: что он любит и не ест, когда привык есть, какие блюда связаны с семьёй, праздниками, верой, в какой обстановке ест спокойнее. В немецкоязычной практике это *Essbiografie*[34]. Её смысл не в анкете ради анкеты: когда человек перестаёт говорить, записанная биография становится одним из каналов его воли (раздел 15).

6.3. Классификация для практики

Карта неоднородности полезна только тогда, когда ею можно пользоваться у раздачи, а не тогда, когда она красиво висит на стенде. Ниже предложена рабочая классификация: она объединяет жителей не по диагнозам, а по тому, что нужно им за столом.

Группа	Как распознать	Главный риск за столом	Маршрут питания
Самостоятельные, стабильные	Едят сами, выражают предпочтения словом	Однообразие, «столовская» еда	Полный выбор, участие в совете жителей
Самостоятельные, нестабильные	Волнообразное состояние	Пропуски приёмов при обострении	Выбор плюс режим «особых состояний» в пищевой карте
Маломобильные	Едят в жилой зоне	Холодная еда, обслуживание «в последнюю очередь»	Подача под готовую помощь, контроль температуры
Нуждающиеся в кормлении	Не могут есть сами	Недоедание, аспирация «на скорость»	Ориентир помощи 1:2 (раздел 20), медленный темп
Неговорящие и малоговорящие	Не отвечают на вопрос о выборе	Подмена выбора удобством персонала	Показ порций, наблюдение, пищевая биография
С дисфагией	Покашливание, «влажный» голос, долгий приём пищи	Аспирация, пневмония	Назначенная врачом текстура, поза, темп (раздел 10)
С выраженным набором веса	Прибавка 5 % и более за 3 месяца на препаратах	Метаболический синдром	Мониторинг, пищевая среда, без самостоятельных «диет» (раздел 13)
С сенсорной избирательностью	Едят узкий круг блюд, отвергают смешанные текстуры	Обеднение рациона, конфликт при «ломке» привычек	Безопасный вариант в каждом приёме, расширение внутри привычного ряда (раздел 9.2)
С расстройствами пищевого поведения	Переедание, ночная еда, пикацизм, заглатывание	Соматические и бытовые риски	Индивидуальные протоколы (разделы 13, 14)

Таблица — проект рабочей классификации для локального использования, не нормативный документ. Один житель может входить в несколько групп одновременно.

Строка о сенсорной избирательности добавлена в этой редакции. Обзор 2025 года, посвящённый питанию взрослых с аутизмом, констатирует, что взрослые с расстройствами аутистического спектра, по-видимому, выбирают еду прежде всего по сенсорному восприятию, и что такой выбор может вести к избыточному весу и дефициту отдельных нутриентов[36]. Те же авторы подчёркивают, что данные о взрослых скудны и большая часть знаний получена на детях. Механизм и тактика стола изложены в разделе 9.2.

6.4. Что сказать повару в понедельник

Пять первоочередных действий раздела 4.2 остаются в силе. Эта глава добавляет к ним пять чисел, без которых меню планируется для абстракции: сколько жителей едят сами; сколько едят с помощью; сколько не говорят или говорят мало; сколько входят в группу дисфагического риска; сколько получают препараты, повышающие вес. Форма для их сбора — приложение 35. Способ получить эти числа за один обход описан в разделе 6.7.

6.5. Почему «средний житель» — опасная конструкция

«Средняя порция» промахивается в обе стороны, и промахи не взаимно погашаются, а складываются. Житель с гиперфагией получает «среднее», остаётся голодным и ищет еду ночью и в чужих тарелках (раздел 13). Житель в депрессивной фазе оставляет две трети порции, отходы растут, его вес падает, но учёт видит «норму», потому что среднее по отделению не изменилось. Одного перекормили, другого недокормили, а в отчёте всё в порядке.

Исследования показывают, что разрыв между выданным и съеденным распределяется по жителям неравномерно. В новозеландском доме ухода, где сравнивали запланированное меню, поданное и съеденное, наибольшие потери питательных веществ и наименьшее потребление были связаны со старшим возрастом, женским полом, более высоким уровнем ухода, меньшим размером порции, протёртым рационом и низким индексом массы тела[37]. Иначе говоря, больше всего недоедают как раз те, кто и без того наиболее уязвим, и именно их «среднее» прячет лучше всего. Общий масштаб этого разрыва приведён в разделе 7.1. Исследование выполнено в одном учреждении на 54 жителях и о российских ДСО и ПНИ прямо ничего не говорит; но механизм — уязвимые теряются в среднем — от страны не зависит.

Защита от этой ловушки — смотреть на распределение, а не на среднее. Простейший показатель: сколько жителей оставляют больше трети порции. Форма замера остатков (приложение 25) поэтому построчная, по каждому жителю, а не по котлу.

6.6. Контингент меняется — карта стареет

Пять чисел раздела 6.4 не константа. Контингент стареет, доля лежащих и нуждающихся в помощи растёт, лекарственные назначения меняются. Числа годичной давности описывают питание людей, которых в этом составе уже нет. Поэтому ежеквартальное обновление карты — не бюрократия, а калибровка прицела.

Самый дорогой вид устаревания карты — рост группы, которой нужна помощь, без роста ставок. Последствия проявляются в определённом порядке: сначала страдает темп кормления, потом масса тела жителей и лишь потом, если повезёт, это отражается в документах. Насколько велика разница во времени между «покормили» и «помогли поесть», показано в разделе 5.1; кадровые решения — в разделе 28.

6.7. Как собрать пять чисел за один обход

Для этого не нужны ни статистик, ни неделя работы. Достаточно обхода с заведующими отделениями, который занимает около полутора часов. Каждая заведующая называет числа своего отделения по памяти, а затем они сверяются со списком жителей. Точность «из головы» — не недостаток, а смысл метода: если заведующая не может назвать число кормимых в своём отделении, эта находка важнее самого числа.

Второй проход делает врач. Он отмечает жителей на препаратах, повышающих вес (по таблице раздела 11), и тех, кому назначены изменённые текстуры. Третий проход — старшие смен: они знают, кто оставляет еду, кто ест ночью и кто «не ест в зале». Три прохода дают живую карту, на

которую опираются разделы 19–20. Обновлять её следует раз в квартал, и для этого в панели показателей предусмотрена отдельная строка (приложение 35).

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-a/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-menu_decay_nanayakkara	Nanayakkara W.S. et al. From menu to mouth: the decay pathway of nutrient intake from planned menu to consumed...// BMJ Open. 2019;9(10):e024044
M-autism_adults_remon	Remón S., Ferrer-Mairal A., Sanclemente T. Food and Nutrition in Autistic Adults: Knowledge Gaps and Future Perspectives // Nutrients. 2025;17(9):1456

В главе также исправлена привязка маркеров прежней редакции: клозапиновый запор подкреплён маркером M-constip_ep (уже имеющимся в разделе 44) вместо M-mortality2, который относится к сердечно-сосудистой смертности; пищевая биография — маркером l-dge (стандарт для пожилых, где описана *Essbiografie*) наряду с l-dge_betr.

Что значит «накормить»

В управленческой речи слово «накормить» обычно означает одно: порция выдана по норме и съедена. Эта глава доказывает, что такого понимания недостаточно, и не из соображений гуманизма, а по сугубо практической причине: одномерное «накормить» само производит недоедание, конфликты и нарушения. Мы разложим понятие на шесть измерений, у каждого из которых есть свои нормы, свои типовые провалы и свои измерители, а затем покажем, как за один день проверить все шесть на собственной линии раздачи.

7.1. Шесть измерений одной тарелки

1. Достаточность. Масса и состав рациона должны покрывать рекомендуемые нормы питания Минтруда России (приказ № 520н) и региональные нормы, принятые на их основе[11, 12, 38]. Но измеряется достаточность не раскладкой, а фактическим потреблением: порция, которая выдана и не съедена, достаточностью не является.

Насколько велик этот разрыв, показало новозеландское исследование, проследившее путь питательных веществ от запланированного меню до тарелки и от тарелки до съеденного. В среднем жителям подавали 91 % запланированной энергии и 89 % белка, а съедали лишь 73 % и 69 % соответственно[37]. Около четверти запланированной энергии и почти треть белка терялись по дороге, причём большая часть — уже на тарелке. Авторы формулируют вывод прямо: «Не всё запланированное и поданное съедается» (в оригинале: *"Not all planned and served food and beverages are consumed"*). Это одно учреждение в Новой Зеландии, и его проценты нельзя приписывать российскому дому. Но они объясняют, почему замер остатков (приложение 25) — не формальность, а единственный способ узнать, сколько нормы на самом деле доходит до человека. О том, кто именно теряется в этом разрыве, — раздел 6.5.

2. Безопасность. Здесь три слоя. *Санитарный* слой включает пробы, температурный режим, отдельные потоки и питьевой режим: на дату семинара действовал СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а с 01.09.2026 его сменил СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (п. 56 подп. 11–13, п. 62)[9]; подробно — раздел 18. *Клинический* слой — это назначенные врачом текстуры при дисфагии (раздел 10) и лекарственно-пищевые ограничения (раздел 11). *Поведенческий* слой — защита от заглатывания, пикацизма и отбирания еды (раздел 14). Провал в любом из слоёв означает не «недовольство качеством», а ответственность (раздел 33)[10].

3. Удовольствие. Вкус, температура, внешний вид, разнообразие. Для человека, живущего в учреждении, еда — главное ежедневное переживание, и удовольствие от неё не роскошь, а фактор потребления: невкусное съедается хуже, и это ведёт к недоеданию при формально достаточных нормах. Международные нормы прямо связывают качество и привлекательность блюд с нутритивными исходами[34, 39]. Измерители — остатки и жалобы.

4. Социальность. Разговор, общий ритм, участие персонала. Финская национальная рекомендация закрепляет совместные трапезы персонала и проживающих как элемент качества[40]. Наиболее известное подтверждение пользы социальной организации стола — нидерландское кластерное рандомизированное исследование «семейной» подачи[41, 42]. В пяти домах сестринского ухода 178 жителей (средний возраст 77 лет) полгода получали еду либо в общих блюдах, из которых накладывали сами, либо, как обычно, порционно на тарелках. В группе семейной подачи качество жизни сохранилось, а в контрольной снизилось (межгрупповая разница 6,1 балла); масса тела различалась на 1,5 кг; суточное потребление энергии — на 991 кДж, то есть примерно на 240 ккал; доля жителей с недостаточностью питания по шкале MNA в группе вмешательства снизилась с 17 до 4 %, а в контрольной выросла с 11 до 23 %[42].

Две оговорки обязательны. Первая: в исследование включали жителей соматических отделений (после инсульта, с болезнью Паркинсона и т. п.), а деменция была критерием *исключения*; к психиатрическому контингенту результаты прямо не переносятся. Вторая: картина в целом менее однозначна, чем один удачный эксперимент. Систематический обзор 2013 года, объединивший 36 исследований вмешательств во время еды в учреждениях длительного ухода (обстановка столовой, способ подачи, обучение персонала, помощь в еде), оценил их качество в целом как низкое; объединённый анализ рандомизированных исследований не показал однозначного влияния на массу тела, а для изменений обстановки столовой прирост суточной энергии (около 181 ккал) не достиг статистической значимости[43]. Авторы заключают, что простые изменения трапезы, возможно, улучшают питание, но для окончательного вывода нужны крупные прагматические испытания. Для дома это значит: социальная организация стола — обоснованная и дешёвая мера, но не гарантированное лекарство от недоедания.

У социальности есть и практическая выгода, которую не измеряют исследования: работник, который сидит за общим столом, замечает «он сегодня не жуёт» раньше, чем это появится в журнале. Это бесплатный мониторинг.

5. Самостоятельность. Пройти линию, выбрать, поесть приборами, убрать за собой. Для части жителей это реабилитация, подготовка к сопровождаемому проживанию; в России такие программы действуют и расширяются[7] (подробнее — раздел 8.8). Стол, который делает за человека всё, закрепляет зависимость. Поточная линия с самообслуживанием, как отмечает одно из российских учреждений, «развивает навыки самообслуживания»[24]. Отечественный стандарт контроля качества социальных услуг добавляет к этому важную мерку: помощь тем, кто утратил способность к самообслуживанию, в том числе при еде, оценивается по тому, позволяет ли она выполнить нужные процедуры без вреда, физических или моральных страданий и неудобств, и проявляет ли персонал деликатность и корректность[44]. Помощь, которая отнимает у человека то, что он ещё может сделать сам, этой мерке не соответствует.

6. Выбор. Что, когда, где и как есть — формула австралийского стандарта «Еда и питание»[45]. Это единственное измерение, которое нельзя делегировать: систему можно построить за человека, решение — нет. Здесь сходятся право (разделы 16–17), технология (разделы 19–22) и собственно тема семинара. Определение вариативности и её отличия от циклического меню и таблицы замен — раздел 8.1.

Справка. Что проверяет отечественный стандарт качества. ГОСТ Р 52496-2019 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения» (утверждён приказом Росстандарта от 06.09.2019 № 641-ст, введён с 01.05.2020) при контроле горячего питания в учреждениях предписывает проверять доброкачественность продуктов, калорийность, соответствие норм питания и санитарных требований и учёт состояния здоровья получателей (п. 4.3.6); помощь при самообслуживании — по отсутствию вреда и страданий и деликатности персонала (п. 4.3.7)[44]. Слов «выбор» или «пожелания» применительно к питанию в стандарте нет. Иными словами, отечественная мерка качества покрывает измерения 1, 2 и отчасти 5, но не 3, 4 и 6. Национальные стандарты по общему правилу применяются добровольно; это ориентир для внутреннего контроля, а не основание для санкций.

7.2. Матрица провалов

Типовой провал каждого измерения виден без специальных обследований:

Измерение	Типовой провал	Быстрый измеритель
Достаточность	Норма на бумаге, недоедание на тарелке	Доля несъеденных порций (7-дневный замер)
Безопасность	Журналы есть, контроль имитируется	Сверка фактических проб с графиком без предупреждения
Удовольствие	«Столовая» еда, однообразие	Блюда-аутсайдеры по остаткам; жалобы
Социальность	Столовая как конвейер, тишина или команды	Наблюдение за одним обедом: есть ли разговор
Самостоятельность	Всё делают за жителя	Доля жителей, проходящих линию самостоятельно
Выбор	Решает кухня	Ответ жителя на вопрос «что ты сегодня выбрал?»

«Накормить» — это шесть задач, а не одна. Поэтому на фразу «питание у нас в порядке» правильный ответ — встречный вопрос: по какому из шести измерений? Деньги закрывают в основном первые три; последние три требуют прежде всего организации и документов. Вариативное питание работает тогда, когда первые пять измерений не провалены: выбор, надстроенный над недоеданием или имитацией контроля, ничего не исправляет.

7.3. Два набора по шесть: измерения тарелки и проверки линии

В прежней редакции этой главы рядом стояли два разных списка из шести пунктов, и это стоит объяснить, чтобы они не путались. Раздел 7.1 описывает шесть **измерений тарелки** — того, чем должна быть еда для человека: достаточность, безопасность, удовольствие, социальность, самостоятельность, выбор. Разделы 7.4 и 7.6 пользуются шестью **ракурсами проверки** — того, как руководитель смотрит на свою линию: безопасность, физиология, психология, социальность, право, экономика.

Эти наборы пересекаются, но не совпадают. Безопасность и социальность есть в обоих. «Физиология» проверки охватывает достаточность и режим (в том числе ночной интервал). «Психология» отвечает за удовольствие и за то, значима ли еда для человека. «Право» проверяет реальность выбора. «Экономика» в измерениях тарелки отсутствует, потому что для жителя она не измерение, а для директора — условие всех остальных. Самостоятельность в наборе проверок

отдельно не выделена и проверяется в матрице 7.2 по доле жителей, проходящих линию сами. Пользоваться стоит обоими наборами, понимая, что первый отвечает на вопрос «что мы должны дать», а второй — «где мы проваливаемся сегодня».

7.4. Проверка каждого измерения на вашей линии

Шесть проверок по десять минут за один день. Проводить их лучше не директору, а тому, кто будет честен.

- **Безопасность.** Сколько жителей из списка риска едят вне поля зрения смены?
- **Физиология.** Сравните время ужина и завтрака с шведским ориентиром ночного интервала — не более 11 часов[39]. Пример: ужин в 17:30 и завтрак в 8:30 дают 15 часов без еды. Без замера в собственном доме называть такой распорядок типовым для России нельзя. Рабочая цель доклада и международный диапазон изложены в разделах 13.9 и 26.
- **Психология.** Вечером спросите у трёх жителей, что было на обед. Если не помнят или отвечают «как обычно», еда стала фоном.
- **Социальность.** Ест ли персонал вместе с жителями или «потом, на кухне»? Второй ответ описывает культуру стола точнее любого положения.
- **Право.** Реален ли выбор (приложение 24)?
- **Экономика.** Сырьевая строка в расчёте на жителя — минута деления (приложение 25).

Ни одна из проверок не стоит ни рубля. Вместе они дают карту первого провала, и начинать нужно именно с него, а не с красивого проекта.

7.5. Граница измерений: что не входит

Два понятия сознательно оставлены за рамкой. **Кулинарное качество** как искусство важно, но не является предметом системы. Свежесть, температура, рецептура — да; субъективный вкус — нет: им занимаются совет жителей и дегустации (раздел 34), а не нормативы. **Медицинская нутрициология** в полном объёме, то есть расчёт нутриентов под конкретные заболевания, — дело врача и, где он есть, диетолога. Доклад организует исполнение назначений, но не подменяет их содержание. Эти границы защищают систему питания с двух сторон: от кулинарного эстетства и от псевдомедицины.

7.6. Минимальная планка каждого измерения

На каждый ракурс проверки — одно действие:

- **Безопасность:** список риска находится на посту.
- **Физиология:** ночной интервал не превышает 13 часов. Это рабочий ориентир авторов внутри международного диапазона 11–14 часов, а не российская норма (разделы 13.9 и 26).
- **Психология:** меню показывают каждому жителю ежедневно.
- **Социальность:** в зале есть хотя бы один «тихий стол».
- **Право:** ведётся журнал замен.

- **Экономика:** сырьевая строка посчитана.

Это не идеал, а вывод из зоны отказа. Так собирается минимальная безопасная модель раздела 4: не совершенство в одном измерении при провале в пяти остальных, а планка, взятая во всех шести.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-bloka/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-menu_decay_nanayakkara	Nanayakkara W.S. et al. From menu to mouth... // BMJ Open. 2019;9(10):e024044
M-familystyle_nijs_intake	Nijs K.A.N.D. et al. Effect of family-style meals on energy intake and risk of malnutrition in Dutch nursing home residents: RCT // J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2006;61(9):935–942
M-mealtime_abbott_sr	Abbott R.A. et al. Effectiveness of mealtime interventions on nutritional outcomes for the elderly living in residential care: systematic review and meta-analysis // Ageing Res Rev. 2013
S041	ГОСТ Р 52496-2019 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения» (приказ Росстандарта от 06.09.2019 № 641-ст)

8

От мономеню к вариативности: лестница моделей

Эта глава — терминологический и организационный центр доклада. В ней даётся определение вариативного меню, на которое опираются все остальные разделы, описываются шесть моделей организации раздачи от мономеню до «своей кухни» и отдельно — ступени участия жителя, то есть мера того, насколько еда возвращена под его контроль. Эти две шкалы пронумерованы одинаково, от нуля до пяти, но измеряют разные вещи, и смешивать их нельзя. Последние разделы главы объясняют, как честно определить, где стоит дом сегодня, почему вариативность легко откатывается назад и зачем она нужна тем, кто готовится жить вне интерната.

8.1. Термины, чтобы не путаться

В разговорах о вариативности обычно смешивают четыре разные вещи.

Цикличное меню — это повторяющийся цикл блюд: 14 дней в российских раскладках, 21 день в канадской провинции Онтарио, четыре недели по немецкому стандарту[24, 27, 34]. Цикл обеспечивает разнообразие во времени, но не выбор: каждый день все получают одно и то же.

Вариативное меню — это ситуация, когда в одной точке приёма пищи существует больше одного варианта и житель выбирает из них.

Замена по таблице — эквивалентная замена продуктов в раскладке, которая десятилетиями присутствует в нормах питания[11, 12]. Таблица замен делает вариативность законной (раздел 19), но сама по себе выбором жителя не является: её применяет кухня, исходя из остатков и поставок.

Персонализация — это индивидуальные назначения: текстура пищи, ограничения, усиленное питание. Они существуют вне общего выбора и назначаются врачом (разделы 10, 11, 13).

Типичная ошибка состоит в том, чтобы назвать «вариативным» цикличное меню («14 дней без повторов») или таблицу замен («поменяли гречку на рис по остаткам»). Ни в том, ни в другом случае у жителя выбора нет. Поэтому в докладе понятие вариативности используется в строгом смысле: **в момент еды житель реально может получить не менее двух вариантов и сам влияет на то, какой из них получит.**

Справка. Почему определение строгое. В соседних материалах встречаются более широкие определения: выбор не только в момент приёма, но и «на период» (сутки, неделю), или заказ заранее вместо выбора у раздачи; в синонимы иногда включают «шведский стол». Доклад сознательно держит узкое определение, чтобы отличить реальный выбор от его видимости. Заказ накануне при этом не исключается: он остаётся вариативностью, если заказанное действительно доходит до тарелки. Расхождения определений в корпусе не сглаживаются и перечислены в wiki-реестре пробелов.

8.2. Лестница моделей

Между мономеню и «полным выбором» лежит лестница. Каждая из шести моделей (M0–M5) — это рабочая конфигурация с известной ценой и известными рисками, а не оценка «хорошо» или «плохо». Модели M1–M2 подтверждены публикациями российских учреждений: Болотнинского и Успенского ПНИ Новосибирской области, Усть-Илимского дома социального обслуживания и нескольких учреждений Иркутской области[2, 3, 4, 6]. Это сообщения самих учреждений и ведомств, а не независимый аудит (раздел 25).

Справка. Модель и ступень. Модель (M0–M5) описывает технологию раздачи: сколько вариантов, где и как житель их получает. Ступень участия (0–5, раздел 8.6) описывает, сколько контроля над едой возвращено конкретному человеку. Дом может работать по модели M2 и при этом держать многих жителей на нулевой ступени участия, если выбор за них делает смена. Нумерация совпадает случайно; оси разные.

Модели раздачи M0–M5

технология: сколько вариантов и как их получают

Ступени участия 0–5

мера контроля над едой, возвращённого жителю



Нумерация совпадает случайно: дом на модели M2 может держать жителя на ступени 0, если выбор за него делает смена. Ступень проверяют вопросом: что изменилось в его тарелке сегодня?

☐ фундамент / неучастие
 ☐ символическое участие
 ☐ выбор доходит до тарелки
 ☐ применимо выборочно
☐ горизонт тренировочных квартир

↓ Лестница работает в обе стороны: без приказа, ротации ответственных и квартальной панели выбор тихо откатывается вниз (раздел 8.5).

Рисунок 3. Две лестницы с одинаковой нумерацией и разными осями: модели раздачи (раздел 8.2) и ступени участия жителя (раздел 8.6). Модели M1–M2 описаны в сообщениях российских учреждений[2, 3, 4, 6].

Модель M0. Мономеню с учётом отказов. Выбора нет, но отказ от блюда влечёт замену по таблице, так что житель не остаётся голодным, а остатки влияют на следующий цикл. Это ещё не вариативность, а её фундамент. Американская федеральная норма требует альтернативы сходной питательной ценности при отказе как базового минимума[46]; подробно — раздел 26.

Модель М1. Выбор из двух вариантов в одной позиции. Второй вариант ключевого блюда (каша А или каша Б, второе А или второе Б) предлагается на части приёмов пищи и в часть дней. Так начинал Болотнинский ПНИ: «несколько раз в неделю», на завтрак и обед, а перечень блюд определяет диетсестра[2]. Усть-Илимский дом вводил выбор поэтапно, начиная с жителей, которые посещают столовую, и предварительно опросив их о предпочтениях[4]. Цена модели — вторая гастрорёмкость и журнал заказа; при подборе парных эквивалентов новых денег почти не требуется (раздел 29).

Модель М2. Выбор по всем основным позициям ежедневно. Два варианта первых, вторых, гарниров и напитков каждый день. По публикациям, так работает Успенский ПНИ во всех отделениях (два вторых, два салата, два напитка)[3] а в Иркутской области выбор из двух первых, двух вторых блюд и гарниров описан для одного отделения Марковского геронтологического центра с сентября 2024 года[6]. Единой региональной модели в источнике нет: четыре учреждения области работают по-разному, а Чунский ПНИ «Радуга» с февраля 2023 года использует зону самообслуживания, близкую к модели М3 (раздел 25.6). Модель требует журнала заказа и пересчёта объёмов варки по статистике выбора (раздел 21).

Модель М3. Выбор на линии раздачи («шведский стол»). Житель сам комплектует тарелку из выставленного ассортимента. Выбора становится больше, но вместе с ним растут требования к площади раздачи, скорости потока и санитарному контролю открытых блюд[9]. Для ПНИ эта модель применима выборочно. Публично такая линия описана у ДДСОЛ[24]. Успенский ПНИ, вопреки иногда встречающемуся описанию, работает по модели М2, а не М3: шведской линии в его сообщении нет[3].

Модель М4. Семейная подача за столом. Блюда ставят на стол в общей посуде, и жители накладывают себе сами. Эффект такой подачи измерен в нидерландском кластерном рандомизированном исследовании: у жителей домов сестринского ухода сохранялись качество жизни, мелкая моторика и масса тела и росло потребление энергии[41, 42]; числа приведены в разделе 7.1. Важное уточнение к прежней редакции: в это исследование включали жителей *соматических* отделений, а деменция была критерием исключения, так что говорить о «доказанном эффекте у пожилых с деменцией» нельзя. Для психиатрического контингента прямых данных нет. Модель применяется точно, там, где позволяют рассадка и поведение за столом, а роль персонала смещается от раздачи к сопровождению.

Модель М5. «Своя кухня». Жители готовят сами при поддержке персонала. Так устроены британские реабилитационные отделения с самостоятельным приготовлением пищи (*self-catering*)[47] и американские малые дома по модели Green House[48]. Для российского дома это горизонт квартир тренировочного проживания и подготовки к сопровождаемому проживанию, а не массовая модель (раздел 8.8).

Насколько велик разрыв между декларируемой и фактической вариативностью, показывает австралийское исследование планирования меню в домах престарелых. В национальном опросе 274 учреждений, анализе меню 161 дома и наблюдении 36 трапез выяснилось, что в обед 64 % общих меню предлагали один вариант и лишь 36 % — два; при этом *в наблюдаемых трапезах выбора в обед не было ни для одной группы*. Меню для изменённых текстур почти не давали выбора, а в 69 % наблюдений жители выбирали блюда за два дня и более[49]. Авторы заключают: «Выбор был низким во всей выборке, но особенно — у получающих протёртые диеты с изменённой

текстурой» (*"Choice was low for the entire sample, but particularly for those receiving pureed texture modified diets"*). Австралийская система ухода устроена иначе российской, и проценты не переносятся. Но два урока универсальны: меню на бумаге ещё не означает выбора на тарелке, и группа с изменённой текстурой теряет выбор первой (о выборе внутри текстуры — раздел 10.10).

8.3. Критерии реального выбора

Любую модель можно проверить пятью критериями. Формальная «вариативность» на них отсеивается (раздел 22 и приложение 24).

1. **Доступность.** Вариант Б существует в тот момент, когда к раздаче подходит житель, а не «закончился на первом отделении».
2. **Равноценность.** Варианты эквивалентны по питательной ценности, то есть подобраны по таблице замен, а не по принципу «гречка или ничего»[11]. Подбор пар эквивалентов — раздел 19.
3. **Информированность.** Житель знает о выборе и понимает его доступным для себя способом: словом, показом порций, визуальным меню (раздел 15).
4. **Уважение.** Выбранное подаётся. Переубеждать «для вашей же пользы» — не норма; ограничения рациона вправе устанавливать только врач.
5. **Учёт.** Выбор фиксируется и влияет на завтрашние объёмы и будущие циклы меню (раздел 21).

Модель без хотя бы одного из пяти критериев остаётся вариативностью на бумаге. Австралийские наблюдения из раздела 8.2 нарушают сразу два: доступность (выбора в обед не было) и информированность (выбор за несколько дней для людей с когнитивными нарушениями мало осмыслен).

8.4. Что сказать повару в понедельник

Понедельник раздела 4.2 — это замер остатков и журналы. Эта глава добавляет одну задачу на неделю: честно определить, на какой модели стоит дом — М0, М1 или М2. Подтверждённые российские практики находятся именно на этом участке лестницы, на моделях М1–М2[2, 3, 4, 6]. Если журналы ведутся хаотично, начинать нужно с М0. Если документы в порядке, можно переходить к М1 на одном отделении (пилот — раздел 35).

8.5. Движение вниз по лестнице: тихий регресс

Лестница работает в обе стороны, и вниз по ней движутся чаще, чем вверх. Сценарий узнаваем. Уходит инициатор — заведующая или диетсестра. Показ меню «временно» упрощают. Через квартал журнал ведётся «для проверки», и выбор снова делает кухня. Снаружи учреждение по-прежнему «внедрило» вариативность: положение действует, отчёт сдан.

Регресс читается в панели показателей раньше, чем появляются жалобы. Падает доля жителей, выбирающих вариант Б; растёт доля «стандартных» порций; пустеет журнал срывов — не потому, что срывов не стало, а потому, что их перестали записывать. Противоядие состоит в том, чтобы

опереть практику на документ и ритм, а не на человека: приказ, ротация ответственных, квартальная панель (раздел 31). Практику, которая пережила смену двух заведующих, можно считать устоявшейся. До этого рубежа она остаётся проектом энтузиаста.

8.6. Лестница участия жителя: критерий измерения

Примечание: нумерация ступеней участия (0–5) не совпадает с моделями организации (М0–М5, раздел 8.2). Это разные оси: модели описывают технологию раздачи, ступени участия — меру контроля над едой, возвращённого жителю.

Образ лестницы участия заимствован из классической работы американского исследователя Шерри Арнстайн о гражданском участии (1969)[50]. Её лестница из восьми ступеней поднимается от «манипуляции» и «терапии» (неучастие) через «информирование», «консультацию» и «умиротворение» (символическое участие) к «партнёрству», «делегированной власти» и «гражданскому контролю». Главная мысль Арнстайн применима к столовой почти дословно: «участие без перераспределения власти — пустой и унижительный процесс для бесправных» (в оригинале: *"participation without redistribution of power is an empty and frustrating process for the powerless"*). Спросить жителя и всё равно принести ему то же самое — это и есть «консультация» в смысле Арнстайн: ритуал без последствий.

Справка. Лестница Арнстайн. Sherry R. Arnstein, «A Ladder of Citizen Participation», журнал Американского института планировщиков, 1969[50]. Работа написана о городском планировании и программах борьбы с бедностью в США, а не о питании или психиатрии. Мы используем её как понятийную рамку: участие измеряется не тем, спросили ли человека, а тем, изменило ли его слово результат. Ступени участия жителя в этом докладе — собственная адаптация авторов, а не перевод восьми ступеней Арнстайн.

Ступень участия определяется одним вопросом: **что изменилось в тарелке конкретного жителя сегодня?** Проверка идёт через жителя, а не через документ.

- **Нулевая ступень:** еду определили регион, кухня и смена.
- **Первая:** жителя спросили, но тарелка осталась той же.
- **Вторая:** выбор дошёл до тарелки сегодня.
- **Третья:** до жителя дошёл выбор также времени и места еды.
- **Четвёртая:** житель влияет на меню через совет жителей (раздел 34).
- **Пятая:** еда снова стала частью жизни, а не процедурой.

Вопрос «на какой ступени мы находимся» звучит абстрактно, пока он не задан про одного жителя, названного по имени. После этого он становится планом. Отметим, что семинарская раздаточная формулирует ступени чуть иначе («спрашивают, готовят одно»; «два варианта на линии ежедневно»); это не модели М1 и М2, и склеивать их не следует.

8.7. Как определить свою ступень за 15 минут

Самооценка почти всегда завышена: «у нас выбор» при проверке оказывается «спрашиваем, но готовим одно». Поэтому ступень определяют не по мнению, а по трём вопросам к фактам.

1. **Покажите вчерашний журнал.** Если вчерашней записи о выборе нет, то, что бы ни говорило положение, дом не поднялся выше первой ступени.
2. **Был ли второй вариант вчера физически на линии?** Спросите смену и сверьте ответ с журналом срывов.
3. **Кто вчера выбрал не то, что принесли бы по умолчанию?** Если ответ «таких нет» звучит третью неделю подряд, выбор декоративен.

Ответы на эти вопросы ставят оценку без субъективности. Полная форма есть в семинарском пакете («форма ступени»). Здесь нужна оговорка: эта форма, несмотря на название, определяет **модель раздачи** М0–М5 по разделу 8.2, а не ступень участия по разделу 8.6. Три вопроса к фактам работают для обеих осей, но по-разному: для модели они показывают, существует ли выбор на линии, а для ступени участия дают её нижнюю границу — если выбор не доходит до тарелки, вторая ступень не достигнута ни для кого. Правило для обеих осей одно: **оценка — это вчерашний день, а не положение.**

8.8. Еда как навык сопровождаемого проживания

Сопровождаемое проживание в России уже не гипотеза. По данным проекта «Если быть точным», в 2024 году услуги сопровождаемого проживания получали около семи тысяч человек, что меньше 5 % от числа подопечных ПНИ[7]. Прежняя редакция говорила, что эти люди «вышли из ПНИ»; источник этого не утверждает. На начало 2024 года 74 % получателей таких услуг жили в учебных (тренировочных) квартирах, и почти 80 % из них получали услуги на базе ПНИ; на постоянном, а не учебном сопровождаемом проживании живут, по оценке того же источника, не более 1,8 тысячи человек[7]. Иначе говоря, большинство пока учится жить самостоятельно, оставаясь в системе интерната, — и именно поэтому навык обращения с едой нужно тренировать внутри дома.

Человек, который десятилетиями не выбирал даже кашу, на выходе встречает магазин и плитку как чужой язык. Ступени участия 3–5 (время и место, совет жителей, своя кухня) — это не «ресторан для интерната», а тренировка: назвать, показать, отказаться, убрать за собой. Вариативное меню внутри дома и менее институциональные формы жизни поэтому не конкурируют друг с другом: первое готовит навык, без которого второе остаётся лозунгом. На ближайший год для большинства домов реалистичны ступени 1–2; ступень 5 и модель М5 — горизонт тренировочных квартир, а не массовая практика (раздел 8.2).

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-a/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/poisk-2026-10-blok-a/istochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
I-menu_choice_abbey	Abbey K.L., Wright O.R.L., Capra S. Menu Planning in Residential Aged Care – The Level of Choice and Quality of Planning of Meals Available to Residents // <i>Nutrients</i> . 2015;7(9):7580–7592
I-ladder_arnstein	Arnstein S.R. A Ladder of Citizen Participation // <i>Journal of the American Institute of Planners</i> . 1969;35(4):216–224
M-familystyle_nijs_intake	Nijs K.A.N.D. et al. Effect of family-style meals on energy intake and risk of malnutrition... // <i>J Gerontol A Biol Sci Med Sci</i> . 2006;61(9):935–942

ЧАСТЬ 3

Клиника за столом

разделы 9–14

9

Пищевое поведение при психических расстройствах

Этот блок открывает клиническую часть доклада. Шесть глав (9–14) описывают, что происходит с едой у людей с психическими расстройствами и что из этого следует для организации стола. Настоящая глава — обзорная: она называет основные паттерны пищевого поведения и показывает, как стол должен их предвидеть. Подробные механизмы дисфагии, лекарственных взаимодействий, отказа, гиперфагии и пикацизма изложены в следующих главах, и здесь мы отсылаем к ним, а не пересказываем.

9.1. Почему обычные правила здесь работают иначе

Стационарный стол рассчитан на «среднего едока»: он приходит вовремя, сидит за столом 20–30 минут, съедает то, что дали, и говорит, если что-то не так. Психические расстройства нарушают каждое из этих допущений, и нарушают системно, а не от случая к случаю. Поэтому стол в ПНИ должен заранее предвидеть паттерны, о которых пойдёт речь ниже.

Справка. Паттерн пищевого поведения. Под паттерном здесь понимается устойчиво повторяющийся способ обращаться с едой: как человек ест (темп, порядок, место), что выбирает и от чего отказывается, когда и сколько. Паттерн — наблюдаемое явление, а не диагноз. Один и тот же паттерн может быть проявлением болезни, побочным действием лекарства, следствием прошлого опыта или реакцией на обстановку столовой.

Паттерн может быть симптомом, лекарственным эффектом или тем и другим одновременно, но не чертой характера. От этого зависит, кто на него отвечает. На симптом отвечает врач. На лекарственный эффект — врач вместе с кухней. На сбой организации стола — администрация. «Дисциплиной» не отвечает никто.

9.2. Паттерны и их механизмы

Снижение интереса к еде (депрессия). Человек не «отказывается» в буквальном смысле: еда просто перестаёт для него что-либо значить, и тарелка уходит со стола без слов. Такое тихое недоедание видно только по массе тела, и то спустя месяцы. Журнал потребления и пороги, после которых сообщают врачу, описаны в разделе 12; при длительном снижении аппетита нужен врач. Немецкоязычные стандарты здесь предлагают принцип *Wunschkost* — еды по желанию: мотивация вообще есть важнее нутритивной строгости[34, 35, 51].

Справка. Wunschkost. Немецкий термин, буквально «желаемая еда»: возможность для человека в учреждении получить блюдо по собственному пожеланию вне общего меню. В немецком стандарте для учреждений, где живут пожилые люди, он стоит рядом с пищевой биографией и *finger food*[34]. Для доклада это ориентир, а не норма: в российских правилах такой категории нет, и пожелание исполняется в пределах раскладки и назначений врача.

Подозрительность к пище (психоз). Человек говорит, что еда «отравлена», «не та», «с запахом». Убеждать его бесполезно. Работают другие приёмы: запечатанная упаковка, блюдо, положенное из общего котла на глазах у человека, выбор из двух порций, доверенный сотрудник, иногда еда вне общего зала. Каждый такой эпизод нужно сообщать врачу, потому что это симптом, имеющий значение для плана лечения.

Возбуждение и мания. Два укуса на ходу — и человек ушёл. Помогают принцип «мало и часто», еда, которую можно брать руками (*finger food*: Британская диетологическая ассоциация предусматривает меню без приборов именно для таких состояний[47]), отдельная комната и отложенная порция. Расписание «обед с 13:00 до 13:30» здесь не работает. Отложенный доступ к еде предусматривают британские и австралийские стандарты[45, 52].

Доказательная база для еды руками, впрочем, пока скромна. Интегративный обзор 2020 года нашёл всего шесть эмпирических исследований её применения в учреждениях ухода (США, Великобритания, Франция), все — у людей с деменцией или другими психическими расстройствами. Три из них сообщили о росте потребления или сохранении массы тела, три — о большей самостоятельности в еде; рандомизированных испытаний не было, и качество исследований авторы оценили как низкое[53]. Их вывод: «низкое качество включённых исследований не даёт надёжных доказательств», и нужны качественные испытания. Исходы, связанные с удушьем, в этих работах не изучались, поэтому для жителя с дисфагией форма *finger food* определяется назначенной текстурой (раздел 10.5), а не удобством.

Справка. Finger food. Еда, которую удобно брать и есть руками без приборов: небольшие куски, рулетики, оладьи, фрукты дольками и т. п. Её смысл в том, чтобы человек, который не может усидеть за столом или утратил навык обращения с приборами, ел самостоятельно и на ходу. Это способ подачи, а не диета: при дисфагии допустимы только те формы, которые соответствуют назначенному врачом уровню текстуры.

Седация. Утренние препараты приводят к тому, что человек спит в часы завтрака. Гибкое окно приёма пищи и отложенная порция — прямая рекомендация Британской диетологической ассоциации[47]; австралийский стандарт требует, чтобы еда и перекусы были доступны круглосуточно[45]. Правило «опоздал — остался голодным» — это не дисциплина, а нарушение доступности питания.

У седации есть и вторая, опасная сторона: человек, который проснулся не до конца, ест хуже и рискует подавиться. В тайваньском ретроспективном исследовании трёх психиатрических отделений на 210 коек за три года зафиксировали 16 эпизодов удушья у 11 пациентов, из них три со смертельным исходом. Десять из шестнадцати эпизодов (62,5 %) случились за завтраком; средняя доза снотворных, назначенных на ночь, у пациентов с эпизодами за завтраком составила 19,5 мг в пересчёте на диазепам против 14,0 мг у всех пациентов отделений, но это различие

статистически незначимо ($p = 0,924$). Значимым оказалось другое: у трёх умерших вечерняя доза снотворного в среднем составляла 41,7 мг, заметно выше, чем у всех пациентов ($p = 0,008$)[54]. Авторы *предполагают*, что остаточное действие снотворного угнетает сознание и защитные рефлексы; это гипотеза, а не доказанная причина, а выборка очень мала. Для дома из этого следует не назначение (дозы определяет врач), а организационное правило: человека, который ещё не проснулся, не кормят «по расписанию», а дают порцию позже, когда он бодрствует и сидит вертикально. Механизмы удушья подробно разобраны в разделе 10.2.

Ригидность и сенсорные особенности (РАС, умственная отсталость). Человек ест узкий круг «безопасных» для него блюд; смешанные текстуры не принимает; значение имеют вид, запах, температура, посуда и соседи по столу. Обзор 2025 года о питании взрослых с аутизмом указывает, что такие взрослые, по-видимому, выбирают еду прежде всего по сенсорному восприятию, и это может вести к избыточному весу и дефициту нутриентов; там же отмечено, что наиболее перспективными выглядят вмешательства, сочетающие сенсорную адаптацию со структурированным планированием питания[36]. Авторы подчёркивают, что данные о взрослых скудны, а большая часть знаний получена на детях, поэтому переносить выводы на жителей российских ПНИ можно лишь как гипотезу. Практические следствия совпадают с тем, что подсказывает опыт: расширять круг блюд постепенно и без насилия; в каждом приёме пищи держать «безопасный» вариант; записывать сенсорные особенности в пищевую карту. Предложить два незнакомых блюда «в лоб» бесполезно: выбор должен строиться внутри привычного ряда.

Справка. Сенсорная пищевая избирательность. Так называют устойчивый отказ от продуктов по их сенсорным свойствам — текстуре, запаху, цвету, температуре, — а не по вкусовому капризу. Она часто встречается при расстройствах аутистического спектра. Тяжёлые формы, ведущие к дефициту питания, психиатрия описывает как отдельное расстройство приёма пищи (в международных классификациях — избегающее/ограничительное расстройство приёма пищи). Диагноз ставит врач; кухня отмечает факт: что человек ест и чего избегает.

Быстрое заглатывание (тахифагия). Человек ест почти не жуя, за считанные минуты. Риски — аспирация, удушье, рвота и отбирание еды «по инерции». Помогают малые порции с последующей добавкой, питьё между глотками, место рядом с работником, отказ от сухих крупных кусков. Механика риска здесь та же, что при дисфагии, и наблюдение строится по разделу 10. Австралийское ведомство здравоохранения Нового Южного Уэльса в своём предупреждении о риске удушья у психиатрических пациентов прямо называет импульсивную или быструю еду среди факторов риска, наряду с седацией, сухостью во рту и дисфагией, и требует, чтобы человек перед едой и приёмом лекарств бодрствовал и сидел вертикально[55].

Справка. Тахифагия. От греч. *tachys* — быстрый и *phagein* — есть: патологически быстрая еда с недостаточным пережёвыванием и крупными глотками. Это описание поведения, а не самостоятельный диагноз. Тахифагия может сочетаться с гиперфагией (раздел 13) и с нарушениями глотания (раздел 10), и именно это сочетание делает её одним из факторов риска удушья.

Переёдание и гиперфагия. Роль препаратов и метаболики разобрана в разделе 13.

Прятание еды («хомячение»). Еду уносят в тумбочку, кладут под матрас. Причинами бывают пережитый голод, тревога, симптомы болезни, ночная еда (раздел 13). Отбирать такие запасы бесполезно и вредно; разумнее легализовать потребность: перекус на посту снимает мотив прятать. Санитарные требования соблюдаются заменой запасов, а не конфискацией.

Избирательность «всё или ничего». Человек съедает только любимое. Это фиксируется в пищевой карте; «опорные» для него блюда регулярно включаются в цикл, а расширение рациона идёт через парные предложения (раздел 19).

Что видит пост	Что делать	Чего не делать
Тарелка уходит молча снижение интереса к еде (депрессия) сообщить врачу	Журнал потребления и пороги для сообщения врачу (раздел 12); еда по желанию	Ждать, пока покажут весы
«Еда отравлена», «не та» подозрительность (психоз) сообщить врачу	Запечатанная упаковка, порция из общего котла на глазах, выбор из двух порций, доверенный сотрудник; каждый эпизод — врачу	Убеждать
Два укуса — и ушёл возбуждение, мания	Мало и часто, еда руками, отдельная комната, отложенная порция	Окно «обед с 13:00 до 13:30»
Спит в часы завтрака седация решает врач	Отложенная порция; кормить, когда бодрствует и сидит вертикально; дозы — только врач	«Опоздал — остался голодным»
Съедает порцию за минуты быстрое заглатывание (тахифагия) решает врач	Малая порция с добавкой, питьё между глотками, место рядом с работником, без сухих крупных кусков; наблюдение по разделу 10	Подавать всю порцию сразу
Съел всё и просит ещё возможная гиперфагия на фоне терапии сообщить врачу	Сообщить врачу; структурированная доступность еды (раздел 13)	Отказывать «вам нельзя» без назначения
Ест только белое или мягкое сенсорная избирательность	«Безопасный» вариант в каждом приёме; пары внутри привычного ряда; особенности — в пищевую карту	Два незнакомых блюда «в лоб»
Прячет еду в тумбочку пережитый дефицит, тревога	Легальный запас допустимых продуктов, перекус на посту; санитарию соблюдать заменой запасов	Конфисковать
Ест только в своей комнате перегрузка общего зала	Признать право на место; приём пищи в жилой зоне прописать в положении	Принуждать к залу
Паттерн — не диагноз. В журнал пишут наблюдаемое: «съедает порцию за 3–4 минуты, не прожёвывает». Вопрос «почему» — к врачу и психологу; кухня видит, фиксирует и передаёт.		

Рисунок 4. Паттерны раздела 9.2 и сцены раздела 9.7 глазами поста: наблюдение, действие смены и типовая ошибка. Красная метка — клинический вопрос, который решает врач.

9.3. Что это меняет в организации стола

Из перечня паттернов вытекают три организационных следствия.

Первое: **журнал потребления — это инструмент диагностики.** Паттерны видны только в записи, и врач должен читать журнал еженедельно.

Второе: **«особые состояния» — штатный режим**, а не исключение. Для этого в пищевой карте каждого жителя есть три строки (раздел 9.6, приложение 3).

Третье: **гибкость по времени и месту — часть безопасности.** Отложенные порции, отдельные столы, приём пищи в жилой зоне должны быть прописаны в положении о питании. Иначе любое отступление от расписания будет выглядеть как «нарушение распорядка», а персонал, проявивший гибкость, окажется виноватым.

9.4. Границы раздела

Доклад не ставит диагнозов и не описывает лечения. Клиника в этой главе — это стол и наблюдение: что видят сиделка и повар, что фиксирует журнал и когда нужно звать врача. Кухня клинику не назначает: она видит, фиксирует и передаёт врачу.

9.5. Ограничение: паттерн ≠ диагноз

Есть и обратная ошибка — психологизация, когда персонал сам объясняет поведение: «ест быстро, потому что в детстве голодал». Наблюдаемое записывается как наблюдаемое: «съедает порцию за 3–4 минуты, не прожёвывает». Вопрос «почему» адресуется врачу и психологу. В журнал и пищевую карту заносятся факты; гипотезы обсуждаются в беседе с врачом. Это правило бережёт жителя от ярлыков, а смену — от выхода за пределы своей компетенции (раздел 28).

9.6. Питание при обострениях: заготовленный режим

Волнообразное течение болезни — норма, а не исключение. Поэтому режим питания на время обострения готовится заранее, до того как оно наступит. В пищевой карте для этого достаточно трёх строк:

1. **Что происходит с едой у этого жителя при ухудшении:** отказывается, объедается, не выходит в зал, считает всё отравленным.
2. **Что помогало раньше:** форматы подачи, продукты, люди.
3. **Кто переводит на этот режим и обратно:** врач.

Если эти три строки есть, смена исполняет план. Если их нет, каждый эпизод решается заново и на ходу. Проверить это просто: попросите трёх заведующих показать эти строки у трёх жителей. Если показать нечего, это первая задача на месяц — важнее нового блюда в меню.

9.7. Паттерны по сменам: что видит пост и что с этим делать

Обзоры дают широкие диапазоны, а пост начинает с конкретной сцены. По данным реалистского синтеза литературы о прибавке веса на антипсихотиках, переедание у людей с тяжёлыми психическими расстройствами встречается в 4,4–45 % случаев в зависимости от диагноза и

инструмента, тяга к еде — в 16,1–64 %, ночная еда — в 4–30 %[56]. «Средней частоты» здесь нет; есть частота в вашем контингенте, и измерять её придётся самим.

Справка. Реалистский синтез. Вид обзора литературы, который отвечает не только на вопрос «работает ли», но и на вопросы «что, для кого, при каких условиях и почему». Он полезен для сложных вмешательств, но не даёт единой оценки распространённости; поэтому диапазоны выше так широки.

Четыре типовые сцены и что за ними стоит:

- **Съел всё за минуты и просит ещё.** Это не жадность, а возможная гиперфагия на фоне терапии (раздел 13). Действие: сообщить врачу и выстроить структурированную доступность еды.
- **Прячет еду в тумбочку.** Часто это след пережитого дефицита (пищевая биография, приложение 3). Действие: не отбирать, а организовать легальный «запас» из допустимых продуктов.
- **Ест только белое или только мягкое.** Это сенсорная избирательность. Действие: пары эквивалентов внутри привычного спектра, а не ломка привычек.
- **Ест только в своей комнате.** Это перегрузка общего зала. Действие: признать право на место, а не принуждать к залу.

Каждая сцена — информация о механизме. Пост, который умеет так читать происходящее, становится первым диагностом системы. Отдельно стоит сцена, когда житель на щадящей текстуре берёт твёрдую еду у соседа: в тайваньской серии такое случилось у трёх пациентов[54]; отбирание чужой еды и его риски разобраны в разделе 14.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-bloka/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-choke_hwang_breakfast	Hwang S.-J. et al. Choking incidents among psychiatric inpatients: a retrospective study in Chutung Veterans General Hospital // J Chin Med Assoc. 2010;73(8):419–424
M-fingerfood_heelan	Heelan M. et al. The use of finger foods in care settings: an integrative review // J Hum Nutr Diet. 2020;33(2):187–197
M-autism_adults_remon	Remón S., Ferrer-Mairal A., Sanclemente T. Food and Nutrition in Autistic Adults: Knowledge Gaps and Future Perspectives // Nutrients. 2025;17(9):1456

В главе также уточнена привязка маркера: принцип *Wunschkost* в разделе 44 описан у стандарта `l-dge` (для пожилых), поэтому он поставлен рядом с маркерами прежней редакции `l-dge_betr` и `l-at_qs`.

10

Дисфагия и аспирационный риск: невидимая угроза за общим столом

Из всех клинических рисков, которые сопровождают человека в доме социального обслуживания, дисфагия, пожалуй, наименее заметна и наиболее опасна. Её не видно в меню, о ней редко говорят на планёрках, и чаще всего о ней вспоминают задним числом: после повторной пневмонии, после эпизода удушья, после смерти, которую в документах объяснят чем-то другим. Эта глава о том, как перевести дисфагию из разряда невидимых бед в разряд рисков, которые дом знает, наблюдает и умеет снижать. Для вариативного меню вопрос принципиален: выбор, который не учитывает глотание, может оказаться опасным, а забота о безопасности, которая отменяет выбор, лишает человека голоса.

Справка. Что такое дисфагия. Дисфагией (от греч. *dys-* — нарушение и *phagein* — есть) называют любое затруднение при продвижении пищи или жидкости изо рта в желудок. Различают **ротоглоточную** дисфагию, когда нарушен сам акт глотания (захват, жевание, формирование пищевого комка, запуск глотательного рефлекса), и **пищеводную**, когда препятствие лежит ниже. В домах социального обслуживания преобладает первая. Её главная опасность — **аспирация**, то есть попадание пищи, жидкости или слюны ниже голосовых складок, в дыхательные пути. Если материал проникает в преддверие гортани, но не ниже складок, говорят о **пенетрации**. Аспирация бывает **«немой»**: человек не кашляет, и внешне приём пищи выглядит благополучным. Поэтому отсутствие кашля ещё не говорит о безопасности.

10.1. Масштаб: что известно и чего мы не знаем

Начнём с честного признания: надёжных данных о распространённости дисфагии в российских ДСО и ПНИ нет. Ни одно известное нам исследование не обследовало проживающих российских стационарных организаций социального обслуживания валидированными инструментами. Поэтому опираться приходится на зарубежные данные о сходных группах, и каждое такое число требует оговорки о переносимости.

Таких групп три, и в наших домах они пересекаются.

Люди с психическими расстройствами. По данным систематического обзора, у пациентов, получающих антипсихотики, расстройства глотания встречались в 21,9–69,5 % случаев[1, 29]. Столь широкий разброс объясняется различием изученных популяций и методов скрининга. Диапазон **нельзя переносить на все российские ДСО и ПНИ** как единую распространённость. Однако и нижняя его граница говорит о том, что проблема массовая, а не исключительная.

Пожилые люди в учреждениях долговременного ухода. Метаанализ 2022 года, объединивший тридцать исследований, оценил распространённость ротоглоточной дисфагии среди пожилых в целом в 32,8 %, а среди проживающих домов ухода — в 47,0 % (95 % ДИ 41,8–52,2)[14]. Авторы

делают два вывода, важных для нас. Первый: более половины проживающих домов ухода имеют нарушения глотания. Второй: «невалидированные инструменты скрининга занижают истинную распространённость дисфагии». Иначе говоря, чем грубее способ поиска, тем меньше находят. Шестьдесят пять процентов жителей российских ПНИ старше 45 лет[7], поэтому возрастной компонент для нас вполне реален.

Люди с интеллектуальной недостаточностью. Систематический обзор двадцати исследований показал, что дисфагия чаще встречается при более тяжёлой степени интеллектуальной недостаточности, при сопутствующем церебральном параличе и двигательных нарушениях[57]. Среди взрослых, состоящих на учёте в профильных службах, нарушения приёма пищи и глотания имеют 8,1–11,5 %. В выборках, сформированных не по популяционному принципу, а по месту оказания помощи, этот показатель превышает 50 %[58]. Для стационарного ухода, где сосредоточены люди с наиболее тяжёлыми нарушениями, ориентиром служит скорее верхняя оценка.

Итог раздела таков. Точной цифры для российского дома нет и в ближайшее время не будет. Но все три группы, из которых складывается контингент ПНИ, по зарубежным данным имеют высокую частоту дисфагии. Следовательно, разумно исходить из того, что значительная часть жителей нуждается если не в изменённой текстуре, то хотя бы в наблюдении. При этом в типовом ПНИ, как правило, нет ни логопеда, ни систематического скрининга, ни назначенных текстур. Дисфагия остаётся невидимой до первой тяжёлой пневмонии.

10.2. Цена: пневмония и удушье

У дисфагии два смертельных исхода, и оба хорошо измерены.

Аспирационная пневмония. По данным метаанализа смертности при шизофрении, риск смерти от пневмонии у людей с тяжёлыми психическими расстройствами в семь раз выше популяционного (относительный риск 7,00). Это наибольшее превышение среди естественных причин смерти, и аспирация служит одним из его ключевых механизмов[15]. Разрыв в продолжительности жизни составляет 15–20 лет, и значимая его часть приходится на причины, на которые так или иначе влияет организация питания[15].

Удушье пищей. Второй исход быстрее и драматичнее. В общенациональной когорте почти шестидесяти тысяч больных шизофренией смертность от удушья оказалась в 20,5 раза выше, чем в общей популяции (стандартизованное отношение смертности 20,5; 95 % ДИ 17,1–23,9)[16]. Два десятилетия ранее австралийское исследование, связавшее базу коронаров с психиатрическим регистром, показало для шизофрении относительный риск 23,0, а для органических психических расстройств — 30,8[59]. Японская серия из восьми случаев остановки кровообращения при удушье у стационарных пациентов с шизофренией описывает одну и ту же картину: несколько антипсихотиков одновременно, высокие суммарные дозы, произвольные движения и во всех случаях хлеб[60]. Это описательная серия без контрольной группы, но её подробности узнаваемы для любого, кто работал в ПНИ.

Справка. Как читать эти числа. Относительный риск (ОР) показывает, во сколько раз событие чаще в изучаемой группе, чем в группе сравнения. **Стандартизованное отношение смертности (SMR)** сравнивает наблюдаемое число смертей с ожидаемым, если бы группа умирала так же, как население того же возраста и пола. Двадцатикратное превышение не означает, что удушье стало частым событием: в абсолютных числах оно остаётся редким. Но для учреждения, где живут сотни людей из группы риска, редкое событие становится вопросом времени, а не вероятности.

Поведенческая сторона риска — привычка глотать, не прожёвывая, и отбирание чужой еды — подробно разобрана в разделах 9 и 14. Здесь важно другое: за поведением почти всегда стоит физиологическая уязвимость глотания, и устранить одно без внимания к другому нельзя.

10.3. Откуда берётся дисфагия при психических расстройствах

Механизмов как минимум шесть, и в наших домах они действуют одновременно, усиливая друг друга.

1. **Лекарственный.** Антипсихотики вызывают экстрапирамидные нарушения в мышцах, обеспечивающих глотание, сухость во рту и седацию, которая замедляет глотательный рефлекс[29]. Риск не одинаков для разных препаратов. В той же общенациональной когорте его повышали именно сильные антагонисты дофаминовых D2-рецепторов, особенно в высоких дозах (скорректированное ОР 1,74), тогда как для остальных антипсихотиков значимой связи не нашли[16]. Сочетание нескольких препаратов и высокие суммарные дозы встречаются в описаниях случаев удушья постоянно[60]. Выбор препарата — решение врача, а не кухни. Но дом должен знать, что смена схемы лечения меняет и риск за столом (раздел 11).
2. **Болезненный.** Само течение расстройства может нарушать координацию в цепочке «жевание — глоток — вдох».
3. **Поведенческий.** Торопливая еда без пережёвывания (раздел 9) перегружает глотание даже при сохранном рефлексе.
4. **Возрастной.** С возрастом слабеют мышцы, участвующие в глотании, развивается саркопения, снижается чувствительность глотки.
5. **Сопутствующий.** Последствия инсультов, болезнь Паркинсона, деменция, эпилепсия, детский церебральный паралич.
6. **Стоматологический.** Отсутствие зубов и плохо подогнанные протезы превращают жевательную задачу в глотательную: кусок, который нечем измельчить, приходится проглатывать целиком.

Справка. Термины механизмов. Экстрапирамидные расстройства — двигательные побочные эффекты антипсихотиков: скованность, тремор, дистония (непроизвольные сокращения мышц). **Поздняя дискинезия** — непроизвольные движения языка, губ и челюсти, которые развиваются при длительном лечении и мешают формированию пищевого комка. **Ксеростомия** — сухость во рту: без слюны пища плохо смачивается и слипается. **Саркопения** — возрастная потеря мышечной массы и силы, затрагивающая в том числе мышцы глотки. **Хлорпромазиновый эквивалент** — способ сравнивать дозы разных антипсихотиков, пересчитывая их на дозу хлорпромазина с тем же действием.

Вывод для организации прост: в ПНИ дисфагия статистически ожидаема, и система обязана её искать, а не ждать, пока она проявится.

10.4. Распознавание: от глаза сиделки к валидированной шкале

Выявление дисфагии начинается не со специалиста, а с обученного наблюдателя и правила записи. Тревожных признаков, которые видит сиделка без логопеда, немного: кашель или поперхивание во время еды и после неё; «влажный», булькающий голос после глотка; многократное проглатывание одного куска; долгое пережёвывание без глотка; еда, остающаяся за щекой; подтекание изо рта; необычно долгий приём пищи; отказ от твёрдой или сухой пищи при сохранном аппетите; повторные пневмонии в анамнезе[29, 61]. Любой из этих признаков — повод записать наблюдение и сообщить врачу. Несколько признаков сразу — основание изменить подачу пищи немедленно, не дожидаясь окончательной оценки.

Наблюдение, однако, зависит от наблюдателя. Метаанализ, о котором шла речь в разделе 10.1, показывает это на числах: в домах ухода стандартизированная оценка глотания выявляла дисфагию у 58,7 % проживающих, а опросник EAT-10 — лишь у 36,1 %[14]. Поэтому там, где дисфагия вероятна (тяжёлые неврологические нарушения, повторные пневмонии, кашель при еде), нужен валидированный инструмент.

- **GUSS** (Gugging Swallowing Screen, «Гуггингский скрининг глотания») — четырёхэтапная прикроватная проба: непрямая проба со слюной, затем полужидкая пища, жидкость и твёрдая пища. Шкала валидирована против эндоскопического исследования глотания и рассчитана на подготовленную медицинскую сестру[62].
- **EAT-10** (Eating Assessment Tool) — опросник из десяти вопросов о симптомах. Заполняется самим человеком или в форме интервью[63]. Для людей, которые не могут оценить свои ощущения, он менее пригоден, и это прямо следует из разницы в цифрах выше.

Обе шкалы созданы не для психиатрического контингента, поэтому инструкцию к ним приходится адаптировать, а результат трактует врач. Разумное разделение труда выглядит так: признаки из первого абзаца отслеживаются ежедневно у всех, шкала применяется по показаниям, а полученное число вносится в карту и сравнивается при повторной оценке через полгода.

Зарубежная практика добавляет два правила, которые российскому дому ничего не стоят. Австралийское ведомство здравоохранения Нового Южного Уэльса после серии инцидентов в психиатрических стационарах предписало проводить скрининг дисфагии **при поступлении** и фиксировать риск удушья **при каждой передаче пациента** — между сменами, отделениями, учреждениями[55]. Для ДСО и ПНИ это означает две строки: проверку при заселении и отметку о дисфагическом риске в документах при переводе или госпитализации.

Справка. Инструментальная диагностика. Окончательно оценить глотание позволяют два метода. **Видеофлюороскопия** — рентгеновская съёмка глотка с контрастным веществом. **FEES** (фиброоптическая эндоскопическая оценка глотания) — осмотр глотки гибким эндоскопом через нос во время еды. Оба метода требуют специалиста и оборудования и в большинстве домов недоступны. Скрининг их не заменяет, но позволяет решить, кого направить на обследование в первую очередь.

10.5. Текстуры: язык IDDSI и его русская версия

Чтобы назначение «давать протёртое» исполнялось одинаково всеми поварами и всеми сменами, нужен общий язык. Таким языком стала международная система **IDDSI** (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, Международная инициатива по стандартизации диет при дисфагии). Она описывает восемь уровней: для напитков уровни 0–4, для пищи — 3–7[64]. IDDSI переведена на русский язык. Официальный перевод даёт готовую терминологию, которую не нужно изобретать заново[65]:

Уровень	Напитки	Пища
0	обычная жидкость	—
1	незначительно загущенная жидкость	—
2	слабозагущенная жидкость	—
3	умеренно загущенная жидкость	жидкая пюризированная пища
4	сильно загущенная жидкость	пюризированная пища
5	—	молотая увлажнённая пища
6	—	пища мягкая кусочками
7	—	обычная мягкая пища, обычная пища

Ценность системы в том, что каждую консистенцию можно проверить подручными средствами. Для напитков служит тест на текучесть (жидкость стекает из шприца за десять секунд). Для пищи — тест с надавливанием вилкой и тест с наклоном ложки[65]. «Протёртое» перестаёт быть делом вкуса повара и становится измеряемым свойством блюда.



Рисунок 5. Восемь уровней IDDSI в официальной русской терминологии; уровни 3 и 4 описывают и напитки, и пищу[64, 65].
 Уровень назначает врач.

Важно понимать границы IDDSI. Это терминология и метод проверки консистенции, а не диагностика и не лечение. Текстуру назначает уполномоченный медицинский специалист по результатам индивидуальной оценки. Кухня клиники не назначает.

В российских нормах для организаций социального обслуживания сопоставимой шкалы консистенций мы не нашли. «Протёртое» там встречается как признак диеты, а не как измеряемая характеристика блюда (раздел 17). Тем не менее IDDSI уже входит в отечественную практику: например, тульский Клинический центр детской психоневрологии в методических рекомендациях 2023 года описывает консистенции именно по уровням IDDSI[66]. Это детское учреждение, и его рекомендации взрослым не адресованы. Но они показывают, что переход на общий язык текстур в России возможен без новых норм.

Измеримый эффект. В исследовании, охватившем пять учреждений, доля поданных текстур, совпадающих с назначенными, выросла после внедрения IDDSI с 44 до 90 %, а для загущённых жидкостей — с 31 до 100 %. Эффект сохранялся шесть месяцев. Главным барьером оказалась осведомлённость персонала, а не оборудование[67]. Значит, решающее вложение — обучение, а не закупка техники. Проверяется результат долей правильных текстур на тарелках по чек-листу пищеблока (приложение 19).

Достоинство изменённой пищи. Протёртое блюдо не должно выглядеть наказанием. Австралийская практика предлагает подавать его в формах, повторяющих облик обычных блюд[68]. Отраслевые публикации сообщают о росте съеденного объёма и снижении отходов при

такой подаче, но первоисточники этих данных пока не установлены, поэтому мы приводим их лишь как иллюстрацию[69]. Строже доказана вторая сторона вопроса — питательная. Люди на протёртом рационе в домах ухода часто недоедают: в новозеландском рандомизированном исследовании исходно у 36 % участников была недостаточность питания, ещё у 55 % — её риск. Замена обычного протёртого мяса гидролизованным увеличила потребление энергии в среднем на 147 ккал в сутки, а белка — на 4 г[70]. Протёртое блюдо, таким образом, должно быть не только безопасным, но и полноценным: при переводе на изменённую текстуру нужно следить за массой тела.

Осознанный риск. Если житель, которому назначена изменённая текстура, настаивает на обычной пище, это не повод ни уступить молча, ни настоять силой. Австралийская модель предлагает процедуру информированного решения с участием врача, где риск обсуждается и фиксируется[68]. Решение принимают житель и врач, а не сиделка, и тем более не по принуждению.

10.6. Жидкости: забытая половина дисфагии

Загущение жидкостей образует отдельный контур IDDSI. В упомянутом исследовании внедрения именно здесь был самый низкий исходный уровень (31 %) и самый большой эффект обучения (до 100 %)[67]. Минимальный набор прост: загуститель по назначениям, тест на текучесть перед выдачей, при показаниях кружки с клапанами.

Однако загущение — не безобидная мера. Загущённые напитки снижают потребление жидкости и ложатся на человека бременем лечения, а убедительных данных о том, что их рутинное применение снижает число респираторных осложнений, нет[71, 72]. Стратегия «загустить и забыть» худшая из возможных: она подменяет одну опасность другой. Обезвоживание у пожилого человека само провоцирует пневмонии и делирий. Уровень загущения назначает врач, и он же его пересматривает.

Дом, где врач бывает не каждый день, может многое сделать сам: учитывать объём выпитого за сутки (единицей служит стакан); предлагать питьё между приёмами пищи, особенно лежащим и в жару; следить у жителей на загущённых напитках за тёмной мочой, сухостью языка и сонливостью вне обычного режима. На панели показателей (раздел 22) это одна строка: «выпито за сутки, мл или стаканов, среднее по группе риска».

Протокол свободной воды. Альтернативу загущению предлагает так называемый протокол Фрейзера: если врач считает риск аспирации чистой воды приемлемым, человек получает неограниченный доступ к чистой воде между приёмами пищи после гигиены полости рта, а во время еды пьёт назначенную текстуру[71]. Систематический обзор восьми исследований показал, что при строгом отборе пациентов протокол не сопровождался значимым ростом лёгочных осложнений (отношение шансов 1,51, без статистической значимости), увеличивал потребление жидкости в среднем на 180 мл в сутки и, по-видимому, улучшал связанное с глотанием качество жизни[73]. Ключевые слова здесь — «строгий отбор»: протокол применяли у тщательно отобранных стационарных пациентов, а не у всех подряд. В России он не закреплён ни в одной

норме. Допуск, группу и исключения определяет врач, а задача дома — гигиена рта перед водой и учёт выпитого. Без гигиены полости рта протокол противопоказан: вода смывает бактерии изо рта в лёгкие.

10.7. Организационный минимум дома без логопеда

Специалистов по глотанию у большинства организаций социального обслуживания нет. Это ограничение, но не повод бездействовать. Дом может своими силами выстроить семь элементов.

1. **Список риска.** Составляется по признакам раздела 10.4 и обновляется при заселении, после госпитализации и при смене лекарственной схемы. Хранится на посту и на кухне, а не только в истории болезни (приложение 21).
2. **Назначенные текстуры.** Врач назначает поимённо текстуру пищи и уровень загущения напитков по шкале IDDSI с датой пересмотра. Кухня маркирует порции, повар проверяет консистенцию вилкой и ложкой.
3. **Поза и темп.** Человек сидит вертикально (около 90°), подбородок слегка опущен. Он ест маленькими порциями, глотает небольшими глотками, с паузами, запивает по ходу приёма. После еды он остаётся сидя не менее тридцати минут[61]. Помогающий остаётся рядом до конца приёма и сидит на уровне глаз, а не стоит над человеком (раздел 20).
4. **Лекарства по тем же правилам.** Таблетки перекрывают дыхательные пути не реже пищи. Человек принимает их бодрствующим и сидя вертикально; если таблетку нельзя проглотить целиком, решение о форме лекарства принимает врач[55].
5. **Опасные продукты.** Хлеб, который в японской серии стал причиной удушья во всех восьми случаях[60]; сухие и рассыпчатые продукты; крупные куски мяса; блюда смешанной консистенции, например суп с кусочками, где жидкость и плотная часть требуют разного глотка. Для группы риска их подают в форме, соответствующей назначенному уровню IDDSI.
6. **Алгоритм удушья.** Порядок действий при удушье описан в приложении 12. В часы приёма пищи на посту находятся двое обученных сотрудников, и навык отрабатывается на занятиях, а не только читается.
7. **Передача сведений.** Дисфагический риск и назначенная текстура указываются в документах при каждом переводе, госпитализации и смене смены[55].

Этот пакет не лечит, не заменяет инструментальную оценку и не отменяет врача. Он переводит дом из состояния «не знаем, кто в группе риска» в состояние «знаем, наблюдаем, исполняем назначения». Именно этот уровень может показать проверка, и именно он спасает жизни.

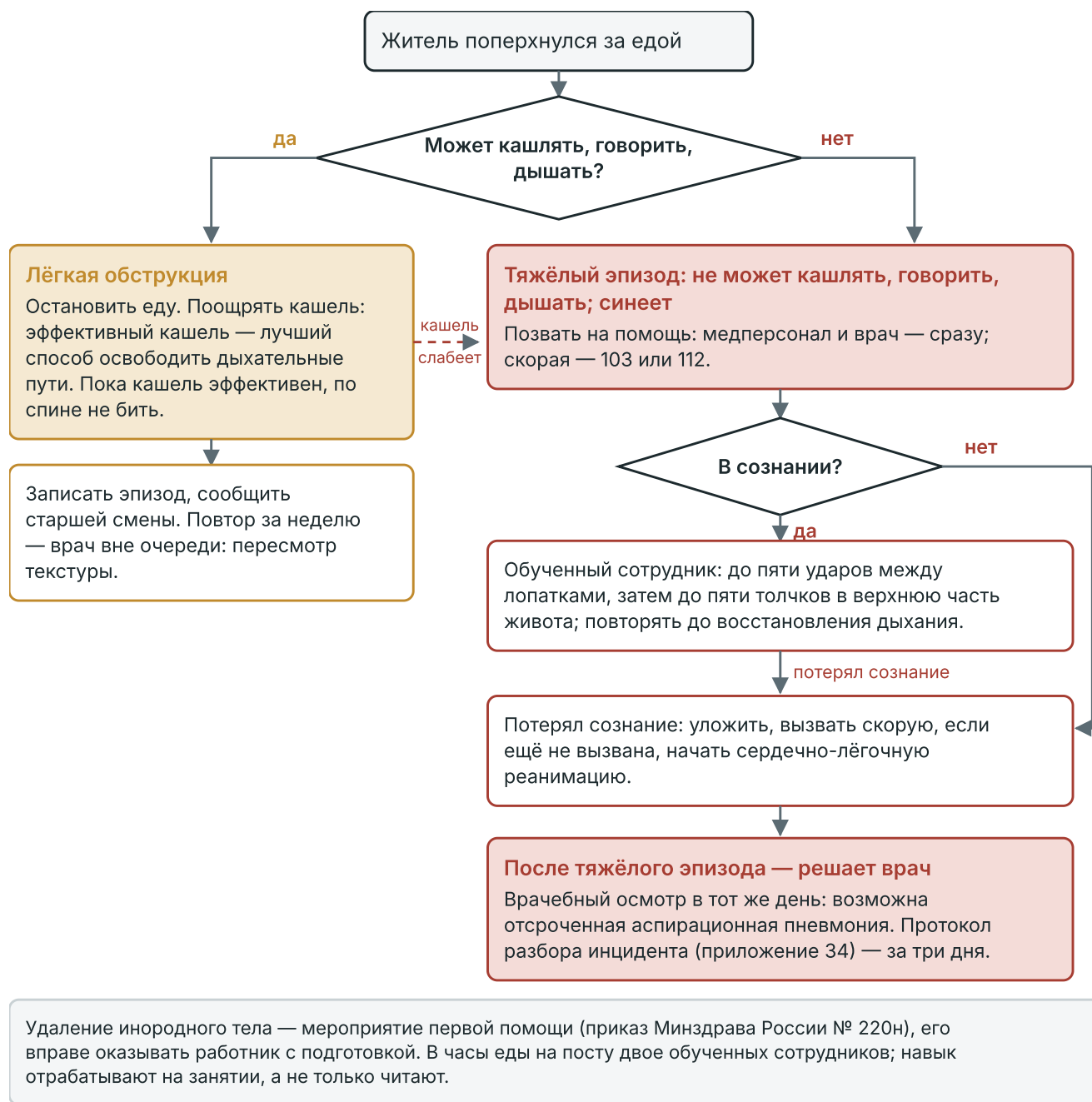


Рисунок 6. Алгоритм приложения 12 в виде схемы для поста: по алгоритму Совета по реанимации Великобритании[74] и порядку оказания первой помощи[75]. Схема не заменяет практического занятия.

10.8. Гигиена полости рта: самая дешёвая профилактика пневмонии

Аспирационная пневмония возникает не только от пищи. Человек с дисфагией постоянно аспирирует собственную слюну, и то, насколько опасна эта аспирация, зависит от бактериальной нагрузки во рту.

Доказательная база здесь неоднородна, и её стоит изложить честно. В японском рандомизированном исследовании в домах ухода, охватившем 366 проживающих, уход за полостью рта после каждого приёма пищи (чистка щёткой, в части случаев обработка повидон-йодом) в сочетании с еженедельным осмотром стоматолога снизил частоту пневмоний с 19 до 11 % [76]. Обзор пяти публикаций (van der Maarel-Wierink и соавт., 2013) пришёл к выводу, что чистка зубов после каждого приёма пищи, ежедневная чистка протезов и еженедельный

профессиональный уход — «по-видимому, лучшее вмешательство для снижения частоты аспирационной пневмонии»[77]. Вместе с тем Кокрейновский обзор 2022 года, оценивший все доступные испытания, оказался осторожнее. Для частоты пневмонии данных о различии недостаточно (пять исследований, свыше пяти тысяч участников, результаты не объединялись). Для смертности, связанной с пневмонией, найдено снижение в 2,3 раза (ОР 0,43; 95 % ДИ 0,25–0,76), но лишь по двум исследованиям и с низкой достоверностью доказательств[78].

Как поступить дому при такой картине? Уход за полостью рта дешёв, безопасен (серьёзных нежелательных явлений в испытаниях не отмечено[78]) и нужен человеку сам по себе, ради комфорта и достоинства. Поэтому его стоит делать, даже если величина эффекта на пневмонию в психиатрическом контингенте не измерена. Заявлять при этом, что дом «предотвращает каждую десятую смерть», нельзя: такой оценки для российских ПНИ нет. Сама формула восходит к шведскому систематическому обзору 2008 года, который по пяти небольшим рандомизированным испытаниям заключил, что механическая гигиена полости рта «может предотвращать примерно один из десяти случаев смерти от пневмонии у зависимых от ухода пожилых людей»[79]. Речь, таким образом, о смертях именно от пневмонии, у пожилых в больницах и домах сестринского ухода и по данным, которые Кокрейновский обзор 2022 года оценил как малодостоверные; а не о каждой десятой смерти в учреждении. Статья Ф. Мюллер 2015 года, на которую ссылалась первая редакция, — трёхстраничный комментарий в приложении к *Journal of Dental Research*, а не обзор испытаний[80].

Расчёт нужно вести не на все 951 место, а на **группу зависимости**: тех, кто не чистит зубы сам, — лежащих, людей с тяжёлой умственной отсталостью или выраженной седацией. Формула: число зависимых × 2–3 минуты × число приёмов пищи. Для восьмидесяти зависимых и трёх приёмов получается около восьми человеко-часов в сутки. Это ставка, а не жест доброй воли, и планировать её нужно как ставку. Минимальный набор: щётка или губка и паста выдаются не «по запросу», а по графику; в листе обхода есть строка «полость рта осмотрена, обработана»; смена прошла обучение. На панели показателей: «осмотр полости рта выполнен, % группы риска».

Отдельно — протезы. Плохо сидящие протезы и сухость во рту — две самые частые жалобы проживающих домов ухода[81]. Протез, который мешает жевать, легко принять за «плохой аппетит» (раздел 12), и человек теряет вес из-за стоматологической проблемы, которую никто не назвал.

10.9. Зондовое и энтеральное питание: отдельный контур, а не жизнь без выбора

У жителей, которые получают питание через зонд или гастростому, вариативность выглядит иначе, чем на линии раздачи. Это выбор времени кормления, объёма, положения тела, вкуса разрешённых пастообразных добавок (если врач допускает пероральные пробы) и сохранение ритуала: сидеть за общим столом со всеми, а не есть в палате, как исключённый. Прямых исследований вариативного меню при энтеральном питании в ПНИ нет. Смесь, скорость введения и положение назначает только врач. График кормления разумно строить вне пика седации, а формула «нельзя в столовую» не должна становиться дисциплинарной мерой. Пероральная проба при зонде — информированное решение врача, а не инициатива смены.

10.10. Дисфагия и выбор

Дисфагия не отменяет выбор — она переносит его внутрь текстуры. Вместо одного протёртого второго жителю предлагают два варианта той же консистенции, составленные по принципу пары эквивалентов (раздел 19). Без этого группа с дисфагией теряет одновременно и здоровье, и голос: ей достаётся одно безликое блюдо, а возможность сказать «нет» и «вот это» исчезает. В карте пищевых предпочтений (приложение 2) текстура и её основание выделены в отдельный раздел с датой пересмотра, чтобы выбор внутри текстуры был законным, а не случайным.

10.11. Чего мы пока не знаем

Честный перечень пробелов не менее важен, чем перечень знаний.

- Нет исследований распространённости дисфагии в российских ДСО и ПНИ с использованием валидированных инструментов.
- Шкалы GUSS и EAT-10 не валидированы для людей с психическими расстройствами и интеллектуальной недостаточностью; русские версии шкал в этой главе не сверялись.
- Неизвестно, насколько снижает пневмонии уход за полостью рта именно в психиатрическом контингенте.
- Протокол свободной воды изучался у тщательно отобранных стационарных пациентов; данных для домов социального обслуживания нет.
- Данные о пользе формованной протёртой пищи пока опираются на вторичные публикации.

Каждый из этих пробелов может закрыть сам дом: аккуратный учёт по пакету раздела 10.7 за год даёт больше знания о собственных жителях, чем любая зарубежная оценка.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре <raw/sources/poisk-2026-10-disfagiya/istochniki.md>. Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-dysph_older_doan	Doan T.-N. et al. Prevalence and Methods for Assessment of Oropharyngeal Dysphagia in Older Adults // J Clin Med. 2022;11(9):2605
M-dysph_id_robertson	Robertson J. et al. Prevalence of dysphagia in people with intellectual disability // Intellect Dev Disabil. 2017;55(6):377–391
M-id_manduchi	Manduchi B., Fainman G.M., Walshe M. Interventions for Feeding and Swallowing Disorders in Adults with Intellectual Disability. Trinity College Dublin
M-choke_ruschena	Ruschena D. et al. Choking deaths: the role of antipsychotic medication // Br J Psychiatry. 2003;183(5):446–450
M-choke_luykx	Luykx J.J. et al. Dopamine D2 receptor antagonism of antipsychotics and the risk of death due to choking // Psychiatry Res. 2024;339:116012
M-choke_nagamine	Nagamine T. Choking risk among psychiatric inpatients // Neuropsychiatr Dis Treat. 2011;7:381–382
I-nsw_choking	NSW Health. Safety Information SI: 016/25 «Minimising choking risk in mental health consumers», 18.11.2025
I-iddsi_ru	IDDSI. Полное описание системы IDDSI 2.0 и методы тестирования, русский перевод (2020–2021)

Маркер	Источник
M-hydrolysed_wu	Wu X.S., Miles A., Braakhuis A. Effects of hydrolysed meat ... pureed diets: crossover RCT // BMC Geriatr. 2022;22:905
I-moulded_farrer	Farrer O. A feast for the eyes – smooth puree diet moulding improves oral intake // Food Processing. 2016 (вторичный пересказ)
M-fwp_gillman	Gillman A. et al. Implementing the Free Water Protocol ... A Systematic Review // Dysphagia. 2017;32(3):345–361
M-oral_vdmaarel	van der Maarel-Wierink C.D. et al. Oral health care and aspiration pneumonia in frail older people // Gerodontology. 2013;30(1):3–9
M-oral_cochrane	Cao Y. et al. Oral care measures for preventing nursing home-acquired pneumonia // Cochrane Database Syst Rev. 2022; CD012416.pub3
M-oral_sjogren	Sjögren P. et al. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospitals and nursing homes // J Am Geriatr Soc. 2008;56(11):2124–2130 (реестр poisk-2026-10-dozakrytie)
M-oral_muller	Müller F. Oral Hygiene Reduces the Mortality from Aspiration Pneumonia in Frail Elders // J Dent Res. 2015;94(3 Suppl):14S–16S (маркер первой редакции; выходные данные уточнены в реестре poisk-2026-10-dozakrytie)
S037	Жеребцова В.А. и др. Диагностика при коррекции нутритивной недостаточности и дисфагии у детей: метод. рекомендации. Тула, 2023

11

Лекарства и еда: пять правил, которые обязана знать кухня

Вариативное меню расширяет круг того, что человек может положить себе на тарелку, налить в чашку или получить в передаче от родных. Для большинства жителей это чистое благо. Но в доме, где многие годами принимают психотропные препараты, часть продуктов перестаёт быть просто едой: чашка кофе, солёный огурец, кусок выдержанного сыра или стакан грейпфрутового сока способны изменить действие лекарства сильнее, чем пропущенная таблетка. Эта глава не учит фармакологии. Она отвечает на более узкий вопрос: какие взаимодействия лекарств и пищи кухни, пост и комната передач обязаны знать, чтобы выбор оставался безопасным, и где заканчивается их ответственность и начинается работа врача.

Справка. Как пища меняет действие лекарства. Большинство психотропных препаратов разрушается в печени ферментами семейства **цитохрома P450** (сокращённо CYP). У каждого фермента свои «клиенты»: клозапин и оланзапин разрушает в основном **CYP1A2**, карбамазепин и многие другие препараты — **CYP3A4**. Если какое-то вещество **ингибирует** (тормозит) фермент, препарат разрушается медленнее и накапливается в крови; если **индуцирует** (ускоряет) — концентрация падает и лечение слабеет. Кофеин сам разрушается тем же CYP1A2 и конкурирует с клозапином; дым сигарет, напротив, ускоряет CYP1A2; грейпфрут тормозит CYP3A4 в стенке кишечника. Отдельный механизм — у лития, который не разрушается вовсе, а выводится почками вместе с натрием, и потому зависит от соли и воды. **AUC** (площадь под фармакокинетической кривой) — интегральная мера того, сколько препарата побывало в крови за определённое время; её рост на 20 % означает, что человек фактически получает на пятую часть больше лекарства, чем назначил врач.

11.1. Принцип раздела

Взаимодействий «препарат — пища» десятки, и полный их справочник не по силам ни повару, ни санитарке. Столу нужен не справочник, а короткий перечень, где у каждой строки есть действие для кухни, для поста и для меню. Чтобы смена понимала, насколько жёстко держать каждое правило, доклад помечает их тремя классами уверенности:

- **(установлено)** — взаимодействие подтверждено исследованиями и официальными инструкциями или справочниками;
- **(мониторинг)** — речь идёт не о запрете, а о стабильности привычного режима и наблюдении за ним;
- **(рекомендация)** — предосторожность, которую предлагают профессиональные руководства, без прямых данных о вреде в нашей ситуации.

Эти классы не тождественны классам утверждений доклада (раздел 41): они говорят о силе фармакологических данных, а не о юридической природе текста. Любое правило главы для российского дома — **рекомендация организационного уровня**, а не норма.

11.2. Правило 1. Клозапин и кофеин: считать чашки (установлено)

Клозапин — препарат выбора при резистентной шизофрении, и в ПНИ его получают многие. Он же самый капризный во взаимодействиях. Кофеин тормозит его разрушение: в контролируемом исследовании добавление кофеина (по библиографии корпуса — 400–1000 мг в сутки, то есть от четырёх до десяти чашек кофе) повышало AUC клозапина в среднем на 19 % [17]. В описанном клиническом случае резкий рост потребления кофеина за счёт энергетических напитков довёл концентрацию клозапина до токсической — 1796 нг/мл — с тяжёлой клинической картиной [30]. Опасна и обратная ситуация: резкая отмена привычного кофеина снижает концентрацию клозапина на 37–47 %, и лечение может потерять эффект [82].

Ещё сильнее на клозапин и оланзапин действует курение: продукты горения табака ускоряют их разрушение, по данным корпуса снижая концентрации примерно вдвое [17]. (Величина «вдвое» при проверке 2026-10 по первоисточнику не подтверждена; направление эффекта подтверждают регуляторы, см. ниже.) Поэтому резкое прекращение курения без коррекции дозы опасно. Новозеландский регулятор Medsafe в 2020 году формулирует это так: «Начало или прекращение курения (но не никотинзаместительная терапия и не вейп) влияет на концентрацию клозапина в крови»; при внезапном отказе от курения концентрация может вырасти, и в первую неделю «настоятельно рекомендуется снижение дозы с лекарственным мониторингом» [83]. Британское агентство MHRA в том же году включило в перечень ситуаций, когда концентрацию клозапина нужно проверить, случаи, когда «пациент бросает курить или переходит на электронную сигарету», а также пневмонию и другие тяжёлые инфекции [84]. Формулировки не противоречат друг другу: ускоряет фермент не никотин, а дым, и переход на электронную сигарету для печени означает то же, что отказ от курения.

Для российского дома это не абстракция. Федеральный закон № 15-ФЗ запрещает курение в помещениях социальных служб и на территориях, предназначенных для оказания медицинских и реабилитационных услуг [85]. Значит, у жителя, который курил «на воле», а при поступлении или госпитализации вынужденно перестал, концентрация клозапина может вырасти без всякого изменения назначений. То же произойдёт, если дом ужесточит правила курения или если житель простудится и перестанет выходить на перекур. Сообщить об этом врачу — задача поста, а не повара, но знать, почему это важно, должны все.

Что делает дом. В индивидуальной карте фиксируется привычное потребление кофе, чая, энергетических напитков и курение. Резкие изменения этих привычек без врача не допускаются; семья предупреждается письменно (приложение 32). Кофе не служит ни наградой, ни наказанием. Любое изменение привычки, будь то желание жителя пить больше кофе или вынужденный отказ от курения, сообщается врачу, а решение о дозе и контроле концентрации принимает он. Британская ассоциация диетологов включает это правило в таблицу взаимодействий, встроенную в меню психиатрического стационара [47].

11.3. Правило 2. Литий, соль и вода: стабильность, а не запрет (мониторинг)

Литий — классический нормотимик, применяемый при биполярном расстройстве. Его терапевтический диапазон узок, а выводят его почки тем же путём, что и натрий. Поэтому литий чувствителен к водно-солевому балансу: резкое уменьшение соли в рационе или обезвоживание повышают его концентрацию вплоть до токсической (дрожь, спутанность, рвота), а резкое увеличение соли снижает эффект лечения[18, 86]. Пациентская памятка Национальной службы здравоохранения Великобритании формулирует оба правила просто: «лучше избегать малосолевой диеты: она может повышать концентрацию лития в крови», а «количество выпиваемой жидкости очень важно... особенно в жару, когда человек больше потеет»; алкоголь также не рекомендуется, потому что обезвоживает[87].

Насколько опасна сама жара? Здесь полезна точность. Крупное нидерландское исследование, сопоставившее более 41 тысячи измерений лития у 3054 пациентов со среднесуточной температурой, нашло статистически значимую, но очень малую разницу: летом в среднем 0,761 ммоль/л, зимой 0,748 ммоль/л. Авторы назвали влияние сезона и температуры «статистически значимым, но терапевтически несущественным», а доля потенциально токсичных значений была наибольшей не летом, а зимой[88]. Это не повод успокоиться, а уточнение адреса угрозы: опасна не жара как таковая, а **жара без воды**, рвота, понос, лихорадка, отказ от питья, то есть реальная потеря жидкости у конкретного человека. Зимние инфекции с рвотой и температурой не менее опасны, чем летний зной. Переносимость данных на российский дом ограничена: исследование проведено на амбулаторных и госпитальных пациентах умеренного климата, а не у жителей ПНИ.

Опасные сцены для дома узнаваемы: «малосольный стол», введённый по инициативе кухни «для здоровья»; жара без доступной воды; эпидемия кишечной инфекции; отказ от питья при обострении психического состояния. Кухня не назначает солевой режим и не меняет его.

Что делает дом. Солевой режим без врача не меняют ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Вода стоит на виду, а не выдаётся «по просьбе». О рвоте, диарее, лихорадке или жаре у жителя на литии врач узнаёт в тот же день. При отказе от еды и питья эскалация по разделу 12 сокращается: такой отказ становится поводом для немедленного звонка врачу.

11.4. Правило 3. ИМАО и тирамин: тираминовая разметка меню (установлено)

Справка. Тирамин и «сырная реакция». Тирамин — вещество, которое образуется при созревании, брожении и длительном хранении белковых продуктов. В норме его разрушает фермент **моноаминоксидаза (МАО)** в кишечнике и печени. Препараты группы **ингибиторов МАО (ИМАО)** блокируют этот фермент; тирамин из пищи тогда попадает в кровь и вызывает выброс норадреналина и резкий подъём давления — **гипертонический криз**, исторически названный «сырной реакцией». Различают **необратимые неселективные ИМАО** (блокируют обе формы фермента надолго), **обратимые селективные ингибиторы МАО-А** и **селективные ингибиторы МАО-В**, применяемые в основном при болезни Паркинсона.

Неселективные ингибиторы МАО назначают редко, но при их приёме тирамин из пищи вызывает гипертонический криз. Источники тирамина — выдержанные и плесневые сыры, копчёности, соленья, брынза, пиво, домашний квас, соевый соус[19, 89]. Описаны подъёмы давления со 160/90

до 220/115 мм рт. ст. и выше[90].

Российская оговорка. В отечественном справочнике лекарственных средств группа ИМАО разделена на те же три подгруппы, а широко описанный обратимый ингибитор МАО-А моклобемид сопровождается гораздо более мягкой формулировкой: больным с повышенным давлением «следует воздержаться от избыточного употребления пищевых продуктов, содержащих тирамин»[91]. Зарегистрированы ли сейчас в России необратимые неселективные ИМАО, мы по доступным страницам не установили. Поэтому правило сохраняется в перечне как правило на случай назначения, а жёсткость тираминовой разметки для конкретного препарата определяет врач: для необратимого ИМАО это строгий запрет списка продуктов, для обратимого — умеренность, для ИМАО-В в обычных дозах — по указанию врача.

Что делает дом. В меню-потребности для такого жителя появляется отдельная строка. Кухня получает от врача тираминовую разметку блюд и продуктов, и выбор строится внутри безопасного множества. Вариативность при этом сохраняется полностью: житель выбирает из всех блюд, кроме размеченных.

11.5. Правило 4. Грейпфрут и ряд психотропных препаратов: исключить по списку (установлено)

Грейпфрут и его сок тормозят фермент CYP3A4 и повышают концентрации препаратов, которые им разрушаются. Для карбамазепина рост AUC составляет порядка 40 %[20]. В зоне внимания находятся также некоторые бензодиазепины и часть антипсихотиков. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США объясняет механизм так: «Грейпфрутовый сок может блокировать действие кишечного фермента CYP3A4», и потому в кровь «попадает больше препарата», а с ним растёт риск побочных эффектов. В числе примеров ведомство называет противотревожный буспирон, а также статины и ряд сердечно-сосудистых препаратов, которые нередко получают пожилые жители ДСО[92]. Длительность эффекта на странице ведомства не указана, поэтому разнести грейпфрут и таблетку «на несколько часов» как способ решения проблемы доклад не предлагает.

Что делает дом. Грейпфрут и его сок не входят ни в закупку, ни в меню вовсе. «Подарочные» фрукты и соки в передачах проверяет дежурный. Одна строка в положении о питании закрывает вопрос, и жертва для вариативности ничтожна: альтернативных цитрусовых и соков достаточно.

11.6. Правило 5. Алкоголь и энергетические напитки: нулевая терпимость и серые зоны (рекомендация)

Алкоголь в сочетании с психотропными препаратами непредсказуемо усиливает седацию, нарушает координацию и самоконтроль за столом; при литии он к тому же обезвоживает[87]. В стационарном учреждении алкоголь исключён полностью, и это фиксируется в правилах передач.

Серая зона — энергетические напитки, сочетающие кофеин со стимуляторами. Для жителя на клозапине они подпадают под правило 1 (именно энергетики привели к описанному токсическому случаю[30]), а для людей с тревожными и биполярными расстройствами служат

возможной провокацией. Вопрос энергетиков в буфете дома закрывает ассортиментный перечень, утверждённый вместе с врачом.

11.7. Лекарственно-пищевая таблица: форма

Пять правил сводятся в таблицу (приложение 21) с колонками: препарат — что недопустимо или контролируется — что делает кухня — что делает пост — что сообщается врачу. Таблицу заполняет врач по фактическим назначениям и пересматривает её при каждой смене терапии. Копии хранятся на посту, на кухне и в комнате передач. Британская ассоциация диетологов встраивает такую таблицу в меню и в информирование пациентов[47]. Наша форма повторяет этот подход средствами российского документооборота.

Таблицу «лекарство × еда» заполняет и подписывает врач по фактическим назначениям.
На кухню и в комнату передач идёт результат («без грейпфрута»), а не диагноз и не название препарата.

Правило и класс уверенности	Кухня	Пост и передачи
1. Клозапин × кофеин установлено кофеин: AUC клозапина +19 %; резкая отмена: −37–47 %; курение тоже меняет уровень	Кофе не награда и не наказание; привычное потребление — в карту	Изменение привычки (больше кофе, отказ от курения) — врачу; семью предупредить письменно
2. Литий × соль и вода мониторинг опасна потеря жидкости: жара без воды, рвота, понос, лихорадка	Солевой режим без врача не менять; «малосольный стол» самовольно не вводить	Вода на виду; рвота, диарея, лихорадка — врачу в тот же день
3. ИМАО × тирамин установлено выдержанные сыры, копчёности, соленья, пиво, квас, соевый соус	Тираминовая разметка от врача; выбор из всех неразмеченных блюд	Жёсткость разметки для препарата определяет врач
4. Грейпфрут × ряд препаратов установлено карбамазепин: AUC ≈ +40 %	Грейпфрут и его сок — ни в закупке, ни в меню	Дежурный проверяет «подарочные» фрукты и соки в передачах
5. Алкоголь и энергетики рекомендация алкоголь усиливает седацию; энергетики при клозапине — правило 1	Ассортимент буфета утверждается вместе с врачом	Алкоголь исключён правилами передач

Классы уверенности говорят о силе фармакологических данных; для российского дома каждое правило — рекомендация организационного уровня, а не норма. Перечень не исчерпывающий: полный список взаимодействий ведёт врач.

Рисунок 7. Пять правил главы 11 с классами уверенности. Это не справочник и не назначение: таблицу подписывает врач (приложение 21). Числа — по [17, 20, 82].

Сведения таблицы о том, какой препарат получает конкретный житель, относятся к сведениям о здоровье. На кухню и в комнату передач передаётся не диагноз и не название препарата, а результат: «без грейпфрута», «кофе — не больше привычного», «тираминовая разметка». Правовая сторона обращения с такими данными изложена в разделе 17.6.

11.8. Чего в разделе нет

Перечень не исчерпывающий: полный список взаимодействий ведёт врач. Кухня не трактует инструкции к препаратам, а исполняет таблицу. Правила задают границы, а внутри этих границ выбор жителя остаётся полным.

11.9. Передачи как фармакологический канал

Без управления комната передач превращается в неконтролируемую аптеку. Кофе, крепкий чай, энергетики, грейпфруты, копчёности, алкоголь, сигареты приходят именно оттуда — с любовью и без рецепта. Порядок работы с передачами включает четыре элемента: перечень на стенде, где санитарный и лекарственный блоки разделены; регистрацию передачи; маркировку; выдачу по режиму для позиций, попавших в таблицу. Памятка для родственников (приложение 32) объясняет смысл без упрёка: «Мы проверяем передачи, потому что у вашего близкого лекарства конфликтуют с некоторыми продуктами».

Регламент передач пишется как разрешение с перечнем недопустимого, а не как полный запрет: полный запрет порождает подполье, и тогда кофе и сигареты всё равно попадают к жителю, но уже без учёта.

11.10. Границы таблицы

Таблица (приложение 21) — минимум дома, а не справочник. Полный справочник существует у врача и в аптечных системах, и полную фармакологию на посту никто не читает. Зато классы уверенности смена усвоить может и должна: они учат различать жёсткость правил. «Установлено» (клозапин и кофеин, литий и соль) и «осторожность по классу» (отдельные комбинации с ИМАО) требуют разной строгости, потому что за ними стоит разная доказательность.

11.11. Три сценария из практики поста

«Добрый кофе». Жителю на клозапине близкие приносят термос крепкого кофе. Кофеин тормозит CYP1A2; описан случай с концентрацией клозапина 1796 нг/мл и тяжёлой клиникой[30]; в контролируемом исследовании добавление 400–1000 мг кофеина в сутки повышало AUC на 19 % [17]. Правильный ответ — не конфискация со скандалом, а сообщение врачу и согласованный с ним режим. Резкая отмена тоже опасна: концентрация падает на 37–47 %[82].

«Солёные огурцы к выходным». Жителю на литии раз в неделю приносят солёную передачу. Натрий и литий выводятся почками одним путём[18, 86]. Решение — не запрет огурцов, а стабильность режима и информирование врача.

«Сок вместо воды». Жителю на карбамазепине дают грейпфрутовый сок «для витаминов», и концентрация препарата может вырасти примерно на 40 %[20]. Исключение грейпфрута должно быть встроено в закупку и меню, а не зависеть от памяти смены.

Все три сценария ловятся не бдительностью отдельного сотрудника, а конструкцией: таблица, правило передач и простое правило поста «увидел — сообщил врачу сегодня».

11.12. Вывод: рамка, внутри которой выбор свободен

Пять правил не сужают меню, а делают его безопасным. Они требуют от кухни немногого: не закупать грейпфрут, не вводить «малосольный стол» без врача, держать воду на виду, исполнять тираминовую разметку, если она назначена, и не превращать кофе в инструмент воспитания. От поста они требуют сообщать врачу об изменениях привычек, особенно о прекращении курения, о рвоте и обезвоживании. Всё остальное — выбор жителя.

Чего мы не знаем. Российских данных о частоте лекарственно-пищевых осложнений в ДСО и ПНИ нет. Все приведённые числа получены в зарубежных популяциях и в клинических условиях; их перенос на российские дома — толкование. Не проверено по первоисточнику число «примерно вдвое» для влияния курения. Наконец, регистрационный статус необратимых ИМАО в России в этой главе не установлен.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-block-b/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/meditsina/meditsina-2026-10-blocks/master/istochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
I-mhra_clozapine_2020	MHRA. Drug Safety Update «Clozapine and other antipsychotics: monitoring blood concentrations for toxicity», 26.08.2020
I-medsafe_clozapine_2020	Medsafe (Новая Зеландия). Clozapine: datasheet updates, 09.06.2020
M-lithium_temp_wilting	Wilting I. et al. The impact of environmental temperature on lithium serum levels // Bipolar Disord. 2007;9(6):603–608
M-lithium_nhs_faq	NHS. Common questions about lithium (пересмотр 09.08.2023)
I-fda_grapefruit	U.S. FDA. Grapefruit Juice and Some Drugs Don't Mix (актуально на 01.07.2021)
S050	РЛС. Моклобемид: описание действующего вещества; группа «Ингибиторы МАО» (проверено 09.10.2026)
S051	Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ, ст. 12 (ред. от 26.06.2026)

12

Отказ от еды: от первого пропуска до врачебного решения

Отказ от еды — самая будничная из клинических ситуаций в доме социального обслуживания и одновременно самая коварная. Он случается каждый день, выглядит одинаково при совершенно разных причинах и почти всегда обрабатывается на глаз: санитарка заметила, сказала старшей, та решила. Вариативное меню меняет картину вдвойне. С одной стороны, право сказать «нет» блюду становится законной частью выбора, и отказ перестаёт быть нарушением. С другой — именно поэтому дом обязан отличать отказ от блюда, который есть выбор, от отказа от еды, который может быть симптомом. Эта глава предлагает алгоритм, позволяющий провести это различие без интуиции дежурного, и проводит границу, которую нельзя пересекать ни при каких обстоятельствах, — границу насилия.

12.1. Почему отказ — самая опасная бытовая ситуация

Отказ в ПНИ случается ежедневно. За одним и тем же «не буду» могут стоять очень разные вещи: блюдо невкусное или остыло; началась депрессия; обостряется психоз с бредом отравления; человек не может проглотить (раздел 10); у него болит живот, зуб или протез; наконец, это начало угасания в конце жизни. Цена ошибки несимметрична. Пропущенный «каприз» стоит одной тарелки. Пропущенная дисфагия или депрессия может стоить жизни: смертность людей с тяжёлыми психическими расстройствами заметно превышает популяционную, и значимая её часть приходится на причины, связанные с питанием и глотанием[15, 29]. Поэтому отказом должен управлять алгоритм, а не интуиция дежурного.

Для пожилых жителей ДСО есть и вторая причина насторожиться. Отказ, растянутый на недели, превращается в **непреднамеренную потерю массы тела**, а она сама по себе связана с ростом заболеваемости и смертности. В обзоре Американской академии семейных врачей клинически значимой считается потеря 5 % массы и более за 6–12 месяцев. Среди причин такой потери, установленных после первичного обследования, злокачественные новообразования составляют 19–36 %, неонкологические болезни органов пищеварения (включая проблемы с зубами, полостью рта и глотанием) — 9–45 %, психосоциальные расстройства, прежде всего депрессия, — 9–24 %; у 6–28 % причину найти не удаётся. Отдельно авторы подчёркивают: «Побочные эффекты лекарств и полипрагмазия могут быть причинами непреднамеренной потери массы тела»[93]. Эти доли получены на амбулаторных пожилых пациентах в США и к контингенту ПНИ напрямую не переносятся. Но вывод из них переносится: за «плохим аппетитом» может стоять опухоль, и поставить её под подозрение способен только врач, если ему вовремя сообщили.

Справка. Полипрагмазия. Полипрагмазией называют одновременный приём многих лекарственных препаратов (чаще всего порогом считают пять и более). У пожилых и у людей на психотропной терапии полипрагмазия — частая причина тошноты, сухости во рту, изменения вкуса, запора и седации, то есть всего, что снижает аппетит. Пересмотр схемы — задача врача; задача дома — сообщить, что отказ совпал по времени с изменением назначений.

12.2. Классификация причин

Причины отказа удобно разложить по шести корзинам. У каждой корзины свои признаки и, главное, свой владелец решения:

Причина	Признаки	Владелец решения
Организационная («невкусно», «не то», «холодное»)	Избирательно, на конкретные блюда; остальное человек ест	Кухня и администрация
Состояние (депрессия, тревога, психоз)	Изменились поведение, сон, контакт	Врач
Лекарственная (тошнота, седация, сухость во рту)	Совпадает по времени с назначением или сменой терапии	Врач
Дисфагия или соматическое заболевание	Покашливание, долгий приём пищи, боль, запор	Врач (срочно)
Осознанный отказ конкретного человека	Аргументирован, устойчив, высказан в ясном состоянии	Житель (отказ фиксируется)
Предсмертный период	Общее угасание, паллиативный статус	Врач и паллиативная служба

Главная ошибка — смешение корзин. Осознанный отказ начинают лечить как симптом, а симптом списывают на «характер». Первое унижает человека, второе может его убить.

В таблице нет отдельной строки «болит жевать», хотя это одна из самых частых масок отказа. Плохо сидящие протезы и сухость во рту — две главные проблемы полости рта у проживающих домов ухода; о проблемах с полостью рта сообщают более половины опрошенных[81]. Внешне это выглядит как «плохо ест твёрдое, просит мягкое», и такой отказ легко отнести к организационным, хотя его место — в стоматологическом маршруте. Простой вопрос «болит ли жевать, мешает ли что-то во рту?» разделяет эти пути за десять секунд. Состояние рта и протезов фиксируется в пищевом паспорте при поступлении (приложение 37); подробнее о гигиене рта — раздел 10.8.

12.3. Алгоритм эскалации

В качестве ориентира доклад берёт канадскую практику домов долговременного ухода, где отказ от трёх приёмов пищи подряд и оставление 25 % порции и более за двумя из трёх приёмов в течение недели служат поводами для врачебной оценки[94]. Эти пороги взяты из профессиональных рекомендаций диетологов Канады, а не из регламента: в тексте онтарийского регламента О. Reg. 246/22, прочитанном 10.10.2026, их нет. Регламент нормирует другое — междисциплинарную оценку при изменении массы тела на 5 % за месяц, 7,5 % за три месяца или 10 % за шесть месяцев и мониторинг потребления пищи и жидкости у жителей с выявленными рисками[27] (раздел 13.8). На этой основе предлагается **проект российского правила**. Это не российская норма, и при включении в локальный акт он должен быть так и обозначен.

1. **Каждый отказ фиксируется** в журнале (приложение 9): кто, на каком приёме, что отверг, сколько съел, как себя вёл.
2. **Отказ влечёт альтернативу** в тот же приём по таблице замен. Житель не остаётся голодным; в американском федеральном правиле это прямо закреплённая норма[46].
3. **Три отказа подряд — врач в тот же день.** Не «на обходе в четверг» и не «завтра утром».
4. **Если человек системно оставляет 25 % порций и больше в течение недели — врач и пересмотр индивидуальной карты** в течение двух дней.
5. **Отказ от воды или одновременно от еды и воды — немедленно.** Обезвоживание при приёме лития и ряда других препаратов — прямая угроза (раздел 11.3)[86].
6. **Эпизод закрывается записью:** что установлено, что назначено, когда пересмотр.

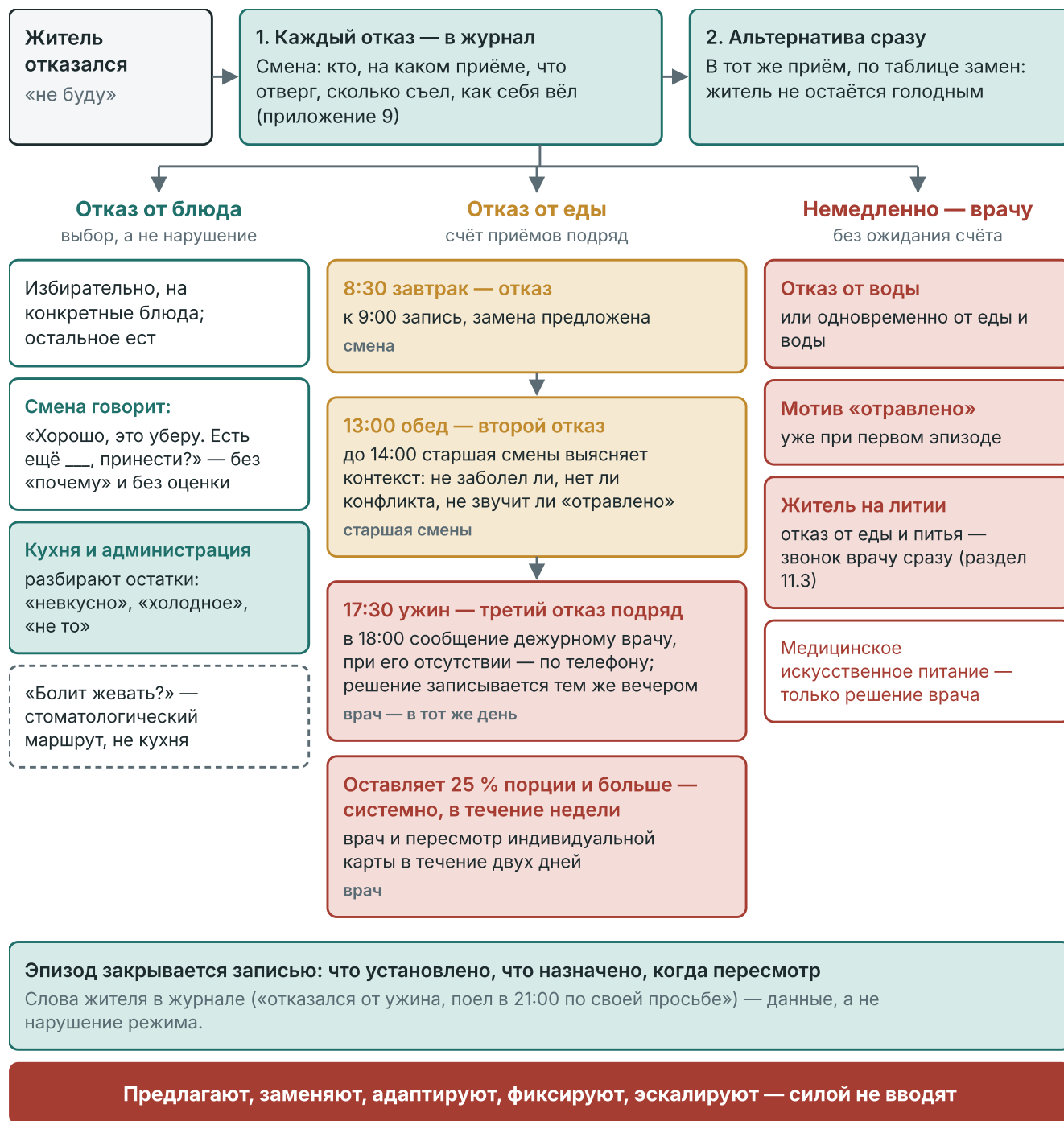


Рисунок 8. Проект российского правила раздела 12.3 по часам одного дня (раздел 12.10). Пороги «три приёма подряд» и «25 % порции» — ориентир из рекомендаций диетологов Канады[94], а не российская норма; всё клиническое решает врач.

12.4. Насилие недопустимо — и что это значит юридически

Кормить силой недопустимо безоговорочно. Принудительное кормление — это насилие, противоречащее праву на «уважительное и гуманное отношение, исключаящее унижение человеческого достоинства», которое ст. 5 ч. 2 Закона РФ № 3185-1 гарантирует каждому лицу с психическим расстройством. Важно не перепутать статьи. Ст. 43 того же закона распространяет на проживающих в стационарных организациях социального обслуживания права,

предусмотренные частями второй и четвёртой ст. 37, но ч. 2 ст. 37 — это перечень прав пациента психиатрического стационара (переписка, свидания, религия и т. д.), а не норма о гуманном обращении[8].

Иное дело — медицинское искусственное питание. Это медицинское вмешательство, и решение о нём принимает врач по законодательству об охране здоровья и правилам оказания психиатрической помощи. Общее правило Федерального закона № 323-ФЗ таково: «Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия», а гражданин или его законный представитель «имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения»; вмешательство без согласия допускается лишь в случаях, прямо перечисленных законом[95]. В эту плоскость доклад не входит: она принадлежит врачу и юристу.

Граница для дома проста и не допускает толкований: жителю **предлагают, заменяют, адаптируют, фиксируют, эскалируют — силой не вводят.**

Оговорка о противоречии внутри корпуса. В более раннем аудите семейства докладов (22.07.2026) формула «принудительное кормление запрещено» названа неточной: прямого запрета в проверенных актах аудит не нашёл, насилие запрещено, а кормление рассматривается как возможное медицинское мероприятие. Канон доклада держит более жёсткую формулу «недопустимо всегда» со ссылкой на ст. 5 ч. 2. Обе позиции фиксируются рядом, а не сглаживаются: для смены разницы нет (сила исключена), для юриста она есть (запрет выводится из права на достоинство, а не из отдельной нормы о кормлении).

12.5. Дееспособность и осознанный отказ

Британская модель исходит из того, что способность принимать решения оценивается применительно к конкретному решению в конкретный момент. Человек с психическим расстройством может быть способен отказаться от конкретного приёма пищи, и тогда его решение фиксируется и уважается[52].

Российская рамка устроена иначе (раздел 16), но в той же логике: недееспособность не отменяет учёта мнения человека, а его отношение к бытовому вопросу оценивается по существу[8]. Интересно, что и общая норма о медицинском вмешательстве не делает законного представителя автоматическим распорядителем: согласие за недееспособного он даёт в случае, если тот по своему состоянию не способен дать согласие сам[95]. Для отказа от конкретного блюда или ужина это означает одно: слова жителя в журнале («отказался от ужина, поел в 21:00 по своей просьбе») — это данные, а не «нарушение режима».

12.6. Предсмертный период

В паллиативной фазе цели питания уступают комфорту. Немецкая и австрийская традиция называет это *Wunschkost* — «желанная еда»: то, что человек хочет и может съесть, важнее полноты рациона[35, 51]. Для ПНИ со стареющим контингентом[7] маршрут питания в конце жизни должен

существовать письменно: кто определяет паллиативный статус, как меняется меню, как информируется семья. Оформление этого маршрута входит в комплект документов раздела 31; содержание паллиативного питания разобрано ниже, в разделе 12.11.

12.7. Что сказать смене в понедельник

Минимальный пакет укладывается в одну планёрку: журнал отказов заведён; правило «три отказа подряд — врач сегодня» знают все; при каждом отказе предлагается альтернатива; список дисфагического риска висит на посту. Стоимость пакета — тетрадь и инструктаж.

12.8. Что говорить жителю: фразы смены

В момент отказа слова рождаются плохие: «ну что ты, давай ложечку». Поэтому смене нужны готовые формулы.

- **Отказ от блюда:** «Хорошо, это уберу. Есть ещё __, принести?» — без вопроса «почему» и без оценки.
- **Отказ от еды вообще:** «Не будете сейчас — оставлю, скажете, когда захотите». Контроль остаётся у жителя, еда сохраняется.
- **«Отравлено»:** «Я вас услышала. Скажу врачу, он придёт сегодня. Хотите, принесу в заводской упаковке?» — без спора с содержанием бреда. Отказ с мотивом отравления передаётся врачу уже при первом эпизоде.

Запрещены фразы «а кто будет доедать», «врач сказал — надо», «в последний раз предлагаю».

12.9. Насилие: почему формулировка жёсткая

Запрет раздела 12.4 сформулирован без оговорок сознательно. Любое «принуждение в исключительных случаях» в стационаре неизбежно расширяется: его границы раздвигают усталость смен и нехватка рук. Удержание, вливание, шантаж, лишение «пока не съешь» недопустимы всегда. Истощение — задача врача (назначения, энтеральная поддержка по показаниям, госпитализация), а не силы смены. Эпизод принудительного кормления — готовый сюжет для прокурорской проверки[8].

12.10. Разбор эскалации по часам

Правило работает только тогда, когда у него есть часы и фамилии. Завтрак в 8:30 — отказ; к 9:00 он записан в журнал, замена предложена. Обед в 13:00 — второй отказ; до 14:00 старшая смены выясняет контекст: не заболел ли человек, нет ли конфликта, не звучит ли «отравлено». Ужин в 17:30 — третий отказ; в 18:00 сообщение уходит дежурному врачу, при его отсутствии — по телефону; решение записывается тем же вечером.

Типичных провалов три. «Подождём утреннего обхода» — обход будет через сутки, а для человека с бредом отравления это слишком поздно. «Передадим устно» — второй отказ теряется, и счёт начинается заново. «Наблюдайте» без записи — это не решение; в записи должно быть указано,

что наблюдать, как часто и когда пересмотр. Три-четыре таких сообщения врачу в месяц — нормальный рабочий поток. Вопрос, ведётся ли журнал, не должен возникать никогда.

12.11. Паллиативное питание: *comfort feeding* и границы искусственного питания

В периоде, описанном в разделе 12.6, отказ становится частью естественного процесса. Вопрос меняется: не «как накормить», а «что еда делает для этого человека сейчас».

Справка. *Comfort feeding*. Комфортное кормление (англ. *comfort feeding*, иногда *comfort feeding only*) — подход, при котором человеку в конце жизни предлагают еду и питьё, пока они приносят ему удовольствие и облегчение: любимые блюда, малые порции, помощь и время, без принуждения и без искусственного питания против воли[96]. Близкое понятие — **бережное кормление с рук** (*careful hand feeding*): помощь в еде с вниманием к темпу, позе и сигналам насыщения.

Исходы здесь нужно читать точно. Ретроспективное госпитальное исследование после рекомендаций *comfort feeding* не имело группы сравнения: среди глубоко паллиативных госпитализированных пациентов с деменцией медиана выживаемости составила 13 дней[97]. Это описание популяции, а не сравнение режимов, и вывода «*comfort feeding* не меняет выживаемость» работа не содержит. Обзор перорального питания при деменции фиксирует прибавку веса при высококалорийных добавках, но не находит доказанного влияния на другие исходы и подчёркивает роль предпочтений человека и культуры ухода[96].

Сравнение с зондом сделало Американское гериатрическое общество в позиционном заявлении 2014 года: «При возникновении трудностей с приёмом пищи зондовое питание пожилым людям с тяжёлой деменцией не рекомендуется». Взамен общество предлагает бережное кормление с рук, «поскольку показано, что оно не уступает зондовому по смертности, аспирационной пневмонии, функциональному статусу и комфорту». Заявление также называет зондовое питание медицинским вмешательством, от которого законный представитель вправе отказаться, и предупреждает учреждения против давления в пользу зонда[98]. Переносимость этого вывода ограничена дважды: он касается тяжёлой деменции, а не психических расстройств вообще, и американской, а не российской правовой и медицинской системы. Но он важен для дома в одном отношении: отказ от зонда в конце жизни — не «оставление без помощи», если взамен человек получает терпеливое кормление с рук.

Итоговая рамка меняет качество процесса, но не доказанно его длительность. В локальном акте её можно выразить тремя строками: (1) формат питания в конце жизни определяет врач вместе с семьёй и, где возможно, с самим жителем; (2) любимые блюда и доступные ему текстуры — элемент паллиативного контура, а не «поблажка»; (3) отказ документируется по разделам 12.4–12.5.

*Маркировка: *comfort feeding* — международный ориентир, а не российская норма; зондовое и парентеральное питание — исключительно врачебное решение (раздел 18 семинарского пакета: «не без врача»).*

12.12. Чего мы пока не знаем

- Российских данных о частоте и причинах отказов от еды в ДСО и ПНИ нет; распределение причин в разделе 12.1 получено на амбулаторных пожилых пациентах в США.
- Пороги «три приёма подряд» и «25 % порции» взяты из канадского регулирования и не проверялись на психиатрическом контингенте; их первоисточник при проверке 2026-10 не открылся.
- Сравнительных исследований comfort feeding и зондового питания у людей с психическими расстройствами без деменции мы не нашли.
- Вопрос о том, запрещено ли принудительное кормление прямой нормой или запрет выводится из права на достоинство, в корпусе остаётся спорным (раздел 12.4).

Журнал отказов, заведённый по разделу 12.3, за год даст дому собственный ответ на первый из этих вопросов.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре <raw/sources/poisk-2026-10-blok-b/istochniki.md>. Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; текст ст. 5, 37 и 43 Закона № 3185-1 (S011) сверен 09.10.2026.

Маркер	Источник
M-wtloss_gaddey	Gaddey H.L., Holder K. Unintentional Weight Loss in Older Adults // Am Fam Physician. 2021;104(1):34–40
M-tube_ags2014	American Geriatrics Society. Feeding tubes in advanced dementia position statement // J Am Geriatr Soc. 2014 (PMID 25039796)
S052	Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ, ст. 20 (ред. от 04.08.2026)

13

Переедание, гиперфагия и ночное едение

Если отказ от еды (раздел 12) пугает своей тишиной, то переедание раздражает своей заметностью. Житель, который просит третью порцию, таскает хлеб со столов и ночью ищет еду, быстро получает ярлык «прожорливого», а вслед за ярлыком — запреты, замки и «воспитательные беседы». Эта глава показывает, что в психиатрическом доме за таким поведением очень часто стоит не характер, а фармакология, и что организация питания может сделать для человека много полезного, не подменяя врача и не превращая столовую в место наказания. Вторая часть главы посвящена тому, чего не видно на тарелке, но что напрямую связано с едой: весу, запору, микронутриентам и согласованию инсулина с гибким временем приёма пищи.

Справка. Гиперфагия и метаболический синдром. Гиперфагией называют патологически повышенное потребление пищи, обусловленное усиленным чувством голода или ослабленным насыщением, а не привычкой или выбором. **Метаболический синдром** — сочетание абдоминального ожирения, повышенного давления, нарушенного обмена глюкозы и липидов, которое резко повышает риск сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых болезней. **Индекс массы тела (ИМТ)** — масса в килограммах, делённая на квадрат роста в метрах. **Весогенными** называют препараты, которые как побочный эффект вызывают прибавку массы тела; среди антипсихотиков наиболее весогенны клозапин и оланзапин.

13.1. Метаболическая цена антипсихотиков: что доказано

Прибавка веса на антипсихотиках — не индивидуальная особенность, а измеренный классовый эффект с большим разбросом между препаратами. Метаанализ ста рандомизированных исследований (Pillinger и соавт., 2020) показал за медиану шести недель лечения разброс от -0,23 кг до +3,01 кг[13]. При длительном применении (около 38 недель) клинически значимую прибавку, то есть 7 % массы тела и более, имеют 76,3 % пациентов на клозапине, 36,9 % на оланзапине и 23,0 % на рисперидоне (Campforts и соавт., 2023, BJPsych Open, DOI 10.1192/bjo.2022.619)[99]. Обратное явление редко: по словам тех же авторов, «доля пациентов, потерявших 7 % массы тела и более, была довольно скромной». При первом эпизоде психоза долгосрочная прибавка составляет 9,34 кг на оланзапине и 7,19 кг на клозапине[100]. Поэтому мониторинг предписан клиническими рекомендациями: вес, глюкоза и липиды контролируются по расписанию (раздел 13.8)[101].

Из этих цифр следует главный вывод главы. Переедание у человека на весогенном препарате — это гиперфагия, а не «прожорливость», и дисциплинарный подход к ней ошибочен по существу. Кухня не лечит голоданием: самостоятельные ограничения рациона без врача противоречат праву (раздел 17) и опасны для здоровья. Клинику кухни не назначает.

13.2. Пищевое поведение: что показывают исследования

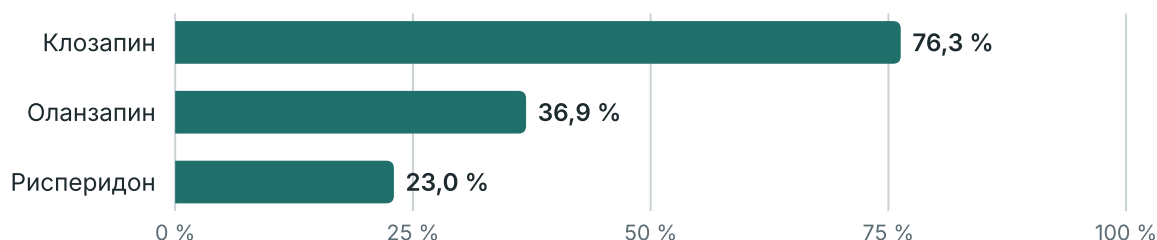
Реалистский синтез RESOLVE, посвящённый пищевому поведению при тяжёлых психических расстройствах, приводит широкие диапазоны: переедание встречается у 4,4–45 % пациентов, навязчивая тяга к еде (food craving) — у 16,1–64 %, ночное едение — у 4–30 %[56]. Широта диапазонов объясняется различием методов и изученных популяций; переносить их на российский дом как точную оценку нельзя. Но даже нижние границы означают заметную группу в каждом доме.

Возможности снизить вес у этой группы скромны. Метаанализ вмешательств в образ жизни даёт в среднем около $-1,4$ кг[102]; программы с участием диетолога работают лучше именно тогда, когда специалист действительно есть[103]. Это марафон с малыми цифрами, и его ядро — среда, мониторинг и врач, а не ограничения.

Лекарственная профилактика прибавки веса существует, но относится исключительно к врачебной зоне. Кокрейновский обзор 2022 года (17 рандомизированных исследований, 1388 участников с шизофренией) нашёл доказательства низкой достоверности в пользу метформина: прибавка массы при его назначении была в среднем на 4,03 кг меньше, чем при плацебо или без лечения (95 % ДИ от $-5,78$ до $-2,28$; 4 исследования, 131 участник), а ИМТ — на 1,63 кг/м² меньше. Авторы осторожны: «Имеются доказательства низкой достоверности в пользу того, что метформин может предотвращать прибавку массы тела», а интерпретацию ограничивают малое число и малый размер исследований[104]. Для дома из этого следует не рекомендация препарата, а аргумент в разговоре с врачом: если житель стремительно набирает вес, у врача есть инструменты помимо диеты, и сообщить ему о прибавке вовремя — задача дома.

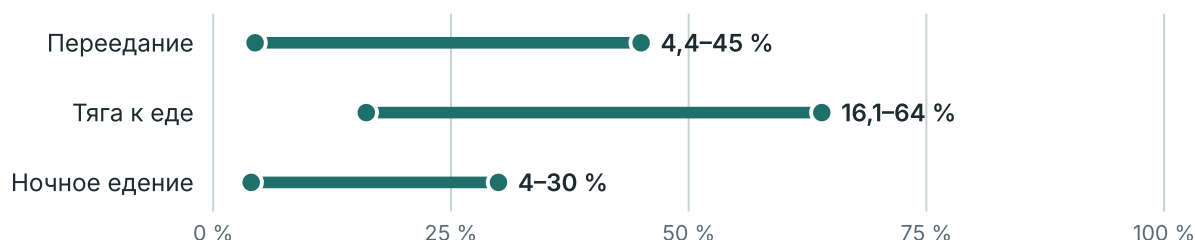
Доля пациентов с прибавкой 7 % массы тела и более

длительное лечение, около 38 недель



Пищевое поведение при тяжёлых психических расстройствах

диапазоны частоты в разных исследованиях



Что делает дом: вес как сигнал врачу

Регламент

взвешивание ежемесячно, на одних весах, в одно время

Набор

прибавка более 5 % за квартал — сообщение врачу

Потеря

5 % за 30 дней, 7,5 % за 90, 10 % за 180 — врачу в тот же день

Зарубежные данные переносятся на российский дом как порядок величины, а не как оценка. Препарат, диету и лекарственную профилактику прибавки выбирает только врач; кухня даёт вес, журнал и карту.

Рисунок 9. Прибавка веса на антипсихотиках[99] и частота пищевого поведения[56] — зарубежные данные, переносимые как порядок величины. Пороги для сообщения врачу — по разделам 13.3 и 13.8[27, 101].

13.3. Что может организация питания (без подмены врача)

Мониторинг веса. Вес измеряется при начале терапии, на 4-й, 8-й и 12-й неделе и далее по графику. Прибавка 5 % и более за три месяца и онтарийские пороги изменения массы 5 / 7,5 / 10 % служат сигналами для врача[27, 101]. Весы, журнал и ответственный сотрудник — вот и всё, что для этого нужно; стоимость практически нулевая. Подробный порядок — в разделе 13.8.

Среда вместо запретов. Важнее не то, что запрещено, а то, что доступно между приёмами пищи: фрукты и кисломолочные продукты вместо выпечки; отсутствие энергетических напитков и ограничение сладких напитков (раздел 11); приёмы пищи без длинных «дыр», провоцирующих голод. Это не диета и не урезание порций, а потому закономерно без врачебного назначения.

Добавка по правилам. Ситуацию «дайте вторую котлету» (кейс раздела 5) закрывает письменный порядок выдачи добавки: кому, что и когда. Ограничение порций допускается только по назначению врача и только поимённо (раздел 17).

13.4. Ночное едение: не наказывать, а структурировать

Ночное едение, встречающееся по данным RESOLVE у 4–30 % пациентов[56], имеет три основных корня: лекарственную гиперфагию, нарушения сна с ночным пробуждением аппетита и тревогу. Замок на кухне не устраняет ни один из них. Он добавляет тревогу, порождает конфликт и толкает человека искать еду вне дома или у соседей. Действенная альтернатива — **структурированная ночная доступность**: поздний перекус по расписанию, вода, чай и сухой перекус на посту. Её устройство разобрано в разделе 13.9.

Справка. Синдром ночного едения. Не всякое ночное перекусывание — расстройство.

Международный консенсус 2010 года предложил для **синдрома ночного едения** (night eating syndrome) такие критерии: аномально повышенное потребление пищи вечером и ночью, проявляющееся «потреблением не менее 25 % суточного рациона после ужина и/или ночными пробуждениями с приёмом пищи не реже двух раз в неделю»; человек осознаёт эти эпизоды; они вызывают страдание или нарушают функционирование; длятся не менее трёх месяцев и сопровождаются дополнительными признаками[105]. Ставит такой диагноз врач. Дому критерии полезны тем, что показывают, какие наблюдения стоит записывать: долю съеденного после ужина, число ночных пробуждений с едой в неделю, помнит ли человек о них утром. Если не помнит, речь может идти о другом расстройстве, связанном со сном, и это тоже повод сообщить врачу.

Та же мера сокращает ночной интервал между ужином и завтраком. Международные ориентиры для него составляют 11–14 часов[39, 46]. Четырнадцать часов — верхняя граница американского регулятора CMS, а не российская норма и не цель. Рабочая цель дома — не более 13 часов; санитарные требования к режиму питания разобраны в разделе 18. Одна бесплатная мера, таким образом, решает две задачи: поведенческую и режимную.

13.5. Когда вопрос клинический

Врачу сообщают: о прибавке 5 % массы и более за три месяца у жителя на препарате; о гиперфагии, которая ломает режим; о ночном едении, похожем на синдром (см. справку выше); о любом запросе «посадить на диету», от кого бы он ни исходил. Только врач решает о смене препарата, ограничительном рационе, консультации эндокринолога, назначении метформина или других лекарств. Дом даёт врачу вес, журнал и индивидуальную карту — и исполняет назначения.

13.6. Что сказать повару в понедельник

Вес измеряется по графику с триггерами; добавка выдаётся по правилам; ночная доступность организована. «Посадить на диету» без врача нельзя. Выбор внутри продуманной среды снижает конфликт за столом.

13.7. Разговор с жителем о весе: без стыда

«Воспитательные беседы» бесполезны и жестоки: весогенный эффект препарата не лечится стыдом[13]. Рабочая формула разговора: «это побочный эффект лечения, который мы вместе обходим», а не «ваше переедание». Инструменты, которые дом может предложить: объёмные

низкокалорийные добавки, дробные приёмы, доступность еды по понятному режиму, физическая активность. Человек, который понимает, откуда берётся голод и как устроена его порция, сотрудничает. Человек, которому ничего не объяснили, обходит правила: через передачи, чужие тарелки, подпольные запасы, где калорий в итоге больше.

13.8. Метаболический мониторинг как часть питания

Вес и сахар крови — предмет кухни в не меньшей мере, чем врачебного кабинета. Антипсихотики различаются по прибавке массы на килограммы уже за недели[13]; при первом эпизоде психоза прибавка на оланзапине достигает 9,34 кг[100]; а на практике мониторинг нередко оказывается неполным[101]. Для стационарной организации социального обслуживания разумен простой регламент: взвешивание ежемесячно, на одних и тех же весах, в одно и то же время; прибавка более 5 % за квартал — сообщение врачу и пересмотр плана.

Отдельно нужно следить не только за набором, но и за потерей массы. Для этого служит **MUST** (Malnutrition Universal Screening Tool — универсальный инструмент скрининга недостаточности питания, разработанный британской ассоциацией BAPEN). Это пять шагов: ИМТ, непреднамеренная потеря более 5 % массы за 3–6 месяцев, наличие острого заболевания, затем суммарная оценка риска и план действий; в домах ухода взвешивание обычно проводят ежемесячно[106]. Не путать с порогом «+5 % на оланзапине»: набор и потеря — две разные строки панели показателей (раздел 22). Шкалу заполняет медицинская сестра или врач; кухня сообщает вес и факт поедания, но категорию риска не ставит. У лежачего жителя без кресла-весов строка «вес» превращается в фикцию, и это надо признать, а не заполнять «на глаз». Онтарийские пороги потери — 5 % за 30 дней, 7,5 % за 90 дней, 10 % за 180 дней[27] — служат поводом сообщить врачу в тот же день. О причинах непреднамеренной потери массы у пожилых — раздел 12.1.

13.9. Ночная доступность: конструкция, а не «открытый холодильник»

Структурированная ночная доступность (раздел 13.4) — это не свободный доступ к кухне и не правило «ночью ничего нет». Она складывается из четырёх элементов.

- **Перечень.** Два-три продукта, согласованных с врачом: кефир, хлеб, фрукты по сезону; при метаболическом риске — низкокалорийные объёмные продукты.
- **Место.** Пост или буфет отделения, но не кухня.
- **Режим.** Окно, например с 21:00 до 22:00, и выдача при ночном пробуждении — с записью.
- **Границы.** При гиперфагии еда выдаётся порционно, а не по принципу «возьми сам».

Клинический смысл конструкции в том, что едение перестаёт быть подпольным и становится видимым врачу. Правовой — в том, что ночная еда оформляется как услуга, а не как «нарушение режима». Арифметика простая: при частоте ночного едения 4–30 % [56] на отделение в 30 человек приходится от одного до девяти человек еженощно. Вопрос, следовательно, не в том, будут ли люди есть ночью, а в том, будет ли это происходить подпольно или организованно.

13.10. Запор: скрытый регулятор аппетита и поведения

Сниженный аппетит, «необъяснимое» беспокойство и отказы от еды нередко имеют причину, о которой не принято говорить, — запор. При лечении клозапином он встречается у 30–60 % пациентов, а при объективных исследованиях гипомотильность желудочно-кишечного тракта выявляется у 80 %; исходом могут стать кишечная непроходимость, перфорация и смерть. Австралийский регулятор TGA ввёл соответствующее предупреждение в инструкцию к препарату[33]. Национальная служба здравоохранения Великобритании называет запор при клозапине потенциально смертельным и рекомендует мониторинг стула и профилактические слабительные по назначению врача[107]. Новозеландский регулятор Medsafe в 2020 году сформулировал то же предельно ясно: «Тяжёлые, иногда смертельные осложнения запора связаны с запоздалой диагностикой»; пациента следует активно расспрашивать о стуле, а действовать при необходимости срочно, «не дожидаясь, пока симптомы пройдут сами»[83].

Справка. Гипомотильность и антихолинергическая нагрузка. Гипомотильность — замедление сократительной активности кишечника, при котором содержимое продвигается медленно. Многие психотропные препараты (клозапин, часть антидепрессантов, корректоры экстрапирамидных расстройств) обладают **антихолинергическим** действием: они блокируют передачу нервных сигналов, усиливающих работу кишечника и слюнных желёз. Суммарный эффект нескольких таких препаратов называют **антихолинергической нагрузкой**; её признаки — запор, сухость во рту, задержка мочи, спутанность.

Что делает дом. В постовом журнале ведётся строка «стул за сутки: да/нет» — без подробностей. Вода и клетчатка стоят в меню, а не выдаются «по просьбе»; после еды предлагается движение. Трое суток без стула у жителя из группы антихолинергической нагрузки — повод сообщить врачу в тот же день. Журнал содержит сведения о здоровье: доступ к нему имеют пост и врач, но не кухня и не «все смены»; основание для его ведения — законодательство о социальном обслуживании и 152-ФЗ (раздел 17.6); диагноз в нём не пишется.

Маркировка: питание — поддержка и мониторинг; слабительные, диагностика и подбор терапии — только врач (раздел 18 семинарского пакета: «не без врача»).

13.11. Микронутриенты: то, что не видно на весах

Весы из раздела 13.8 не покажут дефицитов, которые влияют на настроение, когнитивные функции и аппетит.

- **Витамин D.** Его дефицит широко распространён в психиатрической популяции, и рутинный скрининг рекомендован[108]. Карбамазепин — индуктор печёночных ферментов, и метаанализ связывает его приём со снижением концентрации 25(OH)D, основной циркулирующей формы витамина[109]; этот препарат уже фигурирует в таблице раздела 11.
- **Витамин B12 и фолат.** Их дефицит с возрастом встречается чаще, связан с депрессией и когнитивными нарушениями и недодиагностируется у пожилых[110].
- **Железо.** Редкое мясо в рационе плюс скрытые потери крови дают анемию, которая маскируется под «усталость и плохо ест». Связь анемии с поеданием несъедобного разобрана в разделе 14.4.

Дом не лечит дефициты, а задаёт вопрос и подсвечивает риск: в годовой маршрут жителей на противосудорожных препаратах и вегетарианцев включается строка «профиль микронутриентов обсудить с врачом». Анализы и добавки назначает врач[108].

13.12. Инсулин и время еды: гибкий стол без гипогликемии

Сахарный диабет в стационарных учреждениях — обычное дело, а вариативность ломает привычное правило «все едят в одно время». Если инъекция инсулина привязана к раздаче, а житель выбрал отложенный приём пищи или съел меньше обычного, возникает клинический риск гипогликемии.

Справка. Гипогликемия. Гипогликемия — снижение глюкозы крови ниже безопасного уровня; в британских памятках для домов ухода порогом служит 4 ммоль/л[111]. Признаки — потливость, дрожь, голод, беспокойство, спутанность, у пожилых и у людей на седативных препаратах нередко стёртые. Самая частая бытовая причина — введённый инсулин без последующей еды.

Прямых российских норм о сочетании инсулинотерапии и вариативного меню нет. Зарубежный опыт показывает, что задача решается не на кухне, а в назначении. Так, памятка одного из округов британской NHS для домов ухода различает препараты: человеческий растворимый инсулин короткого действия вводят за 20–30 минут до еды, а ультракороткий аналог — «непосредственно перед едой, содержащей углеводы, во время или после неё (согласно индивидуальному плану лечения)»; при рвоте или отказе от еды и питья памятка велит звонить врачу, а при диабете 1 типа не пропускать инсулин самовольно[111]. Это локальный документ с истёкшим сроком пересмотра, и мы приводим его как иллюстрацию, а не как стандарт; но логика переносится: гибкость времени еды для человека на инсулине — вопрос, который ставят врачу, а не решают сменой.

Что делает дом. Список жителей на инсулине хранится у поста и кухни без диагноза в открытом доступе, с пометкой «время еды фиксировано» или «время еды гибкое». Сдвиг приёма пищи больше [локальный порог, согласовать с врачом] допускается только с отметкой врача. Отложенный обед предлагается вместе с переносом инъекции, согласованным врачом, или не предлагается вовсе. Гибкость для остальных жителей от этого не страдает.

Только врач меняет схему; организация не сдвигает инсулин «по договорённости смены».

13.13. Чего мы пока не знаем

- Российских данных о частоте гиперфагии, ночного едения и прибавки веса на антипсихотиках у жителей ПНИ нет; диапазоны RESOLVE переносятся только как порядок величин.
- Данные о метформине получены на небольших и коротких исследованиях с низкой достоверностью и к организации питания отношения не имеют, кроме того, что врачу нужен вовремя переданный вес.
- Онтариийские пороги потери массы при проверке 2026-10 по первоисточнику не сверены.
- Как структурированная ночная доступность влияет на вес и инциденты в российских домах, никто не измерял; это вопрос для собственного пилота (раздел 35).

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-b/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; атрибуция M-crwg (Campforts и соавт., 2023) сверена со страницей издателя 09.10.2026.

Маркер	Источник
M-metformin_cochrane	Agarwal S.M. et al. Pharmacological interventions for prevention of weight gain in people with schizophrenia // Cochrane Database Syst Rev. 2022; CD013337.pub2
M-nes_allison	Allison K.C. et al. Proposed diagnostic criteria for night eating syndrome // Int J Eat Disord. 2010;43(3):241–247
I-medsafe_clozapine_2020	Medsafe (Новая Зеландия). Clozapine: datasheet updates, 09.06.2020
I-insulin_bnssg	BNSSG APMOC (NHS). Insulin Administration and Blood Glucose Monitoring Record for Adults in Care Homes, 2019

14

Пикацизм, заглатывание и другие поведенческие риски за столом

Предыдущие главы разобрали большие клинические темы стола: поведение (раздел 9), глотание (раздел 10), лекарства (раздел 11), отказ (раздел 12) и переедание (раздел 13). Остаётся группа рисков, каждый из которых по отдельности редок, но в сумме они неизбежны в любом психоневрологическом интернате: поедание несъедобного, проглатывание предметов, отбирание чужой еды, опрокидывание посуды, жёсткие пищевые ритуалы. Организация питания их не лечит, но управляет ими, и от качества этого управления зависит, закончится ли эпизод записью в журнале или травмой. Эта глава собирает такие риски в один протокол и проводит вторую — после раздела 12 — границу с насилием.

Справка. Пикацизм. Пикацизм (от лат. *pica* — сорока, птица, известная привычкой хватать что попало) — устойчивое поедание несъедобных веществ: бумаги, земли, мела, ниток, ваты, штукатурки, волос, мыла. В МКБ-10 рубрика F98.3 описывает его как «устойчивую тягу к поеданию непищевых продуктов» в младенчестве и детстве; российский справочник к рубрике поясняет, что случаи с одновременной умственной отсталостью кодируются рубриками F70–F79 и что, «за исключением случаев с умственной отсталостью, расстройство проходит к подростковому возрасту»[112]. Отсюда практический вывод: у взрослых жителей ПНИ пикацизм обычно не отдельный диагноз в документах, а поведение в рамках основного расстройства, и потому его легко не заметить в медицинской карте. Близкое, но иное явление — **проглатывание инородных тел** (пуговиц, батареек, ложек, острых предметов), нередко намеренное.

14.1. Круг рисков

Помимо паттернов, описанных в разделах 9–13, столовая ПНИ встречается с рисками, редкими по отдельности и неизбежными в сумме. Их не лечит организация — ими она управляет. Цена ошибки здесь — безопасность человека.

Пикацизм (поедание несъедобного). Предметом становятся бумага, земля, мел, вата, бытовая химия, чужие лекарства. Пикацизм встречается при умственной отсталости, психозах, деменции. Управление складывается из среды без доступных опасных объектов (бытовая химия и медикаменты хранятся вне досягаемости и учитываются отдельно), наблюдения за жителем с зафиксированным пикацизмом во время еды и на прогулке и информирования всей смены, а не только врача. Запись о пикацизме в индивидуальной карте обязательна: это вопрос пищевой безопасности не меньший, чем аллергия. Масштаб и причины — раздел 14.4.

Быстрое заглатывание. В разделе 9 оно описано как паттерн поведения, здесь — как риск. Механизм тот же, что при дисфагии: непрожёванный кусок перекрывает дыхательные пути. Удушье пищей — документированная причина смерти в психиатрических учреждениях[61]; масштаб этого риска и его связь с антипсихотиками изложены в разделе 10.2. Меры за столом:

малые порции с возможностью добавки, отсутствие крупных сухих кусков, посадка рядом с сотрудником, владение приёмом Геймлиха всей сменой (алгоритм — приложение 12). Это пищевая безопасность, а не «первая помощь вообще».

Отбирание еды и «грабёж» стола. Причины — лекарственная гиперфагия (раздел 13), опыт недокорма в прошлом, особенности поведения. Меры: не сажать такого жителя рядом с медленно едящими людьми из группы риска; применять правила добавки; следить за весом обоих — и того, кто отбирает, и того, у кого отбирают. Жертву никогда не делают виноватой, и её порция восполняется всегда.

Опрокидывание, бросание, отказ от приборов. Чаще всего это возбуждение или протест. Меры: посуда без стекла; еда, которую удобно брать руками (*finger food*), как штатная опция, — Британская ассоциация диетологов включает её в меню психиатрических стационаров именно для таких ситуаций[47]; отдельный стол; приём пищи после снижения возбуждения, то есть отложенная порция вместо пропущенной (раздел 12).

Ритуалы и пищевые «правила». Определённый цвет еды, своя тарелка, строгий порядок блюд. Пока ритуал не опасен, он учитывается, а не «лечится»: это самый дешёвый вид персонализации. Индивидуальная карта фиксирует его как данность, и кухня с ним считается.

14.2. Общий протокол: среда, наблюдение, запись, эскалация

Для локального акта все перечисленные риски сводятся к четырём звеньям.

1. **Среда:** опасное вне досягаемости, посуда безопасная, рассадка продуманная.
2. **Наблюдение:** сотрудник за столом не только подаёт, но и видит. «Обеденный дежурный» — штатная роль, а не обязанность «кто свободен».
3. **Запись:** пикацизм, заглатывание с поперхиванием, отбирание, опрокидывание — это строка в журнале, а не рассказ «на кухне».
4. **Эскалация:** повторный эпизод — сообщение врачу; угроза (поперхивание, проглоченное несъедобное, чужое лекарство) — врач немедленно.

Как эти звенья распределяются по людям и часам, показано в разделе 14.7.

14.3. Граница с насилием — вторая сторона

Соблазн при таких рисках понятен: связать, запереть, изолировать от еды, кормить отдельно «в наказание». Всё это вне закона и вне доказательности.

Вне закона — потому что Закон РФ № 3185-1 гарантирует каждому лицу с психическим расстройством «уважительное и гуманное отношение, исключаящее унижение человеческого достоинства» (ст. 5 ч. 2), а ст. 43 распространяет на проживающих в стационарных организациях социального обслуживания права пациентов стационара по ст. 37[8]. (В прежней редакции главы гуманное отношение ошибочно приписывалось ст. 37; см. раздел 12.4, где статьи разведены.) Вне доказательности — потому что сила не меняет ни гиперфагию, ни пикацизм, ни заглатывание: она лишь переносит их туда, где их никто не видит.

Изоляция при возбуждении — это клиническая процедура, а не «дисциплина за столом», и питание в этой ситуации организуется по правилам раздела 12.4 и рекомендациям BDA[47]. Локальный акт дома прямо запрещает лишение еды как меру воздействия, ограничение питья и «штрафные» порции. Эта строка положения защищает и жителя, и директора.

Предвидение здесь дешевле реакции. Один инструктаж по четырём звеньям (среда — наблюдение — запись — эскалация), безопасная посуда, продуманная рассадка, правила добавки и запрет «едовых наказаний» — и эпизод заканчивается записью, а не травмой.

14.4. Пикацизм: что известно о масштабе и причинах

Российских данных о распространённости пикацизма в ПНИ нет. Ближайший зарубежный ориентир — сплошное обследование 1008 взрослых с интеллектуальной недостаточностью, живших в специализированных учреждениях канадской провинции Онтарио. Пикацизм обнаружился у 21,8 %, то есть примерно у каждого пятого. Чаще он встречался у мужчин, у людей с аутизмом и у тех, кто общается невербально, причём «сильнейшим коррелятом этого поведения оказалась невербальная коммуникация»; у людей с выраженной зависимостью в повседневной активности он встречался реже[113]. Переносимость ограничена: это учреждения для людей с интеллектуальной недостаточностью, а не смешанный контингент российского ПНИ, и данные получены почти двадцать лет назад. Но порядок величин говорит о том, что в доме на несколько сотен мест жители с пикацизмом наверняка есть, и вопрос лишь в том, знает ли о них смена.

Связь с невербальной коммуникацией важна для доклада о выборе. Человек, который не может сказать «я голоден», «мне скучно» или «у меня болит», выражает это поведением, и поедание несъедобного может оказаться одним из таких сообщений. Здесь пикацизм смыкается с темой невербального выбора и четырёх каналов воли (раздел 15).

Второй известный фактор — дефицит микронутриентов. Метаанализ 43 исследований (6407 человек с пикацизмом и 10 277 контролей) показал, что пикацизм связан с анемией (отношение шансов 2,35; 95 % ДИ 1,94–2,85), более низким гемоглобином, гематокритом и уровнем цинка в плазме. Авторы подчёркивают, что «направление причинной связи между пикацизмом и дефицитом микронутриентов неизвестно»[114]: дефицит может вызывать тягу к несъедобному, а несъедобное — мешать усвоению железа и цинка. Кроме того, исследования охватывали в основном беременных и детей, а не взрослых жителей психиатрических учреждений. Вывод для дома поэтому осторожный: каждый новый эпизод пикацизма — повод для врача рассмотреть и соматические причины, включая анемию (см. также раздел 13.11), а не только поведенческие.

14.5. Заглатывание предметов: граница с соматикой

Проглоченный предмет — это уже соматическая проблема. Стул, температура, боли в животе в последующие дни отслеживаются по назначению врача и записываются. Формула «проглотил — вышло — забыли» опасна: часть предметов травмирует не сразу.

Что известно о таких эпизодах из зарубежной практики. По оценкам, которые приводят гастроэнтерологи, 80–90 % проглоченных инородных тел проходят по желудочно-кишечному тракту самостоятельно, 10–20 % требуют эндоскопического извлечения и около 1 % —

хирургической операции; острые, заострённые и длинные предметы в пищеводе и желудке извлекаются эндоскопически всегда. Намеренное проглатывание сосредоточено именно в нашей группе: в одной из цитируемых серий 92 % случаев были намеренными, а 85 % пострадавших составляли психиатрические пациенты; в другой серии 79 % пациентов имели психиатрический диагноз и 58 % жили в учреждениях. Авторы настаивают на командном подходе с обязательным участием психиатра[115]. Эти числа — вторичный пересказ американских серий, и для российского дома они важны не точностью, а структурой: большинство эпизодов кончается благополучно, но решить, какой эпизод опасен, может только врач, а повторные эпизоды — задача психиатрической, а не хозяйственной службы.

Что делает дом. При опасном проглатывании (острый или длинный предмет, батарейка, бытовая химия, чужие лекарства) вызывается скорая помощь. При любом другом эпизоде — врач в тот же день и наблюдение по его назначению. Каждый эпизод проходит протокол разбора (приложение 34). Вопрос разбора не «кто недосмотрел», а «как предмет оказался доступен»: второй вопрос чинит систему, первый учит смену молчать.

14.6. Пикацизм и кухня: точка пересечения

Часть эпизодов пикацизма — это поиск еды несоциальными способами на фоне голода, реального или субъективного при лекарственной гиперфагии (раздел 13). Здесь у кухни два инструмента. Первый — структурированная доступность еды: перекусы по расписанию снижают поисковое поведение (устройство ночной доступности — раздел 13.9). Второй — безопасный буфет, в котором нет ничего, что нельзя есть: ни моющих средств рядом с хлебом, ни декоративных муляжей фруктов, ни упаковочного материала. Правильно устроенный стол здесь становится профилактикой инцидентов.

14.7. Протокол «среда — наблюдение — запись — эскалация» на практике

Четыре звена раздела 14.2 работают, только если за каждым стоят конкретные люди и часы.

Среда. Старшая смены раз в неделю осматривает зону: мелкие предметы, оторванные детали одежды и мебели, моющие средства, пуговицы, шнурки. Результат фиксируется строкой с подписью. Десять минут такого осмотра ловят риск до эпизода.

Наблюдение. Речь не о том, чтобы «смотреть постоянно», а о том, чтобы знать окна риска. Для пикацизма это скука и бесструктурное время, особенно после еды. Занятие, прогулка, присутствие сотрудника рядом действуют сильнее надзора.

Запись. Что произошло, когда, где и что предшествовало эпизоду. Серия таких записей за месяц даёт паттерн, с которым врач уже может работать.

Эскалация. Врач привлекается при первом же эпизоде, потому что пикацизм — симптом, а не «привычка»: за ним могут стоять дефициты (раздел 14.4), компульсивное поведение, обострение. При опасном проглатывании вызывается скорая помощь.

Замещение. Жевательные альтернативы и доступность еды по согласованию с врачом дают поведению легальный выход. Логика та же, что у ночной доступности (раздел 13): если у поведения нет легального выхода, оно уходит в подполье.

14.8. Чего мы пока не знаем

- Распространённость пикацизма и намеренного проглатывания предметов в российских ПНИ и ДСО не изучена; единственный близкий ориентир (21,8 %) получен в канадских учреждениях для людей с интеллектуальной недостаточностью.
- Связь пикацизма с анемией и дефицитом цинка показана в основном у беременных и детей; для взрослых жителей психиатрических учреждений её величина неизвестна.
- Доли благополучного исхода при проглатывании предметов взяты из вторичного пересказа американских серий.
- Официальный текст МКБ-11 о пикацизме в этой главе не сверялся.

Журнал по разделу 14.7 за год даст дому собственную картину, которой сейчас нет ни у кого.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-b/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; текст ст. 5, 37 и 43 Закона № 3185-1 (S011) сверен 09.10.2026.

Маркер	Источник
M-pica_ashworth	Ashworth M., Martin L., Hirdes J.P. Prevalence and correlates of pica among adults with intellectual disability in institutions // J Ment Health Res Intellect Disabil. 2008;1(3):176–190
M-pica_miao	Miao D., Young S.L., Golden C.D. A meta-analysis of pica and micronutrient status // Am J Hum Biol. 2015;27(1):84–93
M-fb_palese	Palese C., Al-Kawas F.H. Repeat Intentional Foreign Body Ingestion: The Importance of a Multidisciplinary Approach // Gastroenterol Hepatol (N Y). 2012
S053	РЛС. МКБ-10, рубрика F98.3 «Поедание несъедобного младенцами и детьми» (проверено 09.10.2026)

ЧАСТЬ 4

Право и санитария

разделы 15–18

15

Невербальный выбор: как услышать того, кто не говорит

Вариативное меню обычно представляют как вопрос: «Что будете — гречку или рис?» Для значительной части жителей психоневрологического интерната этот вопрос бесполезен, а иногда и жесток: он требует ответа в той форме, которая человеку недоступна, и затем объявляет молчание отказом от выбора. Эта глава о том, как устроить выбор для тех, кто не говорит или говорит с трудом, и почему именно здесь решается, будет ли вариативность реальной для большинства или останется привилегией немногих. Глава открывает блок, где право и санитария встречаются со столом: за ней следуют разделы о дееспособности (16), о российском праве (17) и о санитарных правилах (18).

Справка. Невербальный выбор и альтернативная коммуникация. Невербальным выбором в докладе называется любое выражение предпочтения без слов: указание рукой или взглядом, движение к предмету или от него, мимика, принятие или отталкивание тарелки, наконец, то, что человек съел и что оставил. В специальной литературе близкое понятие — **альтернативная и дополнительная коммуникация** (АДК; англ. *augmentative and alternative communication*): совокупность способов, которые дополняют или заменяют устную речь, от жестов и карточек с изображениями до коммуникационных досок и электронных устройств. Невербальный выбор — не «упрощённая версия» настоящего, а другой канал той же воли.

15.1. Масштаб вопроса

По вторичной аналитике проекта «Если быть точным», около трёх четвертей жителей российских ПНИ (74 %) признаны недееспособными[7]. Это правовой статус, а не характеристика речи, но он хорошо показывает состав контингента. Значимая часть жителей, в том числе сохранивших дееспособность, не выразит выбор словом: среди них неговорящие и малоговорящие люди, люди с глубокой умственной отсталостью, с деменцией, а также находящиеся в остром состоянии. В вашем доме доли будут иными, и их стоит посчитать самостоятельно.

Отсюда следует вывод, который определяет устройство всей системы. Если вариативность опирается только на вопрос «что будете?», она сама отсекает большинство тех, ради кого задумана. Поэтому технология выбора для неговорящих — не пристройка к вариативному меню и не «особый случай», а его ядро.

15.2. Правовая рамка: поддержанное, а не подменяющее решение

Справка. Подменяющее и поддержанное принятие решений. При **подменяющем** (замещающем) принятии решений за человека решает другой — опекун, учреждение, врач — исходя из того, что он считает «наилучшими интересами» подопечного. При **поддержанном** принятии решений человеку помогают сформировать и выразить собственную волю: предоставляют информацию в доступной форме, время, посредника, иные способы коммуникации. Различие принципиально: в первой модели вопрос звучит как «что для него лучше?», во второй — как «чего он хочет и как нам это понять?».

Международным ориентиром служит Замечание общего порядка № 1 Комитета ООН по правам инвалидов к статье 12 Конвенции о правах инвалидов (2014)[31]. Логика документа такова: установка «мы знаем лучше» подлежит замене поддержкой. Человек получает помощь, чтобы выразить свою волю, а его воля и предпочтения не подменяются «наилучшими интересами». Для темы этой главы важны два положения Замечания. В пункте 17 к формам поддержки прямо отнесены «разработка и признание разнообразных, нетрадиционных способов коммуникации», то есть невербальный выбор рассматривается как полноценный способ выражения воли. В пункте 21 сказано, что там, где после значительных усилий установить волю и предпочтения человека невозможно, «наилучшее толкование воли и предпочтений» должно заменить определение «наилучших интересов»[31]. Именно на этом различии построены каналы и иерархии разделов 15.3, 15.4 и 15.9: при молчании человека дом ищет наиболее достоверное толкование его воли, а не собственное представление о полезном.

Российское право этой логике не противоречит, но основания нельзя смешивать. Право на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства, закреплено в части 2 статьи 5 Закона № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»[8]. Статья 43 того же закона задаёт статус и права проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами: в действующей редакции она распространяет на них права, предусмотренные частями 2 и 4 статьи 37[8]. Обязанность опекуна учитывать мнение подопечного, а при невозможности его установить — сведения о его предпочтениях, вытекает из Гражданского кодекса (п. 2 ст. 29, п. 3 ст. 36)[116]; Федеральный закон № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в этой части отсылает к гражданскому законодательству[117]. Подробная карта этих норм — раздел 16.2. Федеральный закон № 442-ФЗ закрепляет права получателя социальных услуг и индивидуализацию их предоставления[118].

Выбор еды — бытовое решение, а не сделка. Неспособность совершать сделки не отменяет способности предпочитать: человек, признанный недееспособным, не может подписать договор, но может отвернуться от рыбы и потянуться к котлете.

Маркировка: этот раздел — системное толкование норм, а не прямое правило закона. Прямой нормы «выбор блюда не требует дееспособности» в российском законодательстве нет. Замечание общего порядка № 1 — толкование международного договора, на которое можно ссылаться как на обоснование, но не как на обязанность кухни (раздел 17.7). Практические формы ниже — проект локальной практики.

15.3. Четыре канала воли

Воля человека, который не говорит, не исчезает — она проявляется иначе. Доклад выделяет четыре канала, по которым её можно уловить и записать. Каждый канал по отдельности несовершенен; вместе они дают картину, которой можно доверять.

Канал 1. Показ вместо вопроса. Вербальный выбор требует удержать в памяти два слова, соотнести их с прошлым опытом и ответить. Для многих жителей это непосильно, и неудача здесь говорит о трудности задачи, а не об отсутствии предпочтения. Две реальные порции снимают эту трудность: человек указывает, тянется, смотрит, отворачивается. Практика ухода за людьми с деменцией, в том числе подходы, основанные на методе Монтессори, рекомендует визуальный выбор вместо вербального[47, 119]. Отсюда организационное условие: вариант Б должен физически стоять на линии раздачи. Без минимальной вариативности показ двух порций невозможен (ступень 1, раздел 8).

Канал 2. Наблюдение за потреблением. Тарелка — это голос. Систематически несъеденное блюдо — зафиксированное «нет», доеденное до конца — «да». Журнал потребления (раздел 9) становится документом предпочтений, если его ведут не ради отчёта, а ради вывода. Скандинавские муниципальные стандарты прямо требуют документировать наблюдаемые предпочтения тех, кто не сообщает их словами[120]. Одно наблюдение ничего не доказывает: человек мог быть сонным, у него мог болеть зуб, блюдо могло остыть. Предпочтение — это серия наблюдений, а не впечатление (раздел 15.6).

Канал 3. Пищевая биография в «хороший день». Пока состояние позволяет, вместе с жителем — а также с семьёй и давними работниками — заполняется пищевая биография: любимое и нелюбимое, ритуалы, «детские» блюда, привычный распорядок[35]. Документ сохраняет волю периода наибольшей ясности на то время, когда ясности станет меньше. В этом смысле он реализует приоритет зафиксированной воли[31]. Форма — приложение 3.

Канал 4. Те, кто знает человека. Семья, опекун, давние работники — источники для толкования воли, а не «решающие за него». Их сведения входят в пищевую карту с обязательным указанием источника[31]. Указание источника нужно не для формальности: когда сведения расходятся, только оно позволяет понять, чьё мнение записано и насколько оно проверено.

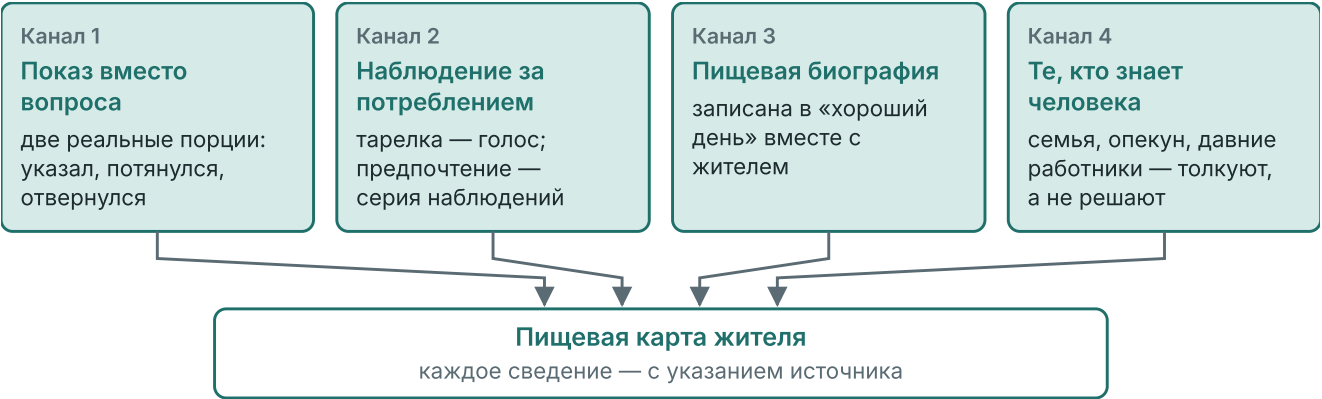
15.4. Иерархия источников при расхождении

Каналы противоречат друг другу регулярно, поэтому порядок их соподчинения нужно закрепить заранее, в локальном акте. В этом разделе предложен следующий порядок:

1. зафиксированная воля самого жителя (пищевая биография, устойчивые предпочтения);
2. текущая демонстрируемая воля (показ, жест);
3. сведения близких;
4. медицинские ограничения по назначению врача — они сужают пункты 1–3 только при реальной клинической необходимости;
5. удобство кухни в иерархию не входит вовсе.

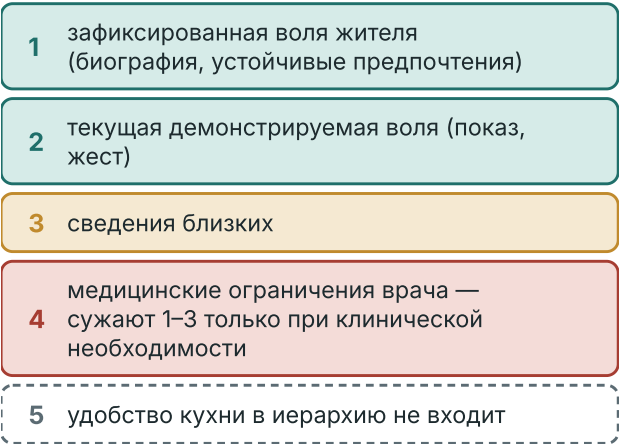
Медицинское ограничение не отменяет выбор, а задаёт множество, внутри которого он совершается. Австрийский стандарт качества питания в домах престарелых требует вовлекать проживающего в решение о диете[51].

Важная оговорка. В разделе 15.9 доклад предлагает другой порядок, в котором первое место занимает текущее выраженное предпочтение, а зафиксированная биография — второе. Это внутреннее противоречие корпуса, и оно не снято (wiki/gaps.md, п. 2). Мы не выбираем «удобную» версию за автора; аргументы обеих сторон изложены в разделе 15.9.

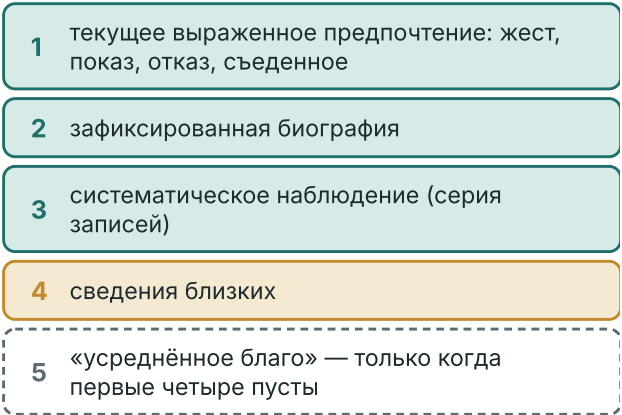


Если каналы расходятся: два порядка в корпусе

Раздел 15.4



Раздел 15.9



Общее у обоих порядков: удобство кухни и «усреднённое благо» — последними; сведения близких не перевешивают данных о самом человеке; медицинское ограничение сужает выбор, но не отменяет его. Какой порядок закрепить — решение локального акта.

Рисунок 10. Четыре канала воли (раздел 15.3) и два порядка источников при расхождении (разделы 15.4 и 15.9). Противоречие между порядками в корпусе не снято; выбор закрепляет локальный акт дома.

15.5. Технология на линии: сценарий для смены

Сценарий показа, построенный по логике российских публичных внедрений вариативного питания в психоневрологических интернатах Новосибирской области[2, 3], выглядит так:

1. На линии стоят два варианта в одинаковых гастрорёмкостях, на виду у жителя.
2. Работник показывает обе порции неговорящему жителю и называет их просто: «гречка — рис».

3. Реакция записывается одним из четырёх значков журнала: указал, потянулся, отвернулся, без реакции.
4. Если реакции нет, человек получает вариант по пищевой карте (зафиксированное предпочтение), а не «первый по очереди».
5. Съеденное фиксируется и уточняет карту.

На одного жителя уходит 15–20 секунд, на отделение — несколько дополнительных минут работы линии. По логике доклада они окупаются снижением числа несъеденных порций; это рабочее предположение, которое дом может проверить собственным замером отходов (приложение 25), а не доказанный эффект.

«Наши не могут выбирать» — самое частое возражение (раздел 37) и одновременно самое проверяемое. Проверка занимает три дня: покажите трём неговорящим жителям две порции и запишите реакцию. Обычно «не может» означает «никогда не спрашивали доступным способом». Там, где большинство жителей признаны недееспособными[7], невербальный выбор и есть вариативность, а не её запасной вариант для меньшинства.

15.6. Что говорят исследования о выборе у людей с тяжёлыми нарушениями

Раздел добавлен во второй редакции, чтобы показать, на чём держится технология 15.5 и где у неё слабые места. Прямых исследований невербального выбора блюд в российских ДСО и ПНИ мы не нашли. Ниже — зарубежные работы о сходных задачах; каждая требует оговорки о переносимости.

Справка. Оценка предпочтений. В прикладном анализе поведения **оценкой предпочтений** (англ. *preference assessment*) называют систематическую процедуру, при которой человеку многократно предъявляют предметы — по одному, парами или наборами — и регистрируют, к чему он тянется, что берёт, что отталкивает. Предпочтение считается установленным не по одному предъявлению, а по устойчивой картине серии. Сценарий раздела 15.5 — упрощённая бытовая версия парного предъявления.

Предпочтения у людей с глубокими множественными нарушениями выявимы, но изменчивы. В американском исследовании учащихся с глубокими множественными нарушениями (Logan и соавт., 2001) адаптированные процедуры — изменённый формат предъявления, другие регистрируемые реакции — позволили выявить больше предпочтений, чем стандартные. Однако авторы подчёркивают, что эффекты предпочитаемых стимулов «были индивидуальными», а данные «вариабельными внутри участников и между ними»[121]. Для дома из этого следуют два правила: способ спрашивать нужно подстраивать под человека, а вывод делать по серии записей, а не по одной реакции. Это дети и подростки, и предъявлялись не блюда, а предметы, поэтому результат служит аналогией, а не доказательством.

Визуальная опора повышает вовлечённость людей с деменцией в решения. В британском исследовании восемнадцати пар «человек с деменцией — член семьи, ухаживающий за ним» обсуждения повседневных тем с помощью визуальной методики Talking Mats (карточки с изображениями, которые человек раскладывает по шкале «нравится — не уверен — не нравится») сравнивали с привычной беседой. По реферату, и люди с деменцией, и их близкие «чувствуют

себя более вовлечёнными в обсуждение того, как они справляются с повседневной жизнью», и были больше удовлетворены его итогом^[122]. Числовых оценок эффекта в реферате нет; выборка мала, участники жили дома, а не в учреждении. Тем не менее это прямой довод в пользу визуального меню (приложение 5) и показа порций.

Предпочтения устойчивы, но не застывают. В американском исследовании 255 проживающих 28 домов ухода повседневные предпочтения опрашивали дважды с интервалом в три месяца. Точное совпадение ответов составило в среднем 59 %, совпадение по признаку «важно — неважно» — 82 %; 68 из 72 предпочтений сохранили стабильность не ниже 70 %^[123]. Отсюда два вывода. Первый: пищевая биография не теряет ценности через квартал — большинство предпочтений сохраняется. Второй: заметная доля ответов меняется, и потому биография требует пересмотра, а текущая реакция человека — внимания. Опрашивались жители, способные отвечать на вопросы; для неговорящих данных такого рода нет.

Персонал систематически недооценивает важность предпочтений. В американской выборке из 16 111 ветеранов, переведённых после госпитализации в учреждения сестринского ухода, оценку предпочтений в 95 % случаев проводили сами жители, в 3 % — их представители, в 2 % — сотрудники. Представители оценивали отдельные предпочтения то выше, то ниже самих жителей, а сотрудники «последовательно реже указывали все предпочтения как важные» по сравнению с жителями^[124]. Это не люди с психическими расстройствами и не российские дома, но направление ошибки показательно: когда за человека отвечает персонал, предпочтения становятся «неважными». Раздел 15.8 разбирает, как этому противостоять.

Вместе эти работы не доказывают, что невербальный выбор улучшает питание или здоровье жителей ПНИ: таких исследований нет (раздел 27). Они показывают другое — что предпочтения у людей с тяжёлыми нарушениями существуют, их можно выявлять подходящим способом, и что опора на мнение персонала вместо наблюдения смещает результат.

15.7. Обучение смены чтению воли: три упражнения

Навык считывать невербальный выбор тренируется, как любой профессиональный навык. Инструктаж смены включает три упражнения.

- **«Молчаливый заказ».** Сотрудники заказывают друг у друга блюдо без слов, а затем проверяют, правильно ли их поняли. Упражнение быстро показывает, как много теряется в «очевидных» жестах.
- **«Перестановка».** Сотрудники на себе проверяют позиционный эффект: меняется ли выбор, если поменять порции местами.
- **«Неделя наблюдения».** Каждый ведёт мини-журнал одного жителя в течение недели и защищает свой вывод перед сменой: что человек предпочитает и на каких записях основан вывод.

Справка. Позиционный эффект. Позиционным эффектом (смещением по стороне) называют склонность выбирать предмет из определённого места — справа, ближе к себе, первым предъявленным — независимо от того, что это за предмет. При парном предъявлении он маскирует истинное предпочтение: человек «всегда выбирает гречку», хотя на деле всегда берёт то, что стоит справа. Простое средство — менять порции местами в разные дни и сравнивать записи.

После такого инструктажа форма наблюдения за невербальным выбором (приложение 6) становится записью того, что смена действительно умеет видеть, а не бумагой для проверки.

15.8. Ошибка «профессионального чтения»

Главный риск этой технологии — уверенность самой смены: «Я его десять лет знаю». Опыт ценен, но непроверяем: знание живёт в голове одного человека и уходит вместе с ним при ротации кадров. Кроме того, исследование раздела 15.6 показывает, что персонал склонен недооценивать важность предпочтений жителей[124], то есть «знаю» нередко означает «привык».

Правило поэтому простое: любое «я знаю» в течение недели переводится в запись — в карту предпочтений или форму наблюдения. Непереведённое знание для системы не существует. Это звучит бюрократично ровно до первой смены кадров. После неё запись оказывается единственным способом не потерять человека вместе с ушедшей сиделкой.

15.9. Иерархия источников воли: кто на каком месте

Каналы противоречат друг другу регулярно. Без заранее объявленной иерархии побеждает тот, кто говорит громче: родственник на свидании, старшая медсестра, администрация. Поэтому доклад предлагает рабочий порядок из пяти уровней. Он отличается от порядка раздела 15.4; в исходной редакции предлагалось записать в положение о питании оба.

1. **Текущее выраженное предпочтение жителя** — жест, показ, отказ, съеденное. Это сильнейший источник, пока он не противоречит назначениям врача.
2. **Зафиксированная биография** (приложение 3). Воля периода ясности сильнее текущих догадок окружающих.
3. **Систематическое наблюдение** — серия записей в форме приложения 6. Оно сильнее единичного впечатления любого сотрудника.
4. **Сведения близких.** Это данные для биографии, но при расхождении они уступают наблюдению: «дома он любил» не перевешивает того, что здесь он два месяца это не ест.
5. **«Усреднённое благо»** («всем полезно») — слабейший источник, к которому обращаются, только когда первые четыре пусты.

С таким порядком спор родственников, смены и администрации о том, «чего он на самом деле хочет», уходит из плоскости мнений: решает не статус спорящего, а уровень источника.

Противоречие с разделом 15.4 и чем его можно взвесить. Порядки двух разделов расходятся в главном: что первично — зафиксированная воля ясного периода или текущая реакция. Это противоречие корпуса (wiki/gaps.md, п. 2), и вторая редакция его не снимает: выбор между

порядками — решение автора и, в конечном счёте, локального акта дома. Для такого решения можно учесть следующее. В пользу первенства текущей реакции говорит то, что предпочтения со временем меняются — в исследовании раздела 15.6 через три месяца точно совпадали в среднем лишь 59 % ответов[123], — и то, что Замечание общего порядка № 1 ставит в центр волю человека «здесь и сейчас»[31]. В пользу первенства биографии говорит то, что большинство предпочтений всё же устойчиво[123], что единичная реакция неговорящего человека изменчива и зависит от способа предъявления[121], и что зафиксированная воля защищает человека от толкований окружающих. Оба порядка сходятся в трёх пунктах: удобство кухни и «усреднённое благо» стоят последними, сведения близких не перевешивают данных о самом человеке, медицинское ограничение сужает выбор, но не отменяет его.

15.10. Культурные и религиозные рамки стола

Каналы раздела 15.3 работают и тогда, когда предпочтение задано не вкусом, а традицией или убеждением: халяль или кашрут, пост, в том числе многодневный, вегетарианство, отказ от определённых продуктов по убеждению. Для пятидесяти одного региона с разным конфессиональным составом это обычная часть контингента, а не экзотика.

Правовая основа для ПНИ здесь прямая, а не только толковательная. Часть 2 статьи 37 Закона № 3185-1 среди прав пациента психиатрического стационара называет право исполнять религиозные обряды и соблюдать религиозные каноны, «в том числе пост», иметь религиозные атрибуты и литературу, если это не нарушает внутренний распорядок; статья 43 распространяет права части 2 статьи 37 на проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами[8]. Статья 39, к которой отсылает часть 2 статьи 43, обязывает организацию установить и разъяснить верующим правила исполнения обрядов с учётом интересов других проживающих и содействовать свободе совести как верующих, так и атеистов[8]. Для жителей ДСО без психиатрического диагноза опорой остаются «индивидуальные потребности» 442-ФЗ[118]; запрета учитывать религиозные ограничения там тоже нет. Человеческое достоинство как общий принцип закреплено частью 2 статьи 5 Закона № 3185-1[8].

Расхождение с прежней редакцией: в первой редакции говорилось, что «русской рамки такого пункта нет». Для ПНИ это неверно: право соблюдать пост прямо названо в законе. Формулировка «если это не нарушает внутренний распорядок» означает, что порядок соблюдения поста определяется правилами учреждения, но не даёт оснований в нём отказать.

Международные нормы идут дальше. Регламент провинции Онтарио требует, чтобы план ухода опирался на междисциплинарную оценку, в которую входят и нутритивный статус, и «культурные, духовные и религиозные предпочтения», а штатный диетолог проводил нутритивную оценку каждого жителя при поступлении и при существенном изменении состояния; персонал за столом должен знать рационы, особые потребности и предпочтения жителей[27].

Практический минимум для дома невелик. В пищевую биографию добавляются два вопроса: «Есть ли пища, которую вы не едите по убеждению или вере?» и «Соблюдаете ли вы посты?». В заказ блюд — строка «ограничения по убеждению». Если таких жителей больше двух-трёх, в цикле

меню держат пару блюд под основные рамки — например, постное горячее как регулярную позицию. Это дешевле индивидуальной готовки и не требует новой строки сметы. Правила исполнения обрядов, которых требует статья 39, для ПНИ удобно включить в то же положение о питании.

Главное различие раздела: религиозное ограничение — волеизъявление того же достоинства, что «не люблю рыбу». Это не медицинская диета и не основание для худшего рациона. Форма фиксации — пищевой паспорт при поступлении (приложение 37), где для этого есть блок «Ограничения по убеждению».

15.11. Постные и религиозные меню-циклы: маркировка «пост — не диета»

Минимальный цикл выглядит так: в периоды многодневных постов (Великий и Рождественский посты, Рамадан) постное горячее подаётся два-три раза в неделю; постные гарниры — ежедневно (крупы и овощи и так есть в раскладке); постные позиции отмечаются в визуальном меню. Действуют три правила.

Первое: пост — волеизъявление, а не назначение. При медицинских показаниях — сахарном диабете, белково-энергетической недостаточности, анемии — постное меню согласуется с врачом, чтобы «постное» не стало «неполноценным». Ограничение по убеждению не отменяет норм питания (приказ Минтруда № 520н)[38]: постный суп на воде без белкового компонента обеда не заменяет. Как сохранить белковую часть постного варианта, решают диетолог или диетсестра по таблицам замен и принципу пар эквивалентов (раздел 19), а не повар по наитию.

Второе: отказ от поста — право жителя в любой день. Рамка раздела 15.10 работает симметрично: давление в пользу поста так же недопустимо, как давление против него. Ни родственник, ни сотрудник, ни священнослужитель не решают за жителя, постится ли он сегодня; решает житель, а если он не говорит — каналы раздела 15.3.

Третье: пост не меняет санитарного контура. Суточные пробы, бракераж, температурный режим остаются теми же (раздел 18).

Формы фиксации — строка «ограничения по убеждению» в заказе (раздел 15.10) и пищевой паспорт (приложение 37).

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-c/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/psk-2026-10-blok-c/istochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; по S011 и l-gc1 в реестре добавлены проверенные формулировки статей 5, 37, 39, 43 Закона № 3185-1 и пунктов 17 и 21 Замечания общего порядка № 1.

Маркер	Источник
M-pref_logan2001	Logan K.R. et al. Preferences and reinforcers for students with profound multiple disabilities: can we identify them? // J Dev Phys Disabil. 2001. DOI: 10.1023/A:1016624923479
M-talkingmats_murphy	Murphy J., Oliver T. The use of Talking Mats to support people with dementia and their carers to make decisions together // Health Soc Care Community. 2013;21(2):171–180

Маркер	Источник
M-pref_abbott	Abbott K.M. et al. The change in nursing home residents' preferences over time // J Am Med Dir Assoc. 2018;19(12):1092–1098
M-proxy_kunicki2023	Kunicki Z.J. et al. Comparing resident, proxy, and staff respondents for nursing home residents' preferences for everyday living // J Appl Gerontol. 2023;42(1):28–36
S060	Гражданский кодекс РФ (часть первая), ст. 29, 30, 35, 36
S061	Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст. 11, 15

16

Дееспособность, опека и выбор еды: карта решений

Тема семинара — права, свободы и интересы жителей. В питании они упираются в вопрос, который редко ставят прямо: кто вправе решать, что ест житель, признанный недееспособным, — и вправе ли вообще кто-то, кроме него самого? Эта глава отвечает на него в форме карты: двенадцать вопросов, и у каждого ответа указан уровень опоры — прямая норма, системное толкование или открытый вопрос. Маркировку мы держим строго, потому что именно здесь директору опаснее всего опереться на красивую, но не подкреплённую законом формулу. Технология выявления воли тех, кто не говорит, изложена в разделе 15; российское право питания в целом — в разделе 17. Здесь — правовой статус человека и то, как он влияет на стол.

Справка. Дееспособность и её режимы. Дееспособность — способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их; в полном объёме она возникает с совершеннолетием. Её не следует путать с правоспособностью — способностью иметь права, которая принадлежит каждому от рождения и не может быть отнята. Гражданский кодекс знает два режима, связанных с психическим расстройством. **Недееспособность** (ст. 29 ГК) устанавливается судом, если человек вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими; над ним устанавливается **опека**, и сделки от его имени совершает **опекун**. **Ограничение дееспособности вследствие психического расстройства** (п. 2 ст. 30 ГК) устанавливается, если человек может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц; над ним устанавливается **попечительство**, и часть сделок он совершает сам, а остальные — с письменного согласия **попечителя**. Ни один из этих режимов не является диагнозом и не описывает, способен ли человек выбрать между гречкой и рисом.

16.1. Постановка вопроса

Вопрос «кто решает, что он ест?» в доме социального обслуживания обычно решается молча: решает тот, кто раскладывает. Карта этой главы делает решение явным. Она нужна по двум причинам. Первая — защита жителя: недееспособность легко превращается в предлог не спрашивать. Вторая — защита директора: при проверке или жалобе ему придётся объяснить, на каком основании дом учитывал или не учитывал мнение жителя, и ответ «так принято» будет худшим из возможных.

16.2. Нормативная основа

Российская рамка держится на трёх федеральных столпах и одном международном ориентире.

Гражданский кодекс РФ. Признание гражданина недееспособным (п. 1 ст. 29) означает, что сделки от его имени совершает опекун (п. 2 ст. 29). Важнейшая для нашей темы деталь содержится в той же норме: опекун совершает сделки, «учитывая мнение такого гражданина», а при невозможности установить мнение — с учётом информации о его предпочтениях, полученной от родителей, прежних опекунов и иных лиц, добросовестно оказывавших ему услуги^[116]. Шире эта обязанность сформулирована в пункте 3 статьи 36 ГК: опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы и исполняют эти обязанности, учитывая мнение подопечного, а при невозможности его установить — сведения о его предпочтениях из тех же источников^[116]. Для подопечных с психическими расстройствами та же норма добавляет обязанность заботиться о развитии (восстановлении) способности понимать значение своих действий или руководить ими^[116]. Опекa как правоотношение оформляется по статьям 31–32 ГК.

Мелкие бытовые сделки без согласия попечителя вправе совершать **ограниченно дееспособные** граждане (п. 1 ст. 30; при ограничении дееспособности вследствие психического расстройства — п. 2 ст. 30 со ссылкой на подп. 1 п. 2 ст. 26), а не недееспособные; смешивать эти режимы нельзя. Однако повседневное пищевое предпочтение — выбор блюда на раздаче — обычно вообще не является гражданско-правовой сделкой: это элемент ухода и права на достоинство. Поэтому недееспособность не снимает обязанности выяснять и учитывать мнение человека о еде.

Федеральный закон № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Закон определяет порядок назначения опекунов и их статус: опекун — законный представитель подопечного, вправе выступать в защиту его прав и интересов в любых отношениях без специальной доверенности (ч. 2 ст. 15); права и обязанности опекунов в остальном определяются гражданским законодательством (ч. 1 ст. 15)^[117]. Для ПНИ ключевая норма — часть 5 статьи 11: недееспособным или не полностью дееспособным лицам, помещённым под надзор в образовательные, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, опекуны или попечители не назначаются, а исполнение их обязанностей возлагается на эти организации^[117]. Ту же конструкцию воспроизводит пункт 4 статьи 35 ГК^[116]. Именно отсюда происходит массовая ситуация «учреждение = опекун» (раздел 16.4).

Уточнение второй редакции: в первой редакции обязанность опекуна учитывать мнение подопечного выводилась «из ст. 29 ГК и 48-ФЗ». При сверке оказалось, что в 48-ФЗ отдельной нормы об учёте мнения нет: закон отсылает к гражданскому законодательству, а сама обязанность сформулирована в п. 2 ст. 29 (для сделок) и п. 3 ст. 36 ГК (для опеки в целом). Смысл прежнего тезиса от этого не меняется, но точная ссылка — ГК.

Закон РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Часть 2 статьи 5 закрепляет право лиц с психическими расстройствами на уважительное и гуманное отношение, исключаящее унижение человеческого достоинства^[8]. Статья 37 содержит перечень прав пациентов психиатрического стационара: обращаться к главному врачу, подавать жалобы без цензуры, конфиденциально общаться с родственниками, законным представителем, адвокатом, священнослужителем, исполнять религиозные обряды и соблюдать посты и другие^[8]. Статья 43 в действующей редакции (Федеральный закон от 04.08.2023 № 465-ФЗ) устроена так:

- часть 1 распространяет на проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами права, предусмотренные частями 2 и 4 статьи 37;
- часть 2 устанавливает, что обязанности организации по созданию условий для реализации этих прав определяются статьёй 39 закона и законодательством о социальном обслуживании; статья 39, в частности, обязывает исполнять обязанности опекуна, если они возложены на организацию законодательством, и контролировать содержание посылок и передач;
- часть 3 обязывает организацию не реже одного раза в год проводить освидетельствование проживающих врачебной комиссией с участием врача-психиатра для решения вопроса об их дальнейшем содержании в организации, а также о возможности пересмотра решений об их недееспособности или ограничении дееспособности[8].

Статья 43 задаёт **статус** проживающих, а не норму «опекун учитывает мнение»: последняя, как сказано выше, — из Гражданского кодекса.

Расхождение с прежней редакцией: в первой редакции к статье 37 были отнесены «гуманное отношение и достоинство». В действующем тексте эти слова находятся в части 2 статьи 5; статья 37 — перечень конкретных прав. Кроме того, в первой редакции целью ежегодного освидетельствования по ст. 43 называлось решение о переводе в организацию общего типа; действующий текст говорит о дальнейшем содержании в организации и о возможности пересмотра решений о недееспособности. Для темы главы второе важнее первого: закон сам связывает ежегодное освидетельствование с пересмотром дееспособности (раздел 16.10).

Федеральный закон № 442-ФЗ. Он закрепляет права получателя социальных услуг (ст. 9), индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ, ст. 16) и учёт индивидуальных потребностей[118].

Международный ориентир. Конвенция о правах инвалидов ратифицирована Россией в 2012 году (раздел 17.7). Комитет ООН по правам инвалидов в заключительных замечаниях по первоначальному докладу Российской Федерации (2018) выразил обеспокоенность тем, что Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы сохраняют концепцию замещающего принятия решений при отсутствии механизмов поддержки, и рекомендовал ввести концепцию поддерживаемого принятия решений (пп. 26–27)[125]. Это рекомендация договорного органа, а не норма российского права: она показывает направление, но не создаёт обязанностей для кухни.

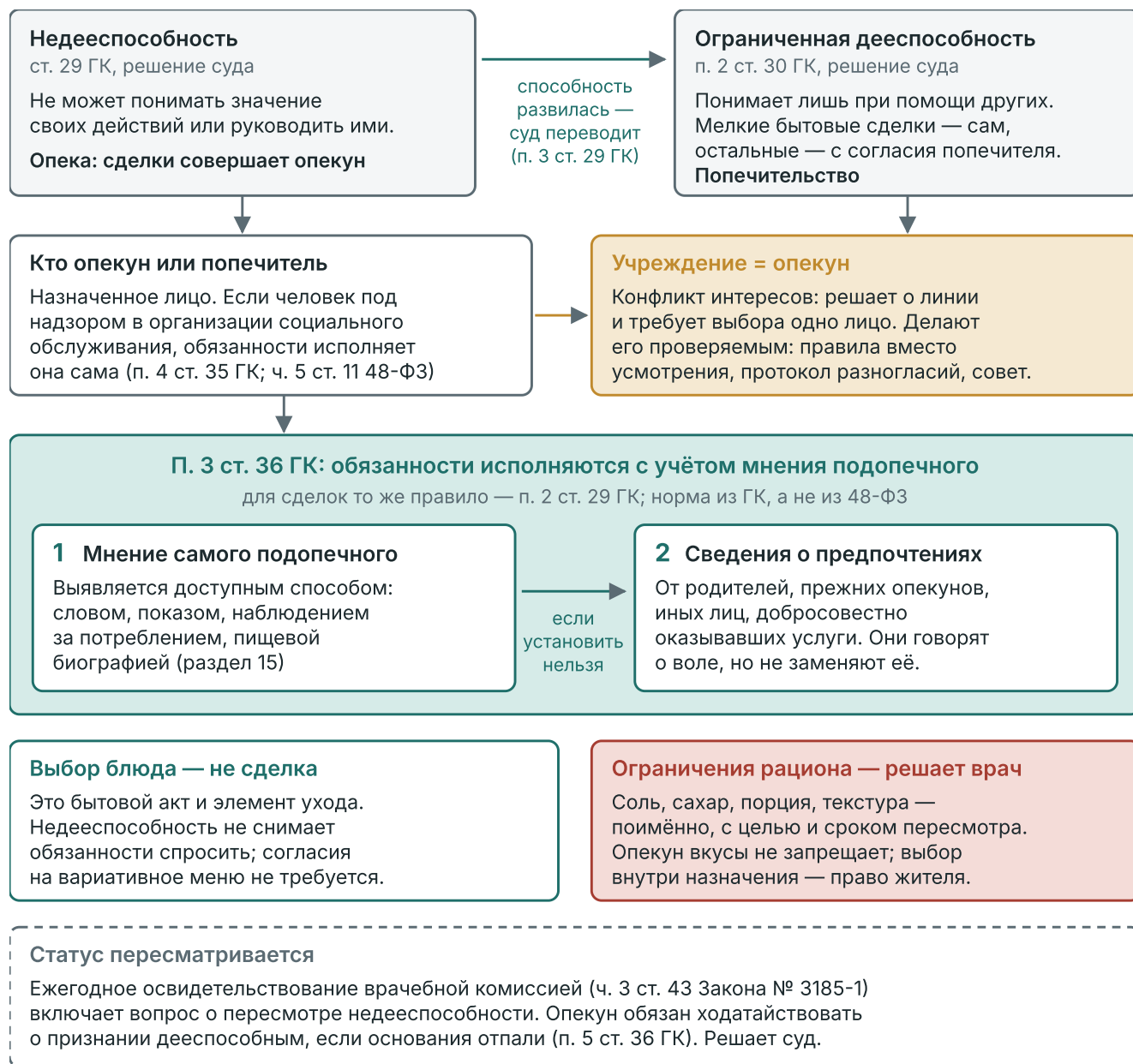


Рисунок 11. Кто решает, что ест подопечный: режимы дееспособности, опекун и обязанность учитывать мнение (п. 3 ст. 36 ГК), раздел 16.2[8, 116, 117]

16.3. Карта решений: двенадцать вопросов

№	Вопрос	Ответ	Уровень
1	Отменяет ли недееспособность бытовые предпочтения?	Нет. Недееспособность касается сделок, а не вкусов	Прямое следствие ст. 29 ГК; ст. 37/43 3185-1 — статус проживающих
2	Является ли выбор блюда «сделкой», требующей дееспособности?	Нет, это бытовой акт	Системное толкование
3	Обязано ли учреждение учитывать мнение жителя, признанного судом недееспособным?	Да, при решении вопросов, затрагивающих его интересы; если учреждение исполняет обязанности опекуна — тем более	Норма (п. 2 ст. 29, п. 3 ст. 36 ГК; ч. 5 ст. 11 48-ФЗ); не ст. 43 3185-1
4	Может ли опекун «запретить» жителю конкретное блюдо?	Только в рамках медицинских назначений; вкусы — не компетенция опекуна	Системное толкование

№	Вопрос	Ответ	Уровень
5	Что делать, если учреждение само — опекун жителя?	Конфликт интересов фиксируется; решения о питании принимаются по прозрачным правилам, а не «усмотрением опекуна»	Открытый вопрос + управленческая рекомендация
6	Нужно ли согласие недееспособного на вариативное меню?	Не требуется: вариативность не ограничивает права, а расширяет возможность выбора	Системное толкование
7	Как быть с отказом недееспособного от еды?	Без насилия: наблюдение, альтернатива, эскалация врачу (раздел 12)	Норма (ч. 2 ст. 5 3185-1) + алгоритм
8	Может ли семья диктовать меню?	Её сведения учитываются как источник знания о воле, но не заменяют её	Толкование (Замечание общего порядка № 1 как ориентир ^[31] ; п. 2 ст. 29 ГК называет близких источником сведений о предпочтениях)
9	Кто решает об ограничениях рациона (соль, сахар, порции)?	Только врач, поимённо, с целью и сроком пересмотра	Системное толкование + международная практика ^[51]
10	Куда вписываются пищевые решения юридически?	В ИППСУ (потребности) и локальные акты (порядок)	Норма (442-ФЗ)
11	Проверяет ли кто-то, учитывается ли мнение жителя?	Прямой проверки «учёта мнения о еде» нет; косвенно — ежегодное освидетельствование по ст. 43, контроль учредителя, прокуратура по жалобам	Норма (3185-1) + толкование
12	Что если житель недееспособен, но его состояние улучшилось?	Вопрос о дееспособности решает суд; опекун обязан ходатайствовать о признании подопечного дееспособным, если основания отпали; до решения — поддержанный выбор в максимальном объёме	Норма (п. 3 ст. 29, п. 5 ст. 36 ГК; ч. 3 ст. 43 3185-1) + практика

Изменения по сравнению с первой редакцией: в строке 7 основание исправлено со «ст. 37» на ч. 2 ст. 5 Закона № 3185-1 (запрет насилия вытекает из права на гуманное отношение; см. также раздел 12.4). В строке 3 добавлены точные нормы ГК и 48-ФЗ. В строке 11 уточнено, что освидетельствование по ст. 43 посвящено дальнейшему содержанию и пересмотру дееспособности, а не учёту мнения о питании, поэтому как контроль оно работает лишь косвенно. В строку 12 добавлена прямая обязанность опекуна (п. 5 ст. 36 ГК).

16.4. Конфликт интересов «учреждение = опекун»: честный разбор

Ситуация массовая и имеет прямое законное основание: если опекун человеку, помещённому под надзор в организацию социального обслуживания, не назначен, обязанности опекуна исполняет сама организация (п. 4 ст. 35 ГК, ч. 5 ст. 11 48-ФЗ)^[116, 117]. Структурный конфликт очевиден. Опекун обязан защищать интересы подопечного и учитывать его мнение (п. 3 ст. 36 ГК), и одновременно он — организация, чьи ресурсы и удобство этими интересами ограничиваются. Тот, кто решает, сколько вариантов на линии, и тот, кто должен потребовать для подопечного выбора, — одно лицо.

Прямого запрета на такое совмещение закон не содержит, но и прямого разрешения игнорировать конфликт тоже нет. Меры, снижающие риск (класс — рекомендация, а не норма):

- 1. Прозрачные правила вместо усмотрения.** Решения о питании закрепляются в положении о питании, триггерах и правилах добавки, одинаковых для всех жителей. Усмотрение заменяется процедурой.

2. **Совет жителей и независимый канал обращений** (раздел 34) дают внешний взгляд на решения «опекуна-учреждения».
3. **Ежегодное освидетельствование по ст. 43** используется по назначению — не как формальность, а как внешняя оценка положения человека, включая вопрос о пересмотре его дееспособности[8].
4. **Спорные случаи — учредителю письменно.** Молчаливое усмотрение хуже зафиксированного решения.

16.5. Практическая формула для локального акта

Формулировка для положения о питании (проект):

«При организации питания учитываются мнение и предпочтения получателей социальных услуг, в том числе признанных недееспособными, выявленные доступным способом (словом, показом, наблюдением за потреблением, пищевой биографией, сведениями близких). Ограничения рациона вводятся только по назначению врача поимённо с указанием цели и срока пересмотра. Лишение пищи или питья как мера воздействия не допускается».

Каждая фраза опирается на разделы 16.2–16.4, и ни одна не выходит за пределы действующего права. Первая фраза повторяет логику п. 2 ст. 29 и п. 3 ст. 36 ГК, перенесённую на бытовые решения; вторая — разделение компетенций кухни и врача (раздел 17.3); третья — ч. 2 ст. 5 Закона № 3185-1 (раздел 17.4).

16.6. Что сказать повару в понедельник

Выбор еды не требует дееспособности. Опекун — в том числе само учреждение — обязан учитывать мнение подопечного, а если его нельзя установить, сведения о его предпочтениях (ст. 29 и 36 ГК). Риски создают не выбор, а непрозрачные решения «по усмотрению», конфликт интересов опекуна-учреждения и отсутствие документов. Всё это закрывается локальными актами.

16.7. Разбор трёх коллизий из зала

«Родственник против опекуна-учреждения». Родственник настаивает на одном меню, учреждение — на своём, житель молчит. Иерархия раздела 15.9 ставит биографию и наблюдение выше обеих сторон: спор решает не статус спорящих, а данные о самом жителе. (Порядок раздела 15.4 приводит к тому же результату — сведения близких и удобство учреждения в обоих порядках уступают данным о человеке; расхождение двух порядков касается другого вопроса и разобрано в разделе 15.9.)

«Врач запретил, житель требует». Назначение врача задаёт рамку, выбор внутри рамки — право жителя. Конфликт возвращается врачу с конкретикой и не решается сменой (кейс 2).

«Раньше выбирал, теперь нет». Снижение способности к выбору — клинический сигнал: депрессия, прогрессирование заболевания, седация после смены лекарственной схемы. О нём сообщают врачу. Рассуждение «перестал выбирать — значит, не хочет» — диагностическая

ошибка.

Каждая коллизия возвращается к источникам воли и к врачу — и никогда к авторитету должности.

16.8. Учреждение = опекун: три антидота в документах

К конфликту раздела 16.4 добавим масштаб. По вторичной аналитике проекта «Если быть точным», до 74 % жителей ПНИ признаны недееспособными, и опекуном нередко выступает само учреждение[7]; статус этих данных — вторичная аналитика, а не официальная статистика. Против конфликта работают три документальных приёма.

Первый — **приоритет зафиксированных предпочтений над административным удобством**, записанный в положении о питании (приложение 29). После этого конфликт становится видимым: каждое отступление от предпочтения требует объяснения.

Второй — **протокол разногласий**: если предпочтение жителя не исполнено, письменно указывается причина (санитарное требование, назначение врача, нехватка ресурса).

Третий — **внешний элемент**: совет жителей с участием независимых представителей, близких, общественных наблюдателей (раздел 34).

Ни один приём не устраняет конфликт; все три делают его проверяемым. Большого локальный уровень дать не может, и это честная граница раздела: устранить конфликт можно только изменением законодательства об опеке, к чему призывает, в частности, Комитет ООН по правам инвалидов[125].

16.9. Карта двенадцати вопросов: как ею пользоваться

Карта исходит из того, что **способность выбрать, дееспособность и диагноз — три разные вещи**. Поэтому её применяют не к «жителю вообще», а к конкретному решению сегодня. Двенадцать вопросов сводятся к трём блокам:

- **информирован** ли человек о варианте — показали ли ему выбор, в доступном ли формате, в подходящее ли время;
- **понимает** ли он последствия в доступной ему мере — проверяется переспросом, а не допросом;
- **может ли сообщить** выбор хотя бы одним каналом (раздел 15).

По ответам житель на сегодня попадает в одну из четырёх рабочих категорий: выбирает сам; выбирает с поддержкой формата; выбор считывается наблюдением; выбор недоступен — действует стандартный вариант с пересмотром. Категория не присваивается навсегда. Её пересматривают при изменении состояния, при смене терапии, а для группы «выбор недоступен» — не реже раза в квартал.

Именно динамичность отличает поддерживаемое принятие решений от опеки[31]: опека фиксирует неспособность, поддержка ищет формат, при котором способность проявляется. Честно скажем о пределах доказательной базы. Систематический обзор 140 работ о вмешательствах, расширяющих участие пользователей психиатрических служб в планировании

помощи (2008 — октябрь 2023), заключил, что исследования в этой области «остаются поисковыми: изучено множество вмешательств, но экспериментальных повторений мало»; главными барьерами названы организационные (ресурсы, культура, приоритет управления рисками), процессные (нехватка знаний и времени) и отношенческие (страх и недоверие с обеих сторон)[126]. Обзор касался медицинских служб, а не домов социального обслуживания, и не выбора еды. Но перечень барьеров легко узнать в любом ПНИ, и он объясняет, почему поддержка выбора держится на процедурах и записях, а не на доброй воле.

16.10. Ограничение дееспособности вследствие психического расстройства: недоиспользованный режим

Со 2 марта 2015 года (дата по корпусу[127]; в ходе поиска 2026-10 не перепроверялась) Гражданский кодекс содержит отдельный режим — ограничение дееспособности гражданина, который «вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц» (п. 2 ст. 30)[116, 127]. В отличие от полной недееспособности (ст. 29), такой гражданин самостоятельно совершает сделки, предусмотренные подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи 26 (мелкие бытовые сделки и распоряжение предоставленными средствами), а остальные — с письменного согласия попечителя (п. 2 ст. 30).

Для ПНИ это развилка. Значительная часть жителей, признанных недееспособными, по клинической картине может подпадать под п. 2 ст. 30, и переход от ст. 29 к п. 2 ст. 30 расширяет бытовую автономию, включая выбор еды, не лишая человека защиты. Механизм перехода закреплён в законе: при развитии способности гражданина, признанного недееспособным, суд признаёт его ограниченно дееспособным по п. 2 ст. 30 (п. 3 ст. 29 ГК)[116]. Решение принимается по заявлению, через суд и с психиатрической экспертизой. Закон не оставляет этот вопрос на волю случая: опекун обязан заботиться о развитии (восстановлении) способности подопечного и ходатайствовать перед судом о признании его дееспособным, если основания отпали (пп. 3 и 5 ст. 36 ГК)[116], а ежегодное освидетельствование по ч. 3 ст. 43 Закона № 3185-1 прямо включает вопрос о возможности пересмотра решения о недееспособности[8]. Если опекун — само учреждение (раздел 16.4), эти обязанности лежат на нём.

Практика при этом узкая. Суды осторожны, а правовая литература отмечает, что судебная практика по учёту мнения и предпочтений подопечных не сложилась, суды подходят к этим положениям формально, а сами критерии «мнения» и «предпочтений» вызывают больше вопросов, чем ответов[127].

Уточнение второй редакции: в первой редакции этот источник цитировался как отмечающий «невостребованность» режима. При повторном чтении статьи (по сводке её содержания) прямого тезиса о невостребованности не найдено; найдены тезисы о несложившейся практике и размытости критериев. Формулировка исправлена.

Доклад не призывает к кампании пересмотра — это дело суда и экспертизы. Практический вывод скромнее. В документах жителя фиксируется не только статус, но и его основание: ст. 29 или п. 2 ст. 30. От основания зависит объём бытовых решений, которые учреждение обязано уважать и обслуживать. В первой редакции местом фиксации названа «карта дееспособности жителя (приложение 37)»; однако приложение 37 — это пищевой паспорт при поступлении, и строки о

правовом статусе в нём нет. До доработки формы основание статуса разумно вносить в пищевой паспорт отдельной строкой с ограниченным доступом (персональные данные — раздел 17.6), а дату ближайшего освидетельствования по ст. 43 — рядом.

16.11. Чего мы пока не знаем

- Нет публичной статистики о том, сколько жителей российских ПНИ ограничены в дееспособности по п. 2 ст. 30, а не признаны недееспособными по ст. 29, и как часто ежегодное освидетельствование приводит к пересмотру.
- Неизвестно, как суды оценивают учёт мнения подопечного в бытовых вопросах, не связанных со сделками; судебной практики «о выборе еды» нет (раздел 33).
- Исследований поддерживаемого принятия решений именно в российских домах социального обслуживания мы не нашли; зарубежная база, по оценке обзора 2024 года, остаётся поисковой^[126].

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре <raw/sources/poisk-2026-10-blok-c/istochniki.md>. Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; по S011 и S024 в реестре добавлены результаты повторной сверки.

Маркер	Источник
S060	Гражданский кодекс РФ (часть первая), ст. 29, 30, 35, 36
S061	Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст. 11, 15
I-crpd_rus_co2018	Комитет ООН по правам инвалидов. Заключительные замечания по первоначальному докладу Российской Федерации. CRPD/C/RUS/CO/1, 09.04.2018
M-sdm_francis2024	Francis C.J., Johnson A., Wilson R.L. Supported decision-making interventions in mental healthcare: a systematic review of current evidence and implementation barriers // Health Expect. 2024;27(2). DOI: 10.1111/hex.14001

17

Право Российской Федерации: что разрешено, что требуется, что опасно

Дата актуальности правового раздела: 19–21.08.2026. Раздел описывает право на дату семинара 25–27.08.2026. С 01.09.2026 действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26, и переходного периода постановление о его введении не предусматривает: с первого сентября новые правила применяются в полном объёме. Сентябрьская проверка оценивает августовские документы по правилам, действовавшим в августе, а сентябрьские — по новым (раздел 18.10, приложение 39). Изменения норм после 21.08.2026 в разделе не отражены; при использовании после этой даты сверяйтесь с разделами 41 и 44. Отдельные реквизиты, добавленные во второй редакции, сверены 09.10.2026 по тексту актов на consultant.ru и по указанным в реестре источникам; такие места отмечены новыми маркерами.

Эта глава отвечает на вопрос, который директор слышит первым, едва речь заходит о выборе блюд: «А нам можно?» Ответ складывается не из одной статьи, а из нескольких слоёв права, которые написаны разными ведомствами, для разных адресатов и с разной обязательностью. Санитарные правила обязательны всегда, но говорят о безопасности, а не о разнообразии. Законы о социальном обслуживании и о психиатрической помощи говорят о достоинстве и правах, но не о каше. Рекомендуемые нормы питания задают рамку рациона, но остаются рекомендуемыми, пока регион не придаст им силу. Задача главы — разложить эти слои так, чтобы директор видел, где закон прямо поддерживает вариативное меню, где требует процедуры и где проходит граница, которую нельзя переступить ни при каких намерениях.

Справка. Норма, толкование, рекомендация. В докладе каждое правовое утверждение имеет класс (подробно — раздел 41). **Норма** — прямой текст действующего акта, обязательного для адресата. **Толкование** — вывод из сопоставления нескольких норм, который разумен, но может быть оспорен проверяющим или судом. **Рекомендация** — совет, основанный на практике или зарубежном опыте; обязательной силы у него нет. Ошибка, которая чаще всего вредит дому, — принять толкование за норму: тогда либо запрещают то, что разрешено, либо требуют того, чего закон не требует.

17.1. Логика раздела

Право в этой главе разложено на три зоны. **Зелёная** — то, что разрешено или прямо требуется. **Жёлтая** — то, что делать можно, но только через документ, согласование или назначение врача. **Красная** — то, что является нарушением независимо от намерений, даже самых добрых. Каждый элемент снабжён уровнем: норма, толкование или рекомендация.

Для тех, у кого мало времени, предлагается навигатор. Зелёная зона изложена в разделе 17.2 (около пяти минут чтения), жёлтая — в 17.3 (около десяти), красная — в 17.4 (около пяти). «Серой зоне» лечебного питания посвящены разделы 17.5 и 17.10; их стоит читать вместе, потому что это две стороны одной конструкции (около десяти минут). Пищевые карты и закон о персональных

данных разобраны в 17.6, Конвенция о правах инвалидов — в 17.7 и 17.9. Раздел 17.11 даёт три вопроса, которые можно задать любому акту (около пяти минут). Раздел 17.12 — указатель к модераторскому блоку 26.08, 17.13 — пересечения со смежными площадками семинара, чтобы не отвечать за чужой зал. Наконец, 17.14 сравнивает правовое положение ПНИ и ДСО.

Зелёная зона разрешено или прямо требуется	Жёлтая зона можно — через документ	Красная зона нарушение при любом намерении
СанПиН 2.3/2.4.4282-26 п. 56 подп. 11: питание не реже трёх раз в день, диетическое — по показаниям. Число блюд не ограничено	Назначение врача Ограничение рациона, текстура: поимённо, с целью и сроком пересмотра. Решает врач	3185-1, ч. 2 ст. 5; КПИ ст. 25 «f» Лишение еды или питья как мера воздействия
442-ФЗ, ст. 9 и 16 Права получателя услуг; ИППСУ для поставщика обязательна	Локальный акт Положение о питании, совет жителей, вариативное меню, уведомление учредителя	Насилие при кормлении Кормить силой нельзя; питание против воли — только медицинское вмешательство по решению врача
3185-1, ч. 2 ст. 5 и ст. 43 Гуманное отношение без унижения достоинства; в ПНИ — право соблюдать пост	152-ФЗ, ст. 10 Пищевые карты: основание обработки сведений о здоровье, ограниченный доступ	КоАП, ст. 6.6 Пробы задним числом, журналы по памяти, недоброкачественные продукты
ГК, п. 3 ст. 36 Опекун учитывает мнение подопечного (раздел 16)	44-ФЗ Изменение контракта на продукты — только в пределах закона и с оформлением (раздел 30)	УК, ст. 178 Картельные и согласованные закупки (раздел 30)
Приказ № 520н, таблицы замен Рамка рациона и эквивалентная замена — основа пар блюд		Отказ «за опоздание» Как система нарушает питание не реже трёх раз в день (толкование)
Серая зона: приказы Минздрава о лечебном питании адресованы медицинским организациям; на дом — только через региональный «мост» (разделы 17.5, 17.10)		
Число блюд в красную зону не входит Три вопроса к любому акту: кому он адресован? каков статус требования? что доказывает бумага? (раздел 17.11)		

Рисунок 12. Карта норм: что разрешено прямо, что — через процедуру, что запрещено независимо от намерений; число блюд в красную зону не входит (разделы 17.2–17.4)[8, 9, 10, 118]

17.2. Зелёная зона: прямые разрешения и требования

Зелёная зона шире, чем принято думать. В ней нет нормы «каждый день два вторых», но есть всё необходимое, чтобы такую практику построить законно.

1. Питание не реже трёх раз в день и диетическое питание по показаниям. Это прямая санитарная норма для организаций социального обслуживания. На дату семинара (25–27.08.2026) действовал СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32. Его раздел VII («Особые требования к организации питания отдельных категорий взрослого населения») содержит пункты 7.1.11–7.1.14. Пункт 7.1.11 требует организовать в стационарных организациях социального обслуживания питание

проживающих «лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» не менее трёх раз в день, в том числе диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям. Пункт 7.1.12 при получении готовых блюд от предприятия общественного питания требует выделить помещение для приёма пищевой продукции и отбора суточных проб; пробы отбирает ответственный работник пищеблока. Пункт 7.1.13 запрещает выдавать неправильно приготовленное или недоготовленное блюдо до устранения недостатков и требует записывать результат бракеража и причины запрета в журнал. Пункт 7.1.14 распространяет эти требования на предприятия общественного питания, которые кормят проживающих[128]. Само постановление № 32 устанавливало срок действия правил с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года[128], однако с 01.09.2026, на четыре месяца раньше этого срока, их сменил СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18)[129]. Требования к стационарным организациям социального обслуживания перенесены в его пункт 56, подпункты 11–14: питание проживающих организуется не менее трёх раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям[9]. Ни одна из двух редакций не ограничивает число вариантов блюд: обе говорят о безопасности и периодичности, а не о единообразии.

2. Права получателя социальных услуг и индивидуальная программа. Статья 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» перечисляет права получателя. Для темы питания важны четыре из них: уважительное и гуманное отношение; участие в составлении индивидуальной программы; обеспечение условий пребывания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, и надлежащий уход; отказ от социальных услуг[118]. Слова «индивидуальные потребности» в статье 9 нет; учёт потребностей проходит через индивидуальную программу предоставления социальных услуг (статья 16). Эта программа, по части 3 статьи 16, для получателя носит рекомендательный характер, а для поставщика — обязательный; пересматривается она по мере изменения потребности, но не реже раза в три года[118]. Отсюда практический вывод: пищевые предпочтения и доступный выбор можно и нужно включать в ИППСУ, и тогда для дома они перестают быть доброй волей. Прямого же субъективного права на ежедневный выбор блюда из нескольких вариантов закон не устанавливает.

Справка. ИППСУ и субъективное право. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) — документ, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объём, периодичность, условия и сроки услуг (ч. 1 ст. 16 442-ФЗ). **Субъективное право** — возможность конкретного человека требовать определённого поведения от обязанного лица, в том числе через суд. Когда говорят, что «права на два варианта нет», имеют в виду именно это: житель не может потребовать второй вариант, сославшись на закон. Но если выбор записан в ИППСУ, у дома появляется обязанность исполнить программу, а у жителя — основание требовать её исполнения.

3. Права проживающих в учреждениях для лиц с психическими расстройствами. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» в части 2 статьи 5 устанавливает, что все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право на «уважительное и гуманное отношение, исключаящее унижение человеческого достоинства». Статья 37 перечисляет права пациентов психиатрического стационара. Статья 43 распространяет на лиц, проживающих в стационарных

организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц с психическими расстройствами, права, предусмотренные частями 2 и 4 статьи 37[8]. Уточнение «частями 2 и 4» существенно: речь не обо всей статье 37, а о перечне прав (часть 2) и о порядке оплаты дополнительных услуг (часть 4). Для стола в этом перечне есть прямая норма: пациент, а значит и житель ПНИ, вправе «исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в том числе пост»[8]. Постный стол в ПНИ, таким образом, не любезность кухни, а исполнение закона. Часть 3 статьи 43 возлагает на организацию обязанность не реже раза в год проводить освидетельствование проживающих врачебной комиссией с участием психиатра[8].

4. Рекомендуемые нормы питания Минтруда. Приказ Минтруда России № 520н и региональные нормы, принятые на его основе, составляют базовую рамку рационов[11, 12, 38]. Ключевое слово здесь — «рекомендуемые»: регион их конкретизирует и может сделать обязательными для своих учреждений (раздел 24).

5. Таблицы замены продуктов. Таблицы замены в региональных нормах и раскладках — действующий механизм эквивалентной замены и тем самым легальная основа вариативности[11, 12]. Как из них собираются пары блюд, описано в разделе 19.2.

6. Питание как социальная услуга. Примерный перечень социальных услуг по видам, утверждённый постановлением Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236, относит к социально-бытовым услугам в стационарной и полустационарной форме «обеспечение питанием в соответствии с утверждёнными нормативами», а ко всем формам обслуживания — «помощь в приёме пищи (кормление)»[130]. Это важно для двух выводов. Во-первых, помощь в еде — услуга, а не милость, и её объём определяется программой человека. Во-вторых, «утверждённые нормативы» — это нормы питания, а не меню: они задают, сколько и чего человек должен получить, но не запрещают предложить это в двух формах.

7. Выбор блюд жителями. Ни одна федеральная норма выбор блюд не запрещает. В 2024–2025 годах он публично реализован как минимум в четырёх учреждениях трёх регионов[2, 3, 4, 5, 6]; подробнее о практиках — раздел 25.

8. Плата за стационарное обслуживание. Часть 4 статьи 32 442-ФЗ ограничивает ежемесячную плату за стационарное социальное обслуживание: она рассчитывается на основе тарифов, но «не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг»[118, 131]. Эта граница определяет рамку финансовых моделей, о которых идёт речь в разделе 29. Правовой обзор НПА 2026 года связывает ту же границу с пунктом 35 приказа № 935н; две ссылки не следует молча отождествлять (wiki/gaps.md, страница 442-ФЗ).

Вывод зелёной зоны таков: закон требует кормить достаточно, безопасно и с уважением; он не требует кормить одинаково. Всё, что делает вариативное меню, укладывается в эту рамку, если оно остаётся внутри норм питания и санитарного контура.

17.3. Жёлтая зона: делать можно — через процедуру

Жёлтая зона — это действия, которые закон не запрещает, но которые становятся законными только тогда, когда за ними стоит документ: назначение врача, локальный акт, основание обработки данных. Без документа то же самое действие легко превращается из заботы в

нарушение.

Действие	Процедура	Основание
Ограничение рациона жителя (сахар, соль, размер порции)	Назначение врача поимённо, с целью и сроком пересмотра	Толкование и международная практика[51]
Изменение текстуры (протёртое, загущённое)	Назначение врача, маркировка порций	Клиническая необходимость (раздел 10)
Изменение цикла меню	Увязка с региональной раскладкой и таблицами замен	[11, 12]
Пищевые карты жителей (персональные данные)	Основание обработки по ст. 10 152-ФЗ, ограничение доступа	152-ФЗ (раздел 17.6)[132]
Отложенные приёмы пищи, ночная доступность еды	Пункт в положении о питании и санитарный контур хранения	[9]
Совет жителей с полномочиями по меню	Локальный акт о совете	Практика и международные нормы[27]
Вариативное меню	Пакет документов (раздел 31) и уведомление учредителя	Рекомендация на основе практики[2, 3]

Общее у всех строк одно: ограничение или особенность, которая касается конкретного человека, должна иметь автора, основание и срок. Ограничение без назначения — это не диета, а произвол, пусть и доброжелательный. Изменение для всех без локального акта — это не реформа, а импровизация, которую следующий директор или проверяющий вправе не признать.

17.4. Красная зона: нарушения независимо от намерений

Красная зона короче зелёной, но её границы жёстче. Здесь не помогают ни добрые намерения, ни ссылка на нехватку персонала.

1. Лишение еды или питья как мера воздействия. Это прямое нарушение части 2 статьи 5 Закона № 3185-1, гарантирующей гуманное отношение, исключаящее унижение достоинства; статья 43 распространяет на проживающих ПНИ права, перечисленные в статье 37[8]. Для всех домов, а не только психиатрических, ту же границу подтверждает Конвенция о правах инвалидов: статья 25, пункт «f», обязывает государства не допускать «дискриминационного отказа в здравоохранении или услугах в этой области либо получении пищи или жидкостей по причине инвалидности»[133]. Использовать еду как награду или наказание — значит нарушать оба акта.

2. Насилие при кормлении. Принудительное бытовое кормление недопустимо; искусственное питание возможно только как клиническая процедура по медицинским правилам (раздел 12.4). Здесь источники корпуса расходятся, и это расхождение не следует сглаживать: ранний аудит утверждает, что прямого запрета «принудительного кормления» в российском праве не найдено и запрещено именно насилие, тогда как канонический текст формулирует «недопустимо всегда» со ссылкой на часть 2 статьи 5 Закона № 3185-1 (wiki/gaps.md, п. 9). Для практики дома обе позиции ведут к одному: кормить силой нельзя, а питание против воли возможно лишь как медицинское вмешательство по решению врача и в установленном законом порядке (ч. 4 ст. 11 Закона № 3185-1 допускает лечение без согласия лишь при принудительных мерах медицинского характера и недобровольной госпитализации)[8].

3. Имитация санитарного контроля. Суточные пробы, отобранные «задним числом», и журналы, заполненные по памяти, — типовой состав дел по статье 6.6 КоАП РФ[10].

4. Недоброкачественные продукты на столе. Это также статья 6.6 КоАП РФ, «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». По тексту статьи на дату сверки штраф для граждан составляет от 1 000 до 1 500 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток[10, 134]. На странице КонсультантПлюс отмечено, что в статью внесены изменения, ещё не вступившие в силу; при использовании после 09.10.2026 размеры санкций нужно сверить заново.

5. Картельные и согласованные закупки. За них наступает антимонопольная ответственность вплоть до уголовной по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»); практику ФАС иллюстрируют два дела последних лет[135, 136]. Подробнее — раздел 30.

6. Отказ в питании «за опоздание» как система. Если человек систематически остаётся без еды потому, что пришёл не вовремя, нарушается требование о доступности питания не реже трёх раз в день (п. 7.1.11 СанПиН 3590-20; с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26)[9, 128]. Это толкование, но толкование прямое: норма требует организовать питание проживающих, а не накормить тех, кто успел.

Красная зона — это безопасность, насилие и честность документов. Число блюд в неё не входит.

17.5. «Серая зона» лечебного питания: честная маркировка

Приказы Минздрава России о лечебном питании адресованы **медицинским организациям**. Речь идёт прежде всего о трёх актах: приказе от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации», приказе от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» и приказе от 23.09.2020 № 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием», а также о картотеке диет[137]. На организации социального обслуживания они автоматически не распространяются.

Справка. Почему приказ 2003 года пишется без «н». В практике Минздрава и Минтруда буквой «н» после номера, как правило, помечают нормативные приказы последних лет. Приказ № 330 от 2003 года такой буквы в своём номере не имеет, поэтому корректная ссылка — «приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330», а не «330н». Это мелочь, но проверяющий и юрист учредителя по ней судят, читал ли автор документа сам акт.

На практике распространена обходная легализация: региональные распоряжения прямо применяют эти приказы к стационарным организациям социального обслуживания. Пример — распоряжение Министерства социального развития Московской области 19РВ-32, на которое опирается ДДСОЛ, где работает совет по питанию[24]. Если такой «мостик» в регионе есть, лечебное питание оформляется по медицинской картотеке. Если его нет, диетические назначения проводятся через врача и положение о питании, без прямых ссылок на акты, не адресованные дому (рабочая конструкция для этого случая — раздел 17.10). *Уровень: системное толкование и практика; до проверки в конкретном регионе не использовать как готовое решение.*

17.6. Пищевые карты и 152-ФЗ

Пищевая карта и пищевая биография жителя содержат персональные данные, а сведения о здоровье относятся к их специальной категории. К той же категории относятся журнал стула (раздел 13.10) и список жителей, у которых время еды фиксировано из-за инсулина (раздел 13.12).

Справка. Специальные категории персональных данных. Статья 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» запрещает обработку сведений о расовой и национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья и интимной жизни, кроме случаев, прямо перечисленных в части 2 той же статьи^[132]. Общие основания обработки из статьи 6 (например, исполнение договора) для этих сведений сами по себе недостаточны.

Отсюда следует правовой минимум для пищевой карты, и он строже, чем в первой редакции доклада. Для сведений о здоровье основанием обработки служит одно из исключений части 2 статьи 10. Для дома практически значимы три из них: письменное согласие субъекта (п. 1); обработка в медико-профилактических целях, для установления диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным хранить врачебную тайну (п. 4); защита жизни и здоровья, когда получить согласие невозможно (п. 3)^[132]. Ссылки только на договор о социальном обслуживании или на ИППСУ, как предлагала первая редакция, для диагнозов и назначений недостаточно. Предпочтения («не любит рыбу», «пьёт чай без сахара») к специальной категории не относятся, если в них не раскрыт диагноз, и могут обрабатываться в рамках договора.

Дальше — организационные правила. Круг доступа: пост и врач видят всё, кухня видит функциональные ограничения («протёртое», «без сахара», «без молока»), но не диагноз. Избыточные данные исключаются: кухне не нужно знать, почему у человека текстура уровня 4, ей нужно знать, что она именно такая. Сроки хранения устанавливаются локальным актом. Если житель недееспособен, согласие дают его законные представители. *Уровень: толкование статей 6 и 10 152-ФЗ; форма карты в приложении 3 требует локальной правовой проверки.*

17.7. КПИ: статус и практическое значение

Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов в 2008 году и ратифицировала её в 2012-м Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ; конвенция действует как международный договор Российской Федерации. Для темы питания значимы три её положения. Статья 28 («Достаточный жизненный уровень и социальная защита») признаёт право инвалидов на достаточный жизненный уровень, «включающий достаточное питание»^[138]. Статья 25, пункт «f», запрещает дискриминационный отказ в пище или жидкостях по причине инвалидности^[133]. Замечание общего порядка № 1 Комитета ООН по правам инвалидов к статье 12 развивает идею поддерживаемого принятия решений^[31]. Российские суды и органы власти используют эти положения как ориентир толкования.

Справка. Международный договор в российском праве. Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ, международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Однако положение договора применяется непосредственно лишь тогда, когда оно достаточно определённо и не требует принятия внутригосударственного акта. Нормы КПИ о достаточном питании и о поддерживаемом принятии решений сформулированы как обязательства государства, а не как правила для кухни конкретного дома. Поэтому ссылаться на них в локальных актах можно как на обоснование, но не как на источник прямой обязанности.

Уровень: международный договор и толковательная практика. В положении о питании ссылка на статью 28 КПИ уместна как обоснование выбора; формула «КПИ требует двух вариантов каши» была бы повышением класса утверждения и при проверке не устоит.

17.8. Что сказать повару в понедельник

Если свести правовую главу к одной фразе для кухни, она будет такой: главный правовой риск — не введение выбора, а отсутствие документов при уже существующей практике (раздел 31). Повару нужно знать две вещи. Первая: положение о питании и журналы — это то, что защищает его самого при проверке, а не лишняя бумага. Вторая: красная зона касается безопасности и насилия, но не числа блюд. Два котла каши не нарушают никакой нормы; нарушает норму каша без пробы и порция, которую не выдали опоздавшему.

17.9. КПИ и правовая культура: дальний горизонт

Конвенция с её акцентом на поддерживаемое принятие решений^[31] не создаёт обязанностей для кухни, но задаёт вектор: от «за него решат» к «ему помогут решить». Нормы о выборе, предпочтениях и участии в мире ужесточаются, и это видно по австралийскому Стандарту 6 качества ухода^[45] и по онтарийским требованиям к домам долговременного ухода^[27] (подробнее — раздел 26). В России обзор нормативной базы 2026 года предлагает закрепить в подзаконных актах Минтруда «не менее двух вариантов на основные приёмы пищи»; это предложение *de lege ferenda*, а не действующая норма и не позиция настоящего доклада (wiki/gaps.md, п. 19).

Дом, в котором уже работают процедуры выбора, встретит будущие требования готовым. Дом, который ждёт, пока выбор станет обязательным, будет догонять в сжатые сроки, а это всегда дороже и почти всегда фиктивнее.

17.10. Серая зона лечебного питания: рабочая конструкция до «моста»

Пока регионального «моста» к приказам Минздрава нет, ошибочны две крайности. Нельзя игнорировать лечебное питание под лозунгом «мы не больница»: санитарные правила прямо требуют диетического питания по медицинским показаниям^[9, 128]. Нельзя и имитировать больницу, заводя «диеты как в стационаре» без больничной инфраструктуры и без адресованного дому акта.

Рабочая конструкция состоит из трёх элементов. Во-первых, назначения по питанию даёт лечащий врач (психиатр, терапевт), и даёт письменно; любая письменная форма лучше устной. Во-вторых, кухня исполняет назначения через текстуры и исключения продуктов, а не через

«номерные диеты» больничной системы. В-третьих, учредителю ежегодно направляется предложение о региональном акте по образцу уже существующих[12]. Сама конструкция называется и документируется как временная, с датой обращения к учредителю. Тогда серая зона перестаёт быть безответственностью и становится пробелом регионального регулирования, у которого есть назначенный владелец.

17.11. Как читать норму: три вопроса к любому акту

Директору не нужно становиться юристом. Достаточно задать три вопроса любому акту, который «грозит» или «разрешает».

Первый вопрос: кому адресован акт? Приказы Минздрава о лечебном питании адресованы медицинским организациям и на организации социального обслуживания автоматически не ложатся; стык обеспечивается через региональный «мост» (раздел 24)[12]. Статья 43 Закона № 3185-1 адресована стационарным организациям, предназначенным для лиц с психическими расстройствами, и не переносится автоматически на любой дом (раздел 17.14)[8].

Второй вопрос: каков статус требования? Рекомендуемые нормы Минтруда (приказ № 520н[38]) остаются ориентиром, пока регион не сделал их обязательными. СанПиН[9] обязателен всегда. ИППСУ обязательна для поставщика (ч. 3 ст. 16 442-ФЗ)[118].

Третий вопрос: что доказывает бумага? Право без процедуры («уважать достоинство») исполняется журналом, картой, протоколом. Если процедуры нет, нет и доказательства, что право исполнено.

Зал обычно совершает две ошибки. Первая — «нам всё запрещено»; часто это ссылка на акт, адресованный не дому. Вторая — «нам всё можно»; часто это ссылка на рекомендательный акт, который в вашем регионе давно стал обязательным. Зелёная, жёлтая и красная зоны — это и есть ответы на три вопроса, применённые к вариативному питанию.

Где источники расходятся. Ответы на три вопроса не всегда совпадают в разных слоях корпуса, и это стоит знать заранее. Для норм питания канон доклада опирается на приказ № 520н, тогда как академическая сверка называет приказ № 774н, а правовой обзор НПА 2026 года — постановление Минтруда № 12 от 15.02.2002; номера не следует отождествлять или объявлять один «отменённым» (wiki/gaps.md, п. 13). Правовой обзор НПА строит права проживающих на 442-ФЗ и не использует Закон № 3185-1; для ПНИ канон опирается именно на 3185-1, и сужать его до 442-ФЗ нельзя (п. 16). Наконец, обзор НПА называет 3590-20 действующим до 01.01.2027, что соответствует сроку, установленному в постановлении № 32[128], но не учитывает его досрочной замены СанПиН 4282-26 с 01.09.2026[129] (п. 7).

17.12. Указатель модератору: дискуссия 26.08

Дискуссия 26.08 «Организация питания: опыт реализации проектов» проходит с 14:00 до 15:30 на площадке № 2 — в ДСО «Тесовый берег». Модераторы — Е. В. Чистяков, директор ДСО «Серафимовский», и Т. А. Нурбаев, директор ДСО «Тесовый берег». Дискуссия построена вокруг шести вопросов:

1. Кто выбирает форму питания — проживающий социального дома или его руководитель?
2. Как формировать меню в условиях жёстких нормативно-правовых и финансовых ограничений?
3. Должно ли быть питание в социальных домах «лечебным»?
4. Как совместить понятия «лечебное питание» и «вариативное меню», не ограничивая право проживающего на выбор?
5. Как соблюсти баланс между выбором недееспособного проживающего «что ему есть» и имеющимися у него медицинскими рекомендациями?
6. Как совместить качество продуктов питания и нормирование цен на них при планировании бюджета в условиях рыночной экономики?

Развёрнутые ответы на каждый вопрос по схеме «правовая рамка — практика — алгоритм — чего делать нельзя», сводная матрица и пакет документов к выступлению вынесены в отдельный спикерский файл модератора и в раздатку не входят. Они действительны на 19–21.08.2026 с учётом правок № 14–16 к программе семинара.

17.13. Смежные площадки семинара: что пересекается с организацией питания

Питание — не обособленный «кухонный» трек. Вопросы, поднятые на других сессиях и не закрытые там, вернутся 26.08 в форме «а вчера нам говорили другое». Ниже собраны только те пересечения, где есть норма или раздел этого доклада. Формулировки даны по обновлённой программе; правки № 15–16 учтены. Лекция А. К. Федермессер проходит 25.08 с 16.15 до 17.45; мозговой штурм «Как наладить жизнь в доме?» — 26.08 с 16.00 до 17.45, сразу после сессии о питании.

17.13.1. 25.08, 12.00–13.30. «Право быть человеком»

Пересечения с питанием есть в двух вопросах сессии: в первом (выбор против гарантированной безопасности, в том числе отказ от жизненно важных процедур) и в третьем (проживающий регулярно выбирает то, что ухудшает его состояние, **включая еду**).

Ответ со стороны питания не отменяет автономию. Отказ от блюда не равен отказу от еды: человеку предлагают эквивалент внутри нормы и, если есть назначение, внутри диеты (разделы 12 и 17.12, вопросы 1 и 5). Отказ от воды или еды дольше суток — это уже клинический контур и решение комиссии, а не повод сказать «он сам выбрал, мы ни при чём»; иначе возникает то перекладывание ответственности, о котором говорит десятый вопрос той же сессии. Уважение к выбору не означает права дать вредное без фиксации. «Диабетический стол» без назначения врача — ограничение без основания; снятие диеты по просьбе жителя при действующем назначении документируется, а не скрывается (раздел 17.12, вопросы 3–5). Безопасность обеспечивается СанПиН, назначениями и журналами, а не отменой выбора.

17.13.2. 25.08, 14.30–16.00. «Право на выбор: есть или нет?»

Е. В. Чистяков — **эксперт этой панели** (модератор К. А. Георгиев). Вопросы панели касаются внедрения, страха коллектива и тех, кто «проиграл». Для питания это не второй доклад, а **перевод** раздела 17.12 на язык управления.

На вопрос «Есть ли выбор, если решение уже принято?» ответ таков: директор вводит пару блюд на линии, а житель выбирает внутри рамки («шеф решает, что готовить; житель решает, что взять»). Риск, который называют первым, — проверка, СанПиН, «не по меню», — делами о вариативности не подтверждён: публичные дела по статье 6.6 КоАП касаются качества и достаточности питания, а не второго блюда (разделы 17 и 18). Наконец, о «проигравших». Проиграть может смена на раздаче (труд растёт), поставщик (если техническое задание ужесточили) и привычка кухни к одной раскладке. Выигрывает житель, чей выбор записан в журнал. Это ответ на шестой вопрос панели.

17.13.3. 25.08, 12.00–13.30. «Право быть недееспособным»

Вопросы 1–4 этой сессии — интересы подопечного, кто их выявляет, по каким алгоритмам. На нашей дискуссии 26.08 им соответствует пятый вопрос. Повседневное пищевое предпочтение, как правило, не является ни сделкой, ни медицинским вмешательством: статья 29 ГК РФ касается сделок, а статья 11 Закона № 3185-1 — согласия на лечение; к диете, назначенной врачом, она применима скорее, чем к выбору между котлетой и рыбой. Иерархия источников воли подробно разобрана в разделах 15.4 и 15.9; порядок в них расходится, и это расхождение оговорено в 15.9. Опекун содействует, а не подменяет.

Особо нужно сказать о сроке извещения опеки, который первая редакция связывала с назначением диеты. Часть 3 статьи 11 Закона № 3185-1 устроена иначе: если лицо, признанное недееспособным, не способно само дать согласие на лечение, согласие даёт его законный представитель, и этот представитель извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного не позднее дня, следующего за днём согласия^[8]. Обязанность лежит на законном представителе, а предметом извещения является согласие на лечение. Распространять её на назначение диеты можно лишь как толкование, и только если диета в данном случае является частью лечения. Если законным представителем выступает сама организация, извещать опеку будет она.

17.13.4. 26.08, 16.00–17.45. «Как наладить жизнь в доме?» (мозговой штурм)

Эта сессия идёт сразу после дискуссии о питании: перерыв с 15.30 до 16.00, тот же дом. Ночной интервал и индивидуальный режим здесь — передача эстафеты, а не новая тема.

Цель сессии — режим дня, построенный из индивидуальных потребностей, а не из удобства смены. Для кухни это ночной интервал и часы приёмов пищи (раздел 7; слайд о ночном голоде). Вариативное меню без сдвига ужина, назначенного «всем удобно на 17:30», оставляет человека на 14–15 часов без еды; выбор блюда голода не лечит. Работает связка: индивидуальный режим, пара блюд на линии и второй ужин по СанПиН, если интервал не укладывается в норму.

17.13.5. 25.08, 14.30–16.00. «Человек или функция»

Тема сессии — делать за человека или помогать ему сделать самому. Тот, кто кладёт на тарелку «как всегда», превращает жителя в функцию раздачи пайка. Тот, кто держит два варианта и ждёт жеста, оказывает сопровождение. Еда как навык сопровождаемого проживания разобрана в разделе 8.8.

17.13.6. 26.08, 11.30–13.00. «Право на частную жизнь»

Второй вопрос сессии: может ли быть частная жизнь у недееспособных? Ежедневный выбор того, что есть, — одна из немногих регулярных зон автономии, которые у человека остаются. Журнал выбора и пищевая биография фиксируют частное предпочтение. Седьмой вопрос программы («нарушение есть во всех домах») на кухне выглядит так: общая раскладка без учёта отказа, еда в палате без согласия, видеокамера на раздаче без рамки 152-ФЗ (разделы 17.6 и 42.3).

17.13.7. 25.08, 16.15–17.45. Интерактивная лекция А. К. Федермессер «Практические советы — как обеспечить соблюдение права на достоинство»

Лекция проходит в тот же день, что и панель «Право на выбор» (14.30–16.00, где Е. В. Чистяков выступает экспертом), после пятнадцатиминутного перерыва. Её тема — достоинство и принцип «не причинять добро». На следующий день этот принцип должен оказаться на тарелке. *(В промежуточной сверке слот ошибочно оставили на 26.08, 16.15–17.45; в обновлённой программе на это время стоит мозговой штурм, раздел 17.13.4.)*

Акцент программы — уважать выбор и «не причинять добро». Навязанный «полезный» стол без назначения врача — как раз причинение добра. Кормление ради комфорта (comfort feeding) и паллиативный контекст разобраны в разделе 12.11, немецкая практика «стола по желанию» (Wunschkost) — в разделе 12.6.

Параллельно нашей сессии, 26.08 с 14.00 до 15.30, идёт сессия «Право на достойный уход» (Олескина), посвящённая предсмертному периоду. Если модератора по питанию там не будет, ответ всё равно содержится в разделе 17.12 (вопрос 5, сценарий В) и в разделе 12.11.

17.13.8. Чего не переносить в доклад о питании

Трудоустройство недееспособных, контент, создаваемый жителями, учебное проживание и киносессии пересекаются с темой питания лишь косвенно. Раздувать эти пересечения не нужно. Тема «еда как занятость» коротко изложена в разделе 8.8.

Источники к разделу 17.13: обновлённая программа семинара 25–27.08.2026; правки к программе (позиции 14–16 учтены); разделы 7, 8, 12, 12.11, 16, 17.12, 18 и 42 настоящего доклада; Конституция РФ, статьи 21 и 41; Закон № 3185-1, статья 11[8]; ГК РФ, статья 29.

17.14. ПНИ и ДСО: различия в правовом статусе, которые важны для темы питания

В зале 26.08 будут представлены оба типа учреждений, и правовые режимы питания у них **не совпадают**. Различие в регулировании — первое, что нужно проверить на старте пилота. Таблица ниже — рабочая памятка директора перед запуском вариативности.

Главное различие лежит в статье 43 Закона № 3185-1. Она распространяет права, перечисленные в частях 2 и 4 статьи 37, на лиц, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, **предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами**[8], то есть на жителей ПНИ. На дом социального обслуживания общего профиля статья 43 не распространяется, даже если среди жителей есть люди с психиатрическим диагнозом. Для них действует часть 2 статьи 5 того же закона — но только «при оказании им психиатрической

помощи»[8], а во всём остальном опорой служат 442-ФЗ и Конвенция о правах инвалидов. Первая редакция доклада описывала положение ДСО как «косвенное распространение статьи 37 через общее правило»; такого общего правила в законе нет, и таблица исправлена.

Параметр	ПНИ (психоневрологический интернат)	ДСО (дом социального обслуживания), в том числе для пожилых и инвалидов
Тип жителей (как правило)	Лица с психическими расстройствами, преимущественно трудоспособного возраста, длительное пребывание	Лица пожилого возраста и инвалиды старше 18 лет, в том числе с психическими расстройствами; часто паллиативный профиль
Применимость статей 37 и 43 Закона № 3185-1	Прямая: ст. 43 распространяет на проживающих права из ч. 2 и 4 ст. 37, включая право соблюдать религиозные каноны и пост	Статья 43 не применяется. Часть 2 ст. 5 действует для лиц с психическими расстройствами при оказании им психиатрической помощи; в остальном — 442-ФЗ и КПИ
Региональный норматив (пример Санкт-Петербурга)	Постановление № 1284 с отдельными нормами для ПНИ; нормы для ПНИ обычно калорийнее и содержат больше белка	То же постановление № 1284 с отдельными нормами для ДСО; калорийность может быть ниже, акцент на лёгкой усвояемости и текстурах
Диетические столы	Чаще ОВД, ЩД, ВБД, реже НБД; значительная доля жителей с назначенной диетой	Чаще ОВД, щадящие и протёртые; выше доля дисфагии и потребность в текстурах по IDDSI
Вариативность: публично подтверждённая модель	М1–М2 (Болотнинский, Успенский ПНИ, Иркутская область). М3 — при наличии площади и санитарного контура, а не как типовой случай	Старт чаще с М1; М2–М3 упираются в текстуры
Учёт невербального выбора	Нужен там, где выбор не выражается словом. Не путать с долей недееспособных (около трёх четвертей, раздел 16): недееспособность не означает молчания	Нужен при дисфагии, деменции, отсутствии речи
Совет жителей (раздел 34)	Работает, но суррогатно: недееспособные участвуют через опекунов, статус совещательный	Работает лучше, особенно в учреждениях для пожилых без тяжёлой психиатрической патологии
Региональные акты-«мостики» к приказам Минздрава о лечебном питании	Встречаются реже; чаще работает «конструкция до моста» (раздел 17.10)	Встречаются чаще; пример ДДСОЛ — распоряжение Минсоцразвития Московской области 19РВ-32 (раздел 17.5)
Типовая претензия проверяющего по ст. 6.6 КоАП	Качество и достаточность питания, соблюдение санитарного контура	Качество и достаточность, а также текстуры (особенно для жителей с дисфагией)
Тариф (ориентир, 2025)	Алтай — 422 руб. в день, единый тариф для ПНИ и ДСО; Санкт-Петербург — распоряжение 1366-р с разбивкой по типам	Те же 422 руб. в день; в Санкт-Петербурге — отдельные позиции в 1366-р

Что из этого следует для вариативности. Стартовый пилот (раздел 35) устроен одинаково, но его точка различается. В ДСО чаще приходится прорабатывать текстуры (раздел 10), в ПНИ — невербальный выбор (раздел 15). Пакет документов (раздел 31) один, но в ДСО чаще требуется согласовать текстуры с учредителем, а в ПНИ — выстроить процедуру взаимодействия с опекой (раздел 16). Четыре публичных кейса Новосибирской и Иркутской областей (раздел 25) относятся к ПНИ; ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург) и ДДСОЛ (Московская область) — к ДСО. Опыт, таким образом, накоплен в обоих типах учреждений, но переносить меню ПНИ в гериатрический ДСО без проработки текстур нельзя.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-block-istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/psk-2026-10-block/istochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; для S001 и S011 в реестре записана построчная сверка статей, использованных во второй редакции.

Маркер	Источник
S070	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 10 (КонсультантПлюс, сверка 09.10.2026)
S071	Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг»
S072	КоАП РФ, ст. 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» (КонсультантПлюс, сверка 09.10.2026)
S073	Приказы Минздрава России от 05.08.2003 № 330, от 21.06.2013 № 395н, от 23.09.2020 № 1008н — реквизиты по вторичному правовому обзору (brace-lf.com)
S074	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. ГГСВ РФ от 27.10.2020 № 32), п. 7.1.11–7.1.14 и п. 2 постановления о сроке действия
S075	СанПиН 2.3/2.4.4282-26: вступление в силу 01.09.2026 и замена 3590-20 (Контур, 25.06.2026; NormaCS)
I-crpd25f	Конвенция о правах инвалидов (2006), ст. 25 п. «f», официальный русский текст (un.org)

18

Санитария и пищевая безопасность при вариативности

Самое частое опасение директора, услышавшего о вариативном меню, звучит так: «А что скажет Роспотребнадзор?» За ним стоит представление, будто санитарные правила требуют однообразия: одно блюдо легче проверить, сохранить и доказать. Эта глава показывает, что представление ошибочно. Санитарные правила говорят о безопасности, а не о числе блюд, и вариативность входит в санитарный контур без изъятий. Но именно поэтому каждый новый вариант должен пройти этот контур целиком — со своей пробой, своей температурой, своей маркировкой и своей строкой в журнале. Раздел написан на стыке двух редакций правил: семинар 25–27.08.2026 прошёл в последнюю неделю действия СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а с 1 сентября 2026 года действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26.

Справка. Санитарный контур пищеблока. Под **санитарным контуром** в докладе понимается вся цепочка контроля безопасности пищи от поступления сырья до тарелки. Её основные звенья: **приёмка** (проверка документов, сроков годности, условий доставки); **поточность** — организация помещений и движения продуктов так, чтобы сырое не пересекалось с готовым, а грязная посуда — с чистой; **бракераж** — органолептическая оценка готового блюда ответственным лицом или комиссией до выдачи с записью в журнал; **суточная проба** — образец каждого блюда, который хранится в холодильнике, чтобы при пищевом отравлении можно было установить его источник; **температурный контроль** при хранении и раздаче; **производственный контроль** — собственная программа организации, определяющая, что, как часто и кем проверяется.

18.1. Главный тезис: СанПиН — про безопасность, а не про однообразие

На дату семинара санитарные требования к питанию в организациях социального обслуживания задавал СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32): не менее трёх приёмов пищи в день, диетическое питание по показаниям, контроль на всех этапах — приёмка сырья, суточные пробы готовой продукции, бракераж, температурный режим, питьевой режим[9].

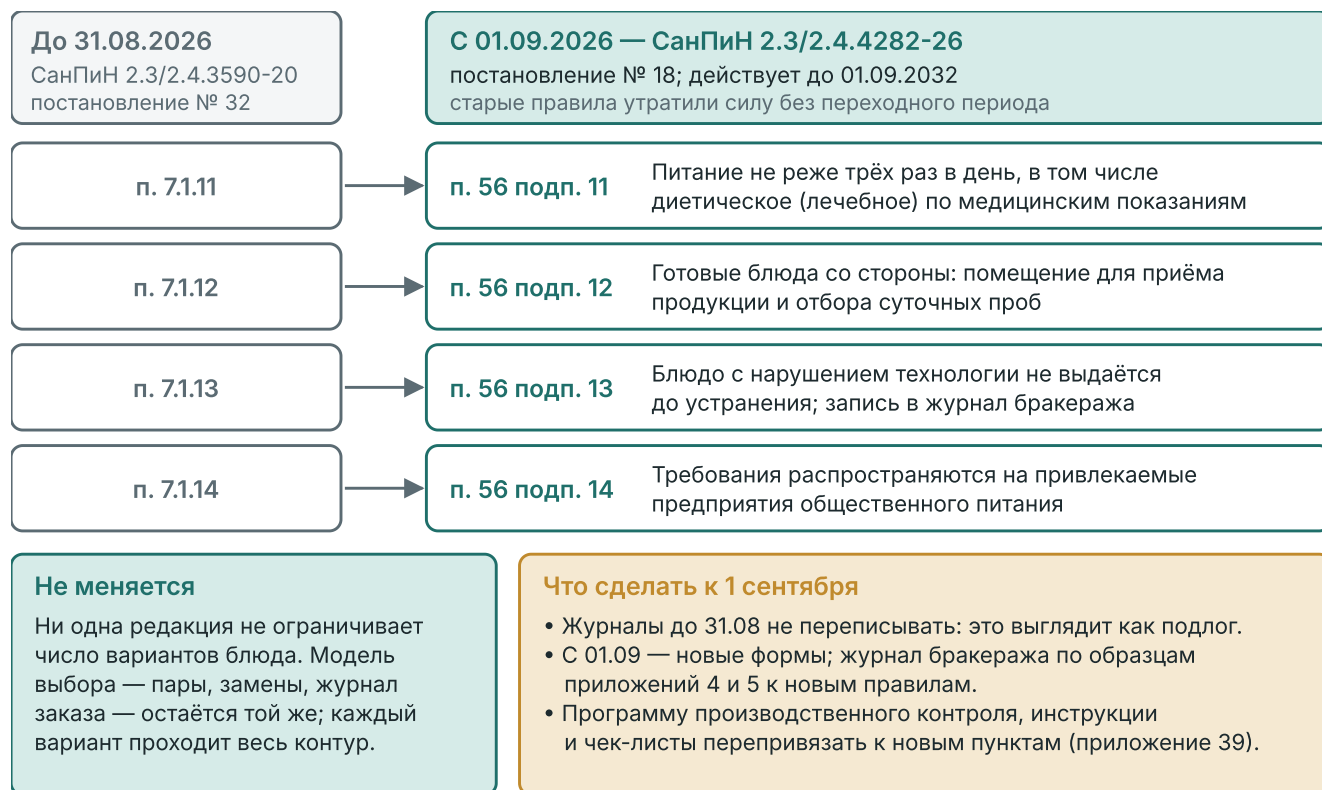
С 01.09.2026 действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26, утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18. Постановление признаёт утратившими силу и постановление № 32 об утверждении СанПиН 3590-20, и изменяющее его постановление от 22.08.2024 № 9; новые правила действуют до 01.09.2032[9]. Каркас сохранён. Пункт 56 распространяется на организацию питания пациентов медицинских организаций и проживающих организаций социального обслуживания, оказывающих услуги в стационарной форме. Его подпункт 11 требует организовать питание проживающих не менее трёх раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям; подпункт 12 — при использовании готовых блюд из предприятий общественного питания выделять помещение для

приёма готовой продукции и отбора суточных проб; подпункт 13 запрещает выдавать блюдо при нарушении технологии или неготовности до устранения недостатков с записью в журнал бракеража; подпункт 14 распространяет требования пункта на привлекаемые предприятия общественного питания[9].

Уточнение второй редакции: в первой редакции правило «суточные пробы — от каждой партии блюда» было отнесено к подп. 11–14 п. 56. При чтении текста правил выяснилось, что порядок отбора пробы изложен в подп. 4 п. 56, а подп. 12 отсылает к нему для СОСО (раздел 18.7).

Ни одна редакция не ограничивает число вариантов блюда. Отсюда сила и уязвимость вариативности в санитарном смысле. Сила в том, что каждый вариант защищён правилами так же, как единственное блюдо мономеню. Уязвимость в том, что каждый вариант обязан пройти весь контур, и слабое звено в варианте Б — такое же нарушение, как в варианте А. После 1 сентября локальные акты и чек-листы пищеблока перепривязываются к пунктам СанПиН 4282-26; модель выбора при этом не меняется.

Противоречие слоёв корпуса. Правовой обзор НПА (литературная редакция 29.08.2026) утверждает, что СанПиН 3590-20 действует до 01.01.2027, и СанПиН 4282-26 не упоминает (wiki/gaps.md, п. 7). Текст постановления № 18 прямо признаёт 3590-20 утратившим силу с 01.09.2026. Для работы дома после этой даты опорой служит 4282-26; ранний слой мы не «исправляем», а оговариваем.



На раздаче проверяют каждый вариант — и А, и Б

Суточная проба подп. 4 п. 56 Отдельно от каждого варианта, в промаркированной ёмкости; хранится не менее 48 часов при +2...+6 °С	Температура п. 50 По технологическим картам: в обеих гастроёмкостях и на последнем столе; при раздаче в комнаты — в палате
Время на раздаче п. 32 Блюда, требующие разогрева, — не более трёх часов с изготовления. Вариант Б — в малых гастроёмкостях	Бракераж подп. 13 п. 56 До выдачи, с записью в журнал; брак не выдаётся, пока недостатки не устранены
Кто раздаёт п. 32 Посторонние к раздаче не допускаются: раздача должна быть в должностной инструкции санитарки или помощника	Остатки п. 32 Не реализуют на следующий день и не замораживают впрок — одинаково для обоих вариантов
Маркировка «вариант А / Б» рекомендация Прямой нормы для линии нет (п. 55 — для кейтеринга), но безымянная кастрюля — типовое замечание	Журналы рекомендация Те же санитарные журналы для обоих вариантов, без отдельной «вариативной бухгалтерии»

Рисунок 13. Что изменилось 1 сентября 2026 года и что санитарный контроль проверяет на раздаче у каждого варианта (разделы 18.1, 18.2, 18.7, 18.10)[9]

18.2. Санитарный контур при двух вариантах

Посмотрим, что именно меняется при переходе от одного варианта к двум.

Пробы. Суточная проба отбирается с каждого блюда, то есть с обоих вариантов. Трудозатраты невелики: вторая пробная ёмкость и вторая строка журнала. Типичная ошибка — проба только «с основного» блюда при раздаче двух. Для проверяющего это отсутствие пробы второго блюда.

Параметры пробы и частые ошибки разобраны в разделе 18.7.

Температура. Её измеряют на линии и на последнем столе, а при двух гастрорёмкостях — в обеих. Нормативная рамка здесь такова: пункт 50 СанПиН 4282-26 требует, чтобы температура горячих блюд, холодных супов и напитков, реализуемых через раздачу, соответствовала технологическим документам; фиксированных градусов правила не называют, их берут из технологических карт[9]. Пункт 32 запрещает держать на раздаче более трёх часов с момента изготовления готовые блюда, требующие разогревания перед употреблением[9]. Для вариативной линии из этого следует практическое правило: меньший объём остывает быстрее, поэтому вариант Б подают в меньших гастрорёмкостях с пополнением, а не держат «комнатной температуры» до конца раздачи.

Маркировка. Чтобы раздающий не перепутал варианты, используют цветные маркеры, наклейки, постоянный порядок на линии. Отдельного требования маркировать ёмкости на линии раздачи СанПиН 4282-26 не содержит; маркировку изотермических ёмкостей с наименованием, датой и временем изготовления правила требуют для кейтеринга (п. 55)[9]. Поэтому маркировка вариантов на линии — рекомендация доклада, а не прямая норма. При текстурных модификациях маркировка становится клиническим элементом (раздел 10): перепутанные протёртая и обычная порции означают риск аспирации.

Раздача и поток. Два варианта удлиняют выдачу на 5–10 секунд на человека. Для маломобильных жителей порядок подачи прописывается отдельно: выбор делается заранее по журналу заказа (раздел 21).

Кто раздаёт. Пункт 32 СанПиН 4282-26 запрещает привлекать к приготовлению, порционированию и раздаче «посторонних лиц, включая персонал, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности»[9]. Пункт находится в общей части правил; применимость общих требований к пищеблоку СОСО обсуждается в разделе 18.10, но безопаснее исходить из того, что пункт действует. Для дома, где раздачу в отделении ведут санитарки или помощники по уходу, вывод прост: раздача должна быть записана в их должностных инструкциях. Иначе вариативная раздача, требующая больше рук, создаёт формальное нарушение там, где его не было.

Хранение остатков. Правила хранения и запрет повторного использования распространяются на оба варианта одинаково[9]. Пункт 32 прямо запрещает реализацию готовых блюд на следующий день и замораживание нереализованных блюд для реализации в другие дни[9]. Журнал замен фиксирует, что ушло в переработку по правилам, а что — в списание.

18.3. Типовые нарушения и их цена

Надзор по социальным учреждениям бьёт в один и тот же набор нарушений: отсутствие или имитация суточных проб, недоброкачественные продукты, нарушение температурных режимов, отсутствие бракеража[10]. Типичный состав — статья 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Её санкция для должностных лиц — штраф от 5 до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток[139]. В разобранных делах должностные лица штрафовались на 5 тыс. руб., то есть по нижней границе[10]. Сумма мала, но

само дело — это проверка, представление прокуратуры и репутационный след. Пример — кейс Кашинского социально-реабилитационного центра (2022): просроченные продукты и отсутствие проб, директор привлечён по ст. 6.6[10]. Полная карта ответственности директора — раздел 33.

Маркировка: дела касаются учреждений социального обслуживания иных типов; для ПНИ это ограниченная аналогия, хотя состав нарушений переносится напрямую. Правовой обзор НПА по санитарному блоку ссылается на ст. 6.3 КоАП, канон доклада по претензиям к качеству и достаточности питания — на ст. 6.6; это разные составы, и подменять один другим нельзя (wiki/gaps.md, n. 15).

18.4. Буфет, передачи и «серая еда»

Помимо общего меню, еда попадает к жителю ещё тремя путями, и каждый из них требует правил.

Буфет и перекусы. Круглосуточная доступность перекусов закреплена в международных нормах — австралийском Стандарте 6 и шведских национальных рекомендациях по питанию пожилых[39, 45]. В российском контуре это означает: ассортиментный перечень буфета утверждён (без энергетических напитков и с учётом лекарственных ограничений раздела 11), продукты проходят тот же контур приёмки, сроки годности контролируются.

Передачи от семьи. Передача — радость и одновременно риск: скоропортящиеся продукты; продукты с тирамином для жителей, получающих ингибиторы МАО; крепкий кофе для группы, принимающей клозапин; грейпфруты (подробно — раздел 11). Решение — не запрет, а регламент: перечень приветствуемых и недопустимых продуктов (приложение 32), осмотр передачи дежурным, информирование семей при поступлении и ежегодно. Для ПНИ у регламента есть прямое законное основание: статья 39 Закона № 3185-1, применяемая к стационарным организациям социального обслуживания через часть 2 статьи 43, обязывает организацию обеспечивать безопасность проживающих и контролировать содержание посылок, бандеролей и передач[8]. Контроль, таким образом, — обязанность, но обязанность контролировать, а не запрещать.

«Своя» еда жителей. Запасы в тумбочках («хомячение», раздел 9) создают проблему сроков годности и гигиены. Решение — легальные зоны хранения перекусов и их регулярная замена, а не конфискации.

Почему эти каналы требуют внимания, показывают зарубежные данные о вспышках. Обзор 75 вспышек кишечных инфекций в учреждениях длительного ухода (январь 1997 — июнь 2007) установил, что 31 % из них были бактериальными, 69 % — вирусными; более половины бактериальных вспышек (52 %) передавались с пищей; среди примерно трёх тысяч заболевших проживающих сообщено о 60 смертях, примерно половина — от сальмонеллёза[140]. Среди рекомендаций по пищевым вспышкам авторы выделяют обучение персонала безопасному обращению с пищей, температурный контроль при приготовлении и надлежащий выбор и обработку яиц[140]. Это данные стран Северной Америки и Европы, и частоту вспышек в российских ДСО и ПНИ они не описывают; но они показывают, что для пожилых и ослабленных жителей пищевая инфекция — вопрос не только жалоб, но и смертности.

Сводной российской статистики вспышек кишечных инфекций в стационарных организациях социального обслуживания в открытом доступе найти не удалось: эпидемиологические работы группируют очаги по детским коллективам и населению в целом. В Москве, например, за 2011–2016 годы зарегистрировано 33 очага норовирусной инфекции, около четверти всех вспышек острых кишечных инфекций в городе; чаще всего — в детских организованных коллективах, и около двух третей вспышек передавались контактно-бытовым путём, около трети — пищевым[141]. Отдельные публичные сообщения показывают, что ДСО эта угроза касается напрямую. В октябре 2024 года в Петрозаводском доме-интернате для инвалидов Роспотребнадзор зарегистрировал 23 случая норовирусной инфекции среди проживающих, преимущественно средней тяжести; путь передачи признан контактно-бытовым, пищевое отравление не установлено, но в ходе расследования проверяли и организацию, отвечавшую за питание[142]. В феврале 2025 года из Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов с признаками кишечной инфекции госпитализировали 33 проживающих[143]. Это единичные случаи, а не статистика; вывод из них практический: при вспышке пищеблок проверяют всегда, даже если источник окажется не в кастрюле.

18.5. Ответственный за санитарный контур

При любой вариативности ответственный один — руководитель учреждения, который делегирует контроль приказом заведующему хозяйством, шеф-повару или диетсестре в зависимости от штата. Делегирование исполнения не снимает ответственности за то, чтобы контроль работал на деле. Различие между «распределил функции» и «контролирует фактически» — центральное в разделе 33.

Минимум — еженедельный обход пищеблока руководителем или его заместителем по чек-листу (приложение 19) с записью. Эти десять минут превращают «формально распределено» в «фактически контролируется».

18.6. Что сказать повару в понедельник

Второй вариант проходит тот же контур: пробы, температуры, маркировка, журналы. Если контур имитируется, вариативность удвоит имитацию. Поэтому порядок такой: сначала работающий контур (модель М0, раздел 8), потом выбор.

18.7. Суточная проба при вариативности: частые ошибки

Порядок отбора суточной пробы изложен в подпункте 4 пункта 56 СанПиН 4282-26. Проба отбирается от каждой партии приготовленной продукции, отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие, в обеззараженные и промаркированные плотно закрывающиеся ёмкости. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки отбираются в количестве не менее 100 г; порционные изделия оставляются целиком, в объёме одной порции. Пробы хранятся не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд в отдельном холодильнике или отведённом месте холодильника при температуре от +2 до +6 °C[9].

Оговорка о применимости. Буквально подпункт 4 говорит о пищеблоках медицинских организаций, а подпункт 12 отсылает к нему для стационарных СОСО, получающих готовые блюда от предприятий общественного питания. Для СОСО с собственным пищеблоком отдельной формулировки в прочитанном тексте мы не нашли. Доклад исходит из того, что вводная часть п. 56 распространяет его требования на стационарные СОСО, и рекомендует отбирать пробы по подп. 4 в любом случае; это толкование, а не прямая норма.

На вариативной линии встречаются три типичные ошибки:

- **«средняя проба по обеду»** — смешанная или одна на весь обед; она не доказывает безопасность ни одного варианта и прямо противоречит правилу «отдельно каждое блюдо»;
- **проба только варианта А** — вариант Б оказывается беззащитен при инциденте;
- **проба без маркировки варианта** — через сутки невозможно доказать, что именно лежит в ёмкости.

Правило: каждый вариант каждой позиции — своя промаркированная проба в тех же журналах. Трудозатраты — минуты; доказательная цена — вся линия.

18.8. Буфет и передачи: два хронических очага

Раздел 18.4 обосновал, почему буфет и передачи нужно регулировать. Здесь — что именно записать в регламент. Буфет и комната передач — ежедневный стык санитарии и прав, и без регламента он закрывается первой же проверкой или первой жалобой.

Буфет. Регламент называет допустимые категории (напитки, хлеб, упакованные продукты, фрукты при условии мытья), режим пополнения и ответственного — письменно. Формула «под присмотром» без регламента не выдерживает проверки. Холодные блюда и напитки на буфете хранятся в охлаждаемой витрине или холодильнике: размещение их на раздаче вне охлаждаемого оборудования и реализация с нарушением сроков годности запрещены пунктом 32 СанПиН 4282-26^[9].

Передачи. Регламент содержит перечень запрещённого (скоропортящееся, открытые домашние заготовки, алкоголь и энергетические напитки, а также продукты из лекарственной таблицы — например, кофеин для группы клозапина^[17]), порядок регистрации и правила хранения с маркировкой.

Без регламента дом скатывается в одну из двух крайностей. Полный запрет нарушает права жителей и порождает «подполье» — тайные запасы и тайные передачи. Бесконтрольность ведёт к отравлениям и лекарственным взаимодействиям. Поэтому регламент пишется как форма разрешения, а не как форма запрета.

18.9. Вторая гастрорёмкость: санитарный паспорт новой позиции

Второй вариант на линии проверяется по пяти пунктам, которые санитарный врач спросит первыми. Ответить на них нужно до старта, на одной странице.

1. **Поточность.** Новая позиция идёт в том же потоке (раздача — столы — мойка) и не создаёт пересечений сырого и готового.
2. **Температура.** Горячие блюда находятся в мармите или на раздаче с контролем. Вторая гастроёмкость либо имеет собственный мармит, либо выдаётся первой по времени; принятое решение фиксируется. Срок нахождения на раздаче — в пределах трёх часов для блюд, требующих разогрева (п. 32)[9].
3. **Маркировка.** На каждой вариативной ёмкости — бирка с наименованием и указанием «вариант А» или «вариант Б». Безымянные кастрюли — классическое замечание проверяющих (класс — практика, а не прямая норма; раздел 18.2).
4. **Суточная проба** — от каждого варианта, а не «от обеда вообще», иначе она не доказывает безопасность варианта Б (раздел 18.7).
5. **Журналы.** Температура и пробы вносятся в те же санитарные журналы, без отдельной «вариативной бухгалтерии».

Страница-паспорт подписывается заведующим производством и прилагается к приказу о пилоте. На первый вопрос проверяющего «как вы это организовали?» отвечает документ, а не экскурсия.

18.10. Переходный месяц: сентябрь 2026

Семинар пришёлся на последнюю неделю старых правил, и первый месяц новых оказался самым нервным. Постановление № 18 не предусматривает поэтапного перехода или отсрочки: с 01.09.2026 все требования СанПиН 2.3/2.4.4282-26 применяются в полном объёме[9].

Документы задним числом не переписываются. Журналы до 31 августа, заполненные по формам СанПиН 3590-20, законны в том виде, в каком велись. С 1 сентября журналы ведутся по новым формам; рекомендуемые образцы журнала бракеража готовой продукции приведены в приложениях 4 и 5 к новым правилам[9]. Сентябрьская проверка оценивает сентябрь по новым правилам, а август — по старым. Попытка «переоформить» августовские журналы под новые формы хуже, чем их возраст: она выглядит как подлог.

Программа производственного контроля актуализируется к 1 сентября — инструкции, графики, формы журналов. Это требование готовности, а не задача «на потом»[9].

Справка. ХАССП. ХАССП (англ. *Hazard Analysis and Critical Control Points* — анализ опасностей и критические контрольные точки) — система управления безопасностью пищи, при которой организация сама выявляет этапы, где возможна опасность (например, недостаточный прогрев или охлаждение), назначает на них контрольные точки с измеримыми пределами и ведёт записи. ХАССП не заменяет санитарных правил, а описывает, как организация доказывает их соблюдение.

Вопрос об обязательности ХАССП для пищеблоков СОСО требует аккуратности. Пункт 4 СанПиН 4282-26 устанавливает, что «предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП», в порядке и с периодичностью, определёнными самим предприятием[9]. Однако Верховный Суд РФ в постановлении от 21.02.2019 № 11-АД19-4 указал, что образовательная организация (школа № 80 в Казани) не является организацией общественного питания, поскольку питание в ней — не реализация пищи

населению[23]. Перенос этого вывода на дома социального обслуживания — аналогия, то есть толкование (раздел 33.2). Это решение принималось по другому поводу и не отменяет специальных требований пункта 56, прямо адресованных стационарным СОСО. Поэтому позиция доклада остаётся прежней: мы не утверждаем, что ХАССП обязателен для каждой СОСО сверх производственного контроля. Если же ХАССП в доме внедрён, его документы перепривязываются к новым пунктам вместе с программой производственного контроля. Если питание дома организует привлечённый оператор — предприятие общественного питания, — для него требование п. 4 действует прямо (подп. 14 п. 56 распространяет требования на привлекаемые предприятия[9]; аутсорсинг — раздел 42).

Чек-лист перепривязки — приложение 39. Модель питания — выбор, пары, замены — не меняется: обе редакции правил её не ограничивают. Переходный месяц — крайний срок, а не передышка: то, что не перепривязано к 1 сентября, со 2 сентября становится уязвимостью.

18.11. Питание при карантине и ОРИ: выбор не отменяется

Вспышка острой респираторной инфекции или карантин отделения — типовой кризис ПНИ, и питание ломается в нём первым: столовая закрыта, персонал перераспределён, доставки ограничены. Методическая рамка для такой ситуации существует. В период COVID-19 Минтруд России выпускал методические рекомендации по работе стационарных организаций социального обслуживания, согласованные с санитарной логикой Роспотребнадзора: усиленный питьевой режим, отдельная посуда, дезинфекционный контур при раздаче в жилые комнаты[144]. Базовые методические рекомендации Минтруда по организации питания в учреждениях социального обслуживания требуют использовать лечебно-профилактические продукты, проводить профилактику витаминной недостаточности и обеспечивать санитарно-эпидемиологическую безопасность[145].

Принципы доклада в карантин переносятся с одной поправкой: **выбор не отменяется — меняется его форма**. В комнату приносят два варианта на подносе, а не устраивают вторую линию раздачи в коридоре. Житель видит обе порции (или картинки на двери), стандартный вариант есть всегда, журнал замен ведётся особенно тщательно: это снимает риск «в спешке забыли».

Температура горячего измеряется на последней выдаче в палате. Путь «мармит — коридор — комната» нарушает требование пункта 50 о соответствии температуры технологическим документам, если её не измерять[9]; к тому же блюдо, которое долго «ездит» по отделениям, рискует выйти за трёхчасовой предел пункта 32[9]. Для медицинских организаций правила при раздаче в отделения требуют специальных термоконтейнеров-тележек (п. 56 подп. 9)[9]; для СОСО это не прямая норма, но разумный ориентир.

Питьевой режим при ОРИ усиливается: тёплое питьё дают по графику (приложение 40). Витаминизация проводится по назначению врача. «План Б» (приложение 45) — холодный буфет, запас посуды, график по отделениям, ответ на вопрос «кто кормит, если не вышла кухня или не приехал аутсорсер» — окупается в первый же день закрытия столовой. Нагрузка на раздачу при этом вырастает кратно, и это нужно видеть в графике до вспышки, а не в восемь утра в день её начала.

Вспышки в учреждениях длительного ухода чаще бывают вирусными: в обзоре раздела 18.4 норовирус был самым частым возбудителем — 43 из 75 вспышек[140]. Это не респираторная инфекция, но логика та же: при вспышке кишечной инфекции контур раздачи в комнаты, раздельная посуда и тщательная гигиена рук раздающих становятся основным барьером.

Наконец, тот же поднос — повседневный маршрут лежачих и маломобильных жителей. Если выбор живёт только в столовой, одиннадцать процентов жителей в него не входят (раздел 20.11).

18.12. Чего мы пока не знаем

- Публичной статистики пищевых отравлений и вспышек кишечных инфекций именно в российских ДСО и ПНИ в ходе поиска не найдено; зарубежный обзор[140] описывает другие страны и период 1997–2007 годов.
- Прямой формулировки об отборе суточных проб на собственном пищеблоке СОСО (а не при получении готовых блюд) в прочитанном тексте СанПиН 4282-26 не найдено; позиция раздела 18.7 — толкование.
- Применимость общих пунктов СанПиН 4282-26, адресованных «предприятиям общественного питания» (ХАССП в п. 4, состав раздающих в п. 32), к пищеблокам СОСО с учётом позиции Верховного Суда[23] официально не разъяснена.
- Дел по ст. 6.6 КоАП, связанных именно с вариативным меню, в публичном поле нет; «данных нет» не означает «риска нет» (раздел 33).

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-c/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; по S003 (СанПиН 2.3/2.4.4282-26: пп. 2–4, 32, 50, 55, 56) и S011 (ст. 39, 43 Закона № 3185-1) в реестре добавлены результаты сверки текста.

Маркер	Источник
S062	Кодекс РФ об административных правонарушениях, ст. 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»
M-enteric_greig	Greig J.D., Lee M.B. Enteric outbreaks in long-term care facilities and recommendations for prevention: a review // Epidemiol Infect. 2009;137(2):145–155
S154	«Вспышка кишечной инфекции произошла в доме-интернате для ветеранов» // Петрозаводск говорит. 09.10.2024 (со ссылкой на Роспотребнадзор; реестр poisk-2026-10-dozakrytie)
S155	«Более 30 подопечных из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Мурманске госпитализированы...» // Би-Порт. 04.02.2025 (реестр poisk-2026-10-dozakrytie)
S156	Ковалев В.А. и др. Современные особенности норовирусной инфекции в городе Москве // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2017;94(6):32–37 (реестр poisk-2026-10-dozakrytie)

ЧАСТЬ 5

Меню, раздача, замер

разделы 19–22

19

Два варианта блюда: технология без второй кухни

С этой главы начинается практический блок доклада. Предыдущие разделы отвечали на вопросы «зачем» и «можно ли»; блок I.5 отвечает на вопрос «как». Он идёт по пути блюда: из котла (глава 19) на линию раздачи (глава 20), оттуда в журнал выбора (глава 21) и, наконец, в аудит, который проверяет, существует ли выбор на самом деле (глава 22). Глава 19 посвящена первому звену — тому, как кухня обычного дома готовит два варианта блюда, не превращаясь при этом в ресторан.

19.1. Идея в одном абзаце

Модели М1–М2 (раздел 8) не требуют второй кухни. Они требуют второго варианта **ключевого блюда** в том же технологическом потоке: каши А и Б варятся одновременно в двух котлах, вторые блюда А и Б готовятся из одной мясной заготовки двумя способами. Так в России уже работают. Болотнинский ПНИ предлагает выбор на завтрак и обед несколько раз в неделю[2]. Успенский ПНИ ежедневно готовит два вторых блюда, два салата и два напитка[3]. Иркутская модель предусматривает выбор из двух первых, двух вторых и гарниров[6]. Ни в одном из этих случаев выбор не потребовал отдельного цеха.

Справка. Технологический поток. На пищеблоке **потоком** называют последовательность операций, через которую проходит продукт: приёмка, хранение, первичная обработка, тепловая обработка, порционирование, раздача. Для каждой группы продуктов санитарные правила требуют своих зон и инвентаря, а поток не должен пересекаться встречными путями сырого и готового. Когда доклад говорит «в том же потоке», он имеет в виду, что второй вариант не требует новой зоны, нового оборудования или нового маршрута: он использует ту же печь, тот же котёл и ту же разделочную доску, что и первый.

19.2. Пары эквивалентов

Вариант Б не берут «с полки». Чтобы стать парой, блюдо должно пройти три фильтра. Первый — **норма**: вариант Б даёт ту же норму белка и круп по таблице замен, что и вариант А[11, 12]. Вторым — **поток**: он готовится на том же оборудовании (печь, котёл, доска). Третий — **спрос**: на него уже есть интерес, видный по журналам прошлых недель.

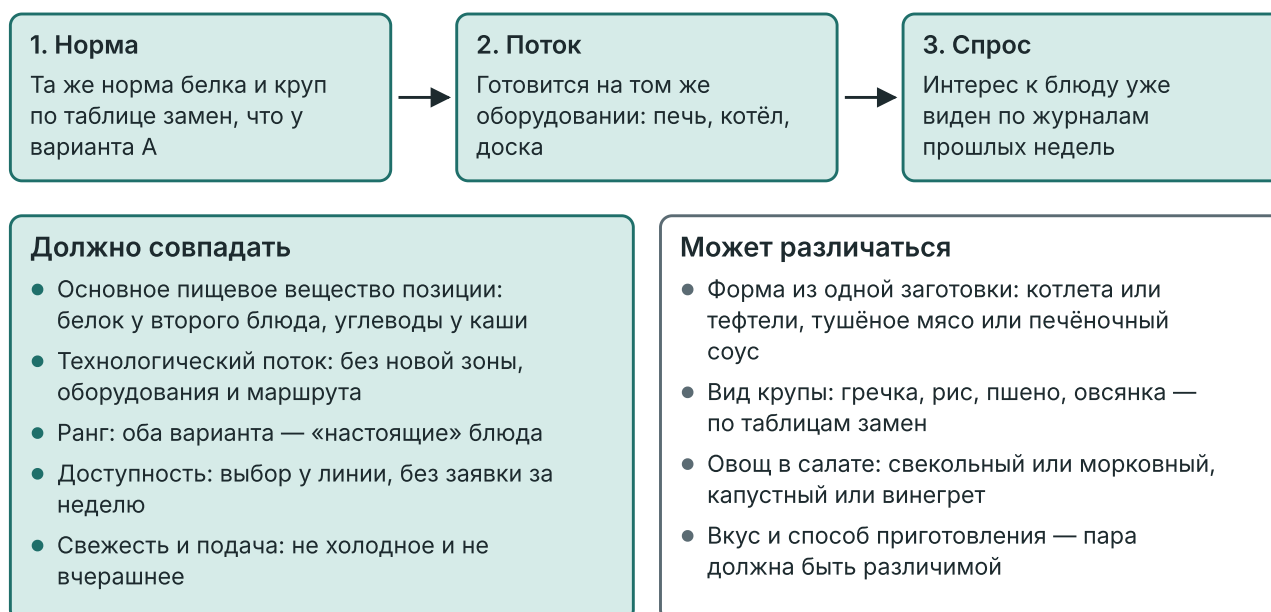
Справка. Таблица замены продуктов. Региональные нормы питания для организаций социального обслуживания, как правило, содержат таблицу, по которой один продукт заменяется другим в количестве, равноценном по основному пищевому веществу: например, мясо — рыбой или творогом по белку, одна крупа — другой по углеводам. Таблица задумана как способ выдержать норму при перебоих в поставках, но она же служит правовой основой вариативного меню: если вариант Б получен по таблице замен, рацион остаётся внутри утверждённых норм (раздел 17.2, п. 5).

Рабочие пары, проверенные практикой, выглядят так:

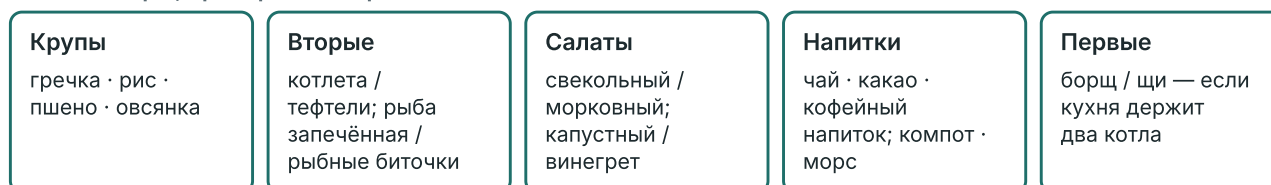
- **Крупы:** гречка, рис, пшено, овсянка взаимозаменяемы по таблицам.
- **Вторые блюда:** котлета или тефтели; тушёное мясо или печёночный соус; рыба запечённая или рыбные биточки. Во всех трёх случаях это одна заготовка и две формы.
- **Салаты:** свекольный или морковный; капустный или винегрет.
- **Напитки:** чай, какао или кофейный напиток, как в Болотнинском ПНИ[2]. Какао и кофейные напитки входят в кофеиновую строку пищевой карты, поскольку кофеин влияет на концентрацию клозапина (раздел 11).
- **Первые блюда:** борщ или щи; суп крупяной или суп овощной — если кухня готова держать два котла.

Одного в паре быть не должно: противопоставления «настоящее блюдо или то, что осталось». Такая пара разрушает равноценность вариантов (раздел 8.3) и за неделю убивает доверие к выбору. Другие формы мнимой пары разобраны в разделе 19.9.

Вариант Б становится парой варианту А, только если проходит три фильтра (раздел 19.2)



Рабочие пары, проверенные практикой



Какао и кофейный напиток — кофеиновая строка пищевой карты

Кофеин влияет на концентрацию клозапина (раздел 11): кому их можно, решает врач. Клинику кухня не назначает.

Что не является парой (раздел 19.9)

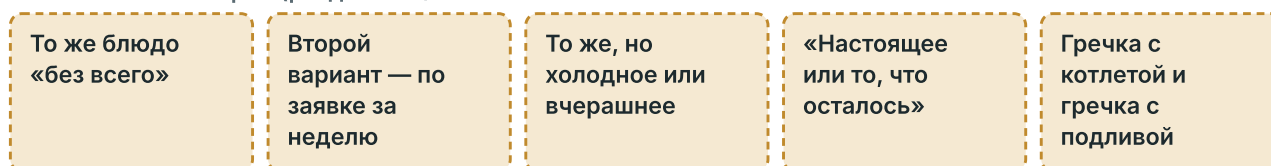


Рисунок 14. Пара эквивалентов: три фильтра для варианта Б, что в паре должно совпадать и что может различаться, рабочие пары и мнимые пары (разделы 19.2 и 19.9)[11, 12]

19.3. Точки выбора: с чего начинать

Практика начинает с завтрака и обеда[2], и с точки зрения кухни это верно: у каш и вторых блюд есть естественные пары, и они готовятся в одном потоке. Завтрак при этом спокойнее обеда: позиций меньше, и персонал учится без давки у линии. Поэтому разумная последовательность такова: сначала одна позиция (каша или второе блюдо), затем вторая, затем салаты и напитки. Итог первого года в Успенском ПНИ — два вторых, два салата и два напитка ежедневно[3].

Постепенность здесь не робость, а технология. Каждая новая точка выбора добавляет кухне одну операцию, раздаче — несколько секунд на человека, а журналу — одну графу. Если добавлять их по одной, сбой сразу видно и его легко локализовать. Если ввести всё одновременно, неудача в

одной точке обрушит доверие ко всей системе.

19.4. Объёмы: журнал заказа

Самый частый сбой вариативного меню — фраза «вариант Б закончился». Её причина почти никогда не в жителях, а в планировании, и механика планирования живёт в обычной тетради.

1. **Заказ накануне.** Вчерашний выбор (журнал, приложение 7) задаёт сегодняшнюю варку.
2. **Стартовая пропорция.** Пока статистики нет, готовят в пропорции 50 на 50 с резервом. Через два-три месяца предпочтения стабилизируются[3, 4].
3. **Пересчёт раз в две недели.** Доля выбравших вариант Б корректирует закупку. Остатки каждого варианта записывают отдельно. Как пересчёт объёмов переходит в пересмотр самого цикла меню, описано в разделах 21.3 и 21.9.
4. **Индикатор сбоя.** Доля тех, кто выбрал вариант Б и не получил его, должна стремиться к нулю. Если она растёт, виноваты объёмы, а не «непредсказуемые жители».

Для тех, кто выбирает невербально (раздел 15), заказ собирают по пищевым картам и по вчерашнему показу блюд. Тетрадь та же, меняется лишь источник сведений.

Заказ накануне и выбор у линии — не одно и то же. Здесь важно не смешать инструмент планирования с самим выбором. Канонический доклад определяет вариативность как наличие не менее двух вариантов **в момент еды** (раздел 8.1). Австралийская Комиссия по качеству и безопасности ухода, рассматривая организацию питания в домах престарелых, приходит к тому же: жителям «следует давать возможность выбирать блюдо в момент подачи или как можно ближе к нему»[146]. Другие слои корпуса допускают и заказ заранее — на сутки или на неделю (wiki/gaps.md, п. 6), и это расхождение не следует сглаживать. Для кухни из него вытекает практическое правило: заказ накануне служит прогнозом объёмов, но не закрепляет за жителем вчерашнее решение. Резерв в каждом варианте нужен именно для того, чтобы человек, передумавший у линии, получил то, что выбрал сегодня. Если резерва нет, предварительный заказ незаметно превращается в распределение пайков по вчерашнему списку.

19.5. Кто это делает: роли

Подтверждённая практикой схема такова: **перечень блюд для выбора формирует диетическая сестра**[2]. Это существенно: вариативность встроена в нормы, а не существует сбоку от них. Распределение ролей выглядит так. Диетическая сестра, а там, где её нет, заведующий хозяйством, отвечает за пары и раскладку. Повар готовит два варианта в одном потоке. Раздающие и сиделки предлагают выбор и ведут журнал. Старший смены контролирует, что вариант Б действительно существует (чек-лист, приложение 24). Руководитель утверждает положение о питании и ежемесячно рассматривает статистику.

Каждая роль здесь — это не новая должность, а новая строка в должностной инструкции. Инструктажи для каждой из них описаны в разделе 28.

19.6. Сколько это стоит: честная рамка

Вариативность не бесплатна, и доклад не утверждает обратного. Подробно экономика разобрана в разделе 29; здесь — только то, что относится к технологии двух вариантов.

Структура затрат такова. Сырьё при парных эквивалентах не растёт: происходит перераспределение внутри одной строки нормы. Растут другие статьи: время на линии (5–10 секунд на человека) и канцелярия (две тетради). Единоновременно могут понадобиться вторые гастрорёмкости и маркировка. Иллюстрация: в отделении на 30 человек второй вариант каши означает 3–4 кг другой крупы в сутки при том же суммарном расходе крупы. Это перераспределение, а не добавка. *Расчёт иллюстративный; до выводов обязателен замер (приложение 25).* Иначе говоря, два варианта — это вторая гастрорёмкость и тетрадь, а не вторая кухня. Поэтому подтверждённые кейсы стартовали в обычных домах без специальных бюджетов[2, 3, 4]. Возражение «нет денег» разобрано в разделе 37.

Справка. Гастрорёмкость и виды отходов. Гастрорёмкость — стандартный контейнер из нержавеющей стали для приготовления, хранения и раздачи блюд; её размеры задаются системой гастронорм (GN), поэтому ёмкость любого производителя встает в мармит и пароконвектомат. Вторая гастрорёмкость на линии — физическое воплощение второго варианта. **Отходы** в организации питания делят на **производственные** (очистки, обрезки, порченное при хранении, приготовленное сверх спроса) и **тарелочные** — то, что человек получил, но не съел. Тарелочные отходы говорят о вкусе, размере порции и состоянии едока, производственные — о качестве планирования.

Что известно об отходах и съеденном при выборе. Первая редакция ограничивалась осторожной формулой «перераспределение, не добавка». Зарубежные исследования позволяют сказать больше, но с существенными оговорками.

Самые измеримые данные получены в больницах. В австралийской государственной больнице переход от традиционной системы питания к модели «обслуживания в палату» (room service), при которой пациент сам заказывает блюдо по своему выбору, сопровождался ростом потребления энергии с 5 513 до 6 379 кДж в сутки и белка — с 53 до 74 г. Доля покрытия потребности в энергии выросла с 64 до 78 %, в белке — с 70 до 99 %. Тарелочные отходы сократились с 30 до 17 %, затраты на питание пациентов — на 28 % в год, а доля пациентов, оценивших питание как хорошее или очень хорошее, выросла с 75 до 98 %[147]. Обзор девяти исследований стратегий сокращения тарелочных отходов в больницах называет такую модель «идеальной стратегией» для этой цели[148]. Однако тот же обзор показывает, что не всякое расширение выбора даёт эффект. Электронный заказ у постели не изменил долю отходов (35,4 % против 34,3 %), хотя и увеличил потребление энергии и белка. Датское «меню свободного выбора» с круглосуточным заказом не изменило общую долю отходов, снизив её лишь на обеде (15,6 % против 26,1 %)[148].

Для домов длительного проживания данных гораздо меньше. Обзор 2026 года, посвящённый пищевым отходам в учреждениях длительного ухода, нашёл 33 источника (20 рецензируемых и 13 источников «серой» литературы). Чаще всего в них измеряли именно тарелочные отходы (14 исследований), а вмешательства, направленные на сокращение отходов, проводились лишь в трёх. Производственные отходы и порчу при хранении, по выводу авторов, изучают гораздо реже[149].

Как читать эти данные российскому дому? Во-первых, больничные модели заказа — это не «два варианта на линии»: пациент больницы находится там дни, а не годы, а меню и персонал устроены иначе. Перенос чисел на ДСО и ПНИ невозможен. Во-вторых, направление эффекта согласуется с логикой этой главы: когда человек получает то, что выбрал, он больше съедает и меньше оставляет. В-третьих, для домов длительного ухода это остаётся гипотезой, которую проверяет только собственный замер до и после введения выбора (приложение 25; раздел 29). Обещать учредителю экономию на отходах на основании зарубежных больничных данных нельзя.

19.8. Журнал замен: недооценённый документ

Журнал замен обычно считают второстепенным, и напрасно. Он единственный доказывает, что отказ от блюда обернулся альтернативой, а не голодом. Американская норма для домов престарелых, участвующих в федеральных программах, прямо требует предоставлять жителям, которые не хотят есть поданное или просят другое блюдо, «привлекательные варианты сходной пищевой ценности»[46]. По сути, эта норма описывает ту самую тетрадь: факт отказа, предложенную альтернативу и её равноценность.

Писать в журнал нужно в день события. Вечерние записи «по памяти» превращают журнал в художественный текст. Фиксируют не только то, чем заменили, но и то, принял ли человек замену. Серия замен одного и того же блюда у разных жителей — сигнал кухне о блюде, а не о жителях. Раз в месяц журнал замен читают вместе с журналом срывов. Срывы показывают, где система подводит жителя; замены — где житель отвергает то, что предлагает система. Это два разных ремонта, и путать их нельзя. Общая система журналов выбора описана в разделе 21, отказы — в разделе 12.

19.9. Что не является парой

Существуют три типичных антипримера. Первый: «второй вариант — то же блюдо без всего». Отказ от компонента — не выбор блюда. Второй: «второй вариант есть, но его нужно просить за неделю у заведующей». Выбор с барьером — декорация. Третий: «второй вариант — то же самое, но холодное или вчерашнее». Это недопустимо и санитарно, и этически. Вместе с противопоставлением «настоящее или что осталось» (раздел 19.2) все эти формы встречаются чаще, чем честное «у нас один вариант». Все их выявляет проверка реальности выбора (приложение 24, вопрос № 3); признаки фиктивной вариативности в целом разобраны в разделе 21.4.

19.10. Пары эквивалентов: строительный набор на месяц

Эквивалентность пары определяется по основному пищевому веществу позиции, а не по полному составу: для второго блюда это белок, для каши — углеводы крупы. Набор на месяц складывается из пар раздела 19.2 и двух дополнений. Первое — белковая линейка: котлета мясная, рыбная, из курицы, биточек. Фарш в сравнении с куском мяса уже сам по себе сервис для тех, кому трудно жевать; если же у человека назначена изменённая текстура, выбор переносится внутрь неё (раздел 10.10). Второе — напитки: компот, морс, чай.

Сверх списка действуют два правила. **Пара должна быть различимой.** Гречка с котлетой и гречка с подливой — это одно блюдо под двумя именами. **Оба элемента пары должны быть одного «ранга».** Пара «рыба или остатки вчерашнего» сортирует жителей по сортам, и жители считают такую ранговость сразу. Подтверждённая практика — две позиции второго блюда, два салата, два напитка[6] — укладывается в этот набор без всякой экзотики.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-d/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; для `I-cfr` в реестре записана сверка текста § 483.60(d).

Маркер	Источник
M-room_service_mccray	McCray S., Maunder K., Barsha L., Mackenzie-Shalders K. Room service in a public hospital improves nutritional intake and increases patient satisfaction while decreasing food waste and cost // J Hum Nutr Diet. 2018;31(6):734–741
M-platewaste_manimaran	Manimaran S. et al. Strategies to Reduce the Rate of Plate Waste in Hospitalized Patients: A Scoping Review // Nutrients. 2023;15(2):301
M-waste_roulston	Roulston M., Thompson C., Pelly F., Cave D. Food waste in residential aged care: A scoping review // Nutr Diet. 2026;83(1):56–73
I-acqsc_food_services	Aged Care Quality and Safety Commission (Австралия). Residential aged care food services: discussion paper (M. Wroth; без даты, не ранее 12.2022)

20

Точка раздачи: дизайн линии, очередь и помощь

Меню пишут в кабинете, а проверяют у линии раздачи. Именно там решается, станет ли выбор реальным действием жителя или останется строкой в положении. Эта глава о том, как устроить линию, стол и маршрут подачи так, чтобы два варианта блюда не превратились в пробку, а помощь тем, кто не может есть сам, приходила вовремя. Большая часть предложенного не требует денег: она требует расписания, расстановки людей и нескольких простых замеров.

Справка. Линия раздачи и «группа помощи». **Линией раздачи** в докладе называется участок, где готовое блюдо переходит из ёмкости пищеблока в тарелку жителя: прилавок, мармит, тележка с подогревом, раздаточное окно. **Группой помощи** мы называем жителей, которые не могут поесть без участия другого человека: одних нужно полностью кормить, другим достаточно нарезать, подать, напомнить, придержать посуду. В зарубежной литературе это различие передаётся словами *total assistance* (полная помощь) и *set-up / partial assistance* (подготовка и частичная помощь). Для расчёта штата различие принципиально: полностью кормимый занимает руки помощника на всё время приёма пищи.

20.1. Почему линия важнее меню

Вариативность живёт или умирает на трёх метрах линии. Здесь одновременно сходятся очередь, выбор, помощь кормимым, температура блюда и неизбежный вопрос «почему ему больше». Меню может быть безупречным, но если линия настроена только на скорость, выбор превращается в давление («быстрее, за вами люди»), а помощь — в ожидание над остывающей тарелкой.

Удобно разбирать линию по четырём элементам: **поток** (как люди и тарелки движутся), **подача помощи** (кто и когда кормит тех, кто не ест сам), **видимость порций** (как раздача выглядит со стороны жителя) и **атмосфера** (что человек слышит, видит и чувствует, пока ест). Каждому элементу посвящены разделы ниже; поток разобран в двух местах — сначала принцип (20.2), затем инженерия очереди и её замер (20.10).

Насколько это не умозрительно, показывает внешний аудит. В 2019 году Генеральный аудитор канадской провинции Онтарио провёл проверку питания в домах долговременного ухода, включавшую внезапные визиты в часы еды в 54 дома. Среди наблюдений — шестнадцать эпизодов, когда жителю приходилось ждать помощи; в одном из описанных случаев житель «съел лишь два кусочка и ждал, когда персонал вернётся его кормить». В среднем при 13 % приёмов пищи на месте не было полного состава персонала, а в одном доме — при 39 %. Утром жители ждали в столовой в среднем 43 минуты, в обед — 29, вечером — 24 минуты^[150]. Онтарио — провинция с подробным регламентом и инспекцией, и всё же сбой оказался не в нормах, а именно на линии и у стола. Переносить эти числа на российские дома нельзя: другой контингент, другой штат, другие здания. Но механизм сбоя тот же, и искать его стоит там же.

20.2. Поток: как не создать пробку

Опасение «выбор устроит очередь» имеет под собой простую арифметику. По нашей рабочей оценке (это оценка, а не замер), два варианта добавляют к выдаче 5–10 секунд на человека. На отделении в 30 человек это 150–300 секунд, то есть от двух с половиной до пяти минут на приём пищи. Много это или мало, зависит не от выбора как такового, а от того, в какой момент и как он делается. Четыре решения снимают большую часть задержки.

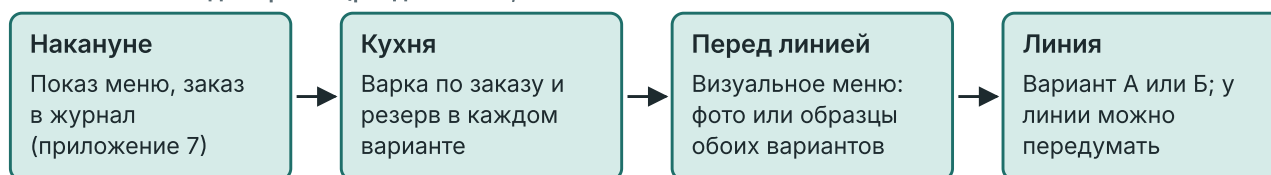
Предварительный заказ. Выбор фиксируют накануне в журнале заказа (раздел 21.2; форма — приложение 7). На линии остаётся выдача по списку, а решение при этом ещё можно изменить. Время раздачи почти не растёт, потому что пауза «что взять?» перенесена из очереди в спокойный разговор накануне. Так устроены российские внедрения, о которых есть публичные сведения[2, 3]; подробности практик — в разделе 25. У предзаказа есть и цена: житель выбирает за сутки, а голоден сейчас. Больничные исследования электронного заказа у постели показывают, что сокращение разрыва между заказом и едой связано с ростом потребления и снижением отходов, но доказательная база узкая: систематический обзор нашёл всего пять исследований с 720 пациентами, разнородных по дизайну, и выводы сделаны описательно[151]. Для дома это довод в пользу правила «накануне заказали, у линии можно передумать», а не в пользу жёсткого списка.

Визуальное меню. Фотографии или выставленные образцы обоих вариантов до начала линии снимают паузу «что там?» и одновременно помогают тем, кто выбирает без слов (раздел 15).

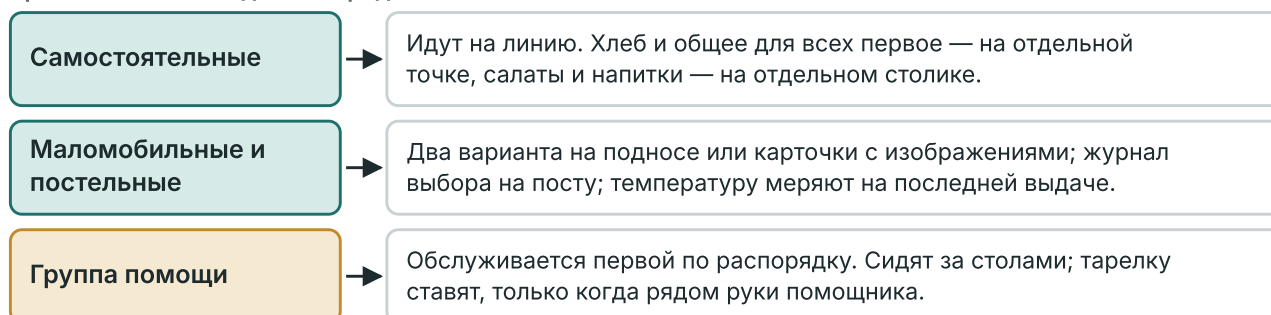
Разнесение потоков. Самостоятельные жители идут на линию. Маломобильные получают выбор в жилой зоне по журналу. Кормимые сидят за столами, и еда приходит к ним. Три потока в одной очереди — конструктивная ошибка большинства столовых: самый медленный поток задаёт скорость всем остальным.

Две точки выдачи. Хлеб и единое для всех первое блюдо выдаются отдельно от позиций с выбором. Тогда выбор не задерживает тех, кому выбирать в этой позиции нечего.

Поток: от заказа до тарелки (разделы 20.2, 20.10)



Три потока — не в одной очереди



Стол группы помощи (раздел 20.8)



Не более двух полностью кормимых на одного помогающего

Ориентир Онтарิโอ, не российская норма; при недостижимости — фактическое число письменно учредителю

Два жителя с дисфагическим риском — не к одному помогающему

Каждый требует полного внимания в момент глотка; текстуры и уровень риска назначает врач

Посуда, порция, разговор

Глубокие тарелки с бортиком, нескользящие подставки, удобные ложки; средняя порция с добавкой; с едоком говорят с едоком

Два бесплатных замера — при запуске и затем ежеквартально (раздел 20.6)

Температурная дельта

Одно блюдо: первый и последний обслуживаемый стол. Падение больше 10–15 °C — перестроить поток.

Время еды самого медленного

Меньше 15 минут — человека, скорее всего, торопят: это прямой риск аспирации (раздел 10).

Рисунок 15. Линия раздачи: поток от заказа до тарелки, три потока вместо одной очереди, устройство стола группы помощи и два бесплатных замера (разделы 20.2–20.10)[27]

20.3. Подача помощи: еда — под готовые руки

Самое важное правило линии формулируется в одну строку: **тарелку ставят перед человеком, который не может есть сам, только тогда, когда рядом есть тот, кто ему поможет.** Тарелка, остывающая перед беспомощным человеком, унижает его, а спешка, с которой её потом «докармливают», повышает риск аспирации (раздел 10).

Международный ориентир, который мы используем, взят из регламента провинции Онтарио к закону о долговременном уходе: один работник помогает одновременно не более чем двум полностью кормимым жителям, и еду не подают, пока помощь недоступна[27]. Это не российское требование, а пример того, как другая юрисдикция превратила здравый смысл в норму. Отметим и то, что даже при такой норме внешний аудит Онтарио регулярно фиксировал ожидание помощи (раздел 20.1)[150]: норма без расстановки людей на смене сама по себе не работает.

Почему именно двое? Ответ даёт хронометраж. В американском контролируемом исследовании в четырёх домах сестринского ухода помощь в еде по протоколу занимала в среднем 42 минуты на одного человека за один приём пищи, тогда как при обычной практике на человека приходилось около пяти минут. Протокольная помощь увеличивала потребление пищи и удерживала массу тела у жителей с риском похудения, а в контрольной группе люди продолжали худеть[25]. Если на основной приём пищи отведён час, а одного человека бережно кормят сорок минут, то два кормимых на одного помощника — это уже предел, а не запас. Это американские данные с другим контингентом и штатом, и норматив для российского ПНИ из них не выводится; тот же расчёт с другой стороны разобран в разделе 5. Но порядок величин показывает, что «покормили» и «помогли поесть» различаются по времени в разы, и разницу персонал обычно покрывает скоростью.

В российских нормах соотношение помогающих и кормимых не закреплено. На реальной смене оно часто далеко от 1:2: в кейсе раздела 5 четыре сиделки приходятся на двенадцать кормимых, то есть 1:3. Без новых ставок можно сделать четыре вещи.

1. **Все руки на час еды.** На основные приёмы пищи к столам выходит вся смена, включая тех, чья основная работа в это время — уборка или документы. Это оформляется приказом и распоряжением, а не остаётся на доброй воле.
2. **Рассадка по помощи.** Кормимых рассаживают по двое у каждого помощника, и подают блюда по готовности рук, а не по очерёдности тарелок с кухни.
3. **Волонтёры и социальные работники дневных отделений** выходят в часы еды там, где это возможно и где они обучены безопасному кормлению.
4. **Честный расчёт дефицита.** Если соотношение 1:2 недостижимо, фактическое число фиксируют и письменно выносят учредителю (раздел 38). Молчаливый дефицит — личный риск директора. Зафиксированный дефицит становится предметом решения учредителя.

20.4. Видимость порций: «почему ему больше»

Выбор делает раздачу прозрачной. Пока всем клали одно и то же, неравенство порций было невидимо; когда житель сам указывает на блюдо, он впервые видит и соседскую тарелку. Отсюда типовой сбой внедрения: конфликт «почему ему больше». Важно понимать его природу: конфликт рождает не выбор, а неравенство, которое выбор сделал заметным. Лечится он прозрачностью.

Работают три меры. **Порционные ложки и мерки на виду**, чтобы порция определялась инструментом, а не рукой раздающего. **Нормы граммов у линии** — табличка вида «котлета — 75 г, гарнир — 200 г». **Объявленные правила добавки**, например «после того как выдано всем,

добавка из остатка — по желанию». Когда правило известно заранее, добавка перестаёт быть привилегией тех, кого раздающий знает лучше.

20.5. Атмосфера: раздача как сервис, а не как раздача

Зарубежные стандарты описывают приём пищи как услугу, а не как технологическую операцию. Немецкий стандарт качества ожидает, что сотрудники кухни выходят к едокам и проводят дегустации[35]. Финские рекомендации по питанию пожилых советуют персоналу садиться за общий стол[40]. Австралийский стандарт качества ухода формулирует право жителя от первого лица: «я выбираю, что, когда, где и как я ем»[45]. Все три документа относятся к своим системам ухода и для российских организаций не обязательны, но направление в них одно.

Минимум, не требующий затрат, состоит из трёх привычек. Раздающий называет варианты вслух («гречка или рис?»), а не молча черпает привычное. Жителю дают три–пять секунд на ответ без давления очереди; эту возможность и создаёт предварительный заказ (раздел 20.2). Жалобу у линии принимают как данные и записывают в журнал, а не «гасят» (раздел 21.5). Бесплатные элементы обстановки зала разобраны отдельно в разделе 20.9.

20.6. Температура и время на еду

Два замера делают один раз при запуске, а затем ежеквартально в составе панели показателей (раздел 22.4).

Температурная дельта. Температуру одного и того же блюда измеряют на первом и на последнем обслуживаемом столе. Если падение превышает 10–15 °С, поток нужно перестраивать: менять порядок обслуживания отделений, подавать к последним столам из отдельной ёмкости, сокращать путь тележки. Санитарные требования к температуре горячих блюд при раздаче — предмет раздела 18; здесь речь об управленческом сигнале, а не о санитарной норме.

Время на еду. Засекают, сколько ест самый медленный человек из группы помощи. Если меньше пятнадцати минут, его, скорее всего, торопят, а это прямой риск аспирации (раздел 10). Сопоставление с хронометражем из раздела 20.3 (около сорока минут на протокольную помощь в зарубежном исследовании) показывает, насколько далеко от «пятнадцати минут» лежит бережное кормление.

Оба замера бесплатны, и оба превращают фразу «у нас всё нормально» в числа, с которыми можно работать.

Подведём промежуточный итог. Линия проверяет вариативность каждый день. Элементы разделов 20.2–20.4, два квартальных замера и маршрут для тех, кто на линию не выходит (раздел 20.11), не требуют денег. Именно здесь жители впервые ощущают разницу между «накормить» и «обслужить».

20.8. Стол для группы помощи: микроустройство

Устройство стола решает половину задачи кормления. Несколько правил проверены практикой и здравым смыслом; доказательная сила у них разная, и это стоит иметь в виду.

Где садится помогающий. Между двумя жителями и на уровне их глаз, а не напротив одного и не стоя над ним. Так он видит лицо и горло каждого и может вовремя остановиться.

Кого не сажать вместе. Жителей с дисфагическим риском не размещают за одним помогающим: каждый требует полного внимания в момент плотка.

Посуда. Глубокие тарелки с бортиком, нескользящие подставки, ложки с утолщённой или изогнутой ручкой. Адаптивная посуда возвращает человеку часть самостоятельности, а каждый житель, который смог есть сам, освобождает минуты помощи для другого.

Порции. Средняя порция с возможностью добавки лучше большой: большая порция деморализует едока и подталкивает помогающего торопиться.

Разговор. Самый частый дефект — помогающий обсуждает свои дела с коллегой через голову едока. Самый дешёвый ремонт описывается одной фразой: с едоком говорят с едоком.

Честная оговорка о доказательствах. Систематический обзор EDWINA (2016), посвящённый косвенным способам поддержать питание людей с деменцией, нашёл по разделу «обстановка столовой и способ подачи» семнадцать вмешательств в пятнадцати исследованиях, и ни одно не было рандомизированным. Контрастная посуда в одном исследовании увеличила потребление жидкости, но не пищи; результаты по освещению противоречивы. Обучение персонала с трёхмесячным сопровождением в одном нерандомизированном исследовании сопровождалось прибавкой массы тела^[152]. Авторы обзора заключают: «мы не нашли окончательных доказательств ни эффективности, ни неэффективности конкретных вмешательств», поскольку исследования «малы и краткосрочны». Вывод для дома: правила стола из этого раздела — разумная практика, а не доказанная терапия. Их стоит вводить потому, что они безопасны, дешёвы и уважительны, и проверять по собственным замерам (раздел 22), а не обещать учредителю измеримого эффекта.

20.9. Атмосфера: бесплатные элементы, которые зал замечает первыми

Американские программы преобразования среды ухода — Pioneer Network, Eden Alternative, Green House^[48, 153, 154] — сходятся в одном: обед оценивают по атмосфере раньше, чем по меню.

Справка. Движение за смену культуры ухода. Под этим названием (*culture change*) в США с 1990-х годов объединяют программы, которые стремятся превратить дом сестринского ухода из «маленькой больницы» в жилой дом. **Pioneer Network** продвигает «домашний» формат питания (*home-style dining*): еда в общих блюдах, выбор за столом, приготовление на виду. **Eden Alternative** строит работу на десяти принципах борьбы с одиночеством, беспомощностью и скукой. **Green House** — модель малых домов на 10–12 человек с общей кухней. Для российских ДСО и ПНИ это не стандарт, а набор идей, часть которых ничего не стоит.

Элементы нулевой стоимости таковы: скатерти и салфетки вместо голого пластика; еда стоит на столах к моменту, когда люди садятся; персонал не стоит полукругом «над» едящими; в часы еды не гремят тележки; освещение рабочее, а не казённое верхнее. Вместе они отличают столовую от раздаточной.

Доказательная база здесь та же, что в разделе 20.8, и такая же скромная. В обзоре EDWINA «семейный» формат питания в одном небольшом нерандомизированном исследовании (18 жителей с тяжёлой деменцией) сопровождался большей прибавкой массы тела через три месяца, а подача из общих ёмкостей с обслуживанием за столом в двух исследованиях повышала потребление энергии и белка, хотя масса тела не менялась^[152]. Всё это данные о людях с деменцией в зарубежных учреждениях; на российский ПНИ они переносятся как гипотеза, а не как обещание.

Проверка для директора проста: сфотографируйте свой зал в часы обеда и положите снимок рядом с фотографией обычной домашней кухни. Разница на снимках — программа работы на квартал.

20.10. Поток: инженерия очереди за один обед

Раздел 20.2 объяснил, откуда берётся задержка. Здесь — как её убрать и как доказать, что убрали. Очередь с выбором — задача организации потока, а не терпения жителей. Решения расположены от дешёвого к дорогому.

1. **Предзаказ** (раздел 20.2) — переносит выбор из очереди во вчерашний день.
2. **Визуальное меню до линии.** Очередь создаёт не сам выбор, а пауза «что брать»; образцы перед линией снимают её.
3. **Разведение точек.** Салаты и напитки выносят на отдельный столик, чтобы основная линия занималась только горячим.
4. **Очерёдность отделений.** Группа помощи обслуживается первой, и этот порядок закреплён в распорядке дня, а не решается каждый раз заново.
5. **Вторая точка выдачи,** если позволяет помещение.

Эффект измеряют одним числом: временем от первой до последней выданной тарелки до изменений и после них. Фраза «выбор добавил четыре минуты к обеду» — факт, с которым можно работать. Фраза «выбор создал хаос» обычно означает, что ни одно из пяти решений не было применено.

20.11. Выбор вне линии: постельные и поднос

По данным исследования проекта «Если быть точным», 11 % жителей российских ПНИ находятся на постоянном постельном режиме^[7]; маломобильных, которые не могут сами дойти до линии, по-видимому, больше, но их доля отдельно не публикуется (раздел 23.2). Если вариативность живёт только на линии, она становится привилегией ходячих.

Для этой группы выбор выглядит как **два варианта на подносе**, а не вторая очередь в коридоре. Житель видит обе порции или карточки с изображениями на двери комнаты и показывает, что хочет; стандартный вариант всегда есть; журнал выбора ведётся на посту. Температуру до комнаты сохраняют средствами, предусмотренными технологическими документами

(термоконтейнеры, тележки с подогревом), и замеряют на последней выдаче, а не только на линии. Та же логика применяется при карантине и острых респираторных инфекциях: раздел 18.11 и приложение 45.

Помощь приходит вместе с едой, а не после неё (раздел 20.3). Проверка для постельных та же, что для ходячих: был ли вчера реальный второй вариант — на подносе, а не в положении.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре raw/sources/poisk-2026-10-blok-e/istochniki.md. Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
I-onaudit2019	Office of the Auditor General of Ontario. Annual Report 2019, Vol. 1, ch. 3.05: Food and Nutrition in Long-Term-Care Homes (value-for-money audit)
M-feedassist_simmons	Simmons S.F. et al. Prevention of unintentional weight loss in nursing home residents: a controlled trial of feeding assistance // J Am Geriatr Soc. 2008;56(8):1466–1473 (маркер общий с новой редакцией гл. 5)
M-dementia_edwina	Bunn D.K. et al. Effectiveness of interventions to indirectly support food and drink intake in people with dementia: EDWINA systematic review // BMC Geriatr. 2016;16:89
M-bedside_order_mackenzie	MacKenzie-Shalders K. et al. Impact of electronic bedside meal ordering systems on dietary intake, patient satisfaction, plate waste and costs: a systematic literature review // Nutr Diet. 2020;77(1):103–111

21

Когда выбор изменился: журнал, пересчёт и «фиктивная вариативность»

21.1. Тема раздела

Выбор жителя не константа. Он меняется вместе с состоянием здоровья, временем года, сменой лекарств и просто с течением жизни. Система, которая однажды записала предпочтения при поступлении и больше никогда не спрашивала, через год кормит человека, которого уже нет. Этот раздел о трёх вещах: как выбор отслеживают, как по нему пересчитывают объёмы и меню и как отличить живую вариативность от декорации.

Насколько быстро меняются предпочтения, известно не так плохо, как кажется, и картина интереснее простого «всё меняется». В американском исследовании 255 жителей 28 домов сестринского ухода дважды, с интервалом в три месяца, отвечали на вопросы о 72 повседневных предпочтениях по опроснику PELI. Точное совпадение ответов составило в среднем лишь 59 %, а совпадение по грубому делению «важно — не важно» — 82 %; 68 из 72 предпочтений сохраняли устойчивость не ниже 70 %[123]. Годовое наблюдение 161 жителя той же исследовательской группы показало, что по 91 % пунктов о досуге оценка важности у большинства не менялась[155].

Справка. Что такое PELI. *Preferences for Everyday Living Inventory* («Перечень повседневных предпочтений») — американский опросник, которым жителя дома ухода спрашивают, насколько для него важны конкретные стороны повседневной жизни: распорядок, уход, досуг, общение и другие. Для домов сестринского ухода существует отдельная версия (PELI-NH). Опросник не создавался для людей с тяжёлыми психическими расстройствами и интеллектуальной недостаточностью и на русском языке, насколько нам известно, не валидирован.

Что из этого следует для дома? Главное устойчиво: человек, для которого важно выбирать еду, через три месяца и через год, скорее всего, по-прежнему этого хочет. Меняется частное: какие блюда, в каком порядке, насколько сильно. Значит, разовый опрос при поступлении нужен, но недостаточен, а детали выбора надо отслеживать непрерывно, по журналу. Перенос американских данных на российский ПНИ остаётся толкованием: исследования проводились с жителями, способными пройти интервью, а значительная часть наших жителей выбирает без слов (раздел 15).

21.2. Три регистра данных о выборе

Данные о выборе собираются в трёх разных регистрах. У каждого свой горизонт, свой владелец и своя функция, и смешивать их не следует.

Журнал заказа (оперативный). Вчерашний выбор определяет сегодняшние объёмы (раздел 19.4). Горизонт — сутки. Владельцы — раздача и кухня. Форма — приложение 7. Без этой тетради объём варианта Б угадывают, и фраза «закончился» становится нормой.

Журнал потребления (клинический). В нём отмечают, что съедено: полная порция, половина, не тронута. Ведут его для группы риска и на период внедрения (раздел 9.3). Горизонт — неделя. Владельцы — сиделки и врач. Функция — увидеть отказы, признаки дисфагии и «нелюбимые блюда» раньше, чем они превратятся в потерю массы тела и пневмонию. Клиническую оценку по этим записям даёт врач, а не кухня. Британский инструмент скрининга недостаточности питания MUST, к слову, при среднем риске рекомендует именно такой учёт: документировать потребление пищи в течение трёх дней, а в домах ухода повторять скрининг не реже раза в месяц^[106] (подробнее — раздел 22.4).

Статистика выбора (управленческая). Это доли вариантов А и Б по позициям и неделям, блюда — лидеры остатков и доля случаев «выбрал Б — не получил Б». Горизонт — месяц. Владельцы — диетсестра и руководитель. Функция — править объёмы, цикл и закупки. В публикации Усть-Илимского дома социального обслуживания такая работа описана как «группировка блюд по популярности»^[4].

Четвёртый источник данных — прямой разговор с жителями — разобран в разделе 21.5.

21.3. Пересчёт объёмов и цикла

Статистика выбора работает на двух скоростях. **Каждые две недели** доли выбора корректируют варку: сколько готовить варианта А и сколько Б. **Каждый цикл** статистика корректирует сам цикл: блюдо-аутсайдер по остаткам заменяют по таблице замен, и это закономерно и безболезненно, потому что таблица замен — часть региональных норм (раздел 24.2)^[11, 12]. Рабочий порядок такого пересчёта по неделям описан в разделе 21.9.

Отдельный вопрос — длина цикла. Международные ориентиры длиннее наших: в Онтарио ориентир — 21 день, в немецком стандарте — четыре недели, тогда как типовой российский цикл составляет 14 дней^[27, 34]. Российский четырнадцатидневный цикл — законный минимум, а не эталон. Удлинение цикла — самая дешёвая форма разнообразия: те же продукты, те же нормы, но реже повторяющиеся блюда. Различие между циклом меню и вариативностью как таковой — раздел 8.1.

Важно и то, на каком горизонте принимать решения. Статистика стабилизируется за два–три месяца, поэтому решения принимают по месячным данным, а не по отдельному эпизоду. «Вчера все взяли гречку» — не основание менять пропорции. «За четыре недели рис берут втрое чаще» — основание.

Справка. Почему один день ничего не доказывает. Доля выбора за один день — случайная величина: на неё влияют погода, настроение, отсутствие нескольких жителей, вкус конкретной партии. Чем меньше отделение, тем сильнее случайные колебания. На отделении в 30 человек разница «18 против 12» вполне может возникнуть случайно, а та же пропорция, устойчиво державшаяся четыре недели (это несколько сотен выборов), уже говорит о предпочтении. Отсюда правило: решения — по накопленным данным, не по впечатлению от одного обеда.

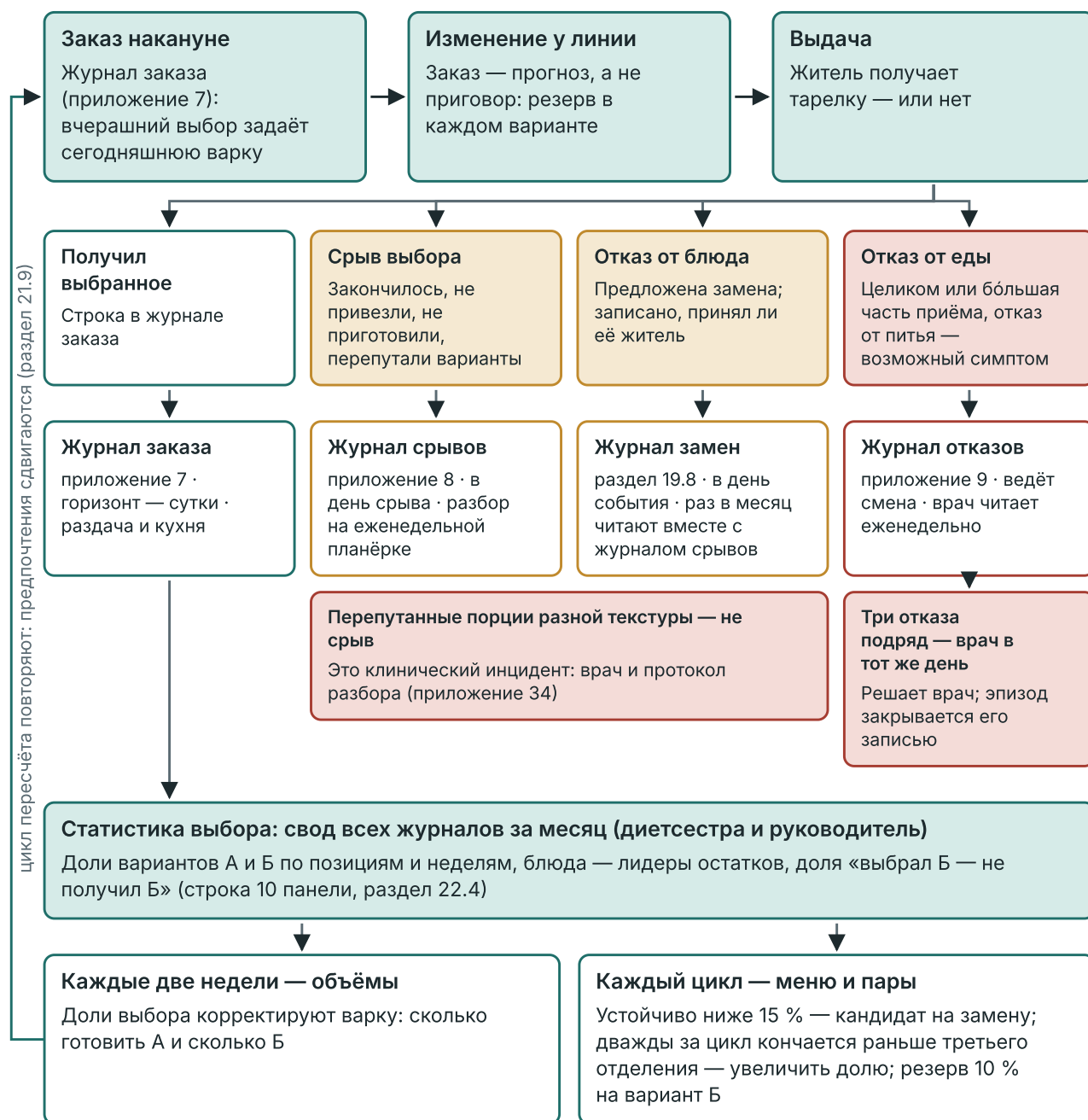


Рисунок 16. Журналы выбора как замкнутый цикл: каждый исход выдачи попадает в свой журнал, журналы сводятся в месячную статистику, статистика правит варку и меню (разделы 21.2, 21.3, 21.9)

21.4. Фиктивная вариативность: пять признаков

Фиктивной мы называем вариативность, которая существует в документах, но не на столе. Пять признаков служат чек-листом и для самопроверки, и для критического чтения чужих презентаций. Полевые приметы, по которым их распознают за один визит, собраны в разделе 21.8.

1. «Вариант Б заканчивается через десять минут». Объём занижен. Индикатор — доля нереализованного выбора Б.

2. **«Все выбирают А».** Либо вариант Б непривлекателен (это видно по остаткам), либо выбор формален: варианты не показывают, на ответ не дают времени.
3. **«Выбор есть в положении, но не на линии».** Документ без процедуры. Выявляется одним визитом в часы еды.
4. **«За жителя выбирает персонал».** Журнал заполняют «по привычке», не задавая вопроса; невербальным жителям варианты не показывают (раздел 15).
5. **«Статистика ни на что не влияет».** Данные собирают, но объёмы и цикл не меняются.

Каждый признак снимается конкретным действием из разделов 19–20. Фиктивность — диагноз, а не приговор.

Признаки сходятся с зарубежным опытом аудита. Проверка Генерального аудитора Онтарио 2019 года отметила, что министерство не требует от домов отчитываться какими-либо показателями питания, и на уровне провинции фактическая работа столовой оставалась невидимой^[150]. Там, где питание не измеряется, разрыв между документом и тарелкой не обнаруживается никем, пока его не увидит внешний наблюдатель (раздел 22).

21.5. Обратная связь жителей: от статистики к разговору

Статистика отвечает на вопрос «что», но не на вопрос «почему». Поэтому к трём регистрам раздела 21.2 нужен четвёртый канал — прямой разговор с жителями. Его формы известны: ящик пожеланий, обсуждение меню на совете жителей (в Онтарио и в шведском кейсе Tallgläntan совет жителей рассматривает меню каждый цикл^[27, 156]), дегустации с голосованием^[35]. Минимальная частота — раз в цикл. Устройство совета жителей описано в разделе 34 и приложении 30; как подавать совету числа — в разделе 21.7.

Канал жив, только пока он меняет меню. Если пожелания не приводят ни к чему, канал умирает за полгода. Поэтому на каждое пожелание на следующем заседании дают ответ: принято или нет, и по какой причине. Немецкий стандарт требует документированной системы жалоб со сроками ответа^[34]; для российского дома это одна строка в регламенте.

Выбор, подкреплённый реальным разнообразием, имеет и измеримую сторону. В американском рандомизированном исследовании в пяти домах сестринского ухода жителям, которым были назначены пищевые добавки, дважды в день между приёмами пищи предлагали либо жидкую питательную смесь, либо перекус на выбор из нескольких вариантов — с помощью персонала. Обе схемы увеличили потребление энергии по сравнению с обычным уходом: смесь — в среднем на 265 ккал в сутки, перекусы — на 303 ккал; значимого влияния на массу тела за 24 недели не выявлено^[157]. Это не исследование вариативного меню как такового: эффект в нём неотделим от помощи персонала. Но оно показывает, что предложение «на выбор и с участием человека» не уступает стандартной добавке.

Четыре источника данных и совет жителей ведутся в тетрадах, а не в специальной программе. В итоге у директора есть что положить на стол учредителю и проверяющему: доли выбора, протокол пересчёта, решения совета (раздел 32).

21.7. Данные для совета жителей: как показывать числа

Статистика выбора — рабочий материал совета жителей (раздел 34). Чтобы числа стали предметом обсуждения, а не отчётом, их подают по трём правилам.

Одна цифра — один вывод. Например: «выбирают 6 из 10 — значит, меню нужно показывать ещё четверым».

Никаких процентов без абсолютных чисел. «Двенадцать человек» понятнее, чем «сорок процентов».

Каждая цифра заканчивается вопросом к залу. «Почему рыбу выбирают чаще курицы?»

Совет, обсуждающий собственные данные, — это уже соуправление, а не формальность. Протоколы таких заседаний убеждают проверяющего быстрее любых положений.

21.8. Пять признаков фиктивной вариативности: полевые приметы

Признаки раздела 21.4 сформулированы как диагнозы. Здесь — как их увидеть в поле за один визит.

- **Журнал заказа заполнен одним почерком и одной ручкой** за всю неделю: записи сделаны задним числом, а не в момент выбора.
- **Доля «стандартных» вариантов выше 90 %** без объяснения причин.
- **На вопрос «что вы выбрали вчера?» житель отвечает «не знаю».**
- **Второй вариант к приходу проверяющего «уже закончился»**, при этом журнал срывов пуст.
- **Выбор есть только на завтрак и только между кашами**, хотя положение обещает «полную вариативность».

Один признак ещё может оказаться невинным. Два и больше означают, что система фиктивна, и разговор нужно вести о перезапуске, а не о «развитии» (кейс 12).

21.9. Пересчёт меню по статистике: рабочий цикл

Раздел 21.3 сформулировал принципы пересчёта; здесь — порядок работы в четырёхнедельном цикле.

Неделя 4 месяца: итоги. По журналу заказа подводят фактические пропорции по каждой позиции — например, 62/38 вместо заложенных 50/50.

Объёмы следующего цикла. Их планируют по фактическим долям с резервом 10 % на вариант Б.

Кандидаты на замену. Позиции, устойчивая доля которых ниже 15 %, — кандидаты на замену. Это не «плохие» блюда; они просто не выбираются этим составом жителей. Замену выносят на дегустацию совета (раздел 34).

Кандидаты на увеличение доли. Позиции, которые дважды за цикл заканчиваются раньше, чем их получит третье отделение, — кандидаты на увеличение доли (журнал срывов, приложение 8).

На всё это уходит около двух часов в месяц у диетсестры или заведующего производством. Честный результат почти всегда одинаков: через 6–8 недель пропорции стабилизируются, эффект новизны проходит, и у дома впервые появляется измеренная карта вкусов его жителей. Эта карта не вечна: как показывают исследования раздела 21.1, частные предпочтения сдвигаются, поэтому цикл пересчёта не завершают, а повторяют.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-e/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-pref_abbott	Abbott K.M. et al. The Change in Nursing Home Residents' Preferences Over Time // J Am Med Dir Assoc. 2018;19(12):1092–1098
M-pref_heid	Heid A.R. et al. The stability of nursing home residents' ratings of importance of recreation preferences over one year // J Appl Gerontol. 2022;41(8):1942–1951
M-snack_simmons	Simmons S.F. et al. Cost-effectiveness of Nutrition Intervention in Long-Term Care // J Am Geriatr Soc. 2015. DOI 10.1111/jgs.13709
I-onaudit2019	Office of the Auditor General of Ontario. Annual Report 2019, Vol. 1, ch. 3.05: Food and Nutrition in Long-Term-Care Homes

22

Как проверить реальность питания: аудит и замеры

22.1. Принцип: измеряй факт, а не документ

Всё, что дальше в докладе говорится о пилоте, финансах и ответственности, стоит на данных. Дом, который себя не измерил, не докажет эффекта, не защитится на проверке и не поймёт, что чинить в первую очередь. Поэтому эта глава предлагает три инструмента разной глубины: экспресс-аудит за один день, семидневный замер отходов и потребления и квартальную панель показателей директора. Общий принцип у них один: измеряют факт — температуру на последнем столе, остаток на тарелке, интервал между ужином и завтраком в часах, — а не запись о факте.

Почему именно факт, хорошо видно на чужом опыте. Генеральный аудитор Онтарио в 2019 году отметил, что профильное министерство провинции «не требует от домов долговременного ухода отчитываться показателями, связанными с едой и питанием»; среди показателей, которых не было, названы доля жителей с высоким риском недостаточности питания и соотношение персонала и жителей, нуждающихся в помощи при еде. Аудиторы же, побывавшие в часы еды в 54 домах, увидели то, чего документы не показывали: ожидание помощи, нехватку персонала на смене, недоеденные тарелки^[150]. Это канадские дома и канадская система надзора, но урок универсален: если питание не измеряется, разрыв между бумагой и тарелкой остаётся невидимым.

Справка. Аудит и обратная связь. В исследованиях качества помощи *аудитом и обратной связью* (*audit and feedback*) называют процедуру, при которой работу измеряют по заранее заданным показателям, а результат возвращают тем, кто её делает. Кокрейновский обзор, обновлённый в 2026 году и охвативший 292 исследования (в основном с участием врачей, режиссёров и фармацевтов), показал, что такая процедура даёт «небольшое или умеренное улучшение качества помощи»: медиана абсолютного улучшения желаемой практики — 2,7 % (межквартильный размах 0,0–8,6)^[158]. Обратная связь работает лучше, когда показывает, как результат соотносится с лучшими коллегами, нацелена на важные области с большим запасом для улучшения, исходит от уважаемого коллеги и сопровождается планом действий. Данных о домах социального обслуживания в обзоре нет, и величину эффекта на наши столовые переносить нельзя. Но условия успеха напрямую подсказывают, как строить аудит в разделах 22.2–22.9.

22.2. Экспресс-аудит «Стол за один день»

Чек-листы экспресс-аудита — приложения 18–21. Аудит проводят в один случайно выбранный будний день. Замеряет человек, не связанный с питанием: заместитель директора по другому направлению, бухгалтер, сестра-хозяйка другого отделения (почему не свой — раздел 22.8). Аудит состоит из четырёх блоков.

До еды. Меню вывешено понятным языком блюд и совпадает с раскладкой. Ночной интервал между вчерашним ужином и сегодняшним завтраком подсчитан в часах. Журналы проб ведутся в реальном времени — это видно по почеркам и проставленному времени. Таблица взаимодействия лекарств и пищи (раздел 11) лежит на посту.

Во время еды. Сколько кормимых приходится на одного работника. Сколько тарелок ждут рук помощника. Какова температура на первом и последнем столе. Соответствуют ли текстуры назначенным — выборочно по трём тарелкам группы риска (раздел 10). Сколько ест самый медленный человек. Объявлена ли добавка. Ест ли персонал вместе с жителями. Какова доля остатков и какие блюда — лидеры остатков. Какова атмосфера: разговор или звон посуды и команды.

После еды. Читает ли врач журнал отказов. Срабатывало ли правило эскалации, по которому после трёх отказов подряд сообщают врачу (раздел 12). Куда ушли остатки. Есть ли вечерний перекус и доходит ли он до постельных жителей. Что может съесть житель в два часа ночи — об этом спрашивают дежурную сиделку, а не читают в положении.

Документы и люди. Есть ли комплект документов раздела 31: положение, меню, журналы, паспорта блюд, согласование. Когда совет жителей последний раз обсуждал меню. Выходил ли повар к жителям за последний месяц. Может ли кто-нибудь за пять минут назвать расход на сырьё на одного жителя в день.

Итог аудита — 24 строки с ответом «да», «нет» или числом. Каждая строка с ответом «нет» сама становится пунктом плана. Опыт показывает, что большинство находок бесплатны: они касаются расписания, порядка подачи, журналов. Меньшая часть требует организационных решений — раскладки, перестановки смены. Лишь единичные находки требуют денег. Как перевести 24 строки в оценку и первый шаг — раздел 22.9.

22.3. Семидневный замер отходов и потребления

Форма — приложение 25. Семь дней подряд трижды в день записывают три веса: сколько выдано (килограммы по линии), сколько вернулось с тарелок и сколько осталось на кухне. Результат — доля несъеденного по блюдам и по дням. Он служит основой финансовой модели (раздел 29), корректировки цикла (раздел 21) и разговора с учредителем (раздел 38).

Метод выбран не случайно. Обзорное исследование 2026 года, обобщившее 33 источника о пищевых отходах в учреждениях длительного ухода для пожилых, показало, что чаще всего измеряют именно отходы с тарелок (14 источников) и делают это чаще взвешиванием (10), чем визуальной оценкой (6); отходы производства и порчи продуктов изучены мало, а из десяти выявленных стратегий сокращения отходов на практике проверялись лишь три^[149]. Взвешивание в трёх точках, которое предлагает приложение 25, захватывает и тарелку, и кухню, то есть закрывает именно ту часть картины, которую исследования обычно упускают.

Насколько велики могут быть такие потери, показывает тот же канадский аудит: по оценкам персонала, от 25 до 60 % ежедневно приготовленной еды выбрасывалось, что соответствовало примерно 26 % суточного норматива на сырьё (9,54 канадского доллара на жителя); в выборке из

более чем 470 тарелок 24 % жителей съели меньше половины порции[150]. Это оценки персонала и одна выборка в чужой системе, а не норма для сравнения. Но они объясняют, почему замер отходов окупается почти всегда.

Справка. Отходы с тарелки, производства и порчи. В литературе различают три вида пищевых отходов. **Отходы с тарелки** (*plate waste*) — то, что выдали, но житель не съел. **Отходы производства** (*production waste*) — то, что приготовили, но не выдали: остатки в котлах и мармитах. **Отходы порчи** (*spoilage*) — продукты, испорченные при хранении. Для вариативного меню важны первые два: отходы с тарелки говорят о вкусе и аппетите, отходы производства — о точности планирования объёмов (раздел 21.9).

Оговорка о точности. Семь дней — короткий ряд: сезонность и «хорошие дни» искажают картину. Поэтому замер повторяют ежеквартально, а выводы делают по повторяемости, а не по одному замеру.

22.4. Квартальная панель директора

Раз в квартал двенадцать чисел сводятся на одном листе (приложение 35).

1. Ночной интервал (часы).
2. Доля несъеденных порций.
3. Блюда-аутсайдеры (три первых по остаткам).
4. Фактическое число кормимых на одного работника.
5. Температурная дельта между линией и последним столом.
6. Соответствие текстур назначенным (по выборке).
7. Число отказов и доля случаев, когда эскалация к врачу прошла в срок.
8. Весовые триггеры — две строки, а не одна: (а) прибавка массы тела на 5 % и более за квартал как сигнал метаболического риска (раздел 13.8); (б) потеря массы по критериям MUST или по рамке Онтарио как сигнал недостаточности питания. Кухня категорию MUST не присваивает: это делает медицинский работник.
9. Доля жителей с актуальной пищевой картой.
10. Доля жителей, выбравших вариант Б и не получивших его (при вариативном меню).
11. Сырьевая строка (рублей на жителя в день).
12. Число жалоб на питание и доля жалоб, на которые ответили в срок.

Макет без значений: числа вписывает дом по своим замерам; в плитке — место для графика хода по месяцам

1 Ночной интервал ужин — завтрак, часы _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =	2 Доля несъеденных порций %, замер — приложение 25 _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =	3 Блюда-аутсайдеры три первых по остаткам _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =
4 Кормимых на одного работника фактическое число _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =	5 Температурная дельта °C, линия — последний стол _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =	6 Соответствие текстур назначенным %, по выборке _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =
7 Отказы от еды а — эпизодов; б — % эскалаций к врачу в срок _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =	8 Весовые триггеры а — прибавка ≥ 5 % за квартал; б — потеря по MUST / Онтарио _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =	9 Актуальная пищевая карта % жителей _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =
10 Выбрал Б — не получил Б % при вариативном меню _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =	11 Сырцевая строка руб. на жителя в день _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =	12 Жалобы на питание а — число; б — % с ответом в срок _____ квартал _____ пред. _____ ↑ ↓ =

☐ строки дома
 ☐ строки 6–8 клинические: оценку даёт врач
 ☐ индикатор срыва выбора

Три вывода квартала и что меняем

без этого плана панель — отчёт, а не инструмент

- _____
- _____
- _____

Рисунок 17. Квартальная панель директора: двенадцать чисел на одном листе и три строки плана на следующий квартал; значения дом вписывает по своим замерам (раздел 22.4, приложение 35)[106]

Справка. Что такое MUST. *Malnutrition Universal Screening Tool* («Универсальный инструмент скрининга недостаточности питания») разработан Британской ассоциацией парентерального и энтерального питания (BAPEN). Он складывает баллы за индекс массы тела, непреднамеренную потерю массы за последние 3–6 месяцев и острое заболевание, при котором человек не ест или не будет есть более пяти дней, и относит человека к низкому, среднему или высокому риску. Для домов ухода инструмент предусматривает ежемесячный повторный скрининг; при среднем риске — трёхдневный учёт потребления, при высоком — направление к диетологу или группе нутритивной поддержки[106]. Пороговые значения баллов в этой главе не приводятся: они даны в пояснительном буклете BAPEN и применяются медицинским работником. Русская версия MUST для домов социального обслуживания в этой главе не сверялась.

Панель решает три задачи. Она показывает динамику, а динамика — главный аргумент в разговоре с учредителем. Она рано сигнализирует о сбоях. И она дисциплинирует систему: что измеряется, то существует.

Квартальный ритм имеет и опору в исследованиях обратной связи: по данным Кокрейновского обзора, обратная связь действеннее, когда она нацелена на важные области с запасом для улучшения и сопровождается планом действий. Частоту возврата результатов мы выбрали сами: квартал — компромисс между нагрузкой на непрофильного сотрудника и скоростью сигнала[158]. Панель без плана на следующий квартал — отчёт; панель с тремя строками «что меняем» — инструмент управления.

22.5. Экспресс-оценка «за 10 минут» для гостя семинара

Это минимальная версия аудита для коллеги, который завтра после семинара вернётся в свой дом. Пять вопросов задаются за десять минут.

1. **Спросить жителя:** «Что вы сегодня выбрали?» Ответ — или его отсутствие — измеряет выбор точнее любых документов.
2. **Заглянуть в мойку после обеда.** Остатки на тарелках — голос всех жителей, включая молчаливых.
3. **Сравнить ночной интервал по расписанию и по факту.** Расхождение показывает разрыв между бумагой и жизнью.
4. **Спросить сиделку:** «Что вы делаете, если он отказался от еды третий раз подряд?» Правильный ответ: «фиксирую и сегодня же сообщаю врачу».
5. **Спросить завхоза:** «Сколько стоит сырьё на одного жителя в день?» Длина паузы измеряет финансовую прозрачность.

Инструменты применяются последовательно: экспресс-аудит — на первой неделе пилота, семидневный замер — на первой и второй неделях, затем квартальная панель. Стоимость — время одного непрофильного сотрудника раз в квартал и две тетради.

22.7. Аудит чужими глазами: взаимные визиты домов

Почти бесплатный формат — обмен аудиторами между двумя домами, лучше разного типа и из разных регионов; найти партнёра проще всего через семинар. Аудитор приезжает на день, проходит чек-листы приложений 18–21 и записывает только факты.

У взаимного визита три преимущества, которых нет у самоаудита. Становятся видны «невидимые нормы» — то, что хозяева давно перестали замечать. Аудитор увозит к себе три находки, подсмотренные у хозяев. И у дома появляется внешний факт для разговора с учредителем. Эти преимущества согласуются с выводом Кокрейновского обзора: обратная связь действеннее, когда исходит от уважаемого коллеги и позволяет сравнить себя с теми, у кого получается лучше[158].

Обязательное правило — предварительная договорённость о некарательности. Находки не уходят вышестоящим без согласия принимающей стороны. Иначе формат умрёт после первого же визита.

22.8. Кто замеряет: почему не свой

Самоаудит завышает оценки не из-за лжи, а из-за адаптации: своя столовая «всегда такая», и привычное перестаёт казаться проблемой. Поэтому замеряет не владелец процесса, а заместитель по другому направлению, бухгалтер, сестра-хозяйка соседнего отделения или коллега из другого дома.

Единственная компетенция, которая для этого нужна, — умение записывать факт, а не впечатление. «Вариант Б закончился на втором отделении» — факт. «Кухня не справляется» — впечатление. Чек-листы приложений 18–21 построены так, чтобы в них помещались только факты.

22.9. Оценка по 24 строкам: как пользоваться шкалой

Результат экспресс-аудита раздела 22.2 выражается не словами «хорошо» или «плохо», а зоной, которая задаёт первый шаг. Балл — число строк из 24 с положительным ответом.

Зона	Балл	Что это значит	Первый шаг
А	18–24	Система работает	Удержание: панель, ротация, защита от регресса (раздел 8.5)
Б	12–17	Практика есть, но контур дырявый	Документы и журналы (раздел 31); линию не трогать
В	6–11	Отдельные элементы есть, системы нет	Пилот по разделу 35, а не «всё сразу»
Г	0–5	Точка старта	Замеры (приложения 25–26) и разговор с учредителем (раздел 38) до любых изменений на линии

Оценку ставит факт вчерашнего дня: строка «положение есть» даёт ноль баллов, если вчера выбора не было.

Повторный аудит, проведённый тем же человеком через квартал, важнее идеальной первой оценки. Динамика балла — главный показатель того, управляет ли дом этой темой. Зоны и пороги — рабочая конвенция доклада, а не валидированная шкала: их смысл в том, чтобы задать первый шаг и сравнить дом с самим собой, а не ранжировать дома между собой.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-bloke/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
I-onaudit2019	Office of the Auditor General of Ontario. Annual Report 2019, Vol. 1, ch. 3.05: Food and Nutrition in Long-Term-Care Homes
M-audit_feedback_ivers	Ivers N. et al. Audit and feedback: effects on professional practice // Cochrane Database Syst Rev. 2026, Issue 6. CD000259 (поиск до июня 2020)
M-waste_roulston	Roulston M., Thompson C., Pelly F., Cave D. Food waste in residential aged care: A scoping review // Nutr Diet. 2026;83(1):56–73

ЧАСТЬ 6

Контекст

разделы 23–27

23

Кто участвует: география семинара и система ПНИ-2026

С этой главы начинается контекстный блок доклада. Прежде чем говорить о нормах регионов (раздел 24), российских практиках (раздел 25), зарубежном опыте (раздел 26) и исследованиях (раздел 27), нужно понять, к кому обращён доклад и какова система, в которой работают его читатели. Глава отвечает на два вопроса: кто собрался на семинаре и что известно о российских психоневрологических интернатах в целом.

23.1. Аудитория по документам

Семинар «Пространство Новых Идей 2.0» собирает в Санкт-Петербурге руководителей стационарных организаций социального обслуживания со всей страны[159]. Очищенный список участников приложен к докладу отдельным файлом: в нём **170 записей из 51 субъекта Российской Федерации**; с учётом четырёх явных дублей это расчётно **166 уникальных организаций**.

Состав неоднороден. В списке есть классические психоневрологические интернаты (Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области), переименованные «дома социального обслуживания» (Красноярский край, Волгоградская, Вологодская, Тюменская области), центры реабилитации и социализации (Воронежская область), «добрые дома» (Московская и Ульяновская области), геронтологические центры с психоневрологическими отделениями (Владимирская область), а также детские и смешанные учреждения.

Аудитория говорит на разных организационных диалектах, но пищевая задача у неё одна. Поэтому доклад обращается к директору стационарной организации социального обслуживания, а не к «директору ПНИ». Различие правового статуса ПНИ и ДСО, которое для темы питания имеет значение, разобрано в разделе 17.14; региональные модели организации — в разделе 24.3.

Справка. ПНИ, ДСО и другие названия. Психоневрологический интернат (ПНИ) — исторически сложившееся название стационарной организации социального обслуживания для людей с психическими расстройствами, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. В последние годы многие регионы переименовывают такие учреждения в **дома социального обслуживания (ДСО)**, «социальные дома», «центры социализации» и т. п. Переименование само по себе не меняет ни контингента, ни штатов, ни норм питания, но меняет публичное обещание: учреждение называет себя домом. В докладе аббревиатура ПНИ используется там, где речь идёт о статистике и правовом статусе, а слова «дом» и «организация» — там, где речь идёт о практике.

23.2. Система в числах (с оговорками о статусе данных)

Основной источник сведений о системе — исследование проекта «Если быть точным» «Как устроены ПНИ в России», опубликованное 9 апреля 2026 года[7]. На следующий день его пересказали «Ведомости»[160]; материал цитировали и другие СМИ, в том числе ТАСС, но ТАСС автором исследования не является. По словам «Ведомостей», исследование построено на открытых данных Росстата, Минтруда и Федерального казначейства. Для второй редакции доклада обе публикации перечитаны (проверка 09.10.2026), и формулировки ниже уточнены по их тексту.

Число учреждений и жителей.

- **466 психоневрологических интернатов для взрослых** действовали в России в 2024 году. За 2022–2024 годы их число сократилось на 13 % — с 536 до 466[160]. В более длинном ряду пик пришёлся на 2014 год, когда интернатов было 540[7].
- **Около 139 500 жителей** во взрослых ПНИ в 2024 году. Максимум был в 2018 году — около 160–161 тысячи человек; в 2023 году число жителей сократилось сразу на 26 000, или на 16 %[7, 160].
- **Более 174 000 человек** проживают во всех отделениях, оказывающих стационарную помощь гражданам с психическими расстройствами, а социальное обслуживание таких граждан обеспечивают **более 730 организаций**[160]. Это число относится именно к отделениям для людей с психическими расстройствами, а не ко всем стационарным организациям социального обслуживания.
- **Средний ПНИ рассчитан на 289 мест**, тогда как оптимальным эксперты, на которых ссылаются авторы, считают 20–50 жителей[7, 160].

Кто живёт в интернатах. Следующие доли относятся к **2022 году**, а не к 2024-му[7].

- **65 % жителей старше 45 лет**, тогда как среди населения России в целом таких 43 %. Контингент стареет.
- **74 % признаны недееспособными** — три четверти. В 2022 году под опекой самих интернатов находилось до 99 % недееспособных подопечных, около 117 000 человек[160]; конфликт интересов «учреждение — опекун» разобран в разделах 16 и 34.5.
- **11 % находятся на постоянном постельном режиме.** Доля маломобильных жителей, которые не лежат, но не могут сами дойти до столовой, в исследовании отдельно не приводится; она, по-видимому, больше, но её надо измерять в каждом доме.
- Большинство жителей имеют вторую группу инвалидности (64 %), 31 % — первую, 5 % — третью[160].

Переименования и выход из интернатов.

- **Как минимум в 41 регионе** к концу 2025 года ПНИ были переименованы в «дома социального обслуживания» и подобные названия[7]; это хорошо видно по списку участников.
- **Сопровождаемое проживание:** в 2024 году на нём находились около **7 000 человек**, то есть менее 5 % от числа подопечных ПНИ; ещё около 6 000 стояли в очереди. Постоянное сопровождаемое проживание работало в 214 квартирах, в среднем по 7–8 человек, и получают его, по оценке авторов, не более **1 800 человек**[7, 160]. В 2025 году услуги сопровождаемого

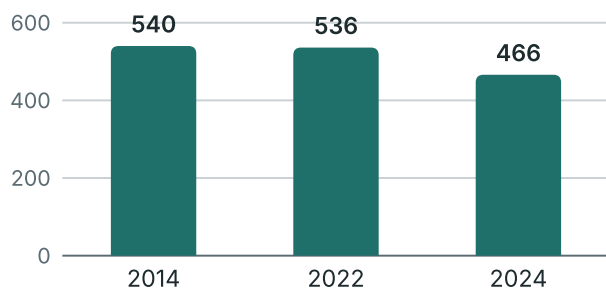
проживания получали уже почти 8 000 граждан с инвалидностью, в том числе 6 400 человек с психическими расстройствами[160].

Справка. Сопровождаемое проживание. Так называют форму жизни человека с инвалидностью вне интерната — в обычной квартире или небольшом доме, — при которой он получает необходимую ему помощь: в быту, в принятии решений, в работе с документами, в лечении. Различают **учебное (тренировочное)** сопровождаемое проживание, когда человек временно живёт в квартире, чтобы освоить навыки, и **постоянное**. Для темы питания это различие важно: в квартире человек сам покупает продукты и готовит, и навыки «своего стола», которые дом может начать развивать раньше, становятся условием перехода.

Статус данных. Это вторичная аналитика на государственных массивах, а не официальная отчётность Минтруда. Первичные ряды в машиночитаемом виде на дату подготовки доклада в открытом доступе извлечены не были, что зафиксировано в журнале верификации. Цифры — порядковые ориентиры, а не точная статистика. Доли состава жителей относятся к 2022 году, численность учреждений и жителей — к 2024-му.

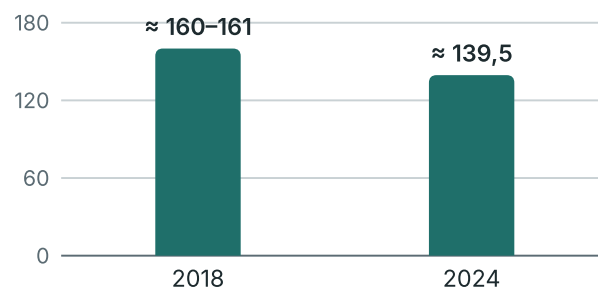
Взрослые ПНИ, число учреждений

пик 2014 года; за 2022–2024 годы — минус 13 %



Жители взрослых ПНИ, тыс. человек

максимум 2018 года; за 2023 год — минус 26 тыс. (16 %)



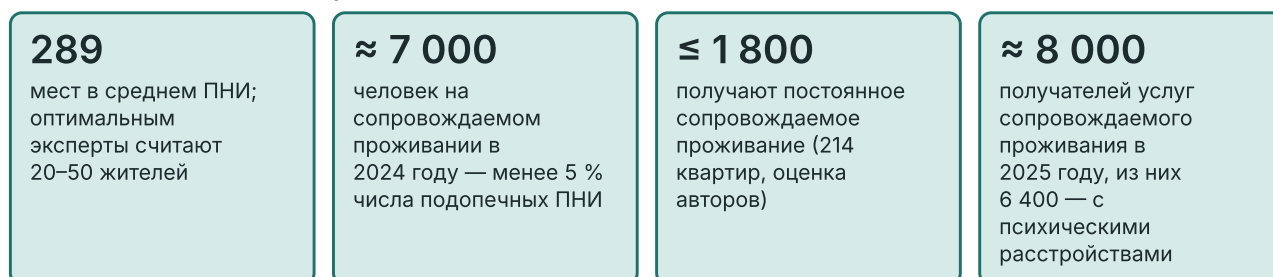
Кто живёт в интернатах — доли 2022 года, %



Группа инвалидности жителей, %



Масштаб и выход из интернатов



Вторичная аналитика на государственных массивах, а не отчётность Минтруда; цифры — порядковые ориентиры. Численность — 2024 год, доли состава жителей — 2022 год (раздел 23.2).

Рисунок 18. Система ПНИ в числах: численность учреждений и жителей, состав контингента и масштаб выхода из интернатов. Численность — 2024 год, доли состава — 2022 год; вторичная аналитика, а не отчётность Минтруда (раздел 23.2)[7, 160]

23.3. Что цифры значат для темы доклада

Из цифр следуют четыре вывода для организации питания.

Первый: контингент стареет. Если 65 % жителей старше 45 лет, то в ближайшие годы растёт доля людей с дисфагией, соматическими заболеваниями и потребностью в помощи за столом (разделы 10, 20, 28). Старение контингента — это не прогноз, а уже сложившаяся структура.

Второй: три четверти жителей недееспособны. Это значит, что невербальный и поддержанный выбор (раздел 15) для дома важнее вербального. В вашем доме цифра будет другой, но логика та же: выбор, который требует умения сказать «я хочу рис», недоступен значительной части жителей.

Третий: переименование в ДСО — не косметика. Новая вывеска задаёт ожидание «дома», и питание — первое место, где это ожидание проверяют. Житель, родственник и проверяющий одинаково спрашивают: похоже ли это на домашний стол?

Четвёртый: сопровождаемое проживание растёт. Рост с 7 000 человек в 2024 году почти до 8 000 в 2025-м пока невелик в масштабах системы, но направление определено. Навыки «своего стола» — ступени 3–5 лестницы участия (раздел 8) — становятся реабилитационной задачей с измеримым результатом: человек, который в доме научился выбирать, планировать и готовить, лучше подготовлен к квартире.

23.4. Кто в зале уже внедрил вариативность

В списке участников есть организации с **подтверждёнными публичными практиками**: Успенский ПНИ (№ 117 в списке)[3], Усть-Илимский дом социального обслуживания (№ 94)[4] и ДСО «Серафимовский» — наш петербургский дом[5]. Болотнинский ПНИ, чья практика также опубликована[2], в списке не значится, но представлен регион: Болотнинский находится в той же Новосибирской области, что Успенский ПНИ и участник № 118 — Тогучинский ПНИ. Содержание и границы подтверждения этих практик разобраны в разделе 25.

Практика, таким образом, сидит в зале. Вопросы «сколько стоило», «что сказала проверка», «где ломалось» стоит задавать носителям опыта, а не только докладчику; формат такой панели предложен модераторам в разделе 40. Для остальных участников это убедительнее любой презентации: коллега с таким же штатом, учредителем и СанПиНом уже это сделал.

23.6. Чего в списке нет — и что это значит

В списке нет общественных организаций жителей и их семей, нет представителей трудовых коллективов смен, нет специалистов по питанию. Состав управленческий. Это не упрёк организаторам: семинар руководителей и должен собирать руководителей. Но из этого следует, что решения будут приниматься о людях, которых в зале нет.

Поэтому первая проверка любого решения семинара — не отчёт учредителю, а столовая: житель и смена. Держать этих двоих в поле зрения — задача модерации каждого обсуждения.

23.7. Что список участников говорит о системе

Список в 170 записей из 51 субъекта, из которых после исключения четырёх дублей остаётся 166 уникальных организаций, — это срез отрасли. Рядом сидят классические ПНИ, переименованные ДСО, дома-интернаты общего типа, социально-реабилитационные центры и детские организации.

Отсюда первая граница доклада. Советы, годные для взрослого ПНИ, для детского учреждения требуют отдельной проверки: детский контур в докладе обозначен, но не раскрыт, и это честная граница, а не упущение.

Отсюда и масштаб. Конституция Российской Федерации в статье 65 перечисляет 89 субъектов^[161]; 51 регион — это больше половины из них (57 %). Повестка семинара, таким образом, способна стать отраслевой (раздел 40). Систематического сравнения норм всех субъектов при этом нет (раздел 24.2).

Наконец, качество данных. В списке 20 записей с пометками о неуверенном распознавании текста и 4 дубля. Даже официальный список федерального семинара требует чистки. Тот же принцип проходит через весь доклад: сначала верификация, потом выводы. Он относится и к самой статистике раздела 23.2: при повторной проверке для второй редакции выяснилось, что в первой редакции год части показателей и содержание двух чисел были переданы неточно (см. реестр расхождений в служебной записке поиска).

Новые источники главы

Полные записи и проверенные формулировки — в реестре <raw/sources/poisk-2026-10-blok-e/istochniki.md>. Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; S004 и S005 перепроверены 09.10.2026 по страницам издателей.

Маркер	Источник
S080	Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями), ст. 65 — перечень субъектов Российской Федерации

24

Как устроены нормы в регионах

Директор, который хочет ввести выбор блюд, первым делом слышит вопрос: «А нормы позволяют?» Ответ почти никогда не лежит в федеральных документах. Он лежит в акте своего субъекта — постановлении правительства, приказе министерства или комитета, — который определяет граммы, раскладку и правила замены продуктов. Эта глава объясняет, как устроена двухуровневая система норм питания, чем региональные акты похожи и чем различаются, как узнать, к какому типу относится ваш регион, и как за одну неделю выяснить собственную правовую рамку. Правовой статус федеральных актов как таковой — предмет раздела 17; санитарные правила — раздела 18.

24.1. Двухуровневая система норм питания

Рамка норм питания в стационарных организациях социального обслуживания двухуровневая.

Федеральный уровень — рекомендуемые нормы Минтруда России (приказ от 13.09.2022 № 520н): суточные наборы продуктов для взрослых и детей[38].

Региональный уровень — акты субъектов, которые принимают эти нормы как обязательные для подведомственных организаций, конкретизируют и дополняют их. Правовое основание таких актов — Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: например, постановление Правительства Челябинской области от 31.10.2014 № 582-П прямо называет своим основанием пункт 6 статьи 8 этого закона[162]; полномочия по 442-ФЗ разобраны в разделе 17.

Первая редакция доклада называла пять проверенных примеров: постановление Правительства Москвы № 1068-ПП, постановление администрации Псковской области № 206, постановление Правительства Красноярского края № 607-п, постановление Правительства Ленинградской области № 458 и постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры № 306-п[11, 12, 163]. При повторной проверке для второй редакции реквизиты уточнены:

- **Красноярский край** — постановление Правительства края от 17.12.2014 № 607-п в актуальной редакции[11].
- **Ханты-Мансийский автономный округ — Югра** — постановление Правительства округа от 22.08.2014 № 306-п «О нормах питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах в организациях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»[164].
- **Псковская область** — это не постановление администрации, а **приказ Комитета по социальной защите Псковской области от 14.07.2020 № 206** «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Псковской области»[165]. Так же акт назван в правовом обзоре НПА, приложенном к корпусу (июль 2026).

- **Москва** — постановления Правительства Москвы № 1068-ПП о нормах питания найти не удалось. Номер и предмет совпадают с ведомственным актом: это **приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 24.12.2014 № 1068** «Об утверждении Норм питания получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в государственных организациях социального обслуживания города Москвы», вступивший в силу с 01.01.2015^[166]. Первая редакция, по всей видимости, ошибочно назвала его постановлением. Суточные наборы в нём различаются по типу организации: в психоневрологических интернатах, например, больше хлеба и картофеля, но меньше мяса и молока, чем в домах общего типа. Более поздний акт того же ведомства (после переименования — Департамента труда и социальной защиты населения) — **приказ от 22.03.2021 № 228** «Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания города Москвы», вступивший в силу с 01.04.2021^[167]. Он утверждает шесть наборов норм, в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов, и требует соблюдать их при разработке циклических меню, допуская отклонение калорийности отдельного приёма пищи в пределах $\pm 5\%$ при соответствии средней недельной пищевой ценности нормам. Правовой обзор НПА называет приказ № 228 действующим и заменившим прежний акт; пункт об отмене приказа № 1068 в открытом фрагменте текста при проверке 10.10.2026 не виден, поэтому для своего учреждения статус обоих актов стоит подтвердить у учредителя.
- **Ленинградская область** — акт № 458 о нормах питания при поиске 10.10.2026 найти не удалось ни среди постановлений Правительства области, ни среди приказов Комитета по социальной защите населения. Сайт подведомственного дома-интерната ссылается на приказ Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 05.11.2014 № 29 и на методические рекомендации Минтруда 2002 года^[168]; это вторичная ссылка, текст приказа № 29 не прочитан, и действует ли он сегодня, не установлено.

Практический вывод остаётся прежним: для директора действует региональный акт — граммы, раскладка, таблицы замен. Первое действие — найти и перечитать свой региональный акт, а не федеральные приказы. Путь к нему лежит через учредителя.

Справка. Нормы питания, раскладка, таблица замен. **Нормы питания** (суточный набор продуктов) — количество продуктов каждой группы в граммах на одного человека в день: хлеб, крупы, мясо, рыба, молочные продукты, овощи и т. д. Различают массу **брутто** (с отходами, как продукт поступает на склад) и **нетто** (после первичной обработки). **Раскладка** (перспективное меню, картотека блюд) переводит граммы продуктов в конкретные блюда с выходом в граммах. **Таблица замены** (взаимозаменяемости) продуктов указывает, каким количеством одного продукта можно заменить другой без потери белков, жиров и углеводов: например, сколько творога или рыбы эквивалентно определённому количеству мяса. Для вариативного меню таблица замен — главный правовой инструмент: она позволяет готовить разные блюда, оставаясь в пределах одного и того же набора.

24.2. Что общего у региональных норм

Проверенные акты в целом держат одну конструкцию из пяти элементов.

1. **Набор продуктов в граммах на человека в день** по группам — хлеб, крупы, мясо, рыба, молочные продукты, овощи, — изложенный прямо или со ссылкой на федеральные рекомендации.
2. **Раскладка блюд** (перспективная картотека) — перечень блюд с выходом в граммах.
3. **Таблицы замены продуктов** — эквиваленты по пищевой ценности. Это ключевой механизм: он легализует вариативность (разделы 8, 19).
4. **Отдельные нормы для категорий** — для детей, для лиц с соматическими заболеваниями.
5. **Периодичность и режим** — число приёмов пищи, интервалы, — в связке с санитарными правилами[9]. С 01.09.2026 действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26, до этой даты действовал СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (раздел 18).

Повторное чтение пяти актов разных лет показывает, что эта конструкция — скорее тип, чем правило. Третий элемент реализован по-разному.

- **Таблица замены как приложение к акту.** Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 14.06.2024 № 269 утверждает нормы для взрослых и детей и отдельно — таблицы замены продуктов по основным пищевым веществам для каждой возрастной группы[169].
- **Отсылка к внешней таблице.** Челябинское постановление 2014 года разрешает «производить замену отдельных продуктов питания в соответствии с» таблицей, но саму таблицу не приводит: для взрослых оно ссылается на приложение к методическим рекомендациям 2002 года[162]. Такая отсылка к документу двадцатилетней давности — повод для письменного вопроса учредителю о том, какая таблица действует сейчас.
- **Общее разрешение без таблицы.** Приказ Главного управления Алтайского края по социальной защите населения от 31.10.2014 № 376 в примечании допускает «замену одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на равноценные по составу продукты», а нормативы замены по белкам и углеводам относит к актам Минздрава. Комиссии при организациях вправе письменным решением увеличивать калорийность, количество продуктов и выход блюд на 10–15 %[170].
- **Нет таблицы, есть допуски.** В постановлении ХМАО — Югры 2014 года таблицы замены нет; нормы заданы перечнями продуктов в граммах брутто и нетто, а свобода выражена допустимыми отклонениями: $\pm 5\%$ при составлении меню и $\pm 10\%$ по химическому составу набора. При использовании другого сырья требуется перерасчёт[164].

Различаются акты и в порядке изменений. Крымский приказ допускает «отдельные изменения в нормах питания» только в пределах выделенных учреждению средств, с обоснованием и по предварительному согласованию с министерством[169]. В Алтайском крае аналогичное решение принимает комиссия самой организации[170]. Для директора это два разных мира: в первом любое отступление — переписка с министерством, во втором — протокол собственной комиссии.

Таким образом, регионы различаются граммами, категориями и прежде всего свободой таблиц замен. Систематического сопоставления норм всех 89 субъектов Российской Федерации[161] мы не нашли. Правовой обзор НПА, приложенный к корпусу, сравнивает акты восьми субъектов; наша

выборка в этой главе — ещё пять актов. Обобщения о «российских нормах вообще» поэтому делать нужно осторожно.

О статусе приказа № 520н. На федеральном уровне приказ Минтруда № 520н устанавливает именно «рекомендуемые нормы». По сведениям первой редакции доклада, в Минюсте он не регистрировался: это рекомендательный акт, а не императив. (*Уточнение 19.08.2026; при повторной проверке 09.10.2026 сведения о регистрации подтвердить по официальному источнику не удалось.*) Полное название акта — «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»; он признал утратившим силу приказ Минтруда от 13.08.2014 № 552н, о котором в тексте сказано, что тот, согласно письму Минюста России от 24.10.2014, в государственной регистрации не нуждался. Сведений о регистрации самого приказа № 520н в его тексте нет[38]. Это косвенно подтверждает рекомендательный характер акта, но не заменяет справки по официальному источнику. Вместе с тем в ряде субъектов региональные акты прямо ссылаются на 520н как на основу норм для подведомственных организаций, и тогда эти нормы обязательны в данном регионе независимо от их федерального статуса. Пример такой ссылки — преамбула крымского приказа 2024 года, которая называет приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н[169]. Проверяя свою рамку (раздел 24.4, шаг 1), уточняйте не только наличие регионального акта, но и его ссылочный аппарат. Как читать статус любого акта — раздел 17.11.

24.3. Региональные модели организации: четыре архетипа

Организации в регионах устроены по-разному, и это влияет на питание. По составу участников семинара (раздел 23.1) различаются четыре архетипа учреждений. Это классификация **организаций**; классификация **регуляторных режимов** — другая ось, она дана в разделе 24.8.

Архетип 1. Классический ПНИ (Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области) — специализированное учреждение для людей с психическими расстройствами. Питание здесь — профильная функция, диетсестра чаще всего в штате. Именно этот архетип дал все три подтверждённые практики вариативности, на которые опиралась первая редакция[2, 3, 4]; подробности и границы подтверждения — раздел 25.

Архетип 2. Дом социального обслуживания (Красноярский край, Волгоградская, Вологодская, Тюменская области и др.; переименования прошли как минимум в 41 регионе[7]) — универсальное учреждение, где люди с психическими расстройствами живут вместе с другими категориями. Питание строится на общих нормах, а психиатрическая специфика переносится в назначения врача и локальные акты.

Архетип 3. Центры реабилитации и «добрые дома» (Воронежская, Московская, Ульяновская области). Питание здесь — элемент восстановления навыков, и по устройству такие учреждения ближе к моделям М3–М5 (раздел 8).

Архетип 4. Смешанные учреждения с психоневрологическими отделениями (Владимирская область и др.) — психоневрологическое отделение внутри геронтологического центра или специального дома-интерната. Питание общего контура с отдельными назначениями для отделения.

Архетип организации отражается и в нормах. Многие региональные акты дифференцируют наборы по видам учреждений. Псковский приказ 2020 года, например, содержит шесть приложений для разных видов организаций и получателей: первое — для стационарных учреждений, включая дома-интернаты для престарелых и инвалидов и психоневрологические интернаты[165]. Челябинское постановление разделяет стационарную форму общего и психоневрологического профиля и отдельно устанавливает нормы для несовершеннолетних на постоянном зондовом питании[162].

Отсюда правило заимствования: заимствуя опыт, смотрите на архетип источника. Модель классического ПНИ переносится на ДСО с адаптацией, но не копируется.

24.4. Пять шагов проверки своей региональной рамки

Ниже — алгоритм для директора (форма — в семинарском пакете). Как уложить его в рабочую неделю, показано в разделе 24.7.

1. **Получить у учредителя действующий региональный акт о нормах питания** и проверить его редакцию: дату, внесённые изменения, ссылки на федеральные акты.
2. **Сверить фактическую раскладку дома с актом:** граммы, категории, таблицы замен.
3. **Проверить таблицы замен:** какие эквиваленты разрешены. Это и есть пространство законной вариативности. Если акт ссылается на внешнюю таблицу (как челябинский — на рекомендации 2002 года), выяснить, какая её редакция применяется.
4. **Найти нормы для особых категорий:** где «диетическое питание» в вашем контуре и кто его назначает.
5. **Зафиксировать письменно**, что решает учреждение и что — учредитель (матрица полномочий, приложение 17). Здесь же — кто согласует отступления от норм: министерство, как в Крыму, или комиссия самой организации, как в Алтайском крае (раздел 24.2).

Таблицы замен — готовое законное пространство выбора, которым почти никто не пользуется по назначению. Без этих пяти шагов пилот строится вслепую.

24.6. Разговор с регионом: как ставить вопрос

Чиновник охотнее отвечает на точный вопрос, чем на просьбу «разберитесь с нормами». Образец постановки вопроса: «Просим подтвердить статус приказа Минтруда России № 520н в части норм питания для подведомственных организаций: рекомендательный или обязательный; просим указать акт, которым этот статус установлен». Один вопрос и одна просьба о документе.

По тому же шаблону строятся ещё три письма — о меню, о «мосте» к лечебному питанию и о формах учёта. Можно добавить и пятый вопрос, если акт региона отсылает к внешней таблице замены: «Просим указать, какая таблица взаимозаменяемости продуктов (наименование и реквизиты документа) применяется при составлении меню в подведомственных организациях». Четыре–пять писем заменяют год коридорных пересудов.

24.7. Проверка за пять шагов: сценарий недели

Пять шагов раздела 24.4 укладываются в одну рабочую неделю.

- **День 1.** Письмо учредителю с вопросами 1–4 из раздела 38.
- **День 2.** Сбор сведений внутри дома: какое меню висит на кухне, кто его утвердил, когда оно пересматривалось.
- **День 3.** Сверка предписанного и фактического. Разницу между ними фиксируют письменно.
- **День 4.** Ответ учредителя или фиксация его отсутствия — и решение о рамке пилота.
- **День 5.** Запись рамки в приказ о пилоте (приложение 28).

Всю неделю на линии ничего не меняется. Но после неё правовая геометрия кухни известна точнее, чем за все предыдущие годы.

24.8. Четыре архетипа региональной регуляции: детализация

Раздел 24.3 классифицировал учреждения. Здесь — режимы регулирования, которые встречаются в актах субъектов. Узнавать каждый режим удобно по одному характерному документу.

«Императивное меню». К постановлению приложено двухнедельное меню с граммовками, и отступления от него не предусмотрены. Вариативность в таком регионе начинается с изменения приложения, а первый шаг — запрос о процедуре изменения (вопрос № 2 учредителю, раздел 38). К этому режиму близки акты, где любые изменения норм требуют предварительного согласования с министерством, как в Крыму^[169].

«Нормы без меню». Закреплены нутриенты, наборы продуктов и кратность приёмов пищи, а меню — дело организации. Свобода здесь максимальна, но и ответственность за пары эквивалентов целиком лежит на организации. Примеры этого режима с разной степенью свободы — акты ХМАО — Югры с допусками $\pm 5\%$ и $\pm 10\%$ ^[164] и Алтайского края с правом комиссии организации увеличивать нормы на 10–15 %^[170].

«Типовая раскладка». Наследие советской раскладки: формально она рекомендована, фактически считается неприкосновенной. Лечится письменным вопросом о статусе (раздел 24.6).

«Мост». Акт, связывающий систему социального обслуживания с системой лечебных диет; образцом служит распоряжение 19РВ-32^[12]. Это самый благоприятный режим для лечебного питания и самый редкий. Отсылки к приказам Минздрава о лечебном питании встречаются и в других регионах — правовой обзор НПА отмечает их, например, в псковском акте, — но отсылка ещё не мост: она не говорит, кто и как переводит диетический стол в меню дома социального обслуживания (раздел 17.10).

Один регион может сочетать несколько режимов, например императивное меню и мост. Поэтому диагностика строится не на анекдоте «у нас нельзя», а на форме из пяти строк: статус норм, меню, мост, формы учёта, закупочная модель. Эту форму семинар собирает по 51 региону (раздел 40). Это будет первый срез вместо фольклора — и, насколько нам известно, первый шаг к тому систематическому сопоставлению региональных норм, которого пока нет (раздел 24.2).

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и где читали — в реестре raw/sources/poisk-2026-10-blok-e/istochniki.md. Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S080	Конституция Российской Федерации, ст. 65 — перечень субъектов Российской Федерации
S081	Приказ Комитета по социальной защите Псковской области от 14.07.2020 № 206 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Псковской области»
S082	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 22.08.2014 № 306-п «О нормах питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах...»
S083	Приказ Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне от 31.10.2014 № 376 «Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания»
S084	Постановление Правительства Челябинской области от 31.10.2014 № 582-П «Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Челябинской области»
S085	Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 14.06.2024 № 269 (ред. приказа от 15.05.2025 № 249) — нормы питания и таблицы замены продуктов
S151	Приказ Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 24.12.2014 № 1068 «Об утверждении Норм питания получателей социальных услуг в стационарной форме...» (реестр poisk-2026-10-dozakrytie)
S152	Приказ Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы от 22.03.2021 № 228 «Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания города Москвы» (реестр poisk-2026-10-dozakrytie)
S153	Сайт ЛОГБУ дома-интерната (dikamen.47social.ru), «Организация питания»: ссылка на приказ Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 05.11.2014 № 29 (вторичная ссылка; реестр poisk-2026-10-dozakrytie)

25

Российские практики: публичные кейсы, региональный опыт и его границы

Вариативное меню в российских домах социального обслуживания не придумано авторами доклада. Его уже делают, и делают по-разному: где-то несколько раз в неделю на завтрак, где-то каждый день во всех отделениях, где-то через заказ накануне. Эта глава собирает то, что о такой практике известно из открытых источников, и с той же тщательностью перечисляет то, чего о ней не известно. Обе половины одинаково важны: первая показывает, что выбор за столом в российском учреждении возможен, вторая удерживает от того, чтобы выдавать новость за доказательство.

25.1. Методологическая рамка: что считается подтверждением

Практикой в этой главе считается только то, о чём организация, её учредитель или орган власти рассказали публично на официальном ресурсе, либо то, что со ссылкой на такой ресурс пересказало СМИ. Такое сообщение подтверждает факт сообщения на определённую дату, но не результат аудита. Из новости нельзя узнать, сколько жителей реально выбирают, как изменились отходы и сохранилась ли практика через год.

Справка. Публичное сообщение как класс источника. В системе классов утверждений доклада (раздел 41) новость учреждения или пресс-релиз ведомства — это свидетельство о том, что организация заявила о практике, а не независимая оценка этой практики. Оно сильнее слуха и слабее проверки. Пересказ отраслевым изданием или агрегатором новостей ещё на шаг дальше от первоисточника: в пересказе легко теряются оговорки («пока только в одном отделении»), и обобщения появляются там, где их не было. Поэтому для каждого кейса ниже указано, читался ли первоисточник или только пересказ.

Перечень не полон. Российская практика вариативности шире её публичной документации, а поиск при подготовке доклада и при второй редакции (09.10.2026) — это срез, а не перепись. Где в источнике нет деталей, так и написано: «данных нет». Модели раздачи М0–М5, по которым ниже классифицируются кейсы, определены в разделе 8; классификация — наше толкование, а не слова учреждений.

25.2. Кейс 1. Болотнинский ПНИ (Новосибирская область), с 2024 года

Учреждение сообщило о практике 16 августа 2024 года[2]. По его словам, «с 2024 года в нашем учреждении несколько раз в неделю введено вариативное питание». В такие дни на завтрак жителю предлагают выбрать «чай, какао или кофейный напиток, молочная каша либо суп», а на обед — из «разнообразия салатов и вторых блюд, а также десерт, фрукты и творог».

Принципиальная деталь: «перечень блюд определяется медицинской сестрой диетической». Учреждение также пишет, что планирует «расширить и ассортимент вечернего меню» (при проверке 09.10.2026 подтверждено по странице учреждения).

По классификации раздела 8 это модель М1: точечный выбор на ключевых приёмах пищи и в отдельные дни. Вариативность здесь живёт внутри норм, а ответственность за набор вариантов лежит на диетической сестре. Тем самым снимается конфликт «выбор против раскладки», который часто пугает руководителей: житель выбирает не из всего, что хочет, а из того, что медицинская служба заранее признала эквивалентным.

Чего в источнике нет: охвата (сколько жителей и отделений), учёта невербального выбора, статистики выбора, влияния на отходы и судьбы практики после 2024 года, в том числе того, расширилось ли вечернее меню. Отсутствие данных — повод для контакта с учреждением, а не для домыслов.

25.3. Кейс 2. Успенский ПНИ (Новосибирская область), с марта 2024 года

Сообщение учреждения датировано 13 августа 2024 года[3]. Сверка при второй редакции уточнила дату старта: вариативное меню внедрено в марте 2024 года по инициативе отдела питания, и «именно тогда все отделения перешли на вариативное меню». Жители выбирают из двух вторых блюд, двух салатов и двух напитков; например, предлагаются два рыбных или два мясных вторых. Учреждение пишет, что страхи персонала не подтвердились, а жители «с лёгкостью освоили новую систему». Вместе с меню обновили посуду и провели занятия по этикету за столом.

Сверка уточнила и содержание страхов: сотрудники «переживали, что для некоторых жителей будет сложно подойти к линии раздачи». Значит, в учреждении есть линия раздачи, где житель называет свой выбор, но самообслуживания с открытой выкладкой («шведской линии») в тексте нет. Поэтому это модель М2 — ежедневный выбор по основным позициям с полным охватом отделений, — а не М3.

Для семинара из кейса следуют два вывода. Во-первых, главное сопротивление было внутренним, со стороны персонала, и оно не материализовалось. Во-вторых, внедрение сопровождалось бытовыми улучшениями и обучением самих жителей: это была программа, а не приказ. Представитель учреждения — участник семинара № 117.

25.4. Кейс 3. Усть-Илимский дом социального обслуживания (Иркутская область), с сентября 2024 года

Сообщение учреждения от 27 сентября 2024 года[4] говорит, что вариативное питание вводится поэтапно. Начали с жителей, которые ходят в столовую. Внедрению предшествовал опрос предпочтений, а блюда сгруппированы по популярности.

Ценность кейса в порядке действий: сначала измерение и сегментация (первыми — мобильные жители), потом выбор. Это та же логика, что и в дорожной карте раздела 35. Представитель учреждения — участник семинара № 94. При второй редакции страница учреждения не

открылась, поэтому сведения оставлены по проверке 23.07.2026. В отраслевом пересказе по Иркутской области (раздел 25.6) упомянут Усть-Илимский дом-интернат «Лидер»; совпадает ли он с этим учреждением, по прочитанным источникам не установлено, и мы их не объединяем.

25.5. Кейс 4. ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург), 2025 год

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга сообщил 22 июля 2025 года[5], что я, директор дома Евгений Чистяков, представил на рабочей группе по реформированию ПНИ первые результаты вариативного меню для части жителей. Несколько месяцев проживающим предлагали накануне выбрать рацион на следующий день. Для этого дом закупил дополнительное оборудование и добавил сотрудников. Жители восприняли эксперимент с энтузиазмом. Вместе с тем в сообщении сказано, что полный переход «крайне затруднителен»: мешают нормы сбалансированности рациона и особенности здоровья жителей, а сами жители склонны выбирать популярные, но не самые полезные продукты.

По классификации это модель М1 — заказ накануне для части жителей, близкий по устройству к пилоту раздела 35. Кейс содержит два факта, которых нет в других публичных российских сообщениях. Первый: старт не был «без новых денег» — оборудование и ставки названы прямо. Второй: учреждение само обозначило пределы практики (нормы, здоровье, тяга к популярному и не самому полезному). Такое признание ценнее победной реляции, потому что позволяет другим домам заранее увидеть, во что они упрутся. *Маркировка: официальная новость учредителя — факт публичного сообщения на дату, а не аудит и не оценка устойчивости. Докладчик семинара — директор этого дома. При второй редакции страница Комитета не открылась (запрет индексации), формулировки сохранены по проверке 17.08.2026.*

Развитие кейса: приказ № 124 от 10.03.2026. Приказ директора[171] утверждает правила внутреннего распорядка жителей. В них закреплено заказное питание (вариативное меню), в том числе для маломобильных: «для маломобильных граждан приём пищи осуществляется в жилых комнатах, оказывается помощь в кормлении (при необходимости)». Тем самым вариативность перешла из статуса «эксперимента, о котором рассказали в новости» в статус нормы внутреннего распорядка — локального акта, который можно предъявить проверяющим. Это локальный акт одного учреждения, а не федеральная или региональная норма. *Реквизиты: PDF приказа размещался на www.pni9.ru; сайт прекратил работу, домен истёк (проверено 21.08.2026); текст правил доступен в архивной копии web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/. Заказное питание — раздел правил, а не отдельный приказ.*

Масштаб и режим (обновление 21.08.2026 по архивным копиям сайта). В феврале 2026 года в доме проживали 1 004 человека: 949 за счёт бюджета Санкт-Петербурга (625 мужчин и 324 женщины; свободных мест нет) и 55 за счёт средств физических и юридических лиц (28 мужчин и 27 женщин); источник — раздел «Свободные места», архив 07.03.2026. Режим питания: завтрак 8.00–10.00, обед 13.00–15.00, полдник 16.00–17.00, ужин 18.00–20.00, второй ужин 20.00–21.00. Ночной интервал от второго ужина до завтрака составляет 11–12 часов, что укладывается в правило «интервал не превышает 14 часов» раздела 4 и в критерий раздела 13.9 (сопоставление с зарубежными нормами ночного интервала — раздел 26.6). В описании материально-технического

обеспечения (архив 24.01.2026) указаны «6-и разовое питание, наличие диет столов», протёртый стол и дополнительное питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; правовой разбор этих фактов — в разделе 17.12.

25.6. Иркутская область: четыре учреждения, а не региональная норма

В первой редакции доклада этот раздел назывался «Региональная модель» и утверждал, что в стационарных учреждениях области действует ежедневный выбор из двух первых, двух вторых блюд и гарниров. При второй редакции источник прочитан полностью[6], и картина оказалась иной (см. «Расхождение с корпусом» в реестре поиска).

Материал от 14 февраля 2025 года («Вариативное питание в стационарных учреждениях социального обслуживания») опубликован агрегатором со ссылкой на сайт министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; сам сайт министерства при проверке не открылся. В тексте нет ни слов «во всех учреждениях», ни числа учреждений: сказано лишь, что схему «уже активно реализовали» в стационарных учреждениях министерства. Дальше описаны четыре учреждения, и у каждого своя модель.

- **Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер».** «Команда пищеблока ежедневно готовит на 220 человек по восьми видам меню, с правом выбора в обед». Восемь видов меню — это, по всей видимости, диетические и текстурные варианты, а выбор относится к обеду; дата старта не указана.
- **Чунский психоневрологический интернат «Радуга».** Вариативное питание «начали внедрять ещё в феврале 2023 года». Установлена зона самообслуживания «для тех, кто может самостоятельно взять понравившееся блюдо»: житель собирает комплексный обед и сам несёт поднос к столу. Для тех, кто не может жевать, разработано альтернативное меню из протёртых блюд. Это первое найденное нами публичное описание самообслуживания (ближе всего к модели М3) именно в ПНИ, и оно на год старше новосибирских кейсов. Важно и то, что выбор не отнят у людей с изменённой текстурой: для них есть своя линия, что соответствует принципу раздела 10.10.
- **Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.** «Сначала вариативным сделали меню на завтрак и обед в отделении активного долголетия, позже подключили отделение милосердия». Это пример поэтапного расширения от мобильных жителей к лежачим.
- **Марковский геронтологический центр.** Здесь и действует формула, которую первая редакция приписала всей области: «право выбора блюд на обед из двух вариантов первых блюд, вторых блюд, гарниров». Внедрение идёт с сентября 2024 года, и «пока возможность выбора блюд доступна только для отделения активного долголетия».

Вывод для доклада: Иркутская область — не первый случай масштабирования вариативности на уровень субъекта, а пример того, как ведомство собирает и публикует опыт нескольких своих учреждений. Это само по себе ценно: министерство показывает, что поддерживает практику. Но писать «вся область внедрила» нельзя, и в таблице 25.8 охват исправлен. Сколько учреждений области практикует выбор сегодня, по-прежнему не установлено. Формулировки о «региональной модели Иркутской области» в разделах 2, 3, 4, 8 и 17 первой редакции требуют такой же правки.

25.7. Опорная практика: ДДСОЛ (Московская область)

ДДСОЛ публикует устройство своего питания^[24]: зимнее и летнее 14-дневное меню, пятишестиразовое питание, поточную линию самообслуживания, буфетную зону, совет по питанию и замены блюд по желанию жителей по согласованию с врачом. Совет по питанию создан на основании распоряжения Министерства социального развития Московской области от 13.04.2017 № 19РВ-32 — медицинской по происхождению рамки, применённой к социальному учреждению. Это не вариативное меню в строгом смысле раздела 8.1 (выбор в момент еды не менее чем из двух вариантов), а работающая персонализация внутри нормы и законный «мостик» к лечебному питанию (раздел 17.5).

25.8. Сравнительная таблица практик

Учреждение	Модель	Точки выбора	Частота	Охват	Ответственный	Особенности
Березовский ПНИ (Свердл. обл.), 2013	M3 (по описанию)	Салаты, первые, вторые	Ежедневно, меню на неделю	Данных нет	Данных нет	Первый найденный случай; судьба неизвестна (25.12)
Болотнинский ПНИ	M1	Завтрак, обед	Несколько раз в неделю	Данных нет	Диетсестра	Перечень от медицинской службы; планы на вечернее меню
Успенский ПНИ	M2	Вторые, салаты, напитки	Ежедневно, с марта 2024	Все отделения	Отдел питания (инициатор)	Посуда, этикет, страх «не подойдут к линии» не подтвердился
Усть-Илимский ДСО	M1 → M2	Старт — столовая	Поэтапно	Мобильные жители	Данных нет	Опрос предпочтений, группировка по популярности
Серафимовский ДСО	M1	Рацион на следующий день	Накануне, несколько месяцев; с 2026 — правила распорядка	Часть жителей; в правилах — и маломобильные	Данных нет	Оборудование и дополнительные ставки; энтузиазм; полный переход затруднителен
Иркутская обл.: «Лидер»	M1 – M2	Обед	Ежедневно	220 порций	Данных нет	Восемь видов меню
Иркутская обл.: Чунский ПНИ «Радуга»	M3 (самообслуживание)	Комплексный обед	С февраля 2023	Кто может взять сам; протёртая линия для остальных	Данных нет	Выбор сохранён и при изменённой текстуре
Иркутская обл.: Ново-Ленинский ДИ	M1 – M2	Завтрак, обед	Данных нет	Активное долголетие, затем милосердие	Данных нет	Расширение от мобильных к лежачим
Иркутская обл.: Марковский центр	M2	2 первых, 2 вторых, гарниры	С сентября 2024	Одно отделение	Данных нет	Расширение «для всех» — в планах

Учреждение	Модель	Точки выбора	Частота	Охват	Ответственный	Особенности
ДДСОЛ	персонализация	Замены по желанию	Постоянно	Все жители	Совет по питанию и врач	14-дневное меню; региональный «мостик» к лечебному питанию

Учреждение	Модель	Старт	Что известно из публикации
Свердловская область			
Березовский ПНИ	M3*	апрель 2013	«Шведский стол»: несколько салатов, первых и вторых; меню на неделю. Судьба практики неизвестна
Новосибирская область			
Болотнинский ПНИ	M1	2024	Несколько раз в неделю, завтрак и обед; перечень блюд определяет диетсестра
Успенский ПНИ	M2	март 2024	Ежедневно во всех отделениях: два вторых, два салата, два напитка
Иркутская область			
Усть-Илимский ДСО	M1→M2	сентябрь 2024	Поэтапно, первыми — мобильные жители; опрос предпочтений, группировка блюд по популярности
Сообщение министерства (14.02.2025): четыре учреждения — у каждого своя модель, это не региональная норма			
«Лидер», Усть-Илимск	M1-M2	нет данных	220 человек, восемь видов меню, выбор в обед
Чунский ПНИ «Радуга»	M3	февраль 2023	Зона самообслуживания; для тех, кто не может жевать, — своя протёртая линия
Ново-Ленинский ДИ	M1-M2	нет данных	Завтрак и обед: сначала активное долголетие, затем милосердие
Марковский центр	M2	сентябрь 2024	Два первых, два вторых, гарниры — только одно отделение
Санкт-Петербург			
ДСО «Серафимовский»	M1	сообщено в июле 2025	Заказ накануне для части жителей; оборудование и ставки; с 2026 года — в правилах распорядка
Московская область			
ДДСОЛ	иное	нет данных	Персонализация внутри нормы: замены по желанию с врачом, совет по питанию; не вариативность в строгом смысле

Модели M0–M5 — раздел 8; классификация — толкование доклада, а не слова учреждений. * — по описанию в новости.

Что подтверждает публикация

Факт сообщения на дату: модель, точки выбора, порой — охват и ответственного

Чего не знаем ни по одному кейсу

Сколько жителей реально выбирают и как выбирают неговорящие; экономику сырьевой строки; отходы; устойчивость сегодня; вопросы проверяющих

Рисунок 19. Публичные российские практики вариативного питания: модель — толкование доклада по разделу 8, а не слова учреждений; подтверждён только факт сообщения на дату (разделы 25.2–25.10)[2, 3, 4, 5, 6, 24, 172]

25.9. Выводы для участников

1. Вариативность в России — не эксперимент одного дома. Публично о ней сообщали как минимум восемь учреждений в четырёх субъектах[2, 3, 4, 5, 6, 172]; самые ранние найденные

описания относятся к 2013 году (Березовский ПНИ) и к февралю 2023 года (Чунский ПНИ), основная волна сообщений — 2024–2025 годы. Это ещё не статистика отрасли (её нет, раздел 23), но уже и не единичный случай.

2. **Универсального «бесплатного старта» нет.** Кейсы Новосибирской и Иркутской областей не сообщают о новых деньгах: второй вариант вводился внутри существующих норм. Серафимовский публично назвал оборудование и дополнительные ставки[5]. Обе картины правдивы для своих условий (раздел 29).
3. **Три кейса сидят в зале** — Успенский, Усть-Илимский и дом докладчика (раздел 40).
4. **Документация отстаёт от практики.** В публичных сообщениях нет учёта, статистики выбора и документов. Учреждение, которое расскажет о выборе с цифрами, сдвинет отрасль сильнее методического доклада (раздел 39).
5. **Пересказ искажает.** Пример Иркутской области (раздел 25.6) показывает, как описание четырёх учреждений с оговорками превратилось в «региональную модель». Каждый кейс стоит проверять по первоисточнику.

25.10. Чего мы не знаем о практиках — и почему это важно сказать

По каждой из описанных практик неизвестно больше, чем известно: экономика сырьевой строки, устойчивость на сегодняшний день, охват неговорящих жителей, вопросы проверяющих органов. Новость подтверждает факт сообщения на дату, и только. Поиск локальных актов и повторных публикаций выполнен там, где их удалось найти (распоряжение по ДДСОЛ[24], сообщение министерства по Иркутской области[6], правила распорядка Серафимовского[171]), и честно не выполнен там, где их нет. Повторных публикаций Болотнинского и Успенского ПНИ после августа 2024 года ни при первой проверке, ни 09.10.2026 не обнаружено; не найдено и продолжения истории Березовского ПНИ после 2013 года. По Серафимовскому известны факты новости Комитета[5] и правил распорядка[171] — но не штатное расписание, не меню и не панель показателей. «Внедрено публично» не равно «работает годами», и участники семинара должны слышать обе половины этой фразы.

25.11. Что объединяет внедривших: общие признаки

Сравнение практик (Болотнинский[2], Успенский[3], Усть-Илимский[4], Серафимовский[5], четыре учреждения Иркутской области[6], ДДСОЛ[24]) даёт механику, а не лозунги.

Точка входа — предпочтения. Опрос предшествует линии раздачи; явно об этом пишет Усть-Илимский дом[4].

Скромный старт. Два вторых, два салата, два напитка[3], заказ накануне для части жителей[5] или выбор только в одном отделении[6].

Поэтапное расширение. От мобильных жителей к лежащим, от одного отделения ко всем — так описывают путь Усть-Илимский дом[4] и два иркутских учреждения[6].

Публичность как защита. То, о чём рассказано на официальных сайтах с датами, труднее тихо отменить.

Страхи и пределы названы задним числом. «Страхи не подтвердились»[3] и «полный переход крайне затруднителен»[5] — два честных итога с разных сторон.

Есть и признак, который **не** общий. Новосибирские и иркутские кейсы не сообщают о новых ставках, а Серафимовский сообщает об оборудовании и сотрудниках. Это не доказывает ни «бесплатности», ни «дороговизны» вариативности (раздел 29): порог входа может быть организационным (опыт Новосибирской области) или требовать ресурсов (опыт Санкт-Петербурга). Пилот на одном отделении без новых денег реалистичен; обещать бесплатный полный переход нельзя.

25.12. Предыстория: «шведский стол» в Березовском ПНИ (2013)

Поиск при второй редакции нашёл кейс, который на десятилетие старше остальных. 12 апреля 2013 года информационное агентство со ссылкой на пресс-службу правительства Свердловской области сообщило, что в Березовском психоневрологическом интернате «впервые в регионе» внедрена система питания по типу «шведского стола»[172]. С начала апреля жители выбирают блюда сами; меню составляется на неделю, и на каждый день предусмотрено несколько салатов, первых и вторых блюд. Заместитель министра социальной политики области сформулировал принцип так: у каждого человека, живёт ли он дома или в интернате, «должно быть право выбора тех блюд, которые он предпочитает». Средняя стоимость питания в интернате, по тому же сообщению, составляла 115 рублей в сутки (данные 2013 года, не сопоставимые с нынешними ценами без пересчёта). Автор новости добавил, что опыт «будет распространён во всей Свердловской области».

Повторных публикаций о том, сохранилась ли практика и распространилась ли она, поиск 09.10.2026 не нашёл. Поэтому кейс годится не как доказательство устойчивости, а как исторический факт: в российском ПНИ выбор блюд, вплоть до самообслуживания, публично декларировался органом власти ещё в 2013 году. Он же напоминает о главном уроке раздела 25.10: обещание «распространить на всю область» без последующих отчётов не позволяет понять, чем закончилась практика.

25.13. Фон: как выглядит типовое положение о питании без выбора

Чтобы оценить шаг, который сделали учреждения из разделов 25.2–25.6, полезно посмотреть на типовые локальные акты, где о выборе ничего не сказано. Два найденных при второй редакции положения показательны.

В положении об организации питания Сормовского дома-интерната (Нижегородская область) допускается «замена одного продукта другим при сохранении химического состава и энергетической ценности»[173]. Это замена продукта по технологической таблице, а не выбор блюда жителем: словари раздела 8.1 здесь как раз нельзя смешивать. Там же установлено «централизованное четырехразовое питание», хотя в расписании пять приёмов, включая второй ужин в 20:00, — мелкое, но характерное несоответствие текста и практики.

В положении отделения-интерната комплексного центра Баганского района Новосибирской области (приказ от 31.07.2020 № 86) сводное 14-дневное меню и картотеку блюд утверждает директор, индивидуализация предусмотрена только по химическому составу стандартных диет, а замены продуктов допускаются лишь вынужденные^[174]. Примечательно, что это учреждение того же региона, где работают Болотнинский и Успенский ПНИ: публичные кейсы вариативности не означают, что типовая документация региона уже учитывает выбор.

Вывод практический. Пока выбор не записан в положение о питании или в правила внутреннего распорядка (как в Серафимовском^[171]), он остаётся личной инициативой руководителя и легко исчезает при его уходе. Как закрепить выбор в документах дома — раздел 31.

25.14. Обратная сторона: когда не накормили

Разговор о выборе блюд имеет смысл только там, где базовая задача — накормить досыта и сбалансированно — решена. Публичный антипример напоминает, что это не само собой разумеется. В 2018 году издание «Медиазона» опубликовало расследование о Прокопьевском ПНИ (Кемеровская область, 500 мест), где питание было передано подрядчику по контракту, который в 2017 году оказался на 11 млн рублей дешевле предыдущего^[175]. По приведённым изданием документам, с января по август 2017 года норма по мясу выполнялась на 15 %, по сезонным овощам не выполнялась, а потеря веса отмечалась у 278 из 461 проживающего, у 121 — на три килограмма и более. Врач интерната в служебной записке назвал основной причиной снижения веса несбалансированное питание. В отношении поставщика составили протокол по ст. 6.6 КоАП; в возбуждении уголовного дела отказывали, и прокуратура дважды отменяла отказ; итог доследственной проверки на дату публикации известен не был. Администрация учреждения заявила, что смертей по причине недостатка питания не зафиксировано.

Это журналистское расследование, а не судебный факт, и связь с исходами для здоровья в нём не установлена. Но оно показывает, почему вариативность в этом докладе стоит на фундаменте раздела 7 («накормить»), а контроль за подрядчиком — на разделах 30 и 42: при аутсорсинге без измерения веса и выполнения норм вопрос «из чего выбирать» не возникает. Ответственность за качество и достаточность питания разобрана в разделе 33.

Следующий шаг блока «Контекст» — международный опыт (раздел 26): что делают в зарубежных системах, где их регулирование расходится с российским и какие нормы там появились раньше, чем у нас.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и сверка прежних маркеров — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-f/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/medaizone/poisk-2026-10-blok-f/istochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; S015, S016 и S018 при второй редакции перепроверены, S018 исправлен по содержанию.

Маркер	Источник
S090	ЕАН. «В свердловских домах для престарелых и инвалидов внедряют "шведский стол"» (Березовский ПНИ), 12.04.2013

Маркер	Источник
S091	ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Положение об организации питания (веб-версия, без реквизитов)
S092	МБУ «КЦСОН Баганского района» (НСО). Положение об организации питания в отделении «Дом-интернат (пансионат) общего типа», приказ от 31.07.2020 № 86
S093	Сологуб Н. «Две смерти, четыре грамма горошка и хлеб вместо котлет. Голодный год в Прокопьевском психоневрологическом интернате» // Медиазона, 08.02.2018

26

Международный опыт: проверяемые нормы зарубежных систем

Раздел 25 показал, что делают российские дома. Здесь — ориентиры и предупреждения из зарубежных систем ухода: Великобритании и Ирландии, Австралии, Канады (Онтарио), США, Скандинавии, Германии и Австрии, Нидерландов и Японии.

Зарубежный опыт обычно приводят в двух жанрах: как образец («у них давно так») или как экзотику («у нас так нельзя»). Оба жанра бесполезны для директора, которому в понедельник нужно переписать положение о питании. Эта глава построена иначе. Из каждой системы берётся то, что можно проверить: число, процедура, формулировка нормы, — и рядом указывается, какой у неё статус у себя дома и насколько она переносима на российские ДСО и ПНИ. Ключевые формулировки даны в переводе на русский; оригиналы и проверенные числа — в реестрах (раздел 44 и реестр поиска 2026-10).

26.1. Правила заимствования

Правил три. Первое: берутся только **проверяемые нормы** — числа, процедуры, документы, а не «ценности» и «подходы». Второе: к каждой норме указывается её статус в своей системе (закон, подзаконный акт, национальный стандарт, профессиональное руководство, условие оплаты) и **граница применимости**. Большинство норм написаны для гериатрии, а не для психиатрии; перенос на ПНИ — наша адаптация, и она так и маркируется. Третье: превосходные степени исключены, сравниваются механизмы, а не страны.

Справка. Статусы зарубежных норм. В этой главе встречаются документы разной силы. **Закон и подзаконный акт** (английский Regulation 14, ирландский S.I. 415/2013, канадский O. Reg. 246/22, американский 42 CFR §483.60) обязательны, их нарушение ведёт к санкциям. **Национальный стандарт качества** (австралийский Standard 6, шотландские Health and Social Care Standards, нидерландский Kwaliteitskader) — основа для инспекции и аккредитации; формально он может не быть законом, но без его выполнения учреждение не проходит проверку или не получает финансирование. **Профессиональное руководство** (британской диетической ассоциации, немецкого общества питания DGE, шведского продовольственного ведомства) — рекомендация специалистов; иногда она превращается в обязательную через сертификацию или договор. **Хартия** (немецкая Pflege-Charta) — декларация прав без собственной санкции. Для российского дома ни одна из этих норм не обязательна; переносится механизм, оформленный своим локальным актом (раздел 31).

26.2. Великобритания: регуляторный минимум и психиатрическая специфика

Англия: Regulation 14. Базовая обязательная норма — регламент 14 «Удовлетворение потребностей в питании и питье», за исполнением которого следит регулятор CQC[52]. Его первая часть лаконична: «Потребности получателей услуг в питании и питье должны удовлетворяться». Содержание этих потребностей раскрыто в четырёх пунктах, и один из них прямо касается выбора: удовлетворение «любых разумных требований получателя услуг к еде и питью, вытекающих из его предпочтений либо религиозной или культурной принадлежности». Руководство CQC переводит это в практику: «люди должны иметь возможность выбирать своё питание», а предпочтения учитываются в том числе «относительно времени подачи, места подачи и количества» — то есть не только по составу блюда. Тем, кто отсутствовал или спал, еду должны подать в другое время; тем, кто предпочитает есть «понемногу и часто», между приёмами должны быть доступны перекусы. Санкции серьёзны: за нарушение регламента CQC может сразу перейти к уголовному преследованию, не направляя предварительного предупреждения. Для людей, неспособных принимать решения, регламент отсылает к принципу наилучших интересов по Закону о психической дееспособности 2005 года и требует побуждения и помощи в еде; соотношение этого принципа с российскими институтами опеки — тема раздела 16.

Психиатрические стационары: руководство BDA. Единственное найденное руководство именно для психиатрических стационаров выпустила Британская диетическая ассоциация[47, 176]. Из него переносимы: гибкий завтрак для людей, седатированных утром; меню без приборов (finger food) там, где приборы небезопасны; протокол питания в изоляции (посуда, текстура, фиксация потребления, порядок эскалации); лекарственно-пищевая таблица в меню (раздел 11); самостоятельное приготовление еды (self-catering) на реабилитационных отделениях.

Шотландия: стандарты от первого лица. Шотландские стандарты здравоохранения и социальной помощи 2017 года[177] сформулированы как высказывания самого человека, и пищевой блок в них читается как готовый перечень прав жителя: «Я могу выбирать прилично поданную и полезную еду и перекусы, включая свежие фрукты и овощи»; «Если мне нужна помощь в еде и питье, её оказывают с достоинством и с уважением к моим личным предпочтениям»; «Я могу есть без спешки, в как можно более спокойной обстановке»; «Если я хочу, я могу есть вместе с другими получателями услуг и с персоналом»; «Если это уместно, я могу сам готовить себе еду и напитки, с помощью, если она нужна»; «Я могу пить свежую воду в любое время». Форма «я могу» удобна для российского дома: её можно почти без изменений перенести в анкету совета жителей (раздел 34) и спросить, выполняется ли каждое утверждение.

«Защищённые приёмы пищи». Британская практика ограждать время еды от процедур и обходов популярна, но систематический обзор признаёт её доказательную базу недостаточной[178, 179]; подробнее — раздел 27.3.

26.3. Австралия: еда как самостоятельный стандарт

С 1 ноября 2025 года, одновременно с новым законом об уходе за пожилыми (Aged Care Act 2024), в Австралии действуют обновлённые стандарты качества, и питание в них выделено в отдельный Стандарт 6 «Food and Nutrition»[45]. Он применяется только к стационарному уходу. Ожидание

сформулировано от лица пожилого человека: «Я получаю вдоволь еды и напитков, которые мне нравятся». Ключевое действие 6.3.2 гласит: «При каждом приёме пищи человек может выбирать, что, когда, где и как он ест и пьёт». Действие 6.3.4 требует, чтобы питательные перекусы и напитки, включая воду, предлагались и были доступны «в любое время». Меню, включая блюда изменённой текстуры, составляются вместе с проживающими, поварами и аккредитованным диетологом и пересматриваются «не реже раза в год путём оценки меню и приёмов пищи аккредитованным практикующим диетологом» (6.3.1). Отдельно оговорено, что проживающие могут разделить еду и напитки со своими посетителями (6.4.3), а помощь в еде оказывается в темпе, который предпочитает человек (6.4.1).

Регулятор — Комиссия по качеству и безопасности ухода за пожилыми — издаёт для получателей услуг информационные листки на многих языках, в том числе на русском. В официальном русском переводе принцип звучит так: «Вы вправе выбирать, что, где и когда есть и пить»[180]. Там же сказано, что жилец вправе высказывать претензии касательно еды, и описан порядок: сначала поставщик услуг (можно с помощью родственника или правозащитника), затем Комиссия.

Текстуры по IDDSI подаются достойно, а если человек хочет есть пищу, связанную с риском, используется процедура «осознанного риска» (dignity of risk)[68]; подробно об этом — раздел 10.5.

Финансовая опора стандарта появилась после общественного скандала. Исследование Нуго и соавт. показало медиану расходов на сырьё 8,00 австралийских долларов на жителя в день[181]. В ответ государство ввело надбавку 10 австралийских долларов в день — **в обмен на обязательную ежеквартальную отчётность о расходах на питание**[182]. Принцип «деньги в обмен на прозрачность» — самый переносимый финансовый элемент из всех зарубежных систем (раздел 29). Стандарт 6 при этом действует меньше года: это норма на старте, а не проверенная модель (раздел 26.10).

26.4. Онтарио: решётка измеримых норм

Подзаконный акт Онтарио O. Reg. 246/22 — самая детальная из найденных конструкций[27]. Цикл меню — не менее 21 дня; на обед и ужин предлагается альтернативный выбор основных блюд, овощей и десертов, а при всех приёмах пищи и перекусах — выбор напитков (ст. 77(1)); **совет проживающих рассматривает цикл меню**, а утверждает его штатный диетолог; еда и напитки, соответствующие рационам жителей, доступны круглосуточно (ст. 77(7)). Ссылку первой редакции на согласование советом времени приёмов пищи в тексте регламента 2022 года (ст. 74–84) подтвердить не удалось. Изменение веса на 5 % за месяц, 7,5 % за три месяца или 10 % за шесть месяцев автоматически запускает междисциплинарную оценку. Время диетолога нормировано: не менее 30 минут на жителя в месяц. Для кормления установлено правило: **один работник помогает не более чем двум кормимым одновременно, а еду подают только тогда, когда помощь готова**. Профессиональные рекомендации диетологов Канады добавляют триггеры по потреблению: съедено не более 25 % порции в двух из трёх приёмов пищи в течение недели или отказ от трёх приёмов подряд[94]. Почти всю эту решётку можно перенести в российский локальный акт без изменения закона (разделы 12, 20, 21).

26.5. США: альтернатива при отказе и ночной интервал

Федеральное правило 42 CFR §483.60[46] требует, чтобы при отказе жителя от блюда ему предложили **альтернативу сходной питательной ценности**, и ограничивает перерыв между существенным ужином и завтраком **14 часами** (16 — если вечером дан питательный перекус). Нарушения фиксируются инспекционными «F-тегами» — пронумерованными пунктами проверочного перечня; пищевому блоку соответствуют F800–F807[183]. Переносима не система штрафов, а механика пронумерованных пунктов: её можно использовать во внутреннем аудите (приложения 18–24).

26.6. Скандинавия: ночной интервал, совместный стол и цена питания

Швеция. Руководство продовольственного ведомства Livsmedelsverket устанавливает ночной интервал **не более 11 часов** с обязательным вечерним перекусом, шесть пищевых событий в день и пищевой совет (matråd) с участием проживающих[39, 156]. В доме Tallgläntan норму интервала замеряли дважды в год; она соблюдалась у 79 % проживающих[156]. Этот пример показывает, что индикатор помещается в одну строку расписания.

Норвегия. 10 сентября 2026 года норвежский Директорат здравоохранения вынес на обсуждение проект национальной рекомендации «Еда, приёмы пищи и питание в службах здравоохранения и ухода», который заменит прежний справочник Kosthåndboken; приём замечаний открыт до 3 декабря 2026 года[184]. Проект содержит прямые числовые ориентиры: «Ночной перерыв в еде не должен превышать 11 часов»; учреждения с круглосуточным пребыванием «должны предлагать четыре основных приёма пищи в день»; горячий обед желательно подавать после 16:00; меню должно вращаться не менее трёх недель. О выборе сказано: «Учреждению следует обеспечить возможность выбора и разнообразие блюд и продуктов», а для расширения свободы выбора может предлагаться вегетарианская альтернатива. Все эти пункты имеют модальность «bør»: отступление от них допустимо, но должно быть профессионально обосновано. Это проект, а не действующая норма, и в нём есть внутренние несостыковки (в разных таблицах ланч указан в 11–13 и в 12–14 часов).

Финляндия. Национальная рекомендация предлагает, чтобы **персонал ел вместе с проживающими**[40, 185]. Это бесплатный способ наблюдения: сотрудник за общим столом видит, кто не доел, кто не справляется с прибором и кто отодвинул тарелку.

Дания. Датская система интересна не нормой выбора, а ценовой рамкой. Жители домов ухода оплачивают пакет питания, который покрывает все приёмы пищи за день, и закон ограничивает его цену: в 2026 году — не более 4 453 крон в месяц; право свободно выбирать поставщика питания для жителей домов ухода не действует[186]. Для российской дискуссии это пример того, как государство нормирует не только состав, но и предельную плату за питание (раздел 29); переносить датские суммы бессмысленно.

Ориентир для российского дома. Наш рабочий ориентир — не более 13 часов ночного интервала. Это не отдельная норма, а точка внутри международного диапазона 11–14 часов. Типичный пример: ужин в 17:30 и завтрак в 8:30 дают 15 часов; это исправляется сдвигом на час и вечерним перекусом без новой сметы (раздел 13.9). В Серафимовском второй ужин и завтрак

дают 11–12 часов (раздел 25.5). *Определения «приёма пищи» и порядок учёта перекуса в разных системах различаются, поэтому считать нужно фактический интервал своего дома, а не сравнивать цифры положений.*

26.7. Германия и Австрия: биография, желание и конец «диабетического стола»

Германия: стандарт DGE. Немецкий стандарт качества питания для учреждений для пожилых (DGE-QST) работает через сертификацию с аудитом. Корпус доклада опирается на версии, где закреплены: **«пищевая биография» (Essbiografie)** при поступлении — прототип нашей пищевой карты; **«пища по желанию» (Wunschkost)** при критических состояниях и в терминальной фазе; цикл меню не менее четырёх недель; ежедневное вегетарианское предложение; замещающая еда для пропустивших приём; выход поваров к жителям с дегустациями[34, 35]. Издание 2023 года[187] подтверждает общий принцип: еду следует выстраивать «по желаниям и предпочтениям жителей», кухня «вовлекает жителей в планирование меню», например через дегустации новых рецептов, а индивидуальные пожелания могут вноситься «в выбор блюд» и в рамках назначенной формы питания. Разделы о Wunschkost и о времени приёмов пищи в извлечённой части издания 2023 года не прочитаны, поэтому конкретные формулировки этих разделов перепроверены не были.

Германия: Хартия прав. Хартия прав людей, нуждающихся в помощи и уходе (Pflege-Charta), изданная федеральными министерствами по делам семьи и здравоохранения, сама по себе не обязательна, но служит ориентиром для всех, кто отвечает за уход[188]. Её статья 4 переводит выбор в язык ожиданий человека: «Вы вправе ожидать, что ваши предпочтения и неприязнь в еде и питье будут учтены»; «Перекусы и напитки должны быть вам доступны в любое время»; «Вы вправе ожидать, что по вашему желанию еду подадут и вне установленного времени приёма пищи». О помощи в еде сказано, что подавать следует то количество, которое человек хочет, и столько времени, сколько ему нужно. Статья 6 называет участие жителей «при составлении меню». В статье 1 «что вы едите» стоит в одном ряду с тем, как и когда человек моется: еда — часть самоопределения, а не только снабжения.

Австрия. Обновлённый в 2022 году австрийский стандарт качества питания в домах для пожилых провозглашает **либерализацию диет**: общего «диабетического стола» нет, решение принимается индивидуально и с участием проживающего[51]. Российская граница этого принципа очевидна: диету назначает врач (раздел 17), и кухня её не отменяет. Исследование SUNRISE показало, что **аппетитные названия блюд измеримо меняют выбор**[189]; это самая дешёвая из всех норм раздела. Оговорка: французское исследование в домах ухода не нашло влияния названий блюд на потребление и удовольствие от еды[190]. Оба вывода совместимы: название может менять то, что человек выбирает, и не менять того, сколько он съест (раздел 27.2).

26.8. Япония: как стимул стал стандартом

Японский путь занял шестнадцать лет. В 2005 году ввели доплату за нутритивный менеджмент; к 2020 году ею пользовались 87–94 % учреждений; в 2021 году нутритивный менеджмент стал обязательным стандартом с **вычетом из оплаты за неисполнение** и сдачей данных в национальную базу LIFE[191, 192, 193]. Доплата ассоциирована с меньшим риском ухудшения

уровня потребности в уходе (HR 0,90)[194]. Больше диетологов в штате — ниже риск потенциально предотвратимых госпитализаций (скорректированный HR 0,72; 95 % ДИ 0,54–0,97; ретроспективная когорта 2 909 жителей 235 домов; BMC Geriatrics, 2023)[195]. Это наблюдательное исследование, а не РКИ; данные одной префектуры; авторы призывают к осторожности в причинной интерпретации. При второй редакции страницу издателя открыть не удалось, число оставлено по проверке первой редакции.

В первой редакции здесь же утверждалось, что «структурированная поддержка питания в наблюдательных когортах ассоциировалась и со снижением смертности (HR 0,90)» со ссылкой на M-sup_hous. Проверка показала, что под этим маркером стоит другая работа — голландский метаанализ вмешательств в образ жизни у людей с тяжёлыми психическими расстройствами в поддерживаемом жилье, где данных о смертности нет, а значимым оказалось лишь малое уменьшение окружности талии[196]. Утверждение о смертности снято; сама работа разобрана в разделе 27.3.

Урок Японии — в траектории: норма росла шестнадцать лет и начиналась с денег за специалиста, а не с призывов к качеству (ставки — раздел 38, вопрос 5).

26.9. Переносимые нормы — сводка

№	Норма	Источник	Российская посадка
1	Ночной интервал не более 11–14 ч	Швеция, Норвегия (проект), США	Расписание и перекус (раздел 13.4)
2	Альтернатива при отказе обязательна	США	Таблицы замен и правило в положении
3	Выбор «что, когда, где и как» при каждом приёме	Австралия, Онтарио, Ирландия	Лестница моделей (раздел 8)
4	Замещающая еда пропустившим; гибкий завтрак	Англия (CQC), Германия, BDA	Пункт положения о питании
5	Аппетитные названия блюд	Австрия	Доска меню (0 руб.)
6	Пищевая биография при поступлении	Германия	Приложение 3
7	Совет жителей о меню и времени приёмов	Онтарио, Швеция, Германия (Хартия)	Раздел 34, приложение 30
8	Триггеры: вес 5/7,5/10 %; 25 % порций; три отказа	Онтарио	Разделы 12, 21, приложение 9
9	Кормление 1:2; еда — только под готовую помощь	Онтарио	Раздел 20 (ориентир)
10	Отчётность о расходах на сырьё	Австралия, Япония	Раздел 29, панель показателей
11	Предпочтения обсуждены и записаны не реже раза в 6 месяцев	Нидерланды	Индикатор панели (раздел 22)
12	Вода и перекусы доступны в любое время	Шотландия, Австралия, Германия (Хартия), Ирландия	Буфет отделения (раздел 13.9)

Во всех рассмотренных системах выбор закреплён законом, стандартом, хартией или условием оплаты. Порядок действий для российского дома один: взять проверяемую норму, пометить её происхождение, внедрить локальным актом и измерять (раздел 22).

26.10. Как читать зарубежные нормы без романтизации

Три фильтра. **Ресурс.** Нормы Онтарио (диетолог 30 минут на жителя в месяц[27]) принадлежат системе с другим финансированием; переносится принцип «время специалиста нормируется», а не минуты. **Правовая конструкция.** F-теги[183] и Regulation 14[52] работают благодаря инспекции с денежными и уголовными санкциями; переносится механика пронумерованных пунктов во внутренний аудит, а не штрафы. **Зрелость.** Стандарт 6, действующий с 01.11.2025[45], — норма на старте, а норвежская рекомендация 2026 года пока только проект[184]; переносится формулировка («что, когда, где и как я ем») как ориентир, а не как проверенная модель.

Романтизация и ксенофобия одинаково отменяют анализ. Правильный вопрос — какой механизм работает и есть ли он у нас. Из десяти норм первой редакции сводки восемь уже имеют российскую рамку: совет жителей, журнал, альтернатива при отказе, триггеры веса, ночной интервал. Две новые строки (пересмотр предпочтений раз в полгода, вода и перекусы в любое время) тоже не требуют ничего, кроме локального акта.

26.11. Ирландия: выбор как обязанность руководителя

Ирландия — пример того, как выбор записан прямо в подзаконном акте. Регламент 18 «Еда и питание» ирландских правил ухода в центрах для пожилых (S.I. No. 415/2013)[197] обязывает руководителя обеспечить, чтобы каждому проживающему: был доступен безопасный источник свежей питьевой воды в любое время; **«при каждом приёме пищи предлагался выбор»**; предоставлялась еда в достаточном количестве, правильно приготовленная, полноценная и соответствующая диетическим потребностям, назначенным медицинским или диетологическим персоналом на основе оценки питания по индивидуальному плану ухода. Отдельные пункты требуют подавать еду, напитки и перекусы «в любое разумное время» и обеспечить во время еды достаточное число сотрудников для помощи жителям.

Конструкция поучительна тем, что выбор и медицинские назначения стоят в одной фразе и не противоречат друг другу: выбор предлагается при каждом приёме, а диета определяется специалистами по оценке. Именно так устроена российская модель «выбора внутри назначения» (разделы 10.10 и 19). Обязанность адресована конкретному лицу — руководителю центра; для российского дома это аргумент в пользу того, чтобы ответственность за выбор была закреплена в должностной инструкции, а не «за всем коллективом» (раздел 28).

26.12. Нидерланды: выбор как измеряемый индикатор

Нидерландская рамка качества сестринского ухода (Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, 2017, актуализация 2021)[198] внесена Национальным институтом здравоохранения в законный Реестр стандартов качества и служит основой для надзора и отчётности. Отдельного раздела о выборе блюд в ней нет; еда входит в тему «жилой комфорт»: «Гостеприимство, еда, уборка и обстановка во многом определяют, как жители воспринимают свою повседневную среду». Общий принцип автономии выражен вопросом от лица жителя: «Могу ли я как можно больше решать сам».

Интереснее способ измерения. Среди обязательных индикаторов базовой безопасности есть «внимание к еде и питью: пищевые предпочтения клиента»[199]. Он определяется как доля жителей отделения, с которыми (или с семьями которых) за последние шесть месяцев **обсуждались пищевые предпочтения** и договорённости зафиксированы в документации ухода. Фиксировать предписано четыре вещи: предпочтения в еде и питье; предпочтения по способу подачи (количество, частота, форма); нужную помощь при еде; предпочтения по времени и месту приёмов пищи.

Для российского дома это готовый индикатор, который не требует ни денег, ни изменения закона: «доля жителей, у которых пищевая карта (приложение 3) пересмотрена за последние шесть месяцев». Он естественно ложится в панель показателей раздела 22 и проверяется по документам. Ограничение то же, что и у любого процессного индикатора: он показывает, что разговор состоялся, но не показывает, изменилась ли еда на тарелке. Поэтому его стоит ставить рядом с индикаторами результата — весом, отказами, остатками.

Новые источники главы

Полные записи, оригинальные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-f/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/istochniki/md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; `I-cqc14` и `I-aus6` перепроверены по текстам регуляторов, `M-sup_hous` исправлен по содержанию.

Маркер	Источник
<code>I-uk_scot_hscs</code>	Scottish Government. Health and Social Care Standards: my support, my life, 09.06.2017 (стандарты 1.33–1.39)
<code>I-aus_ru</code>	Aged Care Quality and Safety Commission. «Питание и прием пищи: ваш выбор имеет значение» (официальный русский перевод информационного листа)
<code>I-no_hdir2026</code>	Helsedirektoratet. Mat, måltider og ernæring i helse- og omsorgstjenesten – høringsutkast, 10.09.2026
<code>I-dk_madordning</code>	Borger.dk. Madlevering og madordning (ældreloven §§ 13–14; потолок 4 453 крон в месяц, 2026)
<code>I-dge_qst2023</code>	DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung mit „Essen auf Rädern“ und in Senioreneinrichtungen. Bonn: DGE, 2023
<code>I-de_charta</code>	BMFSFJ, BMG. Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen, 14. Aufl. (2018/2020)
<code>I-ie_si415</code>	S.I. No. 415/2013 Health Act 2007 (Care and Welfare of Residents in Designated Centres for Older People) Regulations 2013, Reg. 18
<code>I-nl_kader</code>	Zorginstituut Nederland. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (2017, актуализация 2021)
<code>I-nl_ind</code>	Zorginstituut Nederland / Zorginzicht. Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg, verslagjaar 2019: индикатор «Aandacht voor eten en drinken»
<code>M-mealctx_divert</code>	Divert C. et al. Improving meal context in nursing homes. Impact of four strategies on food intake and meal pleasure // Appetite. 2015;84:139–147

Что говорят исследования: доказательные вмешательства и их границы

Доклад о вариативном меню легко превратить в рекламу: выбор — это хорошо, значит, он улучшает всё сразу, от аппетита до качества жизни. Эта глава делает обратное. Она перечисляет, что действительно измерено, у кого и каким способом, и отдельно — что не измерено нигде. Вывод неудобен, но полезен: выбор за столом опирается прежде всего на право и на здоровый механизм, а не на рандомизированные испытания, и потому каждый дом, который вводит выбор, должен измерять его последствия сам.

27.1. Зачем раздел и как его читать

Доклад опирается на исследования, а не на рекламу методик. Каждое вмешательство ниже описано с популяцией, дизайном и ограничениями. Главное ограничение общее: **почти вся доказательная база организационных вмешательств в питании получена в гериатрии, деменс-уходе и больницах, а не в психиатрии**. Перенос на ПНИ требует адаптации и собственного измерения (раздел 22).

Справка. Как читать дизайн исследования. Рандомизированное контролируемое испытание (РКИ) распределяет участников по группам случайно, поэтому различие исходов можно с большой уверенностью приписать вмешательству. В **кластерном РКИ** случайно распределяют не людей, а целые отделения или дома — так поступают, когда вмешательство меняет среду (например, способ подачи еды). **Наблюдательное (когортное) исследование** сравнивает группы, которые сложились сами; оно показывает связь, но не доказывает причину, потому что группы могут различаться и в другом. **Исследование «до — после»** сравнивает одно учреждение до и после изменения; на результат влияет всё, что изменилось за это время. **Отношение рисков (HR)** меньше 1 означает, что событие в группе вмешательства наступало реже; если 95-процентный **доверительный интервал (ДИ)** не пересекает 1, различие статистически значимо. **Систематический обзор** собирает все исследования по вопросу по заранее заданным правилам, а **метаанализ** объединяет их числа. Кокрейновские обзоры оценивают **достоверность доказательств** по системе GRADE: высокая, умеренная, низкая, очень низкая. «Низкая достоверность» означает, что истинный эффект может существенно отличаться от найденного.

27.2. Вмешательства с измеримым эффектом

Семейная подача (family-style dining). Nijs и соавт. (2006) провели кластерное РКИ в пяти голландских домах ухода: в каждом доме одно из двух отделений хронической соматической помощи случайно получило семейную подачу (общие блюда на столе, жители накладывают сами), другое сохранило обычные порционные тарелки; срок — шесть месяцев[41]. Исследование завершили 178 жителей **без деменции**, средний возраст 77 лет. Разница между группами

составила 6,1 балла по качеству жизни (95 % ДИ 2,1–10,3), 1,5 кг по массе тела (0,6–2,4) и 991 кДж в сутки по потреблению энергии (504–1 479). Сверка с текстом статьи добавила важную деталь: эффект — это **сохранение** уровня при семейной подаче на фоне **ухудшения** в контроле. Масса тела в группе вмешательства выросла на 0,5 кг, а в контрольной снизилась на 1,1 кг; качество жизни практически не изменилось (+0,4) против снижения на 5,0 в контроле. Авторы формулируют вывод осторожно: семейная подача «поддерживает качество жизни, физическую активность и массу тела проживающих домов ухода без деменции». Перенос на российские ДСО и тем более на отделения с деменцией или на психиатрический контингент **не обоснован**; механизм (социальность трапезы и самостоятельный выбор порции) можно обсуждать точно, но не как норму. Для острых состояний данных нет. Модель М4 раздела 8 опирается именно на это исследование, и при ссылке на него важно не терять оговорку «без деменции».

IDDSI и текстуры. В пяти учреждениях обучение по международной системе текстур подняло соответствие поданной пищи назначенной текстуре с 44 до 90 %, а для жидкостей — с 31 до 100 %; эффект сохранялся шесть месяцев, а главным барьером была осведомлённость персонала[67]. Перенос прямой: дисфагия есть в любом ПНИ. Подробный разбор — раздел 10.

Монтессори-подход к еде. Обучение персонала деменс-ухода занятиям по методу Монтессори улучшает самостоятельность в еде и снижает проблемное поведение за столом[119]. Это данные для когнитивных нарушений, и речь идёт о навыке персонала, а не о меню.

Поддержка во время кормления. Кокрейновский обзор 2018 года (девять РКИ, 1 502 человека с деменцией, семь испытаний в домах ухода) нашёл, что словесная или тактильная поддержка во время еды через три недели увеличивала потребление примерно на 200 ккал и 15 г белка за приём пищи[200]. Достоверность этих данных низкая, и пищевой статус в этих испытаниях не оценивали. Но направление важно для раздела 20: помощник, который сидит рядом и поощряет, а не просто ставит тарелку, — это вмешательство с измеренным, пусть и неуверенным, эффектом.

Мелкие изменения контекста. Во французском исследовании в трёх домах ухода (42 жителя, 12 приёмов пищи) приправы в центре стола значительно увеличили потребление еды, а два овоща вместо одного — потребление основного блюда[190]. Названия блюд и оформление зала, напротив, «оказались неэффективными» для потребления и удовольствия от еды. Это расходится с австрийским выводом о том, что аппетитные названия меняют выбор блюда[189] (раздел 26.7), но не противоречит ему: выбор и съеденное количество — разные исходы. Исследование малое, а числа величины эффекта на прочитанной странице не приведены.

Доплаты за нутритивный менеджмент (Япония). Доплата ассоциирована с меньшим риском ухудшения уровня потребности в уходе (HR 0,90), а большее число диетологов — с меньшим риском потенциально предотвратимых госпитализаций (скорректированный HR 0,72; 95 % ДИ 0,54–0,97)[194, 195]. *Ограничение: это наблюдательные данные, возможен отбор учреждений; причинность не доказана. Разбор японской траектории — раздел 26.8.*

27.3. Вмешательства со слабой или отрицательной доказательностью

Защищённые приёмы пищи (protected mealtimes). Систематический обзор признаёт доказательную базу **недостаточной**: исследования малочисленны и неоднородны[178, 179]. Более поздний систематический обзор больничных вмешательств подтверждает: защищённые приёмы

пищи не увеличили потребление энергии и белка[201]. Вердикт: мера разумная и бесплатная, но не «доказанная»; её стоит внедрять как организационную гигиену, без обещания эффекта.

Средовые и поведенческие изменения при деменции в целом. Тот же Кокрейновский обзор[200], который нашёл слабый сигнал у поддержки во время кормления, в целом заключает: «мы не можем указать ни одной конкретной средовой или поведенческой модификации» с доказанным влиянием на потребление еды и жидкости. Дополнительные перекусы, обучение питанию, тренировка самостоятельной еды и обучение медсестёр дали очень малые или неопределённые эффекты при низкой или очень низкой достоверности. Причина — малые и методически слабые испытания, а не доказанная бесполезность.

Вмешательства в образ жизни для снижения веса при тяжёлых психических расстройствах. Метаанализ даёт средний эффект порядка $-1,4$ кг[102]: статистически реальный, клинически скромный. Программы с участием диетолога сильнее[103]. В поддерживаемом жилье для людей с тяжёлыми психическими расстройствами картина ещё скромнее: метаанализ восьми РКИ (1 187 участников) не нашёл значимого влияния на массу тела и ИМТ, а единственным значимым исходом оказалось малое уменьшение окружности талии ($g = 0,142$; 95 % ДИ 0,001–0,284)[196]. Авторы пишут, что нашли «ограниченные доказательства эффективности вмешательств в образ жизни для физического здоровья». Метаболическая стратегия дома — это среда и мониторинг (раздел 13), а не ожидание больших цифр.

Малые дома (Green House, Eden Alternative). Оценки показывают улучшение качества жизни и питания[48, 154], но это системные реформы (штат, архитектура, финансирование), а не приёмы: горизонт, а не действие на следующей неделе.

27.4. Что доказано про вес и препараты (свод клинического ядра)

Клинические факты собраны в одной таблице; разбор — в разделах 10–13. **Campforts 2023 (BJPsych Open, CRWG) — исследование веса на антипсихотиках, а не меню.**

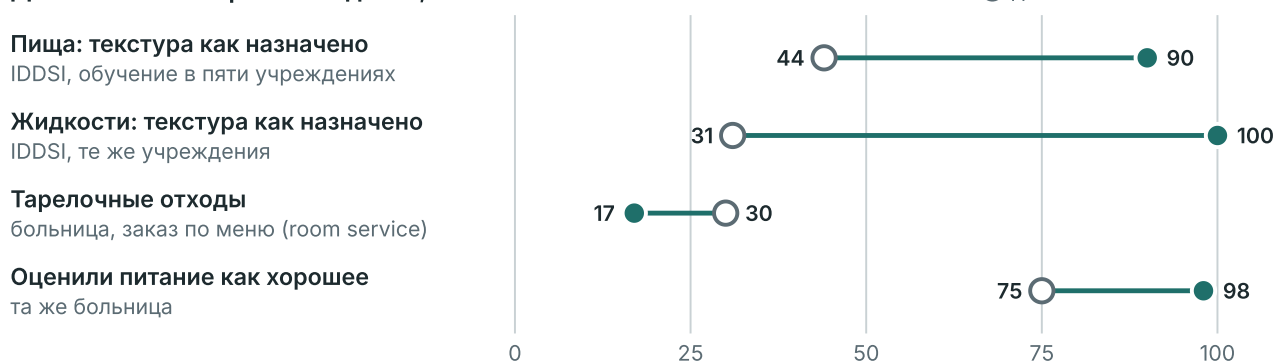
Факт	Число	Источник
Разброс прибавки веса между антипсихотиками (6 недель)	от $-0,23$ до $+3,01$ кг	Метаанализ 100 РКИ[13]
Клинически значимая прибавка (≥ 7 %) при клоzapине	76,3 % пациентов	Campforts 2023, консенсус CRWG[99]
Прибавка при первом эпизоде психоза (оланzapин)	до $+9,34$ кг	FEPWG[100]
Кофеин повышает AUC клоzapина	в среднем $+19$ %	Контролируемое исследование[17]
Грейпфрут повышает концентрацию карбамазепина	порядка $+40$ %	Фармакокинетика[20]
Распространённость дисфагии при психических расстройствах	21,9–69,5 %	Обзоры[1, 29]
Смертность от пневмонии при тяжёлых психических расстройствах	RR 7,00	Национальные когорты[15]
Разрыв продолжительности жизни при тяжёлых психических расстройствах	15–20 лет	Национальные когорты[15]

27.5. Что исследования не говорят (честные пробелы)

1. **Нет РКИ вариативного меню в психиатрических учреждениях.** Внедрение выбора опирается на нормы, практики и здоровый механизм, а не на рандомизированные исходы. Поиск 2026 года этот пробел не закрыл. Это не аргумент против внедрения, но аргумент за собственное измерение (раздел 22).
2. **Нет надёжных данных о том, что вариативность снижает отходы в домах социального обслуживания.** Связь правдоподобна, и в больницах она уже наблюдалась (раздел 27.6), но в домах ухода исследования отходов в основном только измеряют их, а не проверяют вмешательства: обзорное исследование 2026 года нашло среди 33 источников лишь три работы, где проверялось какое-либо вмешательство^[149]. Позиция доклада прежняя: замерить отходы до и после (приложение 25), а не цитировать чужие проценты.
3. **Нет данных по российским ПНИ.** Отечественной исследовательской базы по питанию в ПНИ мы не нашли ни при подготовке доклада, ни при второй редакции. Это находка для семинара: отраслевые данные могут дать только сами учреждения (раздел 39).

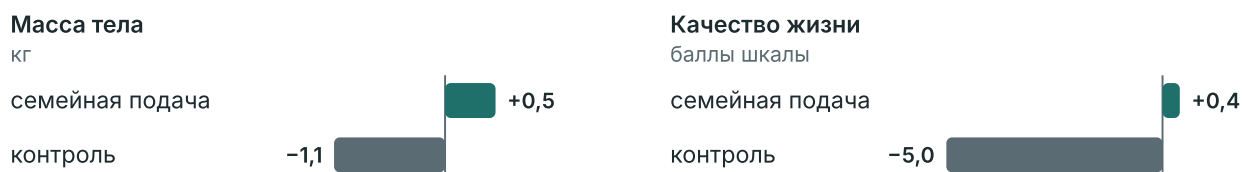
Итог раздела укладывается в три опоры. Вмешательства с измеримым эффектом (семейная подача, IDDSI, Монтессори, диетологи) применяются по показаниям. Слабо доказанные (защищённые приёмы пищи, программы образа жизни) внедряются как гигиена, без обещаний. Пробелы (вариативность, отходы, российские данные) дом закрывает собственным измерением. Кто внедрил выбор и замерил отходы, вес и жалобы, через год владеет доказательством, которого сейчас нет ни у кого в стране.

До и после: измеренные сдвиги, %



Больница — исследование «до — после» в одном учреждении; на дом социального обслуживания не переносится.

Семейная подача: изменение за шесть месяцев (кластерное РКИ, жители без деменции)



Эффект — сохранение уровня на фоне ухудшения в контроле; на ДСО, деменцию и психиатрию не переносится.

Три опоры раздела 27.5

Измеримый эффект — по показаниям

Семейная подача (без деменции); обучение IDDSI; Монтессори при деменции; поддержка при кормлении — около 200 ккал и 15 г белка за приём, достоверность низкая

Слабо доказано — как гигиена

Защищённые приёмы пищи; средовые изменения при деменции; программы образа жизни при тяжёлых психических расстройствах — около -1,4 кг

Пробел — собственный замер

Нет РКИ вариативного меню в психиатрии; нет данных об отходах в домах ухода (вмешательство проверяли 3 работы из 33); нет данных по российским ПНИ

Рисунок 20. Что измерено и что нет: сдвиги «до — после» в зарубежных исследованиях, эффект семейной подачи как сохранение уровня и три опоры раздела 27.5. Зарубежные числа на российские ДСО и ПНИ прямо не переносятся[41, 67, 102, 147, 149, 200]

27.6. Что добавил поиск 2026 года: выбор, отходы и психиатрический стационар

При второй редакции найдено несколько работ, которые не меняют выводов раздела 27.5, но уточняют их.

Выбор и качество жизни в домах ухода. Интегративный обзор девяти исследований о доступе пожилых людей в домах ухода к выбору еды выделил три темы: насколько выбор вообще доступен и учитываются ли предпочтения; как выбор связан с пищевым статусом; как он влияет на автономию и качество жизни[202]. Барьерами названы недостаточное понимание персоналом связи выбора с автономией, неподходящая обстановка столовых и слабые требования регулирования и аккредитации. Вывод авторов: «неспособность обеспечить удовлетворяющий выбор еды сказывается на качестве жизни пожилых людей». Это обзор качественных и наблюдательных работ, а не испытаний; он подтверждает механизм, но не измеряет эффект.

Заказ по меню и отходы в больнице. Самое сильное из найденных свидетельств связи выбора с отходами получено не в домах ухода, а в больнице. В австралийской государственной больнице переход от стандартной раздачи к заказу еды по меню в любое время (room service) сопровождался ростом потребления энергии с 5 513 до 6 379 кДж в сутки и белка с 53 до 74 г, снижением тарелочных отходов с 30 до 17 %, ростом доли пациентов, оценивших питание как хорошее, с 75 до 98 % и снижением затрат на продукты на 28 % в год[147]. Это исследование «до — после» в одном учреждении, и его нельзя переносить на дом социального обслуживания напрямую: другая длительность пребывания, другие пациенты, другая кухня. Систематический обзор больничных вмешательств осторожно обобщает: «персонализация питания и эффективная доставка по заказу могут улучшать потребление, одновременно сокращая пищевые отходы», но подчёркивает слабость доказательств (в основном наблюдательные работы, только два РКИ)[201]. Там же электронный заказ у постели увеличивал потребление во всех трёх исследованиях, а по отходам результаты расходились.

Психиатрический стационар. Одно из немногих исследований питания именно в психиатрии — наблюдательная работа в трёх специализированных австралийских стационарах (74 взрослых) [203]. Медиана потребления энергии составила 6 954 кДж в сутки при оценочной потребности 8 607; белка потребляли больше потребности (85 г против 59). Половина пациентов ела еду из внешних источников, а качество еды получило самые низкие оценки среди всех сторон обслуживания. Данных о выборе блюд в работе нет. Для российского ПНИ это напоминание, что недоедание по энергии может соседствовать с избытком белка и что «еда из передач» — это значимая часть рациона, которую кухня не видит.

Вместе эти работы делают картину раздела 27.5 точнее, но не меняют её: выбор и персонализация **правдоподобно** связаны с потреблением и отходами, и в больницах такая связь наблюдалась, но для домов социального обслуживания и тем более для ПНИ она не измерена.

27.7. Что доклад сделал бы с грантом на исследование

Одно исследование из пробелов раздела 27.5: многоцентровое (5–7 ПНИ разных регионов) прагматичное внедрение выбора из двух вариантов с измерением отходов, веса, отказов, трудозатрат и качества жизни за шесть месяцев, с замером до и после по единой методике. Такое исследование закрыло бы главный пробел («нет РКИ вариативности в психиатрии») дешевле одного федерального форума. Шаг вперёд по сравнению с больничными работами раздела 27.6 — кластерная рандомизация отделений: тогда сравнение шло бы не «до — после», а между отделениями в одно и то же время. Общий замер семинара (раздел 40) — задел для такого исследования.

27.8. Как пользоваться базой, не становясь исследователем

К любой «научной» цифре стоит задать три вопроса. Какая популяция: психиатрия, пожилые, дети, больница? Какой дизайн: РКИ, наблюдение, «до — после» или новость? Что измерено: вес и госпитализации или «удовлетворённость» по самодельной анкете? Цифра, не выдержавшая трёх вопросов, в приказ не попадает — в лучшем случае в презентацию с оговоркой. Реестры доклада (раздел 44) размечены по этим трём осям. Четвёртый вопрос подсказала вторая редакция:

совпадает ли источник с тем, что о нём сказано. Проверка показала, что под одним маркером первой редакции стояла другая работа, чем описано в тексте (раздел 27.9); даже аккуратный реестр требует периодической сверки с первоисточником.

27.9. Три исследования, которые стоит знать в лицо

Первое — кластерное РКИ Нийса и соавт., 2006. Это семейный стиль подачи, а не смена меню; цифры и оговорка «без деменции» — в разделе 27.2[41].

Второе — IDDSI в пяти учреждениях. Обучение подняло соответствие текстур с 44 до 90 %[67]; резерв — в обучении, а не в оборудовании.

Третье — Кокрейновский обзор средовых и поведенческих вмешательств при деменции, 2018. Девять РКИ, и ни одной модификации с уверенно доказанным эффектом на потребление; лишь слабый сигнал у поддержки во время кормления[200]. Это исследование стоит знать именно потому, что оно отрезвляет: даже простые и разумные меры у людей с когнитивными нарушениями пока не доказаны.

В первой редакции третьим номером значилась «японская когорта поддержанного жилья», где питание как сервис будто бы ассоциировалось со снижением госпитализаций и смертности[196]. Сверка показала, что под этим маркером — голландский метаанализ вмешательств в образ жизни без данных о госпитализациях и смертности (раздел 27.3); утверждение снято. Японские данные о питании как услуге в корпусе есть, но это другие работы — о доплатах и диетологах[194, 195] (раздел 26.8).

В тройке нет ни российского исследования, ни исследования вариативного меню. Доказательства касаются механизмов (стол, текстуры, помощь при еде), а «две каши против одной» не проверены нигде. Честный доклад обязан сказать это вслух. Campforts 2023 в тройку не входит: это вес на антипсихотиках, а не меню.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные числа и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-f/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44; M-nijs перепроверен по тексту BMJ, M-sup_hous исправлен по содержанию.

Маркер	Источник
M-env_herke	Herke M. et al. Environmental and behavioural modifications for improving food and fluid intake in people with dementia // Cochrane Database Syst Rev. 2018; CD011542.pub2
M-mealctx_divert	Divert C. et al. Improving meal context in nursing homes. Impact of four strategies on food intake and meal pleasure // Appetite. 2015;84:139–147
M-room_service_mccray	McCray S. et al. Room service in a public hospital improves nutritional intake and increases patient satisfaction while decreasing food waste and cost // J Hum Nutr Diet. 2018;31(6):734–741
M-waste_rinninella	Rinninella E. et al. Hospital Services to Improve Nutritional Intake and Reduce Food Waste: A Systematic Review // Nutrients. 2023;15(2):310
M-waste_roulston	Roulston M. et al. Food waste in residential aged care: A scoping review // Nutr Diet. 2026;83(1):56–73

Маркер	Источник
M-racchoice_wang	Wang D. et al. Access to food choices by older people in residential aged care: An integrative review // Collegian. 2018;25:457–465
M-mhinpt_porter	Porter J., Collins J. Nutritional intake and foodservice satisfaction of adults receiving specialist inpatient mental health services // Nutr Diet. 2022;79(3):411–418

ЧАСТЬ 7

Люди и деньги

разделы 28–30

28

Люди за линией: персонал стола

Любое изменение в питании дома в конечном счёте исполняется руками. Приказ подписывает директор, меню составляет диетсестра, но второй вариант каши предлагает сиделка, гастрорёмкость на линию ставит повар, а запись в журнале делает старшая смены. Если эти люди не понимают, зачем им новая работа, не видят её границ и боятся её последствий, вариативное меню превращается в бумагу: в положении оно есть, у раздачи его нет. Поэтому глава о персонале открывает блок «Люди и деньги», а не замыкает его.

Справка. Сиделка, санитар, помощник по уходу. В российских домах социального обслуживания людей, которые кормят и ухаживают, называют по-разному: санитар(ка), сиделка, младший персонал. Действующий профессиональный стандарт называется «Помощник по уходу» (приказ Минтруда России от 31.05.2023 № 482н); его первая трудовая функция включает «приготовление пищи, подготовку пищи к приёму, кормление лиц, нуждающихся в уходе», а среди трудовых действий прямо названо «кормление, помощь при приёме пищи и соблюдении питьевого режима в соответствии с медицинскими рекомендациями»[204]. Стандарт 2018 года (приказ № 507н) назывался «Сиделка (помощник по уходу)» и выделял «организацию приёма пищи и проведение кормления» в отдельную трудовую функцию[204]. Для этой главы важно одно: кормление и помощь за столом — не «дополнительная нагрузка из милости», а профессиональная обязанность, описанная в стандарте, и, значит, её можно планировать, обучать и проверять. Ниже слова «сиделка» и «помощник по уходу» используются как синонимы.

28.1. Почему тема персонала — половина темы семинара

Формула семинара звучит так: «права, свободы, интересы жителей **и персонала**». Вторая половина формулы не дань вежливости. Изменение исполняют сиделка, повар, раздающий, диетсестра и завхоз, и доклад, который не учитывает их нагрузку и страхи, исполнен не будет. Опыт российских домов это подтверждает: в Успенском ПНИ главным препятствием оказались не деньги и не нормы, а «страхи персонала»[3]. Там же, по сообщению учреждения, эти страхи «не подтвердились» после того, как их проговорили вслух (раздел 28.7). Отсюда главный вывод главы: страх смены — управляемая величина, если его назвать, измерить и ответить на него цифрой, а не призывом.

28.2. Роли и их реальная нагрузка

Чтобы разговор о нагрузке не превращался в обмен впечатлениями, полезно разложить вариативность по ролям и для каждой назвать, что именно добавляется.

Сиделка (санитар, помощник по уходу). Она кормит, наблюдает, фиксирует и предлагает выбор. Вариативность добавляет ей пять–десять секунд на жителя на линии и несколько строк в журналах. Клинический контур добавляет внимание к признакам (дисфагия, отказы) и одну

фразу эскалации — кому и что сказать, если признак замечен. Это минуты смены, а не «энтузиазм», и считать их нужно как минуты (раздел 28.11).

Повар. При парных эквивалентах второй вариант — это та же заготовка в другой форме (раздел 19), то есть нагрузка ложится на гастрорёмкости и маркировку, а не на «второе производство». У повара появляется и то, чего ему обычно не хватает, — обратная связь: он видит, какое блюдо выбирают. Немецкий стандарт качества предусматривает выход поваров к жителям с дегустациями[35]; российский аналог — дегустация цикла с голосованием совета жителей (раздел 34).

Диетсестра (при её отсутствии — завхоз). На ней раскладка, таблицы замен и пары эквивалентов; именно диетсестра формирует перечень блюд для выбора, как это описано в опыте Болотнинского ПНИ[2]. Это единственная роль, где вариативность добавляет не минуты, а интеллектуальную работу: подбор пар и пересчёт объёмов по статистике выбора (раздел 21). Рекомендуемые нормативы Минтруда предусматривают одну ставку медицинской сестры диетической на организацию с численностью получателей услуг до 150 человек[205]; в большом доме эта работа распределяется между несколькими людьми, и её нужно явно закрепить приказом.

Врач. Чаще всего он приходящий. Его функции стоит записать письменно, иначе они «висят»: назначение текстур и ограничений, лекарственно-пищевая таблица (раздел 11), еженедельное чтение журналов отказов и потребления, пороги («триггеры») изменения веса, а в ПНИ — освидетельствование по ст. 43 закона № 3185-1[8]. Клинику кухня не назначает; врач — единственный, кто может это сделать.

Руководитель. Положение о питании и приказы, обход по чек-листу (раздел 18.5), квартальная панель показателей (раздел 22.4), разговор с учредителем (раздел 38). Руководитель не готовит и не раздаёт, но без его подписи ни одна из ролей выше не получит ни времени, ни права.

Процесс	Директор	Завпроиз- водством	Врач	Старшая смены	Сиделка	Бухгал- терия	Совет жителей
Положение о питании	A	C	C	I	I	I	C
Меню с вариантами, пары эквивалентов	A	R	C	I	I	I	C
Санитарный контур: пробы, бракераж, температура	A	R	C	I	—	—	—
Показ меню, сбор выбора	I	I	I	A	R	—	I
Карта предпочтений, пищевая биография	I	C	C	A	R	—	—
Лекарственно-пищевая таблица	I	I	A/R	C	I	—	—
Список дисфагического риска, текстуры	I	I	A	R	R	—	—
Сведения о дисфагии при переводе и госпитализации	I	—	A	R	I	—	—
Обучение первой помощи при удушье	A	I	R	C	I	—	—
Журналы: заказ, замены, отказы, срывы	I	C	I	A	R	I	—
Эскалация отказов к врачу	I	—	A	R	R	—	—
Регламент буфета и передач	A	R	C	R	I	—	C
Разбор инцидентов (приложение 34)	A	R	R	R	I	—	I
Списание продуктов	A	C	—	I	—	R	—
Закупки, претензии	A	C	—	—	—	R	—
Совет жителей	I	C	C	C	—	—	A/R
Панель чисел, отчёт учредителю	A/R	C	C	C	—	C	I

A отвечает за результат (у процесса один A)
R исполняет
C консультирует до решения
I информируется после

Клинические строки: A — врач. Клинику кухня не назначает (раздел 33.5).

Рисунок 21. Матрица ролей RACI по питанию: кто отвечает, исполняет, консультирует и информируется в семнадцати процессах; в клинических строках отвечает врач (приложение 17, разделы 28.2, 31.4, 33.5)

28.3. Норма помощи: самая болезненная цифра

Самый трудный вопрос главы — сколько людей должно быть у стола в момент еды. Международный ориентир взят из регламента провинции Онтарио к закону о долговременном уходе: один работник помогает одновременно не более чем двум жителям, которых кормят

полностью[27]. Подробно эта норма и её хронометрическое обоснование разобраны в разделе 20.3. Для большинства российских учреждений она недостижима при текущих штатах, и доклад не делает вид, будто это решается приказом.

Насколько велик разрыв, видно из российской нормативной рамки. С 1 сентября 2025 года действуют новые Правила организации деятельности организаций социального обслуживания (приказ Минтруда России от 14.05.2025 № 305н), заменившие приказ № 940н 2014 года. Их рекомендуемые нормативы штатной численности для стационарных организаций предусматривают одну должность помощника по уходу на 30 получателей услуг в смену днём и на 60 ночью для групп нуждаемости I–II и одну должность на 12 получателей в смену круглосуточно для групп III–IV[205]. Даже в лучшем случае, у самых зависимых жителей, это соотношение один к двенадцати на всю смену, а не один к двум на время еды. Нормативы эти рекомендуемые, и регионы устанавливают свои: например, в Кемеровской области штатный норматив сиделки в доме-интернате составлял одну должность на восемь коек[206], причём это ставки, а не люди на смене, и их пересчёт в присутствие у стола зависит от графика. Вывод не в том, что российские нормы «плохие», а в том, что ни одна из них не описывает час еды отдельно, и значит, этот час дом должен организовать сам.

Почему соотношение важно, показывают и зарубежные наблюдения. В систематическом обзоре одиннадцати исследований условий труда персонала в учреждениях длительного ухода приводится результат, согласно которому один дополнительный житель на дипломированную медсестру значительно повышал вероятность потери веса у проживающих[207]. Это данные другой системы и другой квалификации персонала, и прямо на российские ДСО и ПНИ они не переносятся; но направление связи — меньше рук, больше потерь веса — согласуется со здравым смыслом.

Отсюда три шага, которые доступны без новых ставок.

1. **Замер.** Сколько кормимых фактически приходится на одного работника на каждом приёме пищи: форма учёта трудовых затрат (приложение 26).
2. **Реорганизация.** Все свободные руки — на час еды, рассадка по степени помощи, порядок подачи под готовые руки (раздел 20). Новых штатов это не требует.
3. **Фиксация дефицита.** Разрыв между фактом и ориентиром оформляется числом и письменно выносится учредителю (раздел 38). Молчаливый дефицит — зона личного риска директора (раздел 33); зафиксированный дефицит становится предметом компетенции учредителя.

28.4. Обучение: три уровня за три инструктажа

Если у дома нет денег на новые ставки, у него почти всегда есть возможность обучить тех, кто уже работает. Доклад предлагает три сорокаминутных инструктажа по темам, каждый с проверкой «на линии», а не в классе:

- **клинический минимум:** признаки дисфагии (раздел 10), правило «три отказа — врач сегодня» (раздел 12), лекарственно-пищевая таблица (раздел 11); проверка — фраза, которую сотрудник произносит на обходе;

- **технология выбора:** два варианта, показ неговорящему жителю (раздел 15.5), журналы; проверка — один обед под наблюдением;
- **санитарный контур:** пробы двух вариантов, температуры, маркировка (раздел 18); проверка — сверка журналов без предупреждения.

Распределение того же материала по аудиториям (кухня, пост, администрация) дано в разделе 28.10.

Почему именно обучение называется самой дешёвой точкой рычага, показывают данные о внедрении системы IDDSI. В оценке внедрения этой системы в учреждениях ухода за пожилыми осведомлённость персонала об IDDSI колебалась от 5 до 79 % в разных учреждениях; из 84 опрошенных сотрудников о системе знали лишь 25 %, правильно сопоставить уровни с номерами и цветовой маркировкой смогли 12 %, и меньше половины считали себя достаточно обученными[67, 208]. Барьером качества оказалась осведомлённость, а не оборудование. Эти числа получены в другой стране и опубликованы в виде препринта, поэтому годятся как иллюстрация механизма, а не как оценка российских домов.

Для сравнения полезен американский ориентир. Федеральные правила для домов сестринского ухода допускают к кормлению оплачиваемых «помощников по кормлению» (paid feeding assistants) только после одобренного штатом курса продолжительностью не менее восьми часов. В программу входят техника кормления, помощь при еде и питье, навыки общения, реакция на поведение жителя, безопасность и действия в экстренной ситуации, «включая приём Геймлиха», инфекционный контроль, права жителей и умение заметить изменения в состоянии и сообщить о них медсестре[209]. Работают такие помощники под надзором медсестры и только с жителями, у которых «нет сложных проблем с кормлением»; к сложным правилам относят нарушения глотания, повторные аспирации, зондовое и парентеральное питание[209]. Три инструктажа по сорок минут — это два часа, вчетверо меньше американского минимума для самой простой группы. Американская норма у нас не действует, но она хорошо показывает, где проходит граница: человек, прошедший короткий инструктаж, может помогать за столом обычным едокам, а жителей с дисфагией кормит тот, кто обучен глубже и работает под врачебным контролем.

28.5. Мотивация и выгорание

Работают три механизма. **Видимый смысл:** статистику пилота (раздел 35) показывают смене, а не только учредителю. **Участие:** повар приходит на дегустацию, сиделка входит в совет жителей, раздающий участвует в разборе жалоб; это лучшее лекарство от «тихого саботажа», когда новое формально принято, но не исполняется. **Защита от конфликтов:** правила добавки, порций и замен записаны, и решение у линии принимает правило, а не человек, на которого потом обидятся (раздел 20.4). Два распространённых мифа о мотивации разобраны в разделе 28.9.

28.6. Типовые ошибки управления

1. **«Приказал — значит внедрил».** Без инструктажа и проверки усвоения приказ производит имитацию: журналы заполнены, выбора нет.

2. **Нагрузка «в подарок».** Новые процедуры вводятся без пересмотра смены. Итог — перегруз и откат к прежнему порядку.
3. **Наказание за данные.** Сиделка, оштрафованная за честную запись об отказах, перестанет записывать, и система ослепнет.
4. **Изменение без объяснения «зачем».** Персонал, не понимающий смысла выбора, видит в нём только лишнюю работу и по-своему оказывается прав.

28.7. Что сказать старшей смене в понедельник

Пять коротких решений: роли записаны письменно, включая роль врача; норма помощи замерена на каждом приёме; три инструктажа проведены с проверкой на линии; статистика пилота показывается смене, а не только учредителю; страхи названы вслух. Последнее не формальность: в Успенском «страхи персонала не подтвердились»[3] именно после того, как их озвучили и проверили практикой.

28.8. Беречь тех, кто кормит

Помощь за столом — эмоционально тяжёлая работа. Сиделка сталкивается с отказами, агрессией, смертью подопечных и почти не получает обратной связи. Три простых жеста меняют многое: разбор трудных ситуаций без поиска виноватых (на материале учебных кейсов 1–22); конкретная, а не дежурная благодарность («ты накормила его вчера, когда он неделю не ел»); фильтр для новых форм — вопрос «какое решение меняет эта графа» (раздел 31.7), который защищает смену от бумажной лавины.

Текучесть персонала — налог на качество. Новая сиделка не знает карт и темпов жителей, и дом с кадровой каруселью кормит хуже при любом меню. Зарубежные данные подтверждают эту связь: в упомянутом систематическом обзоре более высокая текучесть персонала в целом ассоциировалась со значимым ухудшением показателей качества ухода; в одном из включённых исследований рост текучести дипломированных медсестёр на 5,9 % сопровождался ростом доли жителей, принимающих антидепрессанты или снотворные, на 27,2 % [207]. Речь идёт о медсёстрах в странах с иной организацией ухода, и это ассоциация, а не доказанная причина. Но вывод для директора тот же: удержать опытную сиделку дешевле, чем заново научить новую.

28.9. Мотивация без мифов

Первый миф — денежный: «пока не доплатят, ничего не будет». Опыт внедривших домов прошёл без доплат [6, 24]. Настоящая валюта смены — выполнимость. Процедура, которая укладывается в смену, выполняется; процедура, добавляющая час на «бумагу», саботируется молча и, надо признать, справедливо.

Второй миф — идеологический: «главное — объяснить про права». Права убеждают руководителей; смену убеждает другое: меньше скандалов за столом, меньше недоеденных тарелок, ясные ответы на вопрос «а что мне делать, если...». Поэтому ядро инструктажа составляют не ценности, а учебные кейсы 1–22. Ценности — обязательный фон, но фон не заменяет маршрут.

28.10. Три инструктажа: содержание по аудиториям

Единый «общий инструктаж для всех» не работает: повару не нужен алгоритм отказов, а сиделке — правило ранговости пар. Поэтому материал раздела 28.4 раскладывается по аудиториям.

Кухня (45 минут): пары эквивалентов и ранговость; маркировка и пробы двух вариантов; IDDSI с тестом вилкой; лекарственно-пищевая таблица, которая лежит закладкой на рабочем месте, а не хранится в памяти; журнал срывов.

Пост (45 минут): меню в форматах, доступных жителям; журнал заказа, который заполняется при жителе; алгоритмы отказов (приложения 10–11); признаки дисфагии; запрет использовать еду как рычаг поощрения и наказания; помощь в темпе едока.

Администрация (30 минут): правовая рамка (раздел 17); ответ проверяющему (раздел 32); панель показателей.

Обе раскладки дают в сумме те же 120 минут: три темы по сорок минут или три аудитории по 45, 45 и 30. Различается срез, а не объём. При найме инструктаж проводится до первой смены, далее — раз в год. Проверка — три вопроса у линии: «что вы сделаете, если выбранное блюдо кончилось?», «кому вы скажете о трёх отказах?», «покажите запись вчерашнего заказа».

28.11. Трудоёмкость выбора: человеко-минуты, которые нужно знать директору

Главный страх смены звучит так: «это добавит час на каждую раздачу». Реальная цифра другая, и её стоит показать. Ниже — **иллюстративная раскладка** для обеда на отделении из 30 жителей в модели М1, то есть при выборе из двух вариантов в одной позиции на части приёмов и дней (раздел 8.2; в расчёте — обед два-три дня в неделю). Оценки экспертные и опираются на аналоги из канадского руководства по полной стоимости питания (раздел 29.2)^[94]; это не замеры в российских учреждениях, и **собственный замер обязателен** (приложение 25, раздел 22.3).

Действие	Без выбора (мин)	С выбором М1 (мин)	Доп. нагрузка	Кто делает
Показ меню жителям (визуальное, устное)	0	3	+3	Сиделка/санитар
Сбор заказа (накануне / в начале смены)	0	5	+5	Старшая смены
Пересчёт объёмов (по статистике выбора)	0	4	+4	Диетсестра/завпроизводством
Маркировка второй гастроёмкости (загрузка на линию)	0	2	+2	Повар
Раздача с предложением выбора	30 (60 сек × 30)	35 (70 сек × 30)	+5	Сиделка/раздающий
Запись в журнал заказа (3–5 строк)	0	3	+3	Старшая смены
Запись в журнал замен (если были)	0	2	+2	Раздающий
Итого на 30 жителей за обед	30	54	+24 минуты	—
В пересчёте на одного жителя	1,0 мин	1,8 мин	+0,8 мин	—

Сумма строк исправлена по сравнению с первой редакцией, где итог был указан как 52 минуты и +22 минуты; см. реестр поиска.

Как читать таблицу. В день выбора обед на отделении требует примерно на 24 человеко-минуты больше. При модели М1, когда выбор предлагается в один приём два-три дня в неделю, это порядка 50–70 человеко-минут в неделю на отделение — нагрузка, которая укладывается в пересменку, если минуты видны и распределены. Если выбор распространить на все три приёма каждый день, то по той же ставке добавка составит до 70 минут в сутки; первая редакция для этого случая давала оценку +40–50 минут, исходя из того, что завтрак и ужин проще обеда, но эта оценка из строк таблицы не выводится и требует замера. Для моделей М2–М3 ориентир — плюс 60–90 минут в сутки; модели М4 и М5 перестраивают саму роль персонала. Для группы помощи, где житель ест с поддержкой, добавка выше — около двух-трёх минут на жителя. Возражение «нас не хватит» чаще всего закрывается организацией потока (раздел 20): предзаказом, визуальным меню, маркировкой «вариант А / вариант Б».

Важно не перепутать минуты выбора с минутами помощи. Канадское руководство оценивает время помощи жителю, которому нужна поддержка за столом, до 45 минут в сутки[94], что несопоставимо больше наших 1,8 минуты на жителя: там выбор встроен в широкую модель помощи. Американские хронометражи ещё нагляднее. В исследовании 2001 года 74 жителя трёх домов сестринского ухода получали индивидуальную помощь в еде в течение шести приёмов пищи; помощь по протоколу потребовала в среднем 38 минут на жителя за один приём против 9 минут, которые персонал тратил в обычных условиях, и у половины участников потребление пищи и жидкости значительно выросло[210]. Близкие цифры получены и в более позднем контролируемом исследовании той же группы (раздел 20.3)[25]. Прямое сравнение с российской линией раздачи некорректно, но ориентир ясен: **помощь за столом — самая дорогая строка**, и выбор в ней занимает малую долю.

В таблице не учтены три позиции: (а) время повара на второй вариант — 10–20 минут на партию при эквивалентных парах вроде «гречка/рис», которые варятся одновременно; (б) время врача на диетические столы (раздел 19); (в) время диетсестры на пары и раскладку (раздел 19.2) — раз в квартал 4–8 часов. Они разобраны в разделе 29.4; здесь посчитана только линия раздачи.

Цифра для учредителя — **+24 минуты** на обед для 30 жителей в модели М1. Её либо укладывают в пересменку, либо обосновывают ею заявку на ставку. Фраза «не справимся, потому что страшно» без цифры — не управление.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-g/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/2026-10-blok-g/istochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S100	Приказ Минтруда России от 14.05.2025 № 305н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания...» (с 01.09.2025; заменил приказ № 940н), приложение 1 — рекомендуемые нормативы штатной численности
S101	Приказ Департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 14.02.2019 № 30 (изменения в приказ от 26.11.2014 № 178 о нормативах штатной численности стационарных организаций)

Маркер	Источник
S102	Приказ Минтруда России от 31.05.2023 № 482н, профессиональный стандарт «Помощник по уходу»; для сравнения – приказ от 30.07.2018 № 507н (соотношение двух приказов не проверялось), стандарт «Сиделка (помощник по уходу)»
M-staff_perruchoud	Perruchoud E. et al. The Impact of Nursing Staffs' Working Conditions on the Quality of Care Received by Older Adults in Long-Term Residential Care Facilities: A Systematic Review // <i>Geriatrics</i> . 2022;7(1):6
M-iddsi_wu_cfir	Wu X.S., Miles A., Braakhuis A. An Evaluation of Texture Modified Diets Compliant with the IDDSI in Aged-Care Facilities Using the CFIR. Research Square, 2021 (препринт)
I-cfr_feedasst	42 CFR § 483.160 (обучение оплачиваемых помощников по кормлению) и § 483.60(h) (условия их работы), США
M-feedassist_simmons2001	Simmons S.F., Osterweil D., Schnelle J.F. Improving food intake in nursing home residents with feeding assistance: a staffing analysis // <i>J Gerontol A Biol Sci Med Sci</i> . 2001;56(12):M790–M794
M-feedassist_simmons	Simmons S.F. et al. Prevention of unintentional weight loss in nursing home residents: a controlled trial of feeding assistance // <i>J Am Geriatr Soc</i> . 2008;56(8):1466–1473 (маркер общий с новыми редакциями гл. 5 и 20)

29

Финансовые модели: сколько стоит питание и сколько стоит выбор

Разговор о вариативном меню рано или поздно упирается в вопрос «а кто за это заплатит?». На него легко ответить двумя одинаково неверными способами: «это ничего не стоит» и «на это нет денег». Глава предлагает третий путь — считать. Для этого нужно различать, из чего складывается стоимость питания, понимать, какая модель вариативности что меняет в этой стоимости, и уметь превратить собственные граммы и минуты в рубли, понятные учредителю.

29.1. Честная рамка: что мы не утверждаем

В прежних версиях доклада стояла формула «вариативность почти бесплатна». Она удалена. Стоимость зависит от модели и выясняется замером: утверждать экономию без данных нельзя, но нельзя утверждать и невозможность. Глава даёт инструментарий — три стоимости, пять моделей с их ценой, порядок замера. Все числовые примеры в ней иллюстративные.

Осторожность здесь не перестраховка. Даже внутри одного источника оценки расходятся. Правовой обзор региональных норм, лежащий в корпусе рядом с докладом ([raw/sources/variativnoe-menu-npa-2026/](https://raw.sources/variativnoe-menu-npa-2026/)), в заключении пишет, что новосибирская практика доказывает: вариативность «реализуема без изменения норм и без существенного роста затрат», а в разделе о проблемах регионального уровня утверждает, что вариативное меню «объективно дороже единого», поскольку требует большего складского запаса, сложнее планируется и даёт больше отходов при ошибках прогноза выбора. Оба утверждения имеют основания, и мы не выбираем удобное. Позиция доклада такова: модели М1–М2 при парах эквивалентов не требуют новых денег на сырьё (раздел 29.4), но требуют труда, планирования и точного учёта выбора, без которых действительно становятся дороже.

29.2. Три стоимости, которые путают

Справка. Сырьевая строка и полная стоимость. В зарубежной литературе по питанию в учреждениях длительного ухода различают **raw food cost** — стоимость продуктов в расчёте на жителя в день — и **полную стоимость питания** (full cost of food service), куда входят труд кухни, энергия, оборудование и его амортизация. В докладе первая величина называется **сырьевой строкой**. В российской бюджетной практике её ближайший аналог — стоимость набора продуктов по утверждённым нормам питания, которые для учреждений субъектов устанавливаются региональными актами[38, 205]; полную стоимость в российских сметах отдельной строкой обычно не выделяют.

Сырьевая строка — это продукты на жителя в день. Зарубежные ориентиры приводятся с годом и валютой и не являются нормативами для России. В Австралии медиана составляла 8,00 австралийского доллара[181]. В Онтарио строка равнялась 8,33 канадского доллара и выросла до

13,71 после общественной кампании[211, 212]; генеральный аудитор провинции в отчёте 2019 года фиксировал для 2018/19–2019/20 годов 9,54 доллара на жителя в день, из которых около 6,96 оплачивали сами жители и около 2,58 — министерство[150]. В США, по данным профессиональной ассоциации руководителей пищеблоков ANFP (это не государственный орган), более четверти домов в 2025 году тратили на продукты меньше 10 долларов в день[213, 214]. Главный урок здесь не в суммах, а в механизме: во всех трёх странах перемены начинались с **публикации сырьевой строки**[182, 212].

В России сопоставимая статистика по домам социального обслуживания в открытом доступе не собрана. Отдельные числа встречаются в смежных областях, и обращаться с ними нужно осторожно. Упомянутый правовой обзор приводит результаты аудита питания в психиатрическом стационаре Республики Татарстан: стоимость питания составила порядка 224–310 рублей на койко-день при фактическом занижении норм против рекомендуемых. Это учреждение здравоохранения, а не социального обслуживания. Публичные региональные тарифы на социальные услуги тоже содержат строку питания: например, в Свердловской области предельный тариф на услугу горячего питания совершеннолетних в стационарной форме в 2015 году составлял 123,64 рубля «за единицу услуги»[215]. Но единица услуги в документе не раскрыта, и пересчитать её в рубли на жителя в день нельзя. Оба примера показывают, что строка существует, но не дают ориентира для сравнения. Свою строку дом должен посчитать сам (раздел 29.3).

Полная стоимость приёма пищи складывается из сырья, труда кухни, энергии и амортизации. Канадское руководство по лучшим практикам оценивает её в 27,91–54,85 доллара на жителя в день, то есть в три–шесть раз выше сырьевой строки[94]. Аудит Онтарио дал близкую картину: при сырье 9,54 доллара совокупные расходы на питание с учётом производства оценены в 25,31 доллара на жителя в день[150]. Экономия на сырье при такой полной стоимости — самая неэффективная экономия в системе (раздел 29.7).

Стоимость кормления — время помощников за столом. Те же канадские данные дают до 45 минут в день на жителя, которому нужна помощь[94]. Это самая дорогая и самая скрытая строка: она живёт в штатном расписании, а не в продуктовом бюджете, и её разбор дан в разделах 28.3 и 28.11.

29.3. Сырьевая строка: как посчитать свою за час

Формула проста (приложение 25): расходы на продукты за месяц делятся на число жителей и на число дней; получается сумма в рублях на жителя в день. Три правила делают её полезной. Во-первых, считать только продукты, без труда и коммунальных платежей. Во-вторых, сравнивать себя с собой в динамике и с региональными коллегами, а не с зарубежными долларами. В-третьих, публиковать — учредителю и совету жителей: во всех изученных странах прозрачность строки работала на её рост[182, 211]. Если никто в доме не может назвать эту цифру за пять минут, это первая находка аудита (раздел 22).

29.4. Пять моделей вариативности и их честная цена

Модели М1–М5 определены в разделе 8.2; здесь — только их экономика.

Модель	Что меняется	Цена сырья	Цена труда	Разовые затраты
М1. Выбор из двух (завтрак и обед, 2–3 дня в неделю)	Вторая гастрорёмкость, журнал заказа	~0 (перераспределение пар)	+ минуты на линии	Гастрорёмкости, маркеры
М2. Выбор ежедневно по позициям	Тот же принцип в полном объёме	~0 при пересчёте по статистике	+ время раздачи и учёта	Визуальное меню
М3. Буфетная зона (салаты, напитки)	Самообслуживание в зоне	Рост потребления, затем пересчёт	Контроль зоны	Стеллажи, посуда
М4. Семейная подача (точечно)	Подача общими блюдами	~0	Меняется роль персонала	Столовая посуда
М5. «Своя кухня» (реабилитация)	Программа навыков	Как у группы	Персонал-сопровождающий	Кухонная зона

Модельные оценки, не замеры: фактическую цену даёт семидневный замер до старта и через 90 дней (приложение 25).

Механизм для М1–М2 таков: сырьё не добавляется, а **перераспределяется внутри той же строки** через пары эквивалентов (раздел 19.2). Пример: на отделении из 30 человек каша — гречка или рис; суммарный расход круп остаётся прежним, меняется только пропорция. *Расчёт иллюстративный; пропорции даёт статистика выбора.* Именно здесь проходит граница между двумя оценками из раздела 29.1: перераспределение остаётся бесплатным, пока прогноз выбора точен. Ошибка прогноза оборачивается либо излишком одного варианта (отходы), либо нехваткой (замена и недовольство), и цену этой ошибки снижает только журнал заказа (раздел 21).

Модель М1 описана здесь применительно к завтраку и обеду, как в болотнинском опыте (раздел 8.2); в трудовом расчёте раздела 28.11 для простоты взят один обед. Сверх линии раздачи у моделей есть три постоянные трудовые позиции: время повара на второй вариант (10–20 минут на партию при эквивалентных парах), время врача на диетические столы и время диетсестры на пары и раскладку — раз в квартал 4–8 часов (раздел 28.11).

Три стоимости питания, которые путают (раздел 29.2)

Аудит Онтарิโอ, долларов на жителя в день: сырьё 9,54 из 25,31 полной стоимости

Сырьевая строка
продукты: 9,54

Полная стоимость: 25,31
+ труд кухни, энергия, оборудование, амортизация

По канадскому руководству полная стоимость в 3–6 раз выше сырьевой строки.

Стоимость кормления — самая дорогая и самая скрытая строка

Время помощников за столом: до 45 минут в день на жителя, которому нужна помощь (канадские данные). Живёт в штатном расписании, а не в продуктовом бюджете (разделы 28.3, 28.11).

Зарубежные суммы показывают механизм, а не норматив для России: свою строку дом считает сам (раздел 29.3).

Из чего складывается цена выбора при M1–M2 и парах эквивалентов (раздел 29.4)

Сырьё: около нуля

Не добавляется, а перераспределяется внутри той же строки: гречка или рис — расход круп прежний, меняется пропорция

Труд: минуты

Время раздачи и учёта на линии; повар — 10–20 минут на партию второго варианта; диетсестра — 4–8 часов раз в квартал; врач — диетические столы

Разовые затраты

Вторая гастрорёмкость, маркеры, визуальное меню

Ошибка прогноза

Излишек одного варианта уходит в бак, нехватка оборачивается заменой и недовольством; цену ошибки снижает только журнал заказа (раздел 21)

Модельные оценки, не замеры: фактическую цену даёт семидневный замер до старта и через 90 дней.

Калькулятор стоимости вариативности: четыре листа (приложение 42)

Лист 1. Пары блюд

Закладка, г × цена, руб./кг ÷ 1000 = стоимость порции; разница А и Б в месяц

Лист 2. Отходы

Остатки, г на порцию × число порций × цена; кухонные и тарелочные — раздельно

Лист 3. Сценарии

Снижение отходов на 10, 20, 30 % — гипотеза, а не прогноз

Лист 4. Два сценария

Собственный пищеблок или аутсорсинг: две позиции в задании (приложение 43)

Замер до и после — обязателен: калькулятор считает гипотезу, а не доказывает её

Отходы, г × цена килограмма по фактуре = рубли в бак. Снижение отходов подтверждает только повторный замер через 90 дней (приложение 25). С этими строками — разговор с учредителем (раздел 29.9).

Рисунок 22. Из чего складывается стоимость: сырьё — меньшая часть полной стоимости питания, помощь за столом — самая скрытая строка, а цена выбора при M1–M2 — это труд, разовые затраты и ошибка прогноза; калькулятор приложения 42 считает гипотезу, которую проверяет замер (разделы 29.2–29.4)[94, 150]

29.5. Отходы: единственная честная «экономия»

Несъеденная порция — это оплаченное сырьё в баке. Выбор может снижать долю несъеденного, потому что нелюбимые блюда перестают попадать на тарелку. Но здесь нужны две оговорки. Первая: доказательной базы такого эффекта в наших условиях нет (раздел 27.5). Вторая: формула доклада — **замер до и после**. Семь дней до пилота и семь дней через 90 дней дают собственную цифру, и только она имеет значение.

Международные аналоги существуют[216], но переносятся только как гипотеза. Наиболее изучены больницы. Систематический обзор 19 исследований больничных служб питания (2023) нашёл, что заказ блюд по меню «как в номере гостиницы» (room service) сопровождался меньшими тарелочными отходами: в одном австралийском исследовании 12 % против 29 % при традиционном 14-дневном цикличном меню, в другом — 15 % против 40 % при системе разогрева заранее приготовленных блюд; электронный заказ у постели дал смешанные результаты. Авторы заключили, что «персонализация приёма пищи и эффективная служба заказа могут улучшать потребление при одновременном снижении пищевых отходов», но подчеркнули, что результаты «должны быть подтверждены проспективными исследованиями на больших выборках»[201]. Это больницы с короткой госпитализацией, а не дома постоянного проживания, и оба исследования room service выполнены одной группой авторов. Для учреждений длительного ухода данных ещё меньше: обзор 2026 года нашёл лишь три интервенционных исследования (раздел 22.3)[149]. Масштаб потерь в чужой системе показывает аудит Онтарио: стоимость выброшенной еды оценена примерно в 2,48 доллара, или 26 % суточной сырьевой строки (раздел 22.3)[150]. Перевод граммов в рубли для своего дома — в разделе 29.11.

29.6. Каналы денег и разговор с учредителем

У продуктовой строки четыре возможных источника изменения: региональные нормы (их пересмотр — компетенция учредителя и региона), экономия на отходах (подтверждённая замером), пожертвования и целевые программы, выручка буфета (если такая деятельность предусмотрена уставом). Инструмент разговора — пакет раздела 38: сырьевая строка в динамике, замер отходов и международная механика прозрачности[182].

Австралийский опыт показывает, как прозрачность становится условием финансирования. С 1 июля 2021 года государство выплачивает учреждениям дополнительно 10 австралийских долларов в день на жителя в рамках надбавки к базовому суточному платежу (Basic Daily Fee supplement). Условие — письменное обязательство «предоставлять товары и услуги надлежащего качества и количества» с акцентом на питание и ежеквартально отчитываться: о расходах на продукты (приготовленные на месте или внешним поставщиком), о приготовлении пищи, включая часы работы кухни и персонала раздачи, о расходах на диетологов и других специалистов, связанных с питанием[182, 217]. По итогам первого года отчётности средние расходы на питание составили 14,46 австралийского доллара на жителя в день по всем отчитавшимся учреждениям и 12,54 доллара у тех, кто отчитывался только о продуктах[218]. Сравнивать эти суммы с медианой 8,00 доллара из раздела 29.2 напрямую нельзя: другие годы, другая методика, инфляция. Но конструкция «деньги в обмен на ежеквартальную отчётность» ясна, и такую же сделку может предложить учредителю российский директор: «дайте строку — я покажу, куда она пошла». Скелет такого разговора — в разделе 29.9.

29.7. Ловушка экономии

Питание — худшее место для экономии, и это можно показать двумя способами: через цепочку последствий и через структуру затрат.

Цепочка выглядит так. Сырьевую строку сжимают; качество падает; растут отходы и недоедание; за ними растут соматические расходы и жалобы; в итоге система платит втрое по другим строкам[94, 181]. Аргумент для директора, которому «режут продукты», — стоимость недоедания (пневмонии, госпитализации) против копеек сырьевой строки.

Структура затрат делает тот же вывод ещё нагляднее. По канадскому руководству[94] и по аудиту Онтарио[150], сырьё — меньшая часть полной стоимости питания, а труд и инфраструктура — бо́льшая. Сокращение сырьевой строки — самая заметная и самая вредная экономия: она бьёт прямо по жителям, экономит меньшую долю расходов и порождает скрытые издержки — потерю веса, ухудшение здоровья, жалобы, проверки. Разумная стратегия обратная: искать эффективность в большой доле (поток раздачи, трудозатраты, отходы) при стабильной сырьевой строке. Поэтому публикация строки (раздел 29.3) — это защита жителей: видимую строку сократить труднее, чем невидимую[182, 211].

Практических действий три: посчитать строку за час, замерить отходы за неделю и письменно сообщить учредителю о дефиците числом. Модели M1–M2 не требуют новых денег, но и не обещают экономии до замера.

29.9. Разговор о деньгах с учредителем: скелет презентации

Удобно мыслить разговор как десять слайдов (не путать с семинарской презентацией):

1. сырьевая строка, рублей на жителя в день;
2. её динамика за год;
3. доля сырья в полной стоимости питания (по методике канадского руководства[94]);
4. отходы в рублях — факт замера;
5. что сделано без денег;
6. эффект — числа до и после;
7. что стоит денег — три позиции с расчётом;
8. цена бездействия: отходы, жалобы, проверки, а в закупках — риск переплаты при сговоре поставщиков[135] (раздел 30.3);
9. просимое решение — одно, с датой;
10. что покажет отчётность через квартал.

Каждый слайд опирается на число или документ. В разговоре о деньгах эмоция всегда проигрывает смете. Десятый слайд воспроизводит австралийскую логику раздела 29.6: учредитель охотнее даёт деньги тому, кто заранее обещает отчитаться.

29.10. Ловушка экономии: когда «сократить сырьё» дороже всего

Механика ловушки изложена в разделе 29.7. Здесь важно добавить, как её распознать в собственном доме. Три признака говорят, что экономия на сырье уже обходится дороже, чем берегает: доля тарелочных отходов растёт, хотя порции уменьшились; число жителей с потерей

веса по панели показателей (раздел 22.4) растёт квартал к кварталу; жалобы на питание переходят из устной формы в письменную. Каждый из них измеряется без новых затрат, и каждый — аргумент для разговора по скелету раздела 29.9.

29.11. Отходы: как замер превращается в рубли

Замер (приложение 25) даёт граммы на порцию. Три блюда с наибольшими остатками сверяются с циклом меню: их убирают, уменьшают или заменяют парой. Перевод в деньги прост: масса недельных отходов умножается на цену килограмма по фактуре.

Три правила удерживают расчёт от самообмана. Первое: отходы не равны нулю нигде. Второе: тарелочные остатки говорят о вкусе, размере порции и состоянии жителей, а кухонные — о планировании объёмов, и смешивать их нельзя. Третье: снижение отходов после введения выбора — гипотеза, которую подтверждает только повторный замер через 90 дней.

Иллюстрация, а не замер: дом на 150 жителей, 80 граммов отходов на порцию, три приёма пищи — 36 килограммов в день; при условной цене 250 рублей за килограмм это порядка 9 000 рублей в день потенциала. Для дома-тысячника (в Серафимовском, по архиву сайта, на февраль 2026 года проживали 1 004 человека, раздел 25.5) при тех же 80 граммах и трёх приёмах получается **около 240 килограммов в день и порядка 60 000 рублей в день условного потенциала**. Цифры условные, но порядок действий настоящий.

Если учреждение готовит на собственной кухне, действуют модели М1–М5, описанные выше. Если питание передано на аутсорсинг, на первый план выходят контрактные риски, восемь строк технического задания и приёмка: раздел 42.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-g/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/istochniki/md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
I-onaudit2019	Office of the Auditor General of Ontario. Annual Report 2019, Vol. 1, ch. 3.05: Food and Nutrition in Long-Term-Care Homes (маркер общий с новыми редакциями гл. 20–22)
I-aus_bdf	Australian Government, Department of Health. New Basic Daily Fee supplement (undertaking form and conditions), June 2021
I-aus_fnr	Australian Government, Department of Health and Aged Care. Food and Nutrition Report 2021–2022
M-waste_rinninella	Rinninella E. et al. Hospital Services to Improve Nutritional Intake and Reduce Food Waste: A Systematic Review // Nutrients. 2023;15(2):310
M-waste_roulston	Roulston M. et al. Food waste in residential aged care: A scoping review // Nutr Diet. 2026;83(1):56–73 (маркер общий с новой редакцией гл. 22)
S100	Приказ Минтруда России от 14.05.2025 № 305н, п. 15 Правил (нормы питания — по актам субъекта)
S103	Постановление РЭК Свердловской области от 18.11.2015 № 162-ПК, приложение «Предельные тарифы на социальные услуги»

Закупки продуктов: 44-ФЗ без кошмаров

Меню начинается не на кухне, а в спецификации к контракту. То, что не закуплено, нельзя предложить жителю на выбор, а то, что закуплено плохо, не исправит даже лучший повар. Поэтому директору, который вводит вариативность, не обязательно становиться контрактным управляющим, но необходимо понимать несколько точек, где закупка соприкасается со столом. Глава описывает именно эти точки и не заменяет ни контрактной службы, ни юриста.

30.1. Рамка раздела

Справка. Два закона о закупках. Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе...» регулирует закупки для государственных и муниципальных нужд: процедуры жёстко заданы законом, контракт исполняется по его правилам. Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» задаёт лишь общие принципы, а конкретные процедуры заказчик определяет сам в **положении о закупке**, которое размещается в Единой информационной системе. В корпусе доклада эти контуры представлены двумя домами: ДСО «Серафимовский» закупает по 223-ФЗ, ДСО «Тесовый берег» — по 44-ФЗ. Смешивать их механику нельзя.

Какой закон применяет дом, зависит от его типа и от источника денег, и формула «всем 44-ФЗ» здесь неверна. Статья 15 44-ФЗ различает три случая^[219].

- **Казённое учреждение** закупает по 44-ФЗ.
- **Бюджетное учреждение** закупает по 44-ФЗ за счёт субсидий и иных средств. Однако если до начала года оно разместило в ЕИС положение о закупке, то по 223-ФЗ оно вправе закупать за счёт пожертвований и грантов, за счёт средств от приносящей доход деятельности, а также когда само выступает исполнителем по контракту и привлекает третьих лиц.
- **Автономное учреждение** закупает по 223-ФЗ и своему положению. Применять 44-ФЗ оно обязано при закупках за счёт бюджетных средств на капитальные вложения в объекты государственной или муниципальной собственности, а также когда условия предоставления средств прямо требуют соблюдения 44-ФЗ.

В первой редакции доклада было сказано, что у автономного учреждения «субсидия на госзадание нередко остаётся в контуре 44-ФЗ». Текст ст. 15 этого не подтверждает: субсидия на выполнение государственного задания не названа среди случаев обязательного применения 44-ФЗ автономным учреждением^[219]. Исключения возможны, если иное прямо установлено условиями предоставления средств, но это вопрос конкретного соглашения и юриста, а не общее правило.

Закупка несёт два риска. Первый — формальный: нарушение процедуры. Второй — антимонопольный: картель поставщиков, от которого страдает дом, или обвинение самого заказчика в ограничении конкуренции. Ниже речь идёт о стыке закупки с питанием и о тех

вопросах, в которых директор обязан быть грамотным лично.

30.2. Продуктовая рамка: что нужно знать директору

Три принципа. Первый: **объект закупки — продукты по спецификации**, и качество спецификации определяет стол сильнее, чем качество повара. «Крупа гречневая, ГОСТ, ядрица, не ниже первого сорта» и просто «крупа» — это две разные столовые. Второй: **пропорции внутри спецификации — инструмент вариативности**. Пары эквивалентов (гречка и рис, курица и рыба) закладываются в закупку заранее, по статистике выбора (раздел 21); вариативность, не заложенная в план закупок, умрёт на складе. Третий: **сроки и партии важнее экономии на цене**. Срыв поставки одной позиции ломает раскладку и таблицы замен, и выигрыш нескольких процентов на торгах оборачивается заменами «чем есть».

30.3. Антимонопольная зона: практика ФАС

Справка. Картель. Картелем называют соглашение между конкурентами, например поставщиками, о поддержании цен, разделе рынка или поведении на торгах. На торгах он проявляется как видимость конкуренции: участники заранее договорились, кто выиграет и с какой ценой. За картель предусмотрены оборотные штрафы по КоАП, а в тяжёлых случаях — уголовная ответственность по ст. 178 УК (подробнее об ответственности — раздел 33).

Масштаб явления в продовольственных закупках велик. В 2024 году ФАС сообщила о раскрытии картеля на 543 торгах на поставку социально значимых продуктов питания на сумму более 4,7 млрд рублей; заказчиками выступали муниципальные учреждения Москвы, Московской и Владимирской областей и Республики Дагестан. По версии ФАС, компании синхронно повышали цены, контролировали соблюдение договорённостей и обсуждали санкции против участников, не поддержавших сговор; материалы направлены в правоохранительные органы^[135]. В Челябинске выявлен картель на 27 тендерах школьного питания 2022–2024 годов, назначен штраф 5,1 млн рублей и возбуждено уголовное дело по ст. 178 УК (2025)^[136].

Из этой практики директор-заказчик может сделать три вывода.

1. **Картель бьёт по качеству и цене стола.** Заказчик, замечающий признаки согласованности (одни и те же компании с «подставными» заявками, цены «с потолка»), вправе и должен сообщать о них в территориальное управление ФАС. Это защита жителей, а не доносительство.
2. **Заказчик тоже находится в зоне риска.** Избыточные требования — например, «поставщик с опытом работы именно с нашим учреждением» или указание товарных знаков без слов «или эквивалент» — сами образуют состав ограничения конкуренции.
3. **Качество поставок нужно документировать.** Акты приёмки, записи о браке и возвратах относятся к санитарному контуру (раздел 18) и одновременно служат базой для претензий к поставщику и для обращения в ФАС.

Практика ФАС изложена по публичным сообщениям; для конкретных решений нужно заключение контрактной службы или юриста. Признаки картеля в собственных торгах разобраны в разделе 30.7.

30.4. Закупка и вариативность: стыковка

Вариативность и закупка связаны пятью рабочими звеньями.

1. Статистика выбора за два-три месяца (раздел 21) определяет пропорции пар в спецификации.
2. Сезонность и праздничное меню корректируют квартальные объёмы; предложения даёт совет жителей (раздел 34).
3. Таблицы замен превращаются в «запасные эквиваленты» в спецификации на случай срыва поставки.
4. Малые партии скоропортящихся продуктов закупаются по графику поставок, а не складским запасом.
5. Раз в год спецификация пересматривается по замеру отходов (приложение 25): то, что стабильно не съедается, законно уходит из закупки через таблицы замен, в рамках региональных норм питания[11, 12].

Главная трудность в том, что статистика выбора меняется, а контракт фиксирован. Как совместить одно с другим, не нарушая закон, описано в разделе 30.8.

30.5. Аутсорсинг питания: за и против честно

Если питание отдано внешней организации, вопрос стоит иначе. Аргументы «за» — профессиональное производство, санитарная дисциплина, снятие нагрузки с дома. Аргументы «против» нужно знать до заключения контракта: потеря гибкости, зависимость от исполнителя, разрыв связи «житель — кухня». Вариативность закладывается в **техническое задание**: два варианта, текстурные линии, журналы выбора, дегустации. Если её там нет, от исполнителя её не дожидаться. *Это рекомендация, а не норма.* Подробный разбор — в разделе 42.

Итог для директора укладывается в пять пунктов, и погружаться в 44-ФЗ для этого не нужно: спецификация определяет стол; вариативность заложена в план закупок по статистике выбора; директор знает признаки картеля и канал обращения в ФАС; приёмка организована; при аутсорсинге выбор записан в ТЗ.

30.7. Картели: что директор обязан знать, не будучи юристом

Масштаб картелей приведён в разделе 30.3 (543 торга на 4,7 млрд рублей; в Челябинске — 27 тендеров и штраф 5,1 млн рублей)[135, 136]. Директор — не следователь, но три признака в собственных закупках он заметить способен:

- одни и те же два-три поставщика годами поочерёдно «выигрывают» с близкими ценами;
- снижение от начальной цены ритуально мало, доли процента;
- «проигравший» в этом торге побеждает в соседнем с тем же раскладом.

Один признак ещё не доказательство. Устойчивая картина — основание сообщить учредителю и, с его согласия, обратиться в ФАС. Здесь нужна поправка к первой редакции, где было сказано, что «анонимность заявителя законом предусмотрена». Закон о защите конкуренции требует, чтобы заявление о нарушении содержало сведения о заявителе — фамилию, имя, отчество и адрес

физического лица или наименование и место нахождения юридического — и было подписано[220]. Анонимное сообщение заявлением в смысле закона не является. ФАС ещё в 2010 году открыла специальный сайт, где о картельном сговоре можно сообщить анонимно[221]; действует ли этот канал в прежнем виде, на дату проверки не установлено. Для учреждения естественный путь всё равно официальный: письмо от имени заказчика, согласованное с учредителем и контрактной службой.

Картельная закупка — скрытый налог на сырьевую строку (раздел 29). Поэтому разговор «варить два варианта дорого» иногда стоит начинать не с кухни, а с цен закупки.

30.8. Спецификация под вариативность: пять строк, которые всё решают

Новых законов для вариативного меню не нужно — нужны пять строк в спецификации.

Перечень. Позиции описываются как группы взаимозаменяемых продуктов («крупы гарнирные: гречка, рис, пшено»), а не как монопозиция. Тогда пары легальны на уровне контракта.

Пропорции. Объёмы внутри группы задаются по статистике выбора с правом корректировки раз в квартал без изменения сути контракта, в пределах изменений, допустимых по 44-ФЗ. Таких пределов закон знает по меньшей мере два. Первый — изменение количества товара по соглашению сторон не более чем на 10 % с пропорциональным изменением цены (ст. 95 44-ФЗ) [222]. Второй, более гибкий, — закупка с неопределённым объёмом: если количество заранее определить невозможно, заказчик указывает цены единиц товара и максимальное значение цены контракта, а поставка идёт по заявкам в пределах этой суммы (ч. 24 ст. 22, п. 2 ст. 42 44-ФЗ); с 1 июля 2019 года такой способ допускается независимо от предмета закупки[222]. Для пар эквивалентов, где пропорция «гречка — рис» заранее неизвестна, второй механизм выглядит естественным, но это толкование доклада: выбор конструкции согласуется с контрактной службой. Для учреждений, закупающих по 223-ФЗ, аналогичные возможности задаёт их положение о закупке.

Замены. При недопоставке допускается эквивалент из той же группы — по согласованию и с актом. Заменять товар «чем есть» без оформления нельзя: 44-ФЗ допускает при исполнении контракта поставку товара с улучшенными по сравнению с контрактом характеристиками (ч. 7 ст. 95)[222], но не произвольную замену, поэтому группа эквивалентов должна быть описана в самом контракте.

Качество. Указываются характеристики, значимые для текстур: помол, консистенция полуфабрикатов. Иначе дисфагический контур (раздел 10) оказывается заложником «самого дешёвого фарша».

Приёмка. Назначен ответственный, утверждена форма акта. Без этой строки претензии превращаются в обиды.

Каждая строка согласуется с контрактной службой заранее. Конфликт «меню против контракта» — симптом того, что меню меняли, а спецификацию нет.

Аутсорсинг (по 223-ФЗ или 44-ФЗ на услугу питания) устроен иначе: восемь строк ТЗ, контроль приёмки, привязка к меню. Это раздел 42, особенно 42.3 и 42.7.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-g/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/2026-10-blok-g/istochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S104	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ст. 15 (ч. 1, 2, 4) — особенности закупок бюджетных и автономных учреждений
S105	Федеральный закон № 44-ФЗ, ч. 24 ст. 22, п. 2 ст. 42 (закупка с неопределённым объёмом), ст. 95 ч. 1 и ч. 7 (изменение контракта) — по комментариям ppt.ru (2021, обновл. 2025) и saby.ru
S106	Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ч. 1 ст. 44
S107	ФАС России: запуск сайта «Антикартель» с возможностью анонимного сообщения о сговоре (сообщение amic.ru, 07.10.2010)

ЧАСТЬ 8

Документы, риски, стратегия

разделы 31–44

31

Документальный комплект: как практика становится системой

Практика, которая держится на людях, уходит вместе с ними. Практика, закреплённая в документах, переживает смену директора, приход проверяющего и конфликт с родственником. Эта глава собирает в один комплект всё, что в разделах 17–30 было сказано о нормах, ролях, журналах и закупках, и показывает, как превратить его в небольшой набор локальных актов, которые реально работают в ритме смены.

Справка. Локальный акт и проект локальной формы. Локальным нормативным актом называют документ, который организация принимает сама в пределах своей компетенции: положение, порядок, правила, приказ. Он обязателен для работников и, в части, касающейся их, для получателей услуг, но не может противоречить закону и подзаконным актам. Все шаблоны приложений 1–45 к докладу — **проекты локальных форм** (класс утверждения «проект локальной формы», раздел 41): это заготовки, которые дом адаптирует и утверждает сам, а не нормативы и не «рекомендованные министерством образцы». Например, приказ № 124 от 10.03.2026 ДСО «Серафимовский» — локальный акт, утвердивший правила внутреннего распорядка, где закреплено заказное питание; для другого дома и для проверяющего из другого региона он не норма, а пример (раздел 25)^[171].

31.1. Зачем документы, если практика уже работает

Устная договорённость «у нас два варианта» живёт до первого проверяющего, первого конфликта с родственником или первой ротации кадров. Комплект документов делает три вещи: закрепляет границы (что разрешено, что гарантировано, что решает врач), распределяет ответственность по фамилиям и делает практику воспроизводимой. Он собран из разделов 17–30; шаблоны — приложения 1–45, все со статусом **проектов локальных форм**.

Мысль о том, что учреждение социального обслуживания должно иметь документированную систему, не изобретение доклада. Национальный стандарт ГОСТ Р 52497-2005 «Система качества учреждений социального обслуживания» относит к основе документации системы качества положение (устав) учреждения, положения о структурных подразделениях, «руководства, служебные инструкции, правила, методики технологий, предназначенные для регламентирования процесса» предоставления услуг, а также документацию на оборудование и национальные стандарты социального обслуживания^[223]. Стандарт носит добровольный характер; проект его новой редакции обсуждался в 2019 году, и действующий статус следует уточнять. Но логика та же, что у комплекта ниже: процесс, который не описан, нельзя ни воспроизвести, ни проверить.

31.2. Шесть базовых документов

1. Положение об организации питания (локальный акт). В нём указывается нормативная база: закон № 3185-1 (ст. 43)[8]; санитарные правила — СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а с 01.09.2026 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (раздел 18)[9]; приказ Минтруда № 520н, нормы которого носят рекомендательный характер, если регион не установил императивных[38]. Новые Правила организации деятельности организаций социального обслуживания прямо отсылают к региональному уровню: нормы питания в организациях субъекта «устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации»[205], поэтому ссылка на региональный акт в положении обязательна (раздел 24). Далее положение описывает структуру питания, роли и порядок учёта индивидуальных потребностей. Утверждается директором и согласуется с учредителем по регламенту региона.

2. Раздел о вариативности в положении или отдельный порядок. Он содержит перечень позиций с выбором; механизм заказа (журнал, визуальное меню); гарантию стандартного варианта — «никто не остаётся без полноценного приёма пищи»; правило замен; связь с лечебным питанием через «мост» (раздел 24). Как показывает пример Серафимовского, этот раздел может жить и в правилах внутреннего распорядка — важно не место, а то, что он утверждён.

3. Меню с вариантами. Двухнедельное или четырёхнедельное. Международный ориентир цикличности — 21–28 дней[27, 34]; в России императивного требования к длине цикла для стационарных организаций социального обслуживания нет, и региональные требования нужно собирать на месте (раздел 18). Каждая вариативная позиция — пара эквивалентов с нутриентным обоснованием (раздел 19).

4. Журналы заказа и замен. Можно вести два журнала или один совмещённый. Второй важнее, потому что доказывает исполнение гарантии альтернативы при отказе. В США эта гарантия записана прямо: дом обязан предлагать «привлекательные варианты сходной пищевой ценности жителям, которые решили не есть изначально поданное блюдо или просят другой выбор», а меню должно учитывать мнение жителей и их групп[46]. В России она выводится толкованием из ст. 37 закона № 3185-1 в связке со ст. 43[8] (раздел 17); класс этого утверждения — толкование, а не норма прямого действия.

5. Пищевые карты жителей. Это не медицинская карта. В ней — предпочтения, запреты, текстура (по шкале IDDSI при показаниях)[64], необходимая помощь, лекарственные ограничения (раздел 11). Формат — приложение 2; источники сведений — наблюдение, сам житель, близкие и врач, в иерархии, описанной в разделе 15.

6. Согласование с учредителем. Письмо-отчёт о пилоте с панелью двенадцати чисел (раздел 22) до и после. Изменения, проведённые через учредителя, переживают проверки; изменения, введённые «тихо», — не всегда[3, 4].

31.3. Три клинических документа

7. Лекарственно-пищевая таблица (раздел 11, приложение 21): пять правил взаимодействий с классами уверенности. Подписывается врачом, хранится на кухне и на посту, обновляется при каждой смене назначений.

8. Список дисфагического риска (раздел 10, приложение 21): жители с признаками риска, назначенный уровень текстуры, правило «двое обученных сотрудников на посту в часы еды»[1]. Это врачебный документ; его ведение может быть делегировано старшей сиделке, но назначения в нём делает врач.

9. Журнал отказов (раздел 12, приложение 9): дата, приём пищи, обстоятельства, принятые меры. Три отказа подряд — врач в тот же день.

31.4. Три управленческих документа

10. Приказ об ответственных: за питание в целом, за вариативную линию, за журналы, за связь с врачом. Без фамилий комплект не работает.

11. Регламент совета жителей по питанию (раздел 34, приложение 30): состав, периодичность, полномочия (меню, дегустации, пожелания), форма доведения решений до администрации.

12. Квартальная панель (раздел 22, приложение 35): двенадцать чисел на одном листе — от отходов до доли выбирающих. Это не отчётность наверх, а самопроверка.

31.5. Учётная форма: что сказать честно

Учёт продуктов в государственных учреждениях социального обслуживания исторически ведётся по формам, утверждённым приказом Минфина России № 52н[224]. С 2021 года действует приказ Минфина № 61н, утвердивший унифицированные формы **электронных** первичных учётных документов, и переход на них идёт поэтапно; Минфин сопровождает его методическими рекомендациями по отдельным формам[225]. В первой редакции доклада в цепочку этого перехода были включены также приказы № 157н и № 174н. Это неточность: приказ № 157н от 01.12.2010 утверждает единый план счетов бухгалтерского учёта, а приказ № 174н от 16.12.2010 — план счетов бюджетных учреждений, а не формы первичных документов. Приказы № 142н и № 100н в этой цепочке при подготовке новой редакции проверить не удалось. Практический вывод от этого не меняется: не называйте конкретную форму «обязательной для вас», пока это не подтвердили учредитель или региональный орган, — статус форм менялся не раз.

Для вариативного меню существенна одна деталь электронного учёта. По разъяснениям Минфина 2024 года, при выдаче продуктов на основании утверждённой руководителем меню-раскладки электронная требование-накладная (ф. 0510451) формируется автоматически после утверждения расчёта потребности[225]. Значит, пропорции пар, рассчитанные по журналу заказа (раздел 21), должны попадать в меню-раскладку до её утверждения: иначе кухня получит со склада продукты под одно меню, а жители выберут другое. Журнал заказа живёт рядом с любой учётной формой, а не вместо неё, но связь между ними должна быть прописана.

31.6. Порядок сборки комплекта за неделю

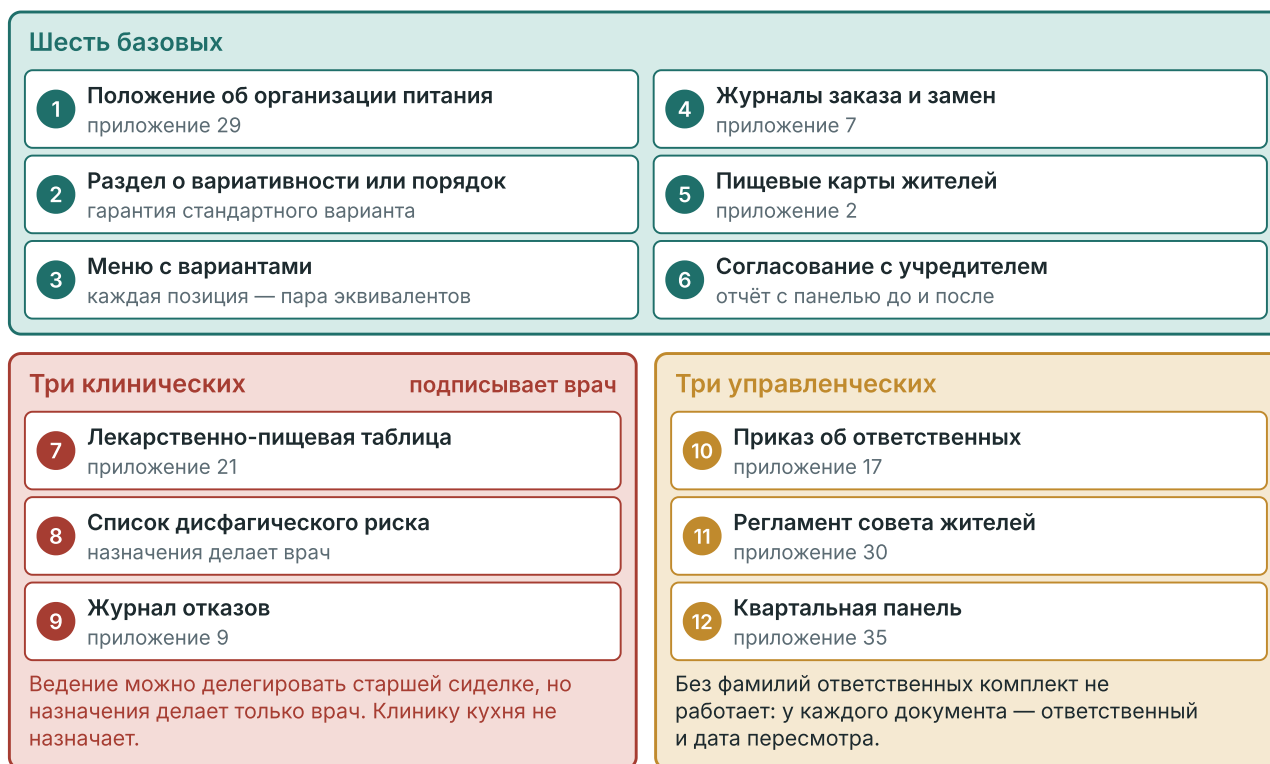
Двенадцать документов — один пакет, а не библиотека. Если приложения уже подготовлены как заготовки, комплект собирается за пять рабочих дней.

- **День 1.** Приказ об ответственных и приказ о пилоте (приложения 17, 28).
- **День 2.** Положение о питании с разделом о вариативности (приложение 29); около 60 % текста берётся из заготовки.
- **День 3.** Клинический блок с врачом: лекарственно-пищевая таблица, список риска, журнал отказов (приложения 21, 9). День не заканчивается без подписи врача.
- **День 4.** Журналы заказа, замен и срывов, меню с парами, пищевые карты первой очереди: первыми — группа риска и неговорящие жители.
- **День 5.** Регламент совета жителей (приложение 30), панель (приложение 35), письмо учредителю.

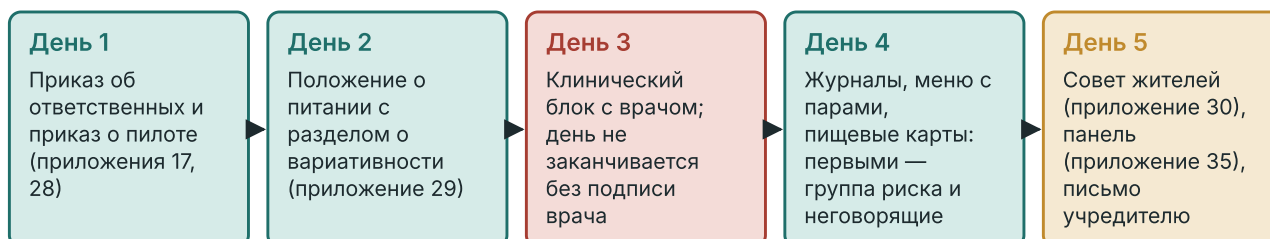
В первой редакции перечень приложений в этой главе назывался то «1–36», то «1–38»; во второй редакции приложений 45, и ссылки приведены к этому перечню.

Проверка готовности — два вопроса: понимает ли новый сотрудник за час, что ему делать, и отвечает ли папка на три вопроса проверяющего из раздела 32? Если оба ответа «да», комплект работает: подпишите приказ, покажите учредителю, и практика перестанет зависеть от того, кто сегодня стоит у раздачи.

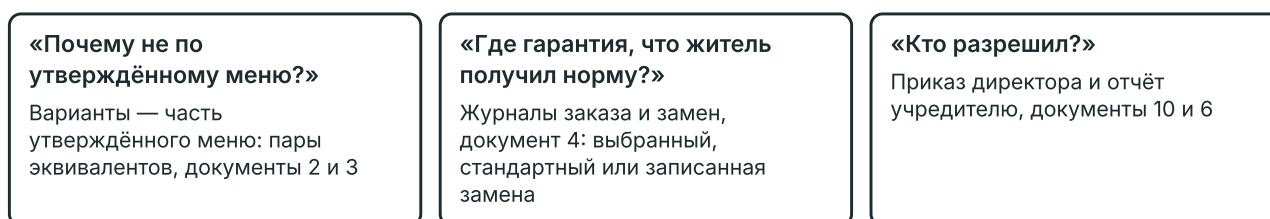
Двенадцать документов — один пакет, а не библиотека (разделы 31.2–31.4)



Сборка за пять рабочих дней, если заготовки приложений готовы (раздел 31.6)



Папка отвечает проверяющему бумагой на устный вопрос (раздел 32.3)



Проверка готовности: понимает ли новый сотрудник за час, что ему делать, и отвечает ли папка на три вопроса проверяющего? Если оба ответа «да», комплект работает.

Рисунок 23. Документальный комплект: шесть базовых, три клинических с подписью врача и три управленческих документа, которые собираются за пять рабочих дней и отвечают на три вопроса проверяющего (разделы 31.2–31.6, 32.3)

31.7. Когда документов слишком много

Обратная опасность — раздувание: положение на сорок страниц, журналы на двенадцать граф, пищевые карты на шесть листов. Признак проблемы один: форма не заполняется в ритме смены. Отсюда правило: каждая графа должна отвечать на вопрос «какое решение принимается по этой графе?»; графа, по которой решений не принимают, удаляется. Лучший комплект — самый

короткий из полностью работающих. Проверяющему нужна доказуемость, смене — выполнимость, и общий знаменатель у них — краткость. Тот же фильтр защищает персонал от бумажной лавины (раздел 28.8).

31.8. Жизненный цикл документа: пересмотр

Документ без даты пересмотра стареет молча. Поэтому у каждого документа комплекта есть свой ритм:

Документ	Когда пересматривается
Меню и пары эквивалентов	по циклу пересчёта (раздел 21.9)
Лекарственно-пищевая таблица	при каждой смене назначений, не реже раза в квартал
Список дисфагического риска	ежемесячно
Положение о питании	раз в год (учётные формы меняются этапами ^[224] ; санитарные правила сменились 01.09.2026)
Квартальная панель	ежеквартально

Ответственный за актуальность каждого документа указывается в приказе об ответственных одной строкой. На обходе полезно задавать вопрос: «когда это менялось последний раз?». Документ, который в живой системе не менялся год, либо мёртв, либо мертва сама система.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре <raw/sources/poisk-2026-10-blok-g/istochniki.md>. Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S108	ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания», п. 5.2.1
S109	Письмо Минфина России от 30.07.2024 № 02-06-06/70843 (методические рекомендации по формам приказа № 61н; новость ГАРАНТ.РУ 06.08.2024)
S100	Приказ Минтруда России от 14.05.2025 № 305н, п. 15 Правил
I-cfr	42 CFR § 483.60(c)(4), (d)(5) — перепроверено 09.10.2026 (маркер прежней редакции)

32

Как отвечать проверяющему: сценарий диалога без страха

32.1. Почему этот раздел стоит отдельно

Когда директора обсуждают вариативное меню, самым сильным доводом против оказывается не цена и не трудозатраты, а короткая фраза: «придут и спросят». Страх этот реален, но размыт. Он не называет ни органа, ни нормы, ни вопроса, а потому от него нельзя защититься: неопределённую угрозу невозможно отработать. Задача раздела в том, чтобы превратить размытую тревогу в конкретный сценарий. Кто приходит, о чём спрашивает, какой документ отвечает на вопрос, что делать, если замечание всё-таки выписано, и как вести себя в ходе самой проверки.

Опорой сценария служат публичная надзорная и административная практика по пищевым сюжетам в учреждениях социального обслуживания[10], единственное доступное судебное толкование по разграничению «пищевых» составов КоАП[23] и, для закупочного контура, дела антимонопольного органа[135, 136]. Последние касаются картелей на торгах, а не кухни, поэтому в этой главе они служат лишь напоминанием о том, что контроль за питанием начинается раньше раздачи (раздел 30). Процессуальную сторону мы сверили с текстом Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»[226] и Закона о прокуратуре[227]. Всё сказанное ниже — организационная рекомендация по классу утверждений раздела 41, а не консультация юриста по конкретному делу.

32.2. Кто приходит и что проверяет

Проверяющие различаются не только ведомством, но и предметом. Тот, кто путает предметы, отвечает на вопросы, которых ему не задавали, и упускает те, которые зададут.

Справка. Виды контроля и надзора. В российском праве различают **государственный контроль (надзор)**, который ведут уполномоченные органы по правилам 248-ФЗ; **ведомственный контроль** учредителя за подведомственным учреждением; **прокурорский надзор** за исполнением законов, который регулируется Законом о прокуратуре и под 248-ФЗ не подпадает; наконец, **общественный контроль**. Для каждого вида свой порядок, свои документы и свои способы обжалования. 248-ФЗ закрепляет за проверяемым («контролируемым лицом») ряд прав: присутствовать при контрольных мероприятиях и давать пояснения, знакомиться с результатами и сообщать о согласии или несогласии с ними, обжаловать действия и решения в досудебном и судебном порядке (ст. 36)[226].

Роспотребнадзор проверяет санитарию. На дату семинара для организаций социального обслуживания действовал СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пункты 7.1.11–7.1.14. С 01.09.2026 его сменил СанПиН 2.3/2.4.4282-26, пункт 56, подпункты 11–14: питание проживающих организуется не менее трёх раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям,

суточные пробы отбираются и хранятся[9]. Вопросы «почему у вас два варианта» санитарный инспектор не задаёт: ни одна редакция санитарных правил не ограничивает число блюд. Его вопросы касаются температуры, маркировки, суточных проб и поточности. Вариативность входит в его поле зрения как дополнительная технологическая линия, а не как новый объект надзора (раздел 18). Отсюда простой вывод: каждая вторая гастрорёмкость должна иметь свою пробу, свою строку в журнале и свою маркировку (раздел 18.9).

Контроль в сфере социального обслуживания и учредитель. Закон № 442-ФЗ разделяет государственный контроль в этой сфере на два уровня. Федеральный контроль ведёт орган, уполномоченный Правительством, и его предметом являются в том числе организации социального обслуживания, подведомственные субъектам Российской Федерации, то есть большинство ДСО и ПНИ. Региональный контроль распространяется на негосударственных поставщиков. Порядок обоих видов определяется 248-ФЗ (ст. 33 442-ФЗ)[118]. Наконец, учредитель, как правило региональный орган социальной защиты, ведёт ведомственный контроль: он смотрит на исполнение стандартов и нормативов региона, на расходование средств, на жалобы. Независимо от формы, защита здесь одна — документы: согласование, меню с эквивалентами, журнал замен, панель показателей (раздел 31). Какой именно федеральный орган сегодня уполномочен на контроль в сфере социального обслуживания, мы в этой редакции не сверяли. Это стоит уточнить по действующему положению о виде контроля до разговора с проверяющим.

Прокуратура приходит, как правило, по жалобе, и предметом её интереса чаще всего становятся права жителей. Опора здесь — статьи 37 и 43 Закона № 3185-1 «О психиатрической помощи...»: статья 43 распространяет на проживающих стационарных организаций социального обслуживания права, которые статья 37 закрепляет за пациентами психиатрического стационара[8]. Прокурор спрашивает, были ли нарушены права. Журнал отказов и документированный выбор в этой логике служат ответом, а не уязвимостью: они показывают, что воля человека была услышана и записана. Важно помнить о форме реагирования. Представление об устранении нарушений закона «подлежит безотлагательному рассмотрению», а в течение месяца со дня его внесения должны быть приняты конкретные меры и о них должно быть письменно сообщено прокурору (ст. 24 Закона о прокуратуре)[227]. Месяц — жёсткий срок, и именно поэтому разбор жалоб в дни, а не в недели (приложение 34), становится не формальностью, а страховкой.

Справка. Акт, предписание, представление, постановление. Акт фиксирует результаты контрольного мероприятия. **Предписание** — обязательное требование контрольного органа устранить нарушения в установленный срок. **Представление прокурора** обязывает рассмотреть нарушения и в месячный срок принять меры. **Постановление по делу об административном правонарушении** назначает наказание, например штраф по ст. 6.6 КоАП (раздел 33.2). Это разные документы с разными сроками обжалования, и ответ на каждый строится по-своему.

32.3. Три вопроса и три ответа

Практика показывает, что почти любой разговор о вариативном меню сводится к трём вопросам. На каждый из них должен существовать заранее подготовленный ответ, и каждый ответ должен опираться на документ.

«Почему не по утверждённому меню?» Ответ: варианты являются частью утверждённого меню, а не отступлением от него. Пары эквивалентов нутриентно равноценны, перечень пар согласован и утверждён (раздел 19). Однако здесь проходит красная линия, о которой нужно сказать прямо. Если региональное меню или раскладка носят императивный характер, то есть исключают замены вне утверждённой таблицы, то сначала меняется региональный документ и лишь затем практика (раздел 24). Раздавать «два варианта» при императивном меню без изменения документа — нарушение, и доклад этого не советует.

«Где гарантия, что житель получил норму?» Ответ: журнал заказа и журнал замен. По ним видно, что каждый житель получил либо выбранный вариант, либо стандартный, либо зафиксированную замену. В США обязанность предложить альтернативу при отказе от блюда закреплена на федеральном уровне[46]. В России аналогичная обязанность прямо не записана; она выводится толкованием из права на уважение человеческого достоинства и гуманное обращение (ч. 2 ст. 5 Закона № 3185-1; для проживающих ПНИ — также ч. 2 и 4 ст. 37 через ст. 43) [8]. Журнал превращает это толкование в доказательство: он показывает не намерение, а факт.

«Кто разрешил?» Ответ: приказ директора и отчёт учредителю. Учреждения, внедрившие выбор публично, шли именно этим путём: решение оформлялось локальным актом и доводилось до вышестоящего органа[6, 24].

Объединяет три ответа одно: на устный вопрос следует отвечать бумагой. Именно поэтому комплект документов раздела 31 собирается до старта пилота, а не после.

32.4. Чего не говорить проверяющему

Есть фразы, которые кажутся убедительными в коридоре, но в акте превращаются в улики.

«Так теперь везде». Это неправда (раздел 23) и вдобавок не аргумент: распространённость практики не делает её законной у вас.

«Нам диетолог разрешил». Должности диетолога может не оказаться в штатном расписании, и тогда ссылка на неё становится уязвимостью, а не защитой. Клинические решения подписывает врач, и это видно по документам клинического блока (раздел 31.3).

«Жители сами захотели» — без документа. Устную волю невозможно проверить, а пищевую карту и протокол совета жителей проверить можно (раздел 34). Та же фраза со ссылкой на протокол из довода превращается в доказательство.

Общее правило простое: у каждой устной фразы должен быть бумажный двойник из комплекта раздела 31. Если двойника нет, лучше промолчать и показать то, что есть.

32.5. Если замечание всё же выписано

Замечание — ещё не поражение, а начало процедуры, в которой у проверяемого есть права и сроки. Действовать нужно по порядку.

Первое: точно зафиксировать формулировку замечания. Без неё нельзя ни возразить, ни устранить.

Второе: запросить норму, на которую ссылается проверяющий. Отсылка к абстрактному «нарушению порядка» без указания пункта санитарных правил или регионального акта слаба. Мы считаем это устойчивым толкованием, а не измеренной закономерностью: статистики по таким спорам в открытых источниках нет. Ранее этот тезис подкреплялся ссылкой на дело ФАС^[135], но та публикация касается картеля на торгах и такого вывода не содержит (см. реестр, «Расхождение с корпусом»).

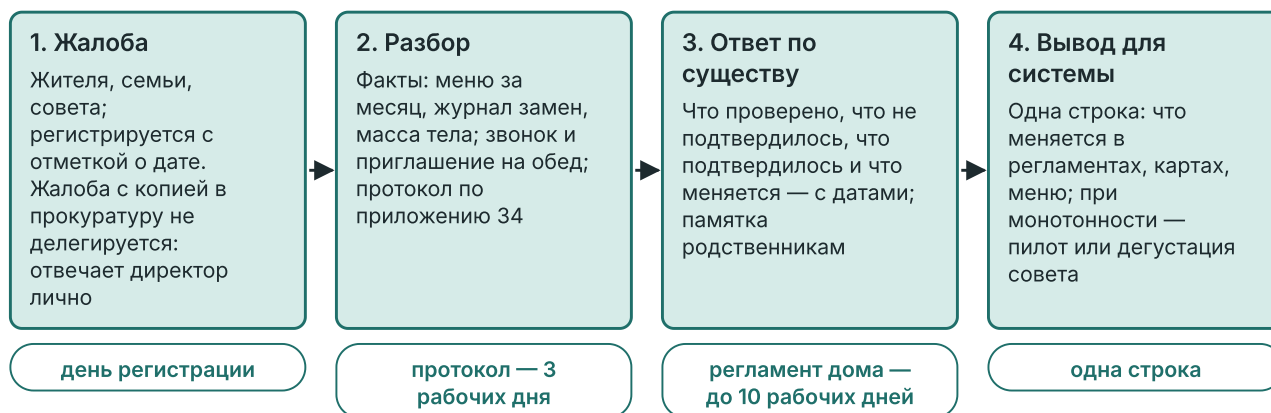
Третье: подключить учредителя на стадии возражения, а не после того, как вынесено постановление.

Четвёртое: знать сроки досудебного обжалования. По 248-ФЗ жалоба на решение или действие контрольного органа подаётся в электронном виде через Единый портал государственных услуг (ст. 40, ч. 1). На решения и действия отведено тридцать календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало о нарушении своих прав. Жалобу на предписание можно подать в течение десяти рабочих дней с момента его получения (ст. 40, ч. 5–6). Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен по ходатайству (ст. 40, ч. 7). Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации (ст. 43, ч. 2)^[226]. Сроки указаны по тексту закона на дату проверки, 09.10.2026; перед подачей их стоит сверить с действующей редакцией.

Пятое: при штрафе оценить перспективу обжалования вместе с юристом. Здесь же стоит знать о норме ст. 4.1.1 КоАП: за впервые совершённое правонарушение, выявленное в ходе государственного контроля, штраф подлежит замене на предупреждение, но только при условиях ч. 2 ст. 3.4 КоАП — если нет вреда или угрозы вреда жизни и здоровью людей и нет имущественного ущерба^[228]. Для санитарных нарушений в питании угроза здоровью нередко усматривается уже в самом нарушении, поэтому рассчитывать на замену автоматически нельзя. Это толкование, и применимость нормы к конкретному делу оценивает юрист.

Данных о том, какая доля замечаний по вариативному питанию отменяется при обжаловании, нет: в судебной практике эта тема не выделена (раздел 33.3а). Статистику здесь выдумывать нельзя.

Внутренний контур: жалоба разбирается в днях, а не в неделях (приложение 34, кейс 19)

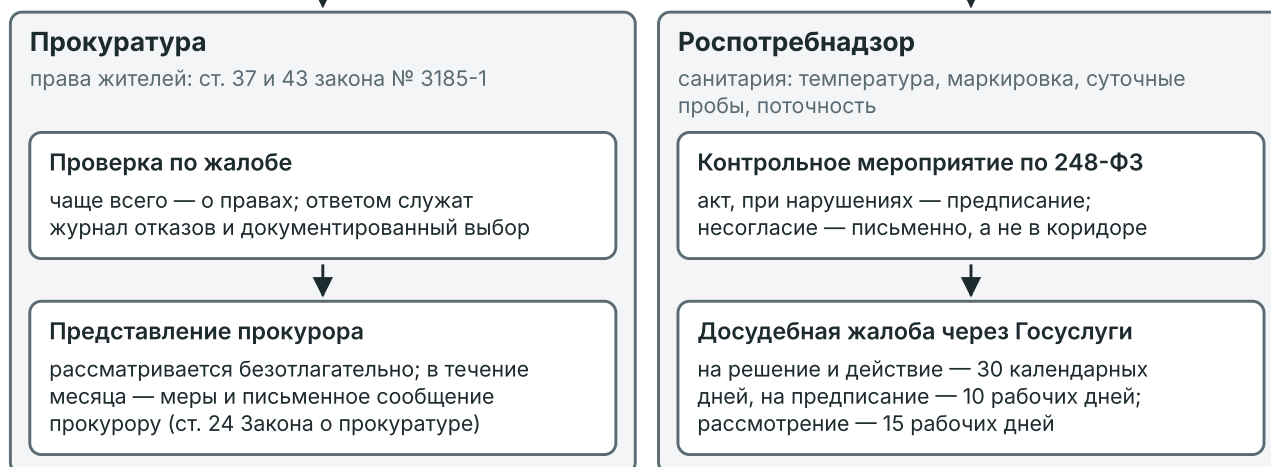


Клинический сюжет (удушьё, отказ, не та текстура) — разбор с участием врача: клинику кухня не назначает

Предельный срок письменного ответа — 30 дней со дня регистрации (ст. 10, 12 закона № 59-ФЗ)

Закон распространяется на учреждения, выполняющие публично значимые функции; применимость к конкретному дому — толкование, но его требования — хороший минимальный стандарт ответа

если жалобу не услышали — надзор



«Прокурорские» сюжеты вырастают из жалоб, которые игнорировались месяц. Дом, который отвечает быстрее, чем требует прокурор, редко получает второе представление (раздел 33.6).

Сроки — по текстам законов на дату проверки 09.10.2026; перед подачей сверить с действующей редакцией.

Рисунок 24. Путь жалобы: разбор в днях внутри дома, тридцатидневный предел ответа по 59-ФЗ и сроки внешнего контура — представления прокурора и досудебного обжалования по 248-ФЗ (разделы 32.2, 32.5, 33.6, приложение 34, кейс 19) [226, 227, 229]

32.6. Досье проверки: папка, которая отвечает за вас

Ответ проверяющему должен существовать до того, как прозвучал вопрос. Поэтому папку «Питание: проверки» собирают заранее, до старта пилота (раздел 35), а не после первого звонка из надзорного органа. Хранится она у заместителя, а не в сейфе: если папку нельзя достать за минуту, её всё равно что нет.

Состав папки складывается из десяти разделов:

1. приказы (о питании, о пилоте, об ответственных);
2. положение о питании с разделом о вариативности;
3. меню с парами эквивалентов и обоснованием их равноценности;
4. журналы за квартал: заказа, замен, отказов, срывов;
5. санитарный блок: пробы, температурные листы, санитарный паспорт второй гастрорёмкости (раздел 18.9);
6. клинический блок: лекарственно-пищевая таблица и список дисфагического риска с подписью врача;
7. квартальная панель показателей (раздел 22);
8. переписка с учредителем;
9. протоколы совета жителей (раздел 34);
10. копия последнего акта проверки с отметками об устранении (если проверка уже была).

Десять разделов отвечают на десять типовых вопросов. Ответ за минуту превращает проверку из допроса в сверку документов. Срок актуальности папки — квартал: прошлогодние журналы хуже отсутствия папки, потому что они показывают, что практика когда-то была, а теперь не ведётся.

32.7. Поведение при проверке: пять правил

Последнее, что определяет исход, — поведение людей в день проверки. Здесь достаточно пяти правил.

Отвечать на заданный вопрос. Экскурсия по учреждению и рассказ о том, о чём не спрашивали, порождают новые вопросы.

Подтверждать факты документом, а не словом. Фраза «у нас ведётся журнал» без самого журнала — это антиответ: она удостоверяет, что журнал должен быть, но не показывает его.

Не спорить в коридоре. Несогласие излагается письменно и после. Коридорный спор проигрывается всегда, письменное возражение иногда выигрывается. Право сообщить контрольному органу о несогласии с результатами мероприятия прямо закреплено законом (ст. 36 248-ФЗ)[226].

Вести собственную запись хода проверки. Кто пришёл, что спросил, какой документ был показан. Такая запись — основа будущих возражений и жалобы.

Не подписывать акт с формулировками, которых вы не понимаете, без оговорки. Акт подписывается тем же способом, которым он составлен. Если проверяемый отказывается или не может его подписать, в акте делается соответствующая отметка (ст. 88, ч. 3 248-ФЗ)[226]. Практичнее, однако, не отказ, а оговорка: «с формулировкой не согласен, возражения будут представлены». Она сохраняет позицию, тогда как молчаливая подпись её хоронит.

Вывод раздела: проверяющий опасен не вариативностью, а пустотой там, где должен лежать документ. Дом, который заранее знает, кто к нему придёт, о чём спросит и какой бумагой ответить, встречает проверку как сверку, а не как допрос.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-h/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/pskovskiy/poisk-2026-10-blok-h/istochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S110	Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 36, 40, 43, 88
S111	Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 24
S112	Кодекс РФ об административных правонарушениях, ст. 3.4, 4.1.1, 6.6
S001 (перепроверка)	Федеральный закон № 442-ФЗ, ст. 33 «Государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания» — статья прочитана впервые в этой редакции
S022 (перепроверка)	Постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4 — содержание уточнено, см. раздел 33.2

33

Ответственность директора: честная карта рисков без запугивания

33.1. Принцип раздела

О юридической ответственности руководителя обычно говорят в одном из двух регистров. Первый — запугивание: «посадят за всё». Второй — успокоение: «ничего не будет». Оба мешают принимать решения. Запуганный директор не меняет ничего, даже то, что менять необходимо. Успокоенный меняет без документов и тем самым создаёт риск, которого не было.

Этот раздел предлагает третий путь — карту. На ней видно, какие составы правонарушений действительно применялись по «пищевым» сюжетам в учреждениях социального обслуживания, какие существуют лишь на бумаге и как вариативное меню меняет профиль риска. Это обзор практики и норм, а не юридическое заключение. Тексты статей КоАП и УК, на которые мы ссылаемся, сверены 09.10.2026 по общедоступным редакциям[228, 230]; применение их к конкретному случаю всегда остаётся делом юриста.

Справка. Виды ответственности. Дисциплинарная ответственность наступает по Трудовому кодексу перед работодателем, для директора государственного учреждения — перед учредителем. **Административная** — по КоАП, в виде штрафа, предупреждения или приостановления деятельности; субъектом может быть как юридическое лицо, так и **должностное лицо**, то есть руководитель или работник с организационно-распорядительными функциями. **Уголовная** — по УК, только для физических лиц и только при наличии вины и последствий, которые указаны в статье. **Гражданско-правовая** — возмещение вреда. Карта этого раздела касается в основном административной и уголовной ответственности, потому что именно ими пугают.

33.2. Что реально применялось: КоАП, статья 6.6

Статья 6.6 КоАП устанавливает ответственность за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению». Санкция для должностных лиц — штраф от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток[228]. Размеры приведены по редакции, опубликованной на справочном портале на дату проверки; перед использованием в документах их следует сверить с официальным текстом.

Публичные дела по этой статье в учреждениях социального обслуживания известны. Штраф получил СРЦ «Кашинский» (2022, качество питания)[10]; сообщение ТАСС описывает дело Зеленогорского дома-интерната для престарелых и инвалидов (2021)[10]. Оба дела касались

качества и достаточности питания, а не вариативности. Дело о «двух вариантах» в публичном поле нет. Но отсутствие данных — это именно отсутствие данных, а не доказательство безопасности (раздел 33.3а).

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, применима ли статья 6.6 к дому социального обслуживания вообще. Единственное найденное нами судебное толкование — постановление Верховного Суда РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4[23]. В прежней редакции доклада оно было описано как дело дома-интерната. Проверка текста показала иное: речь шла об общеобразовательной школе в Казани, где инспекторы обнаружили, что пищу раздают дежурные ученики, а первое блюдо подаётся ниже требуемой температуры. Нижестоящие суды назначили школе штраф в 30 000 рублей по статье 6.6. Верховный Суд переквалифицировал деяние на часть 1 статьи 6.7 КоАП (нарушение санитарных требований к условиям воспитания и обучения), сохранив размер штрафа. Мотив суда: учреждение «не является специализированной организацией, реализующей населению услуги питания», а школьная столовая «не является таким специально оборудованным местом»[23].

Что из этого следует для ДСО и ПНИ? Логика суда переносится по аналогии: питание проживающих в стационарной организации социального обслуживания — часть социальной услуги, а не реализация пищи населению. Однако это толкование, а не прямая позиция суда по дому-интернату (класс утверждения — толкование, раздел 41). Кроме того, у школ есть своя специальная статья 6.7, а для организаций социального обслуживания аналогичной специальной статьи в КоАП нет. Поэтому квалификация защищает от применения чужих норм об общественном питании, но не отменяет санитарных правил и не исключает ответственности по иным составам (например, по статье 6.3 КоАП, которую указывает соседний правовой обзор; расхождение составов отмечено в [wiki/gaps.md](#), п. 15). Настоящая защита и здесь одна — след: меню, акты, журналы.

33.3. Уголовные составы: где граница реальности

К руководителям учреждений формально применимы несколько статей Уголовного кодекса. Статья 238 — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, «не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»; при смерти двух и более лиц по неосторожности наказание доходит до десяти лет лишения свободы (ч. 3)[230]. Статьи 285 и 286 — злоупотребление и превышение должностных полномочий. Статья 293 — халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей «вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе», если это повлекло крупный ущерб (свыше полутора миллионов рублей) или существенное нарушение прав и законных интересов граждан; если же по неосторожности причинён тяжкий вред здоровью или смерть человека, наказание достигает пяти лет лишения свободы (ч. 2)[230].

Справка. Почему уголовная ответственность — редкость. Уголовный состав требует не просто нарушения, а **последствия** и **вины**. Для халатности закон называет конкретные последствия: крупный ущерб, существенное нарушение прав, тяжкий вред, смерть. Административный состав «формальный»: для штрафа по ст. 6.6 КоАП достаточно самого нарушения санитарных требований, вред доказывать не нужно. Отсюда градиент частоты: административные дела встречаются заметно чаще уголовных.

Публичных уголовных дел против директоров ПНИ именно по организации питания в ходе проверки не обнаружено. Отсюда градиент. Жалобы и прокурорские представления встречаются часто. Административные дела по статье 6.6 — реже, но они есть. Уголовные составы по пищевым сюжетам в публичной практике не выявлены. Запугивание уголовными статьями поэтому является недостоверной риторикой, а игнорирование административного контура — легкомыслием.

Особняком стоит закупочный контур. Картельный сговор на торгах влечёт антимонопольную, а при определённых условиях и уголовную ответственность по статье 178 УК; публичные дела ФАС по поставкам социально значимых продуктов и школьному питанию известны^[135, 136]. Здесь директор чаще оказывается пострадавшим заказчиком, чем субъектом ответственности, и подробно эта тема разобрана в разделе 30.

33.3а. Качественная шкала риска без выдуманных вероятностей

Фраза «дел о двух вариантах не найдено» означает **не** «низкий риск», а **непроверенную зону**. Отсутствие публичных дел не равно отсутствию дел вообще. Состав статьи 6.6 карает за качество и достаточность питания, а не за число блюд. Вариативность не создаёт нового состава и не защищает от старых. Риск определяется документальным следом. Числовых вероятностей у нас **нет**, и мы их не приводим. Карта ниже показывает частоту в публичной практике (это не прогноз для конкретного дома), тяжесть последствий и то, что риск повышает или снижает.

Вектор	Частота (публичная практика)	Тяжесть	Повышает	Снижает
Жалоба жителя или родственника	высокая (массовый повод — «невкусно, не ем»)	низкая сама по себе	молчаливая раздача без записи	журнал выбора и замен, совет жителей (раздел 34)
Прокурорское представление	средняя	низкая или средняя: устранение в месячный срок и контроль ^[227]	жалоба, проигнорированная неделями	регламентный разбор в дни (приложение 34)
Административное дело по ст. 6.6 КоАП	низкая, но реальная; дела о качестве и достаточности	средняя: штраф должностному лицу 5–10 тыс. руб., юридическому 30–50 тыс. руб. или приостановление ^[228]	недоброкачественные продукты, имитация проб	пробы, бракераж, температурный контур, меню и акты
Уголовные составы (ст. 238, 285, 286, 293 УК)	по пищевым сюжетам в публичной практике не выявлено	высокая, но крайне редкая	системное бездействие при известном вреде	работающий контроль и своевременная реакция

Вариативность не добавляет в эту таблицу ни одной строки. Она перераспределяет жалобу: «невкусно» превращается в «я выбрал сам», но только если выбор задокументирован. Без документов вариативность **утяжеляет** вектор статьи 6.6: «два варианта без записи» читается проверяющим как отступление от меню.

Отдельно о предупреждении. Статья 4.1.1 КоАП требует заменять штраф предупреждением за впервые совершённое правонарушение, выявленное в ходе государственного контроля, но лишь при условиях части 2 статьи 3.4: при отсутствии вреда или угрозы вреда жизни и здоровью людей и имущественного ущерба[228]. Для нарушений санитарных требований к питанию угроза здоровью часто считается присущей самому нарушению, поэтому на эту норму можно надеяться, но нельзя на неё рассчитывать.

33.4. Как вариативность влияет на риск: два направления

Снижает. Самые массовые жалобы звучат так: «невкусно», «однообразно», «не ем это». Документированный выбор снимает этот повод. Журнал замен закрывает претензию «оставили голодным». Совет жителей (раздел 34) превращает потенциальных жалобщиков в соавторов меню. В зарубежных системах нормы о выборе, предпочтениях и альтернативных блюдах — в США, Онтарио, Австралии — служат защите прав проживающих, и проверяющие оценивают дома по их исполнению[27, 45, 46]. Переносить эти нормы на российские ДСО и ПНИ напрямую нельзя, но они показывают, куда движется надзор (раздел 26).

Создаёт риск при плохом исполнении. Два варианта без документов означают «отступление от меню». Замена без записи означает «не докормили». Выбор без связи с лечебным питанием создаёт риск для жителей на диетах. Профиль риска поэтому определяется документальным контуром (разделы 31–32), а качественная шкала приведена в разделе 33.3а.

33.5. Личная ответственность: три правила спокойного сна директора

Первое правило: решения о вариативности принимаются коллегиально и оформляются документами — приказом, протоколом совета жителей, согласованием с учредителем. Единоличное устное распоряжение — самый уязвимый формат: в нём нет ни основания, ни круга лиц, ни даты.

Второе: клинические границы определяет врач. Директор отвечает за исполнение назначений, а не за их содержание. Дисфагия, лекарственно-пищевые взаимодействия, диеты — зона врача (разделы 10–11). Подпись врача под клиническими документами — не формальность, а распределение ответственности.

Третье: жалоба — сигнал системы, а не личная атака. Регламент разбора жалоб (приложение 34) снимает с директора роль человека, который «бьётся за каждый эпизод», и возвращает ему роль управляющего системой. Директор отвечает за систему контроля, а не за каждое событие за столом. Состав халатности как раз и описывает неисполнение обязанностей «вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе»[230]; работающая и задокументированная система контроля — лучшее доказательство обратного.

Итог раздела: риск вариативности, подкреплённой документами, ниже риска бездокументной монотонности. Считать риск нужно по документам, а не по страшилкам.

33.6. Страховка вместо страха: что реально снижает личный риск

Четыре элемента значат больше, чем любые намерения.

Коллегиальность. Приказ, протокол совета и уведомление учредителя вместе показывают, что решение принято не одним человеком и известно тем, кто должен о нём знать.

Клиническая делегация. Каждый клинический документ подписан врачом. Сотрудник без медицинской квалификации, который подписал таблицу взаимодействий, добровольно и бесплатно принял на себя чужой риск.

Скорость. Жалоба разбирается в дни (приложение 34). «Прокурорские» сюжеты вырастают из жалоб, которые игнорировались месяц. Для прокурорского представления месячный срок принятия мер установлен законом[227], и дом, который отвечает быстрее, чем того требует прокурор, редко получает второе представление.

Честность статусов. Документ, честно названный проектом или локальной формой, не даёт повода для претензии в самоуправстве. Документ, который изображает нормативность, которой у него нет, такой повод даёт (классы утверждений — раздел 41).

К этим четырём элементам стоит добавить пятый, внешний: закупочную дисциплину. Дела о картелях на торгах продуктами[135, 136] напоминают, что риск руководителя начинается не у плиты, а в спецификации и протоколе торгов (раздел 30).

Риск определяется качеством следа, а не смелостью изменений.

33.7. Психологическая цена вопроса и её управление

Страх ответственности остаётся главным тормозом, и документами он снимается не полностью. Человеку, который отвечает за сотни жизней, трудно поверить, что бумага его защитит. Поэтому, кроме документов, нужны три управленческих приёма.

Разделить риск. Решение принимают вместе: директор, врач, совет жителей, учредитель. Это не перекладывание ответственности, а её честное распределение по ролям.

Ограничить первый шаг. Пилот в одном отделении, а не во всём доме (раздел 35). Ошибка на тридцати жителях исправима, ошибка на тысяче — уже нет.

Назначить дату пересмотра. Изменение оформляется как эксперимент с датой подведения итогов, а не как решение «навсегда». Это снимает страх необратимости.

Задача раздела не в том, чтобы директор перестал бояться. Она в том, чтобы бояться стало нечего конкретно: каждый риск назван, у каждого есть документ, который его снижает, и у каждого документа есть ответственный.

Новые источники главы

Полные записи и проверенные формулировки — в реестре <raw/sources/poisk-2026-10-blok-h/istochniki.md>.
Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S112	Кодекс РФ об административных правонарушениях, ст. 3.4, 4.1.1, 6.6
S113	Уголовный кодекс РФ, ст. 238, 293
S111	Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 24
S022 (перепроверка)	Постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4: дело школы № 80 (Казань), переквалификация со ст. 6.6 на ч. 1 ст. 6.7 КоАП

34

Права жителей и совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню

34.1. Правовая рамка без натяжек

Права проживающих в стационарных организациях социального обслуживания закреплены несколькими уровнями норм, и важно не приписывать им больше, чем в них сказано.

Первый уровень — Закон № 3185-1 «О психиатрической помощи...». Статья 37 закрепляет права пациентов психиатрического стационара; в прежней редакции доклада её смысл для нашей темы сформулирован как уважение человеческого достоинства и гуманное обращение (общая норма о гуманном отношении содержится также в ч. 2 ст. 5 того же закона, раздел 17.2). Статья 43 распространяет эти права на проживающих в стационарных организациях социального обслуживания[8].

Второй уровень — Закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан...». Статья 9 называет права получателей социальных услуг, среди них «уважительное и гуманное отношение», «участие в составлении индивидуальных программ», «защиту своих прав и законных интересов», а также «обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход»[118]. Право участвовать в составлении индивидуальной программы особенно важно для нашей темы: именно в индивидуальную программу можно включить пищевые предпочтения и доступный выбор (раздел 17.2).

Третий уровень — международный. Конвенция о правах инвалидов в статье 28 говорит о праве на достаточный жизненный уровень, включая достаточное питание. Замечание общего порядка № 1 Комитета ООН по правам инвалидов к статье 12 разъясняет, что поддержка в осуществлении правоспособности требует узнавать волю и предпочтения человека, а не решать за него[31, 138]. Статус конвенции и пределы её применения разобраны в разделе 17.7.

При всём этом конструкции «права на выбор блюда» в российском законе нет. Это честная серая зона (раздел 17). Выбор внедряется не как новое право, взятое ниоткуда, а как способ реализации уже существующих прав: на достоинство, на участие в составлении индивидуальной программы, на надлежащий уход. Совет жителей — организационная форма, в которой эти права становятся ежемесячной процедурой.

Справка. Совет жителей и попечительский совет — не одно и то же. Попечительский совет организации социального обслуживания предусмотрен законом и примерным положением, утверждённым приказом Минтруда России от 30.06.2014 № 425н. Это совещательный орган из внешних лиц: чиновников, представителей общественных организаций, науки, культуры, предпринимателей. Работники организации в него входить не могут, а его решения «носят рекомендательный характер»[231]. Задачи попечительского совета — содействие развитию организации, привлечение средств, улучшение материальной базы и качества услуг. **Совет жителей** — другая структура: в неё входят сами проживающие, и предмет её работы — повседневная жизнь дома, в нашем случае меню. Федеральной нормы о совете жителей нет; он создаётся локальным актом (приложение 30). Попечительский совет может стать союзником совета жителей, но заменить его не может: в нём нет тех, кто ест.

34.2. Три модели участия жителей

Участие жителей в том, что касается их стола, может быть устроено по-разному, и полезно различать три модели по мере того, насколько они дают людям реальное влияние.

Информационная модель. Жителей извещают о меню: доска объявлений, раздаточный лист, визуальное меню с фотографиями. Минимальный срок — за неделю. Это участие без влияния: человек знает, что будет есть, но не может ничего изменить.

Консультативная модель. Администрация спрашивает: проводит опросы предпочтений, дегустации, ставит «ящик пожеланий». С опроса начинала Усть-Илимская организация[4]. Влияние здесь появляется, но ритм и повестку задаёт администрация: она решает, когда спрашивать и что делать с ответами.

Институциональная модель. Создаётся постоянный совет жителей. Образцом служит совет по питанию ДДСОЛ (Московская область) — постоянная структура, учреждённая распорядительным документом от 13.04.2017[24]. Совет обсуждает меню до утверждения, проводит дегустации, собирает и ранжирует пожелания, получает отчёт о судьбе каждого пожелания. Это единственная из трёх моделей, в которой участие переживает смену заведующих отделениями.

Зарубежная практика показывает, что институциональная модель может быть закреплена нормой. В США федеральные требования к домам сестринского ухода дают проживающему право «организовывать группы жителей в учреждении и участвовать в них». Учреждение обязано предоставить группе отдельное помещение; персонал, посетители и иные лица могут присутствовать на собраниях группы лишь по её приглашению; учреждение должно назначить сотрудника, одобренного группой, который отвечает на письменные запросы по итогам собраний. Наконец, учреждение обязано «учитывать мнение группы жителей или семей и оперативно реагировать на жалобы и рекомендации таких групп» и должно быть способно показать свой ответ и его обоснование (42 CFR § 483.10(f)(5))[232]. В Онтарио учёт предпочтений в плане питания тоже обязателен[27]. Для российских ДСО и ПНИ это не норма, а ориентир: он показывает, какие процедурные детали превращают совет из клуба в институт.

34.3. Совет жителей: как собрать работающий, а не декоративный

Состав. От пяти до девяти человек. Большинство составляют жители, включая недееспособных: их интересы представляют выбранные ими лица или члены совета по регламенту (раздел 34.4). Кроме жителей, в совет входят сиделка, повар и врач с совещательным голосом. Нужны квоты по отделениям, иначе совет превратится в клуб самого активного корпуса.

Полномочия. Их четыре: обсуждать меню до утверждения; проводить дегустации; собирать пожелания и доводить их до администрации; получать ответ в установленный срок. Последнее полномочие самое важное и самое часто забываемое. Американская норма требует от учреждения не согласия с каждым пожеланием, а способности показать ответ и его обоснование[232]; ту же логику стоит заложить в регламент. Не включайте в полномочия того, что администрация не готова исполнять. Декоративный совет хуже отсутствующего: он производит цинизм.

Ритм. Ежемесячное заседание с коротким протоколом (приложение 30). Протокол — доказательство для раздела 32: фраза «жители сами захотели» со ссылкой на протокол становится проверяемым утверждением.

Чем совет рискует. Самый полный на сегодня обзор участия жителей в управлении домами долговременного ухода — скоупинг-обзор канадских исследователей 2025 года[233] — уже в названии формулирует главную опасность: жителей «выслушивают, но редко слышат». Авторы отобрали 59 исследований (62 публикации) из 5 580 записей, и почти две трети из них (38, или 64 %) были посвящены именно советам жителей. Самые частые барьеры: жители не участвуют (11 исследований); нет возможностей для участия людей с когнитивными нарушениями (11); персонал участвует нерегулярно или не поддерживает работу совета (11); персонал вмешивается в ход собраний (10); жители боятся ответных мер со стороны персонала (7). Самые частые условия успеха: сотрудничество персонала в подготовке повестки и работе с пожеланиями (22 исследования) и положительное отношение персонала (16). Обзор честно говорит и о слабости самой доказательной базы: почти половину публикаций (30, или 48 %) составляют комментарии, а количественные данные об участии есть лишь в десяти исследованиях, причём только четыре сообщают об исходах, оценённых самими жителями.

Для российского дома из этого следуют три практических вывода. Первый: страх ответных мер нужно снимать процедурно — протокол фиксирует пожелание без фамилии, если житель того просит. Второй: персонал приходит на совет как помощник, а не как ведущий. Третий: включение людей с когнитивными нарушениями требует особого формата (раздел 34.4), иначе совет будет представлять меньшинство. Обзор описывает канадские и в основном англоязычные дома для пожилых. Переносить его на ПНИ, где контингент моложе и иначе устроен, можно лишь как перечень рисков, а не как измеренный эффект.

34.4. Недееспособные жители в совете: не исключение, а особый формат

По вторичной аналитике, 74 % жителей ПНИ признаны недееспособными[7] (статус этих данных разобран в разделе 23). Исключить их из совета значит исключить большинство. Нужны форматы, которые позволяют учесть их волю.

Представительство через доверенных лиц. Не обязательно через опекуна-учреждение: при совпадении опекуна и поставщика услуг возникает конфликт интересов (раздел 16 и раздел 34.5).

Наблюдательные методы. Показ, выбор, реакция на блюдо фиксируются в пищевой карте по методике раздела 15 и становятся данными для совета.

Ротация «пробных обедов». Реакция жителей, которые не могут высказаться словами, на новые блюда собирается и передаётся совету как данные.

Международные нормы требуют учитывать предпочтения независимо от когнитивного статуса. В Австралии с 01.11.2025 действует Стандарт 6 обновлённых стандартов качества ухода[45]; в Онтарио предпочтения, в том числе культурные и религиозные, входят в обязательную оценку для плана ухода, а цикл меню рассматривает совет проживающих[27]. Канадский обзор подтверждает, что именно эта часть работы советов развита хуже всего: подходы к участию людей с деменцией и когнитивными нарушениями описаны лишь в 12 из 59 исследований (20 %), а нехватка возможностей для их участия названа одним из самых частых барьеров[233]. Иначе говоря, задача, которую ставит перед российским ПНИ его контингент, не решена убедительно и за рубежом, и тем ценнее аккуратный учёт собственного опыта.

34.5. Конфликт интересов «учреждение — опекун» в совете

Если опекуном жителя является само учреждение, то в совете оно потенциально голосует за жителя, то есть само с собой. Антидоты описаны в разделе 16: приоритет пищевой биографии над «усреднённым благом»; независимые представители там, где они есть; фиксация разногласий в протоколе.

Для локального акта предлагается формула: «при расхождении позиции администрации с зафиксированными предпочтениями жителя приоритет имеют предпочтения, если они не противоречат назначениям врача». Формула — проект локальной нормы, а не федеральное требование, и её стоит согласовать с юристом и учредителем.

Совет ничего не стоит, снимает жалобы ещё до их появления и превращает «права жителей» из декларации в ежемесячную процедуру. Начать можно с опроса предпочтений, как в Усть-Илимске[4], и сразу придать опросу статус протокола.

34.6. Первое заседание: сценарий по минутам

Первый совет решает, будет ли второй. Поэтому его стоит провести по сценарию, рассчитанному на сорок минут.

- **5 минут** — открытие и главная мысль: «меню обсуждают те, кто ест».
- **10 минут** — четыре полномочия совета и то, чего совет не может: отменить назначения врача и требования санитарных правил.
- **15 минут** — дегустация двух блюд-кандидатов с голосованием.
- **5 минут** — три пожелания от участников.
- **5 минут** — дата следующего заседания и срок, в который администрация ответит на пожелания.

Типичные ошибки первого заседания: чтение положения о совете вслух; обещания, которые выходят за пределы полномочий; состав, подобранный «для фотографии». Протокол состоит из трёх строк: кто был, что решили, кому поручено. Канадский обзор называет вмешательство персонала в ход собраний одним из частых барьеров[233]; на первом заседании это особенно опасно, поэтому сотрудники в нём помогают, но не ведут.

34.7. Совет и семьи: граница ролей

Пускать ли на совет родственников? Совет — структура жителей. Для семей предусмотрен отдельный канал: дни открытых дверей, дегустации по приглашению совета, памятка приложения 32. Американская норма проводит то же разделение: группы жителей и группы семей — разные структуры, и посторонние, в том числе родственники, приходят на собрание группы жителей только по её приглашению[232].

Смешение ролей опасно прежде всего для тех, кто не говорит. Говорящие родственники представляют говорящих жителей, а молчащее большинство остаётся без голоса. Если житель сам просит, чтобы его представлял близкий человек, — это его выбор представителя, а не «место для родни». Иерархия источников воли описана в разделе 15.9, где близкие стоят на четвёртом уровне; совет не должен переписывать эту иерархию по громкости голоса. Заметим, что порядок источников воли в разделах 15.4 и 15.9 исходной редакции не совпадает ([wiki/gaps.md](#), п. 2); до его согласования совету разумно опираться на тот вариант, который закреплён в локальном акте дома.

Вывод раздела: совет жителей — не украшение и не уступка, а инструмент, через который существующие права становятся видимыми. Работает он лишь тогда, когда у него есть реальные полномочия, срок ответа и формат для тех, кто не может говорить.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blokh/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S114	Приказ Минтруда России от 30.06.2014 № 425н «Об утверждении Примерного положения о попечительском совете организации социального обслуживания»
I-us_cfr_483_10	42 CFR § 483.10(f)(5)–(7) Resident rights: resident and family groups (CША)
M-ltc_councils_hutchinson	Hutchinson M. et al. Listened to but Rarely Heard: A Scoping Review of Resident Engagement in the Organizational Design and Governance of their Long-Term Care Homes // Can J Aging. 2025;44(4):552–564
S001 (перепроверка)	Федеральный закон № 442-ФЗ, ст. 9 — перечень прав получателей социальных услуг сверен 09.10.2026

35

Пилот на 90 дней: минимальный безопасный старт

35.1. Почему девяносто дней и почему пилот

Призыв «меняйте всё с понедельника» ломает сразу две вещи. Первая — кухня. Пищеблок большого дома работает как поток с жёстким ритмом: закладка, варка, порционирование, раздача, мойка, и каждый этап привязан к часам. Вторая — сами жители. Для людей, которые живут в ПНИ, предсказуемость среды — часть благополучия, и резкая смена привычного порядка может вызвать тревогу и поведенческие срывы (раздел 9). Пилот бережёт и кухню, и людей: меняется одна точка — отделение или один приём пищи, а всё остальное идёт так же, как вчера.

Справка. Пилот, апробация, исследование. В методологии различают **пилотное исследование осуществимости** (feasibility study), которое отвечает на вопрос «можно ли это сделать в наших условиях и какой ценой», и **исследование эффективности**, которое отвечает на вопрос «приносит ли вмешательство пользу». Первое не требует контрольной группы и большой выборки; второе требует и того и другого. Пилот этой главы относится к первому типу. В теории внедрения его результаты называют **исходами внедрения**: приемлемость, принятие, уместность, **осуществимость** («степень, в которой новое вмешательство может быть успешно использовано» в данном учреждении), точность исполнения, стоимость, охват и устойчивость^[234]. Эти исходы отличаются от клинических: вмешательство может не сработать потому, что оно неэффективно, а может — потому, что хорошее вмешательство исполнено неправильно. Авторы таксономии называют первый случай «провалом вмешательства», второй — «провалом внедрения»^[234].

Почему именно девяносто дней? За этот срок проявляются три вещи. Первая — устойчивая статистика выбора: первые две недели искажены эффектом новизны (раздел 35.4а). Вторая — реальные трудовые издержки, которые видны лишь после того, как смена перестаёт работать «на подъёме». Третья — первые конфликты, без которых не бывает ни одной перемены. Российский опыт подтверждает логику постепенности. Усть-Илимская организация шла поэтапно: от опроса предпочтений к расширению практики^[4]. Успенский ПНИ зафиксировал, что «страхи персонала не подтвердились», — но сделал этот вывод после пробного периода, а не до него^[3].

Минимальная конфигурация — модель М1 (раздел 35.3)

Одно отделение на 20–35 жителей, одна смена-единомышленница, один приём пищи: два варианта второго блюда на обед, два-три дня в неделю, заказ накануне или на линии. Стандартный вариант гарантирован всегда.

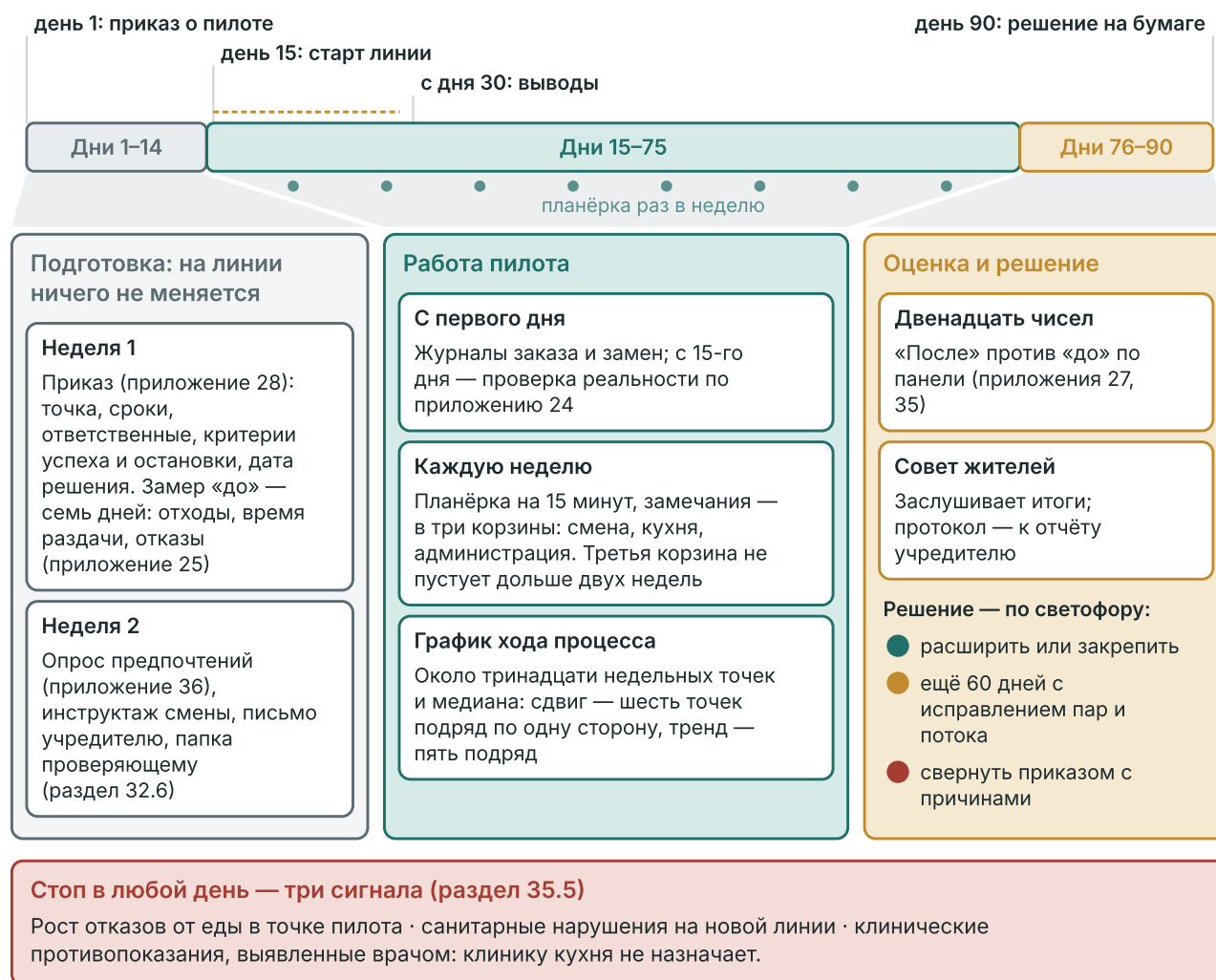


Рисунок 25. Пилот на девяносто дней: две недели подготовки без изменений на линии, два месяца работы минимальной конфигурации М1, две недели оценки и одно письменное решение по светофору; три стоп-сигнала действуют в любой день (разделы 35.2–35.5)[235, 236]

35.2. Дни 1–14: подготовка без изменений на линии

Первые две недели на линии раздачи ничего не меняется. Это время подготовки и замера.

Неделя 1. Подписывается приказ о пилоте (приложение 28). В нём названы точка (отделение и приём пищи), сроки, ответственные, критерии успеха и критерии остановки, а также дата принятия решения по итогам (раздел 36.6). Одновременно начинается замер «до»: семь дней учёта отходов, времени раздачи и отказов (приложение 25). Без этого замера через девяносто дней сравнивать будет не с чем. Семь дней, а не один, нужны потому, что единичный «показательный» день почти всегда оказывается нетипичным (раздел 35.4a).

Неделя 2. В точке пилота проводится опрос предпочтений (приложение 36): житель или его представитель отвечает коротко, ответы заносятся в пищевые карты. Параллельно проходит инструктаж смены раздачи (раздел 28) и отправляется письмо учредителю. Здесь же стоит подготовить папку для проверяющего (раздел 32.6): пилот, начатый без неё, начат с уязвимостью.

35.3. Дни 15–75: работа пилота

Минимальный пилот соответствует модели М1 (определение моделей — раздел 8.2, их цена — раздел 29.4): два варианта второго блюда на обед, два-три дня в неделю, заказ вечером накануне или прямо на линии. Стандартный вариант гарантирован всегда, даже если житель ничего не выбрал. Журнал заказа и журнал замен ведутся с первого дня, а не «когда наладится». Заметим, что раздел 29.4 исходной редакции описывает М1 как выбор на завтраке и обеде; пилот этой главы сознательно уже — только обед, и это не противоречие, а минимальная конфигурация той же модели.

Раз в неделю проводится пятнадцатиминутная планёрка: что выбирали, где возникала очередь, какие были замены, что говорят жители. Все замечания раскладываются по трём «корзинам». Первая — смена (очередь, маркировка). Вторая — кухня (пары, объёмы). Третья — администрация (документы, закупка). Третья корзина не должна пустовать дольше двух недель: если администрация ничего не делает, пилот выдыхается, потому что смена и кухня видят, что их усилия никому не нужны.

Еженедельные числа удобнее всего смотреть не в таблице, а на **графике хода процесса** (run chart): по горизонтали — недели или дни, по вертикали — показатель (доля выбирающих, отходы, время раздачи), посередине — линия медианы. Такой график позволяет отличить настоящий сдвиг от обычного разброса без сложной статистики[235]. Методические материалы Комиссии по клиническому совершенству Нового Южного Уэльса предлагают простые правила чтения: **сдвиг** — «шесть или более последовательных точек выше или ниже центральной линии» (точки на самой линии не считаются); **тренд** — «пять или более последовательных точек, которые все растут или все снижаются»; **выброс** — очевидное значение далеко за пределами обычного разброса. Сам график «лучше всего работает, когда в нём не менее 10 точек»[235]. Для пилота это означает, что недельных точек за девяносто дней хватает на график (около тринадцати), а для отдельных показателей, которые фиксируются ежедневно, точек достаточно уже через две недели.

Справка. Почему график лучше двух чисел «до» и «после». Сравнение двух средних скрывает время: оно не показывает, произошло ли изменение сразу после старта, постепенно или случайно в одну неделю. График хода процесса, опираясь на литературу по статистическому управлению процессами, позволяет «объективно понять, ведут ли наши изменения к улучшению» без сложной математики[237]. Это не статистическое доказательство эффекта, а способ не обмануться случайным колебанием.

Если в точке пилота есть ночное едение (раздел 13), стоит ввести структурированный ночной перекус по согласованию с врачом. Как правило, это самая быстрая субъективная победа пилота, заметная и жителям, и персоналу.

35.4. Дни 76–90: оценка и решение

На последнем этапе двенадцать показателей панели (приложения 27 и 35) сравниваются в состоянии «после» и «до»: доля выбирающих, отходы, время раздачи, отказы, замены, жалобы и остальные. Ни одно число не стоит показывать без фразы «что это значит» (раздел 22): голое число порождает домыслы.

Совет жителей заслушивает итоги и высказывается: расширять, оставить точку как есть или свернуть. Протокол совета прикладывается к отчёту учредителю.

Решение директора — одно из трёх, и оно оформляется на бумаге: расширение, закрепление точки или свёртывание с указанием причин. Свёрнутый пилот с указанными причинами — это результат, а не провал: он защищает дом от следующего «а давайте попробуем» без учёта уже полученного опыта.

35.4а. Что пилот доказывает, а что нет: дизайн и его границы

Честный дизайн важнее красивого отчёта. Пилот на девяносто дней проверяет исполнимость и безопасность, а не эффект вариативности (раздел 27.5). В терминах теории внедрения он измеряет осуществимость, точность исполнения, приемлемость и стоимость, а не клинический результат^[234].

Сравнение «до» и «после» на одном отделении (20–35 человек, без контрольной группы) показывает несколько вещей. Держатся ли два варианта в ритме смены и ведутся ли журналы. Не выросли ли отказы и эпизоды аспирации; на малой выборке важно любое ухудшение. Какова цена сырья, труда и отходов. Но такой пилот не показывает, что именно выбор улучшил отходы, вес, настроение или здоровье: для этого нет ни контрольной группы, ни статистической мощности. Контролируемых исследований эффекта вариативного меню в психиатрии не опубликовано (раздел 27.5).

Смещения нужно назвать вслух, иначе их назовут за вас.

Эффект Хоторна. Люди, которые знают, что за ними наблюдают, ведут себя иначе. Систематический обзор девятнадцати специально спланированных исследований (восемь рандомизированных, пять квазиэкспериментальных, шесть наблюдательных) пришёл к выводу, что такие эффекты участия в исследовании «действительно существуют», но о величине эффекта и условиях, в которых он действует, «мало что можно знать достоверно»^[238]. Поэтому принятое в докладе допущение, что примерно две недели после старта завышены самим экспериментом, — рабочее правило, а не измеренная величина. Практический вывод от этого не меняется: база фиксируется до старта, а выводы делаются по дням 30–90.

Сезонность. Летние отходы нельзя переносить на зиму: меняются аппетит, ассортимент овощей, питьевой режим.

Эффект смены. Пилот лучше вести с одной сменой-единомышленницей. Если меняется состав смены, вы измеряете смену, а не вариативность.

Возврат к среднему. Это статистическое явление, которое «может выдать естественные колебания повторных измерений за реальное изменение»: необычно высокие или низкие значения при повторном замере, как правило, оказываются ближе к среднему[239]. Если дом начинает пилот после особенно плохой недели, следующая неделя окажется лучше сама по себе. Защита — семидневная база вместо одного «показательного» дня и, где возможно, сравнение с отделением, где пилот не проводится. Авторы обзора подчёркивают, что эффект «можно ослабить лучшим дизайном исследования и подходящими статистическими методами»[239].

Решение принимается по осуществимости и безопасности. Удобно заранее записать критерии в формате, который методологи пилотных исследований называют системой светофора: зелёный — продолжать, жёлтый — изменить, красный — остановить. Такая система, по оценке исследователей, «может быть предпочтительнее простого подхода „стоп — продолжать“»: жёлтый сигнал оставляет место для исправимых проблем, а красный зарезервирован для «неразрешимых проблем, которые нельзя устранить»[236]. Работа Эйвери и соавторов написана о внутренних пилотах рандомизированных испытаний, поэтому мы переносим из неё только формат решения, а не пороги.

Сигнал	Условие	Решение
Зелёный — успех	Журналы ведутся без срывов, выбор есть на большинстве приёмов, отказы и клинический риск не выросли, трудозатраты укладываются в смету	«Умеем безопасно». Расширение или закрепление. Не «выбор доказал пользу»
Жёлтый — неоднозначно	Исправимые проблемы: пары, поток, очередь, маркировка	Ещё 60 дней с исправлением пар и потока
Красный — свернуть	Рост отказов или аспираций либо неподъёмные трудозатраты (раздел 35.5)	Свёртывание приказом с причинами

Итог: пилот отвечает на вопрос, безопасно ли это и какой ценой. На вопрос, «работает ли вариативность», он не отвечает.

35.5. Критерии остановки: где проходит линия

Пилот останавливается немедленно при любом из трёх сигналов. Первый — рост отказов от еды в точке пилота: недоедание важнее любой вариативности (раздел 12). Второй — санитарные нарушения на новой линии (раздел 18). Третий — клинические противопоказания, выявленные врачом.

Всё остальное — рабочие проблемы, а не повод для остановки. Очереди решаются организацией потока (раздел 20), страхи персонала — инструктажем (раздел 28), жалобы «выбирают не то» — пересмотром пар (раздел 19).

Девяносто дней, одна точка, три журнала, двенадцать чисел. Пилот модели М1 в одном отделении обычно укладывается в текущую смету. Полный переход дома может потребовать оборудования и дополнительных ставок: так прямо сказано в публичном сообщении о Серафимовском[5].

35.6. Пилот, который «не пошёл»: разбор четырёх исходов

Не каждый пилот заканчивается расширением, и полезно заранее знать, как выглядят неудачные исходы.

Тихая смерть. К шестидесятому дню журналы перестают вестись. Причина — у ритма нет владельца: еженедельная планёрка четыре раза откладывалась «на недельку». Защита — ритм, записанный в приказе с датами и фамилией ответственного.

Бунт кухни. Второй вариант оказывается невыполнимым из-за загрузки плит. Причина — пилот проектировали без заведующего производством. Защита — разделение ролей: кухня проектирует пары, администрация задаёт рамку.

Фиктивное оживление. Журналы заполнены, а жители молчат. Причина — предзаполнение журналов (кейс 4, понятие фиктивной вариативности). Защита — проверка реальности по приложению 24 начиная с пятнадцатого дня.

Честное свёртывание. Отказы выросли или трудозатраты оказались неподъёмными, и пилот свёрнут приказом с причинами. Из четырёх исходов только этот — успех управления: система узнала о себе правду и не заплатила за это здоровьем жителей. Документ о свёртывании защитит дом от повторения того же эксперимента через два года.

Исследование устойчивости улучшений в британских домах ухода показывает, насколько типичны первые три исхода. Когда в 2019 году исследователи вернулись к трём проектам по улучшению качества, проведённым в 2016–2018 годах, из семи внедрённых вмешательств продолжались лишь три; интервью дали 9 сотрудников проектов, 21 сотрудник из 13 домов и 2 медицинских работника. На устойчивость влияли мониторинг результатов, доступ к расходным материалам, готовность персонала тратить время, преемственность кадров с передачей дел новым сотрудникам, постоянная коммуникация, видимая польза и совпадение с приоритетами дома[240]. Подробнее об этом — в разделе 36.6.

35.7. Масштаб первого пилота: почему меньше — значит быстрее

Желание начать «сразу на весь дом» понятно, но губительно. Сбой в доме на триста жителей становится сбоем системы, а в доме-тысячнике тем более. Масштаб Серафимовского — 1 004 проживающих на февраль 2026 года (раздел 25.5).

Точка пилота: одно отделение на 20–35 жителей, одна смена-единомышленница, один приём пищи. Меньше — это уже проба, а не пилот. Больше — это реформа без подстраховки.

При выборе отделения «сложный» контингент (группа помощи, неговорящие жители) предпочтительнее «удобного». Практика, которая прошла на сложном отделении, масштабируется почти сама. Практика, которая прошла только на удобном, ломается о первое сложное отделение и хоронит тему для всего дома. В терминах теории внедрения выбор сложной точки проверяет уместность и осуществимость в худших условиях, а не в лучших[234].

35.8. Первая неделя пилота по дням

Главный риск первой недели — импровизация. Поэтому её стоит расписать по дням.

День 1. Вечером накануне объявляется меню и собирается заказ. Утром до начала варки сверяются объёмы. На линии работает старшая смены. Вечером — десятиминутный разбор.

Дни 2–3. Типичные проблемы: очередь у варианта Б, забытые бирки, «стандартные» порции, выданные без вопроса. Всё исправляется вечером того же дня.

Дни 4–5. Учитываются срывы и замены. Проводится проверка реальности по приложению 24 — пять вопросов.

Выходные. Линия может не работать в режиме выбора, но журнал не молчит: записывается, что выдано.

День 7. Планёрка по трём корзинам.

До того как накопятся семь дней данных, ничего не отменяется и не «улучшается». Первая неделя — это базовая линия работы новой схемы, а не её эффект. Для графика хода процесса^[235] первые семь точек — только начало: правила сдвига и тренда применяются позже.

35.9. Своя кухня и аутсорсинг: один пилот, две точки входа

Глава 35 написана для дома со своей плитой; глава 42 — для дома, где питание поставляет внешний исполнитель по спецификации. Директору, который работает с комбинатом питания, нужна сравнительная таблица, иначе пилот «на линии» начнётся в пустоте.

	Своя кухня	Аутсорсинг
Дни 1–14	Приказ, замер «до», опрос, инструктаж, письмо учредителю	То же, плюс сверка контракта: строки о выборе, заменах, пробах, отчётности (раздел 42.3)
Что меняется	Вторая гастрорёмкость и журнал на линии	Поставка двух вариантов и журнал замен поставщика; линия принимает, а не готовит
Если контракта ещё нет	Старт с понедельника	Сначала восемь строк в техническом задании (календарь — раздел 42.7); пилот без этих строк — декорация
Если контракт уже действует	—	Дополнительное соглашение или претензия по приёмке; не «попросить поваров комбината»
Стоп-сигналы	Рост отказов, санитарные нарушения, противопоказание врача	Те же плюс срыв поставки варианта Б и отсутствие суточных проб у учреждения
Понедельник без разрешения	Замер и журнал отказов	Замер, журнал и фотографии линии без лиц; техническое задание — в график закупки, а не в пожелания

Публичных кейсов вариативного меню при аутсорсинге питания нет. Таблица переносит инструменты доклада, а не чужой измеренный опыт. Критерии остановки одинаковы для обеих моделей (раздел 35.5): здоровье жителей важнее любой модели кухни.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-h/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/psd2026/10-blok-h/istochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-impl_outcomes_proctor	Proctor E. et al. Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda // Adm Policy Ment Health. 2011;38(2):65–76
M-hawthorne_mccambridge	McCambridge J., Witton J., Elbourne D.R. Systematic review of the Hawthorne effect: new concepts are needed to study research participation effects // J Clin Epidemiol. 2014;67(3):267–277

Маркер	Источник
M-rtm_barnett	Barnett A.G., van der Pols J.C., Dobson A.J. Regression to the mean: what it is and how to deal with it // Int J Epidemiol. 2005;34(1):215–220
M-pilot_progression_avery	Avery K.N.L. et al. Informing efficient randomised controlled trials: exploration of challenges in developing progression criteria for internal pilot studies // BMJ Open. 2017;7(2):e013537
M-runchart_perla	Perla R.J., Provost L.P., Murray S.K. The run chart: a simple analytical tool for learning from variation in healthcare processes // BMJ Qual Saf. 2011;20(1):46
I-cec_runchart	Clinical Excellence Commission (NSW Health). Run charts – Quality improvement tools
M-qi_sustain_devi	Devi R. et al. Sustaining interventions in care homes initiated by quality improvement projects: a qualitative study // BMJ Qual Saf. 2023;32(11):665–675

36

Дорожная карта на 12 месяцев: от пилота к системе

36.1. Логика карты

Дорожная карта этой главы построена по одному принципу: каждый квартал должен быть ценен сам по себе. Если дом остановится после любого из них — из-за смены руководства, бюджета или внешних обстоятельств, — у него останется работающий результат, а не недостроенная схема. Карта, в которой польза наступает только в конце года, на практике до конца года не доживает.

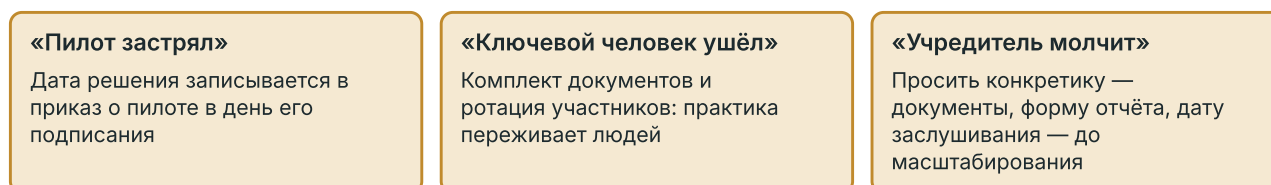
Сроки карты — ориентир для дома среднего размера. Средняя расчётная вместимость ПНИ по вторичной аналитике составляет 289 мест[7]; для такого дома предложенный темп реалистичен. Малым домам он позволит двигаться быстрее, многокорпусным понадобится больше времени. Карта — рекомендация, а не норматив (класс утверждения — раздел 41). Заметим также, что предшествующий корпус рисовал более длинный календарь, на 12–24 месяца, с пилотом лишь на 11–14-м месяце; настоящая редакция сжимает старт до девяноста дней в одном отделении. Это разные календари разных редакций, а не исправление ошибки.

Справка. Как измерять внедрение. Теория внедрения различает восемь **исходов внедрения**, которые отличаются от клинических результатов: **приемлемость** (насколько практика устраивает участников), **принятие** (решение начать её использовать), **уместность** (насколько она подходит учреждению и людям), **осуществимость**, **точность исполнения** («степень, в которой вмешательство было реализовано так, как предписано исходным протоколом»), **стоимость внедрения**, **охват** (насколько глубоко практика проникла в подразделения) и **устойчивость** («степень, в которой новое вмешательство сохраняется или институционализируется» в повседневной работе)[234]. Кварталы этой карты удобно читать как последовательность таких исходов: сначала осуществимость и безопасность, затем охват, затем институционализация, наконец устойчивость.

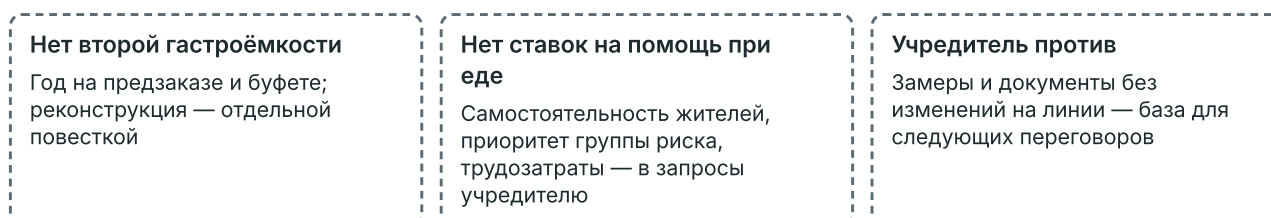


Каждый квартал ценен сам по себе: если дом остановится после любого из них, у него останется работающий результат — документ и число.

Три типовых сбоя и их профилактика (раздел 36.6)



При нехватке ресурсов — другой маршрут к той же цели: отличается темп, а не направление (раздел 36.7)



Сроки — ориентир для дома среднего размера; карта — рекомендация, а не норматив (раздел 41).

Рисунок 26. Дорожная карта на год: каждый квартал оставляет работающий результат и продвигает дом по исходам внедрения — от осуществимости к устойчивости; сбой и обеднённые сценарии меняют темп, а не направление (разделы 36.2–36.7)[234, 240]

36.2. Квартал 1 (месяцы 1–3): безопасный фундамент

Первый квартал идёт параллельно с пилотом (раздел 35) и закладывает основание, без которого расширение опасно.

Проводится аудит по двадцати четырём точкам (раздел 22, чек-листы приложений 18–21). Собирается документальный комплект (раздел 31). Проходят инструктажи трёх уровней (раздел 28). Врач подписывает лекарственно-пищевую таблицу и список дисфагического риска (разделы 10 и 11).

Результат квартала: пилот работает, замеры есть, клинические риски закрыты документами. В терминах исходов внедрения проверены осуществимость и безопасность в одной точке[234]. Если дом остановится здесь, он всё равно окажется лучше исходной точки: у него появились аудит, документы и обученная смена.

36.3. Квартал 2 (месяцы 4–6): расширение по горизонтали

Во втором квартале выбор распространяется либо на все приёмы пищи в точке пилота, либо на соседнее отделение. Решение принимается по готовности смен, а не по желанию администрации: смена, которая не готова, превратит расширение в фиктивную вариативность.

Меню пересчитывается по статистике выбора (раздел 21), пары эквивалентов исправляются. Запускается совет жителей (раздел 34), если он не был запущен раньше.

Результат квартала: вариативность стала ежедневной практикой в одном-двух отделениях, совет работает и ведёт протоколы. Растёт охват, и впервые можно судить о приемлемости практики для жителей и персонала не по первым впечатлениям, а по нескольким месяцам работы.

36.4. Квартал 3 (месяцы 7–9): структурные элементы

Третий квартал выводит вариативность за пределы линии раздачи.

Там, где позволяют контингент и санитарный контур, открывается буфетная зона (модель М3). Семейная подача (модель М4) вводится точно в группах помощи. Закупки переходят на спецификации под парные позиции (раздел 30). Учредитель получает первый квартальный отчёт с панелью показателей (раздел 22).

Результат квартала: система затронула закупки и пространство, а не только линию раздачи. Точка невозврата пройдена: практика встроена в документы, которые живут дольше одного руководителя, — в спецификации, положения, отчётность. Это и есть то, что теория внедрения называет институционализацией[234].

36.5. Квартал 4 (месяцы 10–12): масштабирование и закрепление

Решение о распространении практики на всю организацию принимается по данным трёх кварталов, а не по впечатлениям. Положение о питании обновляется целиком. Учредитель получает годовой отчёт.

Важная часть четвёртого квартала — обмен опытом: региональная площадка, семинар, публикация. Образцом служат учреждения, которые уже открыто рассказали о своей практике[3, 4, 6]. Публичность здесь не самоцель: она закрепляет практику, потому что от публично описанного труднее тихо отказаться.

Результат года: вариативность стала нормой дома — документированной, измеренной и защищённой перед проверкой (раздел 32).

36.6. Три типовых сбоя и их профилактика

Карта может сломаться в любой точке, но три сбоя встречаются чаще других.

«**Пилот застрял**». Точка работает год, но расширения нет. Причина в том, что по итогам девяноста дней не было принято решение. Профилактика: дата решения записывается в приказ о пилоте в день его подписания (раздел 35.2).

«**Ключевой человек ушёл**». Практика держалась на одном заведующем отделением или одной старшей смены, и с их уходом всё остановилось. Профилактика: комплект документов и ротация участников, чтобы практика пережила людей (раздел 31). Исследование устойчивости улучшений в британских домах ухода прямо называет преемственность кадров и передачу дел новым сотрудникам среди факторов, от которых зависит, продолжится ли вмешательство; там же названы мониторинг результатов, доступ к расходным материалам, готовность персонала выделять время, постоянная коммуникация, видимая польза и совпадение с приоритетами дома. Из семи вмешательств, внедрённых в 2016–2018 годах, к 2019 году продолжались лишь три[240]. Главный вывод авторов: об устойчивости лучше заботиться в ходе самого внедрения, «а не рассматривать её как отдельный процесс». Британские дома ухода устроены иначе, чем российские ПНИ, и долю «выживших» вмешательств переносить нельзя, но перечень факторов узнаваем.

«**Учредитель молчит**». Письма уходят, ответов нет. Профилактика: просить конкретику — перечень согласуемых документов, форму отчёта, дату заслушивания. Молчание учредителя — это риск, описанный в разделе 32, и снимать его нужно до масштабирования, а не после.

Каждый квартал должен оставлять после себя документ и число. Бумага переживает энтузиазм.

36.7. Карта при нехватке ресурсов: три ветки обеднённого сценария

Базовая карта рассчитана на ресурсы по умолчанию. Честность требует показать, что делать, когда их нет.

Нет второй гастрорёмкости (кейс 22). Весь год строится на предзаказе и буфете. Лестница моделей в этом случае описывает «максимум для данной инфраструктуры», а не маскирует его под полную вариативность. Реконструкция пищеблока ставится отдельной повесткой каждый год.

Нет ставок на помощь при еде (кейс 21). В центре — самостоятельность жителей и приоритет группы риска. Трудозатраты на помощь ежеквартально включаются в запросы учредителю. Вариативность вводится в позициях, которые не требуют дополнительной помощи.

Учредитель против. Дом ведёт замеры и документы без изменений на линии. Собранная база станет основанием для следующего цикла переговоров. Внешним аргументом может служить региональная группа семинара (раздел 40).

Обеднённый сценарий — не урезанная копия базового, а другой маршрут к той же цели. Отличается он темпом, а не направлением.

36.8. Как карта умирает: предупреждение по датам

У смерти дорожной карты есть своё расписание. В первом квартале она умирает молча: пилот «не дошёл». Во втором — громко: конфликт с учредителем, и тема откладывается «до лучших времён». В третьем и четвёртом — тихо: «и так сойдёт».

Против каждого сценария есть предохранитель.

Первый — публичный старт. Приказ с датами читает весь коллектив. Изменение, о котором знают все, труднее похоронить незаметно.

Второй — внешняя опора. Ответы на вопросы учредителю (раздел 38) и региональная группа семинара.

Третий — победа квартала, названная вслух. Совету жителей — число, коллективу — результат. Британское исследование подтверждает, что видимая польза и мониторинг результатов поддерживают продолжение вмешательств^[240]; дом, который не показывает своих результатов, лишает практику одной из главных опор.

Без предохранителей дорожная карта остаётся пожеланием. С ними она становится планом, который переживает и усталость, и смену людей.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-histochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/psd2026/psd2026-10-blok-histochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-impl_outcomes_proctor	Proctor E. et al. Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda // Adm Policy Ment Health. 2011;38(2):65–76
M-qi_sustain_devi	Devi R. et al. Sustaining interventions in care homes initiated by quality improvement projects: a qualitative study // BMJ Qual Saf. 2023;32(11):665–675

Четырнадцать возражений и честные ответы на них

Любое изменение в устройстве дома проходит через разговор, в котором его пытаются отговорить. Это нормально и даже полезно: возражение показывает, где у собеседника болит, а значит, где предложение ещё не додумано. Глава собирает четырнадцать возражений, которые чаще всего звучат в ответ на идею вариативного меню, и отвечает на каждое так, как отвечал бы коллега коллеге: без иронии, с признанием того, что в возражении верно, и с прямым указанием там, где данных нет.

37.1. Как устроен раздел

Каждое возражение приведено в редакции, близкой к тому, как его произносят на планёрке или в кабинете учредителя. Насмешки над ним здесь нет, потому что в большинстве возражений есть рациональное ядро: опасение за безопасность жителей, за нагрузку персонала, за деньги, за исход проверки. Ответ строится по одной схеме: что в возражении верно, какой механизм снимает опасение, где читатель может проверить ответ на собственных данных. Там, где данных нет ни у автора, ни в литературе, это сказано прямо.

Справка. Почему отвечать замером, а не убеждением. В управленческом споре о новой практике сталкиваются два вида знания: опыт («у нас так не получится») и чужой результат («у них получилось»). Ни то ни другое не переносится на конкретный дом автоматически. Третий вид знания — собственный замер до изменения и после него — единственный, который принимают обе стороны. Поэтому почти каждый ответ ниже заканчивается не аргументом, а предложением измерить: время раздачи, отходы, отказы. Методика замера — приложение 25.

1. «Наши жители не способны выбирать». Часть жителей действительно не выбирает словами, и делать вид, что это не так, бессмысленно. Но выбор не сводится к анкете или устному ответу. У человека есть по меньшей мере четыре канала, через которые его воля доходит до тарелки: показ (жест, взгляд, карточка), наблюдение за тем, что он ест и что оставляет, биография (что он любил до поступления) и знание близких (раздел 15). Зарубежные стандарты исходят из того же. Австралийские усиленные Стандарты качества ухода вступили в силу 1 ноября 2025 года^[45], и Стандарт 6 «Питание» требует, чтобы при каждом приёме пищи человек мог выбирать, «что, когда, где и как» он ест и пьёт (действие 6.3.2), а предпочтения оценивались и регулярно переоценивались у каждого (действие 6.2.1). Норма адресована всем проживающим, без изъятий для людей с когнитивными нарушениями; прямой формулы «независимо от когнитивного статуса» в тексте Стандарта 6 при проверке во второй редакции не найдено (см. новые источники главы). Там, где молчит и наблюдение, остаётся стандартный вариант: выбирать, чтобы поесть, не обязательно. Вариативность добавляет возможность, но не превращает выбор в условие обеда.

2. «Будут очереди и хаос на раздаче». Время на выбор реально, и отрицать его значит потерять доверие смены. Однако поток решается не отказом от выбора, а конструкцией раздачи: заказом накануне, визуальным меню, которое житель видит до подхода к линии, и маркировкой гастрорёмокостей (раздел 20). Успенский ПНИ, перешедший на вариативное меню во всех отделениях, сообщил, что «страхи не подтвердились»[3]. Это публичное сообщение учреждения, а не хронометраж, поэтому ответ на вопрос о вашей линии даст только собственный замер времени раздачи до изменения и после него.

3. «Это дорого». Честный ответ: неизвестно, пока не замерено. Сырьевая строка при парных эквивалентах, то есть при замене одного блюда другим той же пищевой ценности и сопоставимой цены, меняется мало и может быть близка к нулю (раздел 29). Затраты труда растут на минуты, а пищевые отходы могут снижаться. Утверждение «вариативность бесплатна» недоказано, и я его не повторяю; против него говорит и опыт Серафимовского, где старт потребовал оборудования и дополнительных ставок (раздел 25.5).

Зарубежные данные дают ориентир, но не ответ. В австралийской государственной больнице переход от традиционной раздачи по заранее составленному меню к модели «room service», при которой пациент сам заказывает блюдо из меню и получает его в течение часа, сопровождался снижением средних отходов с тарелки с 30 до 17 %, ростом потребления энергии (с 5513 до 6379 кДж в сутки) и белка (с 53 до 74 г в сутки) и снижением годовых затрат на продукты для пациентов на 28 %[147]. Это ретроспективное сравнение «до и после» по данным внутреннего аудита в одной больнице, а не рандомизированное исследование; больничные пациенты с коротким сроком пребывания и жители ПНИ с многолетним проживанием — разные люди, а австралийская больничная кухня — не российский пищеблок. Число показывает направление, в котором стоит смотреть, но не обещает того же результата. Семь дней собственного замера отвечают на вопрос о стоимости точнее любой дискуссии.

4. «Санэпид не разрешит». Санитарные правила регулируют поточность, температуру, суточные пробы и бракераж, но не число вариантов блюда[9]. Это верно и для СанПиН 2.3/2.4.3590-20, действовавшего до 31 августа 2026 года, и для СанПиН 2.3/2.4.4282-26, действующего с 1 сентября. Вторая гастрорёмкость на линии проходит тот же санитарный контур, что и первая, и требует одной дополнительной точки маркировки (раздел 18). Если санитарный врач всё же делает замечание, оно будет касаться конкретного нарушения — температуры, пробы, маркировки, — а не самого факта выбора. Замечание санврача — конкретика, а не фольклор, и отвечать на него нужно конкретикой.

5. «У нас нет диетолога». Для большинства домов это правда, но не препятствие. Пары эквивалентов строятся по нутриентной логике меню-раскладки, которую в доме уже кто-то ведёт (раздел 19), а клинические вопросы решает врач. Диетолог ускоряет работу и делает её точнее; его отсутствие не отменяет ни норм, ни опыта домов, которые внедрили выбор без него[3, 4].

6. «Жители будут выбирать нездоровое». Пара эквивалентов — это выбор внутри нормы, а не между нормой и вредом (раздел 19). Предложение «гречка или рис» не создаёт свободы «гречка или конфеты»: пределы задаёт меню, а не прилавок. В возражении, однако, есть зерно, которое не стоит отбрасывать. Серафимовский прямо сообщил, что жители склонны выбирать популярные, но не самые полезные продукты (раздел 25.5). Ответ на это — не запрет, а конструкция пар и пересчёт пропорций по статистике выбора (разделы 19 и 21).

7. «А если выбрал, а потом отказался?» Для этого существуют журнал отказов, альтернатива и фиксация (разделы 12 и 19). В США правило об альтернативе закреплено на федеральном уровне: дом престарелых обязан предлагать «привлекательные варианты сходной пищевой ценности» тем, кто отказывается от поданного блюда или просит другое (42 CFR § 483.60(d)(5))[46]. В России прямой нормы такого рода нет; для психоневрологических интернатов её можно вывести из статей 37 и 43 закона о психиатрической помощи при условии документирования[8]. Это толкование, а не прямая норма. Отдельные эпизоды отказа неизбежны; неизбежность — предмет журнала, а не повод отказаться от выбора.

8. «Лечебное питание несовместимо с выбором». Совместимо, если есть «мост» между организацией социального обслуживания и системой лечебного питания. Такой мост уже построен в некоторых регионах: распоряжение 19РВ-32, на которое опирается ДДСОЛ, связывает соцучреждение с системой диет[24]. Внутри диеты тоже можно составить пары. Диета ограничивает множество допустимых блюд, но не сжимает его до одного элемента. Назначение диеты остаётся за врачом.

9. «Персонал против». Обычно персонал против не выбора как такового, а непонятной надбавки к работе. Снимается это возражение инструктажем по трём уровням, ролями, прописанными в приказе, и ритмом планёрок. Главное — чтобы персонал проектировал линию раздачи, а не узнавал о ней из приказа (раздел 28).

10. «Проверка спросит — что ответим?» Ответим документом. В разделе 32 разобраны три типовых вопроса проверяющего и три документальных ответа на них. Страх проверки лечится комплектом документов, а не отказом от практики.

11. «Это всё для маленьких прогрессивных домов, у нас 400 мест». Практики вариативного питания внедрены в психоневрологических интернатах стандартной вместимости[3, 4]. В Иркутской области описаны четыре учреждения с разными моделями выбора[6]; единой региональной нормы источник не содержит (раздел 25.6). Масштаб меняет логику — поточность, заказ накануне, — но не принцип.

12. «Зачем, если и так нормально?» «Нормально» — по чьим меркам? Семидневный замер отходов и журнал отказов за неделю покажут, насколько нормально на самом деле. Для ориентира: в обзоре 32 исследований больничного питания медиана отходов с тарелки составила 30 % по массе при разбросе от 6 до 65 %, а среди причин названы, в частности, плохое качество блюд, неподходящие порции и ограниченный выбор[241]. Это больничные данные, и для российского дома они лишь задают масштаб возможной проблемы, а не её величину. Если после замера окажется, что всё действительно в порядке, доклад дал дому инструмент проверки, а не только инструмент изменений, и это тоже результат.

13. «Кухня не своя — нам не из чего выбирать». Без собственной плиты директор меняет не кастрюлю, а спецификацию. Вариативность на аутсорсинге — это восемь строк контракта (раздел 42.3). Если контракт уже идёт без этих строк, пилот начинается с дополнительного соглашения и порядка приёмки. Если контракт ещё впереди, работает осенний календарь правки технического задания (раздел 42.7). Публичных кейсов вариативности на аутсорсинге в открытых источниках нет, но это пробел в знаниях, а не доказательство невозможности.

14. «Новый СанПиН на пороге — не время экспериментировать». Это возражение звучало в последние дни августа 2026 года, за несколько дней до смены санитарных правил. С 1 сентября 2026 года СанПиН 2.3/2.4.4282-26 вступил в силу целиком, без переходного периода[9]. Изменились формы бракеража и привязка программы производственного контроля, но запрета на число вариантов не появилось. Журналы августа не переписываются; с 1 сентября ведутся новые формы (раздел 18.10, приложение 39). Обе редакции санитарных правил выбор допускают. Проверка в сентябре и позже смотрит сентябрь по новым правилам, а август — по старым.

Подведём итог. Двенадцать возражений снимаются документами, замерами и устройством линии. Тринадцатое снимается спецификацией. Четырнадцатое — чек-листом перехода на новые санитарные правила. Вопрос «зачем» снимается только собственными данными дома. Поэтому начинать стоит с замера.

37.2. Риторика спора: как не проиграть правое дело

Правильная идея проигрывает в зале чаще из-за подачи, чем из-за слабости аргументов. Три приёма губят её надёжнее всего.

Моральное превосходство. Ответ словом «достоинство» на вопрос о деньгах зал слышит как признание: «денег нет». Порядок должен быть обратным: сначала механика (замер, пары, поток), потом смысл.

Зарубежный аргумент без фильтра. Фраза «в Онтарио диетолог тратит 30 минут на жителя в месяц» звучит для российского зала как рассказ о чужих деньгах. Работает другая подача: «время специалиста нормируется; минуты мы считаем сами» (фильтры переноса — раздел 26).

Обещание результата. Фраза «отходы упадут на треть» убивает тему, если у слушателя они не упадут. Вместо обещания нужен метод: «замер покажет вашу цифру; вот дома, где замеряли после введения выбора»[3].

Рабочая формула ответа складывается из трёх частей: принцип, метод проверки и чужой измеренный факт с указанием его источника и границ. Такая формула не требует от собеседника веры.

37.3. Возражение-лакмус: «а сами бы вы так ели?»

Самое короткое возражение служит тестом на честность. Оправдание вроде «для жителей нормально» — по сути признание двух сортов людей: тех, кто готовит, и тех, кто ест. Процедура ответа проста. Руководство пробует еду с линии раздачи — с тарелки, а не из папки с раскладкой. Совет жителей проводит дегустации, и они фиксируются в протоколе. Кто в этом месяце не ел ту еду, которую едят жители, не вправе спорить о её качестве и должен сначала пойти и поесть. Стоит это ноль рублей. В чек-листе директора (приложение 18) это одна строка.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре raw/sources/poisk-2026-10-blok-i/istochniki.md. Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-room_service_mccray	McCray S. et al. Room service in a public hospital improves nutritional intake and increases patient satisfaction while decreasing food waste and cost // J Hum Nutr Diet. 2018;31(6):734–741
M-platewaste_williams	Williams P., Walton K. Plate waste in hospitals and strategies for change // e-SPEN. 2011;6(6):e235–e241
I-aus6 (проверка)	Strengthened Aged Care Quality Standards, Standard 6, ред. август 2025; дата вступления 01.11.2025 – по странице ACQSC
I-cfr (проверка)	42 CFR § 483.60(d)(5), (f) – по тексту Cornell LII

38

Десять вопросов учредителю: повестка для разговора наверх

Многое из того, о чём шла речь в предыдущих главах, директор может сделать сам. Но рано или поздно он упирается в границу своих полномочий: в региональную норму, утверждённое меню, форму учёта, строку финансирования. Эта глава о том, как перейти эту границу не просьбой, а вопросом, на который учредитель способен ответить документом.

38.1. Зачем этот список

Большинство решений в организациях стационарного социального обслуживания упираются не в федеральный закон, а в региональный контур: статус норм, утверждённое меню, формы учёта, порядок финансирования (раздел 24). Причина этого заложена в самом законе. Федеральный закон № 442-ФЗ относит к полномочиям органов государственной власти субъекта, в частности, утверждение норм питания в организациях социального обслуживания субъекта (ст. 8, п. 6), утверждение нормативов штатной численности и нормативов обеспечения мягким инвентарём и площадью жилых помещений (п. 5) и утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками (п. 10)^[242]. Иначе говоря, та рамка, в которой живёт кухня дома, по закону задаётся на уровне региона.

Справка. Учредитель и уполномоченный орган. Учредителем государственного учреждения социального обслуживания выступает, как правило, орган исполнительной власти субъекта, ведающий социальной защитой (министерство, комитет, департамент). Он утверждает устав, доводит государственное задание и финансирует его выполнение, согласует крупные решения. Тот же орган или другой орган субъекта утверждает региональные нормы питания и порядок предоставления социальных услуг. Поэтому вопрос «можно ли нам» директор обычно задаёт тому, кто одновременно его финансирует и устанавливает для него правила.

Директор, спрашивающий «можно ли нам», нередко получает ответ «не надо». Десять вопросов ниже превращают разговор из просьбы в инженерную задачу: на каждый можно ответить документом, и каждый ответ что-то меняет в работе дома.

38.2. Вопросы о нормах и документах

1. Каков статус рекомендуемых норм Минтруда (приказ № 520н) в нашем регионе: рекомендация или основа императивного регионального норматива?^[38] От ответа зависит свобода манёвра при составлении пар эквивалентов (раздел 19). Приказ № 520н называется «рекомендуемыми нормами», а утверждение норм питания для своих организаций закон отводит субъекту^[242]. Поэтому реальный статус норм в конкретном доме определяется региональным актом, и директору нужно знать, какой это акт и что в нём написано.

2. Утверждено ли в регионе собственное перспективное меню для организаций социального обслуживания и какова процедура внесения в него изменений? Если меню утверждено как обязательное, вариативность начинается с документа, а не с линии раздачи (раздел 24).
3. Есть ли в регионе акт, связывающий организации социального обслуживания с системой лечебного питания (образец — распоряжение 19РВ-32)[24]? Если такого акта нет, готов ли учредитель инициировать его или санкционировать локальный «мост»?
4. Какая форма учёта продуктов признаётся актуальной с учётом перехода на электронные формы по приказам Минфина[224], и допускает ли она журналы заказа и замен как приложения?

38.3. Вопросы о финансах и закупках

5. Как устроена сырьевая строка нашего финансирования, и можем ли мы публиковать её внутри системы — учредителю и совету жителей — по итогам квартала? Прозрачность этой строки работает на её адекватность. В зарубежных системах стоимость питания стала предметом отдельного расчёта и публичного обсуждения именно тогда, когда её начали считать открыто[182, 211] (подробно — раздел 29).
6. Допускает ли действующий контракт или типовая документация парные позиции и закупку по статистике выбора, или спецификации придётся менять при следующей закупке (разделы 30 и 42.7)?
7. Как в регионе относятся к аутсорсингу питания, и если он у нас есть, включает ли контракт вариативность, текстуру и документирование замен? Без этих строк подрядчику уходит не только кухня, но и часть прав жителей (разделы 30 и 42).

38.4. Вопросы о полномочиях и развитии

8. Согласен ли учредитель на пилот по модели раздела 35 — одна точка, 90 дней, панель показателей — с заранее оговорённой датой заслушивания? Просьба с датой — это просьба о решении, а не о благословении, и на неё легче ответить «да».
9. Готов ли регион к обмену практиками и поддержит ли публичный рассказ о нашем опыте по образцу уже опубликовавших[3, 4, 6]? Практику, о которой рассказано публично, труднее тихо отменить.
10. Что учредитель считает показателями качества питания, и готов ли включить в них долю выбирающих жителей и уровень отходов? Вопрос переводит вариативность из «инициативы директора» в «показатель системы». Сегодня такого показателя в федеральной рамке оценки качества нет. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы измеряет открытость информации, комфортность условий, доступность для инвалидов, доброжелательность работников и удовлетворённость получателей условиями услуг; отдельного показателя, касающегося питания, в едином порядке расчёта нет[243]. Питание попадает в эту оценку только косвенно, через общую удовлетворённость. Если учредитель хочет

видеть качество питания, он может включить свои показатели в государственное задание или в региональный мониторинг; это толкование возможностей учредителя, а не обязанность, вытекающая из нормы.

38.5. Как вести сам разговор

Три правила помогают разговору состояться. Первое: каждому вопросу нужна односторонняя справка (приложение 33), чтобы учредитель видел не абстрактное пожелание, а описанную проблему и вариант решения. Второе: первая повестка — вопросы 1, 2 и 8; остальные подождут второй встречи. Третье: ответы нужно получить письменно, хотя бы в виде служебной записки, потому что позиция учредителя — половина защиты дома при проверке (раздел 32).

У учредителя есть то, чего нет у директора: право менять региональные документы. Десять вопросов — способ передать ему ту работу, которую может сделать только он.

38.6. Если ответ «нет»: три уровня отказа и работа с каждым

Отказ — не конец разговора, а диагностика. По содержанию отказы делятся на три уровня, и с каждым работают по-своему.

Ресурс («нет денег»). Ответ — список мер нулевой стоимости и замеры. Деньги просят позже, под полученные цифры.

Риск («накажут»). Ответ — документы раздела 32 и старт без изменения линии раздачи: замеры, карты жителей, совет.

Статус («не положено»). Ответ — просьба назвать норму. Часто нормы нет, и тогда «не положено» превращается в «не принято», а это уже разговор о решении, а не о запрете.

Отказ тоже нужно получить письменно. Через год рамка может смениться, и письменный отказ станет точкой отсчёта; устный растворится без следа. И одно «нет» не закрывает остальные девять вопросов.

38.7. Когда учредитель — союзник: как не потерять его

Союзник в лице учредителя — ресурс со сроком годности: меняются люди, сменяются приоритеты. Удержать его помогают три вещи. Отчитываться нужно числами, а не описанием активности. Роль учредителя стоит признавать публично, по образцу внедривших учреждений[3, 4]. А риск, который он на себя берёт, должен быть защищён документами, а не оставлен голым. Числа, признанная роль и безопасность держат союз дольше, чем длится одна ротация кадров.

Новые источники главы

Полные записи и проверенные формулировки — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-i/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/poisk-2026-10-blok-i/istochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S121	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», ст. 8, пп. 5, 6, 10, 24.1 (полномочия субъекта)
S122	Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка расчёта показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг...» (зарег. Минюстом 11.10.2018 № 52409)

39

Предложения отрасли: что должно измениться выше уровня учреждения

Предыдущие главы говорили о том, что дом может сделать сам. Эта глава смотрит выше, туда, где решения принимают регион и федеральный центр. Её задача — назвать препятствия, которые директор не устранил никаким приказом по учреждению, и предложить, как их можно снять.

39.1. Граница раздела

Всё сказанное до сих пор касалось того, что организация может сделать сама, в действующем правовом поле. Этот раздел — о том, что ей мешает и что решается только на региональном и федеральном уровнях. Предложения ниже — повестка для обсуждения, в том числе профессионального, а не готовые законопроекты. Нормотворческое конструирование выходит за пределы доклада, и класс этих утверждений — рекомендация (раздел 41).

39.2. Пять федеральных предложений

1. Закрепить минимальный стандарт выбора в рекомендуемых нормах. Приказ № 520н задаёт нутриентные рамки питания[38], но ничего не говорит о структуре выбора. Зарубежные системы закрепляют и её: в Онтарио — альтернативный выбор основных блюд, овощей и десертов на обед и ужин[27], в США — альтернативу при отказе[46], в Австралии — право человека выбирать, «что, когда, где и как» он ест[45]. В Англии требование выбора встроено в обязательное регулирование: правило 14 о потребностях в питании и питье включает в эти потребности подходящую питательную еду и питье, «разумные требования», вытекающие из предпочтений, религиозных и культурных особенностей человека, и поддержку при еде; разъяснения регулятора говорят, что люди «должны иметь возможность выбирать свой рацион», а при нарушении, повлёкшем предотвратимый вред, регулятор — Комиссия по качеству ухода (Care Quality Commission) — вправе преследовать поставщика в суде, не направляя предварительного предупреждения[244]. Российская формула может быть скромнее: в нормы вносится не меню, а принцип «не менее двух вариантов основной позиции там, где это технологически возможно». Близкую формулу как предложение на будущее (*de lege ferenda*) выдвигает и соседний правовой обзор нормативной базы вариативного меню; это совпадение двух рекомендаций, а не норма.

Справка. Перенос зарубежной нормы. Зарубежная норма показывает, что принцип выразим языком права и что система с ним живёт. Она не показывает, что тот же принцип сработает в российской рамке: за правилом 14 стоят инспекция, санкции и иное финансирование. Поэтому переносится формулировка и механизм контроля, но не уровень санкций и не нормативы времени (фильтры переноса — раздел 26).

2. Урегулировать стык организаций социального обслуживания и лечебного питания. Приказы Минздрава о лечебном питании адресованы медицинским организациям, и организации социального обслуживания остаются в серой зоне (раздел 17). Выходом может стать совместный акт Минтруда и Минздрава или типовой региональный «мост»[24]. Пока стык не урегулирован, каждая организация решает клинические вопросы питания на свой страх и риск.

3. Ввести два показателя в отраслевую отчётность: долю жителей, участвующих в выборе, и уровень пищевых отходов. Оба показателя измеряются дёшево (приложения 24 и 25). Что измеряется наверху, то организуется внизу. Сегодня единый порядок расчёта показателей независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы не содержит ни одного показателя, относящегося к питанию: оценка охватывает открытость, комфортность, доступность для инвалидов, доброжелательность персонала и удовлетворённость условиями[243]. Пример того, как отходы становятся отраслевым показателем, даёт Англия: национальные стандарты больничного питания 2022 года обязывают все организации NHS, работающие по стандартному контракту, отслеживать пищевые отходы, принимать меры к их снижению и сообщать данные по каждому виду отходов централизованно, с последующей публикацией[245]. Масштаб проблемы задаёт литература по больничному питанию: медиана отходов с тарелки в 32 исследованиях — 30 % по массе[241]. Для российских домов таких данных нет вообще, и это само по себе аргумент за показатель.

4. Снять неопределённость с формами учёта. Переход на электронные формы (приказы Минфина № 61н, 142н, 100н, 157н, 174н)[224] порождает на местах настроение «всё меняется, лучше не начинать». Нужна разъясняющая справка: какие формы применяют организации социального обслуживания сейчас и какие будут применять после каждого этапа перехода.

5. Поддержать публикацию практик. Внедрившие учреждения существуют[3, 4, 6], но их опыт распространяется через новостные ленты, а не через методические каналы. Сборники практик с документальными приложениями сократили бы цикл распространения с лет до месяцев.

39.3. Пять региональных предложений

Региональные предложения важнее федеральных по одной причине: закон отводит субъекту утверждение норм питания, нормативов штатной численности и порядка предоставления социальных услуг (ст. 8 442-ФЗ, пп. 5, 6, 10)[242]. Именно здесь решается, сколько свободы у кухни конкретного дома.

6. Определить статус рекомендуемых норм. Достаточно одного абзаца в региональном акте: рекомендация это или императив. Неопределённость статуса — главный тормоз (раздел 24).

7. При императивном меню — установить процедуру его изменения с участием самих организаций: кто инициирует изменение, какие нужны обоснования, в какие сроки принимается решение.

8. Создать региональный «мост» к лечебному питанию там, где его нет, по готовому образцу[24].

9. Включить требования к вариативности и документированию в типовые документы закупок и аутсорсинговых контрактов (разделы 30 и 42). Без этих строк права жителей зависят от доброй воли подрядчика.

10. Создать региональную площадку обмена — ежегодный семинар или рабочую группу с публикацией итогов. Иркутский опыт показывает, что поддержка регионального министерства помогает практике распространиться по нескольким учреждениям сразу, причём каждое выбирает свою модель^[6] (раздел 25.6).

39.4. Чего доклад не предлагает

Три умолчания доклада сделаны сознательно.

Новый закон о питании в организациях социального обслуживания не нужен. Действующая рамка — закон о психиатрической помощи, санитарные правила, рекомендуемые нормы^[8, 9, 38] — уже позволяет главное; проблема в статусах норм и в стыках между ведомствами.

Обязательная вариативность без переходного периода не предлагается. Если в доме нет подходящей кухни или достаточной смены, обязательная норма породит фикцию (раздел 21).

Числовые нормативы стоимости не предлагаются. Публичных данных о сырьевой строке российских организаций социального обслуживания нет, и норматив, построенный на пустоте, был бы выдумкой.

Десять предложений директора могут сформулировать вместе. Профессиональная площадка — место их согласования; о том, как была устроена такая площадка на семинаре августа 2026 года, — раздел 40.

39.5. Как предложения становятся нормами: японский путь как учебный пример

Опыт Японии полезен не содержанием норм, а последовательностью, в которой они появлялись^[191, 193]. Этот путь можно разделить на три фазы. В первой государство платит надбавку за добровольное улучшение питания, и вперёд выходит авангард. Во второй создаётся национальная база данных, и отрасль начинает говорить языком цифр. В третьей требование становится обязательным — тогда, когда отрасль уже умеет его выполнять.

Россия находится между первой и второй фазами: авангард есть^[2, 3, 4], данных нет. Поэтому запрос наверх должен звучать как «считайте», а не «разрешите» и не «обязите». Два показателя из предложения 3 запускают вторую фазу без бюджетных затрат и без риска для учреждений. Английский пример с централизованной отчётностью об отходах^[245] показывает, что такой шаг может предшествовать любым требованиям к самому меню.

39.6. Роль профессионального сообщества

Предложения 6–10 реализуют регионы, но инициировать их должны директора: именно они знают, где стык болит. Минимальный набор действий сообщества — рабочая группа при профессиональной ассоциации, ежегодный сбор практик и банк форм, первым взносом в

который могут стать приложения доклада. Стоимость этой работы организационная, а не денежная. Так закрывается методический дефицит, о котором шла речь в разделе 41.3.

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-block-i/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/psk-2026-10-block-i/istochniki.md). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
I-cqc_reg14	Care Quality Commission. Regulation 14: Meeting nutritional and hydration needs (Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014)
I-nhs_standards2022	NHS England. National standards for healthcare food and drink. Version 1, 01.11.2022
M-platewaste_williams	Williams P., Walton K. Plate waste in hospitals and strategies for change // e-SPEN. 2011;6(6):e235–e241
S121	Федеральный закон № 442-ФЗ, ст. 8 (полномочия субъекта)
S122	Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н (единый порядок расчёта показателей независимой оценки качества)

Организационные предложения семинару

Семинар — не глава внедрения, и эта глава в докладе самая короткая. Её назначение — показать, где лежат материалы для тех, кто собирает зал, и отделить их от инструментов для тех, кто внедряет выбор у себя.

Межрегиональный методический семинар-совещание прошёл в Санкт-Петербурге 25–27 августа 2026 года. Сессия о питании состоялась 26 августа на площадке ДСО «Тесовый берег»; её вели директор ДСО «Серафимовский» Евгений Чистяков и директор ДСО «Тесовый берег» Тимур Нурбаев. Во второй редакции доклада глава поэтому описывает не план, а устройство уже использованного пакета и то, что из него остаётся полезным после семинара.

Сценарий трёх дней, работа в малых группах, вопросы залу и предложения площадке собраны в семинарском пакете. В нём описаны уникальность состава участников, пять предложений по формату, перечень того, чего на площадке делать не следует, инфраструктура работы после семинара, конструкция трёх дней и подписка об общем замере. Часть этих материалов сохраняет ценность и вне зала. Сценарий обсуждения в малых группах (45 минут, группы по 8–10 человек, разбор учебного кейса и самоопределение модели М0–М5 с перекрёстной проверкой в парах) можно провести на собственной планёрке или на встрече директоров региона. Пять вопросов залу годятся как входная анкета для коллектива: кто в действительности выбирает, что ест житель; кто из руководства ел еду жителей за последний месяц; на чём основано мнение о стоимости выбора; что происходит с тарелкой жителя, который систематически отказывается от еды; какой документ дом покажет проверке первым.

Чего в корпусе доклада нет, нужно сказать прямо. Ответы зала, итоги работы малых групп и результаты подписки об общем замере в материалы не вошли, и вторая редакция не может на них опираться. Если участники соберут и опубликуют свои замеры, это будут первые сопоставимые данные о вариативном питании в российских домах; пока их нет, пробелы раздела 41.3 остаются открытыми.

Кто собирает зал или рабочую группу, открывает семинарский пакет. Кто внедряет выбор у себя, читает разделы 35–39 и 41–43.

41

Заявление о достоверности: что в этом докладе на чём стоит

Доклад, который предлагает директорам менять устройство питания, обязан отчитаться о собственных основаниях. Эта глава — такой отчёт. Она объясняет, какие виды утверждений есть в тексте, чем подтверждён каждый из них, чего доклад не знает и где читатель может поймать автора на ошибке.

41.1. Зачем этот раздел

Ранние версии материалов, из которых вырос доклад, содержали утверждения без источников, заимствованные цифры и оценки, выдававшиеся за факты. Этот раздел — публичная отчётность о том, как с этим наследием поступили: какие классы утверждений есть в тексте, как подтверждён каждый класс и где читатель может проверить автора.

Справка. Почему у утверждений бывают «классы». В доказательной медицине давно принято различать, насколько надёжно основание утверждения. Международная система GRADE разделяет два вопроса: каково качество доказательств и насколько сильна рекомендация, выведенная из них; сильная рекомендация оправдана тогда, когда высококачественные данные ясно показывают перевес пользы над вредом, а неопределённость данных ведёт к слабой рекомендации[246]. В России та же логика закреплена для клинических рекомендаций приказом Минздрава от 28.02.2019 № 103н: уровни достоверности доказательств (УДД) идут от 1 — систематического обзора рандомизированных клинических исследований с метаанализом — до 5, когда есть лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов; уровни убедительности рекомендаций (УУР) обозначаются буквами А (сильная), В (условная) и С (слабая)[247]. Доклад о питании в социальных учреждениях — не клиническая рекомендация, и эти шкалы к нему формально не применяются. Но принцип тот же: читатель должен видеть, стоит ли за фразой норма, исследование, толкование или мнение автора.

Доклад использует четыре класса утверждений: **норма** (прямое требование действующего акта), **толкование** (вывод из нормы или из сочетания норм), **рекомендация** (предложение автора, основанное на данных или опыте) и **проект локальной формы** (образец документа, который дом может принять, но не обязан). Класс утверждения не повышается: толкование не становится нормой оттого, что повторено несколько раз, а зарубежное число не становится российским фактом без оговорки о переносимости.

Класс	Что это	Пример из доклада
Норма	Прямое требование действующего акта	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56: питание не менее трёх раз в день, суточные пробы (раздел 32.2)
Толкование	Вывод из нормы или из сочетания норм	Обязанность предложить альтернативу при отказе выводится из ст. 5, 37 и 43 закона № 3185-1 (разделы 17, 32.3)
Рекомендация	Предложение автора, основанное на данных или опыте; зарубежный перенос — ориентир	Пилот на 90 дней; ориентир Онтарิโอ «не более двух полностью кормимых на одного помогающего» (разделы 20.3, 35)
Проект локальной формы	Образец документа: дом может принять, но не обязан; адаптирует и утверждает сам	Приложения 1–45, например матрица ролей (приложение 17)

от требования акта к образцу документа

Класс не повышается при пересказе

Толкование не становится нормой оттого, что повторено несколько раз, а зарубежное число не становится российским фактом без оговорки о переносимости.

Четыре категории доступности источника — не смешивать под словом «верифицировано» (раздел 41.2)



Для сравнения: по шкале приказа Минздрава № 103н основания вариативного меню в лучшем случае соответствуют уровням достоверности 3–5 — это оценка автора, а не формальная процедура: доклад — не клиническая рекомендация.

Рисунок 27. Четыре класса утверждений: на чём стоит каждая фраза доклада и почему класс не повышается при пересказе (разделы 41.1–41.2)[247]

41.2. Классы утверждений и их подтверждение

Нормы права. Каждая ссылка на правовой акт дана с реквизитами и привязана к реестру (раздел 44: **34 записи**, маркеры S001–S035 без S026). Дата актуальности реестров — **23.07.2026**, правовая сверка — **19–21.08.2026**. Для каждого акта указано, что именно он подтверждает. Не все позиции реестра — публичные первоисточники: часть составляют внутренние документы, вторичные пересказы или позиции, которые требуют повторной проверки редакции. Приказ № 940н, фигурировавший в ранних материалах, не подтвердился и был исключён, а не оставлен «на всякий случай». Во второй редакции (октябрь 2026 года) новые российские источники получили маркеры за пределами первоначального ряда и внесены в отдельные реестры поисков; счёт раздела 44 относится к первой редакции.

Клинические данные. Числа о лекарственных взаимодействиях, дисфагии, метаболических эффектах и реабилитации отсылают к реестру (раздел 44, **48 записей**): систематические обзоры, метаанализы, руководства IDDSI и профессиональных обществ, описания клинических случаев. Сила доказательств неодинакова. Где она высока, доклад это показывает: взаимодействие

клозапина с кофеином[17], связь уровня лития с потреблением соли[18]. Где она ограничена — например, в оценке частоты отдельных паттернов пищевого поведения, — это оговорено. Где доказательств нет, сказано прямо: рандомизированных исследований вариативного меню в психиатрии не найдено (раздел 27).

Отсутствие таких исследований — не особенность психиатрии. Систематический обзор EDWINA, посвящённый мерам, которые косвенно поддерживают питание людей с деменцией (обстановка столовой, способ подачи, обучение персонала, поведенческие приёмы), включил 56 вмешательств из 51 исследования и пришёл к выводу, что «окончательных доказательств эффективности или неэффективности конкретных вмешательств» нет: исследования малы и кратковременны, лишь 34 % вмешательств проверены в рандомизированных испытаниях, а меры, связанные со средой столовой и подачей пищи, вообще не проверялись рандомизированно. Расширение выбора встречалось там только как часть многокомпонентных программ без ясного влияния на пищевой статус, хотя в двух исследованиях подача из общей ёмкости по типу буфета увеличила потребление энергии и белка[152]. По шкале приказа № 103н основания вариативного меню в лучшем случае соответствуют уровням 3–5; это оценка автора, а не результат формальной процедуры.

Международные нормы. Девять зарубежных систем отражены в реестре (раздел 44, **44 записи**) с указанием акта, пункта и даты вступления там, где она значима (австралийский Стандарт 6 — с 01.11.2025[45]). Перенос на российскую почву — рекомендация или ориентир, а не обязанность.

Российская статистика. Числа о системе ПНИ — вторичная аналитика проекта «Если быть точным»: данные **за 2022 год**, публикация 09.04.2026[7]. Это не статистическая отчётность Минтруда и не исследование ТАСС; информационные агентства лишь пересказывали публикацию. Где независимого подтверждения нет, это сказано прямо.

Российские практики. Каждая практика опирается на публичный первоисточник с датой[2, 3, 4, 5, 6, 24]. Оценки вроде «мало» или «растёт» — интерпретация открытого поиска, а не результат репрезентативного обследования; такого обследования не существует.

Числовые примеры и расчёты. Модельные вычисления помечены как иллюстративные и снабжены допущениями. Формула «вариативность почти бесплатна» удалена как недоказанная; вместо неё дан порядок замера.

Четыре категории доступности источников нельзя смешивать под словом «верифицировано»: **публичный первоисточник, внутренний документ, вторичная публикация, требует перепроверки.**

41.3. Что доклад не знает: честный список пробелов

Репрезентативной статистики вариативного питания в российских организациях стационарного социального обслуживания нет. Рандомизированных исследований эффекта вариативности в психиатрических стационарах не найдено; как показано выше, их нет и для смежной группы людей с деменцией. Судебной практики о вариативном меню не обнаружено. Данных о сырьевой строке российских организаций в публичном поле нет. Статус норм в каждом из 51 региона

индивидуально не проверен: методика проверки дана в разделе 24, сама проверка — работа региональных групп (раздел 40). Пробелы — не слабость, которую нужно прятать, а карта мест, где читатель обязан включать собственную проверку.

41.4. Как проверить авторов

Проверить доклад можно двумя способами. Первый: открыть раздел 44 — каждое утверждение имеет маркер, каждому маркеру соответствует строка списка. Второй: найти утверждение без маркера или маркер без строки. Это ошибка автора, а не недоразумение читателя. Достоверность в этом понимании — не обещание «мы не ошибались», а конструкция «вы можете нас поймать».

41.5. Известные уязвимости этой версии

Датировка. Реестры составлены на 23.07.2026, сверка проведена 19–21.08.2026. Нормы, особенно региональные, и формы учёта^[224] меняются, поэтому перед изданием приказа по учреждению их нужно проверить заново. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 утверждён 02.06.2026 и вступил в силу 01.09.2026, через несколько дней после семинара; по тексту постановления он действует до 01.09.2032 и с той же даты признаёт утратившим силу постановление № 32 об СанПиН 2.3/2.4.3590-20^[9]. Переход от 3590-20 зафиксирован; локальные акты дом перепривязывает сам.

Здесь же нужно назвать противоречие внутри корпуса, которое вторая редакция не сглаживает. Соседний правовой обзор нормативной базы вариативного меню (литературная редакция 29.08.2026) указывает, что СанПиН 3590-20 действует до 01.01.2027, и не упоминает СанПиН 4282-26. Текст постановления о СанПиН 4282-26, перечитанный 09.10.2026, говорит об утрате силы прежних правил с 01.09.2026. Доклад следует тексту постановления, но фиксирует расхождение, чтобы читатель, встретивший другую дату, знал её происхождение.

Языковая асимметрия. Международные тексты читались по-английски; немецкие и шведские нюансы могли сгладиться при переводе. Во второй редакции ключевые иноязычные формулировки приводятся в реестрах поисков в оригинале и в переводе, чтобы перевод можно было проверить.

Отбор практик. Шесть российских практик найдены открытым поиском; одна из них — дом докладчика (кейс 25.5, конфликт интересов раскрыт). Практики без публикаций в доклад не попали.

Собираательные кейсы. Кейсы 1–22 описывают типовые механизмы: они правдивы по логике, но условны по фактуре и не являются хроникой конкретного дома.

Авторская позиция. Там, где доказательств нет, доклад занимает сторону, например в вопросах приоритета зафиксированной воли и формулы «учреждение — опекун». Позиция аргументирована, но остаётся позицией; её границы обозначены в разделе 16.

41.6. Что изменила вторая редакция

Вторая редакция (октябрь 2026 года) не меняет классов утверждений, но меняет метод работы с источниками. Каждый новый источник получил маркер, запись в реестре с указанием того, что именно было прочитано — полный текст или только реферат, — и с переводом ключевой формулировки. Числа берутся только со страниц, которые были прочитаны; то, что проверить не удалось, в текст не попадает и отмечено в реестре. Ошибки первой редакции, найденные при проверке, исправлены в тексте и записаны в реестрах как расхождения с корпусом. Исходный текст первой редакции при этом не правится: он остаётся неизменным, чтобы любое исправление можно было сверить.

Пять уязвимостей раздела 41.5 исправляет не редакция, а новые данные — прежде всего замеры, которые соберут сами дома.

Главные исправления второй редакции. Ниже перечислены расхождения, которые меняют смысл утверждения; мелкие уточнения реквизитов и нумерации записаны только в реестрах.

Где	Было в первой редакции	Как на самом деле
2, 4, 8, 17, 25, 37, 39, 43	Иркутская область ввела региональную модель «два первых, два вторых, гарниры»	Источник описывает четыре учреждения с разными моделями; формула относится к одному отделению Марковского геронтологического центра с сентября 2024 года; единой региональной нормы нет (25.6)
7.1, 8.2	Семейная подача дала эффект «у пожилых с деменцией» и «рост качества жизни»	В исследовании Nijls 2006 деменция была критерием исключения; качество жизни в группе вмешательства сохранилось, а в контрольной снизилось
26.8, 27.3, 27.9	«Японская когорта поддержанного жилья» со снижением смертности	Это нидерландский метаанализ восьми РКИ вмешательств в образ жизни (Kooijen 2022); данных о смертности и госпитализациях в нём нет
2, 4, 6, 23	74 % недееспособных — данные за 2024 год; 11 % — «постельные или маломобильные»	Данные относятся к 2022 году; 11 % — только постоянный постельный режим
8.8, 23.2	«Около 7 тысяч вышли из ПНИ», «1 800 в распределённых квартирах»	7 тысяч — получатели услуг сопровождаемого проживания, большинство в учебных квартирах на базе ПНИ; на постоянном сопровождаемом проживании — не более 1,8 тысячи
10.8	Гигиена рта «предотвращает каждую десятую смерть»	Не подтверждено; Кокрейновский обзор 2022 года оценивает доказательства как низкой достоверности
14.3, 16.2	Гуманное отношение — статья 37 Закона № 3185-1	Часть 2 статьи 5; статья 43 распространяет на проживающих ПНИ только части 2 и 4 статьи 37
2, 4, 16	Опекун учитывает мнение подопечного «по ст. 29 ГК и 48-ФЗ»	Общая обязанность — пункт 3 статьи 36 ГК; статья 29 касается сделок, в 48-ФЗ такой нормы нет
15.10	Для поста и религиозных ограничений «русской рамки нет»	Для ПНИ рамка есть: часть 2 статьи 37 называет право соблюдать пост, статья 39 обязывает установить правила обрядов
17 (шапка)	Переходный период СанПиН 01–15.09.2026	Переходного периода нет; СанПиН 3590-20 утратил силу 01.09.2026, 4282-26 действует до 01.09.2032
17.6	Основание обработки сведений о здоровье — договор или ИППСУ	Нужно основание из части 2 статьи 10 закона № 152-ФЗ
33.2	Постановление ВС № 11-АД19-4 — дело дома-интерната	Это дело школы № 80 в Казани (переквалификация со ст. 6.6 на ст. 6.7 КоАП); перенос на ДСО и ПНИ — аналогия
30.1	Субсидия автономного учреждения «нередко остаётся в контуре 44-ФЗ»	По части 4 статьи 15 44-ФЗ автономное учреждение применяет его при капвложениях или если этого требуют условия выдачи средств
30.7	Анонимность заявителя в ФАС предусмотрена законом	Часть 1 статьи 44 закона № 135-ФЗ требует сведений о заявителе

Где	Было в первой редакции	Как на самом деле
31.5	Приказы 157н и 174н — этапы перехода на электронные формы	Это планы счетов; электронные формы утверждены приказом № 61н
37	Австралийский Стандарт 6 требует выбора «независимо от когнитивного статуса»	Такой формулы в стандарте нет; есть выбор «что, когда, где и как» и оценка предпочтений каждого
11.11	Кофеин повышает концентрацию клозапина «популяционно»	Данные получены в контролируемом исследовании с добавкой 400–1000 мг кофеина в сутки
28.11	Таблица хронометража даёт +22 минуты	Сумма строк — +24 минуты; оценка на три приёма требует замера
35	Эффект Хоторна длится «около двух недель»	Систематический обзор длительности не устанавливает; это рабочее допущение

Полные записи с цитатами — в реестрах [raw/sources/poisk-2026-10-*/](#) (раздел «Расхождения с корпусом» каждого реестра).

Новые источники главы

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-i/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
I-grade_guyatt	Guyatt G.H. et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations // BMJ. 2008;336:924–926
S120	Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 103н (зарег. Минюстом 08.05.2019 № 54588), приложение 2 к требованиям: шкалы УДД и УУР
M-dementia_edwina	Bunn D.K. et al. Effectiveness of interventions to indirectly support food and drink intake in people with dementia: EDWINA systematic review // BMC Geriatr. 2016;16:89
S003 (проверка)	Постановление ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18 (СанПиН 2.3/2.4.4282-26), пп. 2–3: срок действия и утрата силы СанПиН 3590-20

42

Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности

Когда у дома нет своей кухни, кажется, что и говорить о выборе не о чем: еду привозят, её раздают, остальное — дело поставщика. Эта глава показывает, что это не так. При аутсорсинге выбор не исчезает, а переезжает: из кухни — в техническое задание, спецификацию, порядок приёмки и отчётность подрядчика. Директор, который понимает это заранее, сохраняет контроль над тем, что едят жители; директор, который не понимает, обнаруживает, что меню определяет контракт, подписанный без него.

Справка. Формы аутсорсинга питания. Под аутсорсингом питания понимают передачу сторонней организации всей или части работы по обеспечению питанием. На практике встречаются три формы. Первая — **поставка готовых блюд** с фабрики-кухни или комбината питания: еда готовится вне учреждения и доставляется в термоконтейнерах или охлаждённой. Вторая — **кейтеринг на территории заказчика**: подрядчик работает на пищеблоке учреждения своими поварами и, как правило, по своему меню. Третья — **поставка продуктов**, при которой готовит собственный персонал дома, но ассортимент и качество сырья определяет контракт. Глава касается прежде всего первых двух форм, но строки о составе и заменах относятся и к третьей.

42.1. Почему это раздел доклада

Питание жителей всё чаще обеспечивает не свой пищеблок, а комбинат, фабрика-кухня, готовые блюда и чужие повара[248]. Для директора это смена модели управления: теперь не повар, а контракт решает, что едят жители. При этом санитарная рамка не зависит от того, кто стоит у плиты[248].

Кейсов вариативного меню на аутсорсинге в открытых источниках нет, и это пробел, который нужно назвать прямо: повторный поиск 10.10.2026 по сайтам учреждений, отраслевым и новостным публикациям российских примеров тоже не дал. Публично о стороннем исполнителе питания в доме-интернате обычно становится известно по другому поводу — когда при вспышке кишечной инфекции Роспотребнадзор проверяет «организацию, отвечающую за питание» (раздел 18.4)[142]. Раздел поэтому не пересказывает чужой опыт, а переносит в контракт инструменты глав 19–22 и 30. Задача — вписать выбор в документы закупки и научиться проверять подрядчика, не превращая дом в «приёмный пункт тарелок».

42.2. Правовая рамка: кто за что отвечает

Закупка услуг питания для казённых и бюджетных учреждений ведётся, как правило, по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ[249]. Для автономных учреждений режимом может быть 223-ФЗ при наличии положения о закупке. Это оговорка раздела 30.1, а не формула «всем

Я веду ДСО «Серафимовский» по 223-ФЗ. Тимур Нурбаев ведёт ДСО «Тесовый берег» по 44-ФЗ. Кухни и законы двух домов не следует путать. Свежий пример контура «Тесового берега» — извещение № 0372200070825000244: открытый конкурс «Поставка продуктов питания» СПб ГБУСОН «ДСО „Тесовый берег“» (ИНН 7827661874), обеспечение заявки по ст. 45 44-ФЗ, опубликовано 24.11.2025 на площадке АГЗ РТ[250].

Для вариативности ключевая норма 44-ФЗ — правила описания объекта закупки. Статья 33 требует указывать в описании функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки и не допускает требований, которые влекут ограничение количества участников; если заказчик не пользуется показателями и терминологией технических регламентов и документов национальной системы стандартизации, он обязан обосновать, почему применяет иные[251]. Отсюда практический вывод: строки о вариативности, текстурах и заменах нужно формулировать как измеримые характеристики услуги, а не как пожелания и не как требования, которые под силу только одному поставщику. Опорой для характеристик продукции может служить межгосударственный стандарт ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия» (действует с 01.01.2016): он устанавливает общие требования к продукции общественного питания, включая требования безопасности, правила приёма, методы контроля и требования к реализации[252].

Санитарная рамка не «уезжает» вместе с кухней. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 прямо регулирует привлечённые предприятия[9]:

- **п. 56 подп. 12:** если стационарная организация социального обслуживания получает готовые блюда от предприятия общественного питания, в ней выделяется помещение для приёма готовой продукции и отбора суточных проб. Суточные пробы отбирает «ответственный работник пищеблока» по правилам подп. 4 п. 56: каждое блюдо или кулинарное изделие отдельно, холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки — не менее 100 г, порционные изделия — целиком; хранение не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд при температуре от +2 до +6 °С;
- **п. 56 подп. 14:** требования пункта 56 распространяются и на предприятия общественного питания, привлекаемые для организации питания в стационаре;
- **раздел VI (кейтеринг):** исполнитель утверждает внутренний порядок, обеспечивающий прослеживаемость изготовления, перевозки, хранения и реализации и разграничение ответственности на каждом этапе; вскрытие упаковки и порционирование проводятся в отдельном помещении или выделенной зоне в месте оказания услуги.

Одна деталь требует точности. В подпункте 12 сказано «ответственным работником пищеблока», без уточнения, чьего — учреждения или подрядчика. В первой редакции доклада стояло «работник пищеблока учреждения»; это толкование, а не дословная норма. Для сравнения: в подпункте 4, адресованном медицинским организациям, прямо предусмотрено, что при питании по договору пробу отбирает и хранит ответственный работник сторонней организации под

руководством медицинского работника заказчика. Безопаснее для дома считать, что приёмку и пробы контролирует его собственный работник, и закрепить это в контракте и в приказе (раздел 42.3, строка 6), но ссылаться при этом на толкование, а не на прямой текст.

До 01.09.2026 действовала аналогичная рамка СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 7.1.11–7.1.14, раздел VI) [9].

Итоговый принцип: суточные пробы, бракераж и контроль температуры можно делегировать подрядчику в части исполнения, но не в части ответственности. Перед жителями и проверяющими отвечает учреждение. Тот же принцип закреплён и в зарубежных системах: английские национальные стандарты больничного питания 2022 года указывают, что организации здравоохранения сами отвечают за то, чтобы убедиться в безопасности своей цепочки поставок, а за положительный опыт пациента в конечном счёте отвечает руководитель организации[245].

42.3. Восемь строк контракта, которые делают вариативность реальной

Раздел развивает для аутсорсинга логику раздела 30. Восемь строк ниже — минимальный набор, без которого вариативность в контракте остаётся декларацией.

1. Перечень как группы взаимозаменяемых позиций. Например: «крупы гарнирные: гречка, рис, пшено», а не одна монопозиция. Так пары эквивалентов появляются уже на уровне контракта.

2. Пропорции по статистике выбора с правом корректировки раз в квартал без изменения существенных условий контракта.

3. Строка выбора. Там, где заявлена вариативность, подрядчик обеспечивает не менее двух вариантов основных позиций; срыв фиксируется в журнале замен и не считается надлежащим исполнением.

4. Строка замен. При недоставке допускается эквивалент из той же группы по согласованию с учреждением и с оформлением акта.

5. Строка качества. Характеристики продукции для текстур (степень измельчения, консистенция полуфабрикатов). Без них дисфагический контур становится заложником «самого дешёвого фарша» (раздел 10). По правилам статьи 33 44-ФЗ эти характеристики должны быть измеримыми[251].

6. Строка приёмки. Ответственный от учреждения, форма акта, место и процедура отбора суточных проб по п. 56 подп. 12 СанПиН 4282-26[9].

7. Строка состава. Цикличное меню с раскладкой и массой порций прилагается к контракту и сверяется с нормами приказа № 520н[38].

8. Строка отчётности. Подрядчик ежемесячно сообщает долю выбора и остатки по блюдам; эти данные поступают на панель показателей раздела 22.

Каждую строку нужно заранее обсудить с контрактной службой. Конфликт «меню против контракта» — симптом того, что меню меняли, а спецификацию нет.

Чего нельзя отдать строкой технического задания. Исполнение передаётся, ответственность — нет. Контроль отбора проб остаётся за учреждением (п. 56 подп. 12 и 4, с оговоркой о формулировке нормы в разделе 42.2)[9]; бракераж при приёмке оформляется актом учреждения; дисфагия и назначенные текстуры остаются в ведении врача и поста; эскалация отказа от еды (раздел 12) идёт по маршруту дома. Поставщик готовит и везёт. Учреждение решает, что безопасно для жителя сегодня.

42.4. Как проверять аутсорсера без «кухонной войны»

Контроль подрядчика не должен превращаться в ежедневное противостояние. Достаточно пяти регулярных инструментов.

Замер остатков по методике приложения 25. **Внезапный контроль линии:** температура блюд при раздаче по п. 50 СанПиН 4282-26, который отсылает к значениям, установленным технологическими документами[9]; соответствие выданного заказанному; наличие стандартного варианта (раздел 21). **Суточные пробы:** наличие, маркировка, объём, срок хранения. **Фотофиксация линии** без лиц жителей; сведения о здоровье защищены законом о персональных данных 152-ФЗ (раздел 17.6). **Ежеквартальная панель показателей,** которую учреждение разбирает вместе с поставщиком: отходы, жалобы, доля выбора.

Учебные кейсы 14 и 22 переносятся на аутсорсинг без изменений. Ответственность по ст. 6.6 КоАП[10] и практика антимонопольной службы по сговорам на торгах[135] никуда не исчезают оттого, что кухня чужая.

Учредитель уже сформулировал, как держать поставщика. Письмо Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (председатель Е. Н. Фидрикова) опирается на ст. 34, 94 и 95 44-ФЗ и требует ежедневного мониторинга, актов, претензий, а при необходимости — одностороннего расторжения контракта и включения поставщика в реестр недобросовестных поставщиков[253]. Это позиция учредителя в контуре 44-ФЗ, а не пожелание директора.

Справка. Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Реестр, предусмотренный 44-ФЗ[249] и ведущийся ФАС России. Сведения о поставщике вносятся в него, в частности, после одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта из-за существенного нарушения условий; заказчик вправе требовать от участников закупки отсутствия в реестре. Точные основания и сроки нужно сверять с действующей редакцией закона. Поэтому угроза включения в РНП — один из немногих рычагов, которые реально дисциплинируют подрядчика.

42.5. Экономика: почему «дешевле отдать на сторону» — не всегда правда

Полная стоимость приёма пищи в канадском аудите в 3–6 раз превышала сырьевую строку (раздел 29)[94]. Подрядчик, которому нужно уложиться в цену контракта, режет прежде всего сырьё — видимую и при этом малую часть затрат. Защитой служит фиксация состава в контракте: цикличное меню, масса порций, соответствие нормам приказа № 520н[38].

Зарубежный опыт показывает, что стандарты качества при аутсорсинге не ослабляются. Британские стандарты больничного питания обязательны и для контрактных поставщиков[254]; в действующей редакции 2022 года их соблюдение входит в стандартный контракт NHS (пункт

SC19), а организации ежегодно отчитываются о соответствии[245]. Нормы Онтарио применяются независимо от способа обеспечения питанием[27]. Это не значит, что российский дом получит те же механизмы, но показывает направление: экономию нужно считать по строкам, а не «общей цифрой» контракта.

42.6. Итог: аутсорсинг как новое место вариативности

Аутсорсинг не отменяет вариативность, а переносит её в новое место: в спецификацию, приёмку и отчётность. Пары, замер, журналы и пробы должны быть вписаны в контракт (раздел 42.3). Контроль качества передаётся подрядчику в части исполнения, но не ответственности. Если в контракте нет строк выбора и порядка проб, вариативность при аутсорсинге невозможна.

42.7. Календарь правки технического задания

Выбор, не попавший в ближайшую закупку, откладывается на весь срок контракта. Поэтому важен календарь. Даты у каждого дома свои, но логика одна. В первой редакции календарь был рассчитан на осень, начинавшуюся сразу после семинара; во второй редакции, подготовленной в октябре 2026 года, первые его шаги уже должны быть пройдены, и тем, кто их пропустил, полезно сверить своё положение с каждым пунктом.

Сентябрь. Новый СанПиН не останавливает выбор (раздел 18.10). Замер отходов и журнал отказов дают числа для будущей спецификации.

Октябрь. Восемь строк раздела 42.3 обсуждаются с контрактной службой. Пробы, бракераж, дисфагия и эскалация отказа остаются за учреждением.

Ноябрь–декабрь. Если контракт заканчивается в первом полугодии, строки нужно вносить в документацию сейчас. Если действует длинный контракт без этих строк, нужен путь дополнительного соглашения, а не «переторжка».

Январь. Пилот по таблице 35.9: своя линия раздачи или два варианта от поставщика. Без осеннего окна замер провести можно, а обещать выбор в договоре — нельзя.

Деньги разобраны в разделе 29, процедура закупки — в разделе 30, контракт — в этом разделе.

Новые источники главы

Полные записи и проверенные формулировки — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-i/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S123	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ст. 33 ч. 1 пп. 1–2 (правила описания объекта закупки)
S124	ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия» (введён 01.01.2016, действует)
I-nhs_standards2022	NHS England. National standards for healthcare food and drink. Version 1, 01.11.2022
S003 (проверка)	СанПиН 2.3/2.4.4282-26: п. 50, п. 56 подп. 4, 12, 14, п. 52–53 (раздел VI) — по тексту S003
S154	«Вспышка кишечной инфекции произошла в доме-интернате для ветеранов» // Петрозаводск говорит. 09.10.2024 (реестр poisk-2026-10-dozakrytie)

Заключение: что остаётся после последней страницы

Заключение не добавляет к докладу новых аргументов. Его задача — собрать сказанное в несколько мыслей, которые читатель унесёт с собой, и назвать первый шаг, который можно сделать без чьего-либо разрешения.

43.1. Суть доклада в пяти положениях

Первое. Питание в стационаре — не услуга, стоящая рядом с заботой, а ежедневный тест на уважение: система сдаёт его или проваливает три-четыре раза в день.

Второе. Правовое поле позволяет организовать выбор уже сегодня: нормы есть, серые зоны можно обозначить, процедуры описаны.

Третье. Практика работает. О ней публично сообщили Успенский ПНИ, Усть-Илимский дом социального обслуживания и ДСО «Серафимовский»[3, 4, 5], а также четыре учреждения Иркутской области, каждое со своей моделью[6] (раздел 25.6). Если кухня не своя, то же самое начинается со спецификации контракта (раздел 42).

Четвёртое. Доказательная база неоднородна. По клиническим вопросам и международным нормам она сильна, по эффекту вариативности в психиатрии почти пуста (разделы 27 и 41).

Пятое. Поэтому последнее слово доклада — не «внедряйте», а «измеряйте». Семь дней замера отделяют убеждение от знания.

43.2. Пять конфликтов и одна сцена, с которых начинался разговор

В разделе 5 один обед собрал за столом пять конфликтов. Очередь против помощи: четыре сиделки на двенадцать кормимых, и последних кормят холодным. Житель, который третий день отодвигает тарелку, и никто не связывает его покашливание с возможной дисфагией[1]. Житель на клозапине, выпивший с утра две кружки крепкого кофе, о взаимодействии которого с лекарством никто не предупредил[17]. Житель на оланзапине, которому сиделка отказывает в добавке по собственному представлению о пользе. И комиссия учредителя, к приходу которой журналы приводят «в порядок» задним числом. За всеми пятью стоит смена, которая делает «как всегда», потому что это единственный доступный ей сценарий.

Теперь у каждого из этих конфликтов есть процедура: устройство раздачи и тихая зона за столом (раздел 20), журнал отказов и правило трёх отказов (раздел 12), список риска и назначенные текстуры (раздел 10), лекарственно-пищевая таблица врача (раздел 11), работа с весом без самовольных запретов (раздел 13), комплект документов и роли персонала (разделы 28 и 31). Сцена «спустя год» из того же раздела показала, как это выглядит в столовой: женщина, которой

нужна тишина, ест за тихим столом у окна; мужчина на клозапине пьёт кофе, согласованный с врачом; житель с дисфагией ест свою текстуру, и тарелка не выглядит «детской»; человек без слов показал на карточку и получил то, на что показал (раздел 15); смена работает по журналам. Конфликты не исчезли. Они перестали быть безымянными.

43.3. Что изменится для четырёх участников

Для жителя еда перестаёт быть тем, что с ним происходит, и становится тем, в чём он участвует: он называет, показывает, выбирает, отказывается. Отказ при этом не превращается в голод, потому что есть задокументированная альтернатива.

Для сиделки задача «покормить» сменяется работой с опорами: картой жителя, таблицей текстур, правилом трёх отказов.

Для директора питание выходит из тумана ожидания («придут — спросят») и становится управляемой системой: приказ, журналы, панель показателей, дата заслушивания у учредителя.

Для учредителя появляется работа, которую может сделать только он: определить статус норм, построить «мост» к лечебному питанию, ввести отраслевые показатели (разделы 38 и 39).

43.4. Первый шаг

Доклад можно закрыть и начать. Первый шаг — неделя, для которой не нужны разрешения: замер отходов, отказов и времени раздачи (приложение 25).

Справка. Как измеряют отходы с тарелки. В исследованиях больничного питания отходы с тарелки определяют двумя способами: взвешиванием оставшейся пищи или визуальной оценкой доли несъеденного; результат выражают в процентах от массы поданного, в граммах белка, в килокалориях или в деньгах. В обзоре 32 больничных исследований медиана отходов составила 30 % по массе при разбросе от 6 до 65 %; среди причин названы состояние пациента, качество блюд, неподходящие порции, ограниченный выбор, сложность заказа и обстановка приёма пищи, а среди мер — уменьшенные обогащённые порции, раздача из общей ёмкости, помощь при еде, столовые и защищённое время приёма пищи^[241]. Это данные больниц, а не домов социального обслуживания; российских сопоставимых чисел нет. Тем ценнее замер, проведённый по одной методике до изменений и после них.

Для тех, кто уезжал с семинара 27 августа 2026 года, первым практическим рубежом было 1 сентября: журналы не переписывались, новые формы бракеража вводились с утра (приложение 39). Этот рубеж пройден. Дальше — знание о собственном доме, а не мнение о нём. Из этого знания растут пилот, совет жителей, разговор с учредителем, а через год — рассказ, которому коллеги поверят, потому что за ним стоят ваши числа.

Человек за столом ждёт обеда, в котором есть его выбор. Теперь вы знаете, как такой обед организовать.

43.5. Письмо директору через год

Прошёл год. Возможны два сценария.

Сценарий А. Доклад стоит на полке. Изменилось одно: вы знаете, что у коллег работает, и жалобу на еду читаете иначе.

Сценарий Б. Была неделя замера, затем совет жителей, пилот в одном отделении; панель показателей лежит у учредителя; два варианта второго блюда стали так же привычны, как водопровод.

Разница между сценариями — не в деньгах (пилот модели М1 обходится дешевле дня ремонта), не в разрешениях и не в людях. Разница — в первой неделе. Она дешевле года сомнений. Дальше будут ваши числа и жители, которые скажут, какая каша — их. Разговор начался в зале. Продолжается он за линией раздачи, в понедельник, в 8:30.

Новые источники главы

Полные записи и проверенные формулировки — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-blok-i-istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/SPEN/2026-10-blok-i-istochniki/main).
Маркеры прежней редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-platewaste_williams	Williams P., Walton K. Plate waste in hospitals and strategies for change // e-SPEN. 2011;6(6):e235–e241

ЧАСТЬ 9

Учебные кейсы

двадцать два кейса для разбора

Учебные кейсы 1–4

Все кейсы этого блока — учебные ситуации, составленные для разбора на семинаре и в доме. Они не описывают конкретные организации и конкретных людей: имена, отделения и даты условны. Правовые и медицинские основания здесь — ориентиры для обсуждения, а не заключение по реальному делу. Классы утверждений (норма, толкование, рекомендация, проект локальной формы) соблюдаются так же, как в основном тексте (раздел 41); клинику кухня не назначает.

Первые четыре кейса посвящены самой процедуре выбора: тому, как он срывается на линии, сталкивается с назначением врача, выражается без слов и подменяется бумагой. В конце каждого — вопросы для обсуждения.

Кейс 1. Один вариант закончился до подхода последнего отделения

Ситуация. В четверг на обед два вторых блюда: гречка с котлетой и рис с запечённой рыбой. Утром жители выбирали по визуальному меню, и рыбу отметили почти поровну с котлетой — в пятом отделении даже чаще. Тележка идёт по отделениям в привычном порядке, и на третьем гастрорёмкость с рыбой пустеет. Четвёртое и пятое получают только гречку с котлетой; раздающая говорит «рыбы нет» и ставит тарелку. Несколько человек, которые утром показали на рыбу, молча едят котлету, один отодвигает тарелку.

Проблема. Для первых трёх отделений выбор оказался настоящим, для последних двух — фиктивным. Если срыв не записан, он повторится, и через месяц жители последних отделений перестанут выбирать: «всё равно не достанется». Срыв — событие с причиной, а не «неудачный день». В логике раздела 21.4 это первый признак фиктивной вариативности: вариант Б заканчивается раньше, чем его получают все, кто его выбрал.

Что нельзя делать. Выдавать котлету молча, не объяснив, что случилось, и не предложив ничего взамен. Переписывать лист заказа задним числом, чтобы он «сошёлся» с выданным. Делать по одному эпизоду вывод, что «вариативность у нас не работает», — и столь же поспешно перекраивать пропорции на завтра.

Немедленно. Старшая смены раздачи предлагает тем, кто остался без рыбы, замену из того, что есть на линии: другой гарнир, дополнительный салат, рыбное блюдо из резерва, если он предусмотрен. Человеку говорят прямо: «Рыба закончилась, это наша ошибка. Могу предложить вот это». В тот же день в журнал срывов выбора вносится дата, позиция, отделение, число порций, которых не хватило, и что было предложено взамен.

Справка. Срыв выбора и замена — два разных журнала. Срыв — это случай, когда житель выбрал вариант, а система его не дала: подвела кухня, объём, логистика. **Замена** — случай, когда житель сам отказался от поданного и получил альтернативу. Срывы показывают, где система подводит жителя; замены — где житель отвергает то, что ему предлагают. Раз в месяц журналы читают вместе, но не смешивают: это два разных ремонта (раздел 19.8).

Кто принимает решение. Старшая смены раздачи — о замене на месте и о записи. Заведующий производством — о причине: неверный расчёт объёма, отсутствие резерва, неудачный порядок развоза или статистика выбора, которая устарела.

Документы. Журнал срывов выбора (приложение 8), журнал заказа (приложение 7), при замене — журнал замен (раздел 19.8).

Долгосрочное решение. Объёмы пересчитывают по статистике выбора за две–четыре недели, а не по одному обеду (разделы 19.4, 21.3, 21.9). Живое распределение редко бывает «пятьдесят на пятьдесят», и оно различается по отделениям. Рабочее правило таково: стандартный вариант готовят с запасом, вариативный — по фактическим долям с резервом около 10 % (раздел 21.9). Порядок развоза меняют по кругу, чтобы последним не всегда оставалось одно и то же отделение. Заказ накануне или утром — прогноз, а не распределение пайков: резерв нужен и для того, кто передумал у линии (раздел 19.4).

Основания. Американская федеральная норма для домов престарелых обязывает предоставлять жителю, который не получил или не хочет поданное, «привлекательные варианты сходной пищевой ценности» — это международный ориентир, не российская норма[46]. Австралийская комиссия по качеству ухода рекомендует давать жителям выбирать блюдо «в момент подачи или как можно ближе к нему»[146]. В российской рамке опорой служат обязанность организовать питание проживающих не менее трёх раз в день (до 31.08.2026 — п. 7.1.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 СанПиН 2.3/2.4.4282-26, переходного периода нет)[9, 128], право получателя социальных услуг на уважительное и гуманное отношение (ст. 9 442-ФЗ)[118], а для домов, предназначенных для лиц с психическими расстройствами, — то же право по ч. 2 ст. 5 Закона РФ № 3185-1[8]. Прямой российской нормы «выбранное должно быть выдано» нет; вывод о том, что срыв требует замены и записи, — толкование (раздел 17.2).

Ограничение вывода. Один эпизод — не статистика. Объёмы меняют по серии записей журнала, а не по впечатлению смены. Пустой журнал срывов при «всегда заканчивающейся» рыбе — признак того, что срывы не записывают (раздел 21.8).

Вопросы для обсуждения.

1. Что в вашем доме происходит сегодня, когда вариант Б заканчивается: кто узнаёт об этом и где это записано?
2. Как изменить порядок развоза, чтобы риск срыва распределялся между отделениями справедливо?
3. Какой резерв варианта Б вы готовы держать и чем будете его обосновывать перед бухгалтерией?

Кейс 2. Человек выбирает блюдо, противопоказанное по назначению врача

Ситуация. Дееспособному мужчине шестидесяти восьми лет врач ограничил поваренную соль; в пищевой карте отметка «без солёной рыбы». Соседу на ужин подают сельдь с картофелем, и житель громко требует такую же: «Я сорок лет на флоте ел селёдку. Мне что, и это нельзя?»

Проблема. Столкнулись две законные вещи — право человека выбирать еду и врачебное назначение. Обе имеют основания, и ни одна не отменяет другую автоматически. В этой серой зоне персонал обычно либо запрещает «вообще всё», либо пускает на самотёк. Первое превращает назначение в произвол, второе обесценивает его.

Что нельзя делать. Решать спор силой на линии раздачи — выхватывать тарелку, повышать голос. Давать запрещённое, «чтобы успокоился». Обсуждать диагноз и назначения при соседях по столу: сведения о здоровье — специальная категория персональных данных, и кухня не должна их озвучивать (раздел 17.6)^[132].

Немедленно. Старшая смены спокойно предлагает разрешённый эквивалент из меню, например отварную рыбу, и говорит без нотаций: «Я вас поняла. Сегодня могу дать вот это. Про селёдку спросим врача — завтра утром он к вам подойдёт». Запрос жителя записывается — дословно, с датой.

Кто принимает решение. Врач — единолично. У него три пути: скорректировать назначение (например, допустить солёную рыбу малой порцией раз в неделю); подтвердить ограничение и разъяснить жителю причину и цель; либо, если житель после разъяснения настаивает, оформить информированный выбор с фиксацией риска. Персонал и директор назначения не меняют и не толкуют.

Справка. Информированный выбор. Так называют решение человека, принятое после того, как ему понятным языком объяснили, чем полезно назначение, чем рискован отказ от него и какие есть альтернативы. Информированный выбор не равен капризу: он фиксируется письменно, с подписью врача и, по возможности, самого человека, и пересматривается. В российском праве эта конструкция прямо закреплена для медицинского вмешательства (ст. 20 323-ФЗ)^[95]; распространяется ли она на бытовой выбор блюда при диетическом назначении — вопрос толкования, а не нормы.

Документы. Пищевая карта с назначением и его сроком; запись врача о беседе и принятом решении; при изменении — обновлённая карта и отметка для кухни (без диагноза — только функциональное ограничение).

Долгосрочное решение. Правило положения о питании: конфликт «выбор против назначения» в тот же или на следующий день уходит врачу, а не решается на линии. Каждое ограничение рациона назначается поимённо, с целью и сроком пересмотра (раздел 17.3). У диетических назначений тоже есть пары эквивалентов: если человеку нельзя солёное, ему должно быть из чего выбрать внутри разрешённого (раздел 19).

Основания. Ограничение рациона — действие «жёлтой зоны»: законно только при назначении врача, поимённо, с целью и сроком (раздел 17.3). Приказы Минздрава о лечебном питании адресованы медицинским организациям и на дома социального обслуживания автоматически не распространяются^[137]; стык обеспечивается региональным «мостом» — пример такого акта распоряжение 19РВ-32 Министерства социального развития Московской области^[24] — или, при его отсутствии, рабочей конструкцией раздела 17.10. Санитарные правила требуют организовать диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям (п. 7.1.11 СанПиН 3590-20; с

01.09.2026 — п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26)[9, 128]. Выбор человека осуществляется внутри назначенных рамок; уважение к нему опирается на ст. 9 442-ФЗ[118] и, для ПНИ, на ч. 2 ст. 5 Закона № 3185-1[8].

Международный ориентир сдвигает акцент в пользу жителя. Академия питания и диетологии США в позиционном документе 2018 года пишет: «Рацион человека должен определяться вместе с ним и в соответствии с его информированным выбором, целями и предпочтениями, а не исключительно по диагнозу»; «обычная или либерализованная диета, допускающая выбор жителя, чаще всего предпочтительна как исходная»; «предоставление лечебной или текстурно модифицированной диеты вопреки желанию жителя есть нарушение его права на выбор»[255]. Американский регулятор CMS в 2013 году рекомендовал считать обычный рацион вариантом по умолчанию[256]. Это американская рамка, не российская норма; переносить её можно как аргумент в разговоре с врачом, а не как основание для смены назначения персоналом.

Ограничение вывода. Кейс задаёт маршрут, а не судит, «кто прав». Ответ даёт врач; кухня отвечает за разрешённый выбор сегодня и за вопрос врачу завтра.

Вопросы для обсуждения.

1. Сколько ограничений в пищевых картах вашего дома имеют дату пересмотра? Кто последний раз их пересматривал?
2. Какие слова старшая смены может сказать жителю на линии, чтобы не раскрыть диагноз при соседях?
3. Где проходит граница между информированным выбором и «давайте, чтобы не скандалил»?

Кейс 3. Недееспособный житель показывает на фотографию блюда

Ситуация. Недееспособная женщина пятидесяти лет с глубокой умственной отсталостью почти не пользуется речью. Сиделка раскладывает перед ней четыре карточки супов. Женщина уверенно касается борща. Сиделка машет рукой: «Она всегда на первую картинку показывает, это не выбор» — и записывает ей суп «как всем».

Проблема. Как отличить выбор от рефлекса — и кто вправе объявить жест «не выбором»? Сиделка может быть права — позиционный эффект хорошо известен (раздел 15.7), — но может и ошибаться, и тогда лишает человека единственного способа сказать, чего он хочет. Нужна проверка, а не привычка.

Что нельзя делать. Игнорировать жест: «всё равно не выбор». Исполнять жест без проверки, если человек раз за разом показывает на любую первую картинку. Исключать жителя из процедуры выбора навсегда по одному наблюдению одной сиделки.

Немедленно. Поменять порядок карточек и повторить показ. Сократить их число: четыре супа — слишком много; две карточки, а лучше две реальные тарелки, понятнее (раздел 15.3, канал 1). Если женщина снова выбирает борщ, где бы он ни лежал, — это выбор, и его исполняют. Если она снова касается того, что лежит первым, — это позиция, а не содержание, и сегодня ей дают суп по пищевой карте (зафиксированное предпочтение), а не «как всем». Результат вносится в форму наблюдения: что показали, в каком порядке, какая реакция.

Кто принимает решение. Смена — фиксирует наблюдение, но не делает выводов о способности к выбору. Вывод о предпочтениях вносится в пищевую карту по серии наблюдений — несколько дней, разные сотрудники, перестановка порядка; в этом участвуют персонал, знающий жительницу, и, если возможно, близкие (разделы 15.3–15.4). Опекун — а им нередко является сам дом (раздел 16.4) — обязан учитывать мнение подопечной, а при невозможности его установить — сведения о её предпочтениях (п. 2 ст. 29, п. 3 ст. 36 ГК)[116].

Документы. Форма наблюдения за невербальным выбором (приложение 6), пищевая карта (приложение 2), визуальное меню (приложение 5).

Долгосрочное решение. Индивидуальный протокол показа: две карточки или две тарелки, а не пять; удобное для человека время; одинаковое расстояние до обоих вариантов; проверка позиционного эффекта не реже раза в месяц. Предпочтения и способности меняются, поэтому протокол пересматривается, а не пишется один раз. Смена проходит упражнения раздела 15.7.

Основания. Международный ориентир — Замечание общего порядка № 1 Комитета ООН по правам инвалидов: к формам поддержки в принятии решений отнесено признание «разнообразных, нетрадиционных способов коммуникации», а там, где волю установить невозможно, «наилучшее толкование воли и предпочтений» заменяет определение «наилучших интересов» (пп. 17, 21)[31]. Австралийский Стандарт 6 требует давать выбор того, «что, когда, где и как» человек ест, и оценивать предпочтения каждого жителя[45]; формулы «независимо от когнитивного статуса», которую приписывала стандарту первая редакция, в нём нет. Онтарийский регламент требует учитывать предпочтения в плане питания жителя[27]. В российской рамке выбор блюда — бытовое решение, а не сделка, и недееспособность не снимает обязанности выяснять мнение человека доступным способом (раздел 15.2, толкование)[8, 116].

Исследования поддерживают и процедуру, и осторожность. У людей с глубокими множественными нарушениями адаптированные процедуры позволяли выявить больше предпочтений, чем стандартные, но данные были «вариабельными внутри участников и между ними» — значит, вывод делается по серии[121]. Визуальная опора повышает вовлечённость людей с деменцией в решения[122]. А когда предпочтения оценивает персонал вместо самого человека, он склонен считать их менее важными[124].

Ограничение вывода. Перестановка карточек — скрининг позиционного эффекта, а не психологическая диагностика. Она не подменяет знание человека и не устанавливает его «способность к выбору» в правовом смысле.

Вопросы для обсуждения.

1. Сколько жителей вашего отделения никогда не выбирают сами, и по какой причине так решено?
2. Как устроить перестановку, чтобы она не удлиняла раздачу?
3. Кто в доме вправе записать в карту «выбор недоступен» и на какой срок?

Кейс 4. Персонал заполняет лист выбора заранее

Ситуация. Днём в среду заведующая отделением видит на посту заполненный лист заказа на четверг: тридцать фамилий, одна ручка, один почерк. Меню на четверг жителям ещё не показывали. Сиделка не скрывает: «Так быстрее. Я и так знаю, кто что ест».

Проблема. Процедура есть, выбора нет. Хуже того: документ свидетельствует о том, чего не было. При проверке такой журнал «докажет» выбор, который никто не совершал, и эта бумага окажется против дома, а не за него (раздел 32.4). Это четвёртый признак фиктивной вариативности — «за жителя выбирает персонал» (раздел 21.4), и одна из его полевых примет: журнал за неделю заполнен одним почерком и одной ручкой (раздел 21.8).

Что нельзя делать. Устраивать показательный разбор при всей смене. Списывать произошедшее на лень: почти всегда за этим стоит нехватка времени на процедуру. Отменять журнал как «бесполезный» — проблема в способе его заполнения, а не в нём самом.

Немедленно. Предзаполненный лист аннулировать (не уничтожать — пометить «аннулирован, заполнен до показа меню» с датой и подписью). Провести выбор с жителями заново в тот же вечер, когда меню будет вывешено. Спокойно спросить сиделку, сколько времени у неё реально уходит на показ меню и на что ещё она в это время должна успеть.

Кто принимает решение. Заведующая отделением — о порядке процедуры в отделении. Директор — если причина в дефиците времени смены: рекомендуемые нормативы штатной численности (приказ Минтруда России от 14.05.2025 № 305н) не выделяют час еды отдельно, и этот час дом организует сам (раздел 28.3)[205].

Документы. Журнал заказа (приложение 7) с пометкой об аннулировании, служебная записка о нарушении процедуры; при повторении — материалы внутренней проверки.

Долгосрочное решение. Меню вывешивают заранее; показ занимает минуты на человека, и выбор фиксируется при жителе, а не после. По иллюстративной раскладке раздела 28.11 показ меню на отделение из тридцати человек добавляет около трёх человеко-минут, сбор заказа — около пяти, а вся процедура выбора в модели М1 — около 24 минут на обед; эти цифры экспертные, и дом проверяет их собственным замером (приложение 26). Знание сиделки «кто что ест» не выбрасывают, а переводят в пищевые карты: оно становится резервным источником, когда житель не выразил выбора (раздел 15.5, шаг 4), но не заменяет вопроса. Проверка реальности (приложение 24): раз в неделю случайный опрос пяти жителей — «что вы вчера заказывали?».

Основания. Документ, не соответствующий фактам, — худшая позиция перед проверкой (раздел 32). Американская и онтарийская нормы о выборе требуют реальной, а не бумажной альтернативы[27, 46]; австралийский регулятор рекомендует выбор в момент подачи или как можно ближе к нему[146]. Исследование, сравнившее ответы жителей домов сестринского ухода, их представителей и сотрудников, показало: сотрудники «последовательно реже указывали все предпочтения как важные», чем сами жители[124]. Иначе говоря, «я знаю, кто что ест» систематически смещает картину в сторону привычного. Выборка американская, но направление ошибки переносится.

Ограничение вывода. Злого умысла эпизод не доказывает. Фраза «я знаю, кто что ест» часто верна по содержанию — беда в том, что знание подменяет процедуру и не позволяет заметить, когда человек передумал.

Вопросы для обсуждения.

- 1. Когда в вашем отделении вывешивается меню и когда заполняется лист заказа? Есть ли между ними зазор?
- 2. Как отличить предзаполненный лист от добросовестного по самому документу?
- 3. Как превратить знание опытной сиделки в пищевую карту, не обидев её?

Новые источники

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-kejsy-a/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции и второй редакции раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-and_dorner	Dorner B., Friedrich E.K. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Individualized Nutrition Approaches for Older Adults: Long-Term Care, Post-Acute Care, and Other Settings // J Acad Nutr Diet. 2018;118(4):724–735. DOI: 10.1016/j.jand.2018.01.022
I-cms_dining2013	CMS (США), Survey & Certification Group. S&C: 13-13-NH «Information Only: New Dining Standards of Practice Resources are Available Now», 01.03.2013

Исправления по сравнению с первой редакцией. Право на уважительное и гуманное отношение отнесено к ч. 2 ст. 5 Закона № 3185-1 (и к ст. 9 442-ФЗ), а не к ст. 37 и 43 (раздел 41.6). Из кейса 3 убрана приписанная австралийскому Стандарту 6 формула «независимо от когнитивного статуса» (раздел 44, исправления к I-aus6). Обязанность опекуна учитывать мнение подопечного отнесена к п. 2 ст. 29 и п. 3 ст. 36 ГК. Ссылка кейса 2 на «раздел 24» как место «моста» уточнена: конструкция описана в разделах 17.5 и 17.10. Нормы СанПиН даны в двух редакциях с датой смены 01.09.2026 без переходного периода.

Учебные кейсы 5–8

Все кейсы этого блока — учебные ситуации, составленные для разбора. Они не описывают конкретные организации и конкретных людей. Клинические детали даны ровно настолько, насколько они нужны для организационного решения: диагноз, лечение и назначения остаются за врачом. Основания — ориентиры для обсуждения, не заключение по реальному делу.

Кейсы 5–8 посвящены точкам, где организация питания встречается с клиникой: бредовому отказу, седации, пищевой агрессии и опасной манере есть. Роль смены везде одна — увидеть, записать, обезопасить и вовремя передать врачу; соблазн тоже один — решить клиническую задачу дисциплиной.

Кейс 5. Житель отказывается от еды из-за подозрения в отравлении

Ситуация. Мужчина сорока шести лет с параноидной шизофренией второй день почти ничего не ест. За завтраком он отодвигает тарелку: «Здесь отравлено. Я видел, как повар что-то сыпал». Сиделка пытается урезонить: «Да все же едят», — он встаёт и уходит. Вес пока стабилен, но в журнале отказов уже четыре записи подряд.

Проблема. Отказ встроен в клиническую картину: обычные приёмы смены здесь не работают, а бездействие опасно. Убеждение в отравлении — не каприз и не «характер», а симптом, и чем дольше он не попадает к врачу, тем дольше человек недоедает.

Справка. Бред отравления. Бредом в психиатрии называют стойкое ложное убеждение, которое не поддаётся разубеждению доводами и не объясняется культурной средой человека. **Бред отравления** — разновидность бреда преследования: человек уверен, что ему подмешивают яд в еду, питье или лекарства. Спорить с содержанием бреда бесполезно и вредно: логика воспринимается как подтверждение заговора. Работают другие вещи — доверие, прозрачность приготовления и лечение, которое назначает врач.

Что нельзя делать. Доказывать, что еда не отравлена: логика против бреда усиливает недоверие. Кормить принудительно, уговаривать «ещё ложечку», ставить условия «не поешь — не пойдёшь гулять» — насилие недопустимо ни в какой форме (раздел 12.4). Ждать, «пока проголодается», без наблюдения и без врача.

Немедленно. Врач — в тот же день. Правило «три отказа подряд — врач сегодня» здесь срабатывает раньше: отказ с мотивом отравления передаётся врачу уже при первом эпизоде, потому что сама бредовая мотивировка — клинический сигнал (разделы 12.3, 12.8). До прихода врача смена использует приёмы, которые не нарушают доверия (раздел 9.2): продукты в заводской запечатанной упаковке — йогурт, сок, печенье; порция, положенная из общего котла на глазах у человека; выбор тарелки самим жителем из нескольких одинаковых; участие сотрудника, которому он доверяет. Говорят коротко и без спора: «Я вас услышала. Скажу врачу, он придёт сегодня. Хотите, принесу в заводской упаковке?» Отказ от воды или одновременно от еды и воды — повод звать врача немедленно (раздел 12.3, п. 5).

Кто принимает решение. Врач — о клинической тактике, включая коррекцию терапии и, при необходимости, госпитализацию. Смена — о формате подачи в рамках того, что согласовано с врачом. Директор — об условиях: чтобы на посту были упакованные продукты, а кухня могла выдать порцию «из общего котла при жителе».

Документы. Журнал отказов (приложение 9) с дословной записью мотива; алгоритм при отказе от еды (приложение 11); запись врача; динамика массы тела.

Долгосрочное решение. Заготовленный план питания на обострение — три строки в пищевой карте: что происходит с едой у этого жителя при ухудшении, что помогало раньше, кто переводит на этот режим и обратно (раздел 9.6). Для этого жителя это упаковка, «магазинные» продукты, приготовление на глазах там, где возможно, и доверенный сотрудник. При затяжном отказе массу тела контролируют по графику (разделы 12.1, 13.8).

Основания. Принудительное бытовое кормление недопустимо: оно противоречит праву лиц с психическими расстройствами на «уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства» (ч. 2 ст. 5 Закона РФ № 3185-1)[8]. Медицинское искусственное питание — медицинское вмешательство, требующее информированного добровольного согласия, кроме прямо перечисленных законом случаев (ст. 20 323-ФЗ)[95]; это плоскость врача и юриста, не смены. Смертность людей с шизофренией существенно превышает популяционную, и пневмония занимает первое место среди естественных причин избыточной смертности[15]; длительное недоедание повышает этот риск. Непреднамеренная потеря 5 % массы и более за 6–12 месяцев клинически значима; среди её причин у пожилых — психосоциальные расстройства и побочные эффекты лекарств[93]. Эти данные получены в других популяциях и на российский дом переносятся как ориентир.

Ограничение вывода. Приёмы «обхода» бреда — тактика на время обострения, а не постоянная модель. Когда состояние улучшится, формат подачи пересматривает врач.

Вопросы для обсуждения.

1. Есть ли на посту продукты в заводской упаковке, которые можно выдать в любой час?
2. Как смене отличить бредовый отказ от отказа из-за невкусного блюда, не ставя диагноз?
3. Кто в вашем доме пишет три строки плана на обострение и когда их последний раз пересматривали?

Кейс 6. Житель спит во время завтрака из-за седативного эффекта

Ситуация. После смены схемы лечения вечерний приём препаратов в одном из отделений перенесли на 22:00. Через неделю картина утра изменилась: пятеро жителей спят в часы завтрака, их не удаётся разбудить без настойчивости. К одиннадцати они просыпаются голодными и раздражительными, но кухня завтрак уже убрала, а до обеда два часа. Одна жительница, разбуженная «через силу», ест полусонной и поперхивается кашей.

Проблема. Фармакология столкнулась с расписанием. Режим питания не подстроен под ритм людей, и в итоге одни остаются без завтрака, а других кормят в состоянии, когда кормить опасно.

Справка. Остаточная седация. Многие антипсихотики и снотворные вызывают **седацию** — сонливость и замедление реакций. Если препарат принят поздно вечером, его действие может сохраняться утром: человек просыпается не до конца, медленнее глотает, хуже кашляет. Для стола это означает риск: глотательные и защитные рефлексy в таком состоянии ослаблены (разделы 9.2, 10.3).

Что нельзя делать. Будить насильно «потому что завтрак» и кормить полусонного. Оставлять без завтрака по принципу «виноваты сами». Менять время приёма препаратов самостоятельно: это компетенция врача.

Немедленно. Сохранить завтрак для спящих: отложенные порции с соблюдением температурного режима и сроков, установленных технологическими документами, и с учётом запретов СанПиН — блюда, требующие разогревания, не держат на раздаче более трёх часов с момента изготовления, нереализованное не переносят на следующий день (п. 32 СанПиН 2.3/2.4.4282-26)[9]. Проснувшемуся человеку дают порцию, когда он бодрствует и сидит вертикально. В тот же день сообщить врачу картину утра: кто спит, во сколько просыпается, был ли эпизод поперхивания.

Кто принимает решение. Врач — о времени приёма препаратов: перенос на более ранний вечер или иная схема часто снимают проблему, но это клиническое решение. Заведующий производством — о формате отложенного завтрака (что сохраняется, где, сколько). Директор — о распорядке и о записи гибкого окна в положении о питании.

Документы. Распорядок дня отделения; запись врача о времени приёма; журнал выдачи отложенных порций; при поперхивании — запись в форме наблюдения и сообщение врачу (раздел 10.4).

Долгосрочное решение. Гибкое окно завтрака — например, с 8:00 до 9:30 — вместо точки «8:30». Согласование распорядка питания с назначениями становится постоянной процедурой: при каждой смене схемы терапии врач и старшая смены сверяют, не изменится ли время, когда человек способен есть. Правило «кто ещё не проснулся, того не кормят по расписанию» записывается в инструкцию смены (раздел 9.2).

Основания. Санитарные правила требуют питания проживающих не реже трёх раз в день, в том числе диетического по медицинским показаниям (п. 7.1.11 СанПиН 3590-20 — до 31.08.2026; п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26 — с 01.09.2026, без переходного периода)[9, 128]. Отложенные приёмы пищи — действие «жёлтой зоны», законное через положение о питании и санитарный контур хранения (раздел 17.3). Седация замедляет глотательный рефлекс[29]. В тайваньском ретроспективном исследовании трёх психиатрических отделений 10 из 16 эпизодов удушья (62,5 %) пришлось на завтрак; авторы предполагают роль остаточного действия вечерних снотворных, но это гипотеза на очень малой выборке[54]. Ведомство здравоохранения Нового Южного Уэльса требует, чтобы перед едой и приёмом лекарств психиатрический пациент бодрствовал и сидел вертикально[55]. Отложенную порцию и гибкое окно рекомендует Британская диетологическая ассоциация[47]; австралийский Стандарт 6 говорит о выборе того, «что, когда, где и как» человек ест[45]. Это ориентиры, не российские нормы.

Ограничение вывода. Гибкое окно — диапазон режима, а не его отмена. Температура, сроки и правила хранения сохраняются полностью; «отложенный завтрак» не означает «каша, простоявшая до обеда».

Вопросы для обсуждения.

1. Кто в вашем доме узнаёт о смене времени приёма препаратов и успевает ли эта информация дойти до кухни?
2. Где и как хранится отложенная порция, чтобы не нарушить п. 32 СанПиН?
3. Как смене оценить, что человек «проснулся достаточно», чтобы есть безопасно?

Кейс 7. Два жителя отбирают еду друг у друга

Ситуация. За столом на шестерых крупный мужчина тридцати восьми лет, давно получающий оланзапин, систематически забирает котлету у соседа — пожилого худощавого жителя с выраженным когнитивным снижением. Тот не сопротивляется, потом доедает хлеб с чаем. Смена «не замечает»: однажды вмешательство закончилось криком и опрокинутым стулом.

Проблема. За одним столом сошлись две беды: скрытое недоедание одного и пищевая агрессия другого. Молчание смены не нейтрально — оно оставляет в риске обоих. Один теряет массу, другой не получает ни помощи врача, ни предсказуемого режима, который снизил бы его «охоту» за чужими порциями.

Справка. Насилие между проживающими. В зарубежной литературе о домах ухода используется понятие **насилия жителя в отношении жителя** (англ. *resident-to-resident elder mistreatment*): негативные, агрессивные и навязчивые действия одного проживающего в отношении другого — словесные, физические, сексуальные и иные (вторжение в личное пространство, угрожающие жесты). Отбирание еды у беззащитного соседа относится к этому кругу, даже если выглядит бытовой мелочью.

Что нельзя делать. Наказывать отбирающего лишением еды или «штрафной» порцией: еда не инструмент награды и наказания, и использовать её так — значит нарушать закон (разделы 14.3, 17.4). Сажать «обидчика» в одиночку навсегда без наблюдения и пересмотра. Считать, что «они сами разберутся».

Немедленно. Развести жителей по разным столам сегодня же. Пожилому жителю — полная порция под наблюдением, при необходимости с помощью сотрудника; съеденное он не «восполняет хлебом». Эпизод фиксируется письменно: кто, у кого, что забрал, как отреагировала смена. Мужчине при этом объясняют спокойно и без стыда, что у него будет своя полная порция и добавка по правилам (раздел 13.3).

Кто принимает решение. Старшая смены — о рассадке сегодня. Врач — об оценке пищевого поведения: гиперфагия на весогенном препарате, импульсивность и когнитивное снижение — разные механизмы, и только врач решает, что из них стоит за поведением и что с этим делать (разделы 13.1, 13.5). Заведующая отделением — о постоянной схеме столов.

Документы. Запись об инциденте; пищевые карты обоих; график взвешивания пожилого жителя; при повторении — алгоритм при конфликте за столом (приложение 15) и протокол разбора пищевого инцидента (приложение 34).

Долгосрочное решение. Схема рассадки — документ отделения: кто с кем сидит и почему, когда пересматривается. Жителя с гиперфагией не сажают рядом с медленно едящими людьми из группы риска (раздел 14.1). Для него — структурированный режим доступности еды, правила добавки и ночная доступность по конструкции раздела 13.9; это снижает мотив искать еду в чужих тарелках. Для пожилого соседа — регулярное взвешивание и сообщение врачу о потере массы: онтарийские пороги — 5 % за 30 дней, 7,5 % за 90 дней, 10 % за 180 дней[27]; британский инструмент MUST для домов ухода предполагает ежемесячный скрининг[106].

Основания. Лишение еды как мера воздействия нарушает право на гуманное отношение, исключая унижение достоинства (ч. 2 ст. 5 Закона № 3185-1; для всех получателей социальных услуг — ст. 9 442-ФЗ)[8, 118]; Конвенция о правах инвалидов запрещает дискриминационный отказ в пище или жидкостях по причине инвалидности (ст. 25 п. «f»)[133]. Защищать жителя от вреда со стороны других проживающих — часть надлежащего ухода, который ст. 9 442-ФЗ гарантирует получателю (толкование)[118]. Переедание и тяга к еде у людей с тяжёлыми психическими расстройствами встречаются часто — по данным реалистского синтеза, в 4,4–45 % и 16,1–64 % случаев соответственно[56]; прибавка массы на оланзапине — документированный эффект[99]. Насилие между проживающими в домах ухода распространено: в американском исследовании десяти домов штата Нью-Йорк (2011 проживающих) за один месяц хотя бы один эпизод пережили 20,2 % жителей; чаще всего — словесная агрессия (9,1 %), физическая — 5,2 %; более высокие оценки были связаны, в частности, с большей нагрузкой на одного помощника по уходу[257]. Отбирание еды отдельно не выделялось, доли на российские ПНИ не переносятся.

Ограничение вывода. Рассадка — рабочий инструмент безопасности, а не наказание. Схему пересматривают, а не закрепляют пожизненно; «одиночный стол» без срока и без пересмотра становится изоляцией.

Вопросы для обсуждения.

1. Есть ли в вашем отделении письменная схема рассадки и кто её последний раз пересматривал?
2. Как смене вмешаться в отбирание еды, не спровоцировав агрессию?
3. Кого из жителей вы взвесили бы первым, если бы узнали о таком эпизоде сегодня?

Кейс 8. Человек быстро заглатывает куски

Ситуация. Житель пятидесяти пяти лет ест очень быстро: порцию второго — за три-четыре минуты, почти не жуя, большими кусками, часто запихивая следующий кусок до того, как проглотил предыдущий. Дважды за месяц во время обеда — поперхивание с сильным кашлем; во второй раз он покраснел и несколько секунд не мог откашляться. Врач в отпуске, замещающий придёт через неделю.

Проблема. Быстрое заглатывание — фактор риска аспирации и удушья, и два поперхивания за месяц — уже не «особенность», а сигнал. Ждать врача неделю без промежуточных мер — неоправданный риск. Но и самостоятельная «диета» здесь недопустима: переводить человека на протёртое без назначения — значит назначать клинику силами кухни.

Что нельзя делать. Ждать без изменений. Переводить на протёртое «на всякий случай» без назначения: избыточная модификация текстуры бьёт по питательности, аппетиту и достоинству (раздел 10.5). Командовать «ешь медленно!» — это не работает.

Немедленно. Меры подачи, а не диеты (разделы 9.2, 10.7):

- порция небольшая, с добавкой по просьбе, а не большая сразу;
- куски мяса и котлеты нарезаются мельче по просьбе повара — это сервировка, а не изменение текстуры;
- питьё под рукой, запивать по ходу еды;
- место в поле зрения сотрудника, который сидит рядом, а не стоит над ним;
- его стол обслуживается первым — это снимает мотив «надо успеть»;
- для него на время ожидания врача — отказ от сухих крупных кусков, особенно хлеба (раздел 10.7, п. 5).

Смена знает алгоритм удушья, и в часы еды на посту двое обученных сотрудников (приложение 12).

Кто принимает решение. Смена — о сервировке и наблюдении. При повторном поперхивании — врач вне очереди: дежурный, по телефону, через скорую помощь, если эпизод тяжёлый; ждать плановой недели нельзя, потому что поперхивание при еде входит в список признаков дисфагического риска (раздел 10.4). Решение о скрининге глотания, текстуре и её пересмотре принимает только врач.

Документы. Форма наблюдения с описанием темпа еды и эпизодов поперхивания («съедает порцию за 3–4 минуты, не прожёвывает» — наблюдение, а не толкование, раздел 9.5); алгоритм при быстром заглатывании (приложение 13); после осмотра врача, при подтверждении риска, — назначение текстуры по IDDSI с датой пересмотра^[64]; включение в список риска (приложение 21).

Долгосрочное решение. Скрининг дисфагии по назначению врача; при подтверждении — назначенная текстура, темповые приёмы, правильная поза (сидя вертикально, после еды не ложиться около получаса), пары эквивалентов внутри назначенной текстуры, чтобы выбор не исчез (раздел 10.10). Обучение смены приёмам безопасного кормления и отработка алгоритма удушья на занятиях, а не только «по бумаге» (раздел 10.7). Отметка о риске удушья передаётся при каждом переводе, госпитализации и пересменке^[55].

Основания. Поперхивание при еде — признак риска аспирации; аспирационная пневмония — одна из главных причин избыточной смертности людей с тяжёлыми психическими расстройствами^[15, 29, 61]. Смертность от удушья пищей у людей с шизофренией многократно превышает популяционную; числа и их оговорки изложены в разделе 10.2^[16]. Ведомство здравоохранения Нового Южного Уэльса прямо называет импульсивную или быструю еду среди

факторов риска удушья у психиатрических пациентов и требует скрининга при поступлении и передачи сведений о риске[55]. Невалидированное «на глаз» выявление занижает распространённость дисфагии в домах ухода, поэтому при подозрении нужен инструмент, который выбирает врач[14].

Ограничение вывода. Организационные меры — мост до врача, а не замена скрининга. Два поперхивания за месяц — основание для внеочередной оценки, а не для самостоятельного перевода на протёртое. И наоборот: отсутствие кашля не доказывает безопасности, потому что аспирация бывает «немой» (раздел 10, справка «Что такое дисфагия»).

Вопросы для обсуждения.

- 1. Знает ли каждая смена, кого в отделении нельзя оставлять за едой без присмотра?
- 2. Чем «нарезать мельче» отличается от «назначить текстуру» и кто вправе делать то и другое?
- 3. Когда последний раз в вашем доме отрабатывали алгоритм удушья на практике?

Новые источники

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-kejsy-a/istochniki.md](#). Маркеры прежней и второй редакций раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-rrem_lachs	Lachs M.S., Teresi J.A., Ramirez M., et al. The Prevalence of Resident-to-Resident Elder Mistreatment in Nursing Homes // Ann Intern Med. 2016;165(4):229–236. DOI: 10.7326/M15-1209

Исправления по сравнению с первой редакцией. Недопустимость принудительного кормления и лишения еды опирается на ч. 2 ст. 5 Закона № 3185-1, а не на ст. 37 (раздел 41.6). В кейсе 5 маркер M-dysph_prev (распространённость дисфагии на антипсихотиках) заменён на источники о смертности и потере массы, к которым относится утверждение; ссылка «структурированная доступность еды (раздел 13)» заменена на план на обострение (раздел 9.6). В кейсе 6 маркер M-metmon (метаболический мониторинг) заменён на источники о седации и удушье за завтраком; добавлены требования п. 32 СанПиН 4282-26 к хранению отложенных порций. В кейсе 7 маркер M-ebt (статистика ПНИ) снят как не относящийся к пищевой агрессии; ссылка «раздел 20» о еде как инструменте наказания заменена на разделы 14.3 и 17.4. Нормы СанПиН даны в двух редакциях с датой смены 01.09.2026 без переходного периода.

Учебные кейсы 9–12

Все кейсы этого блока — учебные ситуации, составленные для разбора. Они не описывают конкретные организации и конкретных людей. Основания — ориентиры для обсуждения, а не заключение по реальному делу; назначения и их пересмотр остаются за врачом.

Кейсы 9–12 переносят разговор с линии раздачи на уровень системы. Кухня ошибается в текстуре, родственник требует запрета, житель спорит с назначенным ограничением, а положение о выборе живёт только на бумаге. Виноватого исполнителя найти легко, но причина обычно в том, что назначение не доведено, правило не объявлено или процедура не встроена в ритм дома.

Кейс 9. Кухня приготовила протёртое блюдо, не соответствующее назначенной текстуре

Ситуация. Жительнице семидесяти четырёх лет после инсульта врач назначил текстуру IDDSI уровня 6 — «пища мягкая кусочками». На обед в её тарелке оказалось однородное пюре из мяса и картофеля, то есть уровень 4 — «пюреризированная пища». Повар объясняет: «Мы всем протёртым даём одинаково, так надёжнее». Жительница пюре не ест: «Я же не младенец».

Проблема. Ошибка текстуры опасна в обе стороны. Слишком грубая текстура грозит аспирацией и удушьем. Слишком гладкая — это избыточная модификация: меньше питательной плотности, хуже аппетит и сытость, «детский» вид тарелки, который человек справедливо воспринимает как унижение.

Справка. Как кухня проверяет текстуру. Система IDDSI описывает уровни пищи не словами «мягкое» или «протёртое», а проверяемыми свойствами. Для пищи используют **тест надавливания вилок** (как кусок ведёт себя под зубцами вилки — сминается ли, восстанавливает ли форму, остаётся ли след) и **тест наклона ложки** (удерживает ли масса форму и как соскальзывает с ложки). Для напитков служит тест текучести из шприца. Описания уровней и методов тестирования есть в официальном русском переводе IDDSI[65]. Тест занимает около минуты и превращает «протёртое» из дела вкуса повара в измеряемое свойство блюда (раздел 10.5).

Что нельзя делать. Выдать как есть — «протёртое же». Разбавлять пюре водой или бульоном «до нужной консистенции»: текстура и питательность при этом меняются непредсказуемо, а уровень 6 из пюре всё равно не получится. Считать, что «пюре безопаснее, пусть будет пюре»: избыточная модификация — тоже вред. Писать в карту кухни диагноз вместо текстуры: кухне нужно знать, что у человека уровень 6, а не почему (раздел 17.6)[132].

Немедленно. Не выдавать несоответствующую порцию. Собрать порцию назначенной текстуры из доступных компонентов: мягкие кусочки котлеты, тушёные овощи, разварной картофель кусочками — в стандартном меню обычно есть из чего. Проверить её тестом вилок. Записать несоответствие: что было назначено, что приготовлено, что выдано.

Кто принимает решение. Заведующий производством — о порции сегодня. Врач — если несоответствие повторяется: возможно, назначение не доведено до кухни или записано неоднозначно («протёртое» вместо уровня IDDSI). Директор — если кухня не обучена шкале IDDSI: это вопрос обучения, а не дисциплины.

Документы. Назначение текстуры в пищевой карте и на кухонной карточке (функциональное ограничение без диагноза), запись о несоответствии, чек-лист пищеблока (приложение 19) со строкой «доля правильных текстур», список риска (приложение 21).

Долгосрочное решение. Карточка текстур на стене кухни: уровни IDDSI с фотографиями блюд собственного меню на каждом уровне. Обучение поваров тестам вилкой и ложкой — минута на блюдо (раздел 10.5). Маркировка порций с изменённой текстурой на линии, чтобы протёртая и обычная тарелки не перепутались (раздел 18.2). И, наконец, выбор внутри текстуры: два варианта уровня 6, а не одно «блюдо для протёртых» (раздел 10.10).

Основания. IDDSI — международная система описания текстур пищи и напитков[64]; официальный русский перевод даёт готовую терминологию[65]. В исследовании пяти учреждений доля поданных текстур, совпадающих с назначенными, выросла после внедрения IDDSI с 44 до 90 %, а главным барьером была осведомлённость персонала[67]. Протёртая пища несёт и питательный риск: в новозеландском рандомизированном исследовании у 36 % жителей на протёртом рационе исходно была недостаточность питания[70]. Исполнение назначения опирается на требование организовать диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям: п. 7.1.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 — до 31.08.2026; п. 56 подп. 11 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 — с 01.09.2026, без переходного периода[9, 128]. Сопоставимой шкалы консистенций в российских нормах для организаций социального обслуживания нет; IDDSI — международный ориентир, применяемый по назначению врача (раздел 10.5).

Ограничение вывода. Самопроверка кухни — организационная мера. Назначение текстуры и его пересмотр остаются на враче; кухня не «повышает» и не «понижает» уровень по своему усмотрению, даже если жительница просит «нормальной еды» — эта просьба идёт к врачу (раздел 10.5, «осознанный риск»).

Вопросы для обсуждения.

1. Как в вашем доме записано назначение текстуры: «протёртое» или уровень IDDSI?
2. Кто и когда последний раз проверял текстуру на линии тестом, а не на глаз?
3. Сколько вариантов блюда получает сегодня житель с изменённой текстурой?

Кейс 10. Родственник требует запретить продукт без врачебного назначения

Ситуация. Дочь жителя требует у дежурной: «Уберите отцу сахар совсем — у него преддиабет, я читала, что это начало диабета. И сладкое к чаю тоже не давайте». Назначения по сахару в пищевой карте нет, последний анализ глюкозы врач не комментировал. Отцу семьдесят девять, он дееспособен, сахар в чай кладёт всю жизнь, спорить с дочерью не хочет и на вопросы отмалчивается.

Проблема. Третья сторона требует ограничить права жителя без клинического основания. Если исполнить требование молча, дом введёт ограничение рациона без назначения — то есть произвол, пусть и доброжелательный (раздел 17.3).

Справка. Либерализованная диета. Так в зарубежной гериатрии называют подход, при котором пожилому жителю учреждения ухода по умолчанию дают обычный рацион, а ограничения вводят только при ясных медицинских показаниях и пересматривают. Обоснование — в том, что строгие диеты у пожилых снижают аппетит и потребление пищи и могут вести к потере массы тела, а выигрыш от них в этом возрасте часто невелик. Это профессиональная позиция зарубежных сообществ, а не российская норма; в России решение о диете в любом случае принимает врач.

Что нельзя делать. Исполнить требование молча — «родственникам виднее». Отмахнуться — «вы нам не указ»: родственник важен и может знать факты, которых нет в карте. Втягивать жителя в спор «кто главнее» при дочери. Обсуждать с дочерью анализы и диагнозы отца без его согласия: сведения о здоровье — специальная категория персональных данных (раздел 17.6)[132].

Немедленно. Выслушать и поблагодарить: «Спасибо, что сказали. Решение о диете у нас принимает врач — я передам ему ваше обращение». Попросить изложить запрос письменно — заявлением родственника. Маршрутизировать врачу: если основания есть, врач назначит ограничение и разъяснит его отцу; если нет — разъяснит дочери (в пределах того, что отец разрешил сообщать). Позицию самого жителя выяснить отдельно, спокойно, без дочери: хочет ли он что-то менять.

Кто принимает решение. Врач — о клинической стороне. Житель, если он дееспособен, — о своём питании в пределах назначений. Директор — о регламенте приёма таких заявлений. Если бы житель был недееспособен, а опекуном была дочь, она обязана была бы учитывать его мнение и предпочтения (п. 3 ст. 36 ГК)[116]; но и тогда ограничение рациона оставалось бы врачебным решением, а не опекунским.

Документы. Заявление родственника; запись врача; пищевая карта с позицией жителя и указанием источника сведений («со слов дочери» — отдельно от «со слов жителя», раздел 15.3); согласие жителя на сообщение сведений о здоровье родственникам — если он его дал.

Долгосрочное решение. Регламент «третьих сторон»: запрос на ограничение принимается только через врача и только с учётом позиции жителя. Памятка родственникам (приложение 32) заранее объявляет это правило и объясняет, куда обращаться; заранее объявленное правило снимает большинство конфликтов на посту.

Основания. Ограничение рациона без назначения врача относится к «жёлтой зоне» и незаконно без процедуры (раздел 17.3). Права получателя социальных услуг, включая участие в составлении индивидуальной программы и уважительное отношение, закреплены в ст. 9 442-ФЗ[118]; для домов, предназначенных для лиц с психическими расстройствами, — ч. 2 ст. 5 Закона № 3185-1[8]. Близкие — источник информации для толкования воли, а не источник запретов; в иерархии источников раздела 15.4 сведения близких стоят ниже воли самого человека, а медицинские ограничения сужают выбор только при клинической необходимости.

Зарубежные профессиональные позиции прямо касаются этой ситуации. Академия питания и диетологии США: «В учреждениях длительного ухода ограничение рациона не является важной частью ведения диабета у пожилых людей», а «чрезмерно строгие диеты могут создавать для пожилых людей с диабетом дополнительный риск, например непреднамеренной потери массы тела и недостаточности питания»[255]. Американский регулятор CMS в 2013 году рекомендовал сделать обычный рацион вариантом по умолчанию, поскольку «ограничение выбора пищи может приводить к потере аппетита и в итоге массы тела»[256]. Документы американские и касаются пожилых в домах ухода; вывод «сахар можно всем» из них не следует, следует другое — запрет без назначения не является безопасной мерой «на всякий случай».

Ограничение вывода. Если житель недееспособен и обязанности опекуна исполняет сам дом, к конфликту добавляется структурный конфликт интересов «учреждение = опекун»; его разбор и antidotes — в разделах 16.4 и 16.8. Зафиксированные предпочтения человека и тогда имеют приоритет над «усреднённым благом».

Вопросы для обсуждения.

1. Что сегодня отвечает дежурная, когда родственник требует запрета у поста?
2. Как выяснить позицию жителя, который «не хочет спорить»?
3. Что из сведений о здоровье жителя вы вправе сообщить родственнику без его согласия?

Кейс 11. Житель требует добавку при медицинском ограничении

Ситуация. Мужчина сорока двух лет третий год получает клозапин; за это время он прибавил больше двадцати килограммов, у него повышены глюкоза и триглицериды. Врач назначил контроль калорийности: стандартная порция, добавка — только овощи. Каждый обед житель требует вторую порцию второго, а получив отказ, кричит на всю столовую: «Вы меня морите голодом!» Одна сиделка даёт «чтобы замолчал», другая отказывает с нотацией о весе.

Проблема. Лекарственная гиперфагия столкнулась с назначенным ограничением, и столкновение разыгрывается публично. Непоследовательность смены делает конфликт ежедневным: у жителя есть основания думать, что исход зависит от того, кто дежурит, а значит, за добавку стоит бороться. Голод при этом настоящий — он вызван фармакологией, а не распушенностью (раздел 13.1).

Справка. Энергетическая плотность. Так называют число килокалорий в единице массы или объёма продукта. Овощи, супы на овощном бульоне, салаты имеют низкую энергетическую плотность: большой объём при малой калорийности. Именно поэтому «объёмные низкокалорийные добавки» позволяют уменьшить чувство голода, не нарушая назначенного ограничения калорийности. Что именно и в каком количестве допустимо, определяет назначение врача.

Что нельзя делать. Давать добавку «чтобы замолчал»: назначение обесценивается ежедневным исключением, а житель учится, что крик работает. Читать нотации о весе при всех: весогенный эффект препарата стыдом не лечится (раздел 13.7). Оставлять решение «сиделке по настроению».

Немедленно. Выдать запланированную порцию спокойно и без лекции; предложить добавку, которую разрешает назначение, — овощи, салат. Сказать коротко: «Я понимаю, что вам хочется есть. Это от лекарства, мы с врачом это обсудим». Эскалация врачу — не «жалоба на жителя», а запрос на пересмотр тактики: объёмные низкокалорийные добавки, дробность приёмов, ночная доступность, пересмотр схемы лечения.

Кто принимает решение. Врач — о назначении и его коррекции, включая лекарственные средства для профилактики прибавки массы, если считает их показанными. Смена исполняет назначение одинаково каждый день. Директор обеспечивает кухне объёмные низкокалорийные добавки.

Документы. Назначение врача с целью и сроком пересмотра; пищевая карта; график взвешивания и динамика массы тела; записи о конфликтах за столом (приложение 15 — алгоритм при конфликте); письменный порядок выдачи добавки (раздел 13.3).

Долгосрочное решение. Структурированный ответ на гиперфагию (раздел 13): объёмные низкокалорийные компоненты, дробный режим без длинных «дыр», ночная доступность по конструкции раздела 13.9 там, где ночная еда — часть картины. Разговор о весе — по формуле «это побочный эффект лечения, который мы вместе обходим» (раздел 13.7). Метаболический мониторинг массы тела, глюкозы, липидов — по графику для его терапии^[101]; прибавка более 5 % за квартал — сообщение врачу (раздел 13.8).

Основания. Прибавка массы на антипсихотиках — документированный эффект с большим разбросом между препаратами^[13]; при длительном лечении клинически значимую прибавку (7 % массы и более) имеют 76,3 % пациентов на клозапине^[99]; долгосрочная прибавка при первом эпизоде психоза измеряется килограммами^[100]. Переедание и тяга к еде у людей с тяжёлыми психическими расстройствами часты^[56]. Лекарственная профилактика прибавки существует (доказательства низкой достоверности в пользу метформина), но относится исключительно к врачебной зоне^[104]. Исполнение назначения опирается на требование организовать диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям: п. 7.1.11 СанПиН 3590-20 — до 31.08.2026; п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26 — с 01.09.2026^[9, 128]. Ограничение рациона закономерно только по назначению, поимённо, с целью и сроком (раздел 17.3).

Есть и обратная сторона, которую стоит держать в уме: зарубежные профессиональные позиции предостерегают от избыточно строгих диет в учреждениях ухода^[255]. В этом кейсе ограничение назначено врачом по ясным показаниям, и смена его исполняет; но назначение, как и любое ограничение, должно иметь дату пересмотра.

Ограничение вывода. «Добавка или нет» — вопрос назначения, а не дисциплины. Смягчение и ужесточение — только через врача.

Вопросы для обсуждения.

1. Записан ли в вашем доме порядок выдачи добавки — кому, что и когда?
2. Какими словами смена может отказать во второй порции, не унижая человека?
3. Какие низкокалорийные объёмные добавки ваша кухня может выдавать каждый день без новых закупок?

Кейс 12. Выбор есть только на бумаге

Ситуация. Положение о вариативном питании утверждено приказом полгода назад, его зачитали на совещании и подшили в папку. В коридоре висит меню с двумя колонками. Кухня готовит один вариант: «Второй никто никогда не заказывал». Журнал заказа заведён, но страницы пусты; журнал срывов не открывали ни разу.

Проблема. Это фиктивная вариативность уже не операционного масштаба, как в кейсе 4, а организационного. Система самообмана, которая при проверке становится обманом документальным: положение обещает то, чего нет на столе. Здесь сходятся сразу несколько признаков раздела 21.4 — «выбор есть в положении, но не на линии», «все выбирают А», «статистика ни на что не влияет».

Справка. Провал вмешательства и провал внедрения. Исследователи внедрения различают два вида неудачи. **Провал вмешательства** — когда сама идея не работает в данных условиях. **Провал внедрения** — когда хорошее вмешательство было развёрнуто неправильно и до людей просто не дошло^[234]. Отсюда и мера **верности протоколу** (англ. *fidelity*) — степень, в которой вмешательство реализовано так, как задумано. Пустой журнал заказа говорит о провале внедрения, а не о том, что жителям выбор не нужен.

Что нельзя делать. Считать: «положение есть — значит, практика есть». Наказывать кухню: она рационально приспособилась к нулевому спросу, которого никто не создавал. Тихо снять вторую колонку меню и забыть. Делать вывод «нашим жителям выбор не нужен» по данным системы, которая выбор не предлагала.

Немедленно. Диагностика по признакам фиктивной вариативности (разделы 21.4, 21.8): знают ли жители о выборе; показывает ли кто-нибудь меню и когда; реально ли приготовить второй вариант из имеющихся продуктов и ёмкостей; что с журналом заказа и почему он пуст; спросить пятерых жителей разных отделений: «Вы знали, что можно выбрать?» Проверка реальности (приложение 24) даёт для этого готовую форму.

Кто принимает решение. Директор. Это провал внедрения, а не исполнителей: процедура выбора не была встроена в ритм отделений.

Документы. Положение, меню, журнал заказа, результаты диагностики, служебная записка; при перезапуске — проект приказа о пилоте (приложение 28), отчёт о пилоте (приложение 27).

Долгосрочное решение. Перезапуск как пилот (раздел 35): одна точка выбора, одно-два отделения, показ меню как записанная обязанность смены, журнал, замер через 90 дней. Положение без процедуры — предмет для переписывания, а не для полки (приложение 29). Устойчивость закладывается сразу, а не «потом»: мониторинг результатов, время персонала, передача дел новым сотрудникам, постоянная коммуникация. Британское качественное исследование проектов улучшения качества в домах ухода показало, что из семи вмешательств три продолжались, а четыре — нет, и авторы советуют обеспечивать устойчивость в ходе внедрения, «а не рассматривать её как отдельный процесс»^[240].

Основания. Разрыв «документ — практика» — центральный предмет внешней проверки. Регулятор Англии CQC оценивает, как нужды в питании и питье удовлетворяются на деле[52]. Генеральный аудитор Онтарио в 2019 году отметил, что министерство не требовало от домов долговременного ухода отчитываться какими-либо показателями питания, и фактическая работа столовой оставалась невидимой на уровне провинции[150]. В российской рамке соответствие документов практике — управленческая ответственность директора (раздел 33), а документ, не подтверждённый практикой, — худшая позиция перед проверяющим (раздел 32.4).

Ограничение вывода. Нулевой или низкий спрос в первые недели после перезапуска сам по себе ничего не доказывает: жители привыкают к новому, а эффект новизны может действовать в обе стороны; длительность таких эффектов исследования не устанавливают, и это рабочее допущение (раздел 35). Вывод о фиктивности или, наоборот, о том, что выбор не нужен, делают по данным месяцев, а не дней.

Вопросы для обсуждения.

1. Какие три признака фиктивной вариативности проверяющий заметит у вас за один визит?
2. Кто в вашем доме отвечает за то, чтобы журнал заказа кто-то читал?
3. Чем перезапуск в форме пилота отличается от «повторного зачитывания положения на совещании»?

Новые источники

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-kejsya/istochniki.md](#). Маркеры прежней и второй редакций раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
M-and_dorner	Dorner B., Friedrich E.K. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Individualized Nutrition Approaches for Older Adults: Long-Term Care, Post-Acute Care, and Other Settings // J Acad Nutr Diet. 2018;118(4):724–735. DOI: 10.1016/j.jand.2018.01.022
I-cms_dining2013	CMS (CША), Survey & Certification Group. S&C: 13-13-NH «Information Only: New Dining Standards of Practice Resources are Available Now», 01.03.2013

Исправления по сравнению с первой редакцией. В кейсах 9 и 11 исполнение назначения отнесено к п. 7.1.11 СанПиН 3590-20 (диетическое питание по медицинским показаниям), а не к п. 7.1.12, который касается помещения для приёма готовой продукции и отбора суточных проб (раздел 17.2); с 01.09.2026 действует п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26 без переходного периода. В кейсе 10 право на уважительное отношение отнесено к ч. 2 ст. 5 Закона № 3185-1 и ст. 9 442-ФЗ, а не к ст. 37 и 43 (раздел 41.6); обязанность опекуна учитывать мнение подопечного — к п. 3 ст. 36 ГК. В кейсе 12 формулировка о «рейтингах CQC» уточнена по тексту Regulation 14; добавлен довод онтарийского аудита.

Учебные кейсы 13–16

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа. Они описывают типовые механизмы и не являются хроникой конкретного дома (раздел 41.5). Имена, должности и числа условны.

Кейс 13. Бухгалтерия не может связать выбор со списанием

Ситуация. Отделение на сорок человек уже месяц работает по модели М1: на завтрак — гречневая или рисовая каша, на обед два-три раза в неделю — второе блюдо на выбор. В конце месяца главный бухгалтер приходит к директору с вопросом, на который никто не подготовил ответа: «Журнал заказа живёт в отделении, а мы списываем продукты по меню-раскладке, как раньше. В раскладке стоит гречка на всех. Сколько гречки и сколько риса мне списывать? Если придёт ревизия, я не смогу объяснить ни одной цифры».

Проблема. В доме два потока данных, которые не соединены. Первый — журнал заказа (приложение 7): сколько порций варианта А и варианта Б выдано. Второй — складской учёт: какие продукты выданы со склада и на каком основании списаны. Пока они существуют отдельно, расход рисовой крупы не подтверждён никаким документом, а расход гречки завышен. На проверке это выглядит как необоснованное списание, хотя жители получили положенное по нормам.

Что нельзя делать. Списывать «как раньше, пополам» или «всё на гречку»: фиктивная точность хуже честного метода, потому что она фиксирует в первичном документе то, чего не было. Требовать от бухгалтерии «разобраться самим» бессмысленно: данных отделений у неё нет. Наконец, нельзя сворачивать вариативность из-за учёта: задача решаемая, и экономика пар эквивалентов как раз построена на перераспределении, а не на добавлении сырья (раздел 29.4).

Немедленно. Назначить приказом ответственного за сведение данных — обычно заведующего производством или диетсестру. С завтрашнего дня ежедневные итоги журнала заказа (сколько порций какого варианта выдано по каждой позиции) уходят в бухгалтерию одной строкой на позицию. Задним числом за прошедший месяц ничего не переписывается: бухгалтерия получает сводку журналов заказа за месяц как пояснение к уже сделанному списанию, а расхождение объясняется служебной запиской.

Справка. Меню-раскладка и первичный документ. Меню-раскладка (меню-требование) — документ, в котором утверждённое меню переводится в количество продуктов, выдаваемых со склада на кухню. По закону о бухгалтерском учёте каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учётным документом, и принимать к учёту документы, которыми оформлены «не имевшие места факты», нельзя^[258]. Для вариативного меню это значит: если жители выбрали рис, раскладка, по которой со склада ушла только гречка, описывает не тот факт, который произошёл.

Кто принимает решение. Главный бухгалтер совместно с заведующим производством — о методике списания по фактической выдаче. Директор приказом закрепляет форму сведения, сроки её передачи и ответственных. Формы первичных документов для организаций бюджетной

сферы устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством[258].

Документы. Журнал заказа (приложение 7) и сводная форма к нему; приказ о порядке учёта вариативных позиций; чек-лист бухгалтерского учёта (приложение 23); действующие учётные формы — по приказу Минфина № 52н или электронные формы по приказу № 61н с учётом поэтапного перехода, который нужно подтвердить у учредителя[224, 225].

Долгосрочное решение. Списание по факту выдачи. Статистика выбора (раздел 21.2) даёт пропорцию списания парных продуктов. Ключевая деталь электронного учёта: по разъяснениям Минфина 2024 года электронная требование-накладная (ф. 0510451) формируется автоматически после утверждения расчёта потребности по меню-раскладке[225]. Значит, пропорции пар должны попадать в раскладку до её утверждения, иначе склад выдаст продукты под одно меню, а жители выберут другое (раздел 31.5). Какую именно форму признаёт учредитель, нужно уточнить письменно: статусы форм меняются поэтапно[224].

Основания. Требование оформлять каждый факт первичным документом и запрет оформлять несостоявшиеся факты — часть 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ[258]. Порядок электронных форм — приказ Минфина № 61н и методические рекомендации к нему[225]. Методика «выдано по заказам — списано по пропорции» широко применяется на поточных кухнях; это рабочая практика, а не изобретение доклада и не норма.

Ограничение вывода. Методика согласуется с учредителем и закрепляется в учётной политике. Форма сведения — проект локальной формы, не норматив.

Вопросы для обсуждения.

1. Кто в вашем доме сегодня может за пять минут сказать, сколько порций варианта Б было выдано вчера, и где это записано?
2. Как отразить в учёте день, когда вариант Б закончился и часть жителей получила стандартную порцию?

Кейс 14. Поставщик не привёз один из вариантов

Ситуация. Пятница, 17:40. Заказы на субботний обед собраны ещё днём: из шестидесяти жителей двадцать выбрали запечённую рыбу, остальные — тефтели. Звонит менеджер поставщика: «Рыбы на завтра нет, машина ушла без неё. Привезём курицу, вы же не против?» Контрактный управляющий в отпуске, а старшая смены спрашивает, что говорить жителям.

Проблема. Разорвалась цепочка «закупка — меню — заказ»: выбор сделан под продукт, которого не будет. Молчание означает, что двадцать человек узнают о замене у раздачи; «просто принять курицу» — получить товар вне спецификации без документа.

Что нельзя делать. Молча заменить рыбу курицей во всех двадцати порциях: выбор, который тихо отменяют, жители перестают делать. Объявить «завтра без выбора» и сделать это новой привычкой при каждом срыве. Принимать товар не из контракта без оформления: закон допускает при исполнении контракта поставку товара с улучшенными характеристиками, но не

произвольную замену (ч. 7 ст. 95 44-ФЗ)^[222]. И, наконец, нельзя ограничиться скандалом с менеджером по телефону: претензионная работа живёт в документах, а не в раздражении (раздел 30).

Немедленно. Вечером провести повторный показ: «Рыбы завтра не будет. Есть тефтели и курица — выберите заново». Заказ переписывается в журнале заказа с пометкой «перезаказ». Недовольство обычно вызывает не срыв, а молчание о нём. Если курицы нет в контракте, кухня использует резервную пару из имеющихся на складе продуктов в пределах норм и таблицы замен (раздел 19.2). Срыв записывается в журнал срывов выбора (приложение 8). В понедельник оформляется акт о недопоставке.

Кто принимает решение. Заведующий производством — о замене позиции в меню в пределах таблицы замен. Старшая смены отделения — о перезаказе и его записи. Ответственный за исполнение контракта — о претензии поставщику; в учреждении по 223-ФЗ — в порядке, предусмотренном положением о закупке и договором.

Документы. Акт о недопоставке; требование об уплате неустойки (претензия) по контракту; запись о перезаказе в журнале заказа; строка в журнале срывов выбора; при приёмке замены — акт с указанием эквивалента из группы, описанной в контракте.

Справка. Неустойка, пеня, штраф. Неустойка — денежная сумма, которую должник обязан уплатить при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства. По 44-ФЗ она бывает двух видов: **пеня** начисляется за каждый день просрочки, **штраф** — за иные нарушения, кроме просрочки. Условие об ответственности сторон в контракте обязательно, а при нарушении заказчик сам направляет поставщику требование об уплате неустойки^[259]. Недопоставка одной позиции — ненадлежащее исполнение; квалификацию конкретного случая даёт контрактная служба.

Долгосрочное решение. В спецификацию закупки вносится правило взаимозаменяемости: позиции описываются группами эквивалентов («рыба: минтай, хек, треска»), а при недопоставке допускается эквивалент из той же группы по согласованию и с актом (раздел 30.8). Таблицы замен превращаются в «запасные эквиваленты» спецификации (раздел 30.4). На складе держится резервная пара из долгохранящихся продуктов. Статистика срывов по поставщику ведётся в журнале срывов и становится аргументом при следующей закупке (приложение 22, пункт 4).

Основания. Исполнение контракта, ответственность сторон и требование об уплате неустойки — статья 34 44-ФЗ^[259]; пределы изменения контракта — статья 95^[222]. Обязанность обеспечить полноценный приём пищи не реже трёх раз в день при любом срыве поставки — пункт 56 подпункт 11 СанПиН 2.3/2.4.4282-26, действующего с 01.09.2026^[9]. Для дома, работающего по 223-ФЗ, контрактная часть регулируется его положением о закупке (раздел 30.1).

Ограничение вывода. Единичный срыв — рабочая ситуация, а не повод для разрыва отношений. Систематические срывы — повод пересмотреть отношения с поставщиком, но по документам: актам, претензиям, журналу срывов.

Вопросы для обсуждения.

1. Кто в вашем доме вправе вечером в пятницу принять у поставщика товар не из спецификации, и записано ли это где-нибудь?

2. Как сформулировать повторный показ для жителей, которые не говорят и выбирали по двум порциям?

Кейс 15. Персонал использует десерт как поощрение

Ситуация. В одном из отделений годами держится неписаное правило: «Кто убрал за собой посуду — получает компот с булочкой, кто не убрал — только компот». Сиделки считают это педагогикой и искренне гордятся результатом: «У нас самое чистое отделение». Новый заведующий отделением замечает правило на третий день, когда пожилая жительница с тремором плачет над стаканом компота.

Проблема. Еда стала рычагом поведения. Булочка — часть рациона, а не премия, и выдавать её «если» значит превращать питание из права в награду. Для жителей ПНИ это прямо противоречит праву на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение достоинства (ч. 2 ст. 5 Закона № 3185-1)[8]; для домов общего профиля — праву получателя услуг на уважительное и гуманное отношение по статье 9 442-ФЗ[118]. Кроме того, правило бьёт по самым слабым: убрать за собой не может тот, у кого дрожат руки.

Что нельзя делать. Закрывать глаза — «мелочь же»: из таких мелочей и собирается культура столовой. Наказывать сиделок без объяснения: практика укоренилась, значит, вина системная, и наказание лишь научит скрывать. Запрещать булочки «чтобы не было соблазна»: это наказание всех за ошибку персонала.

Немедленно. Прекратить дифференциальную выдачу сегодня же: десерт получают все по норме. Разговор со сменой ведётся не о «плохих людях», а о правиле и его основаниях: еда не используется ни как поощрение, ни как наказание.

Справка. Еда как рычаг и институциональная культура. Институциональной культурой в литературе об учреждениях долговременного ухода называют привычки, которые выросли из удобства персонала и воспринимаются как естественный порядок вещей: общий подъём, раздача «по очереди», «воспитательные» правила. Еда — самый доступный рычаг такой культуры, потому что ею распоряжается персонал. Граница проходит по условию «получишь, если...»: праздничный стол или совместная готовка — деятельность, условная булочка — воздействие.

Кто принимает решение. Заведующий отделением — о немедленном прекращении практики. Директор — о закреплении правила в документах. Врач — если у кого-то из жителей есть медицинские ограничения по сладкому: тогда житель получает альтернативу, а не лишение (раздел 17.3).

Документы. Правило в положении о питании: «Пища и питьё не используются как поощрение или наказание» — в формулировке раздела 16.5. Памятка персоналу «Питание и выбор: десять правил» (приложение 31). Запись об инструктаже с подписями смены.

Долгосрочное решение. Правило входит в инструктаж для поста (раздел 28.10), где запрет использовать еду как рычаг поощрения и наказания назван прямо, и в контрольные вопросы обходов. Для сиделок описываются легальные инструменты поощрения: словесные, режимные, привилегии вне еды (выбор места за столом, участие в дегустации совета жителей).

Основания. Лишение еды или питья как мера воздействия относится к красной зоне права (раздел 17.4). Для жителей ПНИ — часть 2 статьи 5 Закона № 3185-1; статья 43 распространяет на них права, перечисленные в частях 2 и 4 статьи 37[8]. Для всех домов — статья 9 442-ФЗ[118] и статья 25, пункт «б», Конвенции о правах инвалидов, которая не допускает дискриминационного отказа в получении пищи или жидкостей по причине инвалидности[133]. Зарубежные регуляторы приходят к тому же: английское правило 14 требует удовлетворять потребности в питании каждого получателя услуг[52], а американские правила относят к злоупотреблению «лишение... благ или услуг, необходимых для... благополучия»[260]. Отнесение условной булочки к «лишению благ» — толкование доклада; американская норма в России не действует.

Ограничение вывода. Правило касается еды как рычага. Оно не запрещает праздничные столы, совместную готовку и угощение как деятельность. Граница — в условности: «получишь, если».

Вопросы для обсуждения.

1. Какие ещё «педагогические» правила, связанные с едой, могут жить в отделении незаметно для администрации?
2. Как объяснить смене запрет так, чтобы его исполняли, а не обходили?

Кейс 16. Житель не говорит, но систематически оставляет одну кашу

Ситуация. Житель средних лет, не пользующийся речью, второй месяц подряд не притрагивается к манной каше. Всё остальное он съедает, включая другие каши. Смена давно знает: «Манную он не ест». Диетолога в доме нет. Врач на вопрос отвечает: «Раз остальное ест и вес стоит — порядок». Каждый вторник и пятницу тарелка манной каши уходит в бак нетронутой.

Проблема. Невербальное сообщение система уже расшифровала, но не закрепила. Предпочтение живёт в голове смены и исчезнет с её ротацией или отпуском.

Что нельзя делать. Выдавать манную «по меню» и выбрасывать: это и отходы, и ежедневное игнорирование сказанного. Строить теорию из одного наблюдения — «у него аверсия к текстуре»: возможно, но это гипотеза для наблюдения, а не вывод (раздел 15.3). Оставлять знание неформальным.

Немедленно. Записать в карту пищевых предпочтений (приложение 2): «Манную кашу не ест (наблюдение, 2 месяца, источник — смена). Замена: любая другая каша». Проверить запись практикой: две недели фиксировать в форме наблюдения (приложение 6), ест ли он предложенную замену. Заодно проверить, нет ли признаков, указывающих не на вкус, а на глотание: кашля или поперхивания, «влажного» голоса после глотка, подтекания изо рта, еды за щекой (раздел 10.4).

Справка. Пищевая карта и персональные данные. Карта пищевых предпочтений — не медицинская карта, но в ней могут оказаться сведения о здоровье: текстура, ограничения, признаки дисфагии. Такие сведения относятся к специальным категориям персональных данных, и для их обработки нужно основание из части 2 статьи 10 Федерального закона № 152-ФЗ, а не просто договор о социальном обслуживании[132] (раздел 17.6). Практический вывод: предпочтения («не ест манную») и клинические пометки разумно разделять, а доступ к карте ограничивать.

Кто принимает решение. Смена фиксирует наблюдение. Заведующий отделением утверждает запись в карте. Врач подключается, если появятся признаки того, что дело не во вкусе, а в консистенции или в глотании (раздел 10): тогда маршрут становится клиническим, и текстуру назначает только врач.

Документы. Карта пищевых предпочтений (приложение 2), форма наблюдения за невербальным выбором (приложение 6), журнал замен.

Долгосрочное решение. Пищевые карты пересматриваются раз в квартал: предпочтения людей в целом устойчивы, но не застывают. В американском исследовании жителей домов ухода, опрошенных дважды с интервалом в три месяца, точное совпадение ответов о повседневных предпочтениях составило в среднем 59 %, а совпадение по признаку «важно — неважно» — 82 % [123]. Это говорящие жители другой страны, но вывод переносим. Замены из карт поступают в статистику выбора и в планирование закупок (разделы 21.2, 30.4): если манную кашу не едят многие, это сигнал кухне о блюде, а не о жителях (раздел 19.8).

Основания. Наблюдение за потреблением — один из четырёх каналов воли неговорящего человека (раздел 15.3); предпочтение устанавливается серией наблюдений, а не одним эпизодом (раздел 15.6). Опекун, в том числе учреждение, обязан учитывать мнение подопечного, а при невозможности его установить — сведения о его предпочтениях (п. 3 ст. 36 ГК)[116]. Австралийский Стандарт 6 требует оценивать и регулярно переоценивать пищевые предпочтения каждого[45], регламент Онтарио — учитывать их в плане питания[27]. Формулы «независимо от когнитивного статуса» в стандарте нет (раздел 44).

Ограничение вывода. «Не ест манную» — фиксация наблюдаемого, а не диагноз. При признаках дисфагии маршрут становится клиническим, и решения принимает врач.

Вопросы для обсуждения.

1. Сколько в вашем доме таких «знаний смены», которые нигде не записаны?
2. Как отличить нелюбимое блюдо от трудного для глотания, и кто в доме вправе сделать этот вывод?

Новые источники

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-kejsy-b/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/2026-10-kejsy-b/istochniki.md). Маркеры прежней редакции и второй редакции глав раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S137	Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 9 (ч. 1, 2, 4)
S138	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ст. 34 (ч. 4, 6–8): ответственность сторон, требование об уплате неустоек
I-us_cfr_483_5	42 CFR § 483.5 (США): определения abuse и neglect для домов сестринского ухода

Учебные кейсы 17–20

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа. Они описывают типовые механизмы и не являются хроникой конкретного дома (раздел 41.5). Имена, должности и числа условны.

Кейс 17. Житель хочет есть позже установленного времени

Ситуация. Ужин в отделении подают в 17:30. Новый житель, бывший железнодорожник, сорок лет ужинал дома в восемь вечера, после смены. В половине шестого он не голоден и едва притрагивается к тарелке, а к восьми становится раздражительным, ходит по коридору и ругается с соседями. На третий день он просит сиделку: «Просто оставьте мне тарелку, я поем потом». Сиделка отвечает, что так не положено.

Проблема. Режим вступил в спор с биографией. Это одна из самых частых и одновременно самых решаемых точек трения в доме. Есть у неё и физиологическая сторона: ужин в 17:30 и завтрак в 8:30 дают ночной интервал в пятнадцать часов, что длиннее и рабочего ориентира доклада в тринадцать часов, и верхней границы американского регулятора в четырнадцать (разделы 13.4, 26.6).

Что нельзя делать. Отвечать «режим для всех один»: режим — инструмент, а не ценность. Оставлять тарелку на столе на два с половиной часа: это санитарно недопустимо, потому что готовое блюдо, требующее разогрева, нельзя держать на раздаче дольше трёх часов с момента изготовления, а реализовать его на следующий день запрещено (п. 32 СанПиН 2.3/2.4.4282-26)[9]. Делать вид, что просьбы не было.

Немедленно. Предложить одно из двух решений, оформленных по правилам. Первое — **отложенная порция**: её снимают с линии сразу при раздаче, хранят и разогревают по схеме, утверждённой заведующим производством в программе производственного контроля, и выдают в 20:00 в пределах санитарных сроков. Второе — **поздний перекус** из согласованного перечня: кефир, хлеб, фрукты, чай — на посту или в буфете отделения (раздел 13.9). Прежде чем закреплять решение, нужно проверить одно обстоятельство: если житель получает инсулин, сдвиг ужина допустим только по согласованию с врачом, потому что введённый инсулин без последующей еды — самая частая бытовая причина гипогликемии (раздел 13.12).

Справка. Ночной интервал. Ночным интервалом называют время между последним вечерним и первым утренним приёмом пищи. Шведские национальные рекомендации для учреждений ухода за пожилыми ограничивают его одиннадцатью часами[39], американские федеральные правила — четырнадцатью (шестнадцатью при питательном перекусе перед сном)[46]. Российской нормы нет; рабочий ориентир доклада — не более тринадцати часов (раздел 26.6). Сокращают интервал не переносом всех приёмов, а вечерним перекусом.

Кто принимает решение. Старшая смены — о ежедневной отложенной порции для конкретного жителя. Заведующий производством — о санитарно корректной схеме хранения и разогрева. Врач — если у жителя диабет на инсулине или иные основания, при которых время еды имеет

клиническое значение. Директор — если таких жителей много: тогда речь идёт уже о сдвиге режима или о втором окне ужина.

Документы. Карта пищевых предпочтений (приложение 2) с привычным временем ужина; пункт об отложенных порциях и ночной доступности в положении о питании (раздел 17.3); перечень продуктов позднего перекуса, согласованный с врачом; журнал выдачи.

Долгосрочное решение. Структурированная ночная доступность (раздел 13.9) и, при массовом запросе, пересмотр распорядка: сдвиг ужина на час и вечерний перекус часто решают задачу без новой сметы (раздел 26.6). Направление международной практики ясно: австралийский Стандарт 6 закрепляет право выбирать, «что, когда, где и как» человек ест и пьёт[45], а разъяснения английского регулятора к правилу 14 прямо требуют предусмотреть, чтобы люди, которые отсутствовали или спали, получили еду в другое время, и чтобы между приёмами пищи были доступны перекусы для тех, кто предпочитает «есть понемногу и часто»[52].

Основания. Санитарные правила задают кратность — не реже трёх раз в день — и диетическое питание по медицинским показаниям, но не астрономическое время ужина (п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26; до 01.09.2026 — п. 7.1.11 СанПиН 3590-20)[9]. Они же задают сроки хранения и раздачи (п. 32)[9]. Учёт привычного ритма — элемент уважительного отношения: для жителей ПНИ — часть 2 статьи 5 Закона № 3185-1[8], для всех домов — статья 9 442-ФЗ[118]. Вывод о времени ужина из этих норм — толкование, а не прямое правило.

Ограничение вывода. Отложенная порция — сервис для отдельных жителей. Когда исключение становится массовым, менять надо режим, а не плодить исключения.

Вопросы для обсуждения.

1. Каков фактический ночной интервал в вашем доме, если считать по реальному времени раздачи, а не по распорядку?
2. Кто в доме знает, у кого из жителей время еды привязано к инсулину?

Кейс 18. В отделении не хватает работников для помощи за столом

Ситуация. В отделении двенадцать жителей, которые не могут поесть без помощи; троих нужно кормить полностью. На смене — две сиделки. Формально помощь оказывается всем: тарелки расставлены одновременно, сиделки переходят от одного к другому «по ложке». Двое жителей регулярно не доедают, у одной за квартал ушло три килограмма.

Проблема. Дефицит рук — самая дорогая и самая честная проблема питания (раздел 28.3). Её не закрывают ни журналы, ни меню. Ориентир, на который опирается доклад, — регламент провинции Онтарио: один работник помогает одновременно не более чем двум полностью кормимым жителям, и еду не подают, пока помощь недоступна[27]. В отделении из кейса соотношение — один к шести. Российские рекомендуемые нормативы штатной численности предусматривают одну должность помощника по уходу на двенадцать получателей услуг групп нуждаемости III–IV в смену[205], но час еды отдельно не описывают ни они, ни региональные нормативы.

Что нельзя делать. Ускорять кормление: спешка повышает риск аспирации и каждый день унижает человека (раздел 10). Переводить всех на пюре «чтобы быстрее елось» без назначения: текстуру назначает только врач (раздел 17.3). Писать в отчётах, что помощь оказывается «в полном объёме», — такая запись превращает дефицит в зону личного риска директора (раздел 33).

Немедленно. Перестроить час еды без новых ставок (раздел 20.3). Во-первых, все руки — на обед: к столам выходит вся смена, включая тех, чья работа в это время — уборка или документы, и это оформляется распоряжением. Во-вторых, помощь по приоритету риска: первыми кормят жителей из списка дисфагического риска (раздел 10.7). В-третьих, тарелку ставят перед человеком только тогда, когда рядом есть тот, кто поможет. Для частично зависимых — порционная сервировка, нарезка заранее, адаптивная посуда, рассадка «помогающий между двумя нуждающимися». Дефицит оформляется служебной запиской директору с числами.

Справка. Сколько времени занимает помощь в еде. Американские хронометражи показывают, насколько «покармили» отличается от «помогли поесть». В контролируемом исследовании в четырёх домах сестринского ухода помощь по протоколу занимала в среднем 42 минуты на человека за приём пищи против примерно пяти минут при обычной практике; она увеличивала потребление и удерживала массу тела у жителей с риском похудения[25]. В более раннем исследовании той же группы — 38 минут против 9[210]. Это другая страна и другой контингент; норматив для российского дома из этих чисел не выводится, но порядок величин переносится.

Кто принимает решение. Директор — о перераспределении смен между отделениями и о письменном запросе учредителю (форма сообщения о дефиците — приложение 33). Старшая смены — о приоритете помощи внутри смены. Врач — о текстурах и о том, кому из жителей нужна оценка глотания.

Документы. Список дисфагического риска с подписью врача; служебная записка о дефиците; форма учёта трудозатрат на кормление (приложение 26) — замер реальных минут помощи за три типичных дня; распоряжение с правилом «все руки на час еды».

Долгосрочное решение. Замер трудозатрат по формуле приложения 26: число нуждающихся в помощи, умноженное на нормативные минуты и на число приёмов пищи, против фактических минут смены. Разница, переведённая в ставки, — честный аргумент в разговоре о штате: стоимость кормления — самая скрытая строка бюджета питания, она живёт в штатном расписании, а не в продуктовой смете (раздел 29.2)[94]. Параллельно развиваются форматы самостоятельности: адаптивная посуда, блюда, которые можно есть руками, «семейная» подача части блюд там, где позволяет поведение за столом. Волонтёры и сотрудники других служб помогают за столом только после обучения; американские правила, например, не допускают помощников с коротким курсом к жителям с нарушениями глотания (раздел 28.4)[209].

Основания. Помощь в приёме пищи — социальная услуга: примерный перечень, утверждённый постановлением Правительства № 1236, относит к социально-бытовым услугам «помощь в приёме пищи (кормление)»[130], а её объём определяется индивидуальной программой (ст. 16 442-ФЗ)[118]. Санитарные правила требуют организовать питание проживающих не реже трёх раз в день, в том числе диетическое по показаниям (п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26)[9]: организовать

питание — значит обеспечить, чтобы назначенная еда была съедена, а не только поставлена. Это толкование; для жителей ПНИ к нему добавляется ч. 2 ст. 5 Закона № 3185-1[8]. Норма 1:2 — онтарийский ориентир, а не российский норматив[27].

Ограничение вывода. Перераспределение рук и новые форматы — купирование, а не решение. Решение — штатное, и путь к нему лежит через документированный замер дефицита (кейс 21).

Вопросы для обсуждения.

1. Сколько минут на самом деле длится обед у самого медленного жителя вашего отделения?
Если меньше пятнадцати, кто его торопит (раздел 20.6)?
2. Кто ещё в доме мог бы выходить к столам в час еды, и чему его нужно обучить?

Кейс 19. Директор получает жалобу от родственника

Ситуация. На имя директора приходит письмо от сестры жителя: «Моего брата кормят одной перловкой. На фотографии из отделения — серая масса в тарелке. Требую разобраться. Копия направлена в прокуратуру». Проверка показывает: перловка была вчера и до этого — восемь дней назад; фотографию сделали месяц назад при неудачном освещении; брат ест хорошо, масса тела за полгода стабильна. Но меню действительно монотонно: две недели цикла, одни и те же гарниры, никакого выбора.

Проблема. Жалоба неточна по фактам и точна по существу. Монотонность — реальная проблема, и формальная отписка «факты не подтвердились» её не решит, а конфликт — усилит.

Что нельзя делать. Отвечать одним опровержением («перловка была один раз»): родственник прочитает это как «нам всё равно». Искать виноватого до выяснения обстоятельств. Обещать «разобраться и наказать»: жалоба не о наказании, а о еде брата.

Немедленно. Запросить факты: меню за месяц, журнал замен, данные о массе тела жителя за полгода. Позвонить заявительнице и пригласить её на обед в отделение: по опыту домов, личный визит снимает значительную часть напряжения, потому что родственник видит не фотографию, а стол. Подготовить письменный ответ по существу: что проверено, что не подтвердилось, что подтвердилось и что меняется, с датами.

Справка. Обращение гражданина и срок ответа. Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» распространяет свой порядок и на обращения, которые рассматривают государственные и муниципальные учреждения, выполняющие публично значимые функции. Он требует объективного и всестороннего рассмотрения, мер по восстановлению нарушенных прав и письменного ответа «по существу поставленных в обращении вопросов»; письменное обращение рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации[229].
Применимость закона к конкретному дому — вопрос толкования, но его требования — хороший минимальный стандарт ответа в любом случае.

Кто принимает решение. Директор лично. Жалоба с копией в прокуратуру не делегируется: прокурор, если начнёт проверку, будет спрашивать директора.

Документы. Жалоба с отметкой о регистрации; материалы проверки (меню, журналы, данные о массе тела); протокол разбора (приложение 34, срок составления — три дня); письменный ответ заявителю; при системном выводе — приказ о пилоте вариативности (раздел 35) или приглашение семьи на дегустацию совета жителей (раздел 34.7). Памятка родственникам (приложение 32) прикладывается к ответу.

Долгосрочное решение. Регламент разбора жалоб, построенный на форме приложения 34: сроки в днях, обязательный личный контакт, системный вывод одной строкой. Родственники — неоплачиваемые аудиторы качества; для них у дома должен быть свой канал — дни открытых дверей и дегустации по приглашению совета, — отдельный от совета жителей, который остаётся структурой самих жителей (раздел 34.7). Если жалоба касается качества продуктов, стоит заглянуть и в закупку: картели на торгах продуктами питания реальны и бьют прежде всего по качеству стола^[135, 136] (раздел 30.3).

Основания. Требования к рассмотрению обращения и тридцатидневный срок — статьи 10 и 12 59-ФЗ^[229]. Если прокуратура по итогам проверки внесёт представление, оно подлежит безотлагательному рассмотрению, а в течение месяца должны быть приняты меры и о них письменно сообщено прокурору (ст. 24 Закона о прокуратуре)^[227]. Поэтому разбор жалобы в дни, а не в недели, — не вежливость, а страховка (разделы 32.2, 33.6).

Ограничение вывода. Не каждая жалоба справедлива. Регламент защищает обе стороны: жителя — от плохой еды, организацию — от затяжного конфликта, в котором неточные факты подменяют точную суть.

Вопросы для обсуждения.

1. Какие три документа вы покажете родственнику, чтобы он поверил, что брата кормят разнообразно?
2. Как в ответе признать монотонность меню, не признавая «одну перловку»?

Кейс 20. Прокуратура просит показать, как учитывается мнение недееспособных жителей

Ситуация. В ходе проверки исполнения законов в ПНИ на восемьсот мест директор получает требование прокурора: «Представить документы, подтверждающие учёт мнения и предпочтений жителей, признанных недееспособными, при организации питания». Около трёх четвертей жителей недееспособны, и опекуном большинства из них является сам интернат. Ответить нечем: процедур учёта невербальной воли нет, пищевых карт нет, совет жителей существует на бумаге.

Проблема. Нет документированных процедур учёта воли недееспособных жителей, а срок ответа короткий.

Что нельзя делать. Отвечать «их интересы представляет опекун»: опекун здесь само учреждение, и конфликт интересов очевиден (раздел 16.4). Изготавливать документы задним числом: это выясняется, усугубляет положение и переводит вопрос из области «недоработки» в область имитации (раздел 17.4). Отделяться общими фразами о «заботе».

Немедленно. Собрать то, что есть честно: записи о заменах, журнал отказов, протоколы совета жителей, если в них участвовали представители недееспособных, отдельные наблюдения из медицинской документации. Если документов мало, дать честный ответ о текущем состоянии и приложить план мероприятий с датами и ответственными: формы наблюдения за невербальным выбором (приложение 6), карты пищевых предпочтений (приложение 2), анкета в доступном формате (приложение 36), положение о совете (приложение 30). Если срок, установленный требованием, недостаточен, письменно уведомить прокурора и объяснить причины.

Справка. Требование прокурора: сроки. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, «подлежат безусловному исполнению в установленный срок». Документы по требованию представляются безвозмездно в течение пяти рабочих дней, а в ходе проверки исполнения законов — в течение двух рабочих дней, если прокурор не установил более длительный срок. При невозможности уложиться организация письменно уведомляет прокурора с указанием объективных причин, и прокурор устанавливает новый срок (ст. 6 Закона о прокуратуре)^[261]. Требование не заменяет **представления**: представление вносится по итогам проверки и даёт месяц на меры (ст. 24)^[227].

Кто принимает решение. Директор — о содержании ответа. Заведующие отделениями — о сборе существующих записей за один день. Юрист учреждения или учредитель — о форме ответа и о плане мероприятий.

Документы. Ответ на требование; план мероприятий с датами и ответственными; приказ о внедрении процедур учёта воли; формулировка для положения о питании из раздела 16.5: мнение и предпочтения получателей, «в том числе признанных недееспособными», учитываются, будучи «выявленными доступным способом».

Долгосрочное решение. Полный контур раздела 15: четыре канала воли (показ, наблюдение за потреблением, пищевая биография, сведения близких), формы наблюдения, пищевые карты, протоколы совета. К нему добавляются три документальных противовеса конфликту «учреждение = опекун» (раздел 16.8): приоритет зафиксированных предпочтений над административным удобством, протокол разногласий и внешний элемент в совете. После внедрения такой запрос закрывается папкой за час (раздел 32.6).

Основания. Опекун — в том числе организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна, — обязан учитывать мнение подопечного, а при невозможности его установить — сведения о его предпочтениях (п. 3 ст. 36, п. 2 ст. 29 ГК)^[116]; возложение обязанностей опекуна на организацию — п. 4 ст. 35 ГК и ч. 5 ст. 11 48-ФЗ^[116, 117]. Статья 43 Закона № 3185-1 распространяет на всех проживающих ПНИ права, перечисленные в частях 2 и 4 статьи 37, и не делает исключения для недееспособных; право на гуманное отношение закреплено в части 2 статьи 5^[8]. Вывод «выбор еды не требует дееспособности» — системное толкование, а не прямая норма (раздел 15.2). Международные ориентиры: Конвенция о правах инвалидов^[138], Замечание общего порядка № 1 Комитета ООН о поддерживаемом принятии решений^[31] и рекомендация того же Комитета России ввести такую модель (2018)^[125]. Австралийский Стандарт 6 требует оценивать предпочтения каждого человека в еде и питье^[45], регламент Онтарио — учитывать их в плане питания^[27]; формулы «независимо от когнитивного статуса» в австралийском стандарте нет (раздел 44, исправления).

Ограничение вывода. Требование прокурора — не обвинение. Честный ответ с планом и датами почти всегда завершает сюжет. Вымученная «идеальная папка» его только начинает.

Вопросы для обсуждения.

- 1. Какие из ваших сегодняшних документов уже сейчас показывают волю недееспособного жителя, а не мнение персонала о нём?
- 2. Как сформулировать ответ, который честно признаёт пробел и не превращается в самообвинение?

Новые источники

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-kejsy-b/istochniki.md](#). Маркеры прежней редакции и второй редакции глав раскрыты в разделе 44; содержание разъяснений к правилу 14 (l-cqc14) сверено в реестре [poisk-2026-10-blok-f](#).

Маркер	Источник
S135	Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ст. 1 (ч. 4), 10, 12
S136	Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 6 «Обязательность исполнения требований прокурора» (ред. от 04.08.2026)

Учебные кейсы 21–22

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа. Они описывают типовые механизмы и не являются хроникой конкретного дома (раздел 41.5). Имена, должности и числа условны.

Кейс 21. Учредитель не выделяет средства на дополнительный персонал

Ситуация. После трёх дней замера (кейс 18, приложение 26) директор знает точную цифру: чтобы в каждом отделении у стола было не больше двух полностью кормимых на одного помогающего, не хватает трёх ставок помощников по уходу. Расчёт отправлен учредителю. Через месяц приходит ответ в две строки: «Дополнительное финансирование не предусмотрено. Решайте вопрос в рамках имеющихся ресурсов». Директор в отчаянии: без рук всё остальное — меню, журналы, выбор — кажется ему декорацией.

Проблема. Директор упёрся в предел своей компетенции: нормативы штатной численности и финансирование определяет не он. Но кейс проверяет и другое — не стал ли отказ удобным объяснением бездействия.

Что нельзя делать. Ссылаться на отказ как на индульгенцию («денег нет — ничего не можем»): часть изменений стоит минут, а не ставок. Ставить ультиматум «или дайте людей, или не мешайте»: конфронтация без данных проигрывает всегда. Скрывать дефицит дальше: молчание закрепляет статус-кво как норму, а молчаливый дефицит — зона личного риска директора (раздел 28.3).

Немедленно. Составить два списка. Список **нулевой стоимости** внедряется сразу: все руки на час еды, рассадка по степени помощи, приоритет дисфагического риска, тарелка — только под готовые руки, отложенные порции, адаптивная посуда из имеющейся, форматы самостоятельности (разделы 20.3, 28.3). Список **требуемого ресурсов** — ставки, обучение, оборудование — уходит в повторный запрос, но уже с данными: что сделано без денег и чего это не решило.

Справка. Рекомендуемые нормативы штатной численности. С 01.09.2025 действуют Правила организации деятельности организаций социального обслуживания (приказ Минтруда России № 305н), заменившие приказ № 940н. Их рекомендуемые нормативы предусматривают для стационарных организаций одну должность помощника по уходу на 30 получателей услуг групп нуждаемости I–II днём (на 60 ночью) и на 12 получателей групп III–IV круглосуточно[205]. Нормативы рекомендуемые: собственные нормативы штатной численности утверждает субъект Российской Федерации (ст. 8 442-ФЗ)[242]. Ни один из этих документов не описывает отдельно час еды, поэтому довод директора строится не на «нарушении норматива», а на замере.

Кто принимает решение. Директор — о списке нулевой стоимости, и это решение он обязан принять сам, не дожидаясь денег. Учредитель — о ставках. Повторный запрос директор делает документированным: числа, сценарии, последствия бездействия.

Документы. Форма учёта трудозатрат на кормление (приложение 26); форма сообщения учредителю о дефиците ресурсов (приложение 33) — с разделом «что сделано без ресурсов» и просьбой при отказе дать письменное подтверждение; план мер нулевой стоимости с датами; квартальная панель показателей (приложение 35) с динамикой массы тела жителей группы помощи.

Долгосрочное решение. Повторные запросы раз в квартал с обновлёнными данными замера. Ждать решения с первого запроса не стоит: письменный отказ — тоже результат, потому что он становится точкой отсчёта (раздел 38.6). Разговор с учредителем строится по скелету раздела 29.9: что сделано без денег, какой получен эффект, что стоит денег и сколько, какова цена бездействия, о чём именно просим и как отчитаемся. На отраслевом уровне доклад предлагает вводить в отчётность простые показатели питания — долю жителей, участвующих в выборе, и уровень отходов (раздел 39.2, предложение 3); показатель «минуты помощи на жителя группы помощи» мог бы встать рядом с ними, но это уже предложение по аналогии, а не текст раздела 39.

Основания. Стоимость кормления — самая скрытая строка расходов на питание: канадское руководство по лучшим практикам оценивает время помощи жителю, которому нужна поддержка за столом, до 45 минут в сутки^[94] (разделы 28.11, 29.2). Связь между числом рук и потерей веса подтверждают и зарубежные обзоры: в систематическом обзоре условий труда персонала учреждений долговременного ухода приводится результат, по которому один дополнительный житель на медсестру значимо повышал вероятность потери веса у проживающих^[207]; эти данные другой системы, и прямо на российские дома они не переносятся. Помощь в приёме пищи — социальная услуга по примерному перечню (постановление Правительства № 1236)^[130]. Для ПНИ обязанности организации по созданию условий для реализации прав проживающих определяются статьёй 39 Закона № 3185-1 и законодательством о социальном обслуживании (ч. 2 ст. 43)^[8]. Из этого следует двойная обязанность: обеспечить потребление питания имеющимися ресурсами с максимально возможным качеством и одновременно документировать дефицит. Это толкование доклада.

Ограничение вывода. «Нулевая стоимость» — честная категория организационных мер, а не обещание, что проблема рук решается без рук. Пределы списка называют учредителю прямо.

Вопросы для обсуждения.

1. Какие пункты вашего списка нулевой стоимости вы ещё не внедрили, и что мешает сделать это на этой неделе?
2. Как вы покажете учредителю цену бездействия числом, а не эмоцией?

Кейс 22. Пищеблок физически не позволяет готовить две горячие линии

Ситуация. Пищеблок в здании 1970-х годов: одна плита на четыре конфорки, один пищеварочный котёл, узкая раздача, на которую две гастрорёмкости со вторыми блюдами физически не встают. Реконструкция «в планах региона» третий год. Директор только что провёл совет жителей, где люди впервые сказали, чего хотят, и теперь повар говорит ему: «Два вторых я не потяну. Негде».

Проблема. Инфраструктурное ограничение — последнее возражение, которое остаётся, когда сняты все остальные (раздел 37). Оно реально, но не абсолютно: выбор не сводится к двум горячим линиям.

Что нельзя делать. Объявлять «вариативность нам не светит»: лестница моделей начинается гораздо ниже двух горячих линий (раздел 8.2). Готовить второй вариант заранее и держать его часами на водяной бане: готовое блюдо, требующее разогрева, нельзя держать на раздаче дольше трёх часов с момента изготовления (п. 32 СанПиН 2.3/2.4.4282-26)[9], и даже в этих пределах один свежий вариант лучше двух заветренных. Ждать реконструкции как единственного решения.

Немедленно. Перейти к форматам, которые не требуют второй горячей линии.

- **Заказ накануне.** Кухня готовит два варианта последовательно, по статистике заказа, а не параллельно: вариант Б — меньшей партией и в меньшей гастрорёмкости с пополнением (раздел 18.2). Это модель М1 в режиме предзаказа.
- **Вариативность холодных позиций.** Салаты, напитки, десерты, хлеб — на буфете или в зоне выбора; холодные блюда и напитки хранятся в охлаждаемой витрине или холодильнике, а не на раздаче (п. 32)[9]. По экономической раскладке раздела 29.4 это элемент модели М3.
- **Вариативность по дням.** Например, «вторник — рыбный день с двумя гарнирами»: два гарнира на одной конфорке проще, чем два вторых.
- **Отложенные порции и ночная доступность** (кейс 17, раздел 13.9).

Каждая новая позиция получает санитарный паспорт на одной странице: поточность, температура, маркировка, суточная проба от каждого варианта, журналы (раздел 18.9).

Справка. Заказ «как в гостинице». В больничном питании модель **room service** (заказ «в номер») устроена так: пациент выбирает блюдо по меню, а кухня готовит его к назначенному времени, а не выставляет заранее на линию. В австралийской государственной больнице после перехода на такую модель тарелочные отходы снизились с 30 до 17 %, а покрытие потребности в энергии выросло с 64 до 78 %[147]. Это короткая госпитализация, а не постоянное проживание, и данные получены одной группой авторов (раздел 29.5). Для дома важен механизм: выбор переносится из пространства раздачи во время предзаказа.

Кто принимает решение. Заведующий производством — о технологически возможном формате и о санитарном паспорте позиции. Директор — о модели: М1 в режиме предзаказа, буфетная зона холодных позиций (разделы 8.2, 29.4). Учредитель — о реконструкции как отдельной капитальной повестке.

Документы. Обоснование формата на одной странице: ограничение → формат → гарантии санитарии. Санитарный паспорт каждой новой позиции (раздел 18.9). Журнал заказа (приложение 7). Должностные инструкции тех, кто раздаёт в отделениях: санитарные правила запрещают привлекать к порционированию и раздаче персонал, в обязанности которого это не входит (п. 32)[9]. Переписка с учредителем о реконструкции.

Долгосрочное решение. Капитальная повестка оформляется отдельным документом: стоимость второй линии или нового оборудования против ожидаемого эффекта, подтверждённого собственным замером отходов (приложение 25). Опорой для разговора об оборудовании может

служить и то, что приказ Минтруда № 305н, по своему названию, утверждает не только нормативы штатной численности, но и рекомендуемый перечень оборудования организаций социального обслуживания[205]; соответствие пищеблока этому перечню доклад не проверял. Если реконструкции нет, максимум выбора в имеющемся контуре становится постоянной моделью, а не «временной ущербностью». Отдельный путь — аутсорсинг (раздел 42).

Основания. Санитарные правила регулируют безопасность, кратность и сроки, а не число линий раздачи: ни СанПиН 3590-20, ни действующий с 01.09.2026 СанПиН 4282-26 не ограничивают число вариантов блюда[9] (раздел 18.1). Международные стандарты больничного питания[254] и исследования заказного питания[147, 201] показывают, что выбор строится прежде всего на предзаказе и организации, а не только на площадях. Перенос больничных данных на дома постоянного проживания — гипотеза, а не вывод.

Ограничение вывода. Предзаказ переносит выбор с линии на канун. Это другой ритм для смен, и он требует своего инструктажа (раздел 28.10), а не только решения кухни.

Вопросы для обсуждения.

1. Какие позиции вашего меню можно сделать вариативными, не трогая плиту?
2. Что потребует от смены переход на заказ накануне, и кто будет показывать меню неговорящим жителям?

Как пользоваться кейсами на семинаре и в обучении

Каждый кейс рассчитан на пятнадцать минут и разбирается по одной схеме. Ведущий зачитывает только ситуацию. Группа отвечает по восьми пунктам — проблема, что нельзя делать, что сделать немедленно, кто принимает решение, какие нужны документы, каково долгосрочное решение, на чём оно основано и где его граница, — а затем сверяется с текстом. Вопросы для обсуждения в конце каждого кейса помогают перенести разбор на собственный дом.

Ценность упражнения — в расхождении. Если группа предлагает то, чего в кейсе нет, это повод дополнить локальный комплект документов, а не «исправить ошибку». Кейсы можно адаптировать под свою организацию — детскую или взрослую, большую или малую, под региональные нормы, — сохранив структуру из восьми пунктов. Для инструктажа персонала кейсы полезнее лекции о правах: смену убеждают ясные ответы на вопрос «а что мне делать, если...», а не декларации (раздел 28.9). Поэтому кейсы 1–22 составляют ядро трёх инструктажей раздела 28.10 и материал для разбора трудных ситуаций без поиска виноватых (раздел 28.8).

При использовании кейсов после 09.10.2026 правовые ссылки сверяются заново: нормы, особенно региональные и учётные, меняются (раздел 41.5).

Новые источники

Новых маркеров в этом файле нет. Использованные маркеры второй редакции (S100, S121, S071, M-staff_perruchoud, M-room_service_mccray, M-waste_rinninella) раскрыты в разделе 44.4; расхождения этого файла с первой редакцией записаны в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-kejsy-b/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/poisk-2026-10-kejsy-b/istochniki.md).

Маркер	Источник
—	Новых источников нет

ЧАСТЬ 10

Приложения-шаблоны

приложения 1–45

Приложения 1–6

Единый дисклеймер для всех приложений (на каждом шаблоне): «Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации под региональное законодательство, учётную политику, структуру учреждения, медицинскую лицензию и требования учредителя».

Каждому бланку предпослана короткая вводная: назначение, кто и как часто заполняет, на какой раздел второй редакции он опирается. Класс всех форм — **проект локальной формы** (раздел 41): дом вправе менять графы, но не выдавать бланк за норму. С 01.09.2026 санитарные ссылки в формах даются на СанПиН 2.3/2.4.4282-26; переходного периода нет, а журналы, заполненные до 31.08.2026 по СанПиН 3590-20, не переписываются (раздел 18.10)[9].

Сведения о здоровье в приложениях 2, 3, 6 — персональные данные специальной категории: основание обработки — ч. 2 ст. 10 закона № 152-ФЗ, кухня видит ограничения, но не диагноз (раздел 17.6)[132].

Порядок внедрения приложений: приоритеты по срокам

Срок	Приложения	Назначение
Первая неделя	25 (замер отходов), 9 (журнал отказов), 21 (медицинский контур и лекарственно-пищевая таблица), 12 (алгоритм при риске аспирации и удушья), 39 (перепривязка к СанПиН 4282-26)	Базовые измерения и безопасность
Первый месяц	7 (журнал заказа), 8 (журнал срывов), 2 (карта предпочтений), 37 (пищевой паспорт при поступлении), 28 (приказ о пилоте), 29 (положение)	Документальный каркас пилота
Первый квартал	3 (пищевая биография), 6 (наблюдение невербальных), 17 (матрица ролей), 30 (совет жителей), 35 (панель чисел)	Системное закрепление
По мере необходимости	Остальные приложения	Специфические ситуации

Формы — проекты. Под регион и учредителя их адаптируют обязательно.

Приложение 1. Чек-лист готовности учреждения

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Директор, заведующий производством и врач проверяют до старта пилота (раздел 35.2) и перед расширением на новые отделения, есть ли у вариативности опора в праве, клинике, на кухне и в людях. «Нет» — не запрет, а строка плана с ответственным и сроком. Опора: разделы 10, 11, 12, 17, 18, 24, 28, 31.

Право и документы

1. Статус норм питания в регионе выяснен (рекомендация / императив); региональный акт назван в положении о питании (п. 15 Правил, приказ Минтруда № 305н; раздел 31.2)[205] — ☐ да ☐ нет

2. Региональное меню изучено; процедура его изменения и таблица замен известны — ☐ да ☐ нет
3. Согласование учредителя на пилот получено письменно — ☐ да ☐ нет
4. Приказ о пилоте подписан, ответственные названы по фамилиям — ☐ да ☐ нет
5. Основание обработки сведений о здоровье в картах определено, круг доступа записан (раздел 17.6) — ☐ да ☐ нет

Клиника 6. Лекарственно-пищевая таблица подписана врачом и висит на кухне и на посту (раздел 11) — ☐ да ☐ нет 7. Список жителей с риском дисфагии актуален; назначенные текстуры указаны по уровням IDDSI с датой пересмотра; смена знает признаки (раздел 10.4, 10.7) — ☐ да ☐ нет 8. Алгоритм при удушье (приложение 12) отработан на занятии; в часы еды на посту двое обученных сотрудников — ☐ да ☐ нет 9. Правило «три отказа подряд — врач в тот же день; отказ от воды — немедленно» доведено до всех смен (раздел 12.3) — ☐ да ☐ нет 10. При переводе, госпитализации и пересменке дисфагический риск и текстура передаются письменно (раздел 10.7, п. 7) — ☐ да ☐ нет

Кухня и линия 11. Пары эквивалентов на первую неделю рассчитаны и согласованы (раздел 19) — ☐ да ☐ нет 12. Санитарный паспорт второй позиции оформлен по СанПиН 4282-26: температура, маркировка, проба от каждого варианта (раздел 18.9) — ☐ да ☐ нет 13. Программа производственного контроля перепривязана к СанПиН 4282-26 (раздел 18.10, приложение 39) — ☐ да ☐ нет 14. Раздача и порционирование записаны в должностных инструкциях тех, кто их фактически ведёт (п. 32 СанПиН 4282-26, раздел 18.2) — ☐ да ☐ нет 15. Журналы заказа, замен, срывов выбора заведены — ☐ да ☐ нет

Люди 16. Инструктаж смены раздачи проведён: показ меню, роли, замены, невербальный выбор (раздел 28.10) — ☐ да ☐ нет 17. Число кормимых на одного работника в часы еды посчитано по факту, а не по штатному расписанию (раздел 28.3) — ☐ да ☐ нет 18. Жители и близкие информированы; сбор предпочтений начат; регламент передач доведён (раздел 18.8) — ☐ да ☐ нет

Ответов «нет»: ____ План закрытия (пункт — ответственный — срок) — на обороте.

Дата: _____ Подписи: директор _____ зав. производством _____ врач _____

Приложение 2. Карта пищевых предпочтений жителя

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Назначение. Главный рабочий документ выбора. Заводится на каждого жителя, при поступлении — по пищевому паспорту (приложение 37). Заполняют пост и диетсестра, клинические строки — только врач. Пересмотр раз в квартал, после госпитализации, смены лекарственной схемы и эпизода поперхивания. Кухня получает выписку ограничений без диагнозов. Опора: разделы 9.6, 10.10, 11, 14.1, 15.3–15.4, 15.9–15.10.

Графа «Источник» указывается в каждой строке: Ж — сам житель, Н — наблюдение (серия записей, приложение 6), Б — близкие или опекун, В — врач. При расхождении решает уровень источника, а не статус спорящего; порядок уровней закрепляет положение о питании (в докладе два порядка — разделы 15.4 и 15.9). Сведения близких и опекуна — данные о предпочтениях, которые опекун обязан учитывать (п. 3 ст. 36 ГК, раздел 16.2), а не решение за жителя.

ФИО или код жителя: _____ Отделение: _____ Дееспособен: ☐ да ☐ нет ☐ ограниченно

Поле	Содержание	Источник
Любимые блюда		
«Безопасные» блюда (едят всегда, держать в каждом приёме)		
Не ест (наблюдаемое: серия записей, не одно впечатление)		Н
Не ест (заявляет сам)		Ж
Ограничения по убеждению или вере; соблюдает ли посты		Ж / Б
Сенсорные особенности и ритуалы (цвет, температура, своя посуда, порядок блюд)		
Текстура пищи и уровень загущения напитков по IDDSI (если назначены); дата пересмотра		В
Дисфагический риск: ☐ нет ☐ есть — дата скрининга, способ		В
Назначенная диета / ограничения		В
Лекарственные ограничения (из таблицы, раздел 11)		В
Аллергии, непереносимости		В
Полость рта: свои зубы / протезы; болит ли жевать; сухость во рту		Н / В
Помощь за столом (нет / частичная / полная); кто помогает		Н
Поведенческие риски за столом (быстрое заглатывание, отбирание, пикацизм) — отметка обязательна		Н / В
Привычное время еды, ритуалы, ночной перекус		
Напитки: что пьёт, что нет; объём за сутки (если ведётся учёт)		
Канал выбора (речь / показ порций / карточки / наблюдение за съеденным)		
При ухудшении состояния: что происходит с едой		Н / В
При ухудшении: что помогало раньше (формат, продукты, люди)		Н / Б
Кто переводит на режим обострения и обратно	врач	В

Дата заполнения: _____ Заполнил: _____ Дата пересмотра: _____ Выписка для кухни передана: _____

Приложение 3. Пищевая биография

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Назначение. Биография сохраняет волю человека, высказанную в период ясности, на то время, когда ясности станет меньше (раздел 15.3, канал 3). Заполняется при поступлении или для уже живущих — в «хороший день», со слов жителя, близких и давних работников. Не анкета, а

разговор по темам. Пересмотр раз в год: большинство предпочтений устойчиво, но заметная доля за три месяца меняется (раздел 15.6)[123]. Опора: разделы 9.2, 15.3, 15.10.

Темы разговора:

1. Где и как ел всю жизнь: дома, в семье, один, в учреждениях?
2. Что готовил сам? Что готовили для него?
3. Еда праздника и еда будня — что это было?
4. Что никогда не ел и почему (если помнит или говорит)?
5. Есть ли пища, которую не ест по убеждению или вере? Соблюдает ли посты (раздел 15.10)?
6. Кто в его жизни «знает, как он ест» — имя, контакт, степень близости?
7. Что из еды связано с тяжёлыми периодами (голод, стационары, ограничения)? Не прячет ли еду «про запас» (раздел 9.2)?
8. Болит ли жевать, мешает ли что-то во рту, удобны ли протезы?
9. Три блюда, без которых «всё не то».

Свободная запись, 5–15 предложений; указать, чьи слова записаны.

Выдержки — в карту предпочтений (приложение 2) с пометкой источника. Хранить в отделении; смена читает.

Записал: _____ Дата: _____ Присутствовали: _____

Приложение 4. Простая форма выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Выбор записывается при показе меню, вечером накануне или утром; ведёт сиделка или старшая смены, итог уходит в журнал заказа (приложение 7). Лежачим порции или карточки показывают в комнате (раздел 20.11). Опора: разделы 15.5, 19.4, 21.2.

Дата: _____ Приём пищи: ☐ обед ☐ ужин Отделение: _____

№	Житель (фамилия или код)	Как выбирал (речь / показ / карточки / по карте)	Вариант А	Вариант Б	Стандартный	Текстура или ограничение из карты (отметка)	Подача: зал / поднос	Подпись или отметка смены
1			☐	☐	☐			
2			☐	☐	☐			
3			☐	☐	☐			

Выбор — при жителе. «Стандартный» — если не выбрал: нормальный итог, не сбой. Без реакции неговорящий получает вариант по карте, а не «первый по очереди» (раздел 15.5). При дисфагии оба варианта — в назначенной консистенции (раздел 10.10). Лист передаётся на кухню до ____ часов.

Приложение 5. Визуальное меню

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Назначение. Не бланк, а спецификация изготовления — для тех, кому вербальный выбор непосилен (раздел 15.3, канал 1). С визуальной опорой люди с деменцией чувствуют себя вовлечённые в решения; это малое исследование вне учреждений — довод, а не доказательство (раздел 15.6)[122].

Требования к изготовлению:

- формат: лист А4 или А3 на день; в столовой, на посту, у кровати лежащих;
- каждая позиция — фотография реальной порции из собственной кухни, а не стоковая картинка: жители должны узнавать свою еду;
- подписи крупным шрифтом, от 24 пт; без кулинарных терминов («биточек», а не «биточек паровой по-дунайски»);
- варианты выбора расположены рядом, в одинаковом масштабе и визуально сопоставимы; расположение время от времени меняется (позиционный эффект, раздел 15.7);
- позиции изменённой текстуры фотографируются отдельно: житель на протёртом видит свои два варианта;
- постные позиции отмечаются знаком, понятным без чтения (раздел 15.11);
- фотографии обновляются при смене цикла меню; ламинация — для санитарной обработки;
- для жителей со слабым зрением устное дублирование при показе обязательно.

Ответственный за изготовление и обновление: _____ (фамилия в приказе). Дата последнего обновления: _____

Приложение 6. Форма наблюдения за невербальным выбором

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Назначение. Запись выбора человека, который не говорит его словами; ведёт смена при показе, 2–3 минуты. Предпочтение устанавливается по серии записей, поэтому в карту вывод идёт после подтверждающего наблюдения. До начала — упражнения раздела 15.7. Опора: разделы 15.5–15.8.

Справка. Позиционный эффект. Склонность выбирать по месту (справа, ближе, первым), а не по содержанию. Чтобы её отличить, порции в разные дни меняют местами — пункт 3 формы (раздел 15.7).

Дата: _____ Житель (код): _____ Приём пищи: _____ Состояние (бодр / сонлив / возбуждён): _____

1. Что было предъявлено (карточки / реальные порции / визуальное меню): _____ Слева: _____
Справа: _____

2. Реакция: показал рукой ☐ взгляд задержался ☐ потянулся ☐ взял ☐ отвернулся ☐ оттолкнул ☐
без реакции ☐

3. Проверка позиции (порции поменяны местами): реакция повторилась на то же блюдо ☐ на ту же сторону ☐ не проверялось ☐

4. Ел предъявленное: полностью ☐ около половины ☐ меньше четверти ☐ не ел ☐

5. Что могло исказить наблюдение (сонливость, боль, остывшее блюдо): _____

6. Предварительный вывод для карты предпочтений: _____

Подпись: _____

Подтверждающее наблюдение (через 1–2 недели, тем же способом): дата _____ вывод совпал ☐
уточнён ☐ не подтвердился ☐ Внесено в карту (приложение 2), дата: _____

Новые источники

Новых источников в этом файле нет. Использованы маркеры второй редакции: S003, S070, S100, M-pref_abbott, M-talkingmats_murphy (раздел 44).

Приложения 7–12

Приложение 7. Форма предварительного заказа (журнал заказа)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Оперативный регистр выбора: вчерашний заказ задаёт сегодняшнюю варку (разделы 19.4, 21.2). Ведёт отделение по итогам показа (приложение 4); итог — на кухню до часа, который ставит дом.

Дата подачи: _____ Меню на (дата): _____ Отделение: _____

Позиция	Вариант А (заказов)	Вариант Б (заказов)	Стандартный (заказов)	В т. ч. на подносе в комнату	Итого порций
Первое					
Второе					
Гарнир					
Салат					
Напиток					

Особые порции по картам (текстура и уровень IDDSI, диета, ограничения по убеждению — без диагнозов; раздел 17.6):

Особая порция	Вариант А	Вариант Б	Стандартный
Текстура: уровень ____			
Текстура: уровень ____			
Диета по назначению: _____			
Постное / по убеждению			

Итоги передал: _____ Принял на кухне: _____ Время: _____

Ежемесячно итоги сводятся в статистику выбора: доли А и Б, лидеры остатков (с приложением 25), доля «выбрал Б — не получил Б» (приложение 8). По ним пересчитывают объёмы и цикл (разделы 21.3, 21.9) — по месячным данным, а не по одному обеду.

Приложение 8. Журнал срывов выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Учёт случаев, когда заявленный выбор не выдали, — главного признака фиктивной вариативности (раздел 21.4). Ведёт кухня или линия в день срыва; разбор — на еженедельной планёрке.

Дата	Приём пищи	Позиция и вариант	Что случилось (закончилось / не привезли / не приготовили / перепутали варианты)	Сколько жителей заказали, сколько не получили	Чем заменили	Подпись

Три срыва одной позиции — пересчитать объёмы или сменить пару (раздел 21.3). Перепутанные порции разной текстуры — не срыв, а клинический инцидент: врач и приложение 34 (раздел 18.2). Итог месяца — строка 10 панели (раздел 22.4).

Приложение 9. Журнал отказов от еды

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Назначение. Клинический журнал, а не учёт «нарушений режима»: он отличает отказ от блюда (выбор) от отказа от еды (возможный симптом) по записи, а не по интуиции (раздел 12). Пишут каждый отказ от приёма целиком или большей его части и отказ от питья. Ведёт смена; врач читает еженедельно.

Дата, время	Житель (код)	Приём пищи	Сколько съедено (всё / ½ / ¼ / не ел)	Пили ли (да / мало / нет)	Обстоятельства (слова жителя, настроение, контекст)	Особые сигналы (см. ниже)	Что предложено взамен	Принял замену?	Кому и когда сообщено	Подпись

Особые сигналы (вписать букву): **О** — «отравлено», бредовая мотивировка; **Г** — боль или кашель при глотании, поперхивание; **Р** — рвота, резкая слабость; **Ж** — болит жевать, мешают протезы; **Л** — отказ совпал со сменой лекарств.

Правило эскалации (рамкой в журнале) — проект локального правила по канадскому ориентиру (рекомендации диетологов Канады, не регламент Онтарио), не российская норма (раздел 12.3)^[94]:

- три отказа подряд у одного жителя — врач в тот же день;
- системное оставление 25 % порции и больше в течение недели — врач и пересмотр карты в течение двух дней;
- отказ от воды или одновременно от еды и воды — врач немедленно (особенно при приёме лития, раздел 11.3)^[86];
- сигналы О, Г, Р — врач при первом эпизоде;
- сигнал Ж — врач или стоматологический маршрут (раздел 12.2)^[81].

Эпизод закрывается записью врача: что установлено, что назначено, когда пересмотр.

Приложение 10. Алгоритм при отказе от блюда

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Назначение. Действия смены, когда житель не хочет конкретное блюдо. Это выбор; задача — дать альтернативу в тот же приём. В США это прямая норма[46], в России — толкование (раздел 31.2).

1. **Спокойно принять.** Сказать: «Хорошо, это уберу. Есть ещё __, принести?» — без «почему» и без оценки. «А кто теперь будет доедать» — запрещено.
2. **Предложить замену** из того, что есть: второй вариант линии или стандартная замена (хлеб, кисломолочное, фрукты по сезону — перечень утверждён заранее). Замена — в пределах текстуры и лекарственно-пищевой таблицы (разделы 10.5, 11).
3. **Спросить одно:** «Не болит ли жевать, не мешает ли что-то во рту?» Если да — сигнал Ж журнала отказов (раздел 12.2).
4. **Записать** в журнал заказа или замен: житель, блюдо, замена.
5. **При повторении** (тот же житель, то же блюдо, три раза) — запись в карту предпочтений: «не ест __ (наблюдение)».
6. **Если отказ захватывает** большую часть приёма — перейти к приложению 11.

Запрещено: давить уговорами, ставить условия («съешь — получишь»), наказывать отказом в любой форме.

Приложение 11. Алгоритм при отказе от еды

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Эскалация при отказе от приёма пищи целиком. За «не буду» стоят разные причины — от остывшего супа до депрессии, дисфагии или опухоли, — и различает их врач, если ему вовремя сообщили (разделы 12.1–12.3)[93].

1. **Первый отказ.** Сказать: «Не будете сейчас — оставлю, скажете, когда захотите». Спросить почему, предложить замену и формат: позже, в другом месте, с помощью. Запись в журнал отказов (приложение 9).
2. **Второй отказ подряд.** Старшая смены идёт сама в течение часа: нет ли жалоб, температуры, боли при глотании, конфликта за столом, перемен в режиме или в назначениях. Запись.
3. **Третий отказ подряд — врач в тот же день.** Не «на обходе в четверг»; без дежурного — по телефону, решение записать тем же вечером.
4. **Врач при первом эпизоде:** бредовая мотивировка («отравлено»), боль при глотании, рвота или резкая слабость, отказ от воды. При «отравлено» — не спорить, предложить заводскую упаковку (раздел 12.8).
5. **Системное недоедание** (оставляет 25 % порции и больше в течение недели) — врач и пересмотр карты в течение двух дней.
6. **До решения врача:** питьё и лёгкие форматы (кисломолочное, суп), отложенная порция. Учитывать выпитое; взвешивание — по назначению.
7. **Паллиативный статус** определяет врач. Цель в конце жизни — комфорт: любимая еда, бережное кормление с рук (раздел 12.11).

8. Категорически запрещено: принудительное кормление в любой форме, шантаж едой, публичное давление. Основание — право на гуманное отношение (ч. 2 ст. 5 Закона РФ № 3185-1; раздел 12.4)[8]. Искусственное питание — медицинское вмешательство, решение врача (ст. 20 закона № 323-ФЗ)[95].

Все шаги — в журнале отказов (приложение 9).

Приложение 12. Алгоритм при риске аспирации и удушья

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Профилактика и действия при поперхивании и удушье; смертность от удушья при шизофрении многократно выше популяционной (раздел 10.2)[16]. Лист висит на посту и в столовой; навык отрабатывается на занятии. Текстуры и загущение назначает врач.

Профилактика (ежедневно):

- жители из списка дисфагического риска едят в поле зрения обученной смены; в часы приёма пищи на посту минимум двое обученных сотрудников;
- текстура и загущение строго по назначению (IDDSI); перед выдачей повар проверяет пищу вилкой и ложкой, напитки — тестом на текучесть (10 секунд из шприца)[65];
- поза: сидя вертикально, около 90°, подбородок слегка опущен; после еды — не менее 30 минут без укладывания[61];
- темп: маленькие порции, паузы, без спешки;
- не кормить того, кто не проснулся: при сонливости после ночных препаратов порция откладывается[54];
- таблетки — по тем же правилам: бодрствуя и сидя; если таблетку нельзя проглотить целиком, форму лекарства определяет врач[55];
- уход за полостью рта и протезами по графику, а не «по запросу» (раздел 10.8).

Опасные продукты для группы риска — только в форме назначенного уровня IDDSI (раздел 10.7):

Продукт	Почему опасен	☐ учтён в меню группы
Хлеб, сдоба	слипается в плотный комок; во всех случаях японской серии удушья — хлеб[60]	☐
Сухое и рассыпчатое (печенье, сухари, крупка)	рассыпается во рту, частицы аспирируются	☐
Крупные куски мяса	не измельчаются без зубов и при быстрой еде	☐
Смешанная консистенция (суп с кусочками, фрукты с соком)	жидкость и плотная часть требуют разного глотка	☐

При поперхивании, когда человек кашляет и дышит (лёгкая обструкция):

- 1. Остановить еду. Поощрять кашель: эффективный кашель — лучший способ освободить дыхательные пути. Пока кашель эффективен, по спине не бить: удары нужны, только когда кашель слабеет[74].
- 2. Записать эпизод, сообщить старшей смены. Повтор за неделю — врач вне очереди: пересмотр текстуры (раздел 10.4).

При тяжёлом эпизоде (не может кашлять, говорить, дышать; синеет):

- 1. Позвать на помощь; медперсонал и врач — сразу; скорая — 103 или 112.
- 2. Если человек в сознании, обученный сотрудник проводит удаление инородного тела по алгоритму, которому его учили: до пяти ударов между лопатками, затем до пяти толчков в верхнюю часть живота, повторять до восстановления дыхания[74]. Это мероприятие первой помощи[75], которое вправе оказывать работник с подготовкой[262].
- 3. Если человек потерял сознание — уложить, вызвать скорую (если ещё не вызвана), начать сердечно-лёгочную реанимацию[74].
- 4. После эпизода — врачебный осмотр в тот же день: возможна отсроченная аспирационная пневмония.
- 5. Протокол разбора инцидента (приложение 34) — за 3 дня.

Передача сведений. Дисфагический риск и назначенная текстура указываются письменно при пересменке, переводе в другое отделение, госпитализации и выписке; при поступлении — скрининг глотания и отметка в пищевом паспорте (приложение 37)[55].

Обучение приёмам первой помощи: дата последнего занятия _____ Обучены (фамилии): _____

Документы: список риска и текстуры — приложение 21 (медицинский контур); основания — раздел 10.

Новые источники

Полные записи — в реестре <raw/sources/poisk-2026-10-pril-a/istochniki.md>. Остальные маркеры раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S140	Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи» (зарег. Минюстом 31.05.2024 № 78363; с 01.09.2024; заменил приказ № 477н)
S141	Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ, ст. 31 «Первая помощь» (по разъяснению МЧС России)
I-rcuk_choking	Resuscitation Council UK. Adult choking algorithm, 2025 (Совет по реанимации Великобритании: алгоритм помощи взрослому при удушье)

Приложения 13–18

Приложение 13. Алгоритм при быстром заглатывании

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Действия смены при тахифагии — еда почти без пережёвывания, крупными глотками. Это описание поведения, а не диагноз, но механика риска та же, что при дисфагии: непрожёванный кусок перекрывает дыхательные пути (разделы 9.2, 14.1). Импульсивную или быструю еду австралийское ведомство здравоохранения прямо называет фактором риска удушья у психиатрических пациентов[55]. Опора: разделы 9.2, 10.7, кейс 8.

1. **Распознать:** ест заметно быстрее остальных, не прожёвывает, набирает полный рот, были поперхивания; отметить в карте предпочтений (приложение 2).
2. **Сервировка без назначения врача:** порция меньше и добавка; куски мельче (это сервировка, а не смена текстуры); без крупных сухих кусков и хлеба большими ломтями; напиток под рукой; стол — в числе первых (снимает мотив «успеть»).
3. **Наблюдение:** место рядом с сотрудником, в поле зрения смены; человек бодрствует и сидит вертикально; поперхивания — в форму наблюдения.
4. **Эскалация:** любое поперхивание с кашлем — врач вне очереди (скрининг дисфагии; текстура по IDDSI — при подтверждении). Тяжёлый эпизод — приложение 12.
5. **Запрещено:** «ешь медленнее» как единственная мера; отбирание еды за темп; самовольный перевод на пюре — текстуру назначает врач (раздел 10.5).
6. **Документы:** форма наблюдения, запись врача; при назначении — обновить карту и список риска (приложение 21).

Приложение 14. Алгоритм при пикацизме

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Протокол «среда — наблюдение — запись — эскалация» для жителей, которые едят несъедобное (раздел 14.2). Пикацизм нередок: в канадском обследовании взрослых с интеллектуальной недостаточностью в учреждениях — около каждого пятого; чаще у тех, кто общается невербально (раздел 14.4)[113]. Запись о пикацизме в карте обязательна, как об аллергии. Опора: разделы 14.1–14.7.

Справка. Пикацизм — устойчивое поедание несъедобного: бумаги, ткани, земли, мела, мыла, предметов. У взрослых жителей ПНИ это обычно поведение в рамках основного расстройства, а не отдельный диагноз (раздел 14)[112].

1. **Среда — сначала.** Осмотреть зону жителя и столовую: убрать мелкое, острое, токсичное, оторванные детали одежды и мебели. Моющие средства и лекарства — под замком и на учёте.

В буфете — ничего несъедобного: ни муляжей, ни упаковочного материала (раздел 14.6).

2. **Наблюдение.** Знать окна риска: скука, бесструктурное время, особенно после еды. Занятие и присутствие сотрудника рядом действуют сильнее надзора. Писать: что, когда, где, что предшествовало.
3. **Замещение.** Безопасные жевательные альтернативы и перекусы по расписанию — по согласованию с врачом; регулярные перекусы снижают «поисковое» поведение у части жителей (разделы 13.9, 14.7).
4. **Врач — при первом выявленном эпизоде:** нужна клиническая оценка, включая соматические причины. Пикацизм связан с анемией и низким уровнем цинка, хотя направление связи неизвестно (раздел 14.4)[114].
5. **Опасное проглатывание** (острый или длинный предмет, батарейка, бытовая химия, чужие лекарства) — скорая сразу. Любой другой проглоченный предмет — врач в тот же день; стул, температуру, боли в животе отслеживать по назначению. Боль, рвота, задержка стула — скорая (раздел 14.5).
6. **Протокол разбора** (приложение 34). Вопрос разбора — «как предмет оказался доступен», а не «кто недосмотрел».
7. **Запрещено:** связывать, запирасть, лишать еды, кормить отдельно «в наказание» (раздел 14.3).

Осмотр среды (раз в неделю, старшая смены):

Дата	Зона	Найдено и убрано	Подпись

Приложение 15. Алгоритм при конфликте за столом

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Действия смены, когда жители ссорятся, отбирают еду или толкаются. Причины — лекарственная гиперфагия, пережитый голод, рассадка, дефицит любимых позиций (разделы 13, 14.1); у каждой своё решение. Еда не становится инструментом наказания. Опора: разделы 14.1, 14.3, 20, кейс 7.

1. **Прервать эскалацию, не наказывая едой.** Спокойный голос. Развести за разные столы. Еда обоих — целиком.
2. **Пострадавшему** (отобрали, толкнули) — порцию восстановить всегда, приём закончить спокойно. Его не делают виноватым.
3. **Запись в день события:** участники, что произошло, меры.
4. **Разбор на планёрке.** Рассадка, конкретная пара, дефицит любимых позиций, гиперфагия одного из участников. Отбирающего не сажают рядом с медленно едящими жителями из группы дисфагического риска (раздел 14.1).
5. **Повтор одной пары** — постоянная рассадка (документ отделения). Врачу — о пищевом поведении инициатора; масса тела отслеживается у обоих.

6. **Запрещено:** лишать еды, десерта или питья как наказание; выносить из столовой без еды; отчитывать при всех (раздел 14.3).

Приложение 16. Алгоритм при пищевом инциденте

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Порядок действий при массовом недомогании, подозрении на отравление, постороннем предмете в блюде, выдаче с нарушением температуры. Для пожилых жителей пищевая инфекция — вопрос не жалоб, а здоровья: в обзоре 75 вспышек в учреждениях долговременного ухода более половины бактериальных вспышек передавались с пищей, были и смертельные исходы (раздел 18.4)[140]. Санитарная опора с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26[9]. Опора: разделы 18, 33.

1. **Остановить выдачу** подозрительной позиции сразу. Остатки и суточную пробу сохранить, не выбрасывать. Проба хранится не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд при +2...+6 °С, отдельно по каждому блюду и каждому варианту (подп. 4 п. 56 СанПиН 4282-26; раздел 18.7)[9]. Если пробы нужного варианта нет — записать это, а не «досоздавать».
2. **Медицина.** Осмотреть пострадавших. Массовый характер — врач. Тяжёлые симптомы — скорая.
3. **Факты, не версии.** Что готовилось, когда, из чего, какой вариант (А / Б), кто ел. Писать по горячим следам, не согласовывая рассказы.
4. **Уведомления:** руководитель, учредитель. При подозрении на инфекционную болезнь или пищевое отравление медицинский работник передаёт сведения в территориальный орган Роспотребнадзора по форме экстренного извещения № 058/у в установленные сроки[263]. Сроки и порядок сверить с эпидемиологом и записать в программу производственного контроля.
5. **Протокол разбора** (приложение 34) за 3 дня: причина, звено, корректирующее действие, срок, ответственный.
6. **Запрещено:** уничтожать остатки и пробы; «тихо» снимать позицию без записей; переписывать журналы задним числом; искать виноватого до фактов.

Типичный состав по такому делу — ст. 6.6 КоАП РФ (раздел 18.3)[139]; лучшая защита директора — работающая и задокументированная система контроля (раздел 33.5).

Приложение 17. Матрица ролей RACI по питанию

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Кто что делает и кто за что отвечает. Без фамилий и ролей комплект документов не работает (раздел 31.4). Матрица заполняется под свою структуру, утверждается приказом и пересматривается при смене штата. Клинические строки отвечают правилу «клинику кухни не назначает»: А в них — врач (раздел 33.5). Опора: разделы 28.2, 31, 33.

Справка. RACI. R — исполняет; A — отвечает за результат (у процесса один A); C — консультирует до решения; I — информируется после решения.

Процесс	Директор	Зав. производством	Врач	Старшая смены	Сиделка	Бухгалтерия	Совет жителей
Положение о питании	A	C	C	I	I	I	C
Меню с вариантами, пары эквивалентов	A	R	C	I	I	I	C
Санитарный контур: пробы, бракераж, температура (СанПиН 4282-26)	A	R	C	I	—	—	—
Показ меню, сбор выбора	I	I	I	A	R	—	I
Карта предпочтений, пищевая биография	I	C	C	A	R	—	—
Лекарственно-пищевая таблица	I	I	A/R	C	I	—	—
Список дисфагического риска, текстуры	I	I	A	R	R	—	—
Передача сведений о дисфагии при переводе и госпитализации	I	—	A	R	I	—	—
Обучение первой помощи при удушье	A	I	R	C	I	—	—
Журналы (заказ, замены, отказы, срывы)	I	C	I	A	R	I	—
Эскалация отказов к врачу	I	—	A	R	R	—	—
Регламент буфета и передач	A	R	C	R	I	—	C
Разбор инцидентов (приложение 34)	A	R	R	R	I	—	I
Списание продуктов	A	C	—	I	—	R	—
Закупки, претензии	A	C	—	—	—	R	—
Совет жителей	I	C	C	C	—	—	A/R
Панель чисел, отчёт учредителю	A/R	C	C	C	—	C	I

Утверждено приказом № ____ от ____

Приложение 18. Чек-лист директора (ежемесячный)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Назначение. Ежемесячная самопроверка: работает ли система на деле, а не на бумаге. Директор отвечает за систему контроля, а не за каждое событие за столом, и этот лист — доказательство того, что контроль фактический (разделы 18.5, 33.5). Не заменяет еженедельного обхода пищеблока (приложение 19). Опора: разделы 12, 18, 22, 28, 33, 34.

1. Обошёл столовую в часы основного приёма пищи лично; видел, есть ли на линии вариант Б — ☐

2. Просмотрел журналы: заказ, замены, отказы, срывы — записи ведутся по существу, а не для галочки — ☐
3. Отказы: эскалация к врачу проходила в срок (три отказа — в тот же день) — ☐
4. Список дисфагического риска и текстуры пересмотрены по графику; выборочная проверка текстур на тарелках проведена (раздел 22.4, строка 6) — ☐
5. Санитарные документы ведутся по СанПиН 4282-26; программа производственного контроля актуальна (раздел 18.10) — ☐
6. Число кормимых на одного работника в часы еды соответствует плану; отклонения записаны (раздел 28.3) — ☐
7. Панель чисел месяца собрана; отклонения объяснены письменно (приложение 35) — ☐
8. Совет жителей заседал; протокол есть; по решениям есть движение (раздел 34) — ☐
9. Жалобы по питанию разобраны в срок; системные выводы сделаны; инциденты разобраны по приложению 34 — ☐
10. Переписка с учредителем актуальна (запросы без ответа повторены) — ☐
11. Инструктажи новых сотрудников по питанию и первой помощи при удушье проведены — ☐
12. Один случайный разговор с жителем о еде состоялся; запись в дневник обхода — ☐

Подпись: _____ Дата: _____

Новые источники

Полные записи — в реестре raw/sources/poisk-2026-10-pril-a/istochniki.md. Остальные маркеры раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S142	Приказ Минздрава России от 20.08.2026 № 740н «Об утверждении учётной формы № 058/у „Экстренное извещение о случае инфекционной болезни“» (зарег. Минюстом 16.09.2026 № 88291; с 01.03.2027) — по правовым обзорам, текст приказа не читался

Приложения 19–24

Шесть чек-листов этого блока распределяют контроль вариативного питания по тем, кто его исполняет: пищеблок, отделение, врач, контрактная служба, бухгалтерия и директор (или тот, кому директор поручил проверку). Каждый лист короткий и печатается на одной странице. Ставить отметку можно лишь тогда, когда пункт выполнен на деле, а не «по документам». Пустая клетка — повод разобраться, а не провал. Все листы — **проекты локальных форм, а не нормативы**: дом адаптирует их под свой штат, свою модель (M0–M5, раздел 8.2) и свои реквизиты. Ссылки на разделы даны по второй редакции доклада.

Санитарные пункты привязаны к СанПиН 2.3/2.4.4282-26, который действует с 01.09.2026 без переходного периода (раздел 18.10)[9]. Листы, заполненные до 31.08.2026 по СанПиН 3590-20, не переписываются: они законны в том виде, в каком велись.

Приложение 19. Чек-лист пищеблока (ежедневный)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Лист подтверждает, что второй вариант блюда прошёл тот же санитарный контур, что и первый: пробу, температуру, маркировку, бракераж и запись в журналах (разделы 18.2, 18.7, 18.9). **Кто заполняет:** заведующий производством или шеф-повар; при аутсорсинге — ответственный учреждения за приёмку (раздел 42.3, строка 6). **Как часто:** ежедневно, по итогам последнего приёма пищи. Раз в неделю лист просматривает руководитель учреждения или его заместитель при обходе пищеблока (раздел 18.5); его подпись внизу превращает «распределено» в «фактически контролируется».

Дата: «» _____ 20 г. Модель вариативности: M_ Число вариативных позиций сегодня: ____

№	Пункт	Да	Нет	Примечание
1	Санитарные журналы дня ведутся по формам, действующим с 01.09.2026; температура горячих блюд на раздаче соответствует технологическим картам (п. 50 СанПиН 4282-26) и записана для каждой гастрорёмкости, включая вариант Б	☐	☐	
2	Суточная проба отобрана от каждого варианта каждой позиции отдельно, а не «средняя по обеду»; ёмкости промаркированы с указанием варианта; хранение — не менее 48 часов при +2...+6 °С (подп. 4 п. 56; толкование применимости к СОС — раздел 18.7)	☐	☐	
3	Бракераж проведён по обоим вариантам до выдачи; блюдо с нарушением технологии не выдано до устранения недостатков, причина записана в журнал бракеража (подп. 13 п. 56)	☐	☐	
4	Вариативные ёмкости на линии промаркированы: наименование и «вариант А / вариант Б» (рекомендация доклада, не прямая норма — раздел 18.2)	☐	☐	
5	Блюда, требующие разогрева, находились на раздаче не более трёх часов с момента изготовления; нереализованное на следующий день не выдаётся и не заморожено для реализации (п. 32)	☐	☐	
6	Порции модифицированной текстуры приготовлены по поимённому списку врача (уровни IDDSI), промаркированы отдельно от обычных и проверены перед выдачей тестами IDDSI — надавливание вилкой, наклон ложки (раздел 10.5)	☐	☐	

№	Пункт	Да	Нет	Примечание
7	Для группы риска удушья опасные продукты (хлеб, сухое и рассыпчатое, крупные куски мяса, смешанная консистенция) поданы в форме, соответствующей назначенному уровню (раздел 10.7)	☐	☐	
8	Итоги заказа от отделений получены в срок; объёмы вариантов рассчитаны по журналу заказа (приложение 7), а не «на глаз»	☐	☐	
9	Лекарственно-пищевые пометки (приложение 21, часть А) на кухне актуальны: «без грейпфрута», «тираминовая разметка», «солевой режим не менять»; изменения за сутки доведены до поваров	☐	☐	
10	Раздачу ведут работники, у которых раздача записана в должностной инструкции (п. 32)	☐	☐	
11	Отходы взвешены отдельно: тарелочные и кухонные (только в неделю замера, приложение 25)	☐	☐	

Зав. производством: _____ /подпись/ Обход руководителя (раз в неделю): _____ /
подпись, дата/

Приложение 20. Чек-лист отделения (ежедневный, часы приёма пищи)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Лист проверяет то, чего не видно с пищеблока: показан ли выбор жителям, хватает ли рук у стола и в безопасности ли люди с риском аспирации и удушья (разделы 10.7, 20.3, 20.11).

Кто заполняет: старшая смены отделения. **Как часто:** ежедневно, после каждого приёма пищи; ячейки «з/о/у» — завтрак, обед, ужин.

№	Пункт	з	о	у	Примечание
1	Меню показано жителям в доступной форме (визуальное меню, показ порций, приложение 5); выбор записан при жителе, а не заранее	☐	☐	☐	
2	Невербальным жителям варианты показаны, реакция записана по форме наблюдения (приложение 6, раздел 15)	☐	☐	☐	
3	На посту в часы еды не менее двух сотрудников, обученных безопасному кормлению и алгоритму при удушье (приложение 12)	☐	☐	☐	
4	Жители из списка дисфагического риска (приложение 21, часть Б) находятся в поле зрения помогающего; сидят вертикально, около 90°; помогающий сидит на уровне глаз	☐	☐	☐	
5	Порция соответствует назначенной текстуре и уровню загущения напитков; при сомнении порция не выдаётся до сверки с кухней	☐	☐	☐	
6	Таблетки жители из группы риска принимают бодрствуя и сидя; после еды остаются сидя не менее 30 минут (раздел 10.7)	☐	☐	☐	
7	Постельные и маломобильные жители получили выбор на подносе (оба варианта или их изображения), а не «что осталось» (раздел 20.11)	☐	☐	☐	
8	Отложенные порции для спящих и отсутствующих оформлены: время, температура при выдаче, кто выдал	☐	☐	☐	
9	Отказы записаны в журнал отказов (приложение 9) в день события; альтернатива предложена в тот же приём; при трёх отказах подряд врач извещён в тот же день (раздел 12.3)	☐	☐	☐	
10	Замены и срывы выбора («выбрал Б – не получил Б») записаны (приложение 8, журнал замен – раздел 19.8)	☐	☐	☐	
11	Вода стоит на виду; о рвоте, диарее, лихорадке, отказе от питья у жителей на литии и о прекращении курения у жителей на клозапине врач извещён сегодня (разделы 11.2–11.3)	☐	☐	☐	

№	Пункт	з	о	у	Примечание
12	Конфликтов за столом без записи не осталось (приложение 15)	☐	☐	☐	
13	Помощь распределена по приоритету риска; никто из нуждающихся в помощи не остался без неё; если остался — записано, кто и почему (это данные для приложения 26)	☐	☐	☐	
14	При передаче смены названы жители с дисфагическим риском, новые назначения текстуры и случаи поперхивания за смену	☐	☐	☐	

Старшая смены: _____/подпись/ Дата: _____

Приложение 21. Чек-лист медицинского контура

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Документы контура заполняет и подписывает врач: кухня клиники не назначает.

Назначение. Лист собирает три клинических документа, без которых выбор небезопасен: лекарственно-пищевую таблицу (раздел 11.7), список дисфагического риска (раздел 10.7) и ежемесячный пересмотр (разделы 12, 13.8, 22.4). **Кто заполняет:** врач; ведение списка может быть поручено старшей сиделке или медицинской сестре, но назначения в нём делает врач (раздел 31.3). **Как часто:** часть А — при каждой смене назначений; часть Б — при заселении, после госпитализации и при смене лекарственной схемы; часть В — ежемесячно.

Обращение со сведениями. Название препарата и диагноз — сведения о состоянии здоровья, специальная категория персональных данных; основание их обработки выбирается из ч. 2 ст. 10 закона № 152-ФЗ, а не из договора (раздел 17.6)[132]. На кухню и в комнату передач уходит только **результат:** «без грейпфрута», «кофе — не больше привычного», «текстура уровня 5».

А. Лекарственно-пищевая таблица (вкладыш; копии — на посту, на кухне, в комнате передач)

Классы уверенности — по разделу 11.1: «установлено», «мониторинг», «рекомендация». Они говорят о силе фармакологических данных и не тождественны классам утверждений доклада.

Препарат (группа)	Что контролируется	Что делает кухня	Что делает пост	Что сообщается врачу	Класс
Клозапин	Кофеин (кофе, крепкий чай, энергетики) и курение	Не превращает кофе в награду или наказание; не меняет привычный объём	Ведёт учёт привычного кофе, чая, курения; проверяет передачи	Любое резкое изменение: рост кофе, отказ от кофе, прекращение курения или переход на электронную сигарету , пневмония	установлено[17, 82, 84]
Литий	Соль и вода	Солевой режим без врача не меняет ни в одну сторону; «малосольный стол» по своей инициативе не вводит	Вода на виду; солёные передачи — по режиму, а не «загрузками»	Рвота, диарея, лихорадка, жара без питья, отказ от питья — в тот же день	мониторинг[18, 87]

Препарат (группа)	Что контролируется	Что делает кухня	Что делает пост	Что сообщается врачу	Класс
Ингибиторы МАО	Тирамин (выдержанные и плесневые сыры, копчёности, соленья, соевый соус, квас, пиво)	Исполняет тираминовую разметку врача; выбор строится из неразмеченных блюд	Сверяет передачи со списком	Жёсткость разметки определяет врач по препарату (необратимый ИМАО, обратимый МАО-А, МАО-В)	установлено[19, 91]
Карбамазепин и другие препараты, разрушаемые СУРЗА4	Грейпфрут и его сок	Грейпфрут не закупается и в меню не входит для всего дома	Изымает грейпфрут из передач с объяснением семье	Перечень препаратов ведёт врач	установлено[20, 92]
Все психотропные	Алкоголь и энергетические напитки	Энергетики в буфет не входят (ассортимент утверждается вместе с врачом)	Проверяет передачи	Эпизоды употребления	рекомендация

Уточнение второй редакции. Рост концентрации клозапина от кофеина (в среднем на 19 % по AUC) получен в контролируемом исследовании с добавкой 400–1000 мг кофеина в сутки, а не как популяционное наблюдение; резкая отмена привычного кофеина снижает концентрацию на 37–47 % (раздел 11.2).

Б. Список дисфагического риска

Код жителя	Признаки риска (раздел 10.4)	Текстура пищи, уровень IDDSI	Напитки, уровень IDDSI	Помощь и поза	Опасные продукты: в какой форме подавать	Дата назначения / пересмотра	Сведения переданы при переводе или госпитализации (дата)	Подпись врача

Признаки риска — по разделу 10.4: кашель или поперхивание во время еды и после неё; «влажный», булькающий голос после глотка; многократное проглатывание одного куса; еда, остающаяся за щекой; подтекание изо рта; необычно долгий приём пищи; отказ от твёрдой пищи при сохранном аппетите; повторные пневмонии. Отдельно отмечаются несколько антипсихотиков одновременно (раздел 10.3) и быстрое заглатывание (раздел 9). Риск оценивается при заселении[55]. Сведения о дисфагическом риске и назначенной текстуре передаются при каждом переводе, госпитализации и смене смены[55].

В. Ежемесячный пересмотр

Пункт	Да	Нет	Примечание
Список дисфагического риска пересмотрен; новые жители и вернувшиеся из больницы включены или исключены с записью	☐	☐	
Лекарственно-пищевая таблица соответствует текущим назначениям; копии на посту, кухне и в комнате передач заменены	☐	☐	
Журнал отказов (приложение 9) просмотрен; случаи «три отказа подряд» и «25 % порции и больше в течение недели» оценены врачом (раздел 12.3)	☐	☐	

Пункт	Да	Нет	Примечание
Скрининг недостаточности питания проведён медицинским работником (например, MUST – ежемесячно в домах ухода)[106]; прибавка массы 5 % и более за квартал отмечена как метаболический сигнал (раздел 13.8)	☐	☐	
Метаболический мониторинг (вес, глюкоза, липиды) у получающих антипсихотики – по графику назначений	☐	☐	
Случаи поперхивания и удушья за месяц разобраны (приложение 34)	☐	☐	

Врач: _____ /подпись/ Дата: _____

Приложение 22. Чек-лист закупок

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Лист проверяет, совместима ли закупка с меню: выбор, который меняется по статистике, должен жить внутри контракта, который фиксирован (разделы 30.4, 30.8). **Кто заполняет:** контрактный управляющий или руководитель контрактной службы вместе с заведующим производством. **Как часто:** при подготовке каждой закупки продуктов и раз в квартал при пересмотре пропорций. Ссылки на 44-ФЗ даны для учреждений, работающих в его контуре; учреждение, закупающее по 223-ФЗ, сверяет те же пункты со своим положением о закупке. Автономное учреждение применяет 44-ФЗ лишь в случаях ч. 4 ст. 15 (капитальные вложения или условия предоставления средств)[219].

№	Пункт	Да	Нет	Примечание
1	Спецификация описывает позиции как группы взаимозаменяемых продуктов («крупы гарнирные: гречка, рис, пшено»), а не как монопозиции	☐	☐	
2	Пропорции внутри группы рассчитаны по статистике выбора за 2–3 месяца (раздел 21.2)	☐	☐	
3	Выбран механизм корректировки пропорций, согласованный с контрактной службой: изменение количества до 10 % по ст. 95 44-ФЗ или закупка с неопределённым объёмом (ч. 24 ст. 22) – толкование доклада, раздел 30.8[222]	☐	☐	
4	Правило замены при недопоставке прописано в самом контракте: эквивалент из той же группы, по согласованию и с актом; замена «чем есть» без оформления не допускается	☐	☐	
5	Характеристики, значимые для текстур (помол, консистенция полуфабрикатов), описаны измеримо (ст. 33 44-ФЗ)[251]	☐	☐	
6	Грейпфрут и его сок не входят в спецификацию (приложение 21, часть А)	☐	☐	
7	Назначен ответственный за приёмку и претензии; утверждена форма акта недопоставки	☐	☐	
8	Статистика срывов поставок ведётся и учитывается при следующей закупке	☐	☐	
9	Закупка сверена с циклом меню, раскладкой, диетами и текстурами; раз в год спецификация пересмотрена по замеру отходов (приложение 25)	☐	☐	
10	При аутсорсинге в контракт включены восемь строк раздела 42.3 (форма – приложение 43): выбор, замены, текстуры, приёмка и пробы, состав, отчётность, доступ к журналам	☐	☐	
11	Ответственный знает признаки картеля: одни и те же поставщики поочерёдно побеждают с близкими ценами; снижение цены ритуально мало; «проигравший» побеждает в соседнем торге (раздел 30.7)	☐	☐	

№	Пункт	Да	Нет	Примечание
12	Порядок действий при устойчивых признаках картеля известен: сообщить учредителю и с его согласия направить в ФАС письменное заявление от имени заказчика с реквизитами заявителя; анонимное сообщение заявлением в смысле закона не является (ч. 1 ст. 44 закона № 135-ФЗ) ^[220]	☐	☐	

Уточнение второй редакции. Первая редакция связывала обращение в ФАС с анонимностью заявителя; закон её не предусматривает (раздел 30.7).

Контрактный управляющий: _____ /подпись/ Дата: _____

Приложение 23. Чек-лист бухгалтерского учёта

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Лист отвечает на вопрос, который первым задаст ревизор: как выбор жителей отражается в списании продуктов (раздел 31.5; кейс 13). **Кто заполняет:** главный бухгалтер вместе с заведующим производством или диетсестрой. **Как часто:** ежемесячно при закрытии периода; пункт 2 проверяется выборочно еженедельно в первый месяц пилота.

Нормативная рамка. Исторически учёт продуктов ведётся по формам приказа Минфина № 52н^[224]. Унифицированные формы **электронных** первичных документов утверждены приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н; переход на них идёт поэтапно, по методическим рекомендациям Минфина^[225]. Приказы № 157н и № 174н — планы счетов, а не этапы перехода на электронные формы, и в учётной политике в этом качестве не упоминаются (раздел 41.6). Какую форму дом применяет, подтверждают учредитель или региональный орган.

№	Пункт	Да	Нет	Примечание
1	Применяемая учётная форма (бумажная по № 52н или электронная по № 61н) подтверждена учредителем; ссылка на подтверждение записана	☐	☐	
2	Пропорции пар по журналу заказа попадают в меню-раскладку до её утверждения : при электронном учёте требование-накладная (ф. 0510451) формируется автоматически после утверждения расчёта потребности ^[225]	☐	☐	
3	Ежедневные итоги журнала заказа (приложение 7) поступают в бухгалтерию по утверждённой форме и в утверждённый срок	☐	☐	
4	Списание парных продуктов идёт по фактической пропорции выдачи; методика согласована и утверждена приказом	☐	☐	
5	Разница «склад — выдача — списание» объяснима за любой день месяца, выбранный наугад	☐	☐	
6	Отложенные порции, замены и порции модифицированной текстуры отражены в выдаче	☐	☐	
7	Остатки, ушедшие в списание по правилам хранения, отделены от отходов с тарелок (данные замера — приложение 25)	☐	☐	
8	Сырьевая строка (руб. на жителя в день: расходы на продукты за месяц ÷ число жителей ÷ число дней, без труда и коммунальных расходов) посчитана и передана директору (раздел 29.3)	☐	☐	

Главный бухгалтер: _____ /подпись/ Дата: _____

Приложение 24. Чек-лист проверки реальности выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Лист отличает выбор на тарелке от выбора на бумаге (разделы 21.4 и 21.8; кейс 12). Он измеряет факт, а не документ (раздел 22.1). **Кто проводит:** директор, заместитель или сотрудник, не работающий в проверяемом отделении: свой проверяющий видит меньше (раздел 22.8). **Как часто:** еженедельно в пилотной точке, после пилота — ежемесячно, в разные дни недели и разные приёмы пищи. **Как выбирать жителей:** наугад по списку отделения (например, каждый шестой), а не тех, кого предложит смена. Если житель не может ответить словами, вопрос заменяется наблюдением по приложению 6, и это отмечается в примечании.

Отделение: _____ Дата: _____ Приём пищи: _____

№	Пункт	Результат	Примечание
1	Пятерых случайных жителей спросили: «Что вы вчера выбирали?» Ответ совпал с журналом заказа	___ из 5	
2	Журнал заказа заполнен в день показа меню: записи разными почерками и ручками, время соответствует; нет признаков заполнения задним числом или заранее	☐	
3	Оба варианта физически были на линии до конца раздачи (опрос смены и журнал срывов, приложение 8); если «закончился» — это записано	☐	
4	Доля «стандартных» (невыбравших) не растёт третью неделю подряд без объяснения и не превышает 90 %	☐	
5	Замены выдавались реально: спросили двоих, кому меняли блюдо, — ответ совпал с журналом замен	☐	
6	Жители знают, что выбирать можно (тот же опрос)	___ из 5	

Полевые приметы (баллов не дают, но записываются): выбор есть только на завтрак и только между кашами, хотя положение обещает больше; вариант Б «закончился» к приходу проверяющего, а журнал срывов пуст; невербальным жителям варианты не показывают; статистика выбора собирается, но объёмы и цикл не меняются (раздел 21.4, признак 5). Одна примета может оказаться невинной; две и больше означают, что разговор нужно вести о перезапуске (раздел 21.8).

Оценка (по шести пунктам; пункты 1 и 6 засчитываются при результате 4 из 5 и выше): 6 из 6 — выбор реален; 4–5 — точечные сбои, разбор на ближайшей планёрке; 3 и меньше — вариативность фиктивна, диагностика по разделам 21.4 и 21.8 и кейсу 12.

Провёл: _____ /подпись/ Дата: _____ Разбор назначен на: _____

Новые источники

В этом файле использованы только маркеры, уже раскрытые в разделе 44 (первая редакция и 44.4). Новых источников блок 19–24 не потребовал; реестр файла с приложениями 25–30 — raw/sources/poisk-2026-10-pril-b/istochniki.md.

Маркер	Источник
—	НОВЫХ НЕТ

Приложения 25–30

Блок собирает инструменты пилота и документы, которые закрепляют его результат. Две формы замера (отходы и трудозатраты) делают «до» и «после» сравнимыми; форма отчёта и проект приказа задают рамку девяноста дней (раздел 35); положение о вариативном питании и положение о пищевом совете переводят удачный пилот в постоянный порядок (разделы 31 и 34). Все шесть текстов — **проекты локальных форм, а не нормативы**. Числа в них — ориентиры для заполнения, а не обязательные пороги; реквизиты нормативных актов сверены по второй редакции доклада на октябрь 2026 года.

Приложение 25. Форма семидневного замера отходов

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Назначение. Замер даёт исходную точку пилота и единственную «экономию», которую можно проверить: несъеденную еду (разделы 22.3, 29.11). **Кто заполняет:** сотрудник, не отвечающий за приготовление и раздачу в проверяемой точке (раздел 22.8), с участием смены, которая взвешивает. **Как часто:** до пилота (дни 1–14, раздел 35.2), на 80–90-й день и далее ежеквартально; выводы делаются по повторяемости, а не по одному замеру.

Как вести замер. Обычная неделя, не праздничная. Кухонные весы одной и той же модели. В конце каждого приёма пищи записываются **три веса:** сколько выдано по линии, сколько вернулось с тарелок и сколько осталось на кухне. Тарелочные и кухонные остатки не смешиваются: первые говорят о вкусе, размере порции и состоянии жителей, вторые — о точности планирования объёмов (раздел 29.11). Несъедобные части (кости, кожура) взвешиваются отдельно или исключаются, и это правило записывается до начала замера.

Что записать до начала. Международный стандарт учёта пищевых потерь и отходов требует указывать период замера с датами начала и окончания и описывать применённый метод, а при выборочном замере — способ выборки и пересчёта^[264]. Для дома это три строки ниже: без них повторный замер через 90 дней нельзя честно сравнить с первым.

Точка замера: _____ Период: с «» _____ **по** «» _____ 20__ г. Метод: прямое взвешивание, весы _____ Несъедобные части: ☐ исключены ☐ взвешены отдельно Выборка: ☐ все порции ☐ выборочно (как: _____)

День	Приём	Выдано, кг	Тарелочные остатки, кг	Кухонные остатки, кг	Число порций	Тарелочный остаток на порцию, г	Блюда с наибольшими остатками	Примечание
1	завтрак							
1	обед							
1	ужин							

День	Приём	Выдано, кг	Тарелочные остатки, кг	Кухонные остатки, кг	Число порций	Тарелочный остаток на порцию, г	Блюда с наибольшими остатками	Примечание
2	завтрак							
2	обед							
2	ужин							
3	завтрак							
3	обед							
3	ужин							
4	завтрак							
4	обед							
4	ужин							
5	завтрак							
5	обед							
5	ужин							
6	завтрак							
6	обед							
6	ужин							
7	завтрак							
7	обед							
7	ужин							

Остаток на порцию = тарелочные остатки (кг) × 1000 ÷ число порций.

Итоги недели: средний тарелочный остаток на порцию __ г; доля несъеденного от выданного __ %; кухонные остатки за неделю __ кг; три блюда с наибольшими остатками: 1) _____ 2) _____ 3) _____; сравнение с замером «до» (при повторном замере): __ %. Перевод в деньги: масса недельных отходов × цена килограмма по фактуре = _____ руб. (раздел 29.11).

Честность замера. Меню недели не «улучшать». Сменам не объявлять заранее, какие блюда под наблюдением, иначе они изменят поведение. Праздник, похороны, вспышку инфекции, обострение у жителей записывать в примечание, а не вычёркивать молча. Короткий ряд в семь дней искажают сезон и «хорошие дни»; поэтому летние данные не переносятся на зиму (раздел 35.4а). Чаще всего в исследованиях домов ухода измеряют именно тарелочные отходы, а кухонные остаются без внимания^[149]; три веса этой формы закрывают обе части картины.

Замер провёл: _____/подпись/ Проверил: _____/подпись/

Приложение 26. Форма учёта трудозатрат на кормление

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Форма превращает жалобу «нас не хватает» в число, с которым можно идти к учредителю (разделы 28.3, 28.11; письмо — приложение 33). **Кто заполняет:** наблюдатель с секундомером, не участвующий в кормлении. **Как часто:** три типичных дня подряд, каждый приём пищи, до пилота и на 80–90-й день. Поведение смены не исправлять по ходу наблюдения: измеряется обычный день, а не показательный.

Отделение: _____ Число жителей: ____ Из них нуждаются в помощи за столом: ____ Из них кормятся полностью: ____

День / приём	Число жителей, нуждающихся в помощи	Из них кормятся полностью	Число помогающих у стола	Длительность приёма пищи, мин	Суммарные минуты помощи (по секундомеру)	Минут помощи на одного жителя	Жителей на одного помогающего	Кто не получил помощь вовремя и почему

Расчёт дефицита.

- Потребность** = число нуждающихся в помощи × расчётные минуты помощи на жителя.
Расчётные минуты дом устанавливает по собственному хронометражу медленного, неспешного кормления; внешние ориентиры приведены в разделах 20.3 и 28.11 (в американском исследовании помощь по протоколу заняла в среднем 38 минут на жителя за приём против 9 минут в обычных условиях^[210]) и для российского дома нормой не являются.
- Дефицит за приём** = потребность – фактические минуты помощи.
- Дефицит в неделю, часов** = сумма дефицитов за все приёмы недели ÷ 60.
- Перевод в ставки** = недельный дефицит в часах ÷ нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (ч. 2 ст. 91 ТК РФ)^[265]. Для работников с сокращённой продолжительностью рабочего времени знаменатель уточняет кадровая служба.
- Сопоставление с нормативом.** Рекомендуемые нормативы штатной численности (приказ Минтруда России от 14.05.2025 № 305н) предусматривают одну должность помощника по уходу на 30 получателей услуг в смену днём для групп нуждаемости I–II и одну на 12

получателей круглосуточно для групп III–IV^[205]; региональные нормативы могут отличаться. Ни один из них не описывает час еды отдельно: соотношение «один работник — не более двух полностью кормимых жителей» взято из регламента Онтарио как ориентир, а не норма^[27].

Оговорка. Ставки и руки у стола — не одно и то же: дефицит возникает в конкретный час, и его иногда закрывает перестановка графика (все свободные руки на час еды, рассадка по степени помощи, раздел 20) без новых ставок. В письме учредителю указываются оба числа: сколько минут не хватает в часы еды и сколько ставок потребовалось бы, если перестановки недостаточно.

Наблюдатель: _____ /подпись/ Даты наблюдения: _____

Приложение 27. Форма отчёта о 90-дневном пилоте

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Назначение. Отчёт фиксирует, что пилот показал и чего не показал. Пилот на девяносто дней в одном отделении проверяет **осуществимость и безопасность**, а не эффект выбора на здоровье (раздел 35.4а)^[234]. **Кто составляет:** руководитель пилота; данные сводит ответственный за сведение данных (приложение 28, п. 2). **Когда:** на 90-й день; направляется директору, совету жителей и учредителю.

1. Паспорт пилота: точка (отделение, приём пищи); даты начала и окончания; модель (M1–M5, раздел 8.2); число жителей в точке; ответственные; номер и дата приказа (приложение 28).

2. Панель чисел «до/после» (12 показателей). «До» — замер дней 1–14; «после» — дни 76–90. Выводы делаются по дням 30–90: первые недели завышены новизной (раздел 35.4а). Ни одно число не подаётся без фразы «что это значит».

Показатель	Источник данных	До	После	Что это значит (одна фраза)
Доля жителей, сделавших выбор, %	журнал заказа (прил. 7)			
Тарелочный остаток на порцию, г	замер (прил. 25)			
Время раздачи, мин	хронометраж			
Отказы от еды, эпизодов в неделю	журнал отказов (прил. 9)			
Замены, эпизодов в неделю	журнал замен (раздел 19.8)			
Срывы выбора («выбрал Б — не получил Б»), эпизодов в месяц	журнал срывов (прил. 8)			
Жалобы жителей и родственников / из них отвечено в срок	журнал обращений			
Трудозатраты линии, человеко-минут на приём	форма трудозатрат (прил. 26)			
Сырьевая строка, руб. на жителя в день	бухгалтерия (прил. 23)			

Показатель	Источник данных	До	После	Что это значит (одна фраза)
Доля жителей, знающих о выборе, %	проверка реальности (прил. 24)			
Эпизоды поперхивания, удушья, подозрения на аспирацию	медицинский контур (прил. 21)			
Удовлетворённость (анкета в доступном формате, баллы 1–5)	анкета (прил. 36)			

К панели прилагается график хода процесса по недельным точкам для двух-трёх главных показателей: сдвиг — шесть и более точек подряд по одну сторону медианы, тренд — пять и более точек подряд в одном направлении (раздел 35.3)[235].

3. Что пилот не доказывает (заполняется обязательно): контрольной группы не было; возможны эффект наблюдения, сезонность, смена состава смены, возврат к среднему (раздел 35.4a). Какие из них были в этом пилоте: _____

4. Сигнал по критериям, записанным в приказе (формат светофора, раздел 35.4a)[236]:

Сигнал	Условие	Отметка
Зелёный	Журналы ведутся без срывов; выбор есть на большинстве приёмов; отказы и клинический риск не выросли; трудозатраты укладываются в смету	☐
Жёлтый	Исправимые проблемы: пары, поток, очередь, маркировка	☐
Красный	Рост отказов или аспираций, санитарные нарушения, противопоказания врача либо неподъёмные трудозатраты (раздел 35.5)	☐

5. Позиция совета жителей (протокол прилагается): ☐ расширить ☐ сохранить точку ☐ свернуть.

6. Решение директора — одно из трёх, с обоснованием: ☐ расширение ☐ закрепление точки ☐ свёртывание (с причинами) ☐ продление на 60 дней с исправлениями (при жёлтом сигнале). Формулировка успеха — «умеет безопасно», а не «выбор доказал пользу».

7. Приложения: журналы, замеры, графики, разборы инцидентов (приложение 34), протокол совета.

Руководитель пилота: _____ /подпись/ Директор: _____ /подпись/ Дата: _____

Приложение 28. Проект приказа о пилоте вариативного питания

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Назначение. Приказ открывает пилот и заранее, до первых данных, записывает, что будет считаться успехом и что — поводом остановиться (разделы 35.2, 35.5). **Кто готовит:** руководитель пилота; подписывает директор. **Когда:** в первую неделю подготовки, до замера «до». Приказ, подписанный после старта, теряет главную функцию: критерии, записанные задним числом, подгоняются под результат.

ПРИКАЗ № ____ от «_» _____ 20 г. «О проведении пилотного проекта по организации вариативного питания»

В целях реализации права получателей социальных услуг на уважительное и гуманное отношение и на участие в составлении индивидуальной программы (ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ)[118], а для учреждений, предназначенных для лиц с психическими расстройствами, — прав, предусмотренных ч. 2 ст. 5 и ч. 2 ст. 37 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 в силу его ст. 43[8], при соблюдении СанПиН 2.3/2.4.4282-26[9],

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с «__» _____ **по** «__» _____ (90 дней) пилотный проект в отделении № ____: выбор из двух вариантов вторых блюд на обед, ____ дня (дней) в неделю (модель М1, раздел 8.2), с гарантией полноценного стандартного варианта для жителя, не сделавшего выбор.
2. Назначить ответственных: руководитель пилота — _____; кухня — _____; отделение — _____; медицинский контур (списки риска, лекарственно-пищевая таблица) — врач _____; сведение данных — _____.
3. В срок до «__» _____ (дни 1–14), без изменений на линии раздачи: 3.1. провести семидневный замер отходов и трёхдневный учёт трудозатрат (приложения 25–26), а также учёт времени раздачи и отказов; 3.2. провести опрос предпочтений жителей точки (приложение 36) и внести ответы в пищевые карты; 3.3. провести инструктаж смен раздачи и кухни (раздел 28.10); 3.4. оформить санитарный паспорт второй гастрорёмкости за подписью заведующего производством (раздел 18.9) — прилагается к приказу; 3.5. проверить, что раздача записана в должностных инструкциях работников, которые будут её вести (п. 32 СанПиН 4282-26); 3.6. направить письмо учредителю о пилоте; 3.7. подготовить папку для проверяющего (раздел 32.6).
4. Вести с первого дня пилота журнал заказа, журнал срывов выбора и журнал отказов (приложения 7–9), а также журнал замен (раздел 19.8). Проводить еженедельную планёрку (15 минут) и проверку реальности выбора (приложение 24).
5. Установить критерии оценки (формат светофора, раздел 35.4а): — зелёный (продолжать): _____ (например: журналы ведутся без срывов; выбор есть не менее чем на ____ % приёмов; отказы не выросли; трудозатраты в пределах ____ человеко-минут на приём); — жёлтый (исправить и продлить на 60 дней): _____; — красный (остановить): рост отказов от еды в точке пилота; санитарные нарушения на новой линии; клинические противопоказания, выявленные врачом (раздел 35.5). При красном сигнале пилот останавливается немедленно распоряжением руководителя пилота с докладом директору в тот же день.
6. «__» _____ (90-й день) заслушать итоги по форме отчёта (приложение 27) с учётом позиции совета жителей; решение о расширении, закреплении или свёртывании оформить приказом.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор _____ /подпись/ _____ /расшифровка/

С приказом ознакомлены: _____

Приложение 29. Проект положения о вариативном питании

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Назначение. Положение закрепляет выбор как порядок, а не как добрую волю смены (раздел 31.2, документы 1–2). Ниже дан каркас разделов с рекомендуемыми формулировками; текст дом дописывает под себя. **Кто готовит:** заместитель директора по социальной работе или руководитель пилота вместе с врачом, заведующим производством и юристом. **Утверждает:** директор, с согласованием по регламенту учредителя. **Пересмотр:** не реже раза в год и при смене норм (раздел 31.8). Положение может быть самостоятельным актом, разделом положения об организации питания или частью правил внутреннего распорядка: важно не место, а утверждение.

1. Общие положения и правовая основа. Цель — реализация существующих прав получателей социальных услуг через организованный выбор в питании. Прямого субъективного права на ежедневный выбор блюда закон не устанавливает (раздел 17.2), поэтому положение опирается на следующие нормы:

- ст. 9 и 16 Федерального закона № 442-ФЗ: уважительное и гуманное отношение, участие в составлении индивидуальной программы, надлежащий уход; пищевые предпочтения и доступный выбор вносятся в ИППСУ^[118];
- для учреждений, предназначенных для лиц с психическими расстройствами: ч. 2 ст. 5 Закона РФ № 3185-1 (уважительное и гуманное отношение) и ч. 2 ст. 37, распространённая на проживающих ст. 43, в том числе право соблюдать религиозные каноны, включая пост^[8];
- СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18), п. 56 подп. 11–14 — с 01.09.2026^[9];
- приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н (рекомендуемые нормы питания)^[38] и нормы питания, установленные актом субъекта РФ: _____ (реквизиты); по Правилам, утверждённым приказом Минтруда России от 14.05.2025 № 305н, нормы питания в организациях субъекта устанавливаются его нормативными актами^[205];
- Федеральный закон № 152-ФЗ, ст. 10 — для сведений о здоровье в пищевых картах и списках риска^[132].

2. Перечень вариативных позиций и режим: какие приёмы пищи и дни; какие пары эквивалентов (раздел 19.2); как пары обосновываются по таблицам замены региональных норм.

3. Гарантия стандартного варианта. «Житель, не сделавший выбор, получает полноценный стандартный вариант. Выбор — право, а не обязанность. Вариант, выбранный жителем, не заменяется без его согласия, кроме случаев, предусмотренных разделом 6».

4. Показ меню и фиксация выбора: визуальное меню и иные доступные формы (приложения 4–5); выбор невербальных жителей по форме наблюдения (приложение 6, раздел 15); выбор постельных жителей на подносе (раздел 20.11); сроки передачи заказа на кухню (приложение 7); передача пропорций в меню-раскладку до её утверждения (раздел 31.5).

5. Замены и отказы: при отказе жителю предлагается альтернатива в тот же приём (раздел 12.3); замены и срывы записываются (раздел 19.8, приложение 8); отказы — в журнал отказов (приложение 9). Запрещается использовать еду как поощрение или наказание; запрещается принудительное кормление.

6. Связь с назначениями врача: конфликт «выбор против назначения» решает врач в день обращения; диетические столы и модифицированные текстуры имеют собственные пары эквивалентов; лекарственно-пищевые ограничения (приложение 21) исполняются как границы выбора, внутри которых выбор свободен. На кухню передаются функциональные ограничения, а не диагнозы (раздел 17.6).

7. Санитарный контур: каждый вариант проходит пробу, бракераж, температурный контроль и маркировку (раздел 18, приложение 19).

8. Роли и ответственность — по матрице RACI (приложение 17).

9. Контроль: проверки реальности выбора (приложение 24); квартальная панель показателей (приложение 35); отчётность учредителю.

10. Совет жителей — со ссылкой на положение о пищевом совете (приложение 30).

11. Сведения о здоровье: круг доступа (пост и врач — полностью, кухня — только функциональные ограничения), основание обработки по ч. 2 ст. 10 закона № 152-ФЗ, сроки хранения; согласие за недееспособного жителя даёт законный представитель^[132].

Приложение 30. Положение о пищевом совете жителей

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Назначение. Положение делает участие жителей в меню ежемесячной процедурой с протоколом и сроком ответа (раздел 34.3). Федеральной нормы о совете жителей нет: он создаётся локальным актом. Совет не следует путать с попечительским советом организации, который состоит из внешних лиц и действует по примерному положению, утверждённому приказом Минтруда России от 30.06.2014 № 425н^[231]; попечительский совет может помогать совету жителей, но заменить его не может (раздел 34.1). **Утверждает:** директор. **Пересмотр:** раз в год, по итогам работы совета.

- 1. Состав.** От пяти до девяти человек. Большинство — жители, по квоте от каждого отделения, включая недееспособных: их интересы представляют выбранные ими лица или члены совета (раздел 34.4); если опекуном жителя является само учреждение, это отмечается, а разногласия фиксируются в протоколе (раздел 34.5). Кроме жителей — сиделка и повар; врач — с правом совещательного голоса. Срок полномочий — один год; ежегодно обновляется половина состава.
- 2. Полномочия:** обсуждение меню до утверждения; дегустации новых позиций; сбор и ранжирование пожеланий; получение письменного ответа администрации на каждое

пожелание в срок до 14 дней — с решением и его обоснованием, а не только с согласием или отказом.

3. **Ритм:** заседание ежемесячно; кворум — половина состава; протокол хранится __ лет. Первое заседание проводится по сценарию раздела 34.6 (сорок минут, дегустация, три пожелания, дата следующей встречи).
4. **Права совета:** запрашивать меню, журналы срывов, квартальную панель (приложение 35) в доступной форме (раздел 21.7); выносить предложения директору; инициировать дегустации; приглашать на заседания сотрудников, родственников и членов попечительского совета. Посторонние, в том числе родственники и персонал, присутствуют на заседании по приглашению совета.
5. **Защита участников:** по просьбе жителя пожелание записывается в протокол без его фамилии. Сотрудники помогают проводить заседание, но не ведут его (раздел 34.3).
6. **Формат для жителей, не говорящих словами:** реакция на блюда пробных обедов и данные форм наблюдения (приложение 6) представляются совету как данные (раздел 34.4).
7. **Границы.** Совет не подменяет врача и не отменяет санитарных требований. При расхождении позиции администрации с зафиксированными предпочтениями жителя приоритет имеют предпочтения, если они не противоречат назначениям врача (проект локальной нормы, требует согласования с юристом и учредителем; раздел 34.5).

8. Форма протокола:

Дата	Присутствовали (число жителей / сотрудников)	Вопрос	Решение или пожелание	Срок	Ответственный	Ответ администрации (дата, решение, обоснование)

Председатель совета: _____ Секретарь: _____

Новые источники

Полные записи, проверенные формулировки и переводы — в реестре <raw/sources/poisk-2026-10-prib/istochniki.md>. Остальные маркеры раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S145	Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 91 «Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени», ч. 2
I-flw_standard	Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard (FLW Standard), Version 1.0. Food Loss + Waste Protocol; World Resources Institute (секретариат), 2016. Таблица 4.1, требования 3а, 4, 5

Приложения 31–36

Вторая редакция (октябрь 2026). Формы сохраняют структуру первого тома: поля, графы и чекбоксы пригодны к печати и заполнению. К каждой форме добавлена вводная — назначение, кто заполняет, как часто, на какие разделы второй редакции она опирается. Все формы — **проекты локальных форм**, а не нормативные документы (класс утверждений — раздел 41). Норму они получают только после утверждения локальным актом дома.

Приложение 31. Памятка персоналу «Питание и выбор: десять правил»

Назначение. Один лист, который сиделка, помощник по уходу и раздатчик видят перед каждым приёмом пищи. Памятка не заменяет инструктажей (раздел 28.4, 28.10), а напоминает их итог в десяти строках. **Где:** вывешивается на посту и у линии раздачи, вручается при приёме на работу и на первом инструктаже. **Пересмотр:** раз в год или после разбора инцидента (приложение 34), если он показал, что правило сформулировано неясно. **Опора:** разделы 10 (дисфагия), 12 (отказ), 15 (невербальный выбор), 20 (раздача), 21 (журналы), 28 (персонал). **Класс:** проект локальной формы; формат — один лист А4.

1. **Еда — право, а не награда.** Никогда не используйте еду, напиток, кофе или сладкое как поощрение или наказание.
2. **Меню видит каждый.** Показывайте меню каждому жителю, каждый день, в понятном ему формате: словами, карточками, двумя тарелками, жестом (раздел 15.5).
3. **«Стандартный вариант» — нормальный итог**, а не отказ от выбора и не наказание за молчание.
4. **Отказ от блюда — сразу замена и запись.** Предложите замену по таблице замен и запишите в журнал. Без комментариев вслух и без уговоров «ну ещё ложечку».
5. **Три отказа от еды подряд — врач сегодня**, а не «на обходе в четверг». Отказ от воды или от еды и воды вместе — врач немедленно. Слова «отравлено», «мне подсыпают» — врач при первом же эпизоде (раздел 12.3).
6. **Текстура — строго как в карте.** Проверка вилкой и ложкой занимает минуту; ошибка с текстурой может стоить жизни. Хлеб, сухое, крупные куски и суп с кусочками для группы риска — только в назначенной форме (раздел 10.7).
7. **Удушье — действуйте по алгоритму** (приложение 12). В часы приёма пищи на этаже должны быть двое обученных сотрудников. Знайте, кто из них сегодня вы.
8. **Кто ест с помощью — ест в своём темпе.** Помощник сидит рядом на уровне глаз, а не стоит над человеком; еда подаётся под готовые руки. Конвейер недопустим (раздел 20.3).
9. **Записывайте в день события:** замены, отказы, кашель и поперхивание за едой, конфликты, срывы выбора. Не записано — значит, не было.
10. **Не знаете — спросите старшую смены.** Врачебные вопросы (текстура, диета, отказ, лекарства с едой) сами не решайте. Житель за столом — хозяин своей тарелки, а ваша работа —

сделать так, чтобы его выбор был реальным.

Отличие от первой редакции: добавлены правило об отказе от воды (раздел 12.3), правило об опасных продуктах для группы риска и правило об алгоритме удушья (раздел 10.7); прежние правила 7–10 перенумерованы.

Приложение 32. Памятка родственникам

Назначение. Объяснить семье, как в доме устроено питание, что семья может сделать и чего дом не сделает по устной просьбе. Памятка снимает два главных конфликта: «почему у вас ограничивают передачи» и «почему вы не запретили ему сладкое». **Когда:** вручается при поступлении, повторно — раз в год и при изменении правил передач. **Опора:** разделы 11.9 (передачи как фармакологический канал), 16 (опека и воля), 18.4 и 18.8 (регламент передач), 34.7 (семьи и совет жителей). **Класс:** проект локальной формы. Сроки ответа и часы приёма передач дом вписывает сам.

Что мы делаем. В нашем доме жители выбирают из предложенных вариантов. Выбор записывается. Если блюдо не подошло, жителю предлагают замену. Стандартный вариант есть всегда: никто не остаётся без полноценного приёма пищи.

Как вы можете помочь. Расскажите, что ваш близкий любит и чего не ест, есть ли блюда, которые он не ест по вере или убеждению, соблюдает ли посты, — всё это войдёт в его пищевой паспорт (приложение 37). Привычное время еды, любимая кружка, ритуалы, «детские» блюда из прошлого — тоже. Приходите на дни открытых дверей и на дегустации, куда приглашает совет жителей.

Что важно знать.

- Ограничения в питании (диету, текстуру, загущение напитков, запрет продуктов) назначает только врач. Если вы считаете, что близкому нужно ограничение, напишите заявление — врач его рассмотрит и ответит. Устной просьбой запретов не вводим: еда, которую человек любит, — его право.
- Если вы опекун, закон обязывает вас учитывать мнение подопечного (п. 3 ст. 36 ГК РФ^[116]). Решения о питании мы принимаем вместе с жителем, а не только с вами.
- Передачи мы не запрещаем, а проверяем. Некоторые продукты опасно сочетаются с лекарствами: крепкий кофе — с клозапином, грейпфрут — с рядом психотропных препаратов, выдержанные сыры и копчёности — с ингибиторами МАО (раздел 11). Для домов, где живут люди с психическими расстройствами, контроль передач — обязанность учреждения по закону (ст. 39 Закона № 3185-1, применяемая через ч. 2 ст. 43^[8]).
- Перечень того, что принимаем с радостью, и того, что принять не можем (скоропортящееся без холодильника, открытые домашние заготовки, алкоголь, энергетические напитки, продукты из лекарственной таблицы), висит на стенде у комнаты передач.

Куда обращаться.

Вопрос	Кто	Как связаться
Как ест, что выбирает, что не любит	Старшая смены отделения	_____
Ограничения, диета, текстура, лекарства	Врач отделения	_____
Предложения по меню	Совет жителей (через секретаря)	_____
Жалоба	Директор; срок письменного ответа — ____ рабочих дней	_____
Передачи	Пост / комната передач; часы приёма: _____	_____

Приложение 33. Форма сообщения учредителю о дефиците ресурсов

Назначение. Перевести «нам не хватает рук» в число, которое учредитель может рассмотреть и на которое обязан ответить. Молчаливый дефицит — зона личного риска директора; зафиксированный письменно — предмет компетенции учредителя (раздел 28.3, 33.5). **Кто:** директор, расчёт готовят старшая медсестра и заместитель по АХЧ. **Когда:** после замера трудозатрат (приложение 26) и семидневного замера (приложение 25); повторно — когда дефицит не устранён к сроку, указанному в разделе 6. **Опора:** разделы 28.3 (норма помощи), 29.9 (разговор о деньгах), 38.5–38.6 (как вести разговор и работать с отказом). **Класс:** проект локальной формы. Для письма о пилоте при аутсорсинге служит приложение 44.

Генеральному директору / начальнику _____ от директора
 _____ Дата _____ Исх. № _____

1. Дефицит. Конкретно и в единицах: ставки, оборудование, площади. Пример: «3,0 ставки помощника по уходу на время приёмов пищи по расчёту из замера (приложение 26)».

2. Ориентир и методика расчёта.

Показатель	Факт (замер от _____)	Ориентир	Источник ориентира
Кормимых полностью на одного работника в момент еды		2	Онтарио, раздел 28.3[27] — международный ориентир, не норма РФ
Помощников по уходу в смену на группу III–IV		1 на 12 получателей	Рекомендуемый норматив приказа Минтруда № 305н[205]
Помощников по уходу днём / ночью на группы I–II		1 на 30 / 1 на 60	То же[205]
Региональный норматив (если есть)			Акт субъекта: _____

Нормативы приказа № 305н — рекомендуемые и считаются в ставках на смену, а не в людях у стола в момент еды; ни один из них не описывает час еды отдельно (раздел 28.3).

3. Последствия бездействия (по фактам, без оценок). Пример: «12 жителей группы помощи получают менее ____ минут помощи за приём пищи; у двоих за квартал потеря массы тела выше порога (панель, строка 8)».

4. Что сделано без новых ресурсов — перечень мер нулевой стоимости и их измеренный эффект (рассадка по степени помощи, все свободные руки на час еды, порядок подачи под готовые руки — раздел 20).

5. Сценарии.

Сценарий	Что требуется	Ожидаемый эффект (что измерим)	Стоимость в год, руб.
Минимальный			
Полный			

6. Просьба. Рассмотреть до «_» _____ 20 г. При отказе — просим письменного ответа для учёта в плане работы учреждения (письменный отказ — точка отсчёта на следующий год, раздел 38.6).

Приложения: формы замеров; расчёт; квартальная панель (приложение 35).

Директор _____ / _____ /

Приложение 34. Протокол разбора пищевого инцидента и жалобы

Назначение. Разобрать событие так, чтобы изменилась система, а не появился виноватый. Форма служит и регламентом разбора жалоб на питание, на который ссылаются разделы 32 и 33: жалоба разбирается в днях, а не в неделях. **Кто:** составляет ответственный по приказу (заместитель директора, старшая медсестра), с участием врача при клинических инцидентах; утверждает директор. **Сроки:** протокол — в течение 3 рабочих дней после инцидента; ответ заявителю на жалобу — в срок, установленный регламентом дома (рекомендуем не более 10 рабочих дней). Если дело дошло до представления прокурора, меры принимаются и сообщаются письменно в течение месяца (ст. 24 Закона о прокуратуре^[227]). **Опора:** разделы 10.2 и 10.7 (удушьё), 12 (отказ), 14 (пикацизм, заглатывание предметов), 18 (санитарный контур), 32–33 (проверяющий, ответственность). **Класс:** проект локальной формы.

Справка. Системный разбор. Подход, при котором вопрос звучит не «кто недосмотрел», а «как событие стало возможным». Английская служба здравоохранения в 2022 году заменила им прежнюю рамку «серьёзных инцидентов»: новая рамка реагирования на инциденты безопасности пациентов (PSIRF) ставит задачами «сочувственное вовлечение и участие тех, кого затронул инцидент», применение «системных подходов к извлечению уроков» и «взвешенное и соразмерное реагирование», а смысл её формулируется как сосредоточенность «на понимании того, как происходят инциденты, а не на поиске виноватых»^[266]. Это больничная рамка другой страны; в дом социального обслуживания переносится логика, а не процедура.

1. Что произошло. Дата, время, место, участники. Хронология — по записям журналов и постов, без согласования версий между сотрудниками.

2. Класс события (отметить):

☐ удушье / подозрение на аспирацию ☐ отказ от еды или воды с опозданием эскалации ☐ ошибка текстуры (выдана не та) ☐ массовое недомогание / подозрение на пищевую инфекцию ☐ посторонний предмет в блюде ☐ проглатывание несъедобного ☐ лекарственно-пищевое взаимодействие (передача, буфет) ☐ конфликт за столом ☐ срыв выбора (заказанное не выдано) ☐ жалоба жителя / семьи ☐ иное: _____

3. Немедленные меры. Что сделано, кем, когда. Врач: время вызова _____ время осмотра _____. Скорая: ☐ нет ☐ да, время _____. При подозрении на пищевую инфекцию — сохранены ли суточные пробы всех вариантов блюд: ☐ да ☐ нет (раздел 18.7).

4. Причина — звено цепочки (отметить и обосновать): ☐ продукт ☐ технология ☐ текстура / маркировка порции ☐ рассадка ☐ наблюдение / число рук ☐ передача сведений (смена, перевод, госпитализация) ☐ среда ☐ иное. Обоснование: _____

5. Условия, которые позволили событию произойти. Не «человеческий фактор» как стоп-слово, а условия: смена в одиночку, карта не обновлена после госпитализации, сведения о дисфагии не переданы при переводе, хлеб на общем столе у группы риска и т. п.

6. Корректирующие действия.

Действие	Ответственный	Срок	Как проверим исполнение	Отметка
				☐
				☐

7. Уведомления. Кто и когда проинформирован по установленному порядку (врач, законный представитель, учредитель, надзорный орган — если требуется). Сведения о здоровье в уведомлениях — только в объёме, допустимом по ст. 10 152-ФЗ (раздел 17.6).

8. Ответ заявителю (для жалоб): дата ответа _____; суть ответа _____; принято / не принято и почему _____.

9. Вывод для системы — одна строка: что меняется в регламентах, памятках, картах.

Составил: _____ Врач (для клинических событий): _____ Утвердил: директор _____

Приложение 35. Квартальная панель директора

Назначение. Свести на один лист числа, по которым видно, работает ли система питания, — для самопроверки, совета жителей и разговора с учредителем. Что измеряется, то существует; панель без плана на следующий квартал — отчёт, панель с тремя строками «что меняем» — инструмент управления (раздел 22.4). **Кто:** собирает заместитель директора или сотрудник, не связанный с питанием (раздел 22.8); клинические строки подписывает врач. **Когда:** раз в квартал, к первому заседанию совета жителей следующего квартала. **Опора:** раздел 22.4 (двенадцать чисел — канон второй редакции), 6 (живая карта контингента), 13.8 (вес), 21 (журналы). **Класс:** проект локальной формы.

Отличие от первой редакции. Состав двенадцати чисел приведён в соответствие с разделом 22.4. Показатели первой редакции, которых нет в этом перечне, сохранены в блоке Б как дополнительные; блок В собирает пять чисел «живой карты» контингента (раздел 6).

Учреждение _____ Квартал _____ 20__ г. Отделение / весь дом: _____

Блок А. Двенадцать чисел (раздел 22.4)

№	Показатель	Квартал	Предыдущий	Тренд ↑ ↓ =	Комментарий
1	Ночной интервал (ужин — завтрак), часы				
2	Доля несъеденных порций, % (замер — приложение 25)				
3	Блюда-аутсайдеры: три первых по остаткам				
4	Фактическое число кормимых на одного работника				
5	Температурная дельта «линия — последний стол», °С				
6	Соответствие текстур назначенным, % (по выборке)				
7а	Отказы от еды, эпизодов				
7б	Доля отказов, по которым эскалация к врачу прошла в срок, %				
8а	Жителей с прибавкой массы ≥ 5 % за квартал				
8б	Жителей с потерей массы по порогам MUST / Онтарио (5 % за 30 дн., 7,5 % за 90 дн., 10 % за 180 дн.) ^[27]				
9	Доля жителей с актуальной пищевой картой, %				
10	Доля выбравших вариант Б и не получивших его, %				
11	Сырьевая строка, руб. на жителя в день				
12а	Жалоб на питание				
12б	Доля жалоб с ответом в срок, % (приложение 34)				

Строки 8а и 8б — две разные задачи (метаболический риск и недостаточность питания). Категорию MUST присваивает медицинский работник, не кухня (раздел 22.4).

Блок Б. Дополнительные показатели (по решению дома)

№	Показатель	Квартал	Предыдущий	Комментарий
Б1	Доля жителей, реально выбирающих (не «стандарт по умолчанию»), %			
Б2	Отходы на порцию, г			
Б3	Замены по отказам, эпизодов			
Б4	Трудозатраты линии, мин на приём			
Б5	Инциденты по классам (приложение 34, п. 2)			
Б6	Выпито за сутки в группе риска, среднее, мл (приложение 40)			
Б7	Заседания совета жителей: проведено / запланировано			
Б8	Анкета удовлетворённости, средний балл 1–3 (приложение 36)			

Блок В. Живая карта контингента (раздел 6), обновляется раз в квартал

Сколько жителей	Число	Доля, %
едят сами		
едят с помощью		
не говорят или говорят мало		
в группе дисфагического риска (по списку, приложение 21)		
получают препараты, повышающие вес (по таблице врача, раздел 11)		

Три вывода квартала и что меняем (по одному предложению на строку; без плана панель остаётся отчётом):

- _____
- _____
- _____

Составил: _____ Врач (строки 6–8): _____ Директор: _____

Как читать тренд: один квартал против другого может отличаться случайно, особенно в отделении на 20–30 человек (раздел 21.3). Если строка ведётся ежемесячно, удобнее нанести её на график хода процесса^[237] и смотреть на серию, а не на две точки.

Приложение 36. Анкета жителей в доступном формате

Назначение. Услышать жителя напрямую — четвёртый канал обратной связи помимо журналов (раздел 21.5). Анкета используется и в пилоте: на второй неделе как опрос предпочтений в точке пилота (раздел 35.2), а далее раз в квартал. **Кто:** заполняет сам житель или сотрудник со слов жителя; лучше, если опрашивает человек, не раздающий еду этому жителю, — так меньше ответов «чтобы не обидеть». **Невербальные жители:** анкета не проводится; их канал — наблюдение (приложение 6). Ответ родственника или сотрудника за жителя записывается как ответ представителя, а не как ответ самого жителя: исследования показывают, что ответы жителей, их представителей и персонала о предпочтениях расходятся^[124]. **Формат:** крупный шрифт без засечек, одна мысль в строке, картинки к вопросам (правила доступного текста — приложение 38). **Класс:** проект локальной формы.

Дата: _____ Отделение: _____ Отвечал: ☐ сам житель ☐ с помощью сотрудника ☐ представитель за жителя (кто: _____)

1. Еда вам нравится? ☺ да 😊 так себе ☹ нет (обвести)
2. Что вы любите больше всего? _____
3. Что бы вы убрали из меню? _____
4. Вы можете выбрать, что хотите? ☐ всегда ☐ иногда ☐ никогда
5. Еды хватает? ☐ да ☐ хочется больше ☐ слишком много
6. Вам удобно есть? (шум, место, время, помощь) ☐ да ☐ мешает: _____
7. Вы можете попить, когда хотите? ☐ да ☐ не всегда ☐ нет
8. Есть еда, которую вы не едите по вере или убеждению? ☐ нет ☐ да: _____
9. Одно пожелание повару: _____

Обработка. Итоги вопросов 1, 4 и 7 — в панель (приложение 35, строка Б8, и при необходимости отдельной строкой). Ответы на вопросы 3, 8 и 9 — на ближайшее заседание совета жителей; администрация отвечает совету в течение 14 дней: что принято, что нет и почему (раздел 34.3). Ответы о вере и убеждении переносятся в пищевой паспорт (приложение 37, блок «Ограничения по убеждению») — с согласия жителя, так как это специальная категория персональных данных (раздел 17.6).

Отличие от первой редакции: шкала из трёх смайлов сохранена, баллы панели теперь 1–3 вместо 1–5; добавлены вопросы о питье (раздел 10.6) и об ограничениях по убеждению (раздел 15.10); введена отметка «кто отвечал».

Правила применения приложений

Сорок пять форм — единый комплект: наблюдение питает карты, карты — меню и закупки, журналы — панель, панель — сообщения учредителю. Порядок внедрения — по дорожной карте (раздел 36): сначала замеры (приложения 25–26) и карты (2–3, 6, 37), затем журналы (7–9) и алгоритмы (10–16), затем управленческий слой (17–24, 27–35) и памятки жителям и семьям (32,

38); санитарный блок (39–40, 45) и аутсорсинг (43–44) — по мере применимости. Отметка о статусе проекта локальной формы остаётся на каждой форме, пока она не утверждена локальным актом дома.

В первой редакции здесь говорилось о «38 формах»; к тому времени комплект уже включал 45 приложений. Номера приложений в разделах второй редакции сверены с их перечнем.

Новые источники

Полные записи и переводы — в реестре <raw/sources/poisk-2026-10-pril-c/istochniki.md>. Остальные маркеры раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
I- psirf_nhs	NHS England. Patient Safety Incident Response Framework (PSIRF), 2022 — заменила Serious Incident Framework (2015)

Приложения 37–38

Вторая редакция (октябрь 2026). Обе формы — **проекты локальных форм**, не нормативные документы (раздел 41). Структура первого тома сохранена; добавлены вводные, строки, которых требует вторая редакция, и пометки о доступе к персональным данным.

Приложение 37. Пищевой паспорт при поступлении

Назначение. Собрать на одном листе то, что иначе рассеяно по пяти журналам и двум историям: что человек любит, чего не ест и почему, как глотает, что с зубами, какие лекарства конфликтуют с едой, как меняется вес. Паспорт — входная дверь в индивидуальную пищевую карту (приложения 2–3) и в список дисфагического риска (приложение 21). **Кто:** заполняется при поступлении вместе с жителем; если он не может ответить — с опекуном или семьёй, с отметкой, кто давал сведения (иерархия источников воли — раздел 15.9). Клинические блоки заполняют медсестра и врач. **Когда обновляется:** при изменении состояния, после каждой госпитализации, при смене лекарственной схемы и не реже раза в год. **Владелец:** старшая медсестра. **Доступ:** полный — пост и врач; кухне передаются только функциональные ограничения («протёртое, уровень 4», «без молока», «постное по средам»), но не диагнозы (раздел 17.6). **Опора:** разделы 10 (дисфагия), 11 (лекарства и еда), 13.8 (вес), 15.10 (ограничения по убеждению), 16.10 (основание правового статуса), 17.6 (152-ФЗ). **Класс:** проект локальной формы; не заменяет медицинскую документацию.

ФИО _____ Дата поступления _____ Отделение _____ Сведения давали: ☐ сам житель ☐ опекун / попечитель ☐ семья ☐ документы ☐ наблюдение персонала

Блок	Что фиксируется	Кто заполняет	Заполнено / «данных нет»
Предпочтения	Любимые и нелюбимые блюда; привычное время еды и ритм дня; как предпочитает есть (ложка или вилка, своя кружка, тарелка-разделитель, нужна ли помощь); ритуалы	Житель + семья; каналы воли — раздел 15.3	☐ / ☐
Ограничения по убеждению	Пища, которую не ест по вере или убеждению (халяль, кашрут, вегетарианство); соблюдает ли посты. <i>Пост — волеизъявление, не диета (раздел 15.11). Для ПНИ право соблюдать пост прямо названо в ч. 2 ст. 37 Закона № 3185-1[8]. Запись — с согласия жителя (специальная категория данных, ст. 10 152-ФЗ[132])</i>	Житель / семья	☐ / ☐
Аллергии и непереносимости	Пищевые аллергии, целиакия, непереносимость лактозы — со слов и по документам; реакция при контакте	Житель / семья + врач	☐ / ☐
Глотание	Признаки дисфагии — да / нет по каждому: кашель или поперхивание при еде; «влажный» голос после глотка; многократное глотание одного куска; долгое жевание без глотка; еда за щекой; подтекание изо рта; отказ от твёрдой или сухой пищи; повторные пневмонии (раздел 10.4). При сомнении — GUSS или EAT-10 по решению врача, с записью балла и даты[62, 63]	Медсестра	☐ / ☐

Блок	Что фиксируется	Кто заполняет	Заполнено / «данных нет»
Риск удушья	Быстрое заглатывание, отбирание еды, приём нескольких антипсихотиков, эпизоды удушья в прошлом (разделы 9, 10.2, 14). Если риск есть — отметка в списке приложения 21 и инструкция по опасным продуктам: хлеб, сухое, крупные куски, суп с кусочками — только в назначенной форме (раздел 10.7)	Медсестра + врач	☐ / ☐
Назначенная текстура	Уровень IDDSI пищи ___ и напитков ___; кем назначено ____; дата пересмотра ____ (назначает только врач)	Врач	☐ / ☐
Полость рта	Свои зубы / протезы (подходят ли); «болит ли жевать»; сухость во рту; дата последнего осмотра стоматологом	Медсестра	☐ / ☐
Лекарства × еда	Препараты из таблицы раздела 11 (клозапин и кофеин, литий и соль с водой, ИМАО и тирамин, грейпфрут); что из этого следует для буфета и передач; инсулин и фиксированное время еды (раздел 13.12)	Врач	☐ / ☐
Вес и статус питания	Вес и рост при поступлении; ИМТ; динамика за последние 3–6 месяцев, если известна; пороги для сообщения врачу — прибавка $\geq 5\%$ за квартал (раздел 13.8) и потеря 5% за 30 дней, $7,5\%$ за 90 дней, 10% за 180 дней[27]; скрининг MUST — медицинский работник (раздел 22.4); аппетит по шкале 1–5	Медсестра	☐ / ☐
Питьевой режим	Обычный объём за сутки; любимые напитки; ограничение жидкости — только по назначению врача; при загущённых напитках — уровень IDDSI и фактически выпитое (приложение 40)	Медсестра + кухня	☐ / ☐
Стул	Регулярность; входит ли в группу антихолинергической нагрузки (по отметке врача). Для этой группы — ежедневная строка «стул: да / нет» в постовом журнале; трое суток без стула — сообщение врачу в тот же день (раздел 13.10)	Пост	☐ / ☐
Основание правового статуса	☐ дееспособен ☐ ограниченно дееспособен (п. 2 ст. 30 ГК) ☐ недееспособен (ст. 29 ГК)[116]; дата ближайшего освидетельствования по ч. 3 ст. 43 Закона № 3185-1[8] _____. <i>Строка с ограниченным доступом: кухне не передаётся (разделы 16.10, 17.6)</i>	Юрист / социальный работник	☐ / ☐
Передача сведений	При переводе в другое отделение, госпитализации и выписке дисфагический риск, назначенная текстура и риск удушья вносятся в сопроводительные документы[55]; дата и кому передано: ____	Пост	☐ / ☐

Правило формы. Каждая строка заполнена или помечена «данных нет» — пустых строк не бывает. «Данных нет» по блоку «Глотание» у человека, который не может описать свои ощущения, — повод для наблюдения за едой в первые дни, а не для вывода «дисфагии нет».

Заполнил: _____ Врач: _____ Дата: _____ Следующий пересмотр: _____

Отличия от первой редакции. Добавлены строки «Риск удушья», «Назначенная текстура», «Основание правового статуса» (по разделу 16.10: в первой редакции ему ошибочно назначалась «карта дееспособности — приложение 37») и «Передача сведений» (раздел 10.4, 10.7). Ссылка на весовые пороги исправлена: в первой редакции стояло «раздел 26», во второй пороги изложены в разделе 13.8, а онтарийская рамка — в разделе 26.4. Признаки дисфагии перечислены поимённо, а не как «шесть признаков».

Приложение 38. Памятка для жителей «Моя еда — мой выбор» (лёгкое чтение)

Назначение. Сказать жителю на понятном ему языке, какие у него права за столом и что делать, если что-то не так. **Формат.** Лёгкое чтение (*easy read*): короткие фразы, одна мысль в строке, картинка рядом с каждой мыслью, шрифт без засечек не мельче 14 пунктов, без процентов и трудных слов. Европейские правила лёгкого чтения требуют ещё одного: привлекать людей с интеллектуальными нарушениями к созданию и проверке текста — «они могут участвовать в проверке того, насколько информацию легко понять»[267]. Английский стандарт доступной информации обязывает службы предоставлять сведения в формате, который человек может понять[268]. Для российского дома это рекомендация, а не норма; практический вывод — показать черновик памятки двум-трём жителям из совета до печати. **Где:** лист А4 с двух сторон; лист 1 — в столовой и в руки при поступлении; лист 2 — на раздаче и на посту постельных. Пиктограммы — под контингент дома: фотографии своих блюд и своей столовой работают лучше абстрактных значков. **Опора:** разделы 15 (невербальный выбор), 20.11 (выбор вне линии), 10 (дисфагия), 15.10 (вера), 34 (совет жителей). **Класс:** проект локальной формы.

Лист 1. Моя еда — мой выбор

1. Каждый день вам показывают меню. Меню — это список еды.
2. Вы можете сказать: «Хочу это». Вы можете сказать: «Не хочу это».
3. Если вам трудно говорить — вам покажут две тарелки. Покажите пальцем.
4. Вы не останетесь голодным. Всегда будет другая еда.
5. Вы едите в комнате? Вам тоже принесут две тарелки. Покажите, какую хотите.
6. Трудно глотать? Кашляете, когда едите? Скажите персоналу. Вам помогут.
7. Болит, когда жуёте? Скажите персоналу. Вас посмотрит врач.
8. Вы можете пить воду, когда хотите. Попросите пить.
9. Есть еда, которую вы не едите по вере? Скажите. Мы запишем.
10. Вы держите пост? Скажите. Вам дадут постную еду.
11. Ваше мнение важно. Совет жителей говорит о еде. Вы можете прийти.
12. Что-то не так с едой? Вы можете пожаловаться. Это ваше право. Вам ответят.

Оборот листа 1. Куда пожаловаться

Кому	Где	Как
Ответственный за питание: _____	Кабинет ____	Сказать или написать
Совет жителей	Ящик для записок у столовой	Положить записку (можно без имени)
Директор: _____	Кабинет ____	Написать
Телефон доверия учредителя		_____

Лист 2. Сегодня я выбираю (рабочий лист на один приём пищи, не «навсегда»)

Сегодня: ☐ завтрак ☐ обед ☐ ужин Дата: _____

Покажите пальцем или положите метку.

	Еда А	Еда Б	Не хочу ни ту, ни другую
Картинка / название	_____	_____	Принесут другую еду (по таблице замен)
Мой выбор	☐	☐	☐

Вы ничего не отметили? Вам принесут обычную еду. Это нормально. Выбирать не обязательно.

Кто спросил: _____ Кто принял заказ: _____

Правила листа 2. Лист — заказ на один приём пищи, а не медицинский документ: в нём нет диагноза и назначенной текстуры, он не вывешивается в коридоре с фамилиями (раздел 17.6). Для жителя на изменённой текстуре оба варианта готовятся в назначенной текстуре: выбор идёт внутри текстуры, а не вместо неё (раздел 10.10). Заполненные листы хранятся на посту до конца дня и переносятся в журнал заказа (приложение 7).

Отличия от первой редакции. Добавлены строки о кашле при еде и о посте; оборот листа 1 оформлен таблицей; добавлено правило о выборе внутри назначенной текстуры. Варианты названы «Еда А / Еда Б» вместо «Вариант А / Б»: слово «вариант» для лёгкого чтения трудное.

Новые источники

Полные записи и переводы — в реестре <raw/sources/poisk-2026-10-pril-c/istochniki.md>. Остальные маркеры раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
I-easyread_ie	Inclusion Europe. Information for all: European standards for making information easy to read and understand (проект Pathways, ок. 2010)

Приложения 39–42

Вторая редакция (октябрь 2026). Все четыре формы — **проекты локальных форм**, не нормативные документы (раздел 41). Ссылки на СанПиН 2.3/2.4.4282-26 сверены по тексту правил в реестре `poisk-2026-10-blok-c` и дополнительно (пп. 56, 59, 60, 62) при подготовке этих приложений; где сверки не было, это сказано прямо.

Приложение 39. Чек-лист перепривязки документов к СанПиН 2.3/2.4.4282-26

Назначение. Проверить, что положение о питании, программа производственного контроля, журналы и договоры ссылаются на действующие санитарные правила, и ничего не забыть. **Кто:** заведующий производством (шеф-повар, диетсестра) по приказу директора; итог подписывает директор. **Когда:** к 01.09.2026 — как требование готовности; для домов, которые этого не сделали, — немедленно; далее при каждом изменении правил и при смене модели питания (свой пищеблок или аутсорсинг). **Опора:** разделы 18.1, 18.2, 18.7, 18.10 (переходный месяц), 42.2 (аутсорсинг). **Класс:** проект локальной формы.

Правовая рамка. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утверждён постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18 (по записи S003 зарегистрирован в Минюсте 02.06.2026 № 86854; регистрация в проверке 2026-10 не подтверждена и не опровергнута). Правила действуют с 01.09.2026 до 01.09.2032; постановление № 32 об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и изменяющее его постановление от 22.08.2024 № 9 утратили силу с той же даты[9].

Исправление первой редакции. В первой редакции говорилось, что даты семинара (25–27.08.2026) «попадают в переходный период». Переходного периода нет: постановление № 18 не предусматривает поэтапного перехода или отсрочки, и с 01.09.2026 новые правила применяются в полном объёме (раздел 18.10, 41.6). Журналы до 31.08.2026, заполненные по формам СанПиН 3590-20, законны в том виде, в каком велись, и **задним числом не переписываются:** «переоформление» августа под новые формы выглядит как подлог.

№	Требование	Где в СанПиН 4282-26	Действие в учреждении	Ответственный	Сделано
1	Питание проживающих в стационарной СОСО — не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям	п. 56 подп. 11[9]	Перепривязать положение о питании (раздел 31.2); проверить формулировки меню		☐
2	Выдача блюд только после снятия пробы; журнал бракеража; при нарушении технологии или неготовности блюдо не выдаётся до устранения недостатков	п. 56 подп. 3, 13; образцы журнала — приложения 4 и 5[9]	Ввести журналы по новым образцам с 01.09.2026; обучить ответственных за бракераж		☐

№	Требование	Где в СанПиН 4282-26	Действие в учреждении	Ответственный	Сделано
3	Суточная проба: от каждой партии, отдельно каждое блюдо; холодные закуски, первые блюда, гарниры, напитки — не менее 100 г; порционные — целиком; хранение не менее 48 часов после окончания срока реализации при +2...+6 °С	п. 56 подп. 4; для готовых блюд от общепита — подп. 12 со ссылкой на подп. 4 ^[9]	Инструкция по пробам: проба каждого варианта с маркировкой «вариант А / Б» (раздел 18.7). Для собственного пищеблока прямой формулировки нет — отбор по подп. 4 рекомендуется как толкование		☐
4	При получении готовых блюд от предприятия общественного питания — помещение для приёма готовой продукции и отбора суточных проб	п. 56 подп. 12 ^[9]	Выделить помещение; назначить ответственного работника (чьего — учреждения или подрядчика — норма не уточняет; раздел 42.2)		☐
5	Требования п. 56 распространяются на привлекаемые предприятия общественного питания	п. 56 подп. 14 ^[9]	Пункт в договоре аутсорсинга (приложение 43, раздел 42)		☐
6	Кейтеринг: внутренний порядок исполнителя, прослеживаемость изготовления, перевозки, хранения и реализации, разграничение ответственности; вскрытие упаковок и порционирование — в отдельном помещении или выделенной зоне; маркировка изотермических ёмкостей	раздел VI (пп. 51–55) ^[9]	Строка в договоре; проверка маркировки и зоны при приёме		☐
7	Температура блюд и напитков, реализуемых через раздачу, — по технологическим документам (фиксированных градусов правила не называют)	п. 50 ^[9]	Термометры на линии и на последнем столе; сверка с технологическими картами; строка 5 панели (приложение 35)		☐
8	Готовые блюда, требующие разогрева, — не более 3 часов на раздаче; холодные блюда и напитки — только в охлаждаемом оборудовании; запрет реализации на следующий день и заморозки нереализованного	п. 32 ^[9]	Вторая гастроёмкость — меньшего объёма с пополнением (раздел 18.2, 18.9); правила буфета (раздел 18.8)		☐
9	К приготовлению, порционированию и раздаче не допускаются лица, в чьи обязанности это не входит	п. 32 ^[9]	Внести раздачу в должностные инструкции санитаров и помощников по уходу, которые раздают в отделениях (раздел 18.2)		☐
10	Питьевой режим: вода по обязательным требованиям; фонтанчики — ежедневная обработка чаши; кулеры — мойка не реже 1 раза в 7 дней, дезинфекция не реже 1 раза в 3 месяца; кипячёная вода — кипячение не менее 5 минут, смена не реже чем через 3 часа; посуда — из расчёта числа обслуживаемых	п. 62 (распространяется в том числе на организации социального обслуживания) ^[9]	Графики обработки кулеров и смены кипячёной воды; ведомость питьевого режима (приложение 40)		☐

№	Требование	Где в СанПиН 4282-26	Действие в учреждении	Ответственный	Сделано
11	Программа производственного контроля; для предприятий общественного питания — на принципах ХАССП	п. 4[9]	Актуализировать программу к новым пунктам. Обязательность ХАССП для пищеблока СОСО официально не разъяснена (раздел 18.10); для привлечённого оператора-общепита требование действует		☐
12	Документы дома: положение о питании, памятка пищеблоку, чек-листы (приложения 18–20), договоры	—	Заменить ссылки «3590-20» на пункты 4282-26 в действующих формах; архив августа не трогать		☐

Порядок действий.

1. Сверить действующие документы дома с таблицей; каждое «нет» — строка с ответственным и сроком.
2. С 01.09.2026 (или сразу, если срок пропущен) вести журналы по новым формам; августовские журналы оставить как есть.
3. Обновить памятку персоналу пищеблока и провести короткий инструктаж о том, что изменилось в формах, а что осталось прежним.
4. Уведомить учредителя одной страницей: что меняется, что остаётся, что дом уже сделал.

Модель выбора при перепривязке не меняется: ни одна редакция санитарных правил не ограничивает число вариантов блюд (раздел 18.1).

Проверил: _____ Дата: _____ Директор: _____

Приложение 40. Питьевой режим: ведомость учёта и санитарные требования

Назначение. Видеть, сколько пьют люди, которые сами не попросят: лежащие, жители на загущённых напитках, люди с выраженными когнитивными нарушениями, все — в жару и при ОРИ. **Кто:** ведёт пост отделения; итог за сутки проверяет старшая смены; среднее по группе риска раз в месяц переносится в панель (приложение 35, строка Б6). **Когда:** ежедневно для группы риска; для всех — в жаркий период и при вспышках (приложение 45). **Опора:** разделы 10.6 (жидкости и загущение), 12.3 (отказ от воды — немедленно), 11.3 (литий, соль и вода), 18.11 (ОРИ). **Класс:** проект локальной формы; объёмные ориентиры — не норматив.

Правовая рамка. Пункт 62 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 устанавливает требования к питьевому режиму в детских организациях, медицинских организациях и организациях социального обслуживания: вода должна соответствовать обязательным требованиям; режим организуется через стационарные фонтанчики, устройства выдачи воды, упакованную или кипячёную воду; кулеры моются не реже раза в 7 дней и дезинфицируются не реже раза в 3 месяца; кипятят не менее 5 минут и меняют воду не реже чем через 3 часа[9]. Требования к качеству воды — по главе III СанПиН 1.2.3685-21, главе IV СанПиН 2.1.3684-21 и ТР ЕАЭС 044/2017 (перечень по записи S003 первой редакции; в 2026-10 не перепроверялся). До 01.09.2026 действовали аналогичные требования СанПиН 3590-20.

Клинический смысл. Низкое потребление жидкости — частый и недооценённый дефицит у пожилых[269]. Загущённые напитки снижают потребление, а убедительных данных о том, что их рутинное применение снижает число респираторных осложнений, нет (раздел 10.6)[71]. Рекомендации по гидратации в гериатрии — в руководстве ESPEN и в руководстве для учреждений длительного ухода[270, 271].

Ведомость «Выпито за сутки»

Отделение _____ Дата _____ Единица учёта: ☐ стакан 200 мл ☐ маркированная кружка __ мл

Житель	Группа риска*	Утро (до 12:00)	День (12–18)	Вечер (18–22)	Ночь	Итого за сутки, мл	Признаки**	Сообщено врачу (время)

* Группа риска: Л — лежащий; З — загущённые напитки (уровень IDDSI __); К — выраженные когнитивные нарушения; Li — литий (раздел 11.3); О — ограничение жидкости по назначению врача (объём __ мл).

** Признаки, при которых нужна запись и сообщение врачу: тёмная моча; сухость языка; сонливость или спутанность вне обычного режима; снижение тургора кожи; отказ от воды. Важно: по данным обзора, клинические признаки малоинформативны для диагностики обезвоживания, надёжен только лабораторный метод (осмоляльность сыворотки)[269]. Постовые признаки — повод к эскалации, а не диагноз. **Отказ от воды или от еды и воды вместе — врач немедленно** (раздел 12.3).

Правила ведомости.

1. **Ориентир объёма** для взрослых без ограничений — не менее 1,6 л жидкости в сутки для женщин и 2,0 л для мужчин (рекомендация ESPEN по гидратации в гериатрии)[270]. Ориентир индивидуален; при сердечной, почечной патологии и иных показаниях объём и любое ограничение питья устанавливает только врач.
2. **Питьё между приёмами пищи** предлагается активно — особенно лежачим, в жару и при ОРИ. Чайная пауза — полноценное пищевое событие, а не «по просьбе».
3. **На загущённых напитках** записывается фактически выпитое, а не налитое. Уровень загущения назначает и пересматривает врач (раздел 10.6). Протокол свободной воды — только по решению врача и только при гигиене полости рта перед водой.
4. **Санитарный блок** (по п. 62): график мойки и дезинфекции кулеров ведётся рядом с ведомостью; кипячёная вода меняется не реже чем через 3 часа; кружки — из расчёта числа жителей, чистая и использованная посуда — на разных подносах[9].

Кулер / ёмкость (место)	Мойка (не реже 1 раза в 7 дней): дата, подпись	Дезинфекция (не реже 1 раза в 3 месяца): дата, подпись

Отличия от первой редакции. Ссылка на «чайную паузу как шестое пищевое событие (раздел 10.7)» снята: во второй редакции раздел 10.7 этого понятия не содержит, жидкостям посвящён раздел 10.6. Применимость п. 62 к организациям социального обслуживания подтверждена по тексту правил. Добавлены графы группы риска и времени сообщения врачу, строка об отказе от воды и график обработки кулеров.

Приложение 41. Детские учреждения (ДДИ): что переносится, что нет

Назначение. Подсказка руководителям детских домов-интернатов и смешанных организаций: какие элементы модели выбора переносятся в детский контур, а какие требуют отдельной правовой и педиатрической проработки. Доклад и семинар — о взрослых; детский контур в нём не разработан (раздел 23), и этот лист — граница переноса, а не педиатрическое руководство. **Кто пользуется:** руководитель, врач-педиатр, диетолог учреждения. **Класс:** проект локальной формы; толкование, не норма.

Блок	Переносится	Не переносится / требует адаптации
Вариативность и выбор	Принцип «не менее двух вариантов»; визуальное меню; наблюдение за невербальным выбором (раздел 15); IDDSI и текстуры (раздел 10) — IDDSI создана в том числе для детей, а российская детская практика уже описывает консистенции по уровням IDDSI[66]	Возрастные форматы меню и порций; педиатрический контур вместо терапевтического; участие законных представителей

Блок	Переносится	Не переносится / требует адаптации
Учёт мнения ребёнка	Каналы воли и поддержанное решение (разделы 15.2–15.3)	Своя правовая рамка: ребёнок вправе выражать мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его интересы, а мнение ребёнка, достигшего десяти лет, обязательно учитывается, если это не противоречит его интересам (ст. 57 Семейного кодекса РФ) ^[272] . Норма адресована семье, суду и органам опеки; перенос на выбор блюд в учреждении – толкование. Режимы дееспособности раздела 16 к детям не применяются
Нормы питания	Логика пар эквивалентов внутри нормы (раздел 19)	Детские наборы продуктов приказа Минтруда № 520Н ^[38] ; для организованных детских коллективов – раздел VIII СанПиН 4282-26: меню не менее чем на две недели, утверждаемое руководителем, основное и индивидуальные меню (п. 59); приложения о нормах, пищевой ценности и замене продуктов (№ 7, 10, 11) и перечень продукции, не допускаемой для детей (№ 6) ^[9] – <i>содержание приложений при проверке не открывалось</i>
Лечебное и диетическое питание	Правило «текстуру и диету назначает врач»	Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, индивидуальное меню разрабатывает диетолог по назначению лечащего врача; выдача – по утверждённому индивидуальным меню под контролем ответственных лиц (п. 60 СанПиН 4282-26) ^[9]
Санитарные требования	Суточные пробы, бракераж, температурный контроль, питьевой режим (п. 62 – общий для детских и социальных организаций)	Готовые блюда реализуются не позднее 2 часов с момента изготовления (п. 59) ^[9] ; общие требования к детским организациям – СП 2.4.3648-20 (постановление ГГСВ РФ от 28.09.2020 № 28) ^[273]
Права и процедура	Совет жителей → детский совет или опрос по возрасту; доступный формат (приложение 38)	Органы опеки, законные представители, возраст согласия; родительские передачи и домашние блюда – по правилам п. 60 и локального акта

Отличие от первой редакции. Добавлена строка о мнении ребёнка (ст. 57 СК РФ) и уточнено содержание пп. 59–60 и 62 СанПиН 4282-26 по тексту правил; ссылка на «п. 60» как на общее диетическое питание детей уточнена – он касается детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании.

Приложение 42. Калькулятор стоимости вариативности: инструкция

Назначение. Посчитать, сколько стоит пара эквивалентов и сколько денег уходит в бак, — чтобы разговор с учредителем шёл по строкам, а не «общей цифрой» (разделы 29.3, 29.9, 29.11). **Кто:** экономист или бухгалтер вместе с заведующим производством; данные отходов — из замера (приложение 25). **Когда:** до пилота, через 90 дней и при каждой смене контракта или закупочных цен. **Класс:** проект локальной формы. Файл «Калькулятор_стоимости_вариативности.xlsx» в репозитории второй редакции не найден; если файла нет, четыре листа строятся по описанию ниже в любой таблице.

Лист 1. «Пары блюд». Для каждого варианта пары: норма закладки (г на порцию) × закупочная цена (руб. за кг) ÷ 1000 = стоимость порции. Разница вариантов — на порцию и в месяц (× число порций). Проверка: пара — это эквиваленты внутри нормы, а не «дорогое против дешёвого» (раздел 19.9).

Блюдо	Вариант	Сырьё	Закладка, г	Цена, руб./кг	Стоимость порции, руб.	Порций в месяц	Итого, руб./мес.
	А						
	Б						

Лист 2. «Отходы». Масса тарелочных остатков на порцию (г) × число порций × цена сырья = строка «выброшенных денег». Кухонные и тарелочные остатки считаются отдельно: первые говорят о планировании объёмов, вторые — о вкусе, размере порции и состоянии жителей (раздел 29.11). Методика замера — приложение 25.

Лист 3. «Сценарии отходов». Снижение отходов на 10 / 20 / 30 % — это гипотеза. Подтверждается она только повторным замером через 90 дней (раздел 29.5). Зарубежные данные о меньших отходах при заказе блюд получены в больницах, а не в домах постоянного проживания, и переносятся только как гипотеза[201]; для учреждений длительного ухода интервенционных исследований единицы[149].

Лист 4. «Два сценария». (1) Собственный пищеблок: пара эквивалентов внутри нормы, дополнительные затраты — маркировка, вторая гастрорёмкость, время раздачи (раздел 28.11). (2) Аутсорсинг: две позиции в техническом задании вместо монопозиции, группы взаимозаменяемых позиций, отчётность поставщика (приложение 43, раздел 42.3).

Правила. Жёлтые ячейки — ввод, остальные — формулы. Цифры на листах 1–2 в файле-образце — учебные заглушки, а не себестоимость конкретного дома и не экономика Серафимовского. Иллюстрация раздела 29.11 (дом на 150 жителей, 80 г отходов на порцию, три приёма пищи — около 36 кг в день) тоже условна.

Маркировка: калькулятор считает гипотезу, а не доказывает её. Формула доклада — «замер до и после» — обязательна.

Новые источники

Полные записи и переводы — в реестре <raw/sources/poisk-2026-10-pril-c/istochniki.md>. Остальные маркеры раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
S150	Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, ст. 57 «Право ребёнка выражать своё мнение»
S003 (проверка)	СанПиН 2.3/2.4.4282-26: п. 56 подп. 11, п. 59, п. 60, п. 62 — по тексту правил

Приложения 43–44

Вторая редакция (октябрь 2026). Обе формы — **проекты локальных форм**, не нормативные документы (раздел 41). Они переносят восемь строк раздела 42.3 в заполняемый шаблон и в письмо учредителю. Перед использованием их нужно согласовать с контрактной службой: режим закупки (44-ФЗ или 223-ФЗ) у домов разный (разделы 30.1, 42.2).

Приложение 43. Спецификация вариативности для контракта аутсорсинга (форма восьми строк)

Назначение. При аутсорсинге выбор переезжает из кухни в техническое задание, спецификацию, приёмку и отчётность подрядчика (раздел 42). Эта форма — восемь строк, без которых вариативность в контракте остаётся декларацией. **Кто:** готовит директор с заведующим производством и врачом (строка 5); формулировки выверяет контрактная служба. **Когда:** до публикации закупки — по календарю раздела 42.7; для действующего контракта — через дополнительное соглашение, если его условия позволяют изменить контракт (ст. 95 44-ФЗ^[222]), а не через «переторжку». **Как прикладывается:** приложение к контракту вместе с циклом меню и раскладкой. Распечатка А4 — на стол директора. **Опора:** разделы 19, 21, 22, 30.8, 42.2–42.4. **Класс:** проект локальной формы; требует адаптации под 44-ФЗ^[249] или положение о закупке по 223-ФЗ.

Как формулировать. Статья 33 44-ФЗ требует описывать объект закупки через функциональные, технические и качественные характеристики и не допускает требований, ведущих к ограничению числа участников^[251]. Поэтому каждая строка ниже сформулирована как измеримая характеристика услуги, а не пожелание и не условие, которое под силу одному поставщику. Опорой для характеристик продукции может служить ГОСТ 30390-2013^[252].

№	Строка контракта	Формулировка для спецификации (адаптировать)	Как проверяет учреждение	Основание
1	Перечень позиций	Группы взаимозаменяемых позиций (например, «крупы гарнирные: гречневая, рисовая, пшённая»), а не монопозиции	Сверка заявки с группами	Разделы 19, 42.3
2	Пропорции	Пропорции вариантов внутри группы — по статистике выбора учреждения; корректировка раз в квартал без изменения существенных условий контракта	Квартальная заявка по журналу заказа (приложение 7)	Разделы 21, 42.3
3	Гарантия выбора	На приёмах пищи с заявленной вариативностью — не менее двух вариантов основных позиций; срыв выбора фиксируется в журнале замен и не считается надлежащим исполнением	Журнал срывов (приложение 8); строка 10 панели	Раздел 42.3
4	Замены при недопоставке	Эквивалент из той же группы по согласованию с учреждением; двусторонний акт в день замены	Акт замены; сверка с группой	Разделы 19, 42.3
5	Качество для текстур	Характеристики полуфабрикатов, значимые для текстур (степень измельчения, консистенция), — в спецификации качества, измеримо; позиции для жителей с дисфагией — отдельным пунктом; при изменённых текстурах — соответствие уровням IDDSI по назначениям учреждения	Выборочная проверка текстур (строка 6 панели)	Раздел 10; ст. 33 44-ФЗ ^[251]

№	Строка контракта	Формулировка для спецификации (адаптировать)	Как проверяет учреждение	Основание
6	Приёмка и пробы	Ответственный от учреждения; форма акта приёмки; место и процедура отбора суточных проб – помещение для приёма готовой продукции; проба каждого блюда и каждого варианта отдельно, не менее 100 г, хранение не менее 48 ч при +2...+6 °С	Акт приёмки; журнал проб	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 4, 12, 14[9]; до 01.09.2026 – СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11–7.1.14
7	Состав и нормы	Цикл меню с раскладкой и массой порций – приложение к контракту; соответствие нормам питания (региональный акт; федеральный ориентир – приказ Минтруда № 520н)	Сверка раскладки с меню	[38]; раздел 24
8	Отчётность	Ежемесячно: доля выбора по позициям, остатки по блюдам, журнал замен – для панели показателей учреждения	Ежемесячный отчёт; квартальный разбор с поставщиком	Разделы 22, 42.4

Что нельзя отдать строкой технического задания (отдельная строка в ТЗ: «остаётся за заказчиком»). Исполнение передаётся, ответственность — нет (раздел 42.3):

- ☐ контроль отбора и хранения суточных проб (норма п. 56 подп. 12 говорит об «ответственном работнике пищеблока» без уточнения, чей он; безопаснее закрепить контроль за работником учреждения в контракте и приказе — раздел 42.2);
- ☐ бракераж при приёмке готовой продукции — акт учреждения;
- ☐ список дисфагического риска и назначенные текстуры — врач и пост;
- ☐ маршрут эскалации отказа от еды (раздел 12);
- ☐ лекарственно-пищевые ограничения (раздел 11) — передаются поставщику только как функциональные ограничения, без диагнозов (раздел 17.6).

Фотофиксация приёмки: линия, маркировка, термометр. Лица жителей в кадр не попадают; сведения о здоровье защищены 152-ФЗ (раздел 17.6).

Рычаги в контуре 44-ФЗ. Мониторинг исполнения, акты, претензии, при существенном нарушении — односторонний отказ от исполнения контракта и включение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков (раздел 42.4). Для домов Санкт-Петербурга это прямо требует письмо Комитета по социальной политике[253]; в других регионах — по позиции своего учредителя. Основания и сроки сверяются с действующей редакцией закона.

Отличия от первой редакции. В строке 6 уточнена ссылка на СанПиН 3590-20 («п. 7.1» → «п. 7.1.11–7.1.14») и добавлен подп. 4 п. 56 СанПиН 4282-26, где изложен порядок отбора проб; оговорено, что принадлежность «ответственного работника пищеблока» норма не уточняет. В строке 2 «без изменения предмета контракта» заменено на «без изменения существенных условий контракта» (раздел 42.3). Добавлены графа «Как проверяет учреждение», пятый пункт негативного списка и абзац о правилах ст. 33 44-ФЗ.

Приложение 44. Письмо учредителю о пилоте вариативности при аутсорсинге (шаблон)

Назначение. Получить санкцию учредителя на строки выбора в спецификации — у действующего поставщика (дополнительным соглашением) или в новой закупке. **Кто:** директор; расчёты и форму восьми строк готовят контрактная служба и заведующий производством. **Когда:** не позднее чем за 30 дней до срока планирования закупки; лучше — по календарю раздела 42.7 (осень для закупок первого полугодия). **Объём:** одна страница. **Опора:** разделы 38.5 (одностраничная справка, письменный ответ), 38.6 (работа с отказом), 42, 29.9. Для дома со своей кухней и для просьбы о ставках служит приложение 33. **Класс:** проект локальной формы.

Исх. № _____ от «_» _____ 20 г.

(должность, ФИО руководителя учредителя)

Уважаемый(ая) _____!

Государственное учреждение «_____» (стационарная форма социального обслуживания, _____ мест; питание по контракту № _____ с _____, срок действия до _____) просит согласовать включение в спецификацию закупки услуг питания следующих позиций:

1. группы взаимозаменяемых позиций вместо монопозиций;
2. гарантия не менее двух вариантов основных блюд на приёмах пищи с заявленной вариативностью; срыв выбора фиксируется поставщиком и не считается надлежащим исполнением;
3. порядок замен при недопоставке — эквивалентом из той же группы с актом;
4. ежемесячная отчётность поставщика о доле выбора и остатках по блюдам.

Обоснование. Санитарные правила не ограничивают число вариантов блюд (СанПиН 2.3/2.4.4282-26[9]; раздел 18.1); федеральные нормы питания носят рекомендательный характер, а региональные нормы устанавливаются актом субъекта _____ [38, 205]. Выбор при своей кухне и при аутсорсинге совпадает по содержанию: журналы, замеры, гарантия стандартного варианта. Различается место фиксации — контракт. Контроль проб, бракераж при приёмке, текстуры для жителей с дисфагией и маршрут при отказе от еды остаются за учреждением.

Расходы. По сырьевой строке пары эквивалентов, как правило, сопоставимы; меняются спецификация и отчётность. Это не обещание «пилота без затрат»: обучение смены, маркировка, весы, иногда посуда и ставки — отдельные строки. Если они понадобятся, мы направим отдельное письмо с расчётом, а не спрячем их за формулой «финансирование не запрашиваем».

Что мы покажем через квартал: доля выбора по позициям, остатки в граммах и рублях до и после (замер 7 дней), число срывов выбора и жалоб (квартальная панель, приложение 35).

Просим согласовать до «_» _____ 20 г. (срок планирования закупки на 20_ год). В случае отказа просим письменного ответа с указанием оснований — для учёта в плане работы учреждения.

Приложения:

1. Форма восьми строк (приложение 43).
2. Квартальная панель учреждения за последний квартал.
3. Проект графика перехода.
4. Результаты семидневного замера отходов (при наличии).

С уважением, директор _____ / _____ /

Отличия от первой редакции. Добавлены реквизиты действующего контракта, абзац «что мы покажем через квартал» (десятый слайд раздела 29.9: учредитель охотнее соглашается, когда ему заранее обещают отчёт), просьба о письменном отказе (раздел 38.6) и ссылка на региональный акт о нормах питания (приказ Минтруда № 305н отсылает нормы питания к актам субъекта[205]).

Справочно: в разделе 4.5 второй редакции шаблоном письма-уведомления учредителю названо «приложение 32»; по смыслу это приложение 44 (при аутсорсинге) или письмо по образцу приложения 33 (при своей кухне), а приложение 32 — памятка родственникам.

Приложение 45. План Б: питание при закрытии столовой

Назначение. Ответить заранее, на одной странице, на вопросы, которые иначе всплывут в восемь утра первого дня вспышки: кто разносит, на чём, сколько рук, что даём, если не вышла кухня или не приехал поставщик. Выбор в кризис не отменяется — меняется его форма (раздел 18.11). **Кто:** готовит заместитель директора по АХЧ вместе со старшей медсестрой и заведующим производством; подписывает руководитель. **Когда:** подписывается до вспышки, а не утром закрытия; пересматривается не реже раза в год и после каждой вспышки. **Опора:** разделы 18.11 (карантин и ОРИ), 20.11 (поднос для постельных), 18.8 (буфет), 10.6 и приложение 40 (питьё), 42 (аутсорсинг). **Класс:** проект локальной формы. Не заменяет санитарных предписаний и указаний врача-эпидемиолога по конкретному карантину.

Методическая рамка. В период COVID-19 Минтруд России рекомендовал стационарным организациям социального обслуживания усиленный питьевой режим, раздачу в жилые комнаты и дезинфекционный контур^[144]; базовые методические рекомендации Минтруда по организации питания требуют профилактики витаминной недостаточности и санитарной безопасности^[145]. Зарубежные рекомендации по вспышкам норовирусной инфекции в медицинских учреждениях добавляют три правила, прямо касающиеся питания: работники, которые готовят или раздают пищу, при симптомах острого гастроэнтерита отстраняются и возвращаются к этой работе не ранее чем через 48 часов после исчезновения симптомов; на время вспышки из клинических зон убирают все общие продукты для пациентов и персонала; групповые трапезы стоит приостановить^[274]. Это американские больничные рекомендации; в российском доме они служат ориентиром, а не нормой, но объясняют, почему кухня может «не выйти» внезапно и почему холодный буфет при вспышке — индивидуальные порции, а не общая тарелка.

Когда включается (отметить): ☐ закрытие столовой ☐ карантин отделения ☐ вспышка ОРИ ☐ вспышка кишечной инфекции ☐ невыход персонала кухни ☐ срыв поставки / аутсорсера ☐ иное:

Блок	Что подготовлено заранее	Владелец	Отметка
Выбор в комнате	Два варианта основных позиций на подносе, а не вторая линия в коридоре; стандартный вариант всегда есть; для изменённых текстур — оба варианта в назначенной текстуре	Старшая смены + кухня	☐
Заказ	Лист выбора у поста или визуальное меню на двери (приложение 38, лист 2); журнал замен ведётся особенно тщательно — «в спешке забыли» не допускается	Пост	☐
Список риска	Список дисфагического риска и текстур (приложение 21) — у каждого, кто разносит подносы, а не только на посту; при еде в комнате у группы риска рядом остаётся сотрудник (раздел 10.7)	Старшая медсестра	☐
Температура	Горячее доходит до комнаты по технологическим документам (п. 50 СанПиН 4282-26); путь «мармит — коридор — комната» укладывается в трёхчасовой предел для блюд, требующих разогрева (п. 32) ^[9] ; замер — на последней выдаче, не только на линии; термоконтейнеры или тележки с подогревом — ориентир, а для СОСО не прямая норма (раздел 18.11)	Завпроизводством	☐
Питьё	График тёплого питья по отделениям; ведомость «Выпито за сутки» (приложение 40) — для всех жителей карантинного отделения	Пост	☐

Блок	Что подготовлено заранее	Владелец	Отметка
Посуда	Запас одноразовой или раздельной посуды по карантинному контуру на ___ суток; подносы для чистой и использованной посуды раздельно	Завхоз	☐
Холодный буфет	Утверждённый перечень (хлеб, кисломолочные продукты, фрукты — по правилам буфета, раздел 18.8), а не «что осталось в холодильнике»; при кишечной инфекции — только индивидуально упакованные порции, без общих тарелок ^[274] ; холодное — в охлаждаемом оборудовании (п. 32) ^[9]	Кухня	☐
Кухня не вышла / поставщик не приехал	Кто готовит или кто принимает аварийную поставку; телефоны на 7:00: _____; что выдаём в первый приём без горячего цеха; суточные пробы и бракераж аварийной поставки — по общим правилам	Директор / заместитель	☐
Персонал кухни и раздачи	Кто заменяет заболевших; работник с симптомами кишечной инфекции к приготовлению и раздаче не допускается (ориентир — 48 часов после исчезновения симптомов) ^[274]	Заведующий производством	☐
Смена	График раздачи по отделениям с запасными руками; нагрузка на раздачу вырастает кратно — это видно в графике до вспышки, а не в 8 утра	Зам. по АХЧ	☐
Лекарства и инсулин	Время еды у жителей на инсулине и фиксированных схемах сохраняется при раздаче в комнаты (раздел 13.12)	Врач / пост	☐

Чего план не делает. Витаминизация, лечебные добавки и любые ограничения рациона при ОРИ назначаются только врачом (раздел 4.0). Выбор не отменяется: меняется форма подачи.

Подпись руководителя: _____ Дата: _____ Следующий пересмотр: не позднее _____ или после ближайшей вспышки (что наступит раньше).

Отличия от первой редакции. Ссылка «раздел 4.3» заменена на «раздел 4.0»: во второй редакции раздел 4.3 — только указатель на перечень раздела 4.0. Добавлены строки «Список риска», «Персонал кухни и раздачи» и «Лекарства и инсулин», правило индивидуальной упаковки буфета при кишечной инфекции и трёхчасовой предел п. 32 для раздачи в комнаты.

Новые источники

Полные записи и переводы — в реестре [raw/sources/poisk-2026-10-pril-c/istochniki.md](https://raw.githubusercontent.com/WHO/CDC-2026-10-pril-c/istochniki.md). Остальные маркеры раскрыты в разделе 44.

Маркер	Источник
I-noro_hicpac	MacCannell T. et al.; HICPAC. Guideline for the Prevention and Control of Norovirus Gastroenteritis Outbreaks in Healthcare Settings (CDC, 2011), раздел «Summary of Recommendations», рек. 5, 14, 15

Список литературы

Источники пронумерованы в порядке первого упоминания; номер в квадратных скобках в тексте — номер позиции в этом списке. Записи оформлены по ГОСТ Р 7.0.100-2018; для иностранных источников после заглавия дан перевод на русский язык. Выписки с переводом ключевых фрагментов и отметки о том, что именно было прочитано, хранятся в реестрах `raw/sources/` репозитория доклада.

1. Font, L. [Дисфагия на фоне приёма антипсихотиков: распространённость : систематический обзор] / L. Font [et al.]. – Text : electronic // PubMed Central. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10455044/> (дата обращения: 09.10.2026).
2. Вариативное питание. – Текст : электронный // ГАУССО НСО «Болотнинский ПНИ» : [сайт]. – 2024. – 16 авг. – URL: <https://bpni.nso.ru/news/2312> (дата обращения: 09.10.2026).
3. [Вариативное меню во всех отделениях]. – Текст : электронный // ГАУССО НСО «Успенский ПНИ» : [сайт]. – 2024. – 13 авг. – URL: <https://upni.nso.ru/news/1916> (дата обращения: 09.10.2026).
4. Что за зверь такой? Вариативное питание. – Текст : электронный // ОГБУСО «Усть-Илимский дом социального обслуживания» : [сайт]. – 2024. – 27 сент. – URL: <https://ui-ogbuso.ru/novosti/> (дата обращения: 23.07.2026).
5. Работа по развитию психоневрологических интернатов продолжается. – Текст : электронный // Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга : [сайт]. – 2025. – 22 июля. – URL: <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/302216/> (дата обращения: 17.08.2026).
6. Вариативное питание в стационарных учреждениях социального обслуживания. – Текст : электронный // irkutsk.bezformata.com : [сайт]. – 2025. – 14 февр. – Пересказ публикации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. – URL: <https://irkutsk.bezformata.com/listnews/variativnoe/142531226/> (дата обращения: 09.10.2026).
7. Как устроены ПНИ в России : исследование. – Текст : электронный // Если быть точным : [сайт]. – 2026. – 9 апр. – URL: <https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym> (дата обращения: 09.10.2026).
8. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании : Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 : ст. 37, 39, 43, 44. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/ (дата обращения: 09.10.2026).
9. Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения : СанПиН 2.3/2.4.4282-26 : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 18 : зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2026 № 86854. – Взамен СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (действовали до 01.09.2026). – Текст : электронный // rovenkiadm.gosuslugi.ru : [сайт]. – URL: https://rovenkiadm.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/SanPiN_2.4.4282-26.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
10. [Проверки прокуратуры по организации питания в учреждениях социального обслуживания]. – Текст : электронный // kashin.info : [сайт]. – URL: <https://www.kashin.info/prokuratura-informiruet/novosti-prokuratury/9121> (дата обращения: 23.07.2026).
11. [О нормах питания] : постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п : актуальная редакция. – Текст : электронный // ctonus.ru : [сайт]. – URL: https://ctonus.ru/f/normy_pitaniya.docx (дата обращения: 23.07.2026).
12. Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Псковской области : приказа Комитета по социальной защите Псковской области от 14.07.2020 № 206 ; [О нормах питания] : постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п ; [О нормах питания] : постановление Правительства Ленинградской области № 458 ; О нормах питания получателей социальных услуг в стационарной и

полустационарной формах в организациях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.08.2014 № 306-п. – Текст : непосредственный.

13. Pillinger, T. [Прибавка массы тела на фоне антипсихотиков: метаанализ 100 рандомизированных контролируемых исследований] / T. Pillinger [et al.]. – Text : electronic // Lancet Psychiatry. – 2020. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31860457/> (дата обращения: 09.10.2026).
14. Doan, T.-N. Prevalence and Methods for Assessment of Oropharyngeal Dysphagia in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis [Перевод заглавия: Распространённость и методы оценки орофарингеальной дисфагии у пожилых людей: систематический обзор и метаанализ] / T.-N. Doan [et al.]. – Text : electronic // Journal of Clinical Medicine. – 2022. – Vol. 11, No. 9. – Art. 2605. – DOI: 10.3390/jcm11092605. – URL: <https://www.mdpi.com/2077-0383/11/9/2605> (дата обращения: 09.10.2026).
15. Correll, C. [Смертность при шизофрении: метаанализ] / C. Correll [et al.]. – Text : electronic // World Psychiatry. – 2022. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9077617/> (дата обращения: 09.10.2026).
16. Luykx, J. J. Dopamine D2 receptor antagonism of antipsychotics and the risk of death due to choking [Перевод заглавия: Антагонизм антипсихотиков к дофаминовым D2-рецепторам и риск смерти от удушья] / J. J. Luykx [et al.]. – Text : electronic // Psychiatry Research. – 2024. – Vol. 339. – Art. 116012. – DOI: 10.1016/j.psychres.2024.116012. – URL: <https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/113463> (дата обращения: 09.10.2026).
17. Hägg, S. [Влияние кофеина на фармакокинетику клозапина] / S. Hägg [et al.]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2000. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2014893/> (дата обращения: 09.10.2026).
18. [Отравление литием: литий, натрий и водный режим]. – Text : electronic // Cleveland Clinic : [сайт]. – URL: <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25207-lithium-toxicity> (дата обращения: 09.10.2026).
19. [Ингибиторы MAO: диетические ограничения (тирамин) : памятка для пациента]. – Text : electronic // NHS : torbayandsouthdevon.nhs.uk : [сайт]. – URL: <https://www.torbayandsouthdevon.nhs.uk/uploads/25672.pdf?last-updated=20201119> (дата обращения: 09.10.2026).
20. Garg, S. K. [Влияние грейпфрутового сока на фармакокинетику карбамазепина] / S. K. Garg [et al.]. – Text : electronic. – 1998. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9757152/> (дата обращения: 09.10.2026).
21. О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации : приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 : зарегистрирован в Минюсте России 12.09.2003 № 5073 : с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2024 № 70н. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44323/ (дата обращения: 19.08.2026).
22. Об утверждении норм лечебного питания : приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.06.2013 № 395н : зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2013 № 28995 : с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2024 № 70н. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149196/ (дата обращения: 19.08.2026).
23. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 21.02.2019 № 11-АД19-4. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : [сайт]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72095418/> (дата обращения: 09.10.2026).
24. [Питание]. – Текст : электронный // ДДСОЛ : [сайт]. – URL: <https://ddsol.ru/about/pitanie/> (дата обращения: 23.07.2026).
25. Simmons, S. F. Prevention of unintentional weight loss in nursing home residents: a controlled trial of feeding assistance [Перевод заглавия: Профилактика непреднамеренной потери массы тела у проживающих домов престарелых: контролируемое исследование помощи при кормлении] / S. F. Simmons [et al.]. – Text : electronic // Journal of the American Geriatrics Society. – 2008. – Vol. 56, No. 8. – P. 1466–1473. – DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.01801.x. – URL: https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP20080817.html (дата обращения: 09.10.2026).
26. Hemsley, B. Dying for a meal: an integrative review of characteristics of choking incidents and recommendations to prevent fatal and nonfatal choking across populations [Перевод заглавия: Смерть за едой: интегративный обзор характеристик случаев удушья и рекомендаций по предотвращению смертельного и несмертельного удушья в разных группах населения] / B. Hemsley [et al.]. – Text : electronic // American Journal of Speech-Language Pathology. – 2019. – Vol. 28, No. 3. – P. 1283–1297. – DOI: 10.1044/2018_AJSLP-18-0150. – URL: https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2018_AJSLP-18-0150 (дата обращения: 09.10.2026).

27. O. Reg. 246/22: General [Перевод заглавия: Постановление Онтарио 246/22: общие положения] : under Fixing Long-Term Care Act, 2021 : ss. 75–80. – Text : electronic // Ontario.ca : [site]. – 2022. – URL: <https://www.ontario.ca/laws/regulation/220246> (дата обращения: 09.10.2026).
28. Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг : постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 : вступило в силу с 01.01.2015. – Текст : электронный // rulaws.ru : [сайт]. – URL: <https://rulaws.ru/government/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-24.11.2014-N-1236/> (дата обращения: 09.10.2026).
29. [Дисфагия при шизофрении: механизмы : обзор]. – Text : electronic // *Frontiers in Psychiatry*. – 2024. – DOI: 10.3389/fpsyt.2024.1448623. – URL: <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2024.1448623/full> (дата обращения: 09.10.2026).
30. Yartsev, P. [Тяжёлая интоксикация клозапином на фоне употребления энергетических напитков : клинический случай] / P. Yartsev [et al.]. – Text : electronic // *PubMed Central*. – 2021. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8043221/> (дата обращения: 09.10.2026).
31. General comment No. 1 (2014). Article 12: Equal recognition before the law [Перевод заглавия: Замечание общего порядка № 1 (2014). Статья 12: Равенство перед законом] : CRPD/C/GC/1 / Committee on the Rights of Persons with Disabilities. – Text : electronic // United Nations Office at Geneva : [site]. – URL: https://ls-cts.unog.ch/sites/default/files/2019-05/CRPD_GC_1_ENG-CHI_BT.html (дата обращения: 09.10.2026).
32. [Сердечно-сосудистые заболевания как ведущая причина избыточной смертности при шизофрении : регистровое исследование, Швеция]. – Text : electronic // *PubMed Central*. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6137375/> (дата обращения: 09.10.2026).
33. Every-Palmer, S. [Гипомотильность желудочно-кишечного тракта, вызванная клозапином] / S. Every-Palmer [et al.]. – Text : electronic // *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*. – 2017. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5533872/> (дата обращения: 09.10.2026).
34. DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Senioreneinrichtungen [Перевод заглавия: Стандарт качества DGE для питания в учреждениях для пожилых]. – Text : electronic // Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat : [site]. – URL: https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/GesundeErnaehrung/DGE-Standard_Seniorenverpflegung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (дата обращения: 09.10.2026).
35. DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Betrieben, Behörden und Hochschulen [Перевод заглавия: Стандарт качества DGE для питания на предприятиях, в ведомствах и высших учебных заведениях]. – Text : electronic // *Job&Fit* : [site]. – URL: https://www.jobundfit.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE-QST/DGE-Qualitaetsstandard_Betriebe_Behoerden_Hochschulen.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
36. Remón, S. Food and Nutrition in Autistic Adults: Knowledge Gaps and Future Perspectives [Перевод заглавия: Пища и питание взрослых с аутизмом: пробелы в знаниях и перспективы] / S. Remón, A. Ferrer-Mairal, T. Sanclemente. – Text : electronic // *Nutrients*. – 2025. – Vol. 17, No. 9. – Art. 1456. – DOI: 10.3390/nu17091456. – URL: <https://zaguan.unizar.es/record/160956> (дата обращения: 09.10.2026).
37. Nanayakkara, W. S. From menu to mouth: the decay pathway of nutrient intake from planned menu to consumed and characteristics of residents in an aged care facility with greater nutrient decay rates: a cross-sectional study [Перевод заглавия: От меню до рта: путь потерь нутриентов от запланированного меню до съеденного и характеристики жителей дома престарелых с наибольшими потерями: поперечное исследование] / W. S. Nanayakkara [et al.]. – Text : electronic // *BMJ Open*. – 2019. – Vol. 9, No. 10. – Art. e024044. – DOI: 10.1136/bmjopen-2018-024044. – URL: <https://bmjopen.bmj.com/content/9/10/e024044> (дата обращения: 09.10.2026).
38. Об утверждении рекомендуемых норм питания... : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.09.2022 № 520н. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : [сайт]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405607433/> (дата обращения: 23.07.2026).
39. Livsmedelsverket. Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen [Перевод заглавия: Национальные рекомендации по организации питания в службах ухода за пожилыми]. – Text : electronic // Livsmedelsverket : [site]. – 2021. – URL: https://www.livsmedelsverket.se/49bd7f/globalassets/publikationsdatabas/broschyrier-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
40. Suominen, M. Nutritional guidelines for older people [Перевод заглавия: Рекомендации по питанию пожилых людей] / M. Suominen [et al.]. – Text : electronic // *PubMed Central*. – 2020. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12877505/> (дата обращения: 09.10.2026).

41. Nijs, K. [Семейная организация трапез в домах престарелых: кластерное рандомизированное контролируемое исследование] / K. Nijs [et al.]. – Text : electronic // BMJ. – 2006. – Vol. 332. – P. 1180–1184. – URL: <https://www.bmj.com/content/332/7551/1180> (дата обращения: 09.10.2026).
42. Nijs, K. A. N. D. Effect of family-style meals on energy intake and risk of malnutrition in Dutch nursing home residents: a randomized controlled trial [Перевод заглавия: Влияние семейной подачи блюд на потребление энергии и риск недостаточности питания у жителей нидерландских домов престарелых: рандомизированное контролируемое исследование] / K. A. N. D. Nijs [et al.]. – Text : electronic // Journals of Gerontology. Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. – 2006. – Vol. 61, No. 9. – P. 935–942. – DOI: 10.1093/gerona/61.9.935. – URL: <https://research.wur.nl/en/publications/effect-of-family-style-meals-on-energy-intake-and-risk-of-malnutr/> (дата обращения: 09.10.2026).
43. Abbott, R. A. Effectiveness of mealtime interventions on nutritional outcomes for the elderly living in residential care: a systematic review and meta-analysis [Перевод заглавия: Эффективность вмешательств во время приёма пищи для показателей питания пожилых в учреждениях постоянного проживания: систематический обзор и метаанализ] / R. A. Abbott [et al.]. – Text : electronic // Ageing Research Reviews. – 2013. – DOI: 10.1016/j.arr.2013.06.002. – URL: <https://arc-sw.nihr.ac.uk/uploads/attachments/Abbott%20et%20al%202013%20ARR%20Mealtimes%20SR&MA.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
44. ГОСТ Р 52496-2019. Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения : национальный стандарт Российской Федерации : утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.09.2019 № 641-ст : взамен ГОСТ Р 52496-2005 : дата введения 2020-05-01. – Текст : электронный // ГАУССО НСО «Успенский ПНИ» : [сайт]. – URL: https://upni.nso.ru/sites/upni.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2023/11/gostgost_r_52496-2019.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
45. Strengthened Aged Care Quality Standards. Standard 6: Food and Nutrition [Перевод заглавия: Усиленные стандарты качества ухода за пожилыми. Стандарт 6: Еда и питание] / Aged Care Quality and Safety Commission. – Text : electronic // Aged Care Quality and Safety Commission : [site]. – 2025. – URL: <https://www.agedcarequality.gov.au/providers/quality-standards/strengthened-aged-care-quality-standards> (дата обращения: 09.10.2026).
46. 42 CFR § 483.60. Food and nutrition services [Перевод заглавия: Свод федеральных нормативных актов США, раздел 42, § 483.60. Службы питания]. – Text : electronic // Legal Information Institute, Cornell Law School : [site]. – URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.60> (дата обращения: 09.10.2026).
47. British Dietetic Association. Nutrition and Hydration Digest [Перевод заглавия: Сборник по питанию и гидратации]. – Text : electronic // British Dietetic Association : [site]. – URL: <https://www.bda.uk.com/asset/A18E6711-0DCF-4191-851AB06AC59B4C90/> (дата обращения: 09.10.2026).
48. [Модель Green House Project и её независимая оценка: качество жизни и стоимость]. – Text : electronic // PubMed Central. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5338211/> (дата обращения: 09.10.2026).
49. Abbey, K. L. Menu Planning in Residential Aged Care – The Level of Choice and Quality of Planning of Meals Available to Residents [Перевод заглавия: Планирование меню в домах престарелых: степень выбора и качество планирования блюд, доступных жителям] / K. L. Abbey, O. R. L. Wright, S. Capra. – Text : electronic // Nutrients. – 2015. – Vol. 7, No. 9. – P. 7580–7592. – DOI: 10.3390/nu7095354. – URL: <https://www.mdpi.com/2072-6643/7/9/5354> (дата обращения: 09.10.2026).
50. Arnstein, S. R. A Ladder of Citizen Participation [Перевод заглавия: Лестница гражданского участия] / S. R. Arnstein. – Text : electronic // Journal of the American Institute of Planners. – 1969. – Vol. 35, No. 4. – P. 216–224. – DOI: 10.1080/01944366908977225. – URL: <https://www.maineedee.org/uploads/documents/ladder-of-citizen-participation.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
51. Qualitätsstandard für die Ernährung in Wohn- und Pflegeeinrichtungen für Seniorinnen und Senioren : aktualisiert [Перевод заглавия: Стандарт качества питания в учреждениях проживания и ухода для пожилых : актуализированная редакция]. – Text : electronic // Sozialministerium : [site]. – 2022. – URL: https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:4f9ff5dc-a44c-4dee-b8d9-a22e6cd3c300/AKTUALISIERT_QS_f%C3%BCr_die_Ern%C3%A4hrung_in_Wohn-_und_Pflegeeinrichtungen_f%C3%BCr_Seniorinnen_und_Senioren.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
52. Regulation 14: Meeting nutritional and hydration needs [Перевод заглавия: Положение 14: удовлетворение потребностей в питании и питье] / Care Quality Commission. – Text : electronic // Care Quality Commission : [site]. – URL: <https://www.cqc.org.uk/guidance-regulation/providers/regulations-service-providers-and-managers/health-social-care-act/regulation-14> (дата обращения: 09.10.2026).

53. Heelan, M. The use of finger foods in care settings: an integrative review [Перевод заглавия: Использование еды, которую едят руками, в учреждениях ухода: интегративный обзор] / M. Heelan [et al.]. – Text : electronic // Journal of Human Nutrition and Dietetics. – 2020. – Vol. 33, No. 2. – P. 187–197. – DOI: 10.1111/jhn.12725. – URL: https://eprints.soton.ac.uk/436558/2/The_use_of_finger_foods_in_care_settings_An_integrative_review_.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
54. Hwang, S.-J. Choking incidents among psychiatric inpatients: a retrospective study in Chutung Veterans General Hospital [Перевод заглавия: Эпизоды удушья у пациентов психиатрического стационара: ретроспективное исследование в Госпитале ветеранов Чутун] / S.-J. Hwang [et al.]. – Text : electronic // Journal of the Chinese Medical Association. – 2010. – Vol. 73, No. 8. – P. 419–424. – URL: https://wd.vghtpe.gov.tw/jcma/files/7308_419.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
55. Minimising choking risk in mental health consumers : Safety Information SI: 016/25 [Перевод заглавия: Снижение риска удушья у пациентов служб психического здоровья : информация по безопасности SI: 016/25] / NSW Health. – Text : electronic // NSW Health : [site]. – 2025. – 18 Nov. – Взамен SI: 004/24. – URL: <https://www.health.nsw.gov.au/sabs/Documents/2025-si-016.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
56. [RESOLVE: реалистский синтез данных о прибавке массы тела на фоне антипсихотиков]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2025. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12531729/> (дата обращения: 09.10.2026).
57. Robertson, J. Prevalence of dysphagia in people with intellectual disability: A systematic review [Перевод заглавия: Распространённость дисфагии у людей с интеллектуальной недостаточностью: систематический обзор] / J. Robertson [et al.]. – Text : electronic // Intellectual and Developmental Disabilities. – 2017. – Vol. 55, No. 6. – P. 377–391. – DOI: 10.1352/1934-9556-55.6.377.
58. Manduchi, B. Interventions for Feeding and Swallowing Disorders in Adults with Intellectual Disability: A Systematic Review of the Evidence [Перевод заглавия: Вмешательства при нарушениях приёма пищи и глотания у взрослых с интеллектуальной недостаточностью: систематический обзор доказательств] / B. Manduchi, G. M. Fainman, M. Walshe. – Dublin : Trinity College Dublin. – URL: <https://www.tara.tcd.ie/bitstreams/7e359d5d-53b3-4fc7-82d3-e8a0e705b486/download> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
59. Ruschena, D. Choking deaths: the role of antipsychotic medication [Перевод заглавия: Смерти от удушья: роль антипсихотических препаратов] / D. Ruschena [et al.]. – Text : electronic // British Journal of Psychiatry. – 2003. – Vol. 183, No. 5. – P. 446–450. – DOI: 10.1192/bjp.183.5.446. – URL: <https://www.cambridge.org/core/product/38D5F426C8A56688B3B689193C2C334C> (дата обращения: 09.10.2026).
60. Nagamine, T. Choking risk among psychiatric inpatients [Перевод заглавия: Риск удушья у пациентов психиатрических стационаров] : [letter] / T. Nagamine. – Text : electronic // Neuropsychiatric Disease and Treatment. – 2011. – Vol. 7. – P. 381–382. – URL: <https://www.dovepress.com/choking-risk-among-psychiatric-inpatients-peer-reviewed-fulltext-article-NDT> (дата обращения: 09.10.2026).
61. [Дисфагия, аспирационная пневмония и кишечная непроходимость на фоне антипсихотиков у лиц с нарушениями развития : обзор]. – Text : electronic // JSciMed Central : [site]. – URL: <https://www.jscimedcentral.com/public/assets/articles/psychiatry-11-1183.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
62. Trapl, M. [GUSS (Gugging Swallowing Screen): прикроватный скрининг дисфагии] / M. Trapl [et al.]. – Text : electronic // Stroke. – 2007. – DOI: 10.1161/STROKEAHA.107.483933. – URL: <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.483933> (дата обращения: 09.10.2026).
63. Belafsky, P. C. [EAT-10: опросник симптомов дисфагии из 10 пунктов] / P. C. Belafsky [et al.]. – Text : electronic // Annals of Otolaryngology, Rhinology and Laryngology. – 2008. – DOI: 10.1177/000348940811701210. – URL: <https://doi.org/10.1177/000348940811701210> (дата обращения: 09.10.2026).
64. Cichero, J. A. Y. The IDDSI Framework [Перевод заглавия: Система IDDSI] / J. A. Y. Cichero [et al.]. – Text : electronic // Dysphagia. – 2017. – Vol. 32, No. 2. – P. 293–314. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27913916/> (дата обращения: 09.10.2026).
65. Полное описание системы IDDSI 2.0 : русский перевод / International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI). – 2021. – Февр. – URL: https://iddsi.org/IDDSI/media/images/Translations/IDDSI_Framework_Descriptors_V2_Final_Russian_Feb_2021.pdf (дата обращения: 09.10.2026). – Текст : электронный. – То же: Методы тестирования : русский перевод. – 2020. – Ноябрь. – URL: <https://www.iddsi.org/images/Publications-Resources/DetailedDefnTestMethods/Russian/V2TestingMethodsRussianNov2020.PDF> (дата обращения: 09.10.2026).
66. Жеребцова, В. А. Диагностика при коррекции нутритивной недостаточности и дисфагии у детей : методические рекомендации / В. А. Жеребцова [и др.]. – Тула : ГУЗ ТО «Клинический центр детской психоневрологии», 2023. – URL: <https://med-cen-kcdp-tula->

- r71.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Metodichka_disfagiya_nutritivn_25.12.2023.pdf (дата обращения: 09.10.2026). – Текст : электронный.
67. Wu, X. S. [Внедрение IDDSI: соответствие текстур стандарту] / X. S. Wu [et al.]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2022. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8994209/> (дата обращения: 09.10.2026).
 68. Texture-modified food and fluids : provider fact sheet [Перевод заглавия: Пища и напитки изменённой текстуры : информационный листок для поставщиков услуг] / Aged Care Quality and Safety Commission. – Text : electronic // Aged Care Quality and Safety Commission : [site]. – URL: https://www.agedcarequality.gov.au/sites/default/files/media/fnd_providers_texturemodified.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
 69. Farrer, O. A feast for the eyes – smooth puree diet moulding improves oral intake [Перевод заглавия: Праздник для глаз: формирование гладкого пюре улучшает потребление пищи] / O. Farrer. – Text : electronic // Food Processing. – 2016. – 24 Feb. – URL: <https://foodprocessing.com.au/content/prepared-food/article/a-feast-for-the-eyes-smooth-puree-diet-moulding-improves-oral-intake-1197151219> (дата обращения: 09.10.2026).
 70. Wu, X. S. Effects of hydrolysed meat on dietary intake and nutritional status in aged care residents requiring pureed diets: a crossover randomised controlled trial [Перевод заглавия: Влияние гидролизованного мяса на потребление пищи и нутритивный статус жителей домов престарелых на протёртой диете: перекрёстное рандомизированное контролируемое исследование] / X. S. Wu, A. Miles, A. Braakhuis. – Text : electronic // BMC Geriatrics. – 2022. – Vol. 22. – Art. 905. – DOI: 10.1186/s12877-022-03622-2. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-022-03622-2> (дата обращения: 09.10.2026).
 71. Steele, C. M. [Нарушка лечения загущёнными жидкостями при дисфагии] / C. M. Steele. – Text : electronic // Breathe. – 2021. – Vol. 17, No. 1. – Art. 210003. – URL: <https://publications.ersnet.org/content/breathe/17/1/210003> (дата обращения: 09.10.2026).
 72. Li, W. Q. [Применение загущённых жидкостей при дисфагии: систематический обзор и метаанализ] / W. Q. Li [et al.]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2025. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12516007/> (дата обращения: 09.10.2026).
 73. Gillman, A. Implementing the Free Water Protocol Does Not Result in Aspiration Pneumonia in Carefully Selected Patients With Dysphagia: A Systematic Review [Перевод заглавия: Применение протокола свободной воды не приводит к аспирационной пневмонии у тщательно отобранных пациентов с дисфагией: систематический обзор] / A. Gillman, R. Winkler [et al.]. – Text : electronic // Dysphagia. – 2017. – Vol. 32, No. 3. – P. 345–361. – URL: <https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/58d02ea6-913c-4a3c-abfd-6d06fc04dddc> (дата обращения: 09.10.2026).
 74. Adult choking algorithm [Перевод заглавия: Алгоритм помощи взрослому при удушье инородным телом] / Resuscitation Council UK. – 2025. – URL: <https://www.resus.org.uk/sites/default/files/2025-10/Adult%20choking%20algorithm%202025%20.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
 75. Об утверждении Порядка оказания первой помощи : приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.05.2024 № 220н : зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2024 № 78363 : вступил в силу 01.09.2024. – Текст : электронный // Новосибирский государственный технический университет : [сайт]. – URL: https://nstu.ru/static_files/63200/03.05.2024_220.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
 76. Yoneyama, T. [Ежедневный уход за полостью рта и пневмония у жителей домов ухода : рандомизированное исследование] / T. Yoneyama [et al.]. – Text : electronic // Journal of the American Geriatrics Society. – 2002. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11874491/> (дата обращения: 09.10.2026).
 77. van der Maarel-Wierink, C. D. Oral health care and aspiration pneumonia in frail older people: a systematic literature review [Перевод заглавия: Гигиена полости рта и аспирационная пневмония у ослабленных пожилых людей: систематический обзор литературы] / C. D. van der Maarel-Wierink [et al.]. – Text : electronic // Gerodontology. – 2013. – Vol. 30, No. 1. – P. 3–9. – DOI: 10.1111/j.1741-2358.2012.00637.x. – URL: <https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/oral-health-care-and-aspiration-pneumonia-in-frail-older-people-a/> (дата обращения: 09.10.2026).
 78. Cao, Y. Oral care measures for preventing nursing home-acquired pneumonia [Перевод заглавия: Меры по уходу за полостью рта для профилактики пневмонии, приобретённой в доме престарелых] / Y. Cao [et al.]. – Text : electronic // Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2022. – Issue 11. – Art. No. CD012416.pub3. – DOI: 10.1002/14651858.CD012416.pub3. – URL: <https://cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012416.pub3/information> (дата обращения: 09.10.2026).
 79. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospitals and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials / P.

- Sjögren, E. Nilsson, M. Forsell [et al.] // Journal of the American Geriatrics Society. – 2008. – Vol. 56, № 11. – P. 2124–2130.
80. Müller F. Oral Hygiene Reduces the Mortality from Aspiration Pneumonia in Frail Elders (комментарий; в первой редакции ошибочно — «обзор 4 РКИ ... ~1 из 10 смертей», см. исправления в начале раздела). – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4541086/>
81. Porter, J. [Проблемы полости рта у жителей домов ухода: сухость во рту и плохо сидящие протезы] / J. Porter [et al.]. – Text : electronic // International Journal of Dental Hygiene. – 2015. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4501060/> (дата обращения: 09.10.2026).
82. [Кофеин и клоzapин: снижение концентрации клоzapина при отмене кофеина : клинический обзор]. – Text : electronic // Pharmacy Times : [site]. – URL: <https://www.pharmacytimes.com/view/caffeine-and-clozapine> (дата обращения: 09.10.2026).
83. Clozapine: datasheet updates [Перевод заглавия: Клоzapин: обновления листка-вкладыша] / Medsafe, New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority. – Text : electronic // Medsafe : [site]. – 2020. – 9 June (rev. 29 July 2020, 6 Nov. 2020). – URL: <https://msd.govt.nz/safety/Alerts/ClozapineDatasheetUpdates.asp> (дата обращения: 09.10.2026).
84. Clozapine and other antipsychotics: monitoring blood concentrations for toxicity [Перевод заглавия: Клоzapин и другие антипсихотики: контроль концентрации в крови для выявления токсичности] / Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. – Text : electronic // Drug Safety Update. – 2020. – 26 Aug. – URL: <https://www.gov.uk/drug-safety-update/clozapine-and-other-antipsychotics-monitoring-blood-concentrations-for-toxicity> (дата обращения: 09.10.2026).
85. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции : Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ : ст. 12 : редакция от 26.06.2026. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/d9a977963094e5d44905a01c0418cf9753b8e8d8/ (дата обращения: 09.10.2026).
86. Lithium Toxicity [Перевод заглавия: Отравление литием]. – Text : electronic // StatPearls. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499992/> (дата обращения: 09.10.2026).
87. Common questions about lithium [Перевод заглавия: Частые вопросы о литии] / NHS. – Text : electronic // NHS : [site]. – Page last reviewed: 09.08.2023. – URL: <https://www.nhs.uk/medicines/lithium/common-questions-about-lithium/> (дата обращения: 09.10.2026).
88. Wilting, I. The impact of environmental temperature on lithium serum levels [Перевод заглавия: Влияние температуры окружающей среды на концентрацию лития в сыворотке] / I. Wilting [et al.]. – Text : electronic // Bipolar Disorders. – 2007. – Vol. 9, No. 6. – P. 603–608. – URL: <https://researchinformation.umcutrecht.nl/en/publications/the-impact-of-environmental-temperature-on-lithium-serum-levels/> (дата обращения: 09.10.2026).
89. MAOI diet and tyramine: prescriber's guide [Перевод заглавия: Диета при приеме ИМАО и тирамин: руководство для назначающих врачей]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2022. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9172554/> (дата обращения: 09.10.2026).
90. [«Сырная реакция» на ингибиторы МАО: история открытия : исторический обзор]. – Text : electronic // PubMed Central. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2738414/> (дата обращения: 09.10.2026).
91. Моклобемид (Moclobemidum) : описание действующего вещества. – Текст : электронный // Регистр лекарственных средств России (РЛС) : [сайт]. – URL: <https://www.rlsnet.ru/active-substance/moklobemid-229> (дата обращения: 09.10.2026).
92. Grapefruit Juice and Some Drugs Don't Mix : Consumer Update [Перевод заглавия: Грейпфрутовый сок и некоторые лекарства несовместимы : информация для потребителей] / U.S. Food and Drug Administration. – Text : electronic // U.S. Food and Drug Administration : [site]. – Content current as of 07/01/2021. – URL: <https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/grapefruit-juice-and-some-drugs-dont-mix> (дата обращения: 09.10.2026).
93. Gaddey, H. L. Unintentional Weight Loss in Older Adults [Перевод заглавия: Непреднамеренная потеря массы тела у пожилых] / H. L. Gaddey, K. Holder. – Text : electronic // American Family Physician. – 2021. – Vol. 104, No. 1. – P. 34–40. – URL: <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2021/0700/p34.html> (дата обращения: 09.10.2026).
94. Best Practices for Nutrition, Food Service and Dining in Long Term Care Homes [Перевод заглавия: Лучшие практики питания, пищевого обслуживания и организации трапез в домах длительного ухода] / Dietitians of Canada. –

2019. – URL: <https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/2019-Best-Practices-for-Nutrition,-Food-Service-and-Dining-in-Long-Term-Care-LTC-Homes.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
95. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ : ст. 20 : редакция от 04.08.2026. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0b1cadf39ebef0f1fed2ef0b8ebab5973197d7f1/ (дата обращения: 09.10.2026).
96. Oral feeding options for people with dementia: a systematic review [Перевод заглавия: Варианты перорального кормления людей с деменцией: систематический обзор]. – Text : electronic. – 2011. – PMID 21391936. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21391936/> (дата обращения: 09.10.2026).
97. Comfort feeding in hospitalised people with dementia: a retrospective study of survival following comfort feeding recommendations [Перевод заглавия: Комфортное кормление госпитализированных людей с деменцией: ретроспективное исследование выживаемости после рекомендации комфортного кормления]. – Text : electronic // Journal of Nutrition, Health and Aging. – 2024. – DOI: 10.1016/j.jnha.2024.100362. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.jnha.2024.100362> (дата обращения: 09.10.2026).
98. American Geriatrics Society feeding tubes in advanced dementia position statement [Перевод заглавия: Позиция Американского гериатрического общества о зондовом питании при тяжелой деменции] / American Geriatrics Society Ethics Committee and Clinical Practice and Models of Care Committee. – Text : electronic // Journal of the American Geriatrics Society. – 2014. – Publ. online 17 July 2014. – PMID 25039796. – URL: <https://www.themednet.org/publications/american-geriatrics-society-feeding-tubes-in-advanced-dementia-position-statement> (дата обращения: 09.10.2026).
99. Association between antipsychotic medication and clinically relevant weight change: meta-analysis [Перевод заглавия: Связь антипсихотической терапии с клинически значимым изменением массы тела: метаанализ]. – Text : electronic // BJPsych Open. – 2023. – Jan. – DOI: 10.1192/bjo.2022.619. – URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/association-between-antipsychotic-medication-and-clinically-relevant-weight-change-metaanalysis/C2DC78D062978D7C805E0E9B99B7911F> (дата обращения: 09.10.2026).
100. [Прибавка массы тела на фоне антипсихотиков при первом эпизоде психоза : метаанализ]. – Text : electronic // PubMed Central. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5589463/> (дата обращения: 09.10.2026).
101. [Мониторинг метаболического риска на фоне антипсихотиков : клинические рекомендации]. – Text : electronic // PubMed Central. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8582768/> (дата обращения: 09.10.2026).
102. Lifestyle interventions in mental health conditions: systematic review [Перевод заглавия: Вмешательства в образ жизни при психических расстройствах: систематический обзор]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2022. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9462072/> (дата обращения: 09.10.2026).
103. Teasdale, S. [Вмешательства в питание при тяжелых психических расстройствах] / S. Teasdale [et al.]. – Text : electronic // Medical Journal of Australia. – 2023. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9828433/> (дата обращения: 09.10.2026).
104. Agarwal, S. M. Pharmacological interventions for prevention of weight gain in people with schizophrenia [Перевод заглавия: Фармакологические вмешательства для профилактики прибавки массы тела у людей с шизофренией] / S. M. Agarwal [et al.]. – Text : electronic // Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2022. – Publ. 3 Oct. – Art. No. CD013337.pub2. – DOI: 10.1002/14651858.CD013337.pub2. – URL: <https://experts.mcmaster.ca/scholarly-works/2441752> (дата обращения: 09.10.2026).
105. Allison, K. C. Proposed diagnostic criteria for night eating syndrome [Перевод заглавия: Предлагаемые диагностические критерии синдрома ночной еды] / K. C. Allison [et al.]. – Text : electronic // International Journal of Eating Disorders. – 2010. – Vol. 43, No. 3. – P. 241–247. – DOI: 10.1002/eat.20693. – URL: <https://cris.haifa.ac.il/en/publications/proposed-diagnostic-criteria-for-night-eating-syndrome/> (дата обращения: 09.10.2026).
106. MUST – Malnutrition Universal Screening Tool : explanatory booklet [Перевод заглавия: MUST – универсальный инструмент скрининга недостаточности питания : пояснительная брошюра] / BAPEN. – 2003/2018. – URL: https://www.bapen.org.uk/pdfs/must/must_explan.pdf (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
107. Managing constipation in people taking clozapine [Перевод заглавия: Ведение запоров у людей, принимающих клозапин] / NHS Specialist Pharmacy Service. – Text : electronic // Specialist Pharmacy Service : [site]. – URL: <https://sps.nhs.uk/articles/managing-constipation-in-people-taking-clozapine/> (дата обращения: 09.10.2026).

108. Cuomo, A. [Дефицит витамина D в психиатрической популяции] / A. Cuomo [et al.]. – Text : electronic // *Frontiers in Psychiatry*. – 2019. – DOI: 10.3389/fpsy.2019.00167. – URL: <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2019.00167/full> (дата обращения: 09.10.2026).
109. LoPinto-Khoury, C. [Карбамазепин и уровень 25(OH)D : метаанализ] / C. LoPinto-Khoury [et al.]. – Text : electronic // *Epilepsy Research*. – 2021. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34847425/> (дата обращения: 09.10.2026).
110. Hanna, S. [Дефицит витамина B12 и фолата у пожилых: депрессия и когнитивные нарушения] / S. Hanna. – Text : electronic // *Primary Care Companion*. – 2009. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2781043/> (дата обращения: 09.10.2026).
111. Insulin Administration and Blood Glucose Monitoring Record for Adults in Care Homes (Nursing and Residential) [Перевод заглавия: Лист введения инсулина и контроля глюкозы крови для взрослых в домах ухода (сестринских и постоянного проживания)] / BNSSG Area Prescribing & Medicines Optimisation Committee (NHS Bristol, North Somerset and South Gloucestershire). – Approved 16.09.2019. – URL: https://bnssg.icb.nhs.uk/wp-content/uploads/2022/06/BNSSG_CCG_Insulin_toolkit_for_care_homes.pdf (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
112. F98.3. Поедание несъедобного младенцами и детьми : описание рубрики МКБ-10. – Текст : электронный // Регистр лекарственных средств России (РЛС) : [сайт]. – URL: <https://www.rlsnet.ru/mkb/poedanie-nesedobnogo-mladencami-i-detmi-5201> (дата обращения: 09.10.2026).
113. Ashworth, M. Prevalence and correlates of pica among adults with intellectual disability in institutions [Перевод заглавия: Распространённость и корреляты пикажизма у взрослых с интеллектуальной недостаточностью в учреждениях] / M. Ashworth, L. Martin, J. P. Hirdes. – Text : electronic // *Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities*. – 2008. – Vol. 1, No. 3. – P. 176–190. – DOI: 10.1080/19315860802029154. – URL: <https://bibliography.terraai.org/node/41912> (дата обращения: 09.10.2026).
114. Miao, D. A meta-analysis of pica and micronutrient status [Перевод заглавия: Метаанализ связи пикажизма и статуса микронутриентов] / D. Miao, S. L. Young, C. D. Golden. – Text : electronic // *American Journal of Human Biology*. – 2015. – Vol. 27, No. 1. – P. 84–93. – URL: <https://read.qxmd.com/read/25156147/a-meta-analysis-of-pica-and-micronutrient-status> (дата обращения: 09.10.2026).
115. Palese, C. Repeat Intentional Foreign Body Ingestion: The Importance of a Multidisciplinary Approach [Перевод заглавия: Повторное намеренное проглатывание инородных тел: значение междисциплинарного подхода] / C. Palese, F. H. Al-Kawas. – Text : electronic // *Gastroenterology & Hepatology (N Y)*. – 2012. – July. – Comment on: Atluri D., Veluru C., Chopra A., Mullen K. D. Recurrent Intentional Foreign Body Ingestion: An Endoscopist's Dilemma // *Gastroenterology & Hepatology (N Y)*. – 2012. – Vol. 8. – P. 482–484. – URL: <https://www.gastroenterologyandhepatology.net/?p=530> (дата обращения: 09.10.2026).
116. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ : ст. 29, 30, 35, 36. – Текст : электронный // zakonrf.info : [сайт]. – URL: <https://www.zakonrf.info/gk/29/> (дата обращения: 09.10.2026).
117. Об опеке и попечительстве : Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ : ст. 11, 15 : с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.09.2025 № 367-ФЗ. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/512e4c7606acd1bef6241d6120aea969882ac86a/ (дата обращения: 09.10.2026).
118. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ : ст. 9, 16, 17, 31–34. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения: 09.10.2026).
119. Montessori-based interventions for dementia: systematic review [Перевод заглавия: Вмешательства на основе метода Монтеessori при деменции: систематический обзор]. – Text : electronic // *PubMed Central*. – 2023. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10336713/> (дата обращения: 09.10.2026).
120. Riktlinjer för mat, måltider och nutrition : version 6 [Перевод заглавия: Руководство по еде, трапезам и питанию : версия 6] / Örebro kommun. – 2023. – URL: <https://www.orebro.se/download/18.5779588418bcc1d3d2313d8/1700215055156/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20mat,%20m%C3%A5ltider%20och%20nutrition%20version%206,%2023-11-16.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
121. Logan, K. R. Preferences and reinforcers for students with profound multiple disabilities: can we identify them? [Перевод заглавия: Предпочтения и подкрепления у учащихся с тяжёлыми множественными нарушениями: можно ли их выявить?] / K. R. Logan [et al.]. – Text : electronic // *Journal of Developmental and Physical Disabilities*. – 2001. – June. – DOI: 10.1023/A:1016624923479. – URL: <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/1773> (дата обращения: 09.10.2026).

122. Murphy, J. The use of Talking Mats to support people with dementia and their carers to make decisions together [Перевод заглавия: Использование «Говорящих ковриков» для поддержки совместного принятия решений людьми с деменцией и ухаживающими за ними] / J. Murphy, T. Oliver. – Text : electronic // Health and Social Care in the Community. – 2013. – Vol. 21, No. 2. – P. 171–180. – DOI: 10.1111/hsc.12005. – URL: <https://discovery.dundee.ac.uk/en/publications/the-use-of-talking-mats-to-support-people-with-dementia-and-their/> (дата обращения: 09.10.2026).
123. Abbott, K. M. The Change in Nursing Home Residents' Preferences Over Time [Перевод заглавия: Изменение предпочтений жителей домов престарелых со временем] / K. M. Abbott [et al.]. – Text : electronic // Journal of the American Medical Directors Association. – 2018. – Vol. 19, No. 12. – P. 1092–1098. – DOI: 10.1016/j.jamda.2018.08.004. – URL: <https://pure.psu.edu/en/publications/the-change-in-nursing-home-residents-preferences-over-time/> (дата обращения: 09.10.2026).
124. Kunicki, Z. J. Comparing resident, proxy, and staff respondents for nursing home residents' preferences for everyday living [Перевод заглавия: Сравнение ответов жителей, их представителей и персонала о повседневных предпочтениях жителей домов престарелых] / Z. J. Kunicki [et al.]. – Text : electronic // Journal of Applied Gerontology. – 2023. – Vol. 42, No. 1. – P. 28–36. – DOI: 10.1177/07334648221123059. – URL: <https://collaborate.umb.edu/en/publications/comparing-resident-proxy-and-staff-respondents-for-nursing-home-r/> (дата обращения: 09.10.2026).
125. Concluding observations on the initial report of the Russian Federation : CRPD/C/RUS/CO/1 [Перевод заглавия: Заключительные замечания по первоначальному докладу Российской Федерации] / Committee on the Rights of Persons with Disabilities. – Adopted 7 March 2018 (391st meeting), issued 9 April 2018. – Text : electronic // ecoinet : [site]. – URL: https://www.ecoi.net/en/file/local/1439226/1930_1532593850_g1809688.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
126. Francis, C. J. Supported decision-making interventions in mental healthcare: a systematic review of current evidence and implementation barriers [Перевод заглавия: Вмешательства поддерживаемого принятия решений в психиатрической помощи: систематический обзор доказательств и барьеров внедрения] / C. J. Francis, A. Johnson, R. L. Wilson. – Text : electronic // Health Expectations. – 2024. – Vol. 27, No. 2. – DOI: 10.1111/hex.14001. – URL: <https://doaj.org/article/a35dda4d97ae416da0805d44e2483eba> (дата обращения: 09.10.2026).
127. Лозовская, С. О. Правосубъектность лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными вследствие психического расстройства / С. О. Лозовская. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2023. – № 5. – С. 139–146. – URL: <https://vestnik.msal.ru/jour/article/view/2058> (дата обращения: 09.10.2026).
128. Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения : СанПиН 2.3/2.4.3590-20 : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32. – Текст : электронный // rulaws.ru : [сайт]. – URL: <https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-27.10.2020-N-32/> (дата обращения: 09.10.2026).
129. Новый СанПиН для общепита 2026 : [о СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 18]. – Текст : электронный // Контур : [сайт]. – 2026. – 25 июня. – URL: https://kontur.ru/articles/25860-novyy_sanpin_dlya_obshchepita_2026 (дата обращения: 09.10.2026).
130. Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг : постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 : вступило в силу 01.01.2015. – Текст : электронный // rulaws.ru : [сайт]. – URL: <https://rulaws.ru/government/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-24.11.2014-N-1236/> (дата обращения: 09.10.2026).
131. [Плата за стационарное социальное обслуживание : подборка документов: ст. 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ ; постановление Правительства Российской Федерации № 1075 (расчет среднедушевого дохода)]. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/law/podborki/plata_zh_stacionarnoe_socialnoe_obslyuzhivanie/ (дата обращения: 23.07.2026).
132. О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ : ст. 10 «Специальные категории персональных данных». – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/26edb2934b899bf9c74c3a8f7e574651c6565e6d/ (дата обращения: 09.10.2026).

133. Конвенция о правах инвалидов : принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2006 г. : ст. 19, 25 (п. «f»), 28. – Текст : электронный // Организация Объединенных Наций : [сайт]. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обращения: 09.10.2026).
134. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ст. 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/dceffcf2617aa8cbad91f46398ce0beab3d0ea76/ (дата обращения: 09.10.2026).
135. [ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов]. – Текст : электронный // Российская газета : [сайт]. – 2024. – 25 июля. – URL: <https://rg.ru/2024/07/25/fas-raskryla-kartel-na-torgah-na-postavku-socialno-znachimyh-produktov.html> (дата обращения: 09.10.2026).
136. [ФАС и ФСБ: картель на поставке школьного питания в Челябинске]. – Текст : электронный // pro-goszakaz.ru : [сайт]. – 2025. – 1 авг. – URL: <https://www.pro-goszakaz.ru/news/116068> (дата обращения: 23.07.2026).
137. [Лечебное питание: правовое регулирование : обзор приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации», от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания», от 23.09.2020 № 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием»]. – Текст : электронный // brace-lf.com : [сайт]. – URL: <https://brace-lf.com/ru/informaciya/farmatsevticheskoe-i-meditinskoe-pravo/lechebnoe-pitanie-pravovoe-regulirovanie> (дата обращения: 09.10.2026).
138. Convention on the Rights of Persons with Disabilities : art. 28 [Перевод заглавия: Конвенция о правах инвалидов : ст. 28 «Адекватный жизненный уровень и социальная защита»] / United Nations. – Text : electronic // OHCHR : [site]. – URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities> (дата обращения: 09.10.2026).
139. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ : ст. 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». – Текст : электронный // zakonrf.info : [сайт]. – URL: <https://www.zakonrf.info/koap/6.6/> (дата обращения: 09.10.2026).
140. Greig, J. D. Enteric outbreaks in long-term care facilities and recommendations for prevention: a review [Перевод заглавия: Кишечные вспышки в учреждениях долговременного ухода и рекомендации по профилактике: обзор] / J. D. Greig, M. B. Lee. – Text : electronic // Epidemiology and Infection. – 2009. – Vol. 137, No. 2. – P. 145–155. – DOI: 10.1017/S0950268808000757. – URL: <https://www.cambridge.org/core/product/7346921B9C89B5B9DEFCC212A781C541> (дата обращения: 09.10.2026).
141. Современные особенности норовирусной инфекции в городе Москве / В. А. Ковалев, Н. Н. Филатов, М. Н. Локтионова [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2017. – Т. 94, № 6. – С. 32–37. – DOI 10.36233/0372-9311-2017-6-32-37.
142. Вспышка кишечной инфекции произошла в доме-интернате для ветеранов // Петрозаводск говорит : сетевое издание. – 2024. – 9 октября. – URL: <https://ptzgovorit.ru/news/vspyshka-kishechnoy-infekcii-proizoshla-v-dome-internate-dlya-veteranov> (дата обращения: 10.10.2026). – Текст : электронный.
143. Более 30 подопечных из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Мурманске госпитализированы с кишечной палочкой // Би-Порт : сетевое издание. – 2025. – 4 февраля. – URL: <https://b-port.com/news/305912> (дата обращения: 10.10.2026). – Текст : электронный.
144. [О методических рекомендациях по организации работы стационарных организаций социального обслуживания в условиях COVID-19] : письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.04.2020 № 26-4/10/В-3076. – Текст : электронный // normativ.kontur.ru : [сайт]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=361442> (дата обращения: 18.08.2026).
145. Методические рекомендации по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов : утверждены постановлением Минтруда России от 15.02.2002 № 12 : в редакции приказа от 04.06.2007 № 397. – Текст : электронный // docs.cntd.ru : [сайт]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901816611> (дата обращения: 18.08.2026).
146. Residential aged care food services : discussion paper [Перевод заглавия: Пищевое обслуживание в домах престарелых : дискуссионный доклад] / Aged Care Quality and Safety Commission ; M. Wroth, Chief Clinical Advisor ; prepared by Health Outcomes International. – Text : electronic // Aged Care Quality and Safety Commission : [site]. – URL: <https://www.agedcarequality.gov.au/providers/food-nutrition-dining-information-providers/residential-aged-care-food-services-discussion-paper> (дата обращения: 09.10.2026).

147. McCray, S. Room service in a public hospital improves nutritional intake and increases patient satisfaction while decreasing food waste and cost [Перевод заглавия: Обслуживание в палате по заказу в государственной больнице улучшает потребление пищи и удовлетворённость пациентов, снижая пищевые отходы и затраты] / S. McCray [et al.]. – Text : electronic // Journal of Human Nutrition and Dietetics. – 2018. – Vol. 31, No. 6. – P. 734–741. – DOI: 10.1111/jhn.12580. – URL: <https://research.bond.edu.au/en/publications/room-service-in-a-public-hospital-improves-nutritional-intake-and/> (дата обращения: 09.10.2026).
148. Manimaran, S. Strategies to Reduce the Rate of Plate Waste in Hospitalized Patients: A Scoping Review [Перевод заглавия: Стратегии снижения доли несъеденной пищи у госпитализированных пациентов: обзорное исследование] / S. Manimaran [et al.]. – Text : electronic // Nutrients. – 2023. – Vol. 15, No. 2. – Art. 301. – DOI: 10.3390/nu15020301. – URL: <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/2/301/html> (дата обращения: 09.10.2026).
149. Roulston, M. Food waste in residential aged care: A scoping review [Перевод заглавия: Пищевые отходы в домах престарелых: обзорное исследование] / M. Roulston [et al.]. – Text : electronic // Nutrition & Dietetics. – 2026. – Vol. 83, No. 1. – P. 56–73. – DOI: 10.1111/1747-0080.70034. – URL: <https://research.usc.edu.au/esploro/outputs/journalArticle/Food-waste-in-residential-aged-care/991155617202621> (дата обращения: 09.10.2026).
150. Food and Nutrition in Long-Term-Care Homes : Value-for-Money Audit [Перевод заглавия: Питание в домах длительного ухода : аудит эффективности расходов] // Annual Report 2019 / Office of the Auditor General of Ontario. – Toronto, 2019. – Vol. 1, Chapter 3.05. – URL: https://www.auditor.on.ca/en/content/annualreports/arreports/en19/v1_305en19.pdf (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
151. MacKenzie-Shalders, K. Impact of electronic bedside meal ordering systems on dietary intake, patient satisfaction, plate waste and costs: A systematic literature review [Перевод заглавия: Влияние электронных систем заказа блюд у постели больного на потребление пищи, удовлетворённость пациентов, несъеденную пищу и затраты: систематический обзор литературы] / K. MacKenzie-Shalders [et al.]. – Text : electronic // Nutrition & Dietetics. – 2020. – Vol. 77, No. 1. – P. 103–111. – DOI: 10.1111/1747-0080.12600. – URL: <https://research.bond.edu.au/en/publications/impact-of-electronic-bedside-meal-ordering-systems-on-dietary-int/> (дата обращения: 09.10.2026).
152. Bunn, D. K. Effectiveness of interventions to indirectly support food and drink intake in people with dementia: Eating and Drinking Well IN dementia (EDWINA) systematic review [Перевод заглавия: Эффективность вмешательств, косвенно поддерживающих потребление еды и питья людьми с деменцией: систематический обзор EDWINA] / D. K. Bunn [et al.]. – Text : electronic // BMC Geriatrics. – 2016. – Vol. 16. – Art. 89. – DOI: 10.1186/s12877-016-0256-8. – URL: <https://bmgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-016-0256-8> (дата обращения: 09.10.2026).
153. Home-Style Dining Interventions [Перевод заглавия: Вмешательства по организации питания в домашнем стиле] / Pioneer Network. – URL: <http://www.pioneernetwork.org/wp-content/uploads/2016/10/Home-Style-Dining-Interventions.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
154. [Философия и десять принципов Eden Alternative]. – Text : electronic // Eden Alternative : [site]. – URL: <https://edenalt.org/> (дата обращения: 09.10.2026).
155. Heid, A. R. The stability of nursing home residents' ratings of importance of recreation preferences over one year [Перевод заглавия: Устойчивость оценок важности досуговых предпочтений жителей домов престарелых в течение года] / A. R. Heid [et al.]. – Text : electronic // Journal of Applied Gerontology. – 2022. – Vol. 41, No. 8. – P. 1942–1951. – DOI: 10.1177/07334648221089239. – URL: <https://pure.psu.edu/en/publications/the-stability-of-nursing-home-residents-ratings-of-importance-of-/> (дата обращения: 09.10.2026).
156. [Кейс Tallgläntan: замеры ночного голодания] / Region Jämtland. – 2016. – URL: <https://www.regionjh.se/download/18.7b79416a31d3449611c4/1557149809111/2016-2-Skoglund-%C3%96hman.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
157. Simmons, S. F. Cost-effectiveness of Nutrition Intervention in Long-Term Care [Перевод заглавия: Экономическая эффективность нутритивного вмешательства в учреждениях длительного ухода] / S. F. Simmons [et al.]. – Text : electronic // Journal of the American Geriatrics Society. – 2015. – DOI: 10.1111/jgs.13709. – URL: https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP50948.html (дата обращения: 09.10.2026).
158. Ivers, N. Audit and feedback: effects on professional practice [Перевод заглавия: Аудит и обратная связь: влияние на профессиональную практику] / N. Ivers [et al.]. – Text : electronic // Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2026. – Issue 6. – Art. No. CD000259. – Publ. 22 June 2026. – URL: https://www.cochrane.org/CD000259/EPOC_audit-and-feedback-effects-on-professional-practice-and-healthcare-outcomes (дата обращения: 09.10.2026).

159. [Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о семинаре ; Список участников семинара]. – Не опубликовано.
160. Психоневрологических интернатов за три года стало на 13% меньше. – Текст : электронный // Ведомости : [сайт]. – 2026. – 10 апр. – URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2026/04/10/1189295-psihonevrologicheskikh-internatov-stalo-menshe> (дата обращения: 09.10.2026).
161. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 : ст. 65. – Текст : электронный // Президент России : [сайт]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item> (дата обращения: 09.10.2026).
162. Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Челябинской области : постановление Правительства Челябинской области от 31.10.2014 № 582-П. – Текст : электронный // FAOLEX : [сайт]. – URL: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/rus203610.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
163. [О нормах питания в стационарных организациях социального обслуживания] : постановление Правительства Москвы № 1068-ПП. – Текст : непосредственный.
164. О нормах питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах в организациях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.08.2014 № 306-п. – Текст : электронный // FAOLEX : [сайт]. – URL: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/rus203615.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
165. Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Псковской области : приказ Комитета по социальной защите Псковской области от 14.07.2020 № 206. – Текст : электронный // Law and Environment Assistance Platform (LEAP) : [сайт]. – URL: <https://leap.unep.org/en/countries/ru/national-legislation/regional-order-no-206-validating-nutritional-standards-recipients> (дата обращения: 09.10.2026).
166. Об утверждении Норм питания получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в государственных организациях социального обслуживания города Москвы : приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 24 декабря 2014 г. № 1068. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70784358/> (дата обращения: 10.10.2026). – Текст : электронный.
167. Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания города Москвы : приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22 марта 2021 г. № 228. – URL: <https://base.garant.ru/405012407/> (дата обращения: 10.10.2026). – Текст : электронный.
168. Организация питания / Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания : официальный сайт. – URL: <https://www.dikamen.47social.ru/uslugi/pit> (дата обращения: 10.10.2026). – Текст : электронный.
169. [Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в стационарной форме] : приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 14.06.2024 № 269 : в редакции приказа от 15.05.2025 № 249. – Текст : электронный // ГАРАНТ : [сайт]. – URL: <https://base.garant.ru/409229072/> (дата обращения: 09.10.2026).
170. Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания : приказ Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне от 31.10.2014 № 376. – Текст : электронный // FAOLEX : [сайт]. – URL: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/rus203608.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
171. Об утверждении правил внутреннего распорядка жителей СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» : приказ директора СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» от 10.03.2026 № 124. – Текст : электронный // СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» : [сайт]. – URL: <https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/> (дата обращения: 21.08.2026). – Сайт прекратил работу; архивная копия: <https://web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/>.
172. В свердловских домах для престарелых и инвалидов внедряют «шведский стол». – Текст : электронный // ЕАН (Екатеринбург) : [сайт]. – 2013. – 12 апр. – URL: <https://eanews.ru/ekaterinburg/20130412145000/v-sverdlovskih-domah-dlya-prestarelyh-i-invalidov-vnedryayut-shvedskiy-stol> (дата обращения: 09.10.2026).
173. Положение об организации питания / ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». – Текст : электронный // soc52.ru : [сайт]. – URL: <https://soc52.ru/sorm-di-documents/statement/item/447-statement-food> (дата обращения: 09.10.2026).
174. Положение об организации питания в отделении «Дом-интернат (пансионат) общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов» : утверждено приказом МБУ «Комплексный центр социального обслуживания

населения Баганского района» от 31.07.2020 № 86. – Текст : электронный // МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района» : [сайт]. – URL: https://kcsobagan.nso.ru/sites/kcsobagan.nso.ru/wodby_files/files/page_934/2_polozenie_ob_organizacii_pitaniya.pdf (дата обращения: 09.10.2026).

175. Сологуб, Н. Две смерти, четыре грамма горошка и хлеб вместо котлет. Голодный год в Прокопьевском психоневрологическом интернате / Н. Сологуб. – Текст : электронный // Медиазона : [сайт]. – 2018. – 8 февр. – URL: <https://zona.media/article/2018/02/08/kergelesh> (дата обращения: 09.10.2026).
176. [Mental health and learning disability inpatients : resources for practice] [Перевод заглавия: Пациенты психиатрических стационаров и стационаров для людей с интеллектуальными нарушениями : практические ресурсы] / British Dietetic Association. – Text : electronic // British Dietetic Association : [site]. – URL: <https://www.bda.uk.com/practice-and-education/resources-for-practice/mental-health-learning-disability-inpatients.html> (дата обращения: 09.10.2026).
177. Health and Social Care Standards: my support, my life [Перевод заглавия: Стандарты здравоохранения и социальной помощи: моя поддержка, моя жизнь] / Scottish Government. – Text : electronic // Scottish Government : [site]. – 2017. – 9 June. – URL: <https://www.gov.scot/publications/health-social-care-standards-support-life/pages/4/> (дата обращения: 09.10.2026).
178. Porter, J. [Защищённое время приёма пищи: систематический обзор и метаанализ] / J. Porter [et al.]. – Text : electronic // International Journal of Nursing Studies. – 2017. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27866011/> (дата обращения: 09.10.2026).
179. Porter, J. [Защищённое время приёма пищи: ступенчатое кластерное исследование] / J. Porter [et al.]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2019. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5295189/> (дата обращения: 09.10.2026).
180. Питание и прием пищи: ваш выбор имеет значение : информационный листок для получателей услуг : официальный русский перевод / Aged Care Quality and Safety Commission. – Текст : электронный // Aged Care Quality and Safety Commission : [сайт]. – URL: <https://www.agedcarequality.gov.au/sites/default/files/media/fdn-choices-fact-sheet-russian.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
181. Hugo, C. What does it cost to feed aged care residents in Australia? [Перевод заглавия: Сколько стоит накормить жителей домов престарелых в Австралии?] / C. Hugo [et al.]. – Text : electronic // Nutrition & Dietetics. – 2018. – URL: https://pure.bond.edu.au/ws/files/25958488/What_does_it_cost_to_feed_aged_care_residents_in_Australia.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
182. Milte, R. [Исследование Foodservice Costing Tool: полная стоимость пищевой службы домов престарелых] / R. Milte [et al.]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2022. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9321358/> (дата обращения: 09.10.2026).
183. Food Appendix [Перевод заглавия: Приложение о питании] / The Consumer Voice. – URL: <https://theconsumervoice.org/wp-content/uploads/2026/06/Food-Appendix.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
184. Mat, måltider og ernæring i helse- og omsorgstjenesten : høringsutkast [Перевод заглавия: Еда, трапезы и питание в службах здравоохранения и ухода : проект для общественного обсуждения] / Helsedirektoratet. – Text : electronic // Helsedirektoratet : [site]. – 2026. – 10 Sept. – URL: <https://www.helsedirektoratet.no/horinger/retningslinje-for-mat-maltider-og-ernaering-i-helse-og-omsorgstjenesten> (дата обращения: 09.10.2026).
185. New food recommendation for elderly care [Перевод заглавия: Новая рекомендация по питанию в уходе за пожилыми] / Ruokavirasto. – Text : electronic // Ruokavirasto : [site]. – 2020. – URL: <https://www.ruokavirasto.fi/en/foodstuffs/healthy-diet/uutiset/new-food-recommendation-for-elderly/> (дата обращения: 09.10.2026).
186. Madlevering og madordning [Перевод заглавия: Доставка еды и организация питания]. – Text : electronic // Borger.dk : [site]. – URL: <https://www.borger.dk/aeldre/hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/madlevering-og-madordning> (дата обращения: 09.10.2026).
187. DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung mit „Essen auf Rädern“ und in Senioreneinrichtungen [Перевод заглавия: Стандарт качества DGE для питания по программе «Еда на колёсах» и в учреждениях для пожилых]. – 1. Aufl., 2. korrigierter und aktualisierter Nachdruck. – Bonn : DGE, 2023. – URL: <https://www.dge.de/fileadmin/dok/gemeinschaftsgastronomie/dge-qualitaetsstandards/2023/231005-DGE-QST-Senioren.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.

188. Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen [Перевод заглавия: Хартия прав людей, нуждающихся в помощи и уходе] / BMFSFJ, BMG. – 14. Aufl. – Stand: Februar 2020. – URL: <https://www.bmfsfj.bund.de/resource/blob/93450/534bd1b2e04282ca14bb725d684bdf20/charta-der-rechte-hilfe-und-pflegebeduerftiger-menschen-data.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
189. [Leitfaden für Interessierte] [Перевод заглавия: Руководство для интересующихся : проект SUNRISE] / Medizinische Universität Graz. – 2021. – URL: https://www.medunigraz.at/frontend/user_upload/OEs/institute/pflegewissenschaft/pdf/Leitfaden_Interessierte.pdf (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
190. Divert, C. Improving meal context in nursing homes. Impact of four strategies on food intake and meal pleasure [Перевод заглавия: Улучшение обстановки трапезы в домах престарелых. Влияние четырёх стратегий на потребление пищи и удовольствие от еды] / C. Divert [et al.]. – Text : electronic // Appetite. – 2015. – Vol. 84. – P. 139–147. – URL: https://www2.dijon.inra.fr/senior-et-sens/fichiers/1-1_fichier20_en.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
191. [Реформа страхования длительного ухода 2005 г. и доплаты за питание]. – Text : electronic // NIPH Journal. – 2006. – Vol. 55, No. 1. – URL: <https://www.niph.go.jp/journal/data/55-1/200655010006.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
192. [Доплата за нутритивный менеджмент: охват учреждений]. – Text : electronic // comimi.jp : [site]. – 2021. – URL: <https://comimi.jp/archives/column/kasan3> (дата обращения: 09.10.2026).
193. [Пересмотр тарифов 2021 г.: усиление нутритивного менеджмента] / Ministry of Health, Labour and Welfare. – Text : electronic // City of Sapporo : [site]. – URL: <https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2021housyuukaitei/documents/eiyoucaremanezimentonozyuuzitu.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
194. Outcomes of Long-term Care in Japan [Перевод заглавия: Исходы длительного ухода в Японии] / ERIA. – 2020. – (Research Project Report 2020-13). – URL: <https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/2020-13-Outcomes-of-Long-term-Care-Japan/Outcome-of-Long-term-Care-Insurance-Service-in-Japan-new.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
195. [Обеспеченность диетологами и потенциально предотвратимые госпитализации жителей домов престарелых: когортное исследование, Япония]. – Text : electronic // BMC Geriatrics. – 2023. – DOI: 10.1186/s12877-023-04278-2. – URL: <https://doi.org/10.1186/s12877-023-04278-2> (дата обращения: 09.10.2026).
196. Koomen, L. E. M. Lifestyle interventions for people with a severe mental illness living in supported housing: A systematic review and meta-analysis [Перевод заглавия: Вмешательства в образ жизни для людей с тяжёлыми психическими расстройствами, живущих в сопровождаемом жилье: систематический обзор и метаанализ] / L. E. M. Koomen, M. Z. van der Horst, J. Deenik, W. Cahn. – Text : electronic // Frontiers in Psychiatry. – 2022. – Vol. 13. – Art. 966029. – DOI: 10.3389/fpsyt.2022.966029. – URL: <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2022.966029/full> (дата обращения: 09.10.2026).
197. S.I. No. 415/2013 – Health Act 2007 (Care and Welfare of Residents in Designated Centres for Older People) Regulations 2013 : Regulation 18 «Food and nutrition» [Перевод заглавия: Нормативный акт № 415/2013 – Положение 2013 г. об уходе и благополучии проживающих в специализированных центрах для пожилых (к Закону о здравоохранении 2007 г.) : положение 18 «Еда и питание»]. – Text : electronic // Irish Statute Book : [site]. – URL: <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2013/si/415/made/en/print> (дата обращения: 09.10.2026).
198. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg [Перевод заглавия: Рамочный документ о качестве сестринского ухода в домах престарелых] / Zorginstituut Nederland. – 2017 ; actualisatie 2021. – URL: <https://www.zn.nl/app/uploads/2023/02/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-2021.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
199. Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg, verslagjaar 2019 [Перевод заглавия: Руководство для поставщиков сестринского ухода в домах престарелых, отчётный год 2019] / Zorginstituut Nederland, Zorginzicht. – URL: <https://zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/Handboek+voor+zorgaanbieders+van+verpleeghuiszorg+verslagjaar+2019.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
200. Herke, M. Environmental and behavioural modifications for improving food and fluid intake in people with dementia [Перевод заглавия: Изменения среды и поведения для улучшения потребления пищи и жидкости людьми с деменцией] / M. Herke [et al.]. – Text : electronic // Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2018. – Issue 7. – Art. No. CD011542. – DOI: 10.1002/14651858.CD011542.pub2. – URL: <https://www.cochrane.org/CD011542> (дата обращения: 09.10.2026).

201. Rinninella, E. Hospital Services to Improve Nutritional Intake and Reduce Food Waste: A Systematic Review [Перевод заглавия: Больничные службы для улучшения потребления пищи и сокращения пищевых отходов: систематический обзор] / E. Rinninella [et al.]. – Text : electronic // *Nutrients*. – 2023. – Vol. 15, No. 2. – Art. 310. – DOI: 10.3390/nu15020310. – URL: <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/2/310> (дата обращения: 09.10.2026).
202. Wang, D. Access to food choices by older people in residential aged care: An integrative review [Перевод заглавия: Доступ пожилых людей в домах престарелых к выбору еды: интегративный обзор] / D. Wang [et al.]. – Text : electronic // *Collegian*. – 2018. – Vol. 25. – P. 457–465. – DOI: 10.1016/j.colegn.2017.11.004. – URL: <https://openresearch-repository.anu.edu.au/entities/publication/cd11f734-e445-413a-ae23-dc7d621f5b50/full> (дата обращения: 09.10.2026).
203. Porter, J. Nutritional intake and foodservice satisfaction of adults receiving specialist inpatient mental health services [Перевод заглавия: Потребление пищи и удовлетворённость питанием взрослых пациентов специализированных психиатрических стационаров] / J. Porter, J. Collins. – Text : electronic // *Nutrition & Dietetics*. – 2022. – Vol. 79, No. 3. – P. 411–418. – DOI: 10.1111/1747-0080.12745. – URL: <https://research.monash.edu/en/publications/nutritional-intake-and-foodservice-satisfaction-of-adults-receivi/> (дата обращения: 09.10.2026).
204. [Об утверждении профессионального стандарта «Помощник по уходу»] : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2023 № 482н. – Текст : электронный // Национальное агентство развития квалификаций : [сайт]. – URL: <https://nok-nark.ru/download/pk/03.01300.02> (дата обращения: 09.10.2026).
205. Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, рекомендуемых нормативов штатной численности и перечня оборудования... : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2025 № 305н : зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2025 № 82485 : вступает в силу 01.09.2025, действует до 01.09.2031. – Текст : электронный // pravo.ppt.ru : [сайт]. – URL: <https://pravo.ppt.ru/prikaz/mintrud/n-305n-314346> (дата обращения: 09.10.2026).
206. О внесении изменений в приказ ... от 26.11.2014 № 178 : приказ Департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 14.02.2019 № 30 : вступил в силу 26.02.2019. – Текст : электронный // ГАРАНТ : [сайт]. – URL: <https://base.garant.ru/47039162/> (дата обращения: 09.10.2026).
207. Perruchoud, E. The Impact of Nursing Staffs' Working Conditions on the Quality of Care Received by Older Adults in Long-Term Residential Care Facilities: A Systematic Review of Interventional and Observational Studies [Перевод заглавия: Влияние условий труда сестринского персонала на качество ухода за пожилыми в учреждениях длительного проживания: систематический обзор интервенционных и наблюдательных исследований] / E. Perruchoud [et al.]. – Text : electronic // *Geriatrics*. – 2022. – Vol. 7, No. 1. – Art. 6. – DOI: 10.3390/geriatrics7010006. – URL: <https://www.mdpi.com/2308-3417/7/1/6> (дата обращения: 09.10.2026).
208. Wu, X. S. An Evaluation of Texture Modified Diets Compliant with the International Dysphagia Diet Standardisation Initiative in Aged-Care Facilities Using the Consolidated Framework for Implementation Research [Перевод заглавия: Оценка диет изменённой текстуры, соответствующих IDDSI, в домах престарелых с использованием Консолидированной рамки исследований внедрения] : preprint / X. S. Wu, A. Miles, A. Braakhuis. – Text : electronic // Research Square. – 2021. – DOI: 10.21203/rs.3.rs-567321/v1. – URL: <https://www.researchsquare.com/article/rs-567321/v1> (дата обращения: 09.10.2026).
209. 42 CFR § 483.160. Requirements for training of paid feeding assistants ; 42 CFR § 483.60(h). Paid feeding assistants [Перевод заглавия: Свод федеральных нормативных актов США, раздел 42, § 483.160. Требования к обучению оплачиваемых помощников по кормлению ; § 483.60(h). Оплачиваемые помощники по кормлению]. – Text : electronic // Legal Information Institute, Cornell Law School : [site]. – URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.160> (дата обращения: 09.10.2026).
210. Simmons, S. F. Improving food intake in nursing home residents with feeding assistance: a staffing analysis [Перевод заглавия: Улучшение потребления пищи жителями домов престарелых с помощью при кормлении: анализ потребности в персонале] / S. F. Simmons, D. Osterweil, J. F. Schnelle. – Text : electronic // *Journals of Gerontology. Series A: Biological Sciences and Medical Sciences*. – 2001. – Vol. 56, No. 12. – P. M790–M794. – URL: <https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/56/12/M790/545995> (дата обращения: 09.10.2026).
211. Long-term care homes program [Перевод заглавия: Программа домов длительного ухода] / FAO Ontario. – URL: <https://fao-on.org/wp-content/uploads/2024/08/Long-term-care-homes-program.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
212. [Дома престарелых Онтарио кормят пожилых на 8,33 доллара в день]. – Text : electronic // *Toronto Star* : [site]. – 2017. – URL: <https://www.thestar.com/news/canada/ontario-nursing-homes-feed-seniors-on-8-33-a->

day/article_6b7fab43-437c-5ba6-bbfb-0f1d6426062b.html (дата обращения: 09.10.2026).

213. [ANFP Benchmarking Program: расходы на продукты в домах престарелых] / ANFP. – Text : electronic // Edge. – 2018. – March/April. – URL: <https://www.anfponline.org/docs/default-source/legacy-docs/docs/benchmarking-program/anfpbenchmarkingprogramarticle-marchaprile2018.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
214. More than 25% of nursing homes slash food spending below \$10 a day [Перевод заглавия: Более 25 % домов престарелых сократили расходы на питание до уровня ниже 10 долларов в день]. – Text : electronic // Skilled Nursing News : [site]. – 2025. – Apr. – URL: <https://skillednursingnews.com/2025/04/more-than-25-of-nursing-homes-slash-food-spending-below-10-a-day/> (дата обращения: 09.10.2026).
215. [Об установлении предельных тарифов на социальные услуги] : постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015 № 162-ПК : приложение «Предельные тарифы на социальные услуги». – Текст : электронный // pravo.gov66.ru : [сайт]. – URL: https://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/p162_3.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
216. Food services in long-term care homes are associated with residents' food intake [Перевод заглавия: Пищевое обслуживание в домах длительного ухода связано с потреблением пищи жителями]. – Text : electronic // Journal of Nursing Home Research. – URL: <https://www.jnursinghomeresearch.com/1592-food-services-in-long-term-care-homes-are-associated-with-residents-food-intake.html> (дата обращения: 09.10.2026).
217. New Basic Daily Fee supplement [Перевод заглавия: Новая надбавка к базовому суточному сбору : форма обязательства и условия] / Australian Government, Department of Health. – 2021. – June. – URL: <https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/06/new-basic-daily-fee-supplement.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
218. Food and Nutrition Report 2021–2022 [Перевод заглавия: Доклад о питании за 2021–2022 гг.] / Australian Government, Department of Health and Aged Care. – Text : electronic // Australian Government, Department of Health and Aged Care : [site]. – URL: <https://www.health.gov.au/resources/publications/food-and-nutrition-report-2021-2022> (дата обращения: 09.10.2026).
219. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ : ст. 15 «Особенности осуществления закупок бюджетными, автономными учреждениями...». – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/df3ace0ea577a92ea8b71c0d4363fbb79da7160/ (дата обращения: 09.10.2026).
220. О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ : ст. 44, ч. 1. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/823b6d9364817ac5a9d67b0c432824b5c5965c40/ (дата обращения: 09.10.2026).
221. Антимонопольщики запустили сайт anticartel.ru. – Текст : электронный // amic.ru : [сайт]. – 2010. – 7 окт. – URL: <https://www.amic.ru/news/antimonopolschiki-zapustili-sayt-anticartel-ru-134096> (дата обращения: 09.10.2026).
222. [Особенности проведения закупок с неопределенным объемом по 44-ФЗ]. – Текст : электронный // ppt.ru : [сайт]. – 2021. – 4 июня (обновлено 05.02.2025). – URL: <https://ppt.ru/art/zakupki/osobennosti-provedeniya-zakupok-s-neopredelennym-obemom-po-44-fz> (дата обращения: 09.10.2026).
223. ГОСТ Р 52497-2005. Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания : национальный стандарт Российской Федерации : утвержден приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 534-ст : дата введения 2007-01-01. – Текст : электронный // dnaop.com : [сайт]. – URL: https://dnaop.com/html/78254/doc-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_52497-2005 (дата обращения: 09.10.2026).
224. [Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н]. – Текст : электронный // ГАРАНТ : [сайт]. – URL: <https://base.garant.ru/58070703/> (дата обращения: 23.07.2026).
225. [О методических рекомендациях по применению унифицированных форм электронных документов, утвержденных приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н] : письмо Министерства финансов Российской Федерации от 30.07.2024 № 02-06-06/70843. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : [сайт]. – 2024. – 6 авг. – URL: <https://www.garant.ru/news/1746038/> (дата обращения: 09.10.2026).
226. О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации : Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ : ст. 36, 40, 43, 88. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/ (дата обращения: 09.10.2026).

227. О прокуратуре Российской Федерации : Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 : ст. 24. – Текст : электронный // zakonrf.info : [сайт]. – URL: <https://www.zakonrf.info/zakon-o-prokurature/24/> (дата обращения: 09.10.2026).
228. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ст. 3.4, 4.1.1, 6.6. – Текст : электронный // zakonrf.info : [сайт]. – URL: <https://www.zakonrf.info/koap/6.6/> (дата обращения: 09.10.2026).
229. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ : ст. 1 (ч. 1, 4), ст. 10 (ч. 1), ст. 12 (ч. 1) : редакция от 28.12.2024. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/23fb391f3632e3f68a11e40c5a7711f3513cc674/ (дата обращения: 10.10.2026).
230. Уголовный кодекс Российской Федерации : ст. 238, 293. – Текст : электронный // zakonrf.info : [сайт]. – URL: <https://www.zakonrf.info/uk/293/> (дата обращения: 09.10.2026).
231. Об утверждении Примерного положения о попечительском совете организации социального обслуживания : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.06.2014 № 425н : зарегистрирован в Минюсте России 31.07.2014 № 33371. – Текст : электронный // rulaws.ru : [сайт]. – URL: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-30.06.2014-N-425n/> (дата обращения: 09.10.2026).
232. 42 CFR § 483.10. Resident rights : (f)(5)–(7) Resident and family groups [Перевод заглавия: Свод федеральных нормативных актов США, раздел 42, § 483.10. Права проживающих : (f)(5)–(7) Группы проживающих и их семей]. – Text : electronic // Legal Information Institute, Cornell Law School : [site]. – URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.10> (дата обращения: 09.10.2026).
233. Hutchinson, M. Listened to but Rarely Heard: A Scoping Review of Resident Engagement in the Organizational Design and Governance of their Long-Term Care Homes [Перевод заглавия: Выслушаны, но редко услышаны: обзорное исследование участия жителей в организационном устройстве и управлении домами долговременного ухода] / M. Hutchinson [et al.]. – Text : electronic // Canadian Journal on Aging. – 2025. – Vol. 44, No. 4. – P. 552–564. – DOI: 10.1017/S0714980825100263. – URL: <https://www.cambridge.org/core/product/C551889E0C07BB565CC251D3BDD95289> (дата обращения: 09.10.2026).
234. Proctor, E. Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda [Перевод заглавия: Результаты исследований внедрения: концептуальные различия, трудности измерения и исследовательская повестка] / E. Proctor [et al.]. – Text : electronic // Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. – 2011. – Vol. 38, No. 2. – P. 65–76. – DOI: 10.1007/s10488-010-0319-7. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10488-010-0319-7> (дата обращения: 09.10.2026).
235. Run charts [Перевод заглавия: Графики серий] / Clinical Excellence Commission (NSW Health). – Text : electronic // CEC Academy. Quality improvement tools : [site]. – URL: <https://www.cec.health.nsw.gov.au/CEC-Academy/quality-improvement-tools/run-charts> (дата обращения: 09.10.2026).
236. Avery, K. N. L. Informing efficient randomised controlled trials: exploration of challenges in developing progression criteria for internal pilot studies [Перевод заглавия: К эффективным рандомизированным контролируемым исследованиям: трудности разработки критериев перехода для внутренних пилотных исследований] / K. N. L. Avery [et al.] ; Internal Pilot Trials Workshop members. – Text : electronic // BMJ Open. – 2017. – Vol. 7, No. 2. – Art. e013537. – URL: <https://bmjopen.bmj.com/content/7/2/e013537> (дата обращения: 09.10.2026).
237. Perla, R. J. The run chart: a simple analytical tool for learning from variation in healthcare processes [Перевод заглавия: График серий: простой аналитический инструмент для изучения вариабельности процессов здравоохранения] / R. J. Perla, L. P. Provost, S. K. Murray. – Text : electronic // BMJ Quality & Safety. – 2011. – Vol. 20, No. 1. – P. 46–. – URL: <https://qualitysafety.bmj.com/content/20/1/46> (дата обращения: 09.10.2026).
238. McCambridge, J. Systematic review of the Hawthorne effect: new concepts are needed to study research participation effects [Перевод заглавия: Систематический обзор эффекта Хоторна: для изучения эффектов участия в исследовании нужны новые понятия] / J. McCambridge, J. Witton, D. R. Elbourne. – Text : electronic // Journal of Clinical Epidemiology. – 2014. – Vol. 67, No. 3. – P. 267–277. – DOI: 10.1016/j.jclinepi.2013.08.015. – URL: <https://researchonline.lshtm.ac.uk/1380017> (дата обращения: 09.10.2026).
239. Barnett, A. G. Regression to the mean: what it is and how to deal with it [Перевод заглавия: Регрессия к среднему: что это такое и как с ней обращаться] / A. G. Barnett, J. C. van der Pols, A. J. Dobson. – Text : electronic // International Journal of Epidemiology. – 2005. – Vol. 34, No. 1. – P. 215–220. – DOI: 10.1093/ije/dyh299. – URL: <https://academic.oup.com/ije/article/34/1/215/638499> (дата обращения: 09.10.2026).
240. Devi, R. Sustaining interventions in care homes initiated by quality improvement projects: a qualitative study [Перевод заглавия: Поддержание в домах ухода вмешательств, начатых проектами улучшения качества: качественное

- исследование] / R. Devi [et al.]. – Text : electronic // BMJ Quality & Safety. – 2023. – Vol. 32, No. 11. – P. 665–675. – DOI: 10.1136/bmjqs-2021-014345. – URL: <https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/183374/> (дата обращения: 09.10.2026).
241. Williams, P. Plate waste in hospitals and strategies for change [Перевод заглавия: Несъеденная пища в больницах и стратегии изменений] / P. Williams, K. Walton. – Text : electronic // e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism. – 2011. – Vol. 6, No. 6. – P. e235–e241. – URL: https://ro.uow.edu.au/articles/journal_contribution/Plate_waste_in_hospitals_and_strategies_for_change/27740256 (дата обращения: 09.10.2026).
242. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ : ст. 8 «Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания», пп. 5, 6, 10, 24.1. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/2a85900e96a4b07cbc892bd43e0be773fd1f102e/ (дата обращения: 09.10.2026).
243. Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н : зарегистрирован в Минюсте России 11.10.2018 № 52409. – Текст : электронный // rulaws.ru : [сайт]. – URL: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-31.05.2018-N-344n/> (дата обращения: 09.10.2026).
244. Regulation 14: Meeting nutritional and hydration needs [Перевод заглавия: Положение 14: удовлетворение потребностей в питании и питье] : Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014 / Care Quality Commission. – Text : electronic // Care Quality Commission : [site]. – URL: <https://www.cqc.org.uk/guidance-regulation/providers/regulations-service-providers-and-managers/health-social-care-act/regulation-14> (дата обращения: 09.10.2026).
245. National standards for healthcare food and drink [Перевод заглавия: Национальные стандарты питания и питья в здравоохранении] / NHS England. – Version 1. – 2022. – 1 Nov. – Text : electronic // NHS England : [site]. – URL: <https://www.england.nhs.uk/long-read/national-standards-for-healthcare-food-and-drink/> (дата обращения: 09.10.2026).
246. Guyatt, G. H. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations [Перевод заглавия: GRADE: складывающийся консенсус в оценке качества доказательств и силы рекомендаций] / G. H. Guyatt [et al.] ; GRADE Working Group. – Text : electronic // BMJ. – 2008. – Vol. 336. – P. 924–926. – DOI: 10.1136/bmj.39489.470347.AD. – URL: <https://www.bmj.com/content/336/7650/924> (дата обращения: 09.10.2026).
247. Об утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структуре, составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации : приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 № 103н : зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2019 № 54588 : с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2020 № 617н. – Текст : электронный // rulaws.ru : [сайт]. – URL: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-28.02.2019-N-103n/> (дата обращения: 09.10.2026).
248. Кейтеринг в организациях социального обслуживания. – Текст : электронный // Профиздат : [сайт]. – 2022. – URL: https://www.profiz.ru/sec/4_2022/Kejtering/ (дата обращения: 23.07.2026).
249. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 23.07.2026).
250. Поставка продуктов питания : извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0372200070825000244 / заказчик СПб ГБУСОН «ДСО «Тесовый берег». – 2025. – 24 нояб. – Текст : электронный // TenderGuru : [сайт]. – URL: <https://www.tenderguru.ru/tender/90473908> (дата обращения: 19.08.2026).
251. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ : ст. 33 «Правила описания объекта закупки», ч. 1, пп. 1–2. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/d6aec91603ff628ea274b8552ce2849e06e0aa4c/ (дата обращения: 09.10.2026).
252. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия : межгосударственный стандарт : дата введения 2016-01-01. – Текст : электронный // cn.gostinfo.ru : [сайт]. – URL: <https://cn.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5319168> (дата обращения: 09.10.2026).

253. [Об усилении контроля за исполнением поставщиками питания своих обязательств] : письмо Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга руководителям государственных учреждений. – Не опубликовано.
254. Standards for food and drink in NHS hospitals [Перевод заглавия: Стандарты питания и питья в больницах NHS] / Hospital Food Standards Panel. – 2016. – URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a806e1eed915d74e33fa61a/Hospital_Food_Panel_May_2016.pdf (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
255. Dorner, B. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Individualized Nutrition Approaches for Older Adults: Long-Term Care, Post-Acute Care, and Other Settings [Перевод заглавия: Позиция Академии питания и диетологии: индивидуализированные подходы к питанию пожилых людей в учреждениях долговременного ухода, постострой помощи и других условиях] / B. Dorner, E. K. Friedrich. – Text : electronic // Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. – 2018. – Vol. 118, No. 4. – P. 724–735. – DOI: 10.1016/j.jand.2018.01.022. – URL: <https://www.cdrnet.org/vault/2459/web/Individualized%20Nutrition%20Approaches%20for%20Older%20Adults%202018-2025.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
256. Information Only: New Dining Standards of Practice Resources are Available Now : Memorandum S&C: 13-13-NH [Перевод заглавия: Для сведения: новые материалы о стандартах практики организации питания уже доступны : информационное письмо S&C: 13-13-NH] / Centers for Medicare & Medicaid Services, Center for Clinical Standards and Quality, Survey & Certification Group ; signed by T. E. Hamilton. – 2013. – 1 March. – URL: <https://www.cms.gov/medicare/provider-enrollment-and-certification/surveycertificationgeninfo/downloads/survey-and-cert-letter-13-13.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
257. Lachs, M. S. The Prevalence of Resident-to-Resident Elder Mistreatment in Nursing Homes [Перевод заглавия: Распространённость жестокого обращения между жителями домов престарелых] / M. S. Lachs [et al.]. – Text : electronic // Annals of Internal Medicine. – 2016. – Vol. 165, No. 4. – P. 229–236. – DOI: 10.7326/M15-1209. – PMID 27295575. – URL: <https://pure.psu.edu/en/publications/the-prevalence-of-resident-to-resident-elder-mistreatment-in-nurs/> (дата обращения: 09.10.2026).
258. О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ : ст. 9 «Первичные учетные документы» : редакция от 15.12.2025. – Текст : электронный // rulaws.ru : [сайт]. – URL: <https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-06.12.2011-N-402-FZ/Statya-9/> (дата обращения: 09.10.2026).
259. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ : ст. 34 «Контракт», ч. 4, 6–8 : редакция от 04.08.2026. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/c5cbc4acc59ffed792a3921dbc18900d2d0f7eb1/ (дата обращения: 09.10.2026).
260. 42 CFR § 483.5. Definitions [Перевод заглавия: Свод федеральных нормативных актов США, раздел 42, § 483.5. Определения] : Requirements for States and Long Term Care Facilities. – Text : electronic // Legal Information Institute, Cornell Law School : [site]. – URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.5> (дата обращения: 09.10.2026).
261. О прокуратуре Российской Федерации : Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 : ст. 6 «Обязательность исполнения требований прокурора» : редакция от 04.08.2026. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/a7897e6471f1f713c1af63e5476c9ec0c9d46650/ (дата обращения: 09.10.2026).
262. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ : ст. 31 «Первая помощь». – Текст : электронный // МЧС России : [сайт]. – Изложено в разъяснении «Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи». – URL: https://mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/organizacionno-pravovye-aspekty-okazaniya-pervoy-pomoshchi_7 (дата обращения: 09.10.2026).
263. Об утверждении учетной формы № 058/у «Экстренное извещение о случае инфекционной болезни» : приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.08.2026 № 740н : зарегистрирован в Минюсте России 16.09.2026 № 88291 : вступает в силу 01.03.2027. – Текст : электронный // ppt.ru : [сайт]. – Сведения приведены по обзору. – URL: <https://ppt.ru/obzory/vstupayet-v-silu/prikaz-minzdrava-rossii-20-08-2026-740n> (дата обращения: 09.10.2026).
264. Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard (FLW Standard) [Перевод заглавия: Стандарт учёта и отчётности о потерях и отходах пищи] / Food Loss + Waste Protocol ; secretariat World Resources Institute. – Version 1.0. – 2016. – Jan. – URL: https://flwprotocol.org/wp-content/uploads/2017/05/FLW_Standard_final_2016.pdf (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.

265. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ : ст. 91 «Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени». – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/bd14ccccf0a1f074ef104e82522f7e2dea04d651f/ (дата обращения: 09.10.2026).
266. Patient Safety Incident Response Framework (PSIRF) [Перевод заглавия: Рамочный документ о реагировании на инциденты, связанные с безопасностью пациентов] / NHS England. – Version 1. – Text : electronic // NHS England : [site]. – URL: <https://www.england.nhs.uk/patient-safety/patient-safety-insight/incident-response-framework/> (дата обращения: 09.10.2026).
267. Information for all: European standards for making information easy to read and understand [Перевод заглавия: Информация для всех: европейские стандарты подготовки лёгкой для чтения и понимания информации] / Inclusion Europe. – Brussels : Inclusion Europe, [2010]. – ISBN 2-87460-110-1. – URL: https://www.inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2017/06/EN_Information_for_all.pdf (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
268. Accessible Information Standard [Перевод заглавия: Стандарт доступной информации] / Mencap. – Text : electronic // Mencap : [site]. – URL: <https://www.mencap.org.uk/help-and-advice/health/accessible-information-standard> (дата обращения: 09.10.2026).
269. Narrative Review of Low-Intake Dehydration in Older Adults [Перевод заглавия: Описательный обзор дегидратации вследствие недостаточного потребления жидкости у пожилых]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2021. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8470893/> (дата обращения: 09.10.2026).
270. Volkert, D. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics [Перевод заглавия: Руководство ESPEN по клиническому питанию и гидратации в гериатрии] / D. Volkert [et al.]. – Text : electronic // Clinical Nutrition. – 2019. – Vol. 38, No. 1. – P. 10–47. – DOI: 10.1016/j.clnu.2018.05.029. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.029> (дата обращения: 09.10.2026).
271. Dehydration and Fluid Maintenance in the Long-Term Care Setting : clinical practice guideline [Перевод заглавия: Дегидратация и поддержание водного баланса в учреждениях длительного ухода : клиническое руководство] / PALTmed. – 2024. – URL: <https://paltmed.org/sites/default/files/2024-10/Dehydration%20CPG%2008092024.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
272. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ : ст. 57 «Право ребенка выражать свое мнение» : редакция от 23.03.2026 с изменениями от 15.05.2026. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/00731b26adc7c351894969e6f7d05a903cfd6551/ (дата обращения: 09.10.2026).
273. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи : СП 2.4.3648-20 : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 : зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/ (дата обращения: 23.07.2026).
274. MacCannell, T. Guideline for the Prevention and Control of Norovirus Gastroenteritis Outbreaks in Healthcare Settings. Section II: Summary of Recommendations [Перевод заглавия: Руководство по профилактике и контролю вспышек норовирусного гастроэнтерита в медицинских организациях. Раздел II: Сводка рекомендаций] / T. MacCannell [et al.] ; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). – CDC, 2011. – Text : electronic // CDC : [site]. – URL: <https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/norovirus-guidelines/summary-recommendations.html> (дата обращения: 09.10.2026).

Исправления к записям первой редакции

Номер в квадратных скобках — номер источника в списке выше.

ID	Что уточнено
[6]	Источник описывает четыре учреждения Иркутской области с разными моделями, а не региональную норму; формула «два первых, два вторых, гарниры» относится к одному отделению Марковского геронтологического центра (раздел 25.6)
[23]	Постановление касается школы № 80 в Казани, а не дома-интерната; перенос на ДСО и ПНИ — аналогия
[7]	Доли 74 % и 11 % относятся к 2022 году; 11 % — только постоянный постельный режим; «289» — места, а не койки, и это расчёт проекта

ID	Что уточнено
[196]	Это нидерландский метаанализ восьми РКИ вмешательств в образ жизни (Koomen 2022), а не японская когорта; данных о смертности и госпитализациях нет
[41]	Деменция была критерием исключения; качество жизни в группе вмешательства сохранилось, в контрольной снизилось
[80]	Это не «обзор 4 РКИ», а трёхстраничный комментарий: Müller F. // J Dent Res. 2015;94(3 Suppl):14S–16S, DOI 10.1177/0022034514552494. Формула «~1 из 10» восходит к Sjögren 2008 ([79], 5 РКИ) и касается смертей от пневмонии у зависимых от ухода пожилых; обзор пяти публикаций принадлежит van der Maarel-Wierink 2013 ([77]); см. также [78]
[163]	Не постановление Правительства Москвы № 1068-ПП, а приказ Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 24.12.2014 № 1068 ([166]); позднейший акт – приказ ДТСЗН от 22.03.2021 № 228 ([167])
[12]	Акт Ленинградской области № 458 о нормах питания не найден (поиск 10.10.2026); сайт подведомственного учреждения ссылается на приказ комитета от 05.11.2014 № 29 ([168])
[38]	Полное название – «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»; признал утратившим силу приказ № 552н; сведений о регистрации в Минюсте в тексте нет
[27]	Проверен по тексту 2022 года: выбор основных блюд – на обед и ужин (ст. 77(1)(с)); пороги «три отказа подряд» и «25 % порции» в регламенте отсутствуют (это [94]); соотношение 1:2 при полной помощи – ст. 79(2); пороги массы – ст. 75; диетолог 30 минут – ст. 80(2)
[17]	Работа посвящена кофеину; величина «курение снижает концентрацию клозапина вдвое» не подтверждена, направление эффекта подтверждают MHRA и Medsafe
[45]	Формулы «независимо от когнитивного статуса» в Стандарте 6 нет